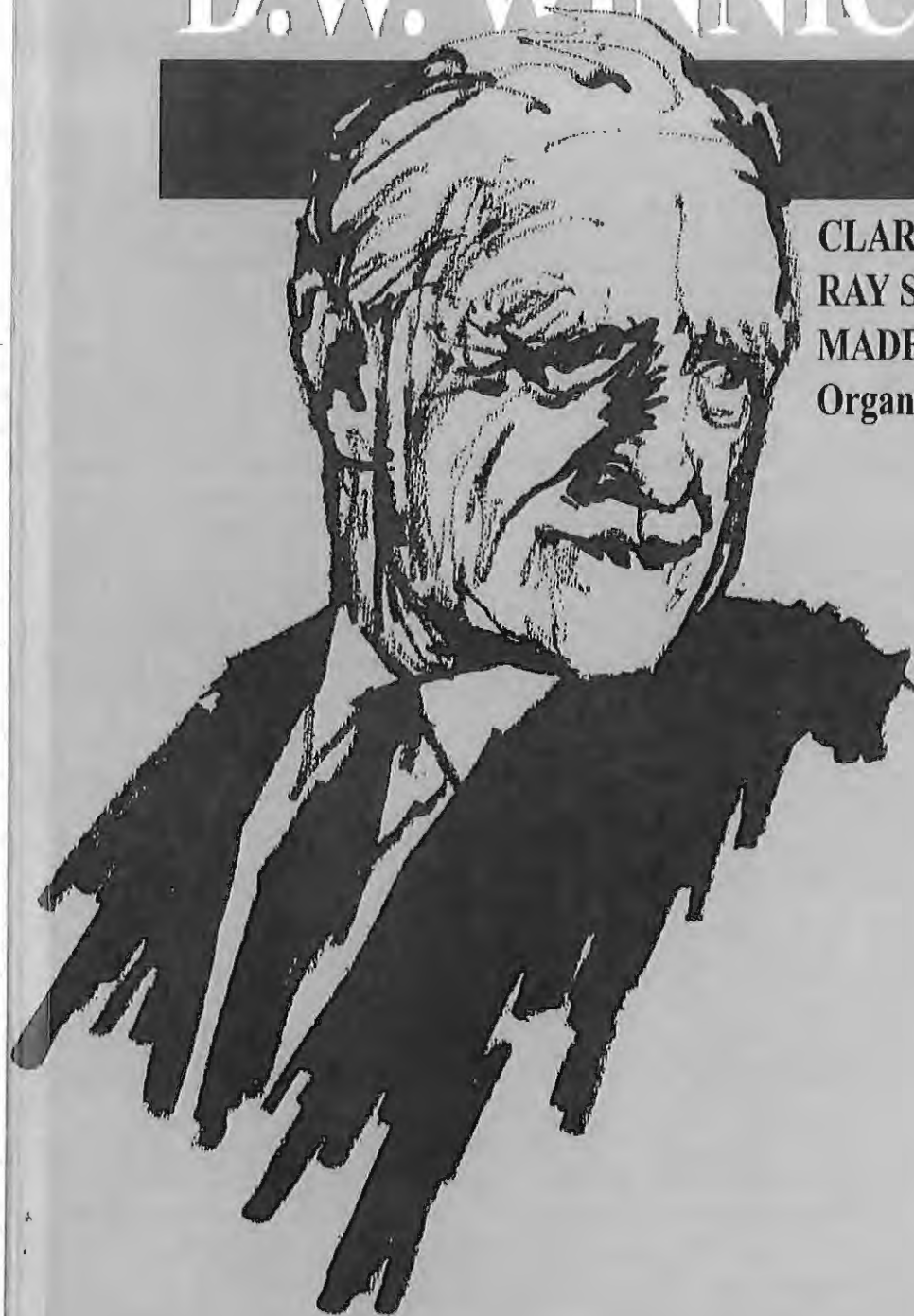


EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS
D.W. WINNICOTT



CLARE WINNICOTT
RAY SHEPHERD
MADELEINE DAVIS
Organizadores



EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS

D.W. WINNICOTT

Aviso ao leitor

A capa original deste livro foi substituída por esta nova versão. Alertamos para o fato de que o conteúdo é o mesmo e que esta nova versão da capa decorre da alteração da razão social desta editora e da atualização da linha de *design* da nossa já consagrada qualidade editorial.

artmed[®]
EDITORA



D766e Winnicott, Clare

Explorações Psicanalíticas: D. W. Winnicott / Clare Winnicott, Ray Shepherd & Madeleine Davis; Trad.: José Octavio de Aguiar Abreu. — Porto Alegre: Artmed, 1994.

1. Psicanálise — Winnicott. I. Shepherd, Ray. II. Davis, Madeleine. III. Título.

CDU 159.964.2 (Winnicott)

Bibliotecária responsável: Mônica Ballejo Canto — CRB 10/1023

ISBN 978-85-7307-017-0

EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS

D.W. WINNICOTT

CLARE WINNICOTT

RAY SHEPHERD

MADELEINE DAVIS

Organizadores

Tradução:

JOSÉ OCTAVIO DE AGUIAR ABREU

Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica da Tradução:

JOSÉ OTTONI OUTEIRAL

ROBERTO BARBERENA GRAÑA

ADRIANE KIPERMAN

BERENICE PONTES NETTO

Reimpressão 2007



1994

Dra. Heloisa Fischer Meyer
Psicoterapeuta Psicanalista
CREMERS 10922 CPF: 47495046-47

Obra originalmente publicada em inglês sob o título
Psycho-Analytic Explorations
por Karnac Books, Londres, Inglaterra, 1989
Copyright by The Winnicott Trust, by arrangement with Mark Paterson & Associates

Capa:
Joaquim da Fonseca

Supervisão Editorial:
Adriane Kiperman

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à
ARTMED® EDITORA S.A.
Av. Jerônimo de Ornelas, 670 - Santana
90040-340 Porto Alegre RS
Fone (51) 3027-7000 Fax (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte,
sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação,
fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

SÃO PAULO
Av. Angélica, 1091 - Higienópolis
01227-100 São Paulo SP
Fone (11) 3665-1100 Fax (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444

IMPRESSO NO BRASIL
PRINTED IN BRAZIL

Agradecimentos

Por permissão para reproduzir material já impresso, agradecemos às seguintes instituições:

Por artigos aparecidos em periódicos: *British Journal of Medical Psychology*; *British Journal of Psychology*; *British Medical Journal*; *British Medical Student's Journal*; *Child Care News*; *International Journal of Child Psychotherapy*; *International Journal of Psycho-Analysis*; *The Lancet*; *Nature*; *New Society*.

Por artigos aparecidos em livros: *Churchill-Livingstone*; *Free Association Books*; *The Hogarth Press*; *Methuen and Co.*, *The Pergamon Press*; *Tavistock Publications*.

Um agradecimento especial é devido à *Squiggle Foundation*, por auxílio na transcrição de antigas gravações. Queremos também agradecer ao Sr. B. E. Eaden, da Biblioteca da Universidade de Cambridge, por sua irrestrita assistência e cortesia.

Os Organizadores

Apresentação à Edição Brasileira

TO BE LEFT HOLDING THE BABY*

Wednesday, 9 february

Patient: "There is a risk involved. You look silly. People might laugh if you prattle". (This word belongs in the analysis to a phase of his early childhood in which it was said that he prattled before he became sullen and withdrawn). "And then you are left holding the baby" (meaning excitement).**

[D. W. Winnicott. *Holding and interpretation. Fragment of an analysis.*
The Institute of Psychoanalysis. London: Karnac Books, p. 25.].

To be left holding the baby é uma expressão idiomática inglesa que serve, perfeitamente, para caracterizar o modelo teórico-clínico de Donald Woods Winnicott (D. W. W.). *Explorações psicanalíticas* é um livro que exemplifica bem a forma de *ser* e de *fazer* do autor, de sua *personalidade total* e de seu *verdadeiro self*. A espontaneidade e a criatividade que se revelam em seus textos e no trabalho de apresentação de Clare Winnicott nos permitem compreender que a "pessoa" de D. W. W. e sua produção científica estão estreitamente interligadas. O conceito de transicionalidade e a sua concepção do brincar (*play*) são exemplos claros da relação estreita entre o autor e a obra.

Esta coletânea de artigos, que inclui material produzido desde a Segunda Guerra Mundial até a morte de D. W. W., em 1971, revela-nos amplo espectro de seus interesses e sua vasta experiência clínica. Segundo Masud Khan (1958), Winnicott

* "Ficar segurando o bebê" (*to be left holding the baby*) é uma expressão idiomática inglesa, que aproximadamente corresponde, em nosso idioma, a "pagar o pato", ou "pegar um pepino", ou, ainda, estar às voltas com um problema ou dificuldade que deveria ser responsabilidade de outra pessoa. Em Psicanálise, poderemos pensar no analista fazendo-se a cargo, no *setting*, de uma falha ambiental precoce vivenciada pelo paciente.

** Quarta-Feira, 9 de fevereiro

Paciente: "Há um risco envolvido. Você fica parecendo tolo. As pessoas podem rir se você ficar tagarelando". (Esta palavra, na Análise, é própria de uma fase da primeira infância na qual, segundo foi dito, ele tagarelava muito, antes de se tornar quieto e retraído.) "E depois é você quem fica segurando o bebê" (significando excitação).

examinou, ao longo da sua vida, cerca de 60 mil pacientes (principalmente crianças e suas mães), e esta profunda experiência clínica nos é possível acompanhar através da obra que ora apresentamos.

Explorações psicanalíticas apresenta uma introdução sobre D. W. W. ("uma reflexão sobre D. W. W."), feita por sua esposa, Clare Winnicott, que nos conduz ao modelo de um Jogo de Rabiscos (*Squiggle Game*), a descobrirmos o Personagem e sua Obra, a partir de uma descoberta pessoal feita pelo próprio leitor. Esta qualidade de buscar ser "simplesmente ele mesmo" pode ser lida na Introdução que M. Masud Khan (1958) escreveu para o livro de D. W. W., *Collect papers: trough pediatrics to psychoanalysis*:

Não conheci nenhum outro analista mais inevitavelmente ele mesmo. Foi esta qualidade de ser inviolavelmente 'eu-mesmo' que lhe permitiu ser tantas pessoas diferentes para criaturas tão diversas. Cada um de nós que o conheceu tem o seu próprio Winnicott, e ele jamais desrespeitou a versão que o outro tinha dele, aprimorando seu próprio estilo de ser. E, contudo, permaneceu sempre e inexoravelmente Winnicott.

Para ler os trabalhos de D. W. W., o leitor tem que ter disposição para "brincar", para *play* (um brincar espontâneo, criativo e prazeroso) e não para *game* (uma atividade regrada), no sentido winnicottiano. É necessário fazer como ele sugere para o *Jogo de Rabiscos (Squiggle Game)*, com o leitor e o autor criando juntos uma "leitura pessoal", um espaço transicional onde o leitor "descobrirá", como um achado pessoal, o que D. W. W. escreveu.

A Obra

Sleep

Let down your tap root to the center of your soul. Suck up the sap from the infinite source of your unconscious and / Be evergreen*

D. W. Winnicott

Para compreender D. W. W. é necessário *brincar* com seu pensamento, ou seja, criar um *espaço transicional* que permita *brincar*, antes de compreender, a *experiência que sua teoria* possibilita. Clare Winnicott comenta que a capacidade de brincar era central não apenas em sua obra, mas também em sua própria vida, e lembrou o comentário de um amigo caracterizando a relação do casal: "você e Donald brincam".

Quando estudamos D. W. W., defrontamo-nos com um estilo do qual podemos dizer, como ele próprio referira, *Le style est l'homme même*; e o estilo de D. W. W. é extremamente pessoal e sofisticado, e ao mesmo tempo simples e natural.

A criatividade das contribuições de D. W. W. dificulta uma sistematização metodológica de sua obra.

André Green diz que o pensamento de D. W. W. forma uma rede, um tecido de fios entrecruzados, distinguindo-se como fios principais os seguintes:

1. A Teoria de Situação Analítica, cujo modelo é o *Setting*.
2. A Teoria das Pulsões, que introduz novas noções sobre a agressividade (com a noção de uma destrutividade sem cólera) e sobre a sexualidade (com a idéia do que Winnicott denomina "elemento feminino puro").

* Sono: Deixa penetrar a raiz no centro da tua alma. Aspira a seiva da fonte infinita de teu inconsciente e / conserva teu verdor.

3. A Teoria do Objeto, enfocada pelas relações entre o objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido, que não combina plenamente com a oposição freudiana entre a representação e a percepção: seu corolário é o *objeto transicional*.
4. A Teoria do *Self* com a oposição entre *falso self* e *self verdadeiro*.
5. A Teoria do Espaço, pela noção de *área intermediária*, *espaço potencial* e *transicional*, fonte de sublimação e da experiência cultural, através do *brincar*.
6. A Teoria da Comunicação e da não-comunicação.
7. Por último, a Teoria do Desenvolvimento, que introduz a noção de *ambiente facilitador*, e a evolução da dependência à independência.

M. Masud Khan, ao escrever o extenso e precioso prefácio para *Collected papers*, comenta a obra de D. W. W., enfocando os seguintes aspectos:

- o conceito de realidade interna *versus* fantasiar;
- do objeto transicional ao uso do objeto;
- regressão, manejo e jogo no *setting* clínico;
- a estruturação e a formação de uma pessoa.

Acreditamos que uma outra forma de sistematizar as contribuições de D. W. W. poderia ser feita da seguinte maneira:

1. Em primeiro lugar, o caminho da dependência à independência, com a dependência possuindo três etapas: a) dependência absoluta; b) dependência relativa; e c) caminhando em direção à independência, enfatizando que esta nunca é absoluta. O indivíduo sadio nunca se torna isolado, mas se relaciona com o ambiente de tal modo que se pode dizer que o indivíduo e o ambiente se tornam interdependentes.

O conceito de *caminhando em direção à independência* pode ser melhor compreendido se utilizarmos uma metáfora criada por Bion: "Quando um navegante se orienta por uma estrela, ele sabe que não irá alcançá-la, mas tomará seu rumo na direção da estrela".

2. Em segundo lugar, o conceito de não-integração e de integração. Ele escreve (*Communication between infant and mother, mother and infant, compared and contrasted*, 1968):

O que existe é um conjunto anatômico e fisiológico, e a isto se acrescenta um potencial para o desenvolvimento de uma personalidade humana. Há uma tendência geral ao crescimento físico e ao desenvolvimento da parte psíquica da parceria psicossomática.

3. Em terceiro lugar, o conceito de *Personalização*. Personalização foi a palavra utilizada por D. W. W. para descrever a trama psicossomática ou a *psique residindo no soma*. Em trabalho intitulado *The theory of the parent-infant relationship* (1960), ele escreve:

A base para este residir é a vinculação de uma experiência motora, sensorial e funcional com o estado de ser uma pessoa para o bebê. Como um desenvolvimento ulterior, surge o que poderia ser chamado de uma membrana limitadora, que, em certo grau, pode ser equiparada à superfície da pele, e assume uma posição entre o *self* e o *não-self* do bebê. Desta forma, o bebê passa a ter um dentro e um fora e um esquema corporal. Assim, o significado se apegua à função do incorporar e de expelir; além do mais, gradualmente se torna significativo postular uma qualidade psíquica pessoal, ou interna, para o bebê.

Madeleine Davis e David Wallbridge, em seu livro *Boundary and space: a introduction to the work of D. W. Winnicott* (1981), escreveram que a maioria das pessoas aceita a trama psicossomática sem discussão, mas D. W. W. percebeu-a como uma realização (*being a person*). Representa um desenvolvimento a partir das “etapas iniciais nas quais a psique imatura (embora fundamentada no funcionamento somático) ainda não está intimamente vinculada ao corpo”. Veremos mais adiante este importante e básico conceito.

Devemos considerar, desde já, que mesmo depois do estabelecimento da trama psicossomática, ou da *Personalização*, pode haver períodos nos quais a psique perde o contato com o corpo.

D. W. W. escreve:

Pode haver fases nas quais não é fácil para o bebê retornar ao corpo, como, por exemplo, ao acordar de um sono profundo. As mães sabem disso, e acordam gradualmente o bebê antes de levá-lo para não causarem os berros de terror ou pânico que podem ser motivados por uma mudança da posição do corpo em um momento em que a psique está ausente dele. Clinicamente, associada a esta ausência de psique pode haver palidez, ocasiões em que o bebê esteja suando e talvez esteja muito frio, e também podem ocorrer vômitos. Neste momento, a mãe pode pensar que o seu bebê está morrendo, mas, quando o médico chega, houve um retorno tão completo à saúde normal que ele é incapaz de entender por que a mãe ficou tão assustada (*The first year of life: modern views on the emotional development*, 1958.).

A *Personalização*, ou a organização da trama psicossomática, não significa apenas que a psique está colocada no corpo, ou na cabeça, mas também significa que à medida que, finalmente, o controle cortical se amplia, o corpo todo se torna o lugar da residência do *self*.

A *Personalização* depende fundamentalmente de suportes ambientais bons o suficiente e de um cérebro intacto.

4. Em quarto lugar é necessário agora fazer referência:

- à noção de mãe suficientemente boa;
- à noção de *holding*;
- à noção de *handling*;
- à noção de apresentação de objeto;
- à noção de continuidade de cuidados maternos.

5. Em quinto lugar, é necessário referenciar, a noção de imposição e trauma (1952).

No início da vida, a invasão ou o trauma “se relaciona com a ameaça de aniquilamento”, que é listada por D. W. W. no que ele denomina *agonias primitivas* ou *ansiedade impensáveis* (1962, 1968):

- despedaçar-se;
- cair para sempre;
- não ter relação com o corpo;
- não ter orientação;
- isolamento completo por não existirem formas de comunicação.

Numa tentativa de desenvolver e ampliar os esquemas apresentados, Júlio de Mello Filho (um dos introdutores do pensamento de D. W. W. no Brasil), junto com Luís E. Prego-Silva, do Uruguai, resume assim o conjunto das contribuições de D. W. W.:

1. Teoria do Desenvolvimento, com um estudo pormenorizado da relação mãe-filho e das influências da família e do ambiente, postulando a interação de processos inatos de maturação com a presença de um ambiente facilitador, desde uma fase de dependência absoluta à aquisição da independência humana.
2. Teoria dos Impulsos, em que reestuda os papéis da sexualidade (elemento masculino e elemento feminino) e da agressividade, relacionando-as em seus primórdios ao desenvolvimento motor e questionando a existência de um instinto de morte. Aqui também é importante a noção de *agressividade sem cólera*, através da qual o bebê se desliga da mãe num *abandono de catexis*, sem uma intencionalidade em si destrutiva.
3. Teoria do Objeto, em que postula a existência de um objeto subjetivo (inicial) e de um objeto objetivo (posterior), como também de um objeto transicional, formulando o conceito de Fenômenos Transicionais em Psicanálise.
4. Teoria do Espaço, em que formula a existência de um Espaço Potencial, de uma zona intermediária entre a realidade interna e a realidade externa, onde se realizam o jogo e o brincar, origem de todas as atividades sócio-criativo-culturais.
5. Teoria do *Self*, da polarização entre um *verdadeiro self*, espontâneo e criativo, fonte de alegria e da saúde mental, em oposição ao *falso self*, artificialmente construído por submissão e excessiva adaptação ao meio.
6. Teoria da Comunicação, na qual estuda as formas de comunicação e os seus contrários, e o problema de incomunicabilidade humana e da esquizoidia, e onde afirma que o núcleo do verdadeiro *self* é um santuário inviolável que nunca se comunica com o exterior.
7. Teoria da Regressão, na qual estuda o problema da regressão no *setting* analítico a etapas primitivas de dependência absoluta, possibilitando *descongelar* situações iniciais de *fracasso ambiental* e retomar o desenvolvimento, com um novo sentido de viver.
8. Teoria do *Setting*, na qual estuda a estruturação, significação, função e seu manejo pelo analista, incluindo a possibilidade de sua ruptura parcial ou transgressão.
9. Teoria da Contratransferência, na qual afirma que ao lado da contratransferência comum e habitual existe uma outra, “verdadeira e objetiva”, representada pelo amor e pelo ódio do analista, que se justificam na situação clínica. Também estuda o problema das falhas do analista e da possibilidade do seu uso por parte do paciente.
10. Teoria Psicossomática, baseada na existência inicial de um *psique-soma* instintivo-fisiológico, do qual se desenvolve mais tarde a mente, com suas complexas funções. A doença psicossomática, caracterizada por múltiplos *splittings*, encerraria, contudo, uma tentativa de retorno (aspecto positivo) à situação de integração inicial.
11. Teoria da Tendência Anti-Social, conseqüente de uma privação inicial e representada pelo roubo e pela destrutividade, condutas de desafio ao meio que contém, paradoxalmente, um sinal de esperança de que o indivíduo ainda confia que o ambiente possa corrigir aquelas falhas que possibilitaram o surgimento desta tendência:

Finalmente, embora se diga que tudo que Winnicott escreveu, em função do seu espírito, ele deixou em elaboração, em transicionalidade, algumas destas teorias se mostram muito mais acabadas, completas, como a teoria do desenvolvimento, do *setting* e do objeto. Outras estão ainda em esboços, como a teoria psicossomática, a ser posteriormente desenvolvida. Neste sentido, podemos dizer que ele também esboçou uma teoria dos limites, dos limites do *setting*, dos limites da analisabilidade, dos limites pessoais ou contratransferenciais do analista (Júlio Mello Filho, 1989).

Sérvulo A. Figueira, ao escrever *Algumas idéias sobre Winnicott*, para o número especial da *Revista Brasileira de Psicanálise* dedicado a D. W. W. (1990), destaca os seguintes aspectos de sua obra:

1. O estilo winnicottiano de escrever e pensar a Psicanálise. O autor descreve que Winnicott “tinha um estilo especial, era uma figura marcante entre os colegas e conseguia gerar uma atmosfera de confiança que facilitava a comunicação com os pacientes. Essa atmosfera, no entanto, se definia por oposição ao carisma, pois, enquanto este é mais ativo e se sustenta num tipo de organização narcísica — os circunstantes tendo sua autonomia liquidada por esse fascínio, a atmosfera winnicottiana era facilitadora do desenvolvimento individual, sendo firme, mas passiva”. Outro aspecto referido é o clima poético, “que se instala entre a mãe e o seu bebê, entre o analista e o seu analisando”.

2. A atmosfera de sua obra “que resulta, dentre estes fatores, de um uso simples, direto e naturalmente poético da linguagem cotidiana, e de um uso positivo e produtivo do paradoxo”. “Um bom exemplo do pensamento de Winnicott”, escreve o autor, “está no texto sobre a capacidade de ficar sozinho”. Este texto permite exemplificar a noção do paradoxal, ou seja, estar só na presença de alguém (mãe) e que constitui um dos maiores sinais de maturidade.

3. A atmosfera do trabalho e a presença de Winnicott resultam de um tipo de personalidade que vários analistas que o conheceram (em especial M. Masud Khan) consideram tipicamente inglesa:

No caso de Winnicott, ser um *englishman* significa que ele encarna em sua vida os valores básicos da cultura inglesa na área da organização da subjetividade: o cultivo da diferenciação individual e do lado positivo da idiosincrasia, o cultivo da independência do pensamento e de julgamento, o respeito pela opinião, pela liberdade e pela autonomia do outro, a valorização da experiência e da observação, em suma, o cultivo da individuação.

4. Um ponto fundamental é o papel estruturante do objeto externo no desenvolvimento psíquico do ser humano.

Explorações psicanalíticas contém “seis conjuntos de trabalhos”, estreitamente ligados entre si:

1. “Uma reflexão sobre D. W. W.”, por Clare Winnicott.
2. Psicanálise: teoria e técnica.
3. Psicoterapia psicanalítica de crianças e adolescentes.
4. Sobre a obra de outros analistas.
5. Sobre outras formas de tratamento.
6. “Posfácio: D. W. W. sobre D. W. W.”.

Sugestões para Leitura de D. W. W.

Uma das formas de realizar uma leitura básica da teoria, técnica e clínica de D. W. W. pode ser feita através de um modelo que busca incluir os textos fundamentais de sua obra e suas contribuições mais originais. Um “roteiro” (talvez possamos chamá-lo assim...) interessante e que é uma versão ampliada e modificada de um Programa de Seminários sobre D. W. W. da *Asociación Psicoanalítica Argentina* e do *Grupo de Estudios Psicanalíticos de Pelotas*, ambas instituições filiadas à *International Psychoanalytical Association* (IPA), apresenta todos os inconvenientes da tentativa de “compactar” uma obra complexa, que abrange várias áreas do conhecimento psicanalítico e que resultou

de uma produção de mais de 200 trabalhos. Poderá, entretanto, ser útil para os que desejarem uma introdução ao pensamento winnicottiano. Este "roteiro de leitura" compreende 16 sugestões de temas para leitura:

1. O autor e a Obra (Introdução)

WINNICOTT, C. Uma reflexão sobre D. W. W. In: D. W. W. *Explorações psicanalíticas*, Artes Médicas: Porto Alegre, 1994.

WINNICOTT, D. W. *Da Pediatria à Psicanálise*. (Prefácio por Masud Khan). Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 7-62, 1988.

OUTEIRAL, J.; GRAÑA, R. *Donald W. Winnicott. Estudos (o autor e a obra)*. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 5-15, 1991.

2. O Meio Ambiente Facilitador (Desenvolvimento emocional primitivo)

WINNICOTT, D. W.: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 269-86, 1988.

WINNICOTT, D. W. (*Preocupação materna primária*) (1956). In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 491-98.

DAVIS, M.; WALLBRIDGE. *Limite e espaço*. Rio de Janeiro: Imago, 1982, p. 100-50.

VALLER, E. A teoria do desenvolvimento emocional de D. W. W. *Revista Brasileira de Psicanálise*. v. 24, n. 2, p. 155-70, 1990.

3. Objetos e Fenômenos Transicionais

WINNICOTT, D. W. *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 389-408, 1988.

4. O Papel de Espelho da Mãe

WINNICOTT, D. W. *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, p. 153-62, 1975.

LACAN, J. O estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nós é revelada na experiência analítica. In: LACAN, J. et al. *O sujeito, o corpo e a letra*. Lisboa: Arcádia, p. 29-48, 1977.

DOIN, C. O espelho e a pessoa. In: MELLO, J. *O ser e o viver*. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 147-73, 1981.

5. O Verdadeiro e o Falso Self

WINNICOTT, D. W. *O ambiente e os processos de maturação*. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 128-39, 1982.

DAVIS, M.; WALLBRIDGE. *Limite e espaço*. Rio de Janeiro: Imago, p. 50-69, 1982.

MELLO, J. *O ser e o viver*. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 112-30, 1981.

6. O Temor ao Colapso

WINNICOTT, D. W. *Explorações psicanalíticas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

7. A Mente e sua Relação com Psique-Soma

WINNICOTT, D. W. *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 409-26, 1988.

8. O Transtorno Psicossomático

WINNICOTT, D. W. *Explorações psicanalíticas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

9. As Raízes da Agressão e o Ódio na Contratransferência

WINNICOTT, D. W. O ódio na contratransferência. In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988; p. 341-54.

WINNICOTT, D. W. A agressão e sua relação com o desenvolvimento emocional. In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 355-76.

10. Aspectos Clínicos e Metapsicológicos da Regressão dentro do Setting Psicanalítico. Retraimento e Regressão

WINNICOTT, D. W. Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do setting psicanalítico. In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 459-82.

WINNICOTT, D. W. Retraimento e regressão. In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 427-36.

11. A Interpretação em Psicanálise: Exemplos Clínicos

WINNICOTT, D. W. *Explorações psicanalíticas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

WINNICOTT, D. W. *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, p. 79-93, 1976.

WINNICOTT, D. W. *Holding e interpretação*. Rio de Janeiro: Martins Fontes, p. 23-33, 1991.

12. Registros Pessoais de Análises com Winnicott

LITTLE, M. *Registro pessoal de uma análise com Winnicott*. Rio de Janeiro: Imago, p. 42-66, 1992.

GUNTRIP, H. My experience of analysis with Fairbairn and Winnicott. *International Review of Psychoanalysis*, v. 2, p. 145, 1975.

13. O Jogo do Rabisco (1968)

WINNICOTT, D. W. O jogo do rabisco (1964-1968). In: *Explorações psicanalíticas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

14. Defesas Maníacas (1935)

WINNICOTT, D. W. *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 247-68, 1988.

15. A Tendência Anti-Social (1956)

WINNICOTT, D. W. A tendência anti-social (1956). In: *Da Pediatria à Psicanálise*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 499-512.

16. Winnicott e Klein

WINNICOTT, D. W. Enfoque pessoal da contribuição kleiniana (1962). In: *O ambiente e os processos de maturação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983, p. 156-62.

WINNICOTT, D. W. *O gesto espontâneo*. (Carta de Winnicott à Melanie Klein, 17 de novembro de 1952.) Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 30-3, 1981.

17. O Uso de um Objeto (1968)

WINNICOTT, D. W. *Explorações psicanalíticas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

Para finalizar é necessário dizer algumas breves palavras sobre a tradução... Pareceu-nos oportuno não traduzir alguns termos fundamentais, ou, quando houve tradução, conservou-se os termos entre colchetes no inglês original, porque, ao fazê-lo, eles perderiam em essência e conteúdo. *Holding*, por exemplo, se traduzido por "sustentação" ou "suporte" não corresponderia à expressão utilizada pelo autor. Sugerimos que o leitor "brinque" com as palavras, criando para elas um sentido que se expressará mais afetivamente do que ao nível cognitivo ou da tradução formal e/ou literal.

Os textos estão aí para serem "usados". É como em um "jogo de rabiscos", no qual D. W. W. deu alguns traços e o leitor deve fazer os seus. Deste espaço transicional é que surgirão elementos criativos, espontâneos e concepções novas, às vezes prenhes de surpresas, indagações e paradoxos... assim é. Não tente "entender tudo" em cada trabalho para só então seguir para o outro. Faça como os Beatles (que D. W. W. tanto gostava) e "*Let it be*", ou "deixe estar..." e siga em frente. Boas brincadeiras para você. Divirta-se com os trabalhos de D. W. W.

José Ottoni Outeiral
Roberto Barberena Graña

Prefácio

Quando Donald Winnicott faleceu, em 1971, deixou mais de uma centena de palestras e artigos, longos e curtos, que nunca haviam sido publicados. Havia também muitos trabalhos publicados em antologias e revistas que nem sempre eram fáceis de ser obtidos. Nosso objetivo foi reunir esse material em livros sob o nome dele, e pelo fato de a natureza dos trabalhos variar tanto, de acordo com as diferentes audiências a que eram dirigidos, decidimos fazer nossas compilações, tanto quanto possível, de acordo com as platéias às quais se destinavam.

Os artigos deste livro são aqueles que consideramos ser de maior interesse para psicanalistas e psicoterapeutas, para quem, em verdade, a maioria deles foi escrita. Esta foi a última compilação em que trabalhamos com Clare Winnicott antes do seu falecimento, em abril de 1984 e para nós, portanto, constitui um lembrete vívido daquilo que ela partilhou conosco a fim de tornar possível este trabalho. É apropriado que suas reflexões a respeito de Donald Winnicott, como pessoa, apareçam no início desta compilação. Após sua morte, enquanto sua casa em Lower Belgrave Street, 49, estava sendo desocupada, alguns trabalhos — entre eles um certo número de artigos curtos — foram encontrados; quase todos eles foram incluídos aqui.

A editoração do texto dos trabalhos foi mantida em um mínimo. Naturalmente, houve menos dificuldades quando um artigo já havia sido publicado, mas em um ou dois casos em que encontramos o original do trabalho, demos preferência a esta versão àquela que acabou por ser impressa.

Antes de falecer, o próprio Winnicott pretendia efetuar novas compilações de sua obra. Com isto em mente, preparara (provavelmente em 1968 ou início de 1969) duas listas separadas de trabalhos, que incluíam, entre muitas outras coisas, quase todo o material que veio a constituir seu livro postumamente publicado, *O Brincar e a Realidade* (1971)*. Dessas listas, acham-se contidos no presente livro os seguintes trabalhos:

* Por já se acharem em sua maioria traduzidos para o português, mencionamos nesta língua os títulos dos textos mais conhecidos de Winnicott, deixando no original os nomes dos trabalhos de outros autores, à exceção dos mais fundamentais e conhecidos. Permaneceram em inglês, também, os títulos dos livros de D. W. W. e outros autores não publicados no país pela *Artes Médicas*, devido às variações que podem ocorrer entre os títulos originais e os títulos utilizados nas publicações nacionais. (N. do T. e N. dos R.)

A Excitação na Etiologia da Trombose Coronária (1957)
Psiconeurose na Infância (1961)
A Enfermidade Psicossomática em seus Aspectos Positivos e Negativos (1964)
Uma Nova Luz sobre o Pensar Infantil (1965)
O Conceito de Trauma em Relação ao Desenvolvimento do Indivíduo dentro da Família (1965)
A Psicologia da Loucura (1965)
O Conceito de Regressão Clínica Comparado com o de Organização Defensiva (1967)
O Uso da Palavra 'Uso' (1968)
Distúrbios Físicos e Emocionais em uma Adolescente (1968)
A Experiência Mãe-Bebê de Mutualidade (1969)
Fisioterapia e Relações Humanas (1969)

Assim como suas listas, duas pilhas de trabalhos, que colocara em ordem, foram encontrados após sua morte; elas continham a maioria dos artigos relacionados nas listas, bem como alguns outros, dos quais um, *O Medo do Colapso*, foi incluído aqui. Foram encontrados também alguns trabalhos assinalados no alto com as palavras *Pertencente ao Livro* e é provável que Winnicott tenha considerado utilizá-los (embora não os tenha de fato incluído) enquanto estava compilando *O Brincar e a Realidade*. Tais trabalhos incluem:

Adendo a "A Localização da Experiência Cultural" (1967)
A Interpretação na Psicanálise (1968)
O Pensar e a Formação de Símbolos (1968)
Raízes da Agressão (1968)

Afora estes trabalhos, alguns outros, escritos em 1969 e 1970, e, portanto, não incluídos nas listas de Winnicott, atendem aos critérios mais estritos para inclusão neste livro. Entre eles se encontram:

A Loucura da Mãe a Aparecer no Material Clínico como um Fator Estranho no Ego (1969)
A Base para o Self no Corpo (1970)
Individuação (1970)

Deveríamos também incluir nesta classe de escolha o relato, de Winnicott, anteriormente publicado em uma antologia de 1965, de *Um Caso de Psiquiatria Infantil que Ilustra a Reação Retardada à Perda*.

À parte estas considerações, que já se deslocam da evidência para a especulação, não temos maneira de dizer quanto do material reproduzido nesta compilação Winnicott teria considerado para publicação ou republicação, ou se ele o teria deixado em sua forma presente. Dezesseis anos, contudo, já se passaram desde sua morte, e parece-nos que, nesse período, o interesse em seu trabalho mais cresceu do que diminuiu. Suas contribuições de vulto ao pensamento psicanalítico são, sem sombra de dúvida, já conhecidas. Mas, na atualidade, parece apropriado reproduzir aqui, mesmo que às vezes sob a forma de notas, o trabalho efetuado em torno de conceitos tais como *brincar*, *elementos masculinos e femininos ex-cindidos** e *o uso de um objeto*.

Acreditamos também que a inclusão de material escrito a respeito da obra de Melanie Klein e outros analistas, amiúde sob a forma de resenhas de seus livros, ajuda a elucidar, entre outras coisas, a questão ainda difícil do relacionamento das formulações de Winnicott com o trabalho dos outros. Em uma rara ocasião, dirigindo-se informalmente a alguns de seus colegas, Winnicott falou ainda mais diretamente a respeito desse relacionamento; uma gravação em fita de sua conversa afortunadamente sobreviveu e incluímos uma transcrição dela ao final do livro.

* Palavra não dicionarizada a que demos preferência sobre *cindidos* e *expelidos* para traduzir *split-off*. (N. do T. e dos R.)

Achamos também importante publicar a maioria dos textos de Winnicott que expressam a sua preocupação — com frequência apaixonada — a respeito do emprego da leucotomia e da terapia de choque no tratamento dos mentalmente enfermos. Em 1943 e 1944, especialmente, ele gastou muito tempo e energia tentando fazer as pessoas pensarem e falarem a respeito dos efeitos psicológicos da terapia eletroconvulsiva, e, no começo da década de 1950, mostrou-se particularmente ativo em chamar a atenção do público para as considerações éticas que rodeavam o emprego da leucotomia. A maior parte do que escreveu na época ainda tem relevância hoje, pois, embora o tratamento pela leucotomia tenha se tornado coisa rara, a tendência — tão perturbadora para ele — a tornar enevoada a distinção entre as considerações éticas e as da eficácia não parece haver diminuído.

Grande parte do material remanescente poderia ser chamado de fragmentário, com boa parte dele achando-se sob a forma do que Winnicott chamava de “pedacinhos” de histórias clínicas. Muitos deles foram obviamente utilizados para ensino; outros foram possivelmente postos de lado para o caso de surgir a necessidade de ilustrar um ponto específico. Cada um deles tem algo a dizer.

O resultado de tudo isto é um livro de trabalhos distintos em extensão e conteúdo, e díspares também na forma da apresentação. Acreditamos que a nossa justificativa para havê-lo assim compilado reside não apenas no que ele contribuirá para a literatura especializada, mas também naquilo que pode revelar a respeito do desenvolvimento das idéias de Winnicott e do seu crescimento através da experiência.

Ray Shepherd
Madeleine Davis

Sumário

Agradecimentos	v
Apresentação à Edição Brasileira	vii
Prefácio por Ray Shepherd e Madeleine Davis	xvii
D.W.W.: Uma Reflexão <i>por Clare Winnicott</i>	1
PARTE 1 PSICANÁLISE: TEORIA E PRÁTICA	15
1 Desilusão Precoce (1939)	17
2 Saber e Não Saber: Um Exemplo Clínico (sem data)	20
3 Um Ponto de Técnica (sem data)	22
4 O Brinquedo na Situação Analítica (1954)	24
5 Fragmentos Referentes a Variedades de Confusão Clínica (1956) ..	26
6 A Excitação na Etiologia da Trombose Coronária (1957)	29
7 Alucinação e Desalucinação (1957)	33
8 Idéias e Definições (década de 50)	36
9 Psicogênese de uma Fantasia de Espancamento (1958)	38
10 Nada no Centro (1959)	41
11 O Destino do Objeto Transicional (1959)	44
12 Notas sobre o Brinquedo (sem data)	49
13 Psiconeurose na Infância (1961)	53
14 Observações Adicionais sobre a Teoria do Relacionamento Parento- filial (1961)	59
15 Uma Nota sobre um Caso Envolvendo Inveja (1963)	62
16 Perversões e Fantasia Pré-Genital (1963)	65
17 Duas Notas sobre o Uso do Silêncio (1963)	66
18 O Medo do Colapso (<i>Breakdown</i>) (1963)	70

19	A Importância do <i>Setting</i> no Encontro com a Regressão na Psicanálise (1964)	77
20	Transtorno [<i>disorder</i>] Psicossomático	82
	I. A Enfermidade Psicossomática em seus Aspectos Positivos e Negativos (1964)	82
	II. Nota Adicional sobre Transtorno Psicossomático (1969)	91
21	A Psicologia da Loucura: Uma Contribuição da Psicanálise (1965)	94
22	O Conceito de Trauma em Relação ao Desenvolvimento do Indivíduo dentro da Família (1965)	102
23	Notas sobre Retraimento e Regressão (1965)	116
24	Uma Nova Luz sobre o Pensar Infantil (1965)	119
25	Comentário sobre Neurose Obsessiva e <i>Frankie</i> (1965)	124
26	Nota sobre o Relacionamento Mãe-Feto (década de 60)	127
27	Ausência e Presença de um Sentimento de Culpa, Ilustradas em Duas Pacientes (1966)	129
28	Sobre os Elementos Masculinos e Femininos Ex-cindidos [<i>split-off</i>]	133
	I. Os Elementos Masculinos e Femininos Ex-cindidos Encontrados em Homens e Mulheres (1966)	134
	II. Material Clínico (1959-1963)	144
	III. Resposta a Comentários (1968-1969)	148
29	O Conceito de Regressão Clínica Comparado com o de Organização Defensiva (1967)	151
30	Adendo a <i>A Localização da Experiência Cultural</i> (1967)	157
31	O Brincar e a Cultura (1968)	160
32	A Interpretação na Psicanálise (1968)	163
33	O Pensar e a Formação de Símbolos (1968)	167
34	Sobre <i>O Uso de um Objeto</i>	170
	I. O Uso de um Objeto e o Relacionamento através de Identificações (1968)	171
	II. Um Sonho de D.W.W. Relacionado a uma Resenha de um Livro de Jung (1963)	178
	III. Notas Escritas no Trem, <i>Parte 2</i> (1965)	180
	IV. O Uso da Palavra <i>Uso</i> (1968)	181
	V. Ilustração Clínica de <i>O Uso de um Objeto</i> (1968)	183
	VI. Comentários sobre meu Artigo <i>O Uso de um Objeto</i> (1968)	185
	VII. O Uso de um Objeto no Contexto de <i>Moisés e o Monoteísmo</i> (1969)	187
35	Desenvolvimento do Tema do Inconsciente da Mãe, tal como Descoberto na Prática Psicanalítica (1969)	192
36	A Experiência Mãe-Bebê de Mutualidade (1969)	195
37	Sobre as Bases para o <i>Self</i> no Corpo	203
	I. As Bases para o <i>Self</i> no Corpo (1970)	203
	II. Dois Outros Exemplos Clínicos (1970)	211
38	Individuação (1970)	219

PARTE 2	PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	223
39	Clínica Particular (1955)	225
40	O Jogo do Rabisco [<i>Squiggle Game</i>] (1964-1968)	230
41	O Valor da Consulta Terapêutica (1965)	244
42	Deduções a partir de uma Entrevista Psicoterapêutica com uma Adolescente (1964)	249
43.	Um Caso de Psiquiatria Infantil que Ilustra a Reação Retardada à Perda (1965)	260
44	Distúrbios Físicos e Emocionais em uma Adolescente (1968)	283
45	A Loucura da Mãe tal como Aparece no Material Clínico como Fator Estranho ao Ego (1969)	287
PARTE 3	SOBRE O TRABALHO DE OUTROS ANALISTAS	295
46	Susan Isaacs	
	I. Obituário (1948)	295
	II. Prefácio a <i>Susan Isaacs</i> , de D.E.M. Gardner (1968)	297
47	Marion Milner	
	Nota Crítica de <i>On Not Being Able to Paint</i> (1951)	299
48	Ernest Jones	
	I. Obituário (1958)	301
	II. Discurso Fúnebre (1958)	309
49	Dorothy Burlingham	
	Resenha de <i>A Study of Three Pairs of Identical Twins</i> (1953)	312
50	W.R.D. Fairbairn	
	Resenha de <i>Psycho-Analytic Studies of the Personality</i> (1953)	316
51	John Bowlby	
	I. Resenha de <i>Maternal Care and Mental Health</i> (1953)	323
	II. Debate de <i>Grief and Mourning in Infancy</i> (1959)	326
52	Michael Balint	
	I. Tipos de Caráter: O Temerário e o Cauteloso (1954)	331
	II. Resenha de <i>The Doctor, His Patient and the Illness</i> (1958)	334
53	Melanie Klein: Sobre o seu Conceito da Inveja	
	I. Resenha de <i>Envy and Gratitude</i> (1959)	338
	II. Primórdios de uma Formulação de uma Apreciação e Crítica do Enunciado Kleiniano da Inveja (1962)	340
	III. Raízes da Agressão (1968)	348
	IV. Contribuição a um Simpósio sobre Inveja e Ciúme (1969)	350
54	Joseph Sandler	
	Comentários sobre <i>On the Concept of the Superego</i> (1960)	353
55	Sigmund Freud	
	Resenha de <i>Letters of Sigmund Freud, 1873-1939</i> (1962)	359
56	Harold F. Searles	
	Resenha de <i>The Non-Human Environment in Normal Development and in Schizophrenia</i> (1963)	362

57	C. G. Jung Resenha de <i>Memories, Dreams, Reflections</i> (1964)	365
58	Erik H. Erikson Resenha de <i>Childhood and Society</i> (1965)	373
59	Virginia Axline Um Comentário sobre <i>Play Therapy</i> (década de 1960)	375
60	Willi Hoffer Um Tributo por Ocasão do Septuagésimo Aniversário de Hoffer (1967)	378
61	James Strachey Obituário (1969)	384
62	Anna Freud Resenha de <i>Indications for Child Analysis and Other Papers</i> (1969)	388
PARTE 4 SOBRE OUTRAS FORMAS DE TRATAMENTO		391
63	Terapia Física do Transtorno Mental: Terapia de Convulsão	393
	I. Tratamento da Doença Mental pela Indução de Convulsões (1943)	394
	II. Tratamento de Choque do Transtorno Mental (1943)	398
	III. Terapia de Choque (1944)	399
	IV. Introdução a um Simpósio sobre a Contribuição Psicanalítica à Teoria da Terapia de Choque (1944)	400
	V. Tipos de Efeitos Psicológicos da Terapia de Choque (1944)	403
	VI. Terapia Física do Transtorno Mental (1947)	406
64	Terapia Física do Transtorno Mental: Leucotomia	412
	I. Leucotomia Pré-Frontal (1958)	412
	II. Leucotomia (1949)	413
	III. Notas sobre as Implicações Gerais da Leucotomia (1951)	416
	IV. Leucotomia Pré-Frontal (1956)	420
65	Terapia Ocupacional Resenha do Livro de Adrian Hill, <i>Art Versus Illness</i> (1949)	422
66	Terapia Comportamental (1969)	424
67	Fisioterapia e Relações Humanas (1969)	427
	Pós-escrito: D.W.W. sobre D.W.W.	433
	Índice Remissivo	445

D.W.W.: Uma Reflexão

por Clare Winnicott

Oh, horas de infância, horas quando por trás das figuras havia mais que o mero passado e o que tínhamos à nossa frente não era o futuro! É certo, estávamos crescendo, e, às vezes, apressávamo-nos por ficar adultos, em parte por causa daqueles a quem nada havia restado a não ser a sua qualidade de adultos. Quando sozinhos, contudo, entretínhamo-nos com a perenidade: nela permaneceríamos, no intervalo deixado entre o mundo e o brinquedo, num lugar que, desde o próprio início, havia sido estabelecido para um evento puro.

Rainer Maria Rilke

Há alguns anos, os organizadores de um livro sobre objetos e fenômenos transicionais¹ convidaram-me a escrever algo de natureza pessoal a respeito de D.W.W. Parece-me que o que escrevi sobre ele então, embora naturalmente estivesse mantendo o tema da área transicional à frente de minha mente, é central para entender a totalidade daquilo que ele alcançou.

Comecei por duas perguntas: o que havia com D.W.W. que tornou inevitável a exploração da área transicional e fez seu uso clinicamente produtivo? Foi minha tentativa de responder a estas perguntas que resultou na contribuição que se seguiu, fornecida aqui com muito poucas alterações.

Sugiro que as respostas devam ser buscadas não simplesmente num estudo do desenvolvimento das idéias de D.W.W. à medida que ele avançava, mas essencialmente, no tipo de personalidade que funcionava por detrás delas. Poderia parecer, portanto, que eu estivesse dizendo que esses conceitos surgiram de modo fácil e natural de sua própria maneira de vida. Em certo sentido, isso é verdade, mas é apenas metade da história. O restante refere-se a períodos de dúvida, incerteza e confusão, dos quais forma e significado acabaram por emergir.

D.W.W. podia ficar excitado com as idéias de outras pessoas, mas só podia utilizá-las e sobre elas erguer algo após haverem passado pela *refinaria* de sua própria experiência. Nessa ocasião, infelizmente, ele com freqüência havia esquecido a fonte e podia, como aconteceu, esquecer de algumas pessoas com sua falta de reconheci-

1. *Between Reality and Fantasy*, org. de Simon A. Grohnick e Leonard Barkin (New York, London: Jason Aronson, 1978).

mento. Embora as idéias de outras pessoas o enriquecessem como clínico e como pessoa, era a elaboração de idéias baseadas na prática clínica que realmente o absorvia e com a qual se engalfinhou até o fim de sua vida. Tratava-se de um processo criativo no qual ficava totalmente envolvido. Em seu trabalho clínico, D.W.W. tomou como meta ingressar em todas as situações sem as defesas de seu saber, de maneira a ficar tão exposto quanto possível ao impacto da própria situação. Do seu ponto de vista, esta era a única maneira pela qual a descoberta e o crescimento se tornavam possíveis, tanto para si quanto para os seus pacientes. Esta abordagem era mais do que uma postura; era uma disciplina essencial e acrescentou a sua vida uma dimensão tão vital para ele quanto o ar puro.

Faz-se às vezes a pergunta de por que D.W.W., em seus textos, parecia principalmente interessado em explorar a área do primeiro relacionamento bipessoal. Estritamente falando, isto não é verdade: ele escreveu sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo adolescência, delinquência e outros assuntos de interesse médico e sociológico, e a maior parte de sua clínica psicanalítica era composta de adultos. Entretanto, poderia ser verdade dizer que a sua principal contribuição, provavelmente mostra-se no estudo dos relacionamentos iniciais e a aplicação dele à etiologia das psicoses e dos mecanismos psicóticos em todos nós. Sugiro que o seu estudo tenha tomado esta direção a partir de duas fontes. Em primeiro lugar, ele trouxe consigo para a psicanálise tudo o que havia aprendido e continuou aprendendo com a pediatria, e, em segundo, na época em que chegou à psicanálise, a área de estudo que então se abria era a referente às experiências iniciais da vida. Consideradas sua personalidade, sua formação e sua experiência, bem como sua premência à descoberta, parece inevitável que concentrasse suas pesquisas na área até então relativamente inexplorada da primeiríssima infância e da infância propriamente dita. Suas descobertas, contudo, são reconhecidas por muitos como possuindo implicações que vão muito além da área imediata de estudo, e é opinião expressa de alguns que elas lançam luz sobre todas as áreas do viver.

Como sugeri, a pista essencial para o trabalho de D.W.W. sobre objetos e fenômenos transicionais pode ser encontrada em sua própria personalidade, em sua maneira de relacionar-se e de fazer os demais com ele se relacionarem, e em todo o seu estilo de vida. O que quero dizer é que foi a sua *capacidade de brincar*, que nunca lhe desertou, que o conduziu de modo inevitável para a área de pesquisa que conceituou em termos de objetos e fenômenos transicionais. Não é meu propósito aqui debater os pormenores de sua obra, mas parece importante notar que, nos termos dele, a capacidade de brincar é igualada a uma *qualidade do viver*. Em suas próprias palavras: "O brincar é uma experiência, sempre uma experiência criativa, e uma experiência num contínuo espaço-tempo, uma forma básica de viver"².

Esta qualidade de viver impregna todos os níveis e aspectos do experienciar e do relacionar-se, incluindo até mesmo o nível sofisticado que é descrito em seu artigo *O Uso de um Objeto*, no qual, em suas próprias palavras, "é a pulsão destrutiva que cria a qualidade da exterioridade, e, ainda, "esta qualidade de 'estar sendo sempre destruído' torna a realidade do objeto sobrevivente sentida como tal, fortalece o tom do sentimento e contribui para a constância objetal"³. Para ele, a destruição do objeto na fantasia inconsciente é semelhante a um processo de limpeza, que facilita, repetidas vezes, a descoberta, de novo, do objeto. Trata-se de um processo de purificação e renovação.

2. *Playing: A Theoretical Statement* (1968). In: *Playing and Reality*. London, Tavistock; New York: Basic Books, 1971; Penguin, (1974).
3. Ver *Playing and Reality* e, também, o Capítulo 34 deste livro.

Havendo dito isto, vejo minha contribuição como uma tentativa de lançar alguma luz sobre a capacidade de brincar de D.W.W. Espero que os leitores se achem suficientemente familiarizados com os textos dele sobre o assunto para saberem que não estou falando de brincar jogos e brinquedos, mas sim sobre a capacidade de operar na área intermediária sem limites, em que a realidade interna e a realidade externa se compõem na experiência de viver. Espero não estar sugerindo que D.W.W. vivesse em um estado de exaltação permanente, porque isso está longe de ser o caso. Ele com frequência achava dura a vida e podia ficar desanimado, deprimido e muito zangado, mas dando-lhe tempo, saía disso e abrangia essas experiências à sua própria maneira, sem ficar atravancado por ressentimentos e preconceitos. Durante seus últimos anos de vida, a realidade de sua própria morte tinha de ser transposta e ele o fez, mais uma vez de modo gradativo e à sua própria maneira. Eu estava sempre pressionando-o a escrever uma autobiografia, por achar que seu estilo de escrever se prestaria a uma tarefa desse tipo. Ele começou a fazê-lo, mas dela existem apenas algumas páginas e, de modo típico, utilizou este exercício para lidar com o seu problema imediato de vida, que era o da morte. Sei que o usou desta maneira porque manteve este caderno consigo e só o vi após o seu falecimento.

O título da autobiografia ia ser *Nada Menos que Tudo* e a aba interna do caderno diz o seguinte:

T.S. Eliot "Custando nada menos que tudo".
T.S. Eliot "O que chamamos começo é amiúde o fim
E chegar a um fim é chegar a um início.
É do fim que começamos".

Prece

D.W.W. — Oh, Deus! Possa eu estar vivo quando morrer.

Na seqüência destas palavras, ele começou a escrever o texto inicial imaginando descrever o fim de sua vida. Citarei suas próprias palavras:

Morri.

Não foi muito bom, e levou um longo tempo, segundo pareceu (mas foi apenas um momento na eternidade).

Tinha havido ensaios (uma palavra difícil de soletrar* e descobri que havia deixado fora o "a". O carro fúnebre [*hearse*] era frio e inamistoso).

Quando a hora chegou, eu sabia tudo a respeito do pulmão cheio d'água que o coração não podia manejar, de maneira que não havia circulação suficiente de sangue nos alvéolos, e existiam tanto uma mingua de oxigênio quanto um afogamento. Mas, para ser justo, eu havia tido um bom tempo: não devia resmungar, como nosso velho jardineiro costumava dizer...

Deixem-me ver. O que estava acontecendo quando morri? Minha prece tinha sido atendida. Eu estava vivo quando morri. Isso fora tudo o que havia pedido e o havia conseguido. (Isto me faz sentir horrível, porque tantos de meus amigos e contemporâneos morreram na I Guerra Mundial e nunca me liberei da impressão de que o fato de eu estar vivo é uma faceta de uma coisa só, da qual a morte deles pode ser vista como outras facetas: algum imenso cristal, um corpo com integridade e forma intrínsecas em si).

Prossegue então debatendo a dificuldade que um homem tem de morrer sem um filho para imaginativamente matar e sobreviver-lhe: "para fornecer a única continuidade que os homens conhecem. As mulheres *são* contínuas". Este dilema é deba-

* Em inglês, *rehearsals*; ver adiante "carro fúnebre". (N. do T.)

tido em termos do Rei Lear e de seu relacionamento com a filha que deveria ter sido um rapaz.

Tenho esperança de que estas citações dêem alguma idéia da capacidade que D.W.W. tinha de chegar a um acordo com a realidade interna e externa de maneira brincalhona, acordo que torna a realidade suportável para o indivíduo, de maneira que a denegação pode ser evitada e a experiência de viver ser tão plenamente realizada quanto possível. Nas suas próprias palavras, “pode-se dizer que o brincar chega ao seu próprio ponto de saturação, que se refere à capacidade de conter experiências”⁴. Ele tinha avidez por experiências e teria odiado perder a experiência interna da realidade de sua própria morte; imaginativamente, alcançou-a. Em conversa, ele com freqüência se referia ao dia de sua morte de maneira descuidada, mas eu sabia que estava tentando nos deixar — a ele e a mim — acostumados à idéia de que o dia chegaria.

Havendo começado pelo fim de sua vida, tenho agora de retornar aos primórdios e relatar algo a respeito de seus primeiros anos e dos anos que ele e eu passamos juntos. Limitarei o que disser a uma tentativa de ilustrar o tema do brincar, porque foi central à sua vida e obra.

Primeiro tenho de fixar o cenário em que ele cresceu, um cenário provinciano essencialmente inglês em *Plymouth*, em Devon, e que se achava longe de Londres, não apenas em distância, mas também em costumes e convenções. Quando íamos de carro de Plymouth para Londres, ele sempre vibrava quando chegávamos ao lugar em que a cor do aterro ao lado da estrada mudava para a terra de cor vermelha de Devon. A riqueza do solo trazia-lhe de volta a riqueza de seu início de vida, com o qual jamais perdera contato. Naturalmente, na viagem de volta, ele ficava igualmente satisfeito por estar deixando-o atrás de si, mas tinha orgulho de ser um homem de Devon e de que existisse uma aldeia com o nome de Winnicott no mapa desse condado. Nós nunca realmente encontramos a aldeia, embora sempre pretendêssemos fazê-lo. Bastava que ela estivesse lá.

O lar dos Winnicott era grande e movimentado, com muita atividade, havia espaço para todos na grande casa e jardim e não faltava dinheiro. Havia uma horta, um pomar, um gramado para jogar críquete, uma quadra de tênis e um açude e árvores altas fechavam todo o jardim. Havia uma árvore especial, nos ramos da qual Donald costumava fazer seus deveres de casa, nos dias anteriores à sua ida para a escola interna. Das três crianças da família, Donald era o único menino, e as irmãs, que ainda moram na casa, eram cinco e seis anos mais velhas que ele. Não há dúvida de que os pais da família Winnicott eram o centro da vida dos filhos e que a vitalidade e a estabilidade de todo o lar deles emanavam. A mãe era vivaz, gostava de sair e era capaz de demonstrar e expressar os sentimentos com facilidade. Sir Frederick Winnicott (título que mais tarde recebeu) era delgado e alto e apresentava uma postura e uma dignidade tranquilas, da velha escola, bem como profundo senso de humor. Aqueles que o conheceram falam dele como sendo uma pessoa de alta inteligência e julgamento correto. Ambos os pais tinham senso de humor.

Do outro lado da estrada havia outro lar dos Winnicott, onde viviam o tio Richard Winnicott (irmão mais velho de Frederick), sua esposa e cinco primos, três meninos e duas meninas. Os primos foram criados quase como se fossem uma só família, de maneira que nunca houve escassez de companheiros de brinquedo. Uma das irmãs disse recentemente que a pergunta “O que posso fazer?” nunca foi formulada na casa deles. Havia sempre alguma coisa para fazer, e espaço para fazê-la e alguém com quem fazê-la, se necessário. Mais importante, porém, havia sempre a

4. De *Playing: A Theoretical Statement*.

vitalidade e a imaginação das próprias crianças para façanhas de todos os tipos. A família de Donald, incluindo os seus pais, era musical, e uma das irmãs tornou-se mais tarde uma pintora bem-dotada. A casa também incluía uma babá e uma governanta, mas elas não parecem haver estorvado as energias naturais das crianças por qualquer maneira irrazoável. Talvez fosse mais correto dizer que as crianças dos Winnicott fugiam com sucesso aos estorvos. Quando criança pequena, Donald foi certamente devotado à sua babá, e uma das primeiras coisas que recordei haver feito com ele, anos mais tarde, em Londres, foi procurá-la e certificar-se de que se achava bem e vivendo com conforto. Descobrimos que a pessoa mais importante da vida dela então (1950) era o seu próprio sobrinho, Donald.

É indiscutível que, desde seus primeiros anos, Donald Winnicott não teve dúvidas de que era amado e experienciou, no lar dos Winnicott, uma segurança que podia tomar como evidente. Num lar deste tamanho, havia uma abundância de oportunidades para muitos tipos de relacionamentos e campo de ação para que as inevitáveis tensões fossem isoladas e solucionadas dentro do arcabouço total. Partindo desta posição básica, Donald era então livre para explorar todos os espaços disponíveis da casa e do jardim que o rodeavam, encher esses espaços com seus próprios fragmentos e, dessa maneira, gradualmente tornar próprio o seu mundo.

Esta capacidade de *sentir-se em casa* serviu-lhe bem através de toda a sua vida. Há uma canção popular que diz: "O lar está em meu coração". Esta foi certamente a maneira pela qual Donald o experienciou e isto lhe concedeu uma liberdade imensa que o capacitou a sentir-se em casa em qualquer lugar. Quando viajávamos pela França e parávamos em pequenas estalagens de beira de estrada, em cada lugar eu pensava comigo mesma: "Estou só pensando quanto tempo vai levar para ele instalar-se na cozinha". A cozinha, naturalmente, era o centro do estabelecimento, e ele, com certeza, quase sempre encontrava o caminho dela de alguma maneira. Na realidade, adorava cozinhas e, quando criança, a mãe queixava-se de que ele passava mais tempo na cozinha, com a cozinheira, do que no resto da casa.

Devido ao fato de Donald ser o membro bem mais jovem do lar dos Winnicott (mesmo o primo mais moço que morava em frente era mais velho que ele) e de ser tão amado e ser, em si mesmo, merecedor de amor, parece provável que um esforço tenha sido feito, particularmente por parte da mãe e das irmãs, para não deixá-lo mimado. Embora isto não o privasse de sentir-se amado, acho que o privou de uma certa intimidade e proximidade de que necessitava. Mas, como Donald possuía (assim como suas irmãs ainda têm) uma capacidade natural para comunicar-se com crianças de quase todas as idades, a comunicação entre crianças e adultos na casa dos Winnicott deve ter sido de alta ordem. Naturalmente, todos eles possuíam um irrepreensível senso de humor e isto, juntamente com a felicidade e a segurança de seu pano de fundo, significou que não existiam "tragédias" na casa, mas apenas episódios divertidos. Há não muitos anos atrás, quando a caixa d'água do telhado vazou, provocando consideráveis inundações e danos, eles ficaram mais excitados e divertidos do que alarmados por esse acontecimento inesperado.

Neste ponto, gostaria de citar outra página das notas autobiográficas de Donald. Antes de fazê-lo, tenho de explicar que o jardim da casa dos Winnicott tinha quatro níveis. No mais baixo, havia o gramado de *críquete*; depois, uma ladeira íngreme (o Monte Everest para uma criança pequena) que conduzia ao nível do açude; a seguir uma outra ladeira, mais suave, levando ao gramado que era uma quadra de tênis e, finalmente, um lance de degraus conduzindo ao nível da casa.

Então aquela ladeira que subia do gramado de *críquete* para a parte plana onde há um açude, e onde havia outrora uma moita de capim dos pampas entre os freixos e chorões (a propósito, vocês sabem que ruidos excitantes faz o capim dos pampas numa tarde

quente, quando as pessoas estão deitadas sobre mantas ao lado do açude, lendo ou dormitando?). Aquela ladeira está carregada como as pessoas diriam, carregada de história. Foi nela que eu peguei o meu próprio e exclusivo malho de *críquete* (cuja empunhadura tinha por volta de uns trinta centímetros de comprimento, pois eu contava apenas três anos de idade) e amassei com uma violenta pancada o nariz da boneca de cera que pertencia às minhas irmãs e que se tornara uma fonte de irritação em minha vida, porque era com essa boneca que meu pai costumava me apouquentar. A boneca era chamada Rosie. Parodiando alguma canção popular, ele costumava dizer (debochando de mim com a voz que usava):

Rosie disse para Donald

Eu amo você

Donald disse para Rosie

Não acredito em você.

(Talvez os versos fossem ao contrário, não me lembro mais). Mas eu sabia que a boneca tinha de ser destruída, e grande parte de minha vida se fundou no fato indubitável de que eu realmente *cometi* esse ato, não meramente o desejei e planejei.

Fiquei talvez um tanto aliviado quando meu pai pegou uns fósforos e, aquecendo suficientemente o nariz de cera, remodelou-o de maneira a que o rosto mais uma vez se tornasse um rosto. Esta demonstração inicial do ato restitutivo e reparador certamente causou impressão em mim e talvez me tenha tornado capaz de aceitar o fato de que eu próprio, uma criança querida e inocente, havia na realidade me tornado violento, diretamente com uma boneca, mas indiretamente como meu bem-humorado pai, que se achava então apenas ingressando em minha vida consciente.

E ainda, para citar mais o caderno de notas:

Ora, minhas irmãs eram mais velhas que eu, cinco e seis anos, de maneira que em certo sentido eu era um filho único com múltiplas mães e com um pai, em meus anos iniciais, extremamente preocupado com assuntos da cidade e de negócios. Ele foi prefeito por duas vezes e acabou por receber o grau de cavaleiro, bem como, depois (como agora se diz), a chave da cidade de *Plymouth*. Ele sentia a sua falta de instrução (tivera dificuldades de aprendizagem) e sempre disse que, por causa disso, não tivera aspirações ao Parlamento, mas se ativera à política local, bastante vivaz naqueles dias na distante *Plymouth*.

Meu pai tinha uma fé (religiosa) simples e certa vez, quando lhe fiz uma pergunta que poderia nos ter envolvido em uma longa discussão, ele apenas respondeu: "Leia a Bíblia, e o que encontrar lá será a resposta verdadeira para você", de maneira que deixaram-me, graças a Deus, ir em frente com isso por mim próprio.

Um dia, porém, quando (aos doze anos de idade) cheguei em casa para o almoço e disse "porcaria", meu pai pareceu sentido como somente ele podia parecer, culpou minha mãe por não cuidar de que eu tivesse amigos apropriados e, a partir daquele momento, preparou-se para enviar-me para a escola interna, o que fez quando completei treze anos.

"Porcaria" soa muito inocente como palavrão, mas ele estava com a razão: o menino que era o meu novo amigo não era bom e ele e eu poderíamos ter tido problemas se houvéssemos sido deixados a nós próprios.

A amizade foi, então, na realidade rompida ali, e esta demonstração de força por parte do pai constituiu um fator importante no desenvolvimento de Donald. Em suas próprias palavras: "De maneira que meu pai se achava lá, para matar e ser morto, mas é provavelmente verdade que, nos primeiros anos, ele me tenha deixado entregue demais às minhas mães. As coisas nunca se corrigem inteiramente sozinhas, elas próprias".

E assim Donald partiu para a *Escola Leys*, de Cambridge, e encontrou-se em seu elemento. Para seu grande prazer, as tardes eram livres e ele corria, andava de bicicleta, nadava, jogava *rugby*, entrou para os escoteiros da escola, fez amigos e cantou no coro, e, cada noite, lia em voz alta uma história para os meninos de seu dormitório. Ele lia extremamente bem e anos mais tarde vim a beneficiar-me desta qualidade, porque nunca nos encontramos sem um livro que ele estivesse lendo em

voz alta para mim. Certa véspera de Natal, sentado no chão (nunca nos sentávamos em cadeiras), leu a noite inteira, porque o livro era irresistível. Ele lia de maneira dramática, saboreando o texto por completo.

Donald descreveu-me a sua partida para a escola. Toda a família estava lá para despedir-se e ele acenava com a mão e ficava triste por partir até perdê-los de vista pela entrada do trem em um túnel bastante longo, logo na saída de Plymouth. Através de todo esse túnel ele se acostumava com a idéia de ir embora, mas, quando dele saía, do outro lado, deixava-os atrás de si e começava a antever a ida para a escola. Com frequência, abençoava o túnel por conseguir honestamente sentir pena por partir até o momento de ingressar nele.

Tenho em meu poder uma carta que Donald escreveu para a mãe, da escola, e que mostra o tipo de interação existente entre os membros da família:

Muito querida Mãe,

No dia 2 de setembro todos os verdadeiros escoteiros pensam nas mães, por ser o aniversário da mãe de Baden Powell quando ela era viva.

Dessa maneira, quando receber esta carta estarei pensando na senhora em particular e só espero que a receba pela manhã.

Contudo, para me agradar muito, tenho de incomodá-la pedindo-lhe que me faça um pequeno favor. Antes de virar a página, quero que a senhora vá até o meu quarto e tire do armário da direita um pacotinho... E então, já o abriu? Bem, espero que goste. Pode trocá-lo no Popham's se não gostar, somente que, se o fizer, terá de pedir para falar com o Número 1, que sabe a respeito.

Tive umas férias formidáveis e não posso agradecer-lhe o bastante por tudo o que fez e por sua doação para os escoteiros.

A minha casa é uma casa linda e só desejo que possa viver à altura dela. Farei o que puder, contudo, trabalharei duro, e isso é tudo o que posso fazer no momento.

Transmita o meu amor aos outros; agradeça a Papai por seus jogos de bilhar e a V. e K. [suas irmãs] por serem tão boas e bobas por me fazerem rir. Contudo, sendo Dia das Mães, a maior parte do amor vai para a senhora,

de seu filho que muito a quer
Donald.

Algumas pessoas que leiam este relato abreviado do começo da vida e dos relacionamentos familiares de D.W.W., podem ficar inclinados a achar que ele soa bom demais para ser verídico. Mas a verdade é que esse início *foi* bom e, por mais que tente, não consigo apresentá-lo sob qualquer outra luz. Essencialmente, ele era uma pessoa profundamente feliz, cuja capacidade de sentir prazer nunca deixou de triunfar sobre os reveses e desapontamentos que lhe surgiram no caminho. Ademais, há um sentido em que a qualidade de seu início de vida e a apreciação que sentia por ele em si próprio, apresentou-se um problema de vulto: o de libertar-se da família e estabelecer sua própria e separada vida e identidade sem sacrificar a riqueza de que auferira, e tomou-lhe um longo tempo efetuar isso.

Foi quando Donald se achava no hospital da escola, por haver quebrado a clavícula no campo de esportes, que consolidou na própria mente a idéia de tornar-me médico. Referindo-se a essa época, amiúde dizia: "Pude ver que, pelo resto de minha vida, se me machucasse ou ficasse doente, teria de depender de médicos; a única saída para essa posição era tornar-me médico eu próprio e desde então a idéia, como uma proposição real, esteve sempre em minha mente, embora soubesse que papai esperava que eu ingressasse em seu florescente negócio e acabasse por assumir de suas mãos".

Um dos amigos de escola de Donald, Stanley Ede (que permaneceu sendo seu amigo por toda a vida), com frequência parara na casa dos Winnicott e era bem-conhecido de toda a família. De volta à escola após uma visita à casa, Donald, então com

dezesseis anos, escreveu o seguinte em uma carta dirigida ao amigo que ainda não retornara à escola:

Caro Stanley,

Muito obrigado pela encantadora e longa carta que me enviou esta semana. Foi tremendamente bom você se dar a esse trabalho e querer fazê-lo...

Papai e eu estivemos tentando, consciente e, talvez, inconscientemente, descobrir qual a ambição do outro com relação ao meu futuro. Do que ele havia dito, eu estava certo de que ele queria, mais do que qualquer outra coisa, que eu ingressasse em seu negócio. Dessa maneira, mais uma vez conscientemente e não, encontrei todos os argumentos em favor da idéia e não pensei muito a respeito de qualquer outra coisa, a fim de não ficar decepcionado. Assim, ensinei-me a prezar a vida comercial com todo o meu coração e pretendi ingressar nela e agradar a meu pai e a mim mesmo.

Quando sua carta chegou ontem, você pode ter esperado que ela me tenha decepcionado. Mas — e estou lhe dizendo tudo o que sinto — fiquei tão excitado que todos os sentimentos armazenados a respeito de médicos que eu havia engarrafado por tantos anos pareceram explodir e borbulhar imediatamente. Você sabe que — no mesmo grau em que Algy queria ir para um mosteiro — eu quis por muitíssimo tempo ser médico, mas sempre tive medo de que meu pai não o quisesse, de maneira que nunca mencionei o assunto e — parecido com Algy — cheguei mesmo a sentir repulsa pelo pensamento.

Esta tarde, fiz uma caminhada de oito milhas até a Estrada Romana com Chandler e contamos um ao outro tudo o que sentíamos, e, especialmente, contei-lhe aquilo que agora acabei de lhe contar. Oh, Stanley!

De seu ainda sóbrio e verdadeiro —
ainda que aparentemente inebriado —
mas, apesar disso, devotado amigo
Donald

Parece que Stanley, um ano mais velho que Donald, oferecera-se para abordar o assunto do futuro deste com o pai, e que o fizera. Existe um cartão postal dirigido a Stanley que diz: "Infinitamente grato por haver dito a papai o que disse e quando o disse. Escrevi a ele uma carta que acredito o tenha quase convencido".

Donald relata que quando conseguiu reunir coragem para ir até o Diretor da escola e dizer-lhe que queria ser médico, o Diretor grunhiu e olhou-o fixamente por longo tempo, antes de responder lentamente "Rapaz, não é brilhante, mas serve". De maneira que ele foi para o *Jesus College*, em Cambridge, e formou-se em biologia. Seu quarto, em Cambridge, era popular como ponto de encontro, porque ele havia alugado um piano, tocava-o sem cessar e tinha uma boa voz de tenor para o canto.

A I Guerra Mundial, contudo, estava acontecendo, e seu primeiro ano como estudante de medicina passou-o ajudando nos colégios de Cambridge, que haviam sido transformados em hospitais militares. Um dos pacientes, que se tornou um amigo de toda a vida, lembra-se de Donald nesses dias: "A primeira vez que o vi foi no hospital, em Cambridge, em 1916, na I Guerra; era um estudante de medicina que gostava de cantar uma canção cômica nas noites de sábado, na enfermaria, e cantava *Bolinhas de Maçã* e nos alegrava a todos".

Constituiu para ele fonte de profundo pesar e conflito que todos os seus amigos entrassem imediatamente para o exército, mas que, como estudante de medicina, Donald dele se achasse isento. Muitos amigos íntimos foram mortos no começo da guerra e toda a sua vida foi afetada por isso, porque sempre sentiu que tinha uma responsabilidade de viver por aqueles que haviam morrido, assim como por si próprio.

O tipo de relacionamento com amigos que tinha por essa época em Cambridge é ilustrado pela carta de um amigo que já se alistara no exército e estava assistindo a um curso para oficiais em Oxford. Ela foi escrita no *Exeter College*, de Oxford, e tem a data de 28 de novembro de 1915:

O que é que você vai fazer sábado para o chá? Bem, eu vou lhe dizer! *Você vai dar um grande Chá de Cambridge para você, para mim e para Southwell* (do Caius) [*Caius College, Cambridge*], que você já encontrou, acho eu. Ele é um sujeito dos melhores e recebeu uma patente. Se você não o conheceu, tem de conhecê-lo, e, de qualquer maneira, já me ouviu falar a respeito dele. Pode dar um jeito? Deixe de lado o futebol, etc., etc., ou acabo com você da próxima vez que o vir. Tente dar um jeito, sim? Bom rapaz! É explorar você, eu sei, mas também sei que você é um idiota completo e não vai se importar. Bobão! Alegre-se, seu filho da mãe, e consiga bastante comida.

Sentindo o que sentia, Donald não pôde estabelecer-se em Cambridge e não ficou satisfeito até estar enfrentando perigo por si mesmo; como provinha de Plymouth, naturalmente quis ingressar na marinha. Candidatou-se e foi aceito como cirurgião estagiário, sendo convocado para servir em um *destróier*, onde era um dos homens mais jovens a bordo e o único oficial médico, apesar de sua falta de formação; afortunadamente, havia um ordenança médico com experiência. Donald foi submetido a muita gozação no Rancho dos Oficiais. A maioria destes havia passado por um ou outro dos colégios navais reais e provinha de famílias com tradição naval. Ficaram atônitos que o pai de Donald fosse um *comerciante*. Isto era uma novidade e eles se aproveitaram dela, assim como Donald parece haver extraído o máximo da companhia deles e de toda a experiência. Ele com frequência relatava divertido as caçadas que lhe faziam por ocasião das refeições. Embora o navio tenha se envolvido em ação com o inimigo e houvesse feridos, Donald tinha muito tempo livre, que parece ter ocupado lendo os romances de Henry James.

Após a guerra, Donald foi direto para o *St. Bartholomew's Hospital*, em Londres, a fim de continuar sua formação médica. Imergiu na medicina e dedicou-se inteiramente a toda a experiência, que incluiu escrever para a revista do hospital e juntar-se à sua vida social: serenatas, danças, ocasionais férias de esquí, e apressar-se no último minuto para escutar óperas pela primeira vez, onde geralmente ficava de pé, em seus chinelos, nas costas dos *Deuses*.

É difícil fornecer quaisquer datas com relação às namoradas de Donald, mas ele teve ligações bastante chegadas com amigas das irmãs e, posteriormente, com outras moças que conheceu através de seus amigos de Cambridge. Esteve à beira do matrimônio por mais de uma vez, mas só se casou realmente (pela primeira vez) quando já contava 28 anos.

Donald teve alguns grandes professores no hospital e sempre dizia que fora Lorde Horder que lhe ensinara a importância de anotar cuidadosamente a anamnese e escutar o que o paciente lhe dizia, em vez de simplesmente formular perguntas. Após qualificar-se como médico, permaneceu no *Bart's* por um ano, trabalhando como encarregado dos feridos. Ele literalmente trabalhava quase todo o dia e a noite inteira, mas não teria perdido essa experiência por nada neste mundo, pois ela continha o desafio do inesperado e proporcionava-lhe o estímulo com que se regalava.

Durante sua formação, Donald caiu doente com o que se revelou ser um abscesso do pulmão, e foi paciente do *Bart's* por três meses. Um amigo que lá o visitou recorda-o nestas palavras: 'Era uma velha e gigantesca enfermaria, com um teto alto que tornava anãs as compactas fileiras de leitos, pacientes e visitantes. Ele estava *intensamente* divertido e interessado por achar-se perdido em uma multidão e disse-me: "Estou convencido de que todo médico deveria ficar, pelo menos uma vez na vida, em um leito de hospital como paciente".

Donald sempre pretendia tornar-se clínico geral em uma área rural, mas um dia, um amigo emprestou-lhe um livro de autoria de Freud e ele descobriu a psicanálise. Decidindo que aquilo era para ele, deu-se conta de que teria de, portanto, permanecer em Londres, a fim de fazer análise. Durante sua formação médica, havia-se tornado profundamente interessado pelo trabalho com crianças e, após prestar seu

exame de filiação à Sociedade Médica, estabeleceu-se como consultor em medicina infantil (naqueles dias, não existia especialização em pediatria). Em 1923, obteve duas indicações hospitalares, no Hospital da Rainha para Crianças e no Hospital Infantil de *Paddington Green*, a última das quais manteve durante quarenta anos. O desenvolvimento de seu trabalho no *Paddington Green* constitui uma história em si e muitos colegas de todas as partes do mundo visitaram-no lá. Por causa de suas próprias habilidades e interesses em desenvolvimento através dos anos, sua clínica gradativamente tornou-se uma clínica psiquiátrica, e ele costumava referir-se a ela como sendo a sua *Lanchonete Psiquiátrica* ou sua clínica para lidar com a hipocondria dos pais. Em 1923, adquiriu também uma sala na área de *Harley Street* e estabeleceu uma clínica particular de consultas.

De início, achou *Harley Street* colossal, porque tinha poucos pacientes, de maneira que, a fim de impressionar o majestoso porteiro que abria a porta para os pacientes de todos os médicos da casa, contou-nos que costumava pagar a passagem das mães e crianças que freqüentavam o hospital, de maneira a que pudessem visitá-lo em *Harley Street*. Naturalmente, este procedimento não se destinava inteiramente a impressionar o porteiro, porque selecionava casos em que se achava particularmente interessado e aos quais desejava conceder mais tempo, de modo a poder começar a explorar os aspectos psicológicos da enfermidade.

A mera pressão do número de pessoas que freqüentavam as suas clínicas hospitalares deve ter-lhe sido importante como incentivo para explorar tão plenamente quanto o fez a maneira de utilizar o *espaço* médico-paciente de modo tão econômico quanto possível para a tarefa terapêutica. As maneiras pelas quais o fez acham-se descritas em seus textos.

Há um detalhe, porém, que ele não descreve, e que eu observei tanto em sua clínica do *Paddington Green* quanto em seu trabalho com crianças evacuadas em *Oxfordshire*, durante a última guerra. Ele tentava rematar a tornar importante a visita de uma criança a ele, dando a esta algo para levar consigo, algo que podia depois ser utilizado, destruído ou jogado fora. Ele rapidamente estendia a mão para um pedaço de papel e o modelava segundo alguma forma, geralmente um dardo ou um leque, com a qual podia brincar por um momento e depois dar à criança enquanto lhe dava adeus. Nunca vi este gesto ser recusado por nenhuma criança. Pode ser que este simples ato simbólico contivesse o germe de idéias que desenvolveu no artigo sobre *O Uso de um Objeto*, escrito ao final de sua vida. Também podia existir aqui um vínculo com o conceito de objeto de transição.

Ao tentar fornecer uma idéia da capacidade que D.W.W. tinha de brincar, de algum modo escorreguei para uma seqüência histórica ou biográfica de escrita, sem pretender fazê-lo. Isto de maneira alguma pretende ser uma biografia. O que estive tentando fazer foi ilustrar como ele se relacionou com pessoas em diferentes estágios de sua vida e em situações diferentes, mas tendo de abandonar agora a perspectiva histórica, que até o momento me protegeu, e colocá-lo rapidamente em foco quanto a mim e em relação à nossa vida conjunta. De agora em diante, *ele* se torna *nós*, e não consigo nos desemaranhar.

Muitos anos atrás, um visitante que estava parando em nossa casa olhou em volta pensativamente e disse: — Você e Donald *brincam*. Lembro-me de ficar surpresa com esta nova luz que fora lançada sobre nós. Nós certamente nunca nos havíamos *disposto* a brincar; não havia nada de autoconsciente e deliberado a respeito. Parece apenas ter acontecido que vivíamos daquela maneira, mas pude perceber o que nosso visitante queria dizer. Nós brincávamos com *coisas* — as nossas possessões — redistribuindo-as, adquirindo-as ou livrando-nos delas de acordo com o nosso humor. Brincávamos com idéias, atirando-as de um lado para outro aleatoriamente, com a liberdade de saber que não precisávamos concordar e que éramos suficientemente fortes para

não sermos feridos um pelo outro. Na realidade, a questão de ferir-se mutuamente não surgia porque achávamo-nos operando na área do brinquedo, onde tudo é permissível. Ambos possuíamos uma capacidade de fruição e ela podia tomar conta de nós nos lugares mais improváveis e conduzir-nos a façanhas que não poderíamos ter antevisto. Após a morte de Donald, um amigo americano descreveu-nos como “dois malucos que se deleitavam um com o outro e deliciavam os amigos”. Donald teria ficado satisfeito com este elogio, tão remanescente de suas palavras: “Somos em verdade pobres, se somos apenas sãos”⁵.

Cedo, em nosso relacionamento, tive de acostumar-me à idéia de que Donald era, e sempre seria, completamente imprevisível em nossa vida privada, exceto por sua pontualidade quanto à hora das refeições e pelo fato de nunca ter deixado de ir buscar-me na estação quando eu estivera ausente. Esta imprevisibilidade tinha suas vantagens, por nunca permitir que nos instalássemos um ao outro como certos no viver cotidiano. O que podíamos tomar como certo era algo mais básico, que só posso descrever como o nosso reconhecimento e aceitação da separação de cada um. Na realidade, a força de nossa unidade residia neste reconhecimento e, implícita nele, encontra-se uma aceitação das pulsões inconscientes cruéis e destrutivas que foram debatidas como desenvolvimento final das teorias dele no trabalho *O Uso de um Objeto*. Nossa separação deixava cada um de nós livre para fazer suas próprias coisas, pensar seus próprios pensamentos e possuir seus próprios sonhos, e assim procedendo, fortalecer a capacidade de cada um de nós de experienciar as alegrias e as mágoas de que partilhávamos.

Havia algumas coisas que eram especialmente importantes para nós, tal como o cartão de Natal que Donald desenhava a cada ano, e que nós dois pintávamos às centenas, ficando de pé até as duas da manhã nos dias que antecediam o Natal. lembro-me de uma vez sugerir a ele que o desenho pareceria melhor se fosse deixado como estava, em preto e branco. Ele respondeu: “Sim, eu sei, mas eu gosto de pintar”. Havia os infundáveis desenhos de rabiscos [*squiggles*], que faziam parte de sua rotina diária. Ele jogava o jogo consigo mesmo e produzia alguns desenhos muito assustadores e outros muito engraçados, que amiúde tinham uma poderosa integridade própria. Se eu me ausentava por uma noite, ele me mandava um desenho pelo correio, para que o recebesse pela manhã, porque o meu papel em tudo isso era fruir e apreciar as produções dele, o que certamente acontecia, mas às vezes eu desejava que não houvesse tantas delas.

O conhecimento e a apreciação que Donald tinha por música eram uma alegria para nós dois, mas foi importante para mim porque me introduziu muita coisa que me era nova. Ele sempre teve um sentimento especial pela música de Bach, mas ao fim de sua vida, eram os últimos quartetos de cordas de Beethoven que o absorviam e fascinavam. Parecia que o refinamento e a abstração do idioma musical dessas obras ajudavam-no a reunir e a dar-se conta em si mesmo da rica seara de uma vida inteira. Em nível completamente diferente, gostava muito dos Beatles e comprava todas as suas gravações. Donald nunca teve tempo suficiente para desenvolver o seu próprio desempenho ao piano, mas com frequência corria até este e tocava por um momento, entre dois pacientes, e invariavelmente celebrava o final de um dia de trabalho com uma explosão musical em *fortíssimo*. Ele gostava do fato de eu saber mais a respeito de poetas do que ele e que lhe pudesse recitar, a pedido, um soneto de Shakespeare ou algo da autoria de T.S. Eliot ou Dylan Thomas. Ele particularmente gostava de “A

5. De “Desenvolvimento Emocional Primitivo” (1945), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* [Artigos Coligidos: Da Pediatría à Psicanálise] London: Tavistock, 1958; New York Basic Books, London: Hogarth Press, 1975).

Coruja e o Gatinho”, de Edward Lear, e nunca lhe bastavam as vezes em que o ouvia. Ao final, acabou por memorizá-lo.

Nossa maneira favorita de celebrar ou simplesmente relaxar era nos vestir bem e sair para um longo jantar sem pressa em um restaurante iluminado a velas, que não ficava longe de onde morávamos. Nos primeiros dias, às vezes dançávamos. Lembro-me dele olhando em volta do restaurante, certa noite, e dizendo: “Temos sorte, não? Ainda temos coisas para dizer um ao outro”.

Durante anos, dois programas de tevê que nunca perdíamos eram *Venham Dançar* (uma mostra de todos os tipos de dança de salão) e *O Jogo do Dia*, que era a reapresentação do melhor jogo de futebol ou *rugby* a cada sábado, ou então, no verão, era o tênis.

Acho que as únicas vezes em que Donald mostrou realmente estar zangado comigo foram ocasiões em que me machuquei ou fiquei doente. Ele odiava ter-me como paciente, e não como esposa e companheira de jogos. Demonstrou isso certo dia, quando machuquei o pé, que ficou com uma equimose e inchado. Não tínhamos ataduras de crepe em casa, de maneira que ele disse que sairia e compraria algumas e que eu ficasse deitada até ele voltar. Ficou ausente duas horas e retornou contente com um bracelete expansível de ouro que havia comprado para mim — mas se esquecera das ataduras.

Sempre especulei a respeito de qual fora o próprio objeto transicional de Donald. Ele não parecia lembrar-se de um, especificamente, até que, de repente, conseguiu entrar em contato com ele. Descreveu-me a experiência em uma carta escrita no começo de 1950:

Noite passada, sonhando, tirei algo inteiramente inesperado do que você disse. Subitamente, você se juntou à coisa mais próxima a que posso chegar de meu objeto de transição: era algo que sempre soube, mas perdi a lembrança dele e, nesse momento, fiquei consciente do que era. Havia uma boneca muito antiga, chamada Lily, que pertencia à minha irmã mais moça, e eu sempre gostei muito dela e fiquei muito aflito quando caiu e se quebrou. Depois de Lily, odiei *todas* as bonecas. Mas sempre soube que, antes de Lily, havia *quelquechose* minha própria. Sabia, retrospectivamente, que devia ter sido uma boneca, mas nunca me ocorrera que não era, tal como eu próprio, uma pessoa, isto é, era uma espécie de outro eu, e um não-eu feminino, parte de mim e, ao mesmo tempo, não, e absolutamente inseparável de mim. Não sei o que aconteceu a ela. Se amo você como amei esta (tenho de dizer?) boneca, amo você totalmente. E acredito que amo. Naturalmente, amo você por todos os tipos de outras maneiras, mas esta coisa me veio como nova. Senti-me enriquecido, e mais uma vez com vontade de escrever meu artigo sobre objetos de transição (adiado para outubro). (Você não se importa, se importa — com isto a respeito de você e do O.T.?)

Não seria correto dar a impressão de que Donald e eu partilhávamos apenas experiências que residiam fora de nosso trabalho. Foi este que nos reuniu em primeiro lugar, permaneceu sendo central e nos uniu de modo inextricável. Escrevendo-me em dezembro de 1946, disse ele: “Em momentos livres, escrevi boa parte do artigo para a Sociedade Psicanalítica em fevereiro, e passei um bocado de tempo elaborando-o. Meu trabalho acha-se realmente muito associado com você. O seu efeito sobre mim é tornar-me agudo e produtivo, e isto ainda é mais terrível, porque, quando fico afastado de você, sinto-me paralisado para qualquer ação e originalidade”.

Na realidade, cada um de nós era essencial para o trabalho do outro. Durante a vida de Donald trabalhamos em esferas diferentes e isto constituiu um interesse adicional que ampliou as fronteiras de nossa existência em comum. Tivemos a sorte de, através dos anos, um amplo círculo de pessoas vir a ficar intimamente incluído em nossas vidas e trabalho, e nós nas deles. Tratou-se de uma intensa força de ligação para todos os interessados, por proporcionar a comunidade de interesses que é o pré-

requisito para o viver criativo. Que sorte tivemos com aqueles que partilharam de nossas vidas, quanto lhes devemos e quanto desfrutamos de sua companhia!

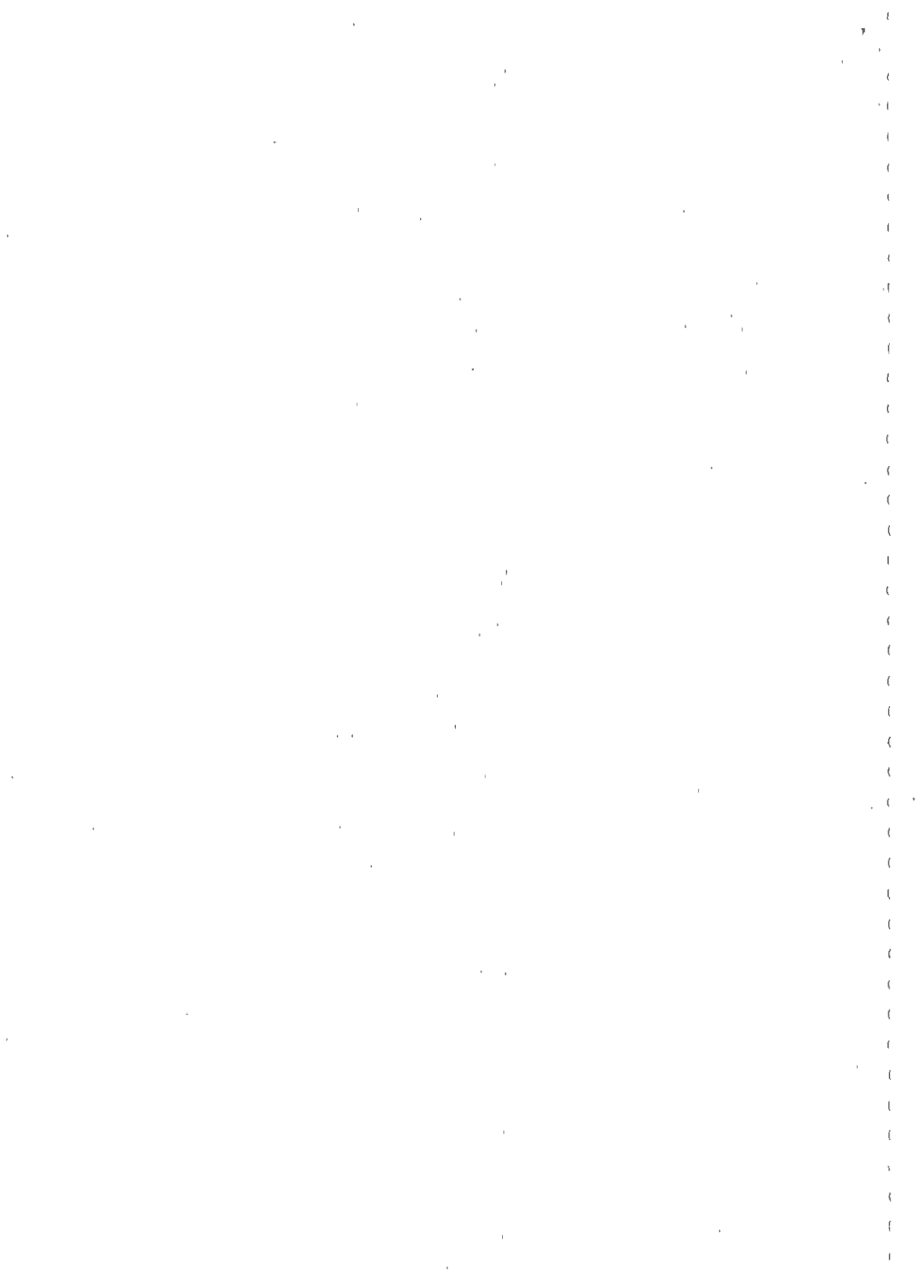
Durante toda a vida Donald nunca deixou de manter-se em contato com seu mundo onírico e de continuar a sua própria análise. Isso foi a corrente subterrânea profunda de sua vida, o acompanhamento orquestral do tema principal, e, aqui, seu poema chamado *Sono* é importante:

Deixe que a sua raiz
vá ao fundo de sua alma.
Sugue a seiva
da fonte infinita
de seu inconsciente
e
permaneça sempre verde.

Para concluir, quero relatar um sonho que tive a respeito de Donald, dois anos e meio após o seu falecimento.

Sonhei que estávamos em nossa loja favorita em Londres, onde há uma escadaria circular que leva a todos os andares. Estávamos subindo e descendo essa escadaria, apanhando coisas aqui, acolá, em todos os lugares, como presentes de Natal para nossos amigos. Estávamos realmente fazendo uma orgia de compras, sabendo que, como de costume, acabaríamos guardando muitas das coisas para nós. De repente me dei conta de que Donald estava vivo, afinal de contas, e pensei com alívio: "Agora não vou ter de me preocupar com o cartão de Natal". Depois, estávamos sentados no restaurante, tomando o nosso café da manhã como era habitual (na realidade, sempre saíamos para tomar o café da manhã nos sábados). Estávamos de frente um para o outro, cotovelos sobre a mesa, e eu o olhei em cheio no rosto e disse: "Donald, existe algo que temos de dizer um ao outro, alguma verdade que temos de dizer, o que é?". Com seus olhos muito azuis, olhando resolutamente os meus, ele respondeu: "Que isto é um sonho". Eu lentamente repliquei: "Oh, sim, é claro, você morreu, você morreu há um ano atrás". E ele reiterou as minhas palavras: "Sim, eu morri há um ano atrás".

Para mim, foi através deste sonho de brincar que a vida e a morte, a dele e a minha, puderam ser experienciados como realidade.



P A R T E 1

Psicanálise: Teoria e Prática

1

Desilusão Precoce

Datado de 24 de outubro de 1939

Nossos pacientes, que nos ensinam tanto do que vimos a saber, com freqüência tornam claro que, em verdade, encontraram a desilusão muito cedo. Eles não têm dúvida a respeito disto e podem atingir uma tristeza cada vez mais profunda relacionada a tal pensamento.

A análise avança e, contudo, um trabalho muito grande tem de ser efetuado antes que a desilusão possa ser descrita, com exatidão, em palavras. Embora não exista atalho para chegar-se a este resultado, é interessante que se registre os resultados individuais, à medida que aparecem.

A queixa com freqüência é que a mãe amada e idealizada treinou a criança para ser *desonesta*. A honestidade parecer ser algo quase fundamental à natureza humana e dentro em pouco direi porque penso que não é inteiramente fundamental e a maneira por que acho que pode ser mais analisada. Seja qual for sua origem, porém, não há dúvida de que a criança pequena — ia dizer bebê — pode ter um choque ruim ao descobrir que não é bom ser honesto.

Como é que acontece de a criança ser levada a entender, tão cedo, que a honestidade não é nem mesmo a melhor política, para não falar em boa?

Em duas palavras, o bebê está lá deitado, sugando o polegar e pensando pensamentos, e alguém chega e tira-lhe o polegar da boca. Ele tem de aprender a continuar com seus pensamentos *sem* a parte óbvia do acompanhamento orgásmico.

Sem dúvida, o que torna eficaz a ação dos pais é a culpa do bebê a respeito dos elementos destrutivos do material de sua fantasia. Poder-se-ia dizer então que, em uma extremidade da escala há o mínimo de culpa e o máximo de interferência dos pais, enquanto que, na outra extremidade, há uma culpa máxima (por causa dos elementos destrutivos) que produz inibição, com pequena interferência dos pais ou sem necessidade desta. Falando de modo aproximado, pode-se dizer que, na extremidade primeiramente mencionada, há uma ocultação das partes *óbvias* do funcionamento orgásmico, com a tensão provinda do funcionamento oculto, enquanto que na outra extremidade há uma inibição *mais* completa do funcionamento corporal, um divórcio mais certo entre o material de fantasia e a vida instintiva do corpo.

Com referência aos sentimentos conscientes, temos aqui uma gama ampla que vai desde uma tentativa desesperada de ser honesto, uma tentativa que nunca é bem-

sucedida, até a posse de um mundo *secreto* de fantasia, um senso de irreabilidade a respeito da fantasia e um repúdio desta, ou uma incapacidade de aceitar a propriedade de qualquer material de fantasia que se intrometa.

Uma paciente está no fim de sua análise, mas não consegue terminá-la. Uma de suas dificuldades é que ela pode finalmente dizer *obrigada*. Ela pode finalmente acreditar que está grata, mas não pode sentir-se certa de que eu (o seu analista) possa aceitar plenamente a gratidão dela. Ela pode sentir tudo isso em termos bastante primários. Ao seio, ela fora voraz, havia-o amado, puxado, rasgado, marcado com cicatrizes, tornado-o cansado e velho. Agora, quer dar algo à mãe. Em si mesma, sente cor, valor, vida, mas de alguma maneira, não consegue acreditar em minha aceitação do movimento perfeito.

Ela pode entrar em contato com as partes destrutivas de sua fantasia. Na transferência, experienciara ódio de modo mais agudo do que eu havia visto qualquer outro paciente sentir. Também pôde me contar a respeito de suas funções orgâsmicas, pôde me mostrar seu sugar de polegar de terrificante intensidade, seus maneios de prazer, suas funções eróticas de excreção. Uma coisa, porém, pode ser notada: na masturbação, *as mãos nunca são usadas* e ela insiste com grande veemência em não existir ação manual perdida ou esquecida. "Por que deveria usar as mãos quando posso tornar todas as partes corporais vivas, excitadas e gratificadas, sem utilizá-las?" "Por que deveria esfregar meus órgãos genitais quando posso obter tal prazer (genital, inclusive) sugando o polegar?" E assim por diante.

Foi claro desde o início da análise que as mãos desta paciente são de grande importância. Ela teve inibições de função manual, mas conseguiu arranjar empregos que essencialmente envolvem trabalho manual e ultimamente tem havido uma notável libertação de sua capacidade de utilizar as mãos (jardinagem, datilografia, etc.).

Está bastante claro que esta paciente não pode permitir que a mãe saiba que ela se masturba com as mãos, isto é, que as suas mãos, na fantasia, furtam e matam, e que ela tem prazer com isto, até certo grau. Ela sabe que gosta de destruir com as mãos e este conhecimento remonta diretamente ao início da infância. Mas falta algo em sua capacidade de ser honesta e deixar a mãe saber disto *através de sua masturbação*. (Ela poderia deixar a mãe sabê-lo sempre, mediante o rasgar compulsivo de papel, ou derrubando coisas e fazendo sujeira, isto é, de modo desafiante).

É provável que, neste caso, a mãe tenha realmente contribuído para a dificuldade, não necessariamente por afastar as mãos da criança dos órgãos genitais, mas mais provavelmente, por tirar-lhe as mãozinhas da boca e bater nelas. Este padrão permaneceu e talvez tenha impedido inteiramente esta criança de jamais utilizar as mãos na masturbação genital. Naturalmente, não estou certo disto, e houve certamente uma disputa real entre a mãe e o bebê a respeito de coçar a pele. (Neste caso, não determinei finalmente a importância relativa da excitação anal.)

É agora possível debater a análise da honestidade.

Esta jovem quer que eu receba um presente do seu interior, em retribuição pelo que fiz. É um presente perfeito e ela não crê que eu possa acreditar nele. Não acredito.

A questão é que, se eu (a mãe) não posso suportar o que ela, em sua honestidade, tentou mostrar-me quando era bebê através de suas atividades orgâsmicas manifestas, como poderei suportar as coisas ruins que certamente se acharão lá, no presente, provindo de seu interior? Na realidade, foi mantido em segredo para mim (a mãe) uma grande parcela de material de fantasia bom e mau, e enquanto isto for assim, ela não pode estar feliz a respeito de sua capacidade de ser grata.

Isto é, ela sabe que não pode realmente restaurar na mãe um pênis bom e total; o pênis foi furtado e ferido, mas ela pode fazer algo no sentido de preencher o buraco que ficou no corpo da mãe com algumas partes do pênis que foram preservadas e até

mesmo carinhosamente desenvolvidas, se puder manejar a dificuldade original do segredo a respeito do furto.

Uma honestidade extremada tem sido uma das desgraças da existência desta pessoa e ela ficaria muito contente com o alívio da honestidade compulsiva, que deve trazer uma análise bem-sucedida de seu fracasso original em encontrar uma mãe que pudesse suportar a honestidade dela.

2

Saber e Não Saber: Um Exemplo Clínico

Sem Data

A paciente, uma mulher de 35 anos, que esteve em análise por alguns anos, está apenas começando a se dar conta de quão enferma esteve. A natureza de sua doença foi tal que ela necessitava não saber a seu respeito e sempre protestou que a análise começara muito antes de ela chegar à análise e que apenas a ajudara a continuar um pouco além do que poderia ter conseguido sozinha, o que sempre fora, até certo ponto, capaz de fazer.

Em particular, nunca reconheceu que tenha estado inconsciente de nada. Quando, em resultado da análise, ocorreram nela mudanças muito consideráveis, sempre dizia, quando se tornava consciente de material de que estivera anteriormente inconsciente, que “eu sempre soube disso”, e é bastante certo que não estivesse apenas mentido, de vez que é, por caráter, uma pessoa extremamente confiável.

Um passo importante em seu autoconhecimento surgiu como um relatório do que um dia dissera a um examinador. Ela respondera à questão dele dizendo “sei, mas esqueci”. Ao me contar isso, embora o estivesse lendo de um roteiro, por tê-lo posto no papel no dia anterior, quando a lembrança lhe ocorrera, cometeu um erro e disse que a sua resposta fora: “Não sei, mas me esqueci”. Não podia acreditar que houvesse cometido este equívoco e me odiou por apontá-lo a ela. E, contudo, ele era realmente a primeira admissão de não saber, e, em certo sentido, um grande progresso em relação ao que dissera ao examinador. A este ela com efeito havia dito: “Sei disso e, quando estiver aviando um remédio, estarei capacitada a utilizar o conhecimento, e o fato de que quando estou falando com o senhor eu não me lembro não é importante”. O que ela me disse foi: “Secretamente, eu sabia”. Em outras palavras, na maneira original de falar havia uma personalidade cindida e, através dessa personalidade, ela conseguia ser desonesta e dissimulada sem ter de reconhecer isso. Ela sabia e não sabia. Na análise, por exemplo, podia dizer: “Não sonho e, portanto, não estou ocultando nada”. Ao mesmo tempo, podia dizer: “Naturalmente sonho, sonho a noite inteira, e a minha vida é um sonho só, mas você não sabe como fazer uso desses sonhos, de maneira que não vou contá-los a você”. Por uma centena de maneiras era capaz de manter o que era característico dela, uma honestidade escrupulosa, por meio desta cisão de si em duas ou mais partes.

A importância desta interpretação com referência ao lapso lingüístico foi corroborada pelo fato de ela havê-la acompanhado dizendo: "Na noite passada, fingi para meu irmão que não tinha mais cigarros. Bem, você vê, se eu lhe dissesse que tinha alguns, ele os teria apanhado todos". Isto foi, no caso desta paciente, uma realização, qual seja, a de que fora capaz de enganar o irmão, e a interpretação ao longo destas linhas produziu mais confirmações. Disse ela: "Esta noite, vou com minha tia a uma palestra sobre sonhos, pelo Dr. Crighton Miller". Isto constituía, para ela, um relacionamento com a tia que era destrutivo para mim, pois não me havia fornecido sonho algum durante dois meses e, quando a confrontei com esse fato, disse que era porque eu não sabia que uso fazer deles. Estávamos no ponto de transição: ela primeiro indicou, segundo as velhas linhas, que não estava sonhando e isto era quase honesto, como teria sido nos velhos tempos, mas logo teve de ver que estava sonhando, retendo os sonhos e me enganando. Ela era, portanto, uma só pessoa me enganando, em vez de duas pessoas a me contarem dois conjuntos de verdades. Após, ela prosseguiu dizendo que sempre enganara o pai, e tenho razões para pensar que esta é a razão pela qual o pai sempre lhe fora de valor, apesar de suas muitas faltas ou, talvez, por causa delas. Fora impossível, por outro lado, enganar a mãe, e isto parece estar ligado ao fato da mãe enganá-la, e por isto quero significar a incapacidade da mãe em saber e reconhecer que enganava a filha. Através de toda a análise sempre aparecera a peruca da mãe em primeiro plano, como lembrança encobridora para algum grande engano. Do engano ligado a ficar grávida e ter um filho quando a paciente contava três anos de idade, já sabíamos que fora importante, mas foi somente agora que compreendemos a importância da incapacidade da mãe em reconhecer que, em determinadas circunstâncias, tenha querido enganar uma criança. Em razão disto, ocorreu à paciente que, às vezes, seria sábio enganar uma criança e que eu, na análise, poderia enganar a paciente para protegê-la de fatores externos que interferissem com a análise.

3

Um Ponto de Técnica

Sem Data

Aprendi recentemente a adotar o seguinte procedimento na prática analítica. Quando a fantasia que está representada no material transferencial é revelada, pergunto-me: qual é o funcionamento corporal orgástico acompanhante e onde se acha ele? E, *per contra*, quando na situação analítica existe funcionamento corporal orgástico, pergunto-me: de que material de fantasia está o paciente me falando através desse funcionamento?

.....

Quando tenho de ampliar este enunciado de um procedimento técnico, fico na incerteza de por onde começar. Coloquei pontinhos abaixo do enunciado para representar os meses que espero, que quem quer que esteja lendo isto levará para examinar seu próprio comportamento clínico e ver quanto ele já age e não age como eu vim a fazer especialmente a este respeito.

Presumindo que esses meses tenham se passado, tento agora ampliar o tema, que, tenho de concordar, não é original nem revolucionário.

Uma paciente tem uma voz que é característica. Quando trabalha duro, na análise, por exemplo, efetua uma quantidade tremenda de trabalho com a boca e com todo o seu aparelho vocal. Fala alto, e gradualmente se torna consciente do fato de que sente prazer no funcionamento de seu departamento da fala em um grau que é quase penoso.

No curso da análise, fantasias de todos os tipos emergiram, acompanhadas por sentimentos de intensidade muito grande.

Certo dia, quando idéias de roubo e todos os tipos de ações manuais de amor, ciúme, ódio e vingança estavam conscientes, desejei muito fazê-la me ver meia hora antes do tempo acertado. Eu sabia que isto lhe seria mais conveniente e também me permitiria evitar abreviar a hora dela, devido a circunstâncias externas ao meu controle. Dessa maneira, arrisquei ir procurá-la. Sabia que estaria jantando em determinado restaurante, de maneira que fui até lá e tentei falar com ela.

Ela estava comendo, comendo como um animal selvagem, e lendo o jornal. Foi bastante difícil romper a carapaça invisível e fazer com que ela me notasse.

A importância desta interpretação com referência ao lapso lingüístico foi corroborada pelo fato de ela havê-la acompanhado dizendo: "Na noite passada, fingi para meu irmão que não tinha mais cigarros. Bem, você vê, se eu lhe dissesse que tinha alguns, ele os teria apanhado todos". Isto foi, no caso desta paciente, uma realização, qual seja, a de que fora capaz de enganar o irmão, e a interpretação ao longo destas linhas produziu mais confirmações. Disse ela: "Esta noite, vou com minha tia a uma palestra sobre sonhos, pelo Dr. Crighton Miller". Isto constituía, para ela, um relacionamento com a tia que era destrutivo para mim, pois não me havia fornecido sonho algum durante dois meses e, quando a confrontei com esse fato, disse que era porque eu não sabia que uso fazer deles. Estávamos no ponto de transição: ela primeiro indicou, segundo as velhas linhas, que não estava sonhando e isto era quase honesto, como teria sido nos velhos tempos, mas logo teve de ver que estava sonhando, retendo os sonhos e me enganando. Ela era, portanto, uma só pessoa me enganando, em vez de duas pessoas a me contarem dois conjuntos de verdades. Após, ela prosseguiu dizendo que sempre enganara o pai, e tenho razões para pensar que esta é a razão pela qual o pai sempre lhe fora de valor, apesar de suas muitas faltas ou, talvez, por causa delas. Fora impossível, por outro lado, enganar a mãe, e isto parece estar ligado ao fato da mãe enganá-la, e por isto quero significar a incapacidade da mãe em saber e reconhecer que enganava a filha. Através de toda a análise sempre aparecera a peruca da mãe em primeiro plano, como lembrança encobridora para algum grande engano. Do engano ligado a ficar grávida e ter um filho quando a paciente contava três anos de idade, já sabíamos que fora importante, mas foi somente agora que compreendemos a importância da incapacidade da mãe em reconhecer que, em determinadas circunstâncias, tenha querido enganar uma criança. Em razão disto, ocorreu à paciente que, às vezes, seria sábio enganar uma criança e que eu, na análise, poderia enganar a paciente para protegê-la de fatores externos que interferissem com a análise.

3

Um Ponto de Técnica

Sem Data

Aprendi recentemente a adotar o seguinte procedimento na prática analítica. Quando a fantasia que está representada no material transferencial é revelada, pergunto-me: qual é o funcionamento corporal orgástico acompanhante e onde se acha ele? E, *per contra*, quando na situação analítica existe funcionamento corporal orgástico, pergunto-me: de que material de fantasia está o paciente me falando através desse funcionamento?

.....

Quando tenho de ampliar este enunciado de um procedimento técnico, fico na incerteza de por onde começar. Coloquei pontinhos abaixo do enunciado para representar os meses que espero, que quem quer que esteja lendo isto levará para examinar seu próprio comportamento clínico e ver quanto ele já age e não age como eu vim a fazer especialmente a este respeito.

Presumindo que esses meses tenham se passado, tento agora ampliar o tema, que, tenho de concordar, não é original nem revolucionário.

Uma paciente tem uma voz que é característica. Quando trabalha duro, na análise, por exemplo, efetua uma quantidade tremenda de trabalho com a boca e com todo o seu aparelho vocal. Fala alto, e gradualmente se torna consciente do fato de que sente prazer no funcionamento de seu departamento da fala em um grau que é quase penoso.

No curso da análise, fantasias de todos os tipos emergiram, acompanhadas por sentimentos de intensidade muito grande.

Certo dia, quando idéias de roubo e todos os tipos de ações manuais de amor, ciúme, ódio e vingança estavam conscientes, desejei muito fazê-la me ver meia hora antes do tempo acertado. Eu sabia que isto lhe seria mais conveniente e também me permitiria evitar abreviar a hora dela, devido a circunstâncias externas ao meu controle. Dessa maneira, arrisquei ir procurá-la. Sabia que estaria jantando em determinado restaurante, de maneira que fui até lá e tentei falar com ela.

Ela estava comendo, comendo como um animal selvagem, e lendo o jornal. Foi bastante difícil romper a carapaça invisível e fazer com que ela me notasse.

A ansiedade e a raiva despertadas por esta minha ação foram muito grandes. Eu havia descoberto o funcionamento corporal orgástico oculto que me havia sido escondido na análise, mas sem o qual o material de fantasia, ainda que intensamente sentido, nunca poderia tornar-se inteiramente real ou pessoal. Gradativamente vim a entender que a pista poderia ter sido encontrada todo o tempo em sua voz, que era a parte dela que estava tentando ser honesta, a despeito de sua determinação geral de manter separados (em seu relacionamento comigo) a fantasia e o acompanhamento corporal.

A análise seguiu esta linha e produziu material que tornou claras suas experiências de sugar o dedo (prazer orgástico, desafio, sentimentos de culpa, inibição) e de sua masturbação manual, que fora por longo tempo inibida e sua idéia repudiada.

4

O Brinquedo na Situação Analítica

Datado de 5 de novembro de 1954

Desejo debater alguns aspectos do brinquedo na análise de adultos. Na análise infantil, o brinquedo está quase sempre em evidência, mas na análise adulta, espera-se poder abandoná-lo e apoiar-se nos sonhos, nas alucinações e no fantasiar.

Ocasionalmente, ouve-se falar de pacientes adultos que são acompanhados durante um período difícil, dando-lhes brinquedos da análise de crianças, os quais manipulam durante uma fase e que capacitam o analista a interpretações durante períodos de silêncio. O que me interessa no momento não é a introdução de material de brinquedo na hora analítica, mas o reconhecimento da importância do brinquedo na análise de adultos, por ele ser diferente da fantasia e do sonho.

Um exemplo me foi dado por um estudante durante uma sessão de supervisão. O paciente dele dissera: "Acabei de descobrir um atalho para a análise". Ao descrever o atalho, disse que passara pelo *playground* das crianças. O estudante muito acertadamente fez a interpretação de que o paciente podia ver o valor do brinquedo. Como este paciente tivera episódios violentos, é muito importante que, na análise, coisas como o senso de humor não sejam negligenciados, porque a única esperança que esse homem tem de chegar ao fim de sua análise, sem períodos em que o manejo controlador se torne necessário (como em verdade aconteceu em determinada ocasião, antes de a análise começar), passa pelo fato de ele ser capaz de brincar.

Após a interpretação fornecida pelo estudante, o paciente inclinou-se, rearrumou o capacho e fez associações com este tipo de brinquedo. Nas circunstâncias, é compreensível que o estudante tenha negligenciado continuar com o tema do brinquedo e se tenha atolado no material das associações livres, que, em verdade, eram importantes em si.

Certa ocasião, uma paciente minha chegou sem haver tomado café no caminho e ficou em extrema agitação a respeito de querer tomar café e sentir que a hora inteira ficaria perdida. Estou certo que o manejo desta situação poderia dar-se ao longo de duas ou mais linhas distintas. Nesta ocasião, forneci-lhe café, e vimos então que diferença tremenda havia entre o relacionamento da paciente com o café, a xícara e o pires, a bandeja e o açúcar, o relacionamento dela com a idéia de querer café, e o sonho que poderia ter existido sobre ter café servido por mim. Isso tornou-se uma questão de brinquedo e exemplo da introdução do material de jogos na análise de adultos.

Por volta desta época, outro paciente, um homem, me disse: "Estive pretendendo dizer-lhe que gosto de entrar e sair, porque isso é um brinquedo, com toda essa história a respeito de uma rotina e evitar ver os outros pacientes, e assim por diante". Tratava-se de uma declaração surpreendente, partida de um homem que é incapaz de brincar e que vem à análise por causa de uma incapacidade de manter suas amizades, de vez que só pode falar de maneira ponderável e não pode brincar. Para que esse homem pudesse fazer essa observação, havia a razão de que, nas sessões anteriores, tratáramos do brincar e, em sua análise, havia chegado a hora de que eu o fizesse ver que, em vez de brincar, ele estava se masturbando com regularidade, e que o fantasiar se achava trancado na masturbação. Esta interpretação, chegando no momento exato, começou a liberar o seu brincar e tornou-o muito consciente de sua solidão durante toda a infância, exceto quando havia jogos organizados. Ele fora incapaz de brincar porque partilhar a fantasia significava perder muito. Um ou dois dias mais tarde deparamo-nos com um jogo que ele não havia conhecido. Descobrimos que havia tido uma irmã imaginária durante toda a sua infância, de quem era violentamente ciumento, embora, na realidade, nunca houvesse sentido ciúmes quer da irmã mais velha, quer da irmã mais nova. Esta menina imaginária que encontrara tinha representado o seu *self* feminino e fora praticamente uma pessoa perfeita, que se relacionava estreitamente com o pai, que ele fora incapaz de ter por ser menino. Em desespero, havia tentado vestir-se de menina muitas vezes durante a infância, mas isto nunca havia sido satisfatório, por causa da menina idealizada que sempre levava consigo e a quem odiava e, naturalmente, amava de maneira narcísica.

Tem certamente sido minha prática recordar o brincar na análise de adultos; com frequência introduzi nelas papel e lápis, e tem havido aspectos de brinquedo, trocas verbais humorísticas, etc., mas foi só recentemente que reconheci as diferenças muito importantes existentes entre estes episódios de brincar e os sonhos e o fantasiar. Uma coisa importante é aquela óbvia de que, no brinquedo, ainda que se tenha de abandonar uma parte considerável que não pode ser partilhada com a outra pessoa, há muito a ser ganho da sobreposição parcial da fantasia da outra pessoa com a nossa, de maneira que existe uma experiência partilhada, ainda que sobre uma área limitada do fantasiar total.

5

Fragmentos Referentes a Variedades de Confusão Clínica

Datado de 13 e 22 de fevereiro de 1956

I

Um aspecto importante do comportamento obsessivo é a confusão que ele implica. Por que é que, na saúde, uma mixórdia pode ser arrumada, e, na doença, a arrumação, que é compulsiva, é também inútil?

A Pista: Na enfermidade obsessiva, a confusão é uma defesa organizada. Um certo grau de confusão é *inconscientemente mantido* a fim de ocultar um fato muito simples: o triunfo do mau sobre o bom, do ódio sobre o amor, da agressão sobre a capacidade de preservação, etc.

Desta maneira, a arrumação nunca pode ter sucesso. Mas pode se encontrar uma confusão quase consciente quando a arrumação parece haver tido sucesso.

Oh, o que se faz e desfaz,
quando se vai cortejar!

Clinicamente, encontramos: a confusão como defesa, organizada, só é alterada pela análise do sadismo oral, que, por sua vez, altera o equilíbrio interno de forças, de maneira que o simples fato da desesperança — que tem de ser oculto pela confusão — existe em menor grau. Pode ser útil para o paciente, no processo, ser informado a respeito da confusão como defesa. Isto ajuda a aceitação da utilidade das obsessões, as quais, contudo, não são por isso *curadas*.

Há um relacionamento entre depressão e obsessão que é do seguinte tipo: (a) pessoas deprimidas e obsecadas não toleram umas às outras; (b) determinado paciente movimenta-se para lá e para cá, da depressão para a obsessão. De modo geral, o paciente sente-se mais real no estado deprimido, mas as obsessões passageiras podem proporcionar um alívio temporário quanto ao humor.

Surge a questão do que torna um paciente deprimido capaz de ficar obsessivo às vezes, e do que faz um paciente obsessivo tornar-se temporariamente deprimido, enquanto que alguns pacientes permanecem em uma ou outra das categorias diagnósticas.

Esta questão enfatiza o fato de que a depressão, como estado clínico, não é a *posição depressiva*. Esta e o fracasso do paciente em alcançá-la acham-se subjacentes, de igual modo, aos estados de depressão e obsessão.

Estamos interessados na capacidade que o paciente tem de tolerar o humor. O temor de defesas antidepressivas pode contribuir para a adoção de técnicas obsessivas, pois quando a depressão é grave como um humor, o seu oposto não é a defesa maníaca, mas a mania. (*Grave como um humor* implica um alto grau de repressão da agressão ou de amor cruel.)

A pessoa deprimida despreza o obsessivo que fugiu dos sentimentos. O obsessivo não pode suportar a capacidade que o depressivo tem de sustentar um humor; pois esta atitude implica esperança e, na realidade, um humor depressivo tende a dissolver-se espontaneamente com o tempo. A pessoa depressiva, contudo, necessita ser preservada do suicídio, quando se acha no "fundo" da fase depressiva.

A depressão, pois, implica esperança. Que tipo de esperança? Sugiro eu: a esperança de ser sustentada durante um certo período de tempo, no decorrer do qual a elaboração possa se dar, isto é, uma recomposição ou reordenamento dentro de si, no chamado mundo interno. É somente aqui que a recomposição deixa de ser inútil.

Haverá uma acumulação de *lembranças* de boa maternagem na época das primeiras realizações com respeito à posição depressiva. No caso do obsessivo, haverá, em vez disso, uma acumulação de *lembranças* de treinamento, ensino, implantações de moralidade. A comparação destes dois estados parece-me conduzir a um contraste entre dois tipos de maternagem inicial.

Incidental neste tema é a complicação que deve ser plenamente reconhecida pelo analista quando se acha presente, a saber: a confusão organizada ser um estado da mãe, correspondente às defesas organizadas contra a depressão sobre as quais escrevi alhures¹.

A confusão, como defesa organizada, deve ser analisada desde que se queira que o paciente chegue àquilo que se encontra sempre no centro do indivíduo, um caos primário, a partir do qual se organizam amostras de auto-expressão individual. Em termos dos estágios iniciais de desenvolvimento, este é o estado primário de não-integração, para o qual Glover chama a atenção em sua teoria dos núcleos do ego². Em nosso trabalho, ficamos clinicamente muito aliviados quando a dissipação da confusão da defesa organizada capacita um paciente a chegar a este caos primário situado no centro. Naturalmente, isto só pode ser alcançado em um meio ambiente que seja do tipo especial, por mim denominado preocupação materna primária, quando a mãe (analista) que sustenta está identificada em alto grau com o bebê sustentado. Neste ponto de uma análise, *alguns* pacientes parecem necessitar serem concretamente sustentados, sob alguma forma simbólica, por uma pequena quantidade de contato físico. O fracasso ambiental neste ponto significa a queda para sempre do *self* não-integrado, e o afeto que corresponde a isto é uma ansiedade de intensidade psicótica. É aqui, mais do que em qualquer outro lugar da análise, que o paciente tem de correr um risco a fim de progredir para a integração.

Ao formular esta nota, deliberadamente fui de um extremo ao outro na descrição da confusão organizada de um tipo sofisticado e no seu contraste com o estado primário de não-integração. As confusões intermediárias possuem sua própria importância. Exemplo delas é a confusão que pode ocorrer em qualquer estágio desde que se faça à atividade mental uma exigência a qual se encontra além do campo de ação do indivíduo, no momento, seja por causa de problemas múltiplos, concomitantes, seja pelo fato de a tarefa achar-se além do que combina com o estado de desenvolvimento e organização do ego.

1. *The Manic Defense* (1935) e *Reparation in Respect of Mother's Organised Defense against Depression* (1948), in *Collected Papers: Through Pediatrics to Psycho-Analysis*.
2. E. Glover, *On the Early Development of the Mind* (London, Imago, 1956).

II

Estive por longo tempo interessado no relacionamento existente entre o conceito de posição depressiva e humor depressivo e as emoções a que se dá o nome de pesar, tristeza, sentimento de perda.

Uma paciente me colocou contra este problema. O quadro clínico é o seguinte: a paciente não se encontra no momento na posição depressiva, embora esteja próximo a dela; quer dizer, não existe uma experiência integradora de uma pessoa total relacionada a um objeto parcial e a um objeto total, com estes dois sendo reconhecidos como relacionados.

A análise acabou de chegar a um ponto em que a paciente encontrou o estado original de confusão pertencente à não-integração, implicando numa considerável confiança no fator ambiental, ou seja, o analista na transferência. A análise foi interrompida neste ponto devido à doença de minha esposa. A princípio, a paciente apresentou-se de maneira falsa e lidou com a situação com simpatia. Após dois dias, isto se rompeu e ela tornou-se confusa; desta vez, a confusão era desintegrada ou mesmo um estado confusional organizado, e não a confusão primária da não-integração. A voltar após quatro dias de intervalo, a paciente foi a princípio incapaz de retornar à análise e estava muitíssimo preocupada com a situação de realidade. Ao final da sessão, tinha chegado ao estágio em que a análise poderia ter continuado ao longo das antigas linhas. No dia seguinte, houve um retorno gradual à confiança e isto conduziu a um episódio de atuação que surpreendeu a paciente, e no qual sucederam certas coisas que me mostraram que ela tinha uma memória corporal de ser subitamente largada. Teve uma ansiedade do tipo mais agudo e, após esta passar, identificamo-la como uma reação retardada ao fato de eu tê-la abandonado quatro dias antes, reação que lhe fora inteiramente impossível ter sozinha. No dia seguinte, a confiança retornou de maneira plena e houve uma repetição da atuação na sessão.

Deve-se notar que na atuação do dia anterior não houve rigidez, que é a reação mais primitiva; ao contrário, houve uma não-integração que se transformou em desintegração. Na segunda ocasião, houve uma reação muito mais madura. A paciente, sob a influência de processos inconscientes, demonstrou de modo muito claro ser um minúsculo bebê em grande aflição, estendendo as mãos e experienciando um sentimento de perda. Não foi inteiramente sentido como pesar, embora se aproximasse disso. O sentimento de perda foi certamente sentido de maneira muito aguda e em lugar da ansiedade. Após a recuperação, a paciente retornou ao relacionamento confiante comigo que tornara possível este episódio de atuação. Aqui, a paciente já avançara com a sua descoberta e com a reação ao meu afastamento. O importante é que aqui houve um momento de meu afastamento ao qual ela pôde reagir com um sentimento de perda, e que isto se comparava com o estado de afastamento da mãe, que não proporcionava ocasião para essa reação. No relacionamento com a mãe, tinha havido simplesmente um estado de retraimento mais ou menos igualmente distribuído. Comigo, entretanto, ela havia agora experienciado o meu afastamento em um certo momento e reagira com um agudo sentimento de perda.

Aqui, então, havia quase pesar. Ao mesmo tempo, recordo que esta paciente não se acha em um estado de desenvolvimento do ego que torne possível a experiência plena da posição depressiva. Sem dúvida, até certo ponto, a experiência de pesar depende não apenas de meu comportamento, mas também da criação pela paciente, dentro de si, da idéia de um objeto bom. Isto se acha estreitamente relacionado à capacidade dela de sustentar a idéia da mãe por um momento, quando esta se retrai, permitindo assim que o sentimento de perda seja uma realidade.

6

A Excitação na Etiologia da Trombose Coronária

Notas para uma palestra proferida perante a Sociedade de Pesquisa Psicossomática, University College, Londres, 5 de dezembro de 1957

A. Sinopse do transtorno psicossomático

A trombose coronária constitui um bom exemplo de transtorno psicossomático.

1. Ela pode ser uma doença puramente física.
2. Torna-se uma doença física:
 - I. mudanças arteriais;
 - II. trombose.
3. Não é uma enfermidade da classe operária, mas sim dos profissionais liberais.
4. Acha-se relacionada ao estresse emocional.
5. Não se acha especialmente relacionada a um grupo diagnóstico psiquiátrico (embora talvez se encontre ligada à depressão).
6. Faz parte de viver uma vida pessoal em um determinado meio ambiente; isto é, faz parte de uma experiência de relacionamento.
7. Por não ser imediatamente fatal, torna possível aos pacientes utilizarem a tendência como um incentivo para alterar um modo inadequado de vida, que se tornou um hábito.

Mas isto não é tudo. Permanece o problema essencial da fisiologia.

B. Literatura sobre a trombose coronária

Na literatura a respeito da trombose coronária, a psicologia do sujeito acha-se principalmente confinada aos três aspectos seguintes:

1. O efeito da doença sobre o paciente, o qual deve ajustar-se a um teto mais baixo de poder físico, pois sabe agora de que forma provavelmente morrerá.
2. Os fatores predisponentes, em termos de uma descrição do meio ambiente e do lugar do paciente nele, tomando-se nota dos fatores de estresse. É geralmente reconhecido que o indivíduo, até certo ponto, é responsável por seu meio ambiente e por continuar a viver nele, se for difícil.
3. Os primórdios de uma compreensão do conflito emocional, em oposição à tensão emocional.

C. Abordagens oriundas da psicologia

Três modos de ataque provêm da psicologia:

1. A abordagem estatística — tal como aplicada à úlcera gástrica ou à hipertensão. Isto envolve noções preconcebidas que podem ser enunciadas e provadas como significantes ou não-significantes.
2. A abordagem com terapia incluída — tal como as observações de Hambling sobre a hipertensão¹.
3. (No outro extremo) o psicanalista que fala em termos da análise total do paciente, no curso da qual transtornos psicossomáticos surgem e desaparecem; tais transtornos podem freqüentemente ser vistos como relacionados à fantasia inconsciente, à defesas contra a ansiedade, à introjeções maciças de situações traumáticas, às tensões e estresses de adaptações à realidade de todos os tipos, etc., e também ao ganho secundário obtido através da doença.

D. Apelo à fisiologia

Neste ponto, deveria ser possível tirar da estante um livro didático de fisiologia e examinar as mudanças pertinentes à excitação, pois a trombose coronária é um transtorno do aparelho da excitação.

Parecer-me-ia que, para isso, ter-se-ia de pedir uma orientação fisiológica, uma orientação vinculada ao novo trabalho dos etologistas e, também, de alguns neurofisiologistas e endocrinologistas.

A fisiologia que aprendi era fria, isto é, podia ser verificada através do exame cuidadoso de uma rã desmedulada ou de uma preparação coração-pulmão. Todo esforço era feito para eliminar variáveis tais como emoções, e os animais, assim como os seres humanos, pareciam-me ser tratados como se estivessem sempre em uma condição neutra com referência à vida instintiva. Pode-se ver o processo civilizador que leva um cão a um estado constante de frustração. Considere-se a tensão que impomos a um cão que *sequer secrete urina na bexiga* até que alguma indicação lhe seja dada de que haverá oportunidade para que ele a descarregue. Quão mais importante deve ser permitirmos que a fisiologia torne-se complicada pela emoção e pelo conflito emocional quando estudamos a maneira pela qual o corpo humano funciona.

Um estudo do problema da trombose coronária como transtorno psicossomático exige de nós um conhecimento da fisiologia da excitação. Isto em verdade deve ser complexo, mas não é o bastante. Precisamos ainda conhecer o que acontece no corpo quando a excitação "esfria", isto é, quando não chega a um *clímax*.

Na literatura, acho que pode ser um fracasso examinar a trombose coronária sob o poder ampliador do microscópio, em grande parte por causa de falta de oportunidade. Em consequência, a psicopatologia permanece obscura. Observar-se-á que fatores externos adversos, por mais reais que sejam, tornam-se tensões internas quando determinado paciente é submetido a escrutínio.

E. Fisiologia da excitação

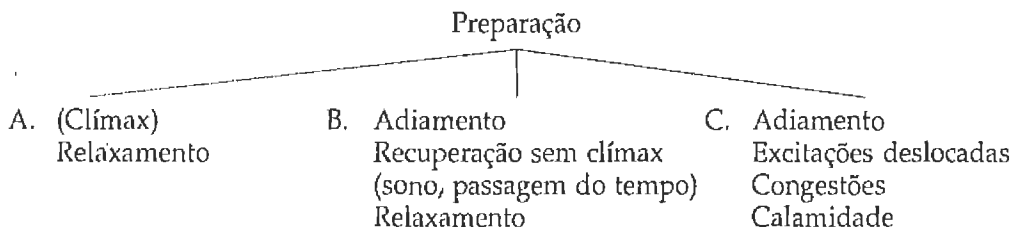
Local	Preparação
Geral	Clímax
	Relaxamento

(Isto implica em uma experiência puramente pessoal, ou seja, não é um relacionamento.)

1. John Hambling, *Emotions and Symptoms in Essential Hypertension*. *British Journal of Medical Psychology*, 24 (1951) e 25 (1952).

A isto tem-se de adicionar o fator de relacionamento, ou seja, tudo o que acompanha a tentativa de vincular a experiência instintiva com outros tipos de amor e com a consideração afetuosa.

Nesta altura, precisamos de algum tipo de diagrama que possa ser modificado de maneira a abranger o grau de excitação que precisa ser perdido.



É necessário levar em conta a idade do sujeito, pois uma pessoa jovem, de 20 a 30 anos, pode suportar a tensão melhor que uma outra de 40 a 50 anos. Uma pessoa jovem pode mesmo sofrer uma tremenda aflição mental e corporal causada por um fracasso em atingir o clímax sem o insulto adicional de um acidente físico, sem mudança reversível, tal como a trombose de uma arteríola.

No primeiro grau de fracasso (B), a excitação local se dissipa ou então, de maneira geral, o clímax é representado pelo sono, por um jogo de golfe ou por uma briga com a cozinheira.

O grau mais adiantado (C) produz um estado de coisas altamente complexo, primeiro com congestões alternativas e excitações deslocadas, e, depois, com qualquer dos estados mentais que chamamos de anormais, de acordo com a constituição do indivíduo.

Calamidade	(histeria) depressão despersonalização desintegração senso de irrealidade ou uma mistura tensão geral (defesas caóticas)
------------------	--

Apenas a passagem do tempo cura esta fase, na qual há impotência ou frigidez e, provavelmente, uma incapacidade de se masturbar, ou, então, a masturbação só é possível pela convocação de mecanismos pervertidos e de regressão.

F. Elaboração do tema da excitação

Fica claro que não estou me referindo à:

1. Exultação, um estado mental, uma questão da mente, ou;
2. Defesa maníaca contra a depressão, com o humor deprimido sendo potencial mas denegado (hipomania); ou
3. Oscilação maníaca na psicose maníaco-depressiva

A excitação é a pré-condição para a experiência instintiva. Há muitas zonas em que a excitação ocorre localmente, mas para a personalidade integrada, as excitações locais fazem parte da construção de um estado geral de excitação, e a satisfação puramente local de uma localização instintiva de vulto constitui uma frustração para a pessoa total que esperava mais resultados — na realidade, uma experiência total, com base na experiência do passado.

Nas referências à masturbação na adolescência, com a qual, freqüentemente, esta questão da participação total é ignorada, de maneira que não se sabe se a descarga local da tensão instintiva foi boa ou má para o corpo como um todo (e isto inteiramente é parte da presença ou ausência de ansiedade ou sentimento de culpa).

Quando a excitação local cresce a ponto de tornar-se parte de uma excitação corporal total, e da excitação da pessoa como um todo, ainda assim queremos saber se este fenômeno faz ou não parte de um relacionamento, e, se fizer, se o outro objeto é uma coisa ou um outro ser humano total.

Em um dos extremos, não há estorvo da parte de fora, nenhuma razão externa para que a excitação não cresça até chegar a um clímax, seguido pelo relaxamento. No outro extremo, existem todas as razões para que seja difícil a determinado indivíduo obter um clímax pessoal satisfatório e oportuno, uma vez que este clímax tem de se encaixar com a necessidade semelhante de que alguém mais tenha de um clímax oportuno. Exceto quando duas pessoas românticas acham-se apaixonadas uma pela outra, as condições para duas satisfações ao mesmo tempo só raramente são alcançadas.

Tudo isto é muito evidente, mas não estou certo de quanta atenção foi dada à fisiologia da impotência e da frigidez — encontramos com mais facilidade a afirmação de que a satisfação instintiva é boa, em sentido fisiológico, produzindo um estado de libertação geral da tensão — ou de um estado que é chamado de normal.

O que normalmente ocorre com homens e mulheres que gostam de vincular suas experiências instintuais com o enriquecimento dos relacionamentos é que muitas excitações têm de permanecer não-correspondidas, e encontrar uma maneira de se extinguir. Aqui nos aproximamos da fisiologia de um transtorno psicossomático tal como é a trombose coronária.

7

Alucinação e Desalucinação

Escrito para um seminário realizado em 3 de outubro de 1957

Uma mulher teve um sonho, cujo relato me foi fornecido como segue:

Acordei de um sonho gritando (imagino que sem som). Achava-me num quarto quando um menininho fora de moda, de aproximadamente seis anos de idade, veio correndo em minha direção, em busca de ajuda. Identifiquei isto imediatamente como uma alucinação e ela simplesmente me aterrorizou e acordei gritando a plenos pulmões. Enquanto ele se retirava, joguei uma almofada atrás dele e, então, alguém parecido com a Babá apareceu na porta, como se quisesse saber o que estava acontecendo. Fiquei pensando se ela também poderia ver o menininho, mas estava bastante indistinguível naquela parte do quarto. Pensei antes que ela o havia apanhado. Tive esperança de que W. escutasse meus gritos e viesse, mas agora, dei-me conta de que não estava na realidade fazendo qualquer barulho. Isto aumentou meus temores e foi neste estado que acordei, ainda bastante desorientada. Não sabia onde estava ou que horas eram, ainda que ouvisse o tique-taque do relógio. Permaneci em estado de susto por algum tempo, mas acabei por me recuperar o suficiente para sair e urinar.

Houve associações ao sonho e a paciente achou que ele tinha a ver com uma interpretação relativa à desalucinação. Ela descreveu este sonho para mim como sendo, de longe, o mais aterrorizante de todos os seus muitos pesadelos.

As associações com o sonho e o lugar dele na análise tornam claras grande parte de sua função. O ponto a que desejo me referir é a esta questão da relação da alucinação com a desalucinação e quero apresentar uma idéia a respeito disto para que vocês a debatam.

Amiúde me impressiona, como sendo uma dificuldade que não enfrentamos, que às vezes dizemos que um paciente está alucinado e tomamos isso como prova de psicose e, outras vezes, referimo-nos a pacientes, e especialmente a crianças, como se estivessem alucinando, sem pensar neles como se achando sequer enfermos. Eles podem talvez estar cansados e, portanto, cientes de alucinações que, quando estão mais alertas, ocultam ou confinam ao tipo de objetos que, na realidade, podem perceber em seu meio ambiente. A maioria das crianças alucina livremente e eu certamente não diagnosticaria uma anormalidade quando uma mãe me diz que, em seu aparta-

mento, há uma vaca no corredor e que o seu filho de quatro anos tem grande dificuldade em lidar com esta obstrução. O mesmo menino possui toda uma série de objetos imaginários que têm de ser tratados com o respeito que lhes é devido: alguém, por exemplo, chamado *Fluflu*, que passa a maior parte do tempo sob uma cadeira e que se acha, de maneira vaga, misturado com a idéia de Jesus. Não há necessidade de que eu forneça exemplos, porque quem quer que se ache em contato com crianças pequenas sabe que aquelas que alucinam livremente não são necessariamente enfermas.

Podemos fazer uma pergunta: existe alguma diferença entre as alucinações que denotam enfermidade e aquelas que não possuem tal significação? Provavelmente a resposta a esta pergunta é que existem várias maneiras pelas quais podemos fazer distinção entre o alucinar normal e o alucinar patológico. Quero me referir a uma das diferenças possíveis e, ao fazê-lo, agradecer a ajuda vinda diretamente da Dra. Margaret Little. Na realidade, acho que o tipo de debate que estou promovendo aqui encontra-se relacionado ao debate de seu artigo sobre transferência delirante¹.

Ao sugerir uma resposta a esta questão, estou me valendo do que me parece ser uma valiosa e nova compreensão da desalucinação. Durante anos estive procurando a pista que me conduzisse ao uso especial que crianças e adultos, às vezes, fazem do preto. Pode-se gostar do escuro e o preto pode ser para algumas pessoas a melhor cor, mas o preto também denota algo mau, terrificante, traumático. Numa reunião da Seção Médica, quando dela era presidente, organizei um debate em torno da palavra "preto" e a resposta que eu queria não se apresentou, embora houvesse sido quase produzida pelo Dr. Robert Moody, um analista junguiano. Estou me referindo a fenômenos bem-conhecidos, tais como, por exemplo, o enegrecimento de quadros após haverem sido pintados. Conheço um paciente que se acha em um hospital psiquiátrico no momento e que pinta realmente bem, mas sempre enegrece a sua obra de arte; às vezes, uma delas consegue ser resgatada e ele então não objeta a que seja emoldurada e colocada na parede, mas acho que, nessa ocasião, ele não sabe mais que ela é de sua autoria.

Um menino esquizofrênico, paciente meu, por longo tempo não fez mais que enegrecer a totalidade de toda folha de papel que lhe era fornecida. Gradativamente, tornou-se claro que, de seu ponto de vista, havia uma pintura sob o negro. Às vezes, ele levantava o véu e pintava ou desenhava, e me permitia ver o que havia para ser desalucinado, mas era-lhe traumático que um desenho lhe fosse arrebatado e mostrado, tão traumático que, na realidade, ninguém jamais faria algo tão horrível quanto seria forçá-lo a isso.

Minha sugestão é que, em alguns casos, notamos que o alucinar é patológico por causa de um elemento compulsivo nele existente que pode ser explicado da seguinte maneira: algo foi desalucinado e, de maneira secundária, o paciente alucina em denegação da desalucinação. É complexo porque, primeiramente, houve algo que foi visto, depois algo desalucinado e, então, uma longa série de alucinações que, por assim dizer, preenchem a lacuna produzida pela escotomização.

O sonho que apresentei ilustra muito bem este ponto. O caso é simplificado pelo fato de a paciente não ser psicótica, mas teve de tornar-se psicótica na transferência, a fim de chegar a uma lembrança de um tipo muito aflitivo, pertencente à época em que contava por volta de dois anos de idade. Esta análise já percorreu um caminho muito longo e, a fim de alcançar a força necessária para lidar com este trauma, a paciente precisou fazer uma regressão muito profunda. Em outras palavras, teve de

1. Margaret I. Little, *On Delusional Transference (Transference Psychosis)*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 39(1958); reproduzido em Little, *Transference Neurosis and Transference Psychosis* (New York, London, Jason Aronson, 1981).

se tornar capaz de lidar com suas dificuldades iniciais em relação à mãe, a fim de poder vir a utilizar o pai como pai, e, então, tolerar o trauma aterrorizante de sua exposição a ele. No *setting* real, o pai estivera, por assim dizer, proporcionando ao bebê psicoterapia infantil, oferecendo-lhe um pênis bom e não excitado, que compensava a retirada muito precoce do seio por parte da mãe. Repentinamente, e de modo inteiramente inesperado, a paciente deparou-se com o pai sexualmente excitado e o resultado disso foi totalmente desastroso. Posso deixar de fora a totalidade do restante da descrição do caso e simplesmente dizer que, quando a paciente chega agora a este momento traumático (que, na realidade, reúne traumas múltiplos), ela chega a uma desalucinação do órgão genital excitado. No sonho, a criança que avança é alucinada de maneira compulsiva e em uma tentativa final de denegar o espaço deixado em frente da paciente no momento de ela desalucinar o órgão genital excitado.

Há um sonho de muitos anos atrás em que tudo isto já era prenunciado, mas o sentimento pertencente a esta sucessão de eventos — percepção, escotomização, alucinar compulsivo — só se tornou atingível apenas recentemente. Quando a paciente pela primeira vez veio até mim, ao invés do menininho havia uma luz brilhante, e isto quase fez a paciente seguir uma trilha falsa de espiritualismo, a trilha que em verdade foi seguida pelos outros membros da família, que se acham todos lidando, tal como a paciente, com vários aspectos do estado anormal do pai, que por sua vez derivava de uma sedução ocorrida durante o próprio começo da infância dele, possivelmente quando contava aproximadamente dois anos de idade.

Minha tese, pois, é que às vezes notamos um tipo especial do alucinar que é compulsivo e assustador, apesar do fato de que o que é alucinado não constituir, em si mesmo, uma ameaça. A pista, sugiro eu, é que ele tem de ser mantido a fim de denegar a escotomização ou a desalucinação. Deve haver um estágio muito importante, dependendo de o trauma emocional ter sido algo real ou um sonho.

8

Idéias e Definições

Provavelmente começo da década de 50¹

O *self* falso. O *self* verdadeiro

Estes termos são utilizados na descrição de uma organização defensiva na qual se dá uma assunção prematura das funções de amamentação da mãe, de maneira que o bebê ou a criança se adapta ao meio ambiente ao mesmo tempo em que protege e oculta o *self* verdadeiro, ou a fonte dos impulsos pessoais. É semelhante à função do Ego, no Freud inicial, voltado para o mundo, entre o Id e a realidade externa.

Nos casos típicos, o *self* verdadeiro aprisionado é incapaz de funcionar e, por ser protegido, sua oportunidade de experiência viva é limitada. A vida é vivida através do *self* falso complacente e o resultado disso, clinicamente, é um senso de irrealidade. Para descrever estados semelhantes, outros autores utilizam o seguinte termo: Ego Observador.

A espontaneidade e o impulso real só podem provir do *self* verdadeiro e, para que isto aconteça, alguém precisa assumir as funções defensivas do *self* falso.

Objeto transicional. Fenômenos transicionais

O termo *objeto transicional* destinou-se a conceder significância aos primeiros sinais, no bebê em desenvolvimento, da aceitação de um símbolo. Este precursor de um símbolo é, a um só e ao mesmo tempo, parte do bebê e parte da mãe. Com frequência este símbolo precursor é na realidade um objeto, e a adição do bebê a esse objeto real é reconhecida e admitida pelos pais. Amiúde, porém, não existe materialização e, então, pode-se descobrir mais tarde que certos fenômenos possuem a mesma importância, tais como, por exemplo, olhar, pensar, fazer distinção entre cores, exploração de movimentos e sensações corporais, etc.

A própria mãe pode tornar-se um objeto transicional, e, às vezes, o polegar. Formas degeneradas são representadas pelo balançar, o bater com a cabeça, o sugar do polegar altamente compulsivo, e, mais tarde, a *pseudologia fantástica* e o furto.

1. Este trabalho foi encontrado numa pasta marcada "Idéias" [N. dos Organizadores]

se tornar capaz de lidar com suas dificuldades iniciais em relação à mãe, a fim de poder vir a utilizar o pai como pai, e, então, tolerar o trauma aterrorizante de sua exposição a ele. No *setting* real, o pai estivera, por assim dizer, proporcionando ao bebê psicoterapia infantil, oferecendo-lhe um pênis bom e não excitado, que compensava a retirada muito precoce do seio por parte da mãe. Repentinamente, e de modo inteiramente inesperado, a paciente deparou-se com o pai sexualmente excitado e o resultado disso foi totalmente desastroso. Posso deixar de fora a totalidade do restante da descrição do caso e simplesmente dizer que, quando a paciente chega agora a este momento traumático (que, na realidade, reúne traumas múltiplos), ela chega a uma desalucinação do órgão genital excitado. No sonho, a criança que avança é alucinada de maneira compulsiva e em uma tentativa final de denegar o espaço deixado em frente da paciente no momento de ela desalucinar o órgão genital excitado.

Há um sonho de muitos anos atrás em que tudo isto já era prenunciado, mas o sentimento pertencente a esta sucessão de eventos — percepção, escotomização, alucinar compulsivo — só se tornou atingível apenas recentemente. Quando a paciente pela primeira vez veio até mim, ao invés do menininho havia uma luz brilhante, e isto quase fez a paciente seguir uma trilha falsa de espiritualismo, a trilha que em verdade foi seguida pelos outros membros da família, que se acham todos lidando, tal como a paciente, com vários aspectos do estado anormal do pai, que por sua vez derivava de uma sedução ocorrida durante o próprio começo da infância dele, possivelmente quando contava aproximadamente dois anos de idade.

Minha tese, pois, é que às vezes notamos um tipo especial do alucinar que é compulsivo e assustador, apesar do fato de que o que é alucinado não constituir, em si mesmo, uma ameaça. A pista, sugiro eu, é que ele tem de ser mantido a fim de denegar a escotomização ou a desalucinação. Deve haver um estágio muito importante, dependendo de o trauma emocional ter sido algo real ou um sonho.

8

Idéias e Definições

Provavelmente começo da década de 50¹

O *self* falso. O *self* verdadeiro

Estes termos são utilizados na descrição de uma organização defensiva na qual se dá uma assunção prematura das funções de amamentação da mãe, de maneira que o bebê ou a criança se adapta ao meio ambiente ao mesmo tempo em que protege e oculta o *self* verdadeiro, ou a fonte dos impulsos pessoais. É semelhante à função do Ego, no Freud inicial, voltado para o mundo, entre o Id e a realidade externa.

Nos casos típicos, o *self* verdadeiro aprisionado é incapaz de funcionar e, por ser protegido, sua oportunidade de experiência viva é limitada. A vida é vivida através do *self* falso complacente e o resultado disso, clinicamente, é um senso de irrealidade. Para descrever estados semelhantes, outros autores utilizam o seguinte termo: Ego Observador.

A espontaneidade e o impulso real só podem provir do *self* verdadeiro e, para que isto aconteça, alguém precisa assumir as funções defensivas do *self* falso.

Objeto transicional. Fenômenos transicionais

O termo *objeto transicional* destinou-se a conceder significância aos primeiros sinais, no bebê em desenvolvimento, da aceitação de um símbolo. Este precursor de um símbolo é, a um só e ao mesmo tempo, parte do bebê e parte da mãe. Com frequência este símbolo precursor é na realidade um objeto, e a adicção do bebê a esse objeto real é reconhecida e admitida pelos pais. Amiúde, porém, não existe materialização e, então, pode-se descobrir mais tarde que certos fenômenos possuem a mesma importância, tais como, por exemplo, olhar, pensar, fazer distinção entre cores, exploração de movimentos e sensações corporais, etc.

A própria mãe pode tornar-se um objeto transicional, e, às vezes, o polegar. Formas degeneradas são representadas pelo balançar, o bater com a cabeça, o sugar do polegar altamente compulsivo, e, mais tarde, a *pseudologia fantástica* e o furto.

1. Este trabalho foi encontrado numa pasta marcada "Idéias" [N. dos Organizadores]

Em condições favoráveis, este objeto gradualmente cede lugar a uma gama de objetos cada vez mais ampla e à totalidade da vida cultural.

Regressão (à dependência)

O termo *regressão* aplica-se ordinariamente, nos textos psicanalíticos, a posições instintuais. A regressão se dá de experiências ou fantasias eróticas genitais para outras pré-genitais, ou para pontos de fixação pertencentes à vida da primeira infância em que a fantasia pré-genital é naturalmente dominante.

Regressão é também um termo conveniente para uso na descrição do estado de um adulto ou de uma criança na transferência (ou em qualquer outro relacionamento dependente), quando uma posição avançada é abandonada, restabelecendo-se uma dependência infantil. Tipicamente, uma regressão desta espécie se dá da independência para a dependência. Neste emprego do termo, o meio ambiente se vê indiretamente incluído, uma vez que a dependência implica em um meio ambiente que atenda à dependência. Em comparação, no outro uso do termo *regressão* não há referência implícita a um meio ambiente. A expressão é também usada para descrever o *processo* que pode ser observado em um tratamento, o desfazer-se gradual do *self* falso ou que toma conta, e a abordagem a um novo relacionamento, no qual o *self* zelador é passado para o terapeuta.

Mãe suficientemente boa

Este termo é utilizado na descrição da dependência que pertence à primeiríssima infância. A implicação é que a saúde mental tem de se fundar, em todos os casos, na mãe, que, na saúde, atende às necessidades que o seu bebê tem de minuto a minuto. O que o bebê precisa, e necessita de modo absoluto, não é algum tipo de perfeição de maternagem, mas uma adaptação suficientemente boa, aquela que faz parte de uma relação viva em que a mãe temporariamente se identifica com o seu bebê. A fim de poder identificar-se com seu bebê no grau necessário, a mãe precisa ser protegida da realidade externa, de maneira a que possa desfrutar de um período de preocupação, com o bebê sendo o objeto dessa preocupação. A fim de poder perder este alto grau de identificação à medida que o bebê passa da dependência para a independência, a mãe precisa ser saudável, no sentido de não estar sujeita à preocupação mórbida.

9

Psicogênese de Uma Fantasia de Espancamento

Datado de 11 de março de 1958

O artigo de Freud, *Uma Criança é Espancada*, colocou em foco o assunto da fantasia de espancamento. A extrema complexidade da organização existente por trás destas fantasias é claramente ressaltada, e também a diferença existente entre essas fantasias em meninos e meninas. A idéia de que uma fantasia deste tipo é superdeterminada faz parte da tese, e também se torna por evidente que a crueldade desta maneira organizada certamente se acha associada a uma fixação na fase anal. Segundo minha experiência, estas fantasias, que são extremamente comuns e assumem inumeráveis formas, devem sempre ser examinadas como novas em cada caso, porque embora existam denominadores comuns, nunca pode haver uma regra aproximada que possa ser aplicada a todos os casos.

Nesta breve nota, gostaria de descrever a história de uma fantasia de espancamento que persistiu através de toda uma longa análise e da qual a elucidação só chegou ao final desta. Muitas tendências se achavam reunidas neste importante detalhe e cada tendência possuía sua própria importância. Desde o início, a paciente tornou inteiramente claro que sua análise não seria bem-sucedida, a menos que esclarecesse esta particular idéia pervertida que lhe era tão importante e que recorrera toda a sua vida como uma válvula sexual de escape e que, apesar disso, jamais fora atuada. Tratava-se em verdade de um detalhe importante, quando se revelou que, na fantasia em si, não havia sofrimento.

Tinha havido um acontecimento inicial da infância que resultou nesta fantasia estabelecida. Desde o início da análise sabia-se que, em certo estágio do desenvolvimento à época em que a paciente contava aproximadamente cinco anos de idade, a surra fora aplicada por uma certa Sra. Stickland e era óbvio que a vara [*stick*] que a mulher possuía era importante. Não se tratava apenas de uma idéia, mas era sentido pela paciente como sendo de importância fundamental. Em um dos desenvolvimentos do tema, a mãe da paciente tira de seu guarda-roupa uma vara, mas existiam inúmeras variações do tema. Em determinada ocasião, pensou-se que tinha havido um episódio em que o pai desta paciente a havia surrado em um momento de excitação sexual. Isto, contudo, revelou-se um equívoco e uma fantasia encobridora por trás da qual residia um episódio sexual em que o pai era descoberto pela criança em um

momento embaraçoso. Ao final, a paciente e eu concordamos que não havia quaisquer provas de ter havido algum espancamento real, nem mesmo em brinquedos de infância.

Esta paciente havia tido uma longa análise antes de chegar até mim, e também outra curta; no curso de uma análise de dez anos comigo passara por uma regressão muito profunda. Nesta, ela era inequivocamente infantil e, quando no fundo da regressão, encontrava-se em estado de regressão quase total, com muito pouco ego sadio que estivesse em contato com a realidade externa. Neste estágio, como já descrevi alhures, era eu quem visitava a paciente e, em verdade, tratava de seus assuntos e comprava-lhe comida. Durante a fase da regressão mais profunda uma assistente social preparava-lhe a comida e cuidava dos trabalhos caseiros. A paciente acabou saindo de seu estado regredido, efetuando um avanço que teve muitas interrupções inesperadas, cada uma das quais era extremamente penosa para a paciente e para mim, por causa da tensão em que este tratamento estava nos colocando.

Foi interessante que, no curso desta regressão profunda e no movimento para frente que a seguiu, a fantasia de espancamento foi a única coisa que permaneceu constante, apesar de pertencer a um estágio mais avançado de desenvolvimento. Sempre que a paciente desenvolvia tensão sexual, o alívio era obtido ao longo da fantasia que estou descrevendo. Era-lhe talvez a única válvula de escape sexual confiável, pois bastante cedo no tratamento o contato sexual com homens havia-se tornado sem sentido. Note-se, de passagem, que esta paciente — por razões que acabarão por tornar-se bastante claras — não havia tido experiências manifestas de homossexualidade, embora houvesse atraído o tipo de pessoas com as quais poderiam haver formado este tipo de relacionamento. A ausência de experiências homossexuais fazia parte de sua extrema desesperança no relacionamento com a mãe, a mesma que aparece também na fantasia de espancamento.

Bem ao fim do tratamento, a paciente apresenta para análise esta mesma constelação inalterada, e ambos sabíamos que a análise não poderia terminar sem a sua resolução. Acabou-se por preparar o caminho para uma melhor compreensão dela através de material que exigiu a interpretação de que a idéia do espancamento estava suplantando uma extrema desesperança a respeito de comunicar-se com a mãe em nível anal. Toda sua vida a paciente manipulava a sua flatulência e havia em verdade desenvolvido uma técnica de especialista a este respeito, mas tudo foi em vão e houve um período de depressão profunda associada com o pleno reconhecimento da absoluta desesperança que ela tivera, em bebê, com referência a qualquer comunicação com a mãe por esta maneira. Isto seguiu-se, naturalmente, a uma desesperança mais profunda a respeito de comunicar-se em nível oral, mas o fracasso aqui ia tão fundo e envolvia processos tão primitivos que o ego da paciente não se achava suficientemente organizado para ela experienciar pesar ou desesperança. Ela podia apenas sentir que sua boca e seu apetite haviam-se ido com a mãe que a desmamara e abandonara com a idade de dois meses a uma babá.

A paciente sentia que a fantasia de espancamento achava-se relacionada a uma fixação.

Pode-se dizer que nada teria alterado o sentimento da paciente a respeito da fantasia de espancamento até que fosse possível fazer a interpretação, do material fornecido durante a sessão, de que a fixação era na mãe. Era o sadismo reprimido da mãe o fator inalterável. Na vida, o masoquismo da mãe era evidente e sempre fora um elemento muito importante que verdadeiramente afetara o marido e todos os filhos. Poder-se-ia dizer que ela casara e tivera filhos como uma experiência masoquista, chegando às vezes a uma posição mais evidente de autopunição, com um elemento suicida em si. O sadismo subjacente, em verdade, emergira em sua velhice e mostrava-se particularmente evidente no tratamento que dava a uma mulher que lhe era devotada e também, de modo bastante óbvio, um tipo homossexual.

Após esta interpretação e a sessão que lhe deu sentido, houve a impressão de ter-se dado uma mudança na associação de vida inteira da paciente com a fantasia de espancamento. É talvez possível vincular o detalhe de nunca ter havido qualquer sensação de ficar machucada com o fato de que o masoquismo e a fixação da mãe é que eram operativos.

Pode-se mencionar que durante toda a análise o relacionamento da paciente com o inconsciente reprimido da mãe fora importante e também o relacionamento dela com esta última como sendo uma organização de defesas contra a ansiedade. A desesperança no relacionamento da paciente com a mãe era simplesmente uma outra expressão do fato de que a mãe, como pessoa, não se achava disponível, embora tenha se tornado acessível quando a paciente ficou mais velha e, em verdade, tornou-se uma boa amiga, do tipo triste e sofredor.

Há ainda mais um ponto a examinar: o de que a própria fixação anal da paciente era também importante, mas é preciso notar que, clinicamente, neste caso nenhuma mudança podia ser feita até que a fixação da mãe nesse nível fosse trazida à análise como importante. Passando em revista o material, não consigo acreditar que um conhecimento disto tivesse possibilitado ao analista encurtar a análise, por fazer este tipo de interpretação em data mais anterior. Acho, na realidade, que a interpretação da fixação anal e do sadismo reprimido da mãe só poderia ter sido feita ao final da análise da paciente, e baseio esta opinião no fato de que somente então foi fornecido na análise o material para esta interpretação.

10

Nada no Centro

Datado de 19 de junho de 1959

A paciente, mulher de 30 anos é atriz, chegou à análise em estado muito amistoso. Falava sobre muitas coisas que estavam acontecendo em sua vida. Tinha uma personalidade atraente e havia muito que ela podia dizer que indicava que as pessoas gostam dela ativamente. Posso dizer que este é um exemplo da defesa principal desta paciente.

A sessão anterior havia sido extremamente insatisfatória. A paciente não conseguira encontrar nada de particular a que reagir. Encontra-se entre trabalhos, mas nenhum trabalho novo se acha pendente e há uma lacuna de várias semanas em que talvez nada lhe apareça. Poder-se-ia dizer que estava agitada, assustada com o estado de coisas produzido por não existir nada a que pudesse reagir. Como disse, podia chegar em casa e encontrar um convite para jantar ou uma mensagem de seu agente, e ficaria inteiramente bem de novo, feliz, vivaz e bem-orientada. Na sessão anterior, havia atingido um estado de apatia e achava-se intensamente irritada comigo por eu parecer ser a favor dele. O que queria dizer era que eu não me achava adotando a atitude que ela própria adota — e seus pais e amigos também — qual seja, a de “pelo amor de Deus, arranje um trabalho, faça alguma coisa, arrume a roupa”, etc.

Esta moça trabalhara muito arduamente desde a idade de dez anos, quando começara a representar. No início do tratamento, passou um período em um hospital psiquiátrico, onde lhe permitiram ficar deprimida e isto foi de imenso valor para ela, mas ainda uma vez, não estava em dificuldades por se achar, todo o tempo, lidando com uma depressão. Ela sentia saber onde estava indo. Agora, que se encontra quase recuperada, descobre-se, contudo, neste estado assustado, com falta de orientação.

Na análise desta paciente, a coisa realmente difícil era chegar ao comer e à fantasia de comer, isto é, ao erotismo e ao sadismo orais que complicam outros tipos de relacionamentos com objetos. A paciente estivera tão irritada comigo na sessão anterior que, quando tossi, ela não pôde suportá-lo e, de qualquer modo, sabia que estava irritada comigo por razões desconhecidas. Conseguiu relatar que tivera a idéia de um bebê em algum lugar da mente, indicando que a análise não era boa porque não lhe havia produzido uma gravidez. Este, contudo, era apenas um dos aspectos da frustração geral da análise, que, na realidade, havia sido uniformemente bem-sucedida e produtiva.

Por ocasião desta sessão particular a que me estou referindo, a paciente achava-se em seu estado usual de defesa maníaca, em que tudo vai bem e todos gostam dela, mas tanto ela quanto eu sabíamos que isso era precário e que por detrás de tudo aquilo havia outra coisa.

O notável foi o que aconteceu quando fiz uma certa interpretação: Foi ela quem apontou que a sua felicidade era devida ao fato de que algumas coisas haviam estado lhe acontecendo, mas que, por debaixo delas, continuava a ser a mesma. Interpretei que se nada estava acontecendo para que ela reagisse a isso, então ela havia chegado ao centro de si mesma, onde sabe que não existe nada. Disse-lhe que este nada no centro é a tremenda fome dela. O buraco no meio que é ela própria é uma fome de tudo, pertence à totalidade de sua vida e inclui o vazio antes da impregnação, assim como o desejo sexual e oral. Assim que a tendência de minha interpretação se lhe tornou clara, e a interpretação era inteiramente nova, ela caiu profundamente adormecida e assim permaneceu por cerca de vinte minutos. Quando começou a despertar e a ficar impaciente por ter dormido e perdido a sessão, comeci novamente a interpretação, depois da qual ela tombou novamente em outro sono e assim permaneceu até o final da sessão. Quando acordou, disse: "Estive colada no divã". Arrancou-se deste, a fim de sentar-se e enfiar os sapatos, porque, apesar de haver dormido, sabia quando era hora de ir embora e assim fez. No momento em que chegou à porta de saída havia recobrado sua costumeira e atraente vivacidade.

Esta paciente com frequência adormece, mas nesses casos, é porque se encontra usualmente em estado de exaustão, resultado do excesso de trabalho físico e de haver ficado acordada até tarde, de maneira condizente com a vida de uma atriz. Desta vez, o sono tinha em si uma qualidade nova, pensei, uma qualidade que ela descrevera como estar colada no divã. Presumi que o sono representava um tipo específico de resistência à interpretação. A essência desta era haver um *self* dissociado que não é nada, nada senão um vácuo: ele é apenas vazio e, quando esse vazio se aviva, ela não é nada mais que uma imensa fome. Esta fora a primeira vez que ela e eu, no curso de quatro anos de análise, havíamos encontrado juntos um enunciado satisfatório para o seu *self* verdadeiro e, ao mesmo tempo, para o seu apetite.

Tenho ao mesmo tempo em minha clínica um paciente, um homem que é médico. Ele também teve de descobrir em si um nada central. Durante longo tempo este aparecera na análise como um estado de chafurdamento que lhe era muito alarmante e tivemos de lidar com este em diversas camadas. Em determinada camada, quando gradualmente eliminamos todas as colisões, de maneira que ele não tinha mais nada a que reagir, ele se tornou uma coisa no espaço, a ignorar o tempo e a posição. Em três sessões sucessivas, esta semana, o paciente chegou a um enunciado diferente disto, que, para ele, faz parte de sua busca de um *self* que sinta como real. Com grande dificuldade, elimina todo o tremendo número de coisas em sua vida a que reage e enfrenta com sucesso, inclusive seu relacionamento com a família e uma esposa que indubitavelmente lhe apresenta grandes dificuldades, por causa de sua própria capacidade de encaixar-se exatamente no padrão da mãe do paciente. Ele a escolheu por causa disso, como sabe agora bem demais. Neste paciente específico, é vitalmente importante que eu tenha de reconhecer que, no centro, não existe nada. Ele teve de pôr de lado até mesmo a sua potência, por ser reativa. Ele não apenas não acredita que exista alguma coisa que possa ser chamada ele, mas antes, sabe que no centro não há nada e é somente isso que pode tolerar. Se eu lhe fornecesse qualquer esperança de existir algo, ele teria de destruir-me. Foi interessante a maneira pela qual este paciente começou a revelar-se de maneira positiva quando já se havia estabelecido o suficiente como um nada. O que ele relatou ao final dessas três sessões em que este tema havia sido minuciosamente elaborado e nas quais fora capaz de manter um estado de nada expressou-se da seguinte maneira: disse sentir-se apertadamente en-

rolado entre as pernas e prosseguiu descrevendo o efeito disto sobre seus órgãos genitais e sua capacidade de urinar. Tive à minha disposição uma quantidade muito grande de material, a qual me permitiu efetuar a seguinte interpretação: ele estava me contando, em termos físicos, como a sua mãe lhe transmitira, quando era ainda um minúsculo bebê, que, do ponto de vista dela, ele era uma menina e não um menino. Havia substância nisto, por haver ele sido o segundo menino que lhe nascera e a atitude dos pais, todo o tempo, revelara o fato de que teriam gostado de ter tido uma menina como segundo filho. Pude dizer-lhe que a mãe arrumava-lhe as fraldas de uma maneira que seria apropriada para um bebê do sexo feminino, talvez como uma toalhinha sanitária. O resultado disto fora que não tivera liberdade para urinar e, quando lhe apontei que, se fosse uma criança nativa, a viver numa cabana na floresta, teria sido diferente, ele subitamente apanhou o sentido de minha interpretação e, através dela, chegou à idéia de um menino a urinar livremente. Esta é a primeira vez que pôde recordar em que sentiu o pênis como sendo seu próprio. Parece como se isto fosse o início de sua potência, que nunca tivera, embora na realidade possuía uma família. Aqui, de maneira diferente, quando comparada com o primeiro caso, havia um homem que tinha de chegar ao nada central. Em seu caso, o que surgiu não foi a fome, mas o urinar. Os dois casos podem talvez ser comparados, para fins de debate.

11

O Destino do Objeto Transicional

*Preparação para uma palestra proferida perante
a Associação de Psicologia e Psiquiatria Infantil,
de Glasgow, em 5 de dezembro de 1959*

Embora muitos de vocês já estejam muito familiarizados com o que eu já falei a respeito de objetos transicionais, gostaria, primeiramente, de reenunciar a visão que tenho deles e, depois, passar para o meu tema principal, que é a questão de seu destino. Aqui temos, então, um enunciado da maneira pela qual os objetos transicionais me parecem ter importância. Eles me parecem achar-se em várias linhas de transição. Uma delas tem a ver com os relacionamentos objetais; o bebê coloca o punho na boca, depois o polegar, e, depois, há uma mistura do uso do polegar ou dos dedos, e de algum objeto que é escolhido pelo bebê para manejar. Gradualmente há um uso de objetos que não fazem parte do bebê, mas tampouco fazem parte da mãe.

Outro tipo de transição tem a ver com a mudança de um objeto — que é subjetivo para o bebê — para outro, que é objetivamente percebido ou externo. A princípio, qualquer objeto que conquiste um relacionamento com o bebê é criado por este, ou pelo menos, esta é uma teoria sobre o assunto que tem a minha adesão. Assemelha-se a uma alucinação. Faz-se um pouco de trapaça e um objeto que se encontra à mão sobrepõe-se parcialmente a uma alucinação. Obviamente, a maneira pela qual a mãe ou o substituto dela se comporta é de importância suprema aqui. Uma mãe é boa e outra é má em deixarem um objeto real ficar exatamente onde o bebê está alucinando um objeto, de maneira que, na realidade, a criança fica com a ilusão de que o mundo pode ser criado e de que o que é criado é o mundo.

Neste ponto, vocês estarão pensando no termo *realização simbólica*, de Mme. Sechehaye¹, no tornar real o símbolo, apenas que, desde nosso ponto de vista, que trata da primeiríssima infância, estamos pensando em tornar real a alucinação. Isto, com efeito, dá início à capacidade que o bebê tem de utilizar símbolos, e, onde o crescimento é constante, o objeto transicional é o primeiro símbolo. Aqui o símbolo é, ao mesmo tempo, tanto a alucinação quanto uma parte objetivamente percebida da realidade externa.

Disto tudo, ver-se-á que estamos descrevendo a vida de um bebê que significa também o relacionamento do meio ambiente, através da mãe ou do substituto desta para o bebê. Estamos falando a respeito de um "par que cuida", para usar a expressão

1. M. A. Sechehaye, *Symbolic Realization* (New York, International Universities Press, 1951).

de Merrill Middlemore². Estamos nos referindo ao fato de não existir uma coisa chamada bebê, porque, quando vemos um bebê neste estágio inicial, sabemos que com ele encontraremos o cuidado infantil com o bebê, como parte desta função.

Esta maneira de enunciar o significado do objeto transicional torna necessário que empreguemos a palavra *ilusão*. A mãe está capacitando o bebê a ter a ilusão de que objetos da realidade externa podem ser reais para ele, isto é, que eles podem ser alucinações, uma vez que são apenas estas que são sentidas como reais. Se se quer que um objeto externo pareça real, então o relacionamento com ele tem de ser o relacionamento que se tem com uma alucinação. Como prontamente concordarão, isto faz explodir um antigo enigma filosófico, e estarão pensando nos dois *limericks**, um deles da autoria de Ronald Knox:

A pedra e a árvore
Continuam a existir
Quando não há ninguém no pátio?

E a resposta:

A pedra e a árvore
Continuam a existir,
Tal como observadas pelo sinceramente seu...

O fato é que um objeto externo não tem existência para vocês ou para mim exceto na medida em que vocês ou eu o alucinamos, mas sendo sãos, tomamos o cuidado de não alucinar, exceto quando sabemos o que ver. Naturalmente, quando estamos cansados ou há penumbra, podemos cometer alguns equívocos. O bebê com um objeto transicional acha-se, em minha opinião, todo o tempo neste estado em que lhe permitimos ficar e, embora seja louco, não o chamamos de loucura. Se o bebê pudesse falar, sua reivindicação seria: "Este objeto faz parte da realidade externa e eu o criei". Se vocês ou eu disséssemos isso, seríamos trancados a chave ou, talvez, leucotomizados. Isto nos dá um significado para a palavra *onipotência* do qual realmente precisamos, porque, quando falamos a respeito da onipotência da primeira infância, não queremos dizer apenas onipotência de pensamento; pretendemos indicar que o bebê acredita em uma onipotência que se estende a certos objetos e, talvez, estenda-se para abranger a mãe e algumas outras pessoas no meio ambiente imediato. Uma das transições é do controle onipotente dos objetos externos para o abandono do controle e, finalmente, para o reconhecimento de que existem fenômenos que se acham fora de nosso próprio controle pessoal. O objeto transicional que faz parte tanto do bebê quanto da mãe adquire uma nova condição a que damos o nome de *posse*.

Há outras transições que acredito acharem-se em processo durante o período de tempo em que o bebê utiliza objetos transicionais. Exemplificando, há aquela que pertence aos poderes em desenvolvimento do bebê, ao desenvolvimento da coordenação e ao gradual enriquecimento da sensibilidade. O sentido do olfato acha-se em seu auge e, provavelmente, nunca mais será tão elevado assim, exceto, talvez, durante episódios psicóticos. A textura significa mais do que poderá jamais significar, bem como a secura e a umidade, e também o que se sente como frio e o que se sente como morno; todas estas coisas possuem um significado tremendo.

Juntamente com isto, é necessário mencionar a extrema sensibilidade dos lábios

2. M. P. Middlemore, *The Nursing Couple* (London, Hamish Hamilton, 1941).

* Espécie de verso de cinco linhas com a rima na 1ª, 2ª e 5ª linhas e na 3ª e 4ª. (N. do R.)

infantis e, sem dúvida, do sentido do gosto. A palavra “repugnante” ainda não veio a significar nada para o bebê e, no começo, ele nem mesmo se tornou interessado pelas excreções. A baba que caracteriza a primeira infância cobre o objeto e faz-nos lembrar do leão em sua jaula no zoológico, que quase parece amolecer o osso com saliva antes de acabar por dar-lhe fim mordendo-o e comendo-o. É fácil imaginar o leão com ternos sentimentos de carinho em relação ao osso que será logo destruído. Dessa maneira, nos fenômenos transicionais, vemos o início da capacidade de sentimentos afetuosos, com o relacionamento instintual direto mergulhando na repressão primária.

Desta maneira, podemos ver que o uso que um bebê faz de um objeto pode ser de uma maneira ou outra unido ao funcionamento corporal, e, em verdade, não se pode imaginar que um objeto possa ter significado para um bebê, a menos que assim se ache unido. Esta é outra maneira de enunciar que o ego se baseia em um ego corporal.

Forneci alguns exemplos apenas para lembrá-los de todos os tipos de possibilidades que existem e que são ilustrados no caso de seus próprios filhos, assim como no das crianças que são suas clientes. Às vezes, encontramos a mãe sendo usada como se ela própria fosse um objeto transicional, e isto pode persistir e dar origem a grandes problemas. Exemplificando, um paciente com quem tive de lidar recentemente usava o lóbulo da orelha da mãe. Adivinharão que, nestes casos em que a mãe é usada, existe quase certamente algo nela — uma necessidade inconsciente do filho ou filha — em cujo padrão a criança está se encaixando.

Temos também o uso do polegar ou dos dedos, que pode persistir, e pode haver ou não o acariciar afetoso de alguma parte do rosto ou de alguma parte da mãe, ou, ainda, de um objeto, tudo a ocorrer ao mesmo tempo. Em alguns casos, o acariciamento continua e perde-se de vista o sugar do polegar ou dedo. Então, com frequência acontece que um bebê que não utilizou a mão ou o polegar para gratificação auto-erótica, apesar disso pode usar um objeto de um ou outro tipo. Quando um objeto é empregado, geralmente se descobre uma ampliação do interesse, de maneira que, em breve, outros objetos se tornam importantes. Por uma razão ou outra, as meninas tendem a persistir com objetos macios até utilizarem bonecas e os meninos tendem a passar mais rapidamente para uma adoção de objetos duros. Poder-se-ia talvez dizer melhor que o menino que existe nas crianças de ambos sexos passa para os objetos duros, e que a menina que existe nas crianças de ambos os sexos tende a manter o interesse na suavidade e na textura, e isto pode acabar por juntar-se à identificação materna. Com frequência, quando há um objeto transicional nítido que data dos primeiros tempos ele persiste, embora, na realidade, a criança esteja mais empregada em utilizar os objetos seguintes e menos importantes; talvez em épocas de grande aflição, tristeza ou privação haja um retorno ao original ou ao polegar ou a uma perda completa da capacidade de utilizar símbolos e substitutos.

Deixarei isto por aqui. Há uma variedade infinita nos quadros clínicos e tudo de que podemos falar a respeito, com utilidade, é das implicações teóricas.

A Passagem do Objeto Transicional

Há duas abordagens para este assunto:

A. Os velhos soldados nunca morrem; apenas se desvanecem. O objeto transicional tende a ser relegado ao limbo das coisas semi-esquecidas no fundo das gavetas da cômoda ou na parte de trás do armário de brinquedos. É costumeiro, contudo, que a criança saiba. Exemplificando, um menino que esqueceu o seu objeto transicional tem uma fase de regressão que segue-se a uma privação. Ele retorna ao seu objeto transicional e, então, dá-se um retorno gradual às outras possessões posteriormente adquiridas. Dessa maneira, o objeto transicional pode ser:

- I. suplantado mas mantido;
- II. gasto;
- III. dado a outrem (não satisfatório);
- IV. guardado pela mãe, como relíquia de um tempo precioso na vida dela (identificação);
- V. etc.

Isto se refere ao destino do objeto em si.

B. Chego agora ao ponto principal que quero apresentar para debater. Não se trata de uma idéia nova, embora acreditei que o fosse quando a descrevi em meu artigo original. (Temo, agora que chego a ela, que a achem óbvia demais, a menos que, naturalmente, dela discordem.)

Se for verdade que o objeto transicional e os fenômenos transicionais encontram-se na própria base do simbolismo, acho então que podemos com justiça reivindicar que esses fenômenos assinalam a origem, na vida do bebê e da criança, de uma espécie de terceira área da existência, uma terceira área que acho que tem sido difícil de encaixar na teoria psicanalítica, que teve de ser erigida gradualmente, de acordo com o método pedra-por-pedra de uma ciência.

Esta terceira área poderia revelar ser a vida cultural do indivíduo.

O que são as três áreas? Uma, a fundamental, é a realidade psíquica ou interna individual, o inconsciente, se quiserem (não o inconsciente reprimido, que começa muito cedo, mas definitivamente, mais tarde). A realidade psíquica pessoal é aquela da qual o indivíduo *alucina*, ou *cria*, ou *imagina*, ou *concebe*. É dela que os sonhos são feitos, ainda que se vistam de materiais coletados na realidade externa.

A segunda área é a realidade externa, o mundo que é gradualmente reconhecido como NÃO-EU pelo bebê sadio em desenvolvimento que estabeleceu um *self*, com uma membrana limitadora, um interior e um exterior, o universo em expansão do qual o homem se contrai, por assim dizer.

Ora, os bebês, as crianças e os adultos recebem em si a realidade externa, como uma veste para os seus sonhos, e projetam-se em objetos e pessoas externas e enriquecem a realidade externa através de suas percepções imaginativas.

Mas eu acho que realmente encontramos uma terceira área, uma área do viver que corresponde aos fenômenos transicionais do bebê e, na realidade, deles deriva. Na medida em que o bebê alcançou os fenômenos transicionais, penso que a aceitação de símbolos é deficiente e a vida cultural, marcada pela pobreza.

Não há dúvida de que percebem com facilidade o que quero dizer. Colocando-o de modo bastante grosseiro: vamos a um concerto e ouvimos um dos últimos quartetos de corda de Beethoven (estão notando que sou intelectual). Esse quarteto não é apenas um fato externo produzido por Beethoven e tocado pelos músicos, e não é um sonho meu, que, em realidade, não teria sido tão bom. A experiência, acoplada à preparação que eu mesmo fiz para ela, capacita-me a criar um fato glorioso. Eu o desfruto porque digo que o criei, alucinei-o, e é real e teria estado lá houvesse eu ou não sido concebido.

Isto é louco. Em nossa vida cultural, porém, aceitamos a loucura, exatamente como aceitamos a loucura do bebê que alega (ainda que em murmúrios não-compreensíveis) "Eu alucinei isso e faz parte da mãe que se achava lá antes de eu aparecer".

Disto, verão porque acho que o objeto transicional é essencialmente diferente do objeto interno da terminologia de Melanie Klein. O objeto interno é uma questão da realidade interna, que se torna crescentemente complexo a cada momento da vida do bebê. O objeto transicional é, para nós, um pouco um cobertor, mas para o bebê, é um representante tanto do seio da mãe, digamos, quanto do seio internalizado dela.

Observem a seqüência que se dá quando a mãe acha-se ausente. O bebê aferra-se ao objeto transicional. Após um certo período de tempo, a mãe internalizada se

desvanece e, então, o objeto transicional deixa de significar alguma coisa. Em outras palavras, o objeto de transição é simbólico do objeto interno que é mantido vivo pela presença viva da mãe.

Da mesma maneira, talvez, um adulto pode sentir luto por alguém e, no decurso do luto, deixar de desfrutar interesses culturais; a recuperação do luto se faz acompanhar por um retorno de todos os interesses intermediários (inclusive as experiências religiosas) que enriquecem a vida do indivíduo na saúde.

Desta maneira, sinto que os fenômenos transicionais não passam, pelo menos não na saúde. Eles podem se tornar uma arte perdida, mas isto faz parte de uma doença no paciente, uma depressão, e algo equivalente à reação à privação na primeira infância, quando o objeto transicional e os fenômenos transicionais são temporariamente (ou, às vezes, permanentemente) sem sentido ou inexistentes.

Gostaria muitíssimo de escutar as reações de vocês a esta idéia de uma terceira área de experiência, de sua relação com a vida cultural e da derivação, por ela sugerida, dos fenômenos transicionais da primeira infância.

12

Notas sobre o Brinquedo

*Sem data*¹

I

A característica do brinquedo é o prazer.

Observações de animais jovens, inclusive o humano.

II

A satisfação no brinquedo depende do uso de símbolos, embora, na base, a pulsão provenha do instinto.

Símbolos: Isto representa aquilo.

Se aquilo é amado, isto pode ser usado e fruído.

Se aquilo é odiado, isto pode ser derrubado, ferido, morto, etc., e restaurado, e ferido novamente.

Isto é: a capacidade de brincar é uma *conquista* no desenvolvimento emocional de toda criança humana.

III

O brinquedo como conquista ou realização no desenvolvimento emocional individual.

A. A tendência, herdada, que impele a criança avante e (devido à extrema dependência do bebê humano);

B. A provisão, no meio ambiente, de condições que atendem às necessidades do bebê e da criança pequena, de maneira que o desenvolvimento não seja interrompido por reações a choques (frio, calor, má sustentação [*holding*], manejo defeituoso, inanição, etc.); e

1. Estas notas manuscritas foram encontradas no arquivo "Idéias" de D.W.W. É provável que datem de antes do final da década de 60, quando ele tornou costumeiro utilizar o substantivo verbal "brincar" (*playing*), em vez de (como na maioria das vezes aqui) "brinquedo" (*play*). [N. dos Organizadores]

C. O brinquedo começa como símbolo da confiança do bebê e da criança pequena na mãe (ou substituto materno).

IV

O brinquedo é uma *elaboração imaginativa* em torno de funções corporais, relacionamento com objetos e ansiedade.

Gradativamente, à medida que a criança se torna mais complexa como personalidade, com uma realidade pessoal ou interior, o brinquedo torna-se uma expressão, em termos de materiais externos, de relacionamentos e ansiedades internas. Isto conduz à idéia do brinquedo como expressão de identificação com pessoas, animais e objetos do meio ambiente inanimado.

V

O brinquedo é, primariamente, uma *atividade criativa* (tal como o sonho) desempenhada

1. em termos do real (o próprio corpo e objetos que se encontrem à mão);
2. em condições nas quais a criança tem confiança em alguém ou tornou-se confiante de modo geral, mediante a experiência satisfatória de um cuidado bom.

Em comparação, o cuidado insuficiente, produzindo uma falta de confiança, faz diminuir a capacidade de brincar.

VI

Produtos do brinquedo

Ao lado do elemento essencial, que é o prazer, o brinquedo dá à criança prática em

- a. manipulação de objetos;
- b. administração do poder de coordenação, habilidades, julgamentos, etc.;
- c. controle sobre uma área limitada. Embora a criança descubra um poder limitado de controlar, ela ao mesmo tempo descobre o campo de ação ilimitado da imaginação.

Através do brinquedo, a criança lida criativamente com a realidade externa. Ao final, isto produz um viver criativo e conduz à capacidade de sentir-se real e sentir que a vida pode ser usada e enriquecida. Sem o brinquedo, a criança é incapaz de ver criativamente o mundo, e, em consequência disso, é arrojada de volta à submissão e a um senso de futilidade, ou à exploração de satisfações instintuais diretas.

É especialmente na administração da agressão e da destrutividade que o brinquedo possui uma função vital, quando a criança tem a capacidade de fruir a manipulação de símbolos. No brinquedo, um objeto pode ser:

- destruído e restaurado;
- ferido e reparado;
- sujo e limpo;
- morto e trazido de volta à vida,

com a conquista adicional da ambivalência, em lugar da cisão do objeto (e do *self*) em bom e mau.

VII

Desenvolvimento da capacidade de brincar (socialização)

Do brincar provém

- a. brincar juntamente com outros, com ganhos no exercício de;
- b. brincar de acordo com regras: da própria criança, de outros, regulamentos partilhados;
- c. brincar jogos com regras e regulamentos previamente acordados;
- d. permitir complexidades em termos de líder e liderados.

VIII

Psicopatologia do brinquedo

A. *A perda da capacidade* associada com falta de confiança, ansiedade associada com insegurança.

B. *Estereotipia* nos padrões do brincar (ansiedade com referência à fantasia livre).

C. *Fuga para o devaneio* (um estado manipulado, situado a meio caminho entre o sonho verdadeiro e o brinquedo).

D. *Sensualização* — o instinto a aparecer em forma grosseira, juntamente com o fracasso da simbolização.

E. *Dominação* — uma criança que só é capaz de brincar o seu próprio jogo, mas que envolve outras crianças que têm de submeter-se a ela.

F. *Fracasso em jogar um jogo* (crianças inquietas, privadas), a menos que este seja dominado por regras estritas e um encarregado de jogos.

G. *Fuga ao exercício físico*, desde a ginástica calistênica até uma necessidade de ser exercido, se se quer evitar a inércia.

IX

Relação com a masturbação na adolescência

Nesta fase etária, pode haver uma linha muito fina entre a masturbação física com fantasia inconsciente e a atuação compulsiva da fantasia masturbatória como parte de uma tentativa (em grande parte inconsciente) de enfrentar o conflito e a culpa a respeito da masturbação real.

X

A caminho da adolescência

O brinquedo ajuda durante esta fase de sexo indeterminado porque, na representação e no fantasiar-se, há um campo infinito de ação para as identificações cruzadas — travestismo legítimo.

Também — expresso em tipos de caráter
garota masculinizada (menina)
tipo maternal ou adoração de herói (menino)
paixonite (por alguém)
envolvimento homossexual

XI

Início da adolescência

As tensões instintuais tornam-se intensas, de maneira que a capacidade de brincar pode ser perdida e a masturbação compulsiva (especialmente em rapazes) pode substituí-la.

Especialmente nesta fase, há uma tendência à atuação compulsiva da fantasia masturbatória de deslocar o brinquedo.

Na cultura da escola pública inglesa, os jogos são tipicamente explorados para distrair os rapazes dos conflitos que surgem das tensões sexuais e da compulsão à masturbação. Com as moças, este artifício não é tão bem-sucedido, de vez que funciona apenas com garotas que se identificam com os indivíduos do sexo masculino. As que se identificam com mulheres são relativamente mal-servidas na provisão social, e passam por períodos de intensa depressão (aos quatorze anos, digamos), talvez geralmente competindo sem sucesso contra as jovens que buscam uma carreira e parecem ser geralmente aceitas e exitosas.

No caso dos rapazes, que são maternos na qualidade de suas identificações típicas, há um considerável sofrimento a se esperar nos lugares em que a cultura local espera que bastem jogos e façanhas, ao invés de uma vida pessoal. Os que protestam são fracassos clínicos nesta idade e têm de lutar para conquistar reconhecimento social; para compensar, reúnem-se em grupos que os isolam da sociedade.

XII

Adolescência

A característica do brinquedo na adolescência é o fato de que os "objetos de brinquedo" são assuntos mundiais.

1. "Brincam" com a política mundial, sentem-na intensamente, e envergonham os adultos por realmente se preocuparem, ou
2. "brincam" de pais e mães no sentido de terem casos amorosos e talvez casar e ter filhos, ou
3. "brincam" com a construção imaginativa, tornando-se ou aprendendo a se tornarem artistas, músicos, filósofos, arquitetos, entusiastas religiosos, etc., ou
4. "brincam" em jogos, tornando-se profissionais ou competindo por campeonatos mundiais, ou
5. "brincam" de guerra, por irem a ela e lutarem, ou por fazerem coisas que os envolvem em risco real. Se delinqüentes, "brincam" de ladrões sendo ladrões, ou
6. não conseguem brincar, havendo perdido essa capacidade, de maneira que são lançados de volta à
 - i. paralisia (introversão ou um não-viver esquizóide), a incluir a cama, as drogas, surtos de mania ou impulsos suicidas
 - ii. exploração do instinto e atividade de fantasia livre (na melhor das hipóteses, uma vida extrovertida).

13

Psiconeurose na Infância

*Trabalho apresentado ao Congresso Ortopsiquiátrico
Escandinavo, em Helsinque, 8 de setembro de 1961*

Originalmente, o título de minha palestra foi anunciado como sendo *A Criança Neurótica*. Acharmos, entretanto, que estas palavras, na língua inglesa pelo menos, constituem uma terminologia popular, antes que diagnóstica. Na realidade, com frequência se descobre no tratamento analítico que crianças ditas neuróticas são em parte psicóticas. Um elemento psicótico se acha oculto na criança neurótica e pode ser este o elemento que tem de ser atingido e tratado, se se quer que o estado clínico da criança seja corrigido.

A fim de tornar um pouco mais fácil minha tarefa, decidimos alterar o título para “Psiconeurose na Infância”. Desta maneira, estou tentando fornecer-lhes um enunciado de algo que é diferente da psicose. Permanece uma dificuldade, contudo, no fato de haver duas maneiras possíveis de lidar mesmo com este título simplificado. Devo falar a respeito das origens da psiconeurose, origens que sempre se encontram na infância do indivíduo em estudo, ou sobre o estado clínico de crianças que são elas próprias, na ocasião, durante a infância, psiconeuróticas? Acho que não tentarei ser cuidadoso demais a respeito deste dilema.

Acho-me, portanto, descrevendo a psiconeurose e distinguindo-a de outros estados psiquiátricos. Naturalmente, em psiquiatria não existem fronteiras claras entre estados clínicos, mas a fim de chegar a algum lugar, temos de fingir que existem. A alternativa principal à psiconeurose é a psicose. Digamos que, na psicose, há um transtorno que envolve a estrutura da personalidade. Pode-se mostrar que o paciente se acha desintegrado, ou irreal, ou fora de contato com o seu próprio corpo ou com aquilo que nós, como observadores, chamamos de realidade externa. Os problemas do psicótico são desta ordem. Em comparação na psiconeurose, o paciente existe como pessoa, é uma pessoa total, que reconhece objetos como totais; acha-se bem-aquiloado em seu próprio corpo e a capacidade de relacionamentos objetivos está bem-establishada. Desde este ponto de vista, o paciente encontra-se em dificuldades, e estas surgem dos conflitos que resultam da experiência dos relacionamentos objetivos. Naturalmente, os conflitos mais graves aparecem em conexão com a vida instintual, isto é, as variadas excitações com acompanhamentos corporais que têm como fonte a capacidade que o corpo possui de ficar excitado — de modo geral e localizado.

Temos aqui então dois conjuntos de crianças, aquelas cujos estágios mais iniciais de desenvolvimento foram satisfatórios e que tiveram problemas a que damos o nome de psiconeuróticos, e aquelas cujos estágios mais iniciais de desenvolvimento são incompletos e esta qualidade domina o quadro clínico. Assim, o importante a respeito da psicose é que ela constitui um transtorno daquelas crianças que são suficientemente sadias para não serem psicóticas.

Naturalmente, esta divisão de estados clínicos em dois é simples demais. Há três complicações que tenho de mencionar, para que vocês fiquem satisfeitos com o que estou dizendo.

1. Em algum lugar entre a psicose e a psicose entra a depressão. Nesta, a estrutura da personalidade é relativamente bem-estabelecida. Podemos lidar com esta complicação dizendo que há depressões que são bastante psicóticas, com coisas tais como estados de despersonalização fazendo parte do quadro, e que há depressões que são praticamente psicose. Em qualquer dos casos, o paciente se encontra em dificuldades com as idéias e impulsos destrutivos que acompanham a experiência dos relacionamentos objetais. Com isto, quero dizer a experiência de relacionamentos objetais que possuem excitações neles mesmos, ou seja, que são mais vitais e intensos do que sentimentos que podem ser descritos por palavras tais como afetuosos, e que incluem clímax ou orgasmo.

2. A segunda complicação provém do fato de que, em alguns pacientes, há uma expectativa persecutória, e esta pode datar até mesmo da primeiríssima infância.

3. A terceira complicação tem a ver com o estado a que às vezes nos referimos pela palavra "psicopatia". Quero dizer, crianças com uma tendência anti-social merecem uma classificação toda sua, porque elas podem ser, essencialmente, normais ou psiconeuróticas ou depressivas ou psicóticas. O fato é que se tem de pensar em sua sintomatologia em termos de valor de dano. A tendência anti-social representa o SOS ou o *cri de coeur* da criança que, em um estágio ou outro foi privada, privada da provisão ambiental que seria apropriada na idade em que lhe faltou. A privação alterou a vida da criança; causou-lhe aflição intolerável e a criança está com a razão em reclamar o reconhecimento do fato de que "as coisas estavam bem e, depois, não ficaram bem" e de que isto constituiu um fator externo, fora do controle da criança.

Uma criança desse tipo acha-se engajada em retornar, através da privação e da aflição intolerável, ao estado que existia antes da privação, quando as coisas não eram muito ruins. Não podemos classificar este estado, que pode conduzir à delinquência ou à reincidência, junto com os outros estados que etiquetamos com as palavras psicose, depressão e psicose.

Concordarão, espero eu, que primeiro tenho de estabelecer o mapa psiquiátrico desta maneira, de forma a que possa perseguir minha tese de que a psicose é um estado de crianças (ou adultos) que, em seu desenvolvimento emocional, chegaram a um estado de relativa saúde mental. Havendo sido trazidos através dos estágios mais iniciais que pertencem à dependência extrema, e chegando aos estágios bem mais posteriores em que a privação traumatiza, estes indivíduos acham-se agora em posição de terem *suas próprias dificuldades*. Estas pertencem essencialmente à vida e aos relacionamentos interpessoais, e, de modo geral, as pessoas não se ressentem com estas dificuldades, porque elas são suas próprias, isto é, não são resultado de fracassos ambientais ou de negligência.

Encarada desta maneira, a psicose assume uma determinada forma e pode ser descrita com considerável clareza. Eu diria que *O Ego e os Mecanismos de Defesa*, de Anna Freud, fornece um bom retrato da psicose, e provavelmente todos vocês conhecem esse livro¹.

1. London, Hogarth Press, 1937.

Podem estar imaginando em que idades estou pensando quando falo das origens da psicose e da psiconeurose. Com referência à psicose, penso na primeiríssima infância como sendo o estágio de dependência extrema, quando mal faz sentido, em psicologia, falar em um bebê, porque a presença e a atitude da mãe são parte vital do que poderia ser chamado de potencial infantil em processo de tornar-se um bebê.

Penso na primeira infância mais tardia, enquanto a dependência está se tornando menos séria, quando me refiro às origens das ansiedades depressivas. Penso no período (que vai aproximadamente de dez meses a dois a três anos) quando me refiro à idade na qual a privação leva ao estabelecimento de uma tendência anti-social, e aqui estou de acordo com John Bowlby, cuja obra todos vocês conhecem. Então, quando chego ao lugar em que a psiconeurose aparece, estou-me referindo à idade em que a criança começa a dar os primeiros passos, à época em que a criancinha da família está elaborando a explosão plena do complexo edípiano, isto é, se ele ou ela forem sadios o bastante para chegarem lá.

Mas não quero que vocês me prendam de maneira demasiadamente exata e estas idades. Estamos falando mais de estágios do que de idades. Os estágios da primeira infância e da dependência reaparecem, e assim o fazem todos os estágios posteriores, de maneira que não há idade que corresponda exatamente a um estágio, e, na puberdade, muita coisa tem de ser reencenada, se é que se quer que o menino ou a menina conduzam o desenvolvimento inicial pela vida adulta adentro.

Encontramo-nos, então, na idade dos 3-4-5 anos. O menino ou a menina desenvolveram-se bem e, no brinquedo ou no sonho, são capazes de identificação com qualquer dos pais, e, juntamente com o brinquedo e o sonho, há a vida instintual e as excitações corporais. Tomamos por certo um desenvolvimento satisfatório do uso dos símbolos. Grande parte da vida da criança permanece sendo inconsciente, mas à medida que ela se torna mais e mais consciente de si, a distinção entre o que é consciente e o que é inconsciente se torna mais nítida. A vida inconsciente, ou a realidade psíquica da criança, aparece principalmente através da representação simbólica.

Temos agora de fazer um enunciado geral a respeito das crianças da idade em que começam a caminhar e iremos nos referir a crianças que moram em casa, em bons lares.

Entendam que esta é a idade em que, na saúde, a psiconeurose está se estabelecendo e formando o seu padrão. Se analisarmos pacientes de qualquer idade, encontraremos as origens da psiconeurose neste período 2-3-4-5 anos. O que acontece, contudo, se olharmos diretamente para a própria criança que começa a caminhar?

Devemos dizer claramente que essa criança, quando sadia, tem todo tipo possível de sintoma psiconeurótico. (Tomemos como exemplo um menino, para que não tenha de continuar dizendo ele ou ela.) Ele é vital e fisicamente ativo, mas também fica branco e flácido, de um jeito que a mãe pensa que a vida dele se foi. Ele é bondoso e doce, e também cruel com o gato, e, aos insetos, deve assemelhar-se ao pior dos torturadores do mundo. É afetuoso mas também machuca, chuta a barriga da mãe se esta parece estar ficando grande, diz ao pai para ir embora, ou, talvez, se una com este e despreze as mulheres. Tem acessos de manha, que podem ser embaraçosos quando se está na rua principal da cidade; tem pesadelos e, quando a mãe chega para consolá-lo, diz-lhe: — Vá-se embora, sua bruxa; eu quero a minha mãe. Tem medo disto ou daquilo, embora seja muito bravo ou bravo demais. Fica altamente desconfiado de uma comida que tenha um fio de cabelo nela, ou que seja da cor errada ou que não tenha sido cozinhada pela mãe, ou, então, talvez recuse a comida em casa e coma vorazmente na casa da tia ou da avó.

É bastante provável que existam todos os tipos de pessoas ou animais imaginários no corredor do apartamento, ou que haja crianças imaginárias para quem se tem de pôr a mesa, na hora do jantar. É mais fácil aceitar estes delírios do que tentar buscar a sanidade.

De vez em quando a criança diz que te ama ou faz um gesto espontâneo que indica a mesma coisa. Uma mistura de tudo.

Neste estágio de desenvolvimento, a criança se acha em processo de elaborar um relacionamento entre o potencial onírico ou a vida imaginativa total com a confiabilidade ambiental acessível. Exemplificando, se o pai achar-se lá ao desjejum (refiro-me à Inglaterra), então é seguro sonhar que ele foi atropelado ou ter um sonho em que, sob forma simbólica, o ladrão atira no marido da senhora rica, a fim de apoderar-se da coisa de jóias dela. Se o pai não estiver presente, um sonho desse tipo é assustador demais e conduz a um sentimento de culpa e a um humor deprimido. E assim por diante.

Tenho agora de tentar enunciar o que está acontecendo.

Mesmo no meio ambiente mais satisfatório possível, a criança tem impulsos, idéias e sonhos em que há um conflito intolerável: conflito entre amor e ódio, entre o desejo de preservar e o desejo de destruir e, de maneira mais sofisticada, entre as posições heterossexual e homossexual na identificação com os pais. Tais ansiedades são de se esperar; fazem parte da história e implicam em estar viva a criança.

Esta, contudo, acha intolerável certos aspectos das ansiedades e, dessa maneira, começa a estabelecer defesas. Estas defesas se organizam e, então, falamos de psiconeurose. A psiconeurose é a organização de defesas contra uma ansiedade do tipo que estou descrevendo.

Naturalmente, a criança pode regredir à dependência infantil e a padrões infantis, pode perder as qualidades fálicas e genitais que se tornaram uma característica, na fantasia e no brinquedo, que combina com a excitação, e pode retornar a uma existência oral ou de trato alimentar, ou até mesmo a uma perda das primeiras conquistas da integração e de ter uma capacidade para relacionamentos objetivos; pode até mesmo perder um pouco do contato estreito que se desenvolveu entre sua psique e seu corpo. Então, não falaríamos aqui de psiconeurose.

Atendo-nos estritamente ao nosso assunto, dizemos que, na psiconeurose, a criança não perde nada do desenvolvimento integrador inicial, mas defende-se contra a ansiedade de diversas maneiras, maneiras que a Srta. Freud descreve com clareza no livro a que já me referi.

Primeiro, temos a repressão: um tipo especial de inconsciente se desenvolve, o inconsciente reprimido. Grande parte da vida da criança que começa a caminhar cai sob a repressão e torna-se inconsciente. O inconsciente reprimido é, naturalmente, um inconveniente, porque a repressão é cara em termos de energia, e, também, aquilo que é reprimido está sempre sujeito a aparecer sob uma forma ou outra, num sonho, ou, talvez, projetado sobre fenômenos externos. Apesar disso, o lucro tem de ser medido em termos da diminuição da suscetibilidade da criança à ansiedade manifesta ou clínica. Um aspecto especial da repressão é a inibição do impulso, uma perda de um pouco da pulsão instintual no relacionamento com objetos. Isto equivale a um sério empobrecimento da experiência de vida da criança.

Em segundo, a fantasia reprimida pode aparecer e criar problemas sob a forma de transtorno psicossomático, os ditos sintomas de conversão, cujo conteúdo de fantasia se perdeu; ou de ansiedades hipocondríacas a respeito de partes do corpo ou da alma, e não existe solução para tal sintomatologia, exceto pela recuperação do conteúdo de fantasia perdido².

2. Ocorre-me que possa estar usando a palavra "fantasia" de uma maneira que não é familiar a alguns de vocês. Não estou falando sobre o fantasiar, ou sobre a fantasia imaginada, mas sim pensando na totalidade da realidade psíquica ou pessoal da criança, certa parte dela consciente, mas a maior parte, inconsciente, e, ainda, incluindo aquilo que não é verbalizado, imaginado ou ouvido de maneira estrutural, por ser primitivo e próximo das raízes quase fisiológicas das quais brota. — D.W.W.

Em terceiro, tornam-se organizadas certas fobias, tais como, por exemplo, medo de lobos, ou de ratos, se estes se acharem mais próximos de casa. Uma fobia desse tipo pode muito bem resguardar uma criança contra a rivalidade entre irmãos, por exemplo, e o medo dos irmãos odiados.

Em quarto, pode-se organizar uma tendência obsessiva para lidar com a confusão e impedir a volta perigosa do impulso destrutivo. No perfeccionismo, lida-se antecipadamente com um ódio do mundo que o viraria de cabeça para baixo. Trata-se de um substituto pobre para a seqüência de saúde — (1) impulso e idéia destrutiva, (2) senso de culpa, (3) reparação ou atividade construtiva — mas para o neurótico, tem de servir.

Poderão acrescentar a esta relação vários outros tipos de formação psiconeurótica de padrões. Em todos os casos, o padrão das defesas é contra a ansiedade no nível de complexo edipiano, e determinada, até certo ponto, pelo caráter do meio ambiente, mas a pulsão à formação psiconeurótica de sintomas provém dos conflitos essenciais, existentes no indivíduo, entre amor e ódio, conflitos esses que indicam um desenvolvimento emocional sadio no sentido da estruturação e fortaleza do ego, e também indicam um fracasso do ego em tolerar as conseqüências das tensões instintivas ou do id.

E a defesa principal é a repressão. Esta é a razão pela qual a psicanálise, em sua forma clássica, é um tratamento que lida com pacientes que têm o ego sadio até o ponto em que lidaram com a ambivalência por meio da repressão e sem um rompimento da estrutura do ego, e o trabalho principal da análise do paciente com sintomas psiconeuróticos consiste em trazer à consciência o inconsciente reprimido. Isto é feito mediante a interpretação, dia a dia, do relacionamento do paciente com o analista, à medida que este relacionamento gradativamente evolui, e, ao evoluir revela o padrão da própria história do paciente no nível do complexo edipiano e na idade de 2-3-4 anos.

Que papel desempenha o meio ambiente nestas questões? Já indiquei a parte vital que ele desempenha no começo, no estágio da dependência muito grande. Referi-me ao período especial durante o qual a criança pequena pode facilmente ser transformada em uma criança carente, e por diversas maneiras demonstrei, espero eu, que, no estágio do complexo edipiano, é *imensamente valioso* que a criança possa seguir vivendo em um ambiente assentado de lar, de maneira que seja seguro brincar e sonhar, e que o impulso a ser amoroso possa ser transformado em um gesto efetivo, no momento apropriado.

O meio ambiente é algo que tomamos como evidente. Uma criança que se ache em uma instituição tem uma tarefa diferente neste estágio, o estágio dos primeiros relacionamentos triangulares, que a da criança que está morando em seu próprio lar, com seus próprios pais e irmãos. O lar bom também absorve muitas dificuldades que só se tornam muito aparentes quando o lar se rompe ou é perturbado pela doença, especialmente anormalidades psiquiátricas nos pais. Apesar disso, se eu me ativer estritamente ao meu argumento, que é o estudo da psicose, ser-me-á necessário enfatizar que é apenas aqui e exatamente aqui que estamos lidando com as tensões e estresses *internos*, os conflitos, principalmente inconscientes e pertencentes aos domínios da realidade psíquica pessoal do indivíduo.

O paciente, que sofre de psicose, quer uma ajuda pessoal do tipo que torne possível a diminuição das forças da repressão e a liberação da energia pessoal para o impulso não-premeditado.

A enfermidade psiconeurótica pode ser medida de acordo com a rigidez das defesas, defesas contra a ansiedade que pertence à experiência real e imaginária dos relacionamentos triangulares, tal como se dão entre pessoas totais.

Verão que o meio ambiente ingressa no quadro da psicose, em parte por determinar a natureza do padrão de defesa. A psicose, contudo, não encontra a sua etiologia na condição ambiental, mas nos conflitos pessoais que pertencem espe-

cificamente ao indivíduo. Em contraste, a criança anti-social é muito claramente anti-social em resultado de uma privação. Também, para nossa surpresa, descobrimos que na etiologia do mais grave transtorno psiquiátrico, a esquizofrenia, um fracasso do cuidado na fase mais inicial de dependência absoluta da primeira infância é ainda mais importante que o fator hereditário.

Na prática, esta visão da psicose é tornada obscura pelo fato de nós não encontrarmos comumente pacientes que sejam, por assim dizer, casos psicose "puros". Ademais, como Melanie Klein nos mostrou³, a origem do fracasso da criança em evitar organizações psicose de defesa reside em fracassos desenvolvimentais em estágios anteriores. Mas isto não nos deve deixar confusos. Temos de falar como se as enfermidades fossem quer psicose, quer transtornos afetivos, quer psicose, quer a tendência anti-social, a fim de nos poder situar.

Surge a questão: o que é normalidade? Bem, podemos dizer que, na saúde, o indivíduo foi capaz de organizar suas defesas contra os conflitos intoleráveis da realidade psíquica pessoal, mas em contraste com a pessoa doente de psicose, a pessoa sadia é relativamente livre da repressão maciça e da inibição do instinto. Na saúde, também, o indivíduo pode empregar todo tipo de defesas, e mudar de uma para outra, e, na realidade, não apresenta aquela rigidez de organização defensiva que caracteriza a pessoa enferma.

Havendo dito tudo isto, quero sugerir que, clinicamente, o indivíduo realmente sadio está mais próximo da depressão e da loucura que da psicose. A psicose é entediante. É um alívio concedido por um senso de humor, e conseguir, por assim dizer, flertar com as psicose. Através da arte moderna, experienciamos a anulação dos processos que constituem a sanidade e as organizações defensivas psicose, e o princípio da segurança em primeiro lugar.

Permitam-se acrescentar uma das palavras a respeito do vasto assunto da adolescência. No período da adolescência, a puberdade ameaça e, depois, desenvolve-se e domina a cena. Uma descrição do adolescente seria bastante semelhante à da criança de 2-3-4-5 anos, ou seja, uma coleção de tendências autocontraditórias. Por causa do amadurecimento gradativo dos instintos, o adolescente encontra-se, durante alguns anos, em um estado de *não aceitar soluções falsas*. Isto ocasiona a nossa dificuldade em lidar com adolescentes, ou seja, o fato que temos de tolerar a recusa deles e encontrar uma saída para a dúvida e para o dilema. A única solução para a adolescência é o amadurecimento que o tempo trará, à medida que ela se transforma em estado adulto.

Dessa maneira, a psicose ingressa no quadro da adolescência como uma ameaça de falsas soluções, falsas soluções que provêm de dentro do indivíduo, inibições, rituais obsessivos, fobias e sintomas de conversão, defesas contra a ansiedade associadas com a vida instintual que agora ameaça por uma maneira nova. Faz parte do problema mundial da adolescência atualmente que tenhamos de assistir cada criança a defender intrepidamente o seu direito de *não encontrar uma solução falsa*, quer na psicose, quer através da aceitação dos vários tipos de auxílio que desamparadamente oferecemos.

A psicose que persiste na vida adulta é claramente vista e sentida como um inconveniente e uma anormalidade, e a única coisa que preciso dizer aqui a respeito da psicose adulta é que a sua etiologia pertence ao período da infância do indivíduo que vai dos dois aos cinco anos, ao período do primeiro estabelecimento de relacionamentos interpessoais, e ao desenvolvimento, na criança, de uma capacidade de efetuar uma identificação com os pais nas vidas instintuais destes.

3. *The Oedipus Complex in the Light of Early Anxieties* (1945), em Melanie Klein, *Contributions to Psycho-Analysis, 1921-1945* (London, Hogarth Press, 1948).

Observações Adicionais Sobre a Teoria do Relacionamento Parento-Filial

Parte de um debate de artigos da autoria de Phyllis Greenacre e Winnicott, realizado no XXII Congresso Psicanalítico Internacional, em Edimburgo, 1961¹

Aguardei com excitação o debate destes dois artigos e do vasto tema que eles introduzem. Naturalmente, é importante para mim que haja um certo grau de concordância entre a Dra. Greenacre e eu. Exemplificando, ambos presumimos os processos maturacionais inatos do bebê e vêmo-los em um *setting* de dependência. Não irei mais adiante, de momento, na contribuição da Dra. Greenacre. Ela desenvolveu de maneira muito interessante o tema dos processos de amadurecimento, e, deste assunto imenso, escolhi tratar o tema da dependência.

Com referência à minha própria contribuição, interessa-me que este tema não seja psicanálise, mas sim "psicanalistas debatendo algo que é muito importante para eles". Quando estamos vendo mães e bebês em uma clínica infantil pública, alguns dos bebês que vemos já são doentes no sentido de que, quando crescerem, não serão aceitos para tratamento por uma psicanálise clássica. Eles podem ser, naturalmente, fisicamente muito saudáveis. Tal como o estou colocando de minha maneira limitada, talvez o problema, seja: é o bebê um fenômeno que possa ser isolado, pelo menos hipoteticamente, para observação e conceptualização? E estou sugerindo que a resposta é não. Quando voltamos o olhar para as nossas análises de crianças e adultos tendemos a ver mecanismos, antes que bebês. Mas se olharmos para um bebê, vemos um bebê que está sendo cuidado. Os processos de integração, de separação, de conseguir viver no corpo e de relacionar-se com objetos, são, todos eles, questões de amadurecimento e realização. Inversamente, o estado de não ser separado, de não ser integrado, de não estar relacionado a funções corporais, de não se achar relacionado ao objetos, este estado é muito real; temos de acreditar nestes estados que pertencem à imaturidade. O problema é: como o bebê sobrevive a tais condições?

1. Os dois artigos debatidos na conferência podem ser encontrados no *International Journal of Psycho-Analysis*, 41 (1960). O artigo de Winnicott também aparece sob o título *A Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil* em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (London, Hogarth Press; New York, International Universities Press, 1965; POA, Artes Médicas, 1983). O debate do qual estas observações são extraídas contém comentários da autoria de Greenacre e muitos outros analistas e termina por uma resposta de Winnicott não-publicada aqui, mas que pode ser encontrada no *International Journal of Psycho-Analysis*, 43 (1962).

Ao preparar este trabalho, descobri haver alcançado uma compreensão mais profunda da que havia tido antes da função dos pais em termos deste problema, da maneira pela qual os bebês sobrevivem à imaturidade. Vi com mais clareza do que antes que, ao introduzir o mundo à criança em pequenas doses, isto é, na adaptação dela às necessidades de ego de seu bebê, a mãe concede tempo para o desenvolvimento das ampliações dos poderes do bebê que chegam com o amadurecimento. Em um debate como este, em que o estado de dependência do bebê deve receber lugar importante, precisamos em verdade entrar em acordo com o paradoxal. Exemplificando, o bebê sabe apenas como admitir, ou não-admitir, a união dos pais que produziu sua própria concepção. Ele a princípio não sabe como deixar que a relação sexual dos pais preceda a sua existência. Mas seu esquema corporal acaba por vir a incluir tudo. Em um meio ambiente suficientemente bom, o bebê gradualmente começa a descobrir maneiras de incluir objetos não-eu e fenômenos não-eu em seu próprio esquema corporal e, portanto, de evitar ferimentos narcísicos. Se um crescimento constante é facilitado, então a onipotência e a onisciência são retidas, *juntamente com* uma aceitação intelectual do princípio de realidade. Em um enunciado psicanalítico teórico, dizemos que se formam defesas em relação à ansiedade. Observando um bebê vivo, dizemos que ele experiencia uma ansiedade intolerável, com recuperação através da organização de defesas. Disto decorre que o desfecho bem-sucedido de uma análise depende não da compreensão, pelo paciente, do significado das defesas, mas sim de sua capacidade, através da análise e na transferência, de *reexperienciar esta ansiedade intolerável* em função da qual as defesas foram organizadas.

Num caso dito limítrofe, tem-se de descobrir não apenas a ansiedade intolerável, mas também o colapso clínico real da primeira infância, o superestiramento da onipotência, o aniquilamento que constituiu a ferida narcísica. Tudo isto fornece, para mim, um colorido vívido ao nosso quadro do relacionamento parento-filial e à nossa visão do cuidado real de um bebê. A palavra "amor" não é suficientemente específica. E a palavra "separação" é imperfeita para o nosso uso. Todo o tempo, de acordo com a idade e o estágio de amadurecimento do bebê, o progenitor (a) acha-se empenhado em impedir o colapso clínico, do qual a recuperação só ocorre através da organização e reorganização de defesas. É pelo cuidado minuto a minuto que o progenitor (a) assenta a base da futura saúde mental do bebê, e esta é a tremenda tarefa dos pais. Seu porte se reflete na extensão de um tratamento psicanalítico e na duração da doença mental, mesmo quando o paciente recebe o melhor cuidado mental possível. E, de modo geral, os pais sempre tenderam a alcançar êxito nisso, em sua tarefa essencial e tremenda, sendo que a razão para esse propósito, é que eles precisam ser eles próprios, e ser e fazer exatamente o que gostam de ser e fazer. Só por fazê-lo, poupam os filhos de espasmódicas reorganizações de defesas e da aflição clínica subjacente de cada uma dessas reorganizações.

Na psicanálise do caso bem-escolhido para análise clássica, a aflição clínica surge sob a forma de ansiedade, associada com lembranças, sonhos e fantasias. Como analistas, porém, nos envolvemos no tratamento de pacientes cujos *colapsos clínicos reais da primeira infância* têm de ser lembrados através de sua revivência na transferência. Em todos os casos, o alívio só chega mediante um reviver da ansiedade intolerável original ou do colapso mental original. O colapso acha-se associado a um fator ambiental que, na época, não pôde ser trazido para a área da onipotência do bebê, tal como me exprimi. O bebê não conhece qualquer fator externo, bom ou mau, e sofre uma ameaça de aniquilamento. Num tratamento bem-sucedido, o paciente se torna capaz de pôr em cena o trauma ou o fracasso ambiental e experienciá-lo dentro da área da onipotência pessoal, e, dessa maneira, com um ferimento narcísico menor. É assim que, como analistas, repetidamente nos tornamos envolvidos no papel do fracasso e não nos é fácil aceitar este papel, a menos que vejamos o seu valor positivo.

Somos transformados em pais que fracassam e somente desse modo alcançamos sucesso como terapeutas. Este é apenas mais um exemplo do paradoxo múltiplo do relacionamento parento-filial.

Gosto de lembrar a mim mesmo que quando os filhos dos pacientes estão enfermos e as coisas não estão indo bem, podemos dizer a eles como comportar-se feito terapeutas. Em comparação, porém, não podemos dizer aos pais como comportar-se como pais se tudo vai bem. Se tudo vai bem, isso apenas acontece. O que podemos fazer então é estudar o que está acontecendo e avaliar de modo apropriado esta função dos pais, de maneira a reconhecê-la e apoiá-la, e ver que com ela não se interfira, quando existe.

Pensei que não faria um resumo de meu artigo, mas apenas este comentário e o deixaria como está.

15

Uma Nota sobre Um Caso Envolvendo Inveja

Datado de janeiro de 1963

Este paciente já tem cerca de três anos de análise comigo, após três tratamentos anteriores com outros terapeutas, o último dos quais durou cerca de 25 anos. O fim do tratamento acha-se à vista, embora uma data ainda não tenha sido marcada.

O paciente deitou-se no divã, como de costume, e disse: — Bem, aqui temos um dia em que não sei o que vai acontecer. A sessão do dia anterior fora importante, por ter sido uma hora sem sentimentos. O paciente prosseguiu então descrevendo com considerável sentimento o comportamento de um colega que com frequência aparece no material apresentado. A este colega, darei o nome de Dr. X e acontece ser ele um pediatra que odeia a psicologia. O paciente descreveu, com exatidão até onde sei, como o Dr. X é arrogante, satisfeito consigo mesmo, vaidoso, autoconfiante, autoritário, etc. — Eu o invejo, disse, ficando bastante surpreso a respeito disto, porque a ele próprio, como já afirmou, falta confiança em si mesmo e é discreto e sensível.

Após haver gasto alguns minutos expressando seus sentimentos a respeito do homem citado, interpretei-lhe que estava usando o Dr. X para expressar sentimentos a meu respeito. Apesar de possuir um *insight* muito considerável neste estágio de sua análise, o paciente não se dera conta disso, mas contudo, sentiu que eu estava fazendo a interpretação correta. Gastou diversos minutos contando-me quão satisfeito se achava por não mais estar fazendo a sua própria análise, por poder deixar isso para mim. Isto apenas recentemente havia se tornado possível. Recordou-me o fato de que apenas há pouco tempo atrás chegara à posição de ficar contente por descobrir que sou mais que uma projeção de suas próprias capacidades.

Interpretei ainda o ódio que sentia por mim, por ser a pessoa a quem havia emprestado toda a sua própria auto-segurança e compreensão. No curso de reagir à minha interpretação, em que reiterou seu sentimento de alívio por poder deixar a análise a mim, prosseguiu para tratar de seu ódio por mim, mas interrompendo isto, ocorreu o seguinte episódio. Disse ele, neste ponto: "Meu nariz ficou entupido e estou com uma dor na barriga, mas estou lutando com a idéia de ir até o meu sobretudo, a fim de pegar o vidro de efedrina". No sobretudo, ele tem também comprimidos para indigestão e outras coisas. A fim de tornar isto compreensível, é necessário relatar que, na sessão do dia anterior, estas coisas haviam sido mencionadas como fazendo parte de sua hipocondria, que se acha muitíssimo associada com sua identificação materna

intensamente desenvolvida. Isto, por sua vez, teve de ser liberado do delírio amplo que sempre teve de que é verdadeiramente mulher. O brincar de ser mulher da identificação feminina que é muito mais flexível surgira agora na análise e eu fizera a interpretação de que a sua hipocondria era a precursora da fantasia de fecundação.

Na presente sessão, tive de fazer uso da interrupção na qual ele se referiu a estas questões, o que nos levou de volta à sessão anterior. Minha interpretação foi de que, por falar, ele estava visando à sua destruição de mim como homem, mas no caminho, encontrara a sua hipocondria, que tem a ver com a possibilidade de ele estar apaixonado por mim como homem. Há muita história por trás de tudo isto. Também, na primeira parte da sessão, o paciente descrevera o seu próprio manejo da filha, no qual estava adotando um papel materno.

Continuei com a interpretação de que, em sua identificação feminina e em sua busca de um homem (que, em seu caso, jamais o levara a práticas homossexuais manifestas, mas conduziu-o para muito perto disso), ele evidentemente estivera em busca do homem que queria castrar.

Ele ficou interessado por esta interpretação, mas foi incapaz de senti-la em grande profundidade. Falamos a respeito do fator tempo na reação à interpretação, que tem de acompanhar aquela outra coisa que é o peneiramento das interpretações, que podem estar tanto certas quanto erradas. Arrisquei-me a repetir a interpretação em termos de seu pai. Disse-lhe que se ele descobrisse agora que seu pai fora forte e útil, ficaria tão satisfeito por descobrir isto que não gostaria da descoberta de este ser o pai que deseja castrar, porque é o pai potente no triângulo edipiano. Durante algum tempo o paciente achou que isto era algo intelectualmente bastante bom, mas inaceitável bem no fundo. Disse então que o que acontece com o Dr. X é que ele é arrogante, vaidoso e satisfeito consigo mesmo, e que o paciente realmente admira isso, embora seja exatamente aquilo de que não gosta nas pessoas. Elaboramos então juntos que fora necessário afirmar que o Dr. X havia sido trazido à baila para ajudar a idéia da potência do analista. O Dr. X era jovem e dava a impressão de ser potente, e o paciente temia que eu fosse velho, bem como bastante cansado e débil em potência, de maneira a precisar desse empurrão. A fim de chegar à inveja que sentia de mim tivera de transformar seu analista em um analista Dr. X. Estava agora evidente que ele admirava o analista Dr. X e aqui se encontrava a base para a identificação materna, a posição homossexual e a hipocondria que era uma fantasia potencial de gravidez.

Descobri então que minha interpretação anterior produzira no paciente toda uma série de idéias secundárias, às quais estava reagindo. Elas incluíam a noção de que teria de passar por uma fase homossexual em relação a mim, isto é, uma fase nova, que ignorava os exemplos anteriores disto na análise, e ele se achava completamente entediado com essa perspectiva. Descobri isto quando fiz a interpretação de que ele achava penoso sentir amor e à premência a castrar o analista Dr. X, com a ambivalência aqui sendo grosseira. Isto fez o paciente relatar sua idéia de que teria de ter uma fase de homossexualidade na transferência. Ele agora quase podia aceitar o fato de estar procurando um analista Dr. X potente, a fim de encontrar uma figura paterna para castração, e, ao fugir do conflito que disto resultaria, ficaria sujeito a organizar uma fase homossexual. Isto lançou uma luz considerável sobre o seu padrão de comportamento na adolescência e início da idade adulta, e grande parte do material de sua vida subsequente, na qual lutou para tornar-se heterossexual a fim de afastar-se do homossexualismo. (A desesperança a respeito de tudo isto conduziu à exploração mais plena possível de seu delírio fundamental de ser mulher, que parece ter tido raízes muito precoces em seu desenvolvimento emocional.) Desta maneira, a inveja que o paciente sentia de mim tinha muitos aspectos. Pertencia ao extremo prazer que derivara por finalmente entregar a análise a alguém que não ele próprio e obter as interpretações de que precisa, sem ter de dizer ao analista o que falar. A inveja

é também pertinente a haver ele alcançado, nos últimos meses, um reconhecimento de minha existência como pessoa separada, que pode usar para projeção de sua própria capacidade analítica, bem como de seu próprio funcionamento materno e paterno e de seus próprios poderes intelectuais. Em relação a tudo isto, ele me odeia por ser necessário e por ser, em sua opinião pessoal, a única pessoa de quem poderia ter feito uso desta maneira, chegando por fim à entrega de toda a responsabilidade a mim, como seu analista.

Para trazer sua inveja a pleno tom, ele teve de me dar o empurrão do Dr. X e, depois, houve a armadilha em que teria caído sem as interpretações apropriadas de evitar a castração ou o ódio pela exploração de uma área intermediária em que estava satisfeito por encontrar o analista potente e apaixonar-se por ele.

16

Perversões e Fantasia Pré-Genital

Artigo inacabado, redigido em 1963

O objetivo principal deste artigo é apontar o vínculo que parece existir entre a fantasia pré-genital de fecundação e as perversões.

Um estudante disse-me uma vez: "O conferencista Fulano de Tal torna chatas até as perversões". Isto me pareceu muito engraçado. A piada, tal como relatada, pode servir para introduzir um tópico que é, de certa maneira, enfadonho, pelo fato de trazer-nos ao debate questões cotidianas que, na realidade, envolvem a todos, e que é melhor deixar intocadas, exceto onde um interesse científico possa ser beneficiado por isso.

O postulado é que, enquanto que na maturidade genital há uma relação direta entre a potência e a fecundação, na imaturidade há inumeráveis fantasias que acabam por tornar-se uma idéia de fecundação; além disso, são estas fantasias pré-genitais que, na saúde, proporcionam a margem imaginativa que rodeia o fato contundente do bebê no útero.

Deste postulado surge a idéia de que, no indivíduo imaturo, pode haver uma persistência de fantasias pré-genitais de fecundação, que possuem uma qualidade sintomática e são exageradas por um bloqueio relativo no processo desenvolvimental. Elas são então, até certo ponto, substitutos da coisa real. Ademais, na homossexualidade masculina, estas fixações pré-genitais vêm a ser exploradas, porque elas são aquilo de mais próximo da gravidez que o indivíduo do sexo masculino pode chegar.

Até certo ponto, esta é uma idéia que já foi bem-enunciada na literatura técnica, mas pareceria existir lugar para um desenvolvimento ulterior do tema. Exemplificando, Klein apontou que, para a potência plena no indivíduo do sexo masculino — rapaz ou homem — nela deve achar-se incluída a pulsão de ansiedade que é claramente descrita no que ela chamou de "a posição depressiva no desenvolvimento emocional".

Do lado feminino, na medida em que as ansiedades hipocondríacas dominam o quadro, o interior do corpo, em oposição ao interior do útero, é o lugar onde se espera que o bebê cresça. O bebê uterino é um milagre e tranquiliza os pais que esperam um produto do mundo interno de objetos e forças em contenda, ou um bebê anal que tem de ser limpo e ensinado a ser humano e a comportar-se, ou um pedaço de barro inerte que tem de ser modelado com a língua, trazido à vida e mantido vivo. Desta maneira, passamos da normalidade à depressão em nossa descrição dos pais.

17

Duas Notas sobre o Uso do Silêncio

Redigido em 1963

I

Neste caso, não estou tomando notas, embora me dê conta de que a minha paciente um dia vai desejar que eu o tivesse feito. Fiz uma tentativa de manter notas nos primeiros estágios, mas descobri que isso interferia com a minha análise da paciente, por manter os detalhes superenfaturados na mente consciente. Desta maneira, a reação inconsciente ou menos consciente tornava-se distorcida.

Examinando as duas últimas semanas, sinto que uma descrição poderia ser valiosa para referência em uma data posterior e que o tipo de coisas que aconteceram ilustra o padrão desta análise. As reações da paciente também são menos violentas do que o eram em um estágio mais inicial, de maneira que posso agora até mesmo cometer erros, ou "bolhas" como eles são chamados neste tratamento, sem grande risco de que a paciente tenha uma reação realmente séria ou busque outro analista.

A base do tratamento, atualmente, é o meu silêncio. Em toda semana passada, fiquei absolutamente calado, à exceção de uma observação feita no início da semana. A paciente sente isso como algo que ela conquistou, fazer-me ficar silencioso. Há muitas línguas para descrever isto e uma delas é que uma interpretação é um pênis masculino irrompendo através do campo, com este sendo o seio com o bebê incapaz de lidar com a idéia de um pênis. O seio é aqui um campo, antes que um objeto de sugar e comer, e, nas associações da paciente, seria representado por uma almofada, antes que uma fonte de alimento ou gratificação instintual.

De todas as semanas, a semana passada foi talvez a mais bem-sucedida de todas e a paciente apreciou muito eu desempenhar esse papel, que ela equilibra com um estudo muito atento que está fazendo de Henry James. Neste, ela encontra um analista masculino que lida com palavras e possui uma compreensão muito particular e abrangente, mas é celibatário.

Esta semana quase perfeita terminou de modo estranho. Eu não tinha qualquer idéia da existência de algum problema, mas na segunda-feira, a paciente me relatou que o que eu havia feito ao final da sessão de sexta fora muito perturbador. Em consequência, todas as suas antigas defesas haviam retornado, em grau moderado, durante o fim de semana. Parece que quando ela se levantou para ir embora houve

um som como o de papel sendo roçado. Na segunda-feira, foi capaz de falar a respeito disto e da reação que tivera, mas não até haver achado maneiras de se queixar a meu respeito, que fossem menos delirantes. De meu ponto de vista, é inteiramente claro que o meu comportamento perfeito durante a semana é algo em que ela não pôde acreditar e que, ao final dela, teve um delírio de algum tipo que indicava que me acho extremamente impaciente em meu papel de não falar. Diz ela que, por fazer-me não falar, está-me transformando em uma mulher, castrando-me, tornando-me impotente, etc., e entende perfeitamente que eu não possa suportar isso, e concluiu que tenho ciúmes dela por haver-lhe dado o que ela precisa porque eu próprio nunca tive.

Em outro nível, o barulho significara-lhe que eu havia estado me masturbando, uma outra prova de minha incapacidade de ficar sem fazer nada. A única base de realidade para este delírio que fui capaz de descobrir seria que, ao final da sessão, às vezes ponho o meu lenço no bolso, se estive com ele na mão. Não estou certo, contudo, de que algo tenha acontecido que pudesse constituir uma base de realidade para o delírio, naquela ocasião.

Na segunda-feira, disse duas coisas, e disse-as não porque achei difícil ficar calado, mas porque achei que deviam ser ditas. Ela me pediu que eu a informasse do que pretendia fazer no verão e no próximo Natal, por causa de disposições que tinham de ser tomadas, e falou que achava que realmente queria uma resposta. Pretendi dizer: "Não me acho em posição de dar-lhe a resposta que pede", mas o que respondi, contudo, foi: "Você quer uma resposta aqui que não me encontro em posição de dar". Como o coloquei desta maneira, ela o tomou como se eu a houvesse repreendido, dizendo-lhe que não devia perguntar esse tipo de coisa. Então, mais uma vez fiz uma interpretação, quando ela disse pensar que poderia ser capaz de suportar um pouquinho de interpretação de minha parte. Referi-me a um sonho relatado por ela na semana anterior e apontei-lhe que um objeto grande e sólido em meio a material que tinha a ver com um rendilhado delicado representava a realidade de fato (ou externa) a irromper na fantasia. Esta é outra versão do pênis através do seio e de várias outras figuras de retórica semelhantes. O problema com esta interpretação é que eu estava apenas repetindo uma interpretação que ela própria havia feito. A paciente tinha agora duas "bolhas" que podia usar e, na terça-feira, sentiu que se achava na mesma posição em que estivera perto do início da análise, quando não retornou. Ela havia estudado de novo os meus artigos sobre *Mães Devotadas Comuns*, sublinhara as passagens relevantes e sabia que eu realmente compreendia o que ela precisava. "A única explicação possível", disse ela, "é que você não pode fazer o que sabe ser necessário e que toda a coisa é falsa. A razão (continuou) deve ser que você não pode suportar ser feminilizado, ou seja lá o que o silêncio significa para você". E já havia afirmado que, no presente, Henry James tinha todo o funcionamento masculino e o que ela precisava na análise era de uma maternagem absolutamente pura. Para atender a isto, fica extremamente regredida e dependente na sessão analítica, embora seja capaz de funcionar bem a maior parte do tempo em seu trabalho. Sua vida privada, neste estágio, está quase confinada a uma atividade muito grande em seu quarto, e isto inclui ler e estudar vorazmente Henry James e sua biografia.

Primeiramente, tenho de aceitar minha posição como sendo a de alguém que não diz nada. Isto foi extremamente difícil na manhã de terça-feira, não porque me importe ficar calado, mas porque podia ver o que estava acontecendo e não há nada mais difícil para um analista suportar do que a transferência delirante do paciente. O efeito disto sobre mim foi que fiquei com uma comichão na garganta, a qual, contudo, consegui esconder, e reconheci que se houvesse podido falar três palavras, a cegueira teria passado. Não poder falar tem um efeito curioso, pelo fato de exigir uma escuta que é diferente da minha maneira normal de escutar. Até certo ponto, sempre escuto com a garganta, e minha laringe acompanha os sons que escuto no mundo e, em

particular, a voz de quem está falando comigo. Estas sempre foram características minhas e, em certa época, constituiu um sintoma sério. Após meia hora, a paciente disse: "Agora me sinto inteiramente diferente, havendo dito aquilo tudo e posso suportar que você diga alguma coisa; na verdade, acho que preciso ouvi-lo". O alívio causado por isto foi grande e estava inteiramente claro para mim que ele não se devia ao fato de eu estar calado; na realidade, até gosto disso. A razão de ter sido um alívio para mim foi que pude então começar a fazer alguma coisa a respeito do delírio da paciente, mas naturalmente, não seria capaz de fazer muito. Neste tipo de análise, é essencial aceitar a respeito de si próprio certas idéias que não são verdadeiras.

A permissão para falar concedeu-me oportunidade para interpretar que o problema fora o que havia acontecido ao final da sessão de sexta-feira. Isto tinha muito pouca base em fatos e foi mais fácil para ela tomar as duas "bolhas" na segunda-feira e falar a respeito delas como destruindo a análise — sob outros aspectos boa — em que fico calado. Corri um risco e disse que a maneira pela qual havia expresso minha informação sobre as férias, de fato fizera parecer como se eu estivesse reprovando a paciente. Também não há muito sentido em fazer uma interpretação que já foi feita pelo paciente. Estas duas coisas tinham, portanto, uma base de realidade, quando comparadas com o que acontecera ao final de sexta-feira, que era tênue e quase inteiramente dependente das expectativas dela. Pela técnica do silêncio, eu poderia ter proporcionado condições em que a própria paciente teria solucionado o problema de sexta. Tudo o que ela precisava era tempo e oportunidade, sem o "pênis atravessando o campo do seio". Nessa ocasião, a paciente havia quase voltado a conseguir acreditar em meu silêncio como sendo algo que eu podia dar por causa da necessidade dela. Tem-se de enfatizar, contudo, que ela manteve uma intensa idéia delirante de que, na realidade, eu não podia suportar ficar calado, e acabou por fazer surgir uma interpretação de minha incapacidade de ficar em silêncio, a fim de ajudar-me. Era a de que, se eu faço algo bom para o paciente, fico com ciúmes dele, porque ninguém jamais fez isso por mim.

No decorrer de toda esta quinzena muitas coisas haviam acontecido e me acho muito confiante a respeito da técnica do silêncio, que estou muito disposto a empregar, exceto na medida em que a paciente não possa acreditar nela.

Acontece que sei, com um bom grau de certeza, uma interpretação que seria aplicável a toda esta fase. É necessário, porém, que eu espere que a paciente faça esta interpretação ela própria, como aconteceria se ela dissesse: "Com minha história de um pai excitável, constantemente interrompendo o que quer que houvesse de experiência mãe-bebê, é necessário que eu mesma possa chegar às interpretações". Naturalmente, é compatível com isto que haja momentos em que uma interpretação é necessária, devido ao fato de a paciente precisar de algo mais do que tem em si para perceber. Apesar disto, nesta fase a paciente é perfeitamente capaz de chegar à compreensão necessária e, na realidade, quase chegou a ela no decurso da semana passada. Farei uma tentativa de enunciar esta interpretação:

A paciente se encontra em um ponto muito delicado de transição de comer e ser comida, com a última sendo uma reação de talião, e um comer e ser comida em que a dualidade constitui simplesmente uma expressão da identificação de bebê e mãe um com a outra, ou da falta de diferenciação do bebê. Este estágio se acha representado nos meus textos que a paciente havia lido, nos quais um bebê de doze semanas alimenta a mãe enquanto é amamentado, e a paciente diz que sente como me trazendo algo com que me alimentar. Acho, contudo, que ela está tentando chegar à idéia de ser comida pela mãe e sente que a própria mãe falhou-lhe nesta área da experiência. Ela, naturalmente, experienciou o temor de ser comida à maneira de talião, mas faltava a isto a base que é ser comida, simplesmente porque seja o que for que o bebê sente, a mãe está também sentindo.

II

Vários problemas ressaltam, de maneira geral. Por trás de tudo o mais acha-se o problema que surge do não falar. Eu raramente faço uma interpretação e a análise progride melhor na base de eu não dizer absolutamente nada. Isto, contudo, produz complicações, porque se torna cada vez mais evidente que um dos propósitos do interpretar é estabelecer os limites da compreensão do analista. A base para não interpretar e, na realidade, não emitir qualquer som, é a presunção teórica de que o analista realmente sabe o que está se passando. Provavelmente, até o presente, posso dizer que sei o que está se passando nesta análise e, por essa razão, continuo com a política de não falar, que é certamente o que a paciente pede de mim. Dentro deste arcabouço, existem dois temas. Mais à superfície, acha-se toda a questão dos relacionamentos triangulares, tal como acontecem entre pessoas totais: o complexo edipiano, Electra, Cressida, etc. Este tema começou com "cabelos louros", etc., e incluía a idéia de eu ter ciúmes do relacionamento sexual da paciente com homens e, também, a idéia de minha esposa ter ciúmes da paciente, em seu relacionamento comigo (guarda-chuva no porta-guarda-chuvas; minha esposa poderia apanhar o da paciente por engano, etc.). Há uma quantidade muito grande de material em torno deste tema e têm havido atuações que fazem muitíssimo parte da análise. Tudo isto é alterado pelo fato do outro tema, que poderia ser chamado de tema da sina ou destino. Desta maneira, tudo que é de natureza edipiana acha-se quer dentro, quer fora da área do destino. A declaração principal a respeito do destino aconteceu antes das férias de Páscoa, quando todo o problema interpessoal foi enunciado em termos de mitologia grega, de tal maneira que tive de estudar o livro sobre as tragédias de Sófocles, de Bowra, a fim de estar preparado para ela. A frase operacional era "não um peão do destino, mas um agente dele". Após os feriados da Páscoa, o mesmo tema apareceu em outra linguagem: "Sempre fui um objeto parcial". "Pela primeira vez posso dizer que sou uma pessoa muito neurótica, e o acento cai na palavra pessoa". Aqui, a interpretação, se houvesse sido feita, teria sido que um objeto parcial não pode experimentar onipotência. A paciente, contudo, não está preparada para ser uma pessoa total que experiencia onipotência e não tem confiança suficiente no meio ambiente facilitador para tomar de empréstimo forças no ego materno. Aqui entra o analista muito bem comportado que, apesar disso, não se pode confiar que se comporte bem, exceto de modo negativo, isto é, por não comportar-se mal.

A interpretação principal, que não pode ser feita por causa das circunstâncias, é que a onipotência infantil que a paciente evidentemente não experiencia em seu relacionamento com a mãe foi projetada indiscriminadamente na mitologia grega e, agora, após os feriados, na história irlandesa antiga, nos druidas, nas raízes do cristianismo na Irlanda, e na cruz irlandesa que fica em um círculo. Reenunciando: para esta paciente, com uma experiência insuficiente do viver onipotente, o complexo edipiano e todos os relacionamentos, acham-se fora da onipotência projetada (objetos parciais inter-relacionados) ou, então, estão condenados, apanhados pelo destino, isto é, com a onipotência infantil da paciente projetada de forma exagerada.

18

O Medo do Colapso (*Breakdown*)

Redigido em 1963¹

Enunciado Preliminar

Minhas experiências clínicas levaram-me recentemente a uma nova compreensão, segundo acredito, do significado de um medo de colapso.

É meu intuito, aqui, enunciar de modo tão simples quanto possível esta compreensão, nova para mim e, talvez, nova para outros que trabalham com psicoterapia. Naturalmente, se o que digo tem em si verdade, esta já terá sido tratada pelos poetas do mundo, mas os clarões de *insight*, que surgem na poesia, não podem absolver-nos de proceder à penosa tarefa de afastar-nos passo a passo da ignorância, em direção ao nosso objetivo. É opinião minha que um estudo desta área limitada conduz a um reenunciado de diversos outros problemas que nos intrigam quando fracassamos em nos sair tão bem clinicamente quanto quereríamos fazê-lo e, ao final, indicarei quais as extensões da teoria que proponho para exame.

Variações Individuais

O medo do colapso é um aspecto de importância em alguns de nossos pacientes, mas não em outros. Desta observação, se for correta, pode-se tirar a conclusão de que esse medo acha-se relacionado às experiências passadas do indivíduo e aos caprichos ambientais. Ao mesmo tempo, tem-se de esperar um denominador comum do mesmo medo, a indicar a existência de fenômenos universais, já que estes, em verdade,

1. Este trabalho foi publicado na *International Review of Psycho-Analysis* (1974). A data de sua composição é incerta. Existem algumas evidências de que foi redigido como uma palestra a ser proferida perante a Clínica Davidson, em Edimburgo, em 1963, mas que, em vez dele, outro artigo foi apresentado; foi por volta desta época que Winnicott utilizou o mesmo material no pós-escrito a seu artigo *Classificação* (1964), em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (London, Hogarth Press; New York, International Universities Press, 1965; Porto Alegre, Artes Médicas, 1963). No artigo *A Psicologia da Loucura* (1965), Capítulo 21 deste volume, Winnicott volta-se mais para uma dificuldade que encontrou na idéia existente por trás de "O Medo do Colapso", a saber, se é ou não possível que um colapso completo das defesas *seja experienciado*. [N. dos Orgs.]

tornam possível a todos saber empaticamente o que se sente quando um de nossos pacientes apresenta este medo em grande escala (O mesmo se pode dizer, em verdade, de todos os detalhes da insanidade da pessoa insana. Todos nós a conhecemos, embora esse detalhe específico possa não estar nos incomodando).

Surgimento do Sintoma

Nem todos os nossos pacientes que têm este medo queixam-se dele ao início de um tratamento. Alguns o fazem, mas outros têm suas defesas tão bem organizadas que somente após o tratamento haver efetuado considerável progresso é que o medo do colapso vem para o primeiro plano como fator dominante.

Exemplificando: um paciente pode ter diversas fobias e uma organização complexa para lidar com elas, de maneira que essa dependência não surge rapidamente na transferência. Finalmente, a dependência se torna um aspecto principal e, então, os equívocos e fracassos do analista se tornam causas diretas de fobias localizadas e, assim, do desencadeamento do medo do colapso.

Significado de “Colapso”

Utilizei intencionalmente a expressão “colapso” por ser bastante vaga e por poder significar diversas coisas. Em geral, neste contexto, a palavra pode ser tomada como significando o fracasso de uma organização de defesa. Mas perguntamos de imediato: uma defesa contra o quê? E isto nos conduz ao significado mais profundo do termo, uma vez que precisamos utilizar a palavra “colapso” para descrever o impensável estado de coisas subjacente à organização defensiva.

Notar-se-á que embora haja valor em pensar que, na área das psiconeuroses, é a ansiedade de castração que jaz por trás das defesas, nos fenômenos mais psicóticos que estamos examinando é um colapso do estabelecimento do *self* unitário. O ego organiza defesas contra o colapso da organização do ego e é esta organização a ameaçada. Mas o ego não pode se organizar contra o fracasso ambiental, na medida em que a dependência é um fato da vida.

Em outras palavras, estamos examinando uma inversão do processo de amadurecimento do indivíduo, e isto torna necessário reformular sucintamente os estágios iniciais do crescimento emocional.

Crescimento Emocional. Estágios Iniciais

O indivíduo herda um processo de amadurecimento, que o faz progredir na medida em que exista um meio ambiente facilitador e somente na medida em que este exista. O meio ambiente facilitador é, ele próprio, um fenômeno complexo e necessita de um estudo especial por seu próprio direito: o aspecto essencial é que ele possui uma espécie de crescimento seu, próprio, estando adaptado às necessidades mutantes do indivíduo em crescimento.

O indivíduo progride da dependência absoluta para a independência relativa e no sentido da independência. Na saúde, o desenvolvimento se dá em um ritmo que não sobrepuja o desenvolvimento da complexidade nos mecanismos mentais, achando-se isto ligado ao desenvolvimento neurofisiológico.

O meio ambiente facilitador pode ser descrito como *sustentação* [*holding*], evoluindo para o *manejo* [*handling*], ao qual se acrescenta a *apresentação de objeto* [*object-presenting*].

Em um meio ambiente facilitador desse tipo, o indivíduo passa por um desenvolvimento que pode ser classificado como *integrador*, ao qual se acrescentam a *personalização* [*indwelling*] (ou *conluio psicossomático*) e, depois, o *relacionamento objetual* [*object-relating*].

Esta é uma supersimplificação grosseira, mas deve bastar neste contexto.

Observar-se-á que, em uma descrição desse tipo, o movimento para a frente no desenvolvimento corresponde estreitamente à ameaça de um movimento retrógrado (e defesas contra esta ameaça) na doença esquizofrênica.

Dependência Absoluta

À época da dependência absoluta, com a mãe suprimindo uma função de ego auxiliar, tem-se de lembrar que o bebê ainda não separa o *não-eu* do *eu*: isto não pode acontecer separadamente do estabelecimento do *eu*.

Agonias Primitivas

É possível listar as agonias primitivas (*ansiedade*, aqui, não é uma palavra suficientemente forte), entre as quais apresentamos as seguintes:

1. Retorno a um estado não-integrado (Defesa: desintegração).
2. Cair para sempre (Defesa: sustentar-se/*self-holding*).
3. Perda do conluio psicossomático, fracasso da despersonalização (Defesa: despersonalização).
4. Perda do senso do real (Defesa: exploração do narcisismo primário, etc.).
5. Perda da capacidade de relacionar-se com objetos (Defesa: estados autistas, relacionados apenas a fenômenos do *self*).

E assim por diante.

A Enfermidade Psicótica Como Defesa

É minha intenção mostrar aqui que o que vemos clinicamente é sempre uma organização de defesa, até mesmo no autismo da esquizofrenia infantil. A agonia subjacente é impensável.

É errado pensar na enfermidade psicótica como um colapso; ela é uma organização defensiva relacionada a uma agonia primitiva, e é geralmente bem-sucedida (exceto quando o meio ambiente facilitador não foi deficiente, mas sim atormentador, que é talvez a pior coisa que pode acontecer a um bebê humano).

Enunciado do Tema Principal

Posso agora enunciar a minha afirmação principal, e ela se revela muito simples. Afirmo que o medo clínico do colapso é *a medo de um colapso que já foi experienciado*. Ele é um medo da agonia original que provocou a organização de defesa que o paciente apresenta como síndrome de doença.

Esta idéia pode ou não se mostrar imediatamente útil para o clínico. Não podemos apressar nossos pacientes, mas apesar disso, podemos deter seu progresso por genuíno desconhecimento; assim, qualquer pequeno conhecimento nosso pode ajudar a nos manter emparelhados com as necessidades do paciente.

Segundo minha experiência, existem momentos em que se precisa dizer a um paciente que o colapso, do qual o medo destrói-lhe a vida, *já aconteceu*. Trata-se de um fato que se carrega consigo, escondido no inconsciente. Este último aqui, não é exatamente o inconsciente reprimido da psicose, nem, tampouco, o inconsciente da formulação freudiana da parte da psique que se acha muito próxima do funcionamento neurofisiológico. Tampouco se trata do inconsciente de Jung, que eu diria ser todas aquelas coisas que se passam em cavernas subterrâneas, ou (em outras palavras) a mitologia do mundo, nas quais há um conluio entre o indivíduo e as realidades psíquicas internas maternas. Neste contexto especial, o inconsciente quer dizer que a integração do ego não é capaz de abranger algo. O ego é imaturo demais para reunir todos os fenômenos dentro da área da onipotência pessoal.

Tem-se de perguntar aqui: por que o paciente continua a preocupar-se com isto que pertence ao passado? A resposta tem de ser que a experiência original da agonia primitiva não pode cair no passado a menos que o ego possa primeiro reuni-la dentro de sua própria e atual experiência temporal e do controle onipotente agora (presumindo a função de apoio de ego auxiliar da mãe, ou analista).

Em outras palavras, o paciente tem de continuar procurando o detalhe passado que *ainda não foi experienciado*, e esta busca assume a forma de uma procura deste detalhe no futuro.

A menos que o terapeuta possa ter êxito em trabalhar com base em que esse detalhe já é um fato, o paciente tem de continuar a temer encontrar o que está sendo compulsivamente procurado no futuro.

Por outro lado, se o paciente estiver preparado para algum tipo de aceitação deste tipo esquisito de verdade, de que o que ainda não foi experienciado apesar disso aconteceu no passado, irá se abrir o caminho para que a agonia seja experienciada na transferência, na reação às falhas e equívocos do analista. Em doses que não sejam excessivas, o paciente pode lidar com estas últimas, e explicar cada falha técnica do analista como contratransferência. Em outras palavras, o paciente gradualmente reúne o fracasso original do meio ambiente facilitador dentro da área de sua onipotência e da experiência de onipotência que pertence ao estado de dependência (fato transferencial).

Tudo isto é muito difícil, consome tempo e é penoso, mas pelo menos, não é fútil. Fútil é a alternativa, e é esta que deve ser agora examinada.

Futilidade na Análise

Tenho de tomar por certa a compreensão e a aceitação da análise da psicose. Baseado nesta presunção, digo que, nos casos que estou examinando, a análise começa bem e progride com ímpeto; o que está acontecendo, contudo, é que o analista e o paciente estão-se divertindo em conluio em uma análise psiconeurótica, quando, na realidade, a enfermidade é psicótica.

Repetidas vezes o par analítico está satisfeito com o que fizeram juntos. Foi válido, foi arguto, foi cômodo — por causa do conluio. Entretanto, cada um dos chamados progressos termina em destruição. O paciente o rompe e pergunta — E daí? Na realidade, o avanço não foi um avanço, mas sim um novo exemplo de o analista jogar o jogo que o paciente faz de postergar a questão principal. E quem pode culpar quer o paciente, quer o analista (a menos, naturalmente, que possa haver um analista que desempenhe o papel de peixe psicótico em uma linha psiconeurótica muito longa

e espere, por esse meio, evitar ser finalmente apanhado por algum golpe do destino, tal como a morte de um ou outro dos participantes do par, ou uma falta de respaldo financeiro)?

Temos de presumir que tanto paciente quanto analista realmente desejam terminar a análise, mas infelizmente, não há fim, a menos que o fundo do cocho tenha sido alcançado, a menos que *a coisa tentada tenha sido experienciada*. E, em verdade, uma saída para o paciente é ter um colapso (físico ou mental), e isto pode funcionar muito bem. A solução, contudo, não é suficientemente boa se não incluir compreensão e *insight* analíticos por parte do paciente, e, em verdade, muitos dos pacientes a que me estou referindo são pessoas de valor, que não podem dar-se ao luxo de um colapso no sentido de serem mandadas para um hospital psiquiátrico.

O intuito deste artigo é chamar a atenção para a possibilidade de que o colapso já tenha acontecido, próximo do início da vida do indivíduo. O paciente precisa "lembrar" isto, mas não é possível lembrar algo que ainda não aconteceu, e esta coisa do passado não aconteceu ainda, porque o paciente não estava lá para que ela lhe acontecesse. A única maneira de "lembrar", neste caso, é o paciente experienciar esta coisa passada pela primeira vez no presente, ou seja, na transferência. Esta coisa passada e futura torna-se então uma questão do aqui e do agora, e é experienciada pelo paciente pela primeira vez. É este o equivalente do lembrar, e tal desfecho constitui o equivalente do levantamento da repressão que ocorre na análise do paciente psiconeurótico (análise freudiana clássica).

Outras Aplicações Desta Teoria

Medo da morte

É necessário pouca alteração para transferir a tese geral do medo do colapso para um medo específico da morte. Este é talvez um temor mais comum, um medo que é absorvido nos ensinamentos religiosos a respeito de uma vida além-túmulo, como a negar o fato da morte.

Quando o medo da morte constitui um sintoma significativo, a promessa de uma vida futura fracassa em proporcionar alívio e a razão para isso é que o paciente possui uma compulsão a procurar a morte. Novamente, é a morte que aconteceu, mas que não foi experienciada, que é a buscada.

Quando Keats se achava "meio enamorado da morte agradável", ele se achava, de acordo com a idéia que estou apresentando aqui, ansiando pelo conforto que viria se ele pudesse "lembrar" ter morrido, mas para lembrar, tem-se de experienciar a morte agora.

A maioria de minhas idéias é inspirada por pacientes, com quem reconheço meu débito. É a um deles que devo a expressão "morte fenomenal". O que aconteceu no passado foi a morte como um fenômeno, mas não como o tipo de fato que observamos. Muitos homens e mulheres passam suas vidas pensando se encontrariam solução no suicídio, isto é, no envio do corpo a uma morte que já aconteceu na psique. O suicídio, contudo, não é uma resposta, mas sim um gesto de desespero. Entendo agora, pela primeira vez, o que minha paciente esquizofrênica (que se matou) queria dizer quando falou: "Tudo o que lhe peço é que me ajude a cometer suicídio pela razão certa e não pela razão errada". Não consegui fazê-lo e ela se matou no desespero de encontrar a solução. Seu objetivo (como agora percebemos) era obter de mim a declaração de que já morrera na primeiríssima infância. Com base nisto, acho que ela e eu

poderíamos tê-la ajudado a postergar a morte corporal até que a velhice lhe cobrasse seus direitos.

A morte, encarada desta maneira, como algo que aconteceu ao paciente que não era suficientemente maduro para experienciar, tem o significado de aniquilamento. É como se se desenvolvesse um padrão no qual a continuidade do ser fosse interrompida pelas reações infantis do paciente às intrusões [*impingements*], com estas sendo fatores ambientais que se permitiu invadirem por falhas do meio ambiente facilitador. (No caso da paciente citada, os problemas começaram muito cedo, pois houve uma percepção prematura despertada antes do nascimento por causa de um pânico materno; em adição a isso, o parto foi complicado por uma placenta prévia não-diagnosticada.)

Vazio

Mais uma vez, meus pacientes mostram-me que o conceito de vazio pode ser encarado através deste mesmo par de óculos.

Em alguns pacientes, o vazio precisa ser experienciado, e este vazio pertence ao passado, ao tempo que precedeu o grau de maturidade que tornaria possível ao vazio ser experienciado.

Para entender isto, é necessário pensar não em traumas, mas em nada acontecendo quando algo poderia proveitosamente ter acontecido.

É mais fácil para um paciente lembrar um trauma do que nada acontecendo quando poderia ter acontecido. Na ocasião, ele não sabia o que poderia ter acontecido e, assim, não poderia experienciar nada, exceto notar que algo poderia ter sido.

Exemplo

Uma fase do tratamento de uma paciente ilustra isto. Esta jovem mulher deitava-se inutilmente no divã e tudo o que podia fazer era dizer: "Nada está acontecendo nesta análise!"

No estágio que estou descrevendo, a paciente havia fornecido material de um tipo indireto, de maneira que eu podia saber que ela estava provavelmente sentindo algo. Eu era capaz de dizer que ela estivera sentindo sentimentos e os experienciado a atenuarem-se gradualmente, de acordo com o padrão dela, um padrão que lhe causava desespero. Os sentimentos eram sexuais e femininos. Não se mostravam clinicamente.

Aqui na transferência estava eu (quase) sendo a causa agora de malogar-se sua sexualidade feminina: quando isto foi corretamente enunciado, tivemos um exemplo, no presente, do que lhe havia acontecido inumeráveis vezes. No caso dela (para simplificar a bem da descrição) havia um pai que, a princípio, dificilmente se achava presente e que, quando retornava à casa, quando ela era uma meninazinha, não queria o *self* feminino da filha e nada tinha a dar a título de estímulo masculino.

Agora, o vazio é um pré-requisito para o desejo de receber algo dentro de si. O vazio primário significa simplesmente: antes de começar a se encher. Uma considerável maturidade é necessária para que este estágio possa ter significado.

O vazio que ocorre num tratamento é um estado que o paciente está tentando experienciar, um estado passado que não pode ser lembrado, exceto por ser experienciado pela primeira vez agora.

Na prática, a dificuldade é que o paciente teme o horror do vazio e, como defesa, organizará um vazio controlado, não comendo ou não aprendendo, ou então, impiedosamente o encherá por uma voracidade que é compulsiva e parece louca. Quando o paciente pode chegar ao próprio vazio e tolerar esse estado por causa da dependên-

cia no ego auxiliar do analista, então receber em si pode começar a ser uma função prazerosa; pode aqui iniciar-se um comer que não é uma função dissociada (ou excindida)* como parte da personalidade; é também desta maneira que alguns de nossos pacientes que não conseguem aprender, podem começar a aprender com prazer.

A base de toda aprendizagem (assim como do comer) é o vazio. Mas se o vazio não é experienciado como tal, desde o começo, ele aparece então como um estado que é temido, mas contudo, compulsivamente buscado.

Não-existência

A busca da não-existência pessoal pode ser examinada da mesma maneira. Descobrir-se-á que a não-existência aqui faz parte de uma defesa. A existência pessoal é representada pelos elementos de projeção e a pessoa está fazendo uma tentativa de projetar tudo o que possa ser pessoal. Esta pode ser uma defesa relativamente refinada e o objetivo dela é evitar responsabilidade (na posição depressiva) ou perseguição (no que eu chamaria de estado de auto-asserção, isto é, o estágio do *Eu sou*, com a implicação inerente de que *Eu repudio tudo o que não seja eu*). É conveniente aqui utilizar como ilustração o brinquedo infantil de "Eu sou o Rei do Castelo; você é o Patife Sujo".

Nas religiões, esta idéia pode aparecer no conceito de unicidade com Deus ou com o Universo. É possível ver-se esta defesa sendo negada nos textos e ensinamentos existencialistas, nos quais o existir é transformado em culto, numa tentativa de neutralizar a tendência pessoal no sentido de uma não-existência que faz parte de uma defesa organizada.

Pode haver um elemento positivo em tudo isso, ou seja, um elemento que não é uma defesa. Pode-se dizer que *somente a partir da não-existência é que a existência pode começar*. É surpreendente quão cedo (até mesmo antes do nascimento e certamente durante o processo de nascimento) a percepção de um ego prematuro pode ser mobilizada. Mas o indivíduo não pode desenvolver-se a partir de uma raiz de ego se esta estiver divorciada da experiência psicossomática e do nascisismo primário. É somente aqui que começa a intelectualização das funções do ego, e pode-se observar aqui que tudo isto se acha a uma longa distância, no tempo antes do estabelecimento de qualquer coisa que possa ser utilmente chamada de *self*.

Resumo

Tentei demonstrar que o medo do colapso pode ser um medo de um acontecimento passado que ainda não foi experienciado. A necessidade de experienciá-lo é equivalente à necessidade de lembrar nos termos da análise dos psiconeuróticos.

Esta idéia pode ser aplicada a outros medos afins, e dentre eles mencionei o medo da morte e a busca do vazio.

* No original, *splitt-off*, sem correspondência literal em português; remete ao significado presente em expelido — cindido. (N. do T. e N. dos R.)

19

A Importância do *Setting* no Encontro com a Regressão na Psicanálise

Redigido para um seminário de estudantes de terceiro ano no Instituto de Psicanálise, em 9 de julho de 1964

Já dei meus três seminários oficiais, nos quais tentei falar a respeito da psicanálise sem permitir que minhas próprias idéias pessoais usurpassem os demais. Expressou-se o desejo, contudo, de que eu falasse sobre minhas opiniões pessoais neste seminário não-oficial. Pediram-me, particularmente, que falasse sobre a regressão.

Naturalmente, isto abre um território muito amplo. Tenho de adaptar-me a fornecer o que for essencial e tentar enunciar algo que possa ser entendido e debatido.

Talvez meu objetivo principal vá ser neutralizar algumas das más concepções que tão facilmente se apinham em torno da idéia de defrontar-se com uma regressão. O erro mais importante que se comete é que a regressão seja alguma saída fácil no trabalho analítico.

Quero tornar inteiramente claro que é afortunado quando a questão de enfrentar uma regressão não surge em grande escala em uma análise.

Entender-se-á que os princípios básicos da análise são aceitos por mim e que o que tento fazer é seguir os princípios estabelecidos por Freud, que me parecem fundamentais a todo o nosso trabalho. Em um certo *setting*, Freud lidou com o material produzido pelo paciente e grande parte de seu trabalho esteve relacionado ao imenso problema de como lidar com esse material.

Em alguns casos, contudo, revela-se ao final, ou mesmo de começo, que o *setting* e a manutenção dele são tão importantes quanto a maneira pela qual se lida com o material. Em alguns pacientes, com um certo tipo de diagnóstico, a provisão e a manutenção do *setting* são mais importantes que o trabalho interpretativo. Quando isto se dá, podemos sentir-nos desafiados e é inteiramente possível que a coisa certa a fazer seja encerrar o tratamento, pelo motivo de não se ser capaz de atender às exigências do paciente.

No caso comum, estamos nos aproveitando do trabalho efetuado pelos pais, particularmente a mãe, no início da infância e primeira infância do paciente. Não foi muito difícil à mãe adaptar-se às necessidades de seu bebê, porque só precisou fazê-lo durante um período de tempo relativamente curto, uns poucos meses, e, usualmente, isto é o que ela gosta de fazer. Sabe também que, com o decurso do tempo, recuperará sua própria independência.

Forneço este exemplo porque, embora houvesse escapado por um tris, emergi dele sem ter de enganar ninguém e sem nada mais que um enunciado de minhas próprias imperfeições. Pode-se facilmente perceber que simplesmente não podemos nos dar ao luxo de cometer estes erros com pacientes que se encontram mais enfermos, e, por isto, quero dizer pacientes que tenham personalidades menos sadias, ao lado de seu fragmento enfermo. O fragmento enfermo é tão doente em um paciente quanto em outro, e não se pode, de maneira alguma, diminuir-se a adaptação às necessidades do paciente por saber-se que este possui uma considerável porção de personalidade sadia. É o fragmento enfermo com que se está lidando e ele é tão enfermo quanto possível.

O espantoso é que, ao se ter um paciente que está passando por uma dessas fases, podemos adaptar-nos de maneira muito detalhada às necessidades dele durante um período de tempo, isto é, na hora que é reservada para este paciente podemos ter uma confiabilidade profissional que é muitíssimo diferente de nossa própria e inconfiável personalidade. Com o tempo, porém, a nossa própria inconfiabilidade começa a vazar, e um dos perigos disso é que, assim que o paciente começa a ficar melhor no sentido de ser capaz de permitir-nos diminuir a vigilância, ficamos sujeitos a tirar umas férias, por assim dizer, e precipitar-nos com uma demonstração de nosso próprio impulso. Não podemos nos culpar por sermos assim, mas isto pode nos fazer perder um caso que está indo bem.

Tudo então aponta para o fato de que este trabalho é não apenas difícil, mas absorve uma grande quantidade de nossa capacidade de investimento psicoenergético e pode facilmente acontecer que se possa conduzir dois ou, talvez, até mesmo três casos, mas não quatro ao mesmo tempo. De modo geral, é possível ter-se por vez somente um paciente que se ache maximamente enfermo.

Princípios

A teoria deste trabalho depende de certos princípios. Eles já foram formulados e, uma vez formulados, pode-se ver que são, em grande parte, óbvios.

O enunciado básico é que o desenvolvimento emocional constitui um processo de amadurecimento ao qual se adiciona um crescimento baseado na acumulação de experiências.

O processo maturacional é o que é herdado.

Ele não se torna real, exceto em um meio ambiente facilitador.

O meio ambiente facilitador precisa ser estudado em relação aos detalhes do processo maturacional.

O processo maturacional inclui a integração sob suas variadas formas, a saber:

1. A moradia da psique no soma.
2. O relacionamento objetal.
3. A interação dos processos intelectuais com a experiência psicossomática.

Correspondentes a estes e a outros pormenores do processo de amadurecimento temos os três aspectos seguintes do meio ambiente facilitador:

- a. A sustentação [*holding*];
- b. O manejo [*handling*];
- c. A realização [*realising*].

O funcionamento do meio ambiente facilitador começa por quase 100% de adaptação, diminuindo rapidamente de acordo com as necessidades crescentes do bebê.

Estas necessidades incluem a oportunidade de relacionar-se objetivamente através da agressão.

Antes disto, vem a satisfação erótica mediante a realização bem-sucedida. No crescimento emocional do bebê, o caminho vai da dependência absoluta para a dependência e, desta, no sentido da independência. Nos estágios iniciais, o bebê não se dá conta da dependência e relaciona-se com objetos subjetivos.

Aspecto importante do crescimento é a mudança do relacionamento com objetos subjetivos para um reconhecimento de objetos que se acham fora da área da onipotência, isto é, que são objetivamente percebidos, mas não-explicados com base na projeção. Nesta área de mudança encontra-se a oportunidade máxima para o indivíduo fazer sentido dos componentes agressivos. Fazer sentido desses componentes conduz à experiência que o bebê tem da raiva (relacionada ao conceito kleiniano da inveja do seio bom) e, no caso favorável, à fusão dos componentes agressivos e eróticos que resultam no comer. Na saúde, quando da época em que comer estabeleceu-se como parte do relacionamento com objetos, tornou-se organizada também uma existência de fantasia que é paralela ao viver real e conduz consigo seu próprio senso do real.

Não é possível fornecer uma resposta direta à pergunta: o bebê possui um ego, desde o início? A razão para tal é que, de começo, o ego de bebê é, ao mesmo tempo, débil e poderoso. É débil ao extremo se não existe um meio ambiente facilitador satisfatório. Em quase todos os casos, contudo, a mãe ou a figura materna fornecem apoio ao ego, e, se ela faz isso de modo suficientemente bom, o ego do bebê é muito forte e possui sua própria organização. A mãe é capaz de proporcionar este apoio ao ego mediante sua capacidade e disposição de identificar-se temporariamente com seu bebê.

É importante distinguir entre a capacidade que uma mãe tem de identificar-se com seu bebê, mantendo, naturalmente, sua própria autonomia, e o estado, próprio ao bebê, de não haver ainda emergido da dependência absoluta. É só gradualmente que ele separa o *não-eu* do *eu*, e um estágio importante de desenvolvimento emocional ocorre quando o bebê se torna capaz de reconhecer o fato da dependência e conseguir ter um *self* que é apenas relativamente dependente — ao invés de absolutamente dependente — do estado temporário da mãe em que ela se conluía com o bebê, de maneira que este tem, por causa do conluio dela, um ego, uma organização do ego e um certo grau de força e elasticidade do ego.

Transtorno [*disorder*] Psicossomático

I. A Enfermidade Psicossomática em seus Aspectos Positivos e Negativos

*Originalmente, palestra proferida perante a Sociedade
de Pesquisa Psicossomática, em 21 de maio de 1964¹*

Apresentação

1. A palavra "psicossomático" é necessária porque não existe nenhuma palavra simples que seja apropriada para a descrição de certos estados clínicos.
2. O hífen* tanto une quanto separa os dois aspectos da prática médica que se acham constantemente sendo examinados em qualquer debate deste tema.
3. A palavra descreve com exatidão algo que é inerente a este trabalho.
4. O profissional psicossomático se orgulha de sua capacidade de cavalgar dois animais, com um pé em cada uma das selas e ambas as rédeas em suas hábeis mãos.
5. Para conceder um lugar ao hífen, tem-se de encontrar algum agente que tenda a separar os dois aspectos do transtorno [*disorder*] psicossomático.
6. Este agente é, na realidade, uma dissociação no paciente.
7. A enfermidade no transtorno psicossomático não é o estado clínico expresso em termos de patologia somática ou funcionamento patológico (colite, asma, eczema crônico), mas sim a persistência de uma cisão na organização do ego do paciente, ou de dissociações múltiplas, que constituem a verdadeira enfermidade.
8. Este estado de doença no paciente é, ele próprio, uma organização de defesa com determinantes muito poderosos, e, por esta razão, é muito comum que médicos bem-intencionados e bem-informados, e até mesmo excepcionalmente bem-preparados fracassem em seus esforços para curar pacientes que tenham um transtorno psicossomático.
9. Se as razões para esta tendência a fracassar não são compreendidas, os clínicos perdem o ânimo. Então, o tema da psicossomática se torna um tema para exame não-clínico ou *teórico*, e isto é relativamente fácil, porque o teórico é desligado e não se acha assoberbado pela responsabilidade por pacientes reais. O teórico é aquele que está apto a perder contato com a dissociação e é capaz de enxergar desde ambos os lados, de maneira demasiadamente fácil.

1. Publicado em sua presente forma no *International Journal of Psycho-Analysis* (1966). Copyright (C) *Institute of Psycho-Analysis*.

* Refere-se ao sinal entre *psycho* e *somatic*, inexistente em português. (N. do T.)

Estas necessidades incluem a oportunidade de relacionar-se objetivamente através da agressão.

Antes disto, vem a satisfação erótica mediante a realização bem-sucedida. No crescimento emocional do bebê, o caminho vai da dependência absoluta para a dependência e, desta, no sentido da independência. Nos estágios iniciais, o bebê não se dá conta da dependência e relaciona-se com objetos subjetivos.

Aspecto importante do crescimento é a mudança do relacionamento com objetos subjetivos para um reconhecimento de objetos que se acham fora da área da onipotência, isto é, que são objetivamente percebidos, mas não-explicados com base na projeção. Nesta área de mudança encontra-se a oportunidade máxima para o indivíduo fazer sentido dos componentes agressivos. Fazer sentido desses componentes conduz à experiência que o bebê tem da raiva (relacionada ao conceito kleiniano da inveja do seio bom) e, no caso favorável, à fusão dos componentes agressivos e eróticos que resultam no comer. Na saúde, quando da época em que comer estabeleceu-se como parte do relacionamento com objetos, tornou-se organizada também uma existência de fantasia que é paralela ao viver real e conduz consigo seu próprio senso do real.

Não é possível fornecer uma resposta direta à pergunta: o bebê possui um ego, desde o início? A razão para tal é que, de começo, o ego de bebê é, ao mesmo tempo, débil e poderoso. É débil ao extremo se não existe um meio ambiente facilitador satisfatório. Em quase todos os casos, contudo, a mãe ou a figura materna fornecem apoio ao ego, e, se ela faz isso de modo suficientemente bom, o ego do bebê é muito forte e possui sua própria organização. A mãe é capaz de proporcionar este apoio ao ego mediante sua capacidade e disposição de identificar-se temporariamente com seu bebê.

É importante distinguir entre a capacidade que uma mãe tem de identificar-se com seu bebê, mantendo, naturalmente, sua própria autonomia, e o estado, próprio ao bebê, de não haver ainda emergido da dependência absoluta. É só gradualmente que ele separa o *não-eu* do *eu*, e um estágio importante de desenvolvimento emocional ocorre quando o bebê se torna capaz de reconhecer o fato da dependência e conseguir ter um *self* que é apenas relativamente dependente — ao invés de absolutamente dependente — do estado temporário da mãe em que ela se conluía com o bebê, de maneira que este tem, por causa do conluio dela, um ego, uma organização do ego e um certo grau de força e elasticidade do ego.

Transtorno [*disorder*] Psicossomático

I. A Enfermidade Psicossomática em seus Aspectos Positivos e Negativos

Originalmente, palestra proferida perante a Sociedade de Pesquisa Psicossomática, em 21 de maio de 1964¹

Apresentação

1. A palavra "psicossomático" é necessária porque não existe nenhuma palavra simples que seja apropriada para a descrição de certos estados clínicos.
2. O hífen* tanto une quanto separa os dois aspectos da prática médica que se acham constantemente sendo examinados em qualquer debate deste tema.
3. A palavra descreve com exatidão algo que é inerente a este trabalho.
4. O profissional psicossomático se orgulha de sua capacidade de cavalgar dois animais, com um pé em cada uma das selas e ambas as rédeas em suas hábeis mãos.
5. Para conceder um lugar ao hífen, tem-se de encontrar algum agente que tenda a separar os dois aspectos do transtorno [*disorder*] psicossomático.
6. Este agente é, na realidade, uma dissociação no paciente.
7. A enfermidade no transtorno psicossomático não é o estado clínico expresso em termos de patologia somática ou funcionamento patológico (colite, asma, eczema crônico), mas sim a persistência de uma cisão na organização do ego do paciente, ou de dissociações múltiplas, que constituem a verdadeira enfermidade.
8. Este estado de doença no paciente é, ele próprio, uma organização de defesa com determinantes muito poderosos, e, por esta razão, é muito comum que médicos bem-intencionados e bem-informados, e até mesmo excepcionalmente bem-preparados fracassem em seus esforços para curar pacientes que tenham um transtorno psicossomático.
9. Se as razões para esta tendência a fracassar não são compreendidas, os clínicos perdem o ânimo. Então, o tema da psicossomática se torna um tema para exame não-clínico ou *teórico*, e isto é relativamente fácil, porque o teórico é desligado e não se acha assoberbado pela responsabilidade por pacientes reais. O teórico é aquele que está apto a perder contato com a dissociação e é capaz de enxergar desde ambos os lados, de maneira demasiadamente fácil.

1. Publicado em sua presente forma no *International Journal of Psycho-Analysis* (1966). Copyright (C) *Institute of Psycho-Analysis*.

* Refere-se ao sinal entre *psycho* e *somatic*, inexistente em português. (N. do T.)

Tenho o desejo de tornar claro que *as forças em funcionamento no paciente são tremendamente fortes*. O dilema do profissional psicossomático praticante é, em verdade, uma realidade.

Uma ou duas complicações devem ser mencionadas neste estágio do debate.

a. Alguns médicos praticantes não são realmente capazes de montar os dois cavalos. Sentam-se em uma das selas e levam o outro animal pela brida ou, então, perdem contato com ele. Afinal de contas, por que devem os médicos ser mais sadios, em sentido psiquiátrico, que os seus pacientes? Eles não foram escolhidos em bases psiquiátricas. As dissociações do próprio médico precisam ser consideradas juntamente com as dissociações nas personalidades dos pacientes.

b. Os pacientes podem ter mais de uma enfermidade. Um homem com uma tendência a espasmos coronários, secundários à confusão emocional, pode também ter artérias calcificadas, ou uma mulher com fibromas e menorrágia pode ter também uma imaturidade sexual, e assim por diante. De modo geral, são os hipocondríacos que não conseguem ser examinados quando têm câncer do seio ou um hipernefoma, assim como são os pacientes fisicamente enfermos que se apresentam como a necessitar de psicanálise ou hipnotismo. E os pacientes que estão sempre incomodando uma sucessão de médicos, a fim de serem examinados muito raramente, têm algo que possa ser descoberto por exames físicos. Desta maneira, os médicos se desencaminham e espantosas histórias de negligência são relatadas, em algumas das quais se tem de acreditar.

c. Muitos pacientes não dividem o seu cuidado médico em duas partes; a cisão se dá em fragmentos múltiplos, e nós, como médicos, nos descobrimos agindo no papel de um desses fragmentos. Utilizei (1958) o termo "disseminação dos agentes responsáveis"² para descrever esta tendência. Pacientes desse tipo fornecem os exemplos citados em levantamentos de assistência social nos quais descobriu-se que vinte, trinta ou mais agências se achavam envolvidas no alívio da aflição de uma só família. Os pacientes com dissociações múltiplas também exploram as divisões naturais na profissão médica, tais como:

{	{	médica
		cirúrgica
		psiquiátrica
		psicanalítica
{	{	psicoterapêutica
		homeopática
		osteopática
{	{	cura pela fé
		diversos serviços auxiliares

A Psicossomática como Tema

A psicossomática é, sob muitas maneiras, um tema curioso, pois se ascender-se na esfera da intelectualização e perder-se contato com o paciente real, logo se descobre que a expressão psicossomática perde a sua função integradora e cedo nos perguntamos: por que existe esta especialidade? Não se refere ela a todos os aspectos do crescimento humano, exceto, talvez, o do comportamento? Eu próprio descobri-me

2. Ver a resenha, por Winnicott, de *The Doctor, His Patient and the Illness* (1958), de Michael Balint, no Capítulo 52 do segundo tomo deste livro.

envolvido nas mesmas considerações, que, para meu próprio benefício, tentei esclarecer em *A Mente e sua Relação com a Psique-Soma* (1949)³, porque foi na redação desse trabalho que me dei conta da confusão causada pelo emprego do termo "transtorno mental", expressão que, de alguma maneira, falha em abranger o caso de uma criança com uma crise biliosa ou o de uma pessoa com uma moléstia física fatal que não se torna despida de esperança.

Sugiro que qualquer tentativa intelectualizada de tornar fácil a psicossomática se mantenha distante da barafunda muito clínica em que nos atolamos em nosso trabalho real. Descobrimo-nos envolvidos em tentativas de construir uma *teoria*, onde a palavra deveria ser *teorias*, no plural. Meu objetivo não é enunciar uma verdade final, mas sim apresentar meus argumentos, e, dessa maneira, fornecer material para consideração.

O elemento que dá coesão ao nosso trabalho em psicossomática parece-me ser, como já afirmei, a cisão patológica, feita pelo paciente, da provisão ambiental. A cisão é certamente uma divisão que separa o cuidado físico da compreensão intelectual; mais importante, ela separa o cuidado da psique do cuidado do soma.

Se eu tomar um caso de minha clínica agora e tentar descrever-lhe o dilema, corro o risco de arruinar o tratamento, porque, por mais cuidadosamente que enuncie o que tenho a relatar, não posso satisfazer o meu paciente, que poderia ler o que lhe é relatado. A solução, no caso de qualquer paciente, não deve ser buscada em um relato cada vez mais cuidadoso; ela só pode vir através do sucesso do tratamento, que, ao lhe conceder tempo, pode resultar em o paciente tornar-se capaz de não mais precisar da cisão que cria o dilema médico que estou descrevendo. Como sou médico praticante, tenho de ser muito cuidadoso na apresentação de meu material ilustrativo.

Finjamos que tenho um paciente entre os leitores, um paciente com uma variedade deste transtorno a que demos o nome de psicossomático. O paciente provavelmente não se importará por ser citado, não é este o problema aqui. O problema é que *não me seria possível fornecer uma descrição aceitável de algo que ainda não se tornou aceitável na economia interna desse paciente*. Somente a continuação do tratamento tem utilidade no caso real e, no decorrer do tempo, o paciente cuja existência estou postulando pode vir a aliviar-me do dilema em que sua doença me coloca, o dilema que é o tema de meu artigo. É uma das coisas que eu odiaria fazer seria seduzir o paciente a um enunciado acordado que envolveria um abandono da psique-soma e uma fuga para o conluio intelectual.

Estarei começando a transmitir o que quero dizer, de que, na prática, existe realmente uma dificuldade real e insuperável, qual seja, a dissociação no paciente que, como uma defesa organizada, mantém separadas a disfunção somática e o conflito na psique? Concedendo-se tempo e circunstâncias favoráveis, o paciente tenderá a recuperar-se dessa dissociação. As forças integradoras nele tendem a fazer o paciente abandonar a defesa. Tenho de tentar efetuar um enunciado que evite o dilema.

Estará evidente que estou fazendo uma distinção entre o caso psicossomático verdadeiro e o problema clínico quase universal do envolvimento funcional nos processos emocionais e nos conflitos mentais. Não chamo necessariamente de caso psicossomático uma paciente minha cuja dismenorréia está relacionada a componentes anais na organização genital, nem tampouco o homem que tem de urinar urgentemente em certas circunstâncias. Isto é apenas a vida e faz parte do viver. Mas o paciente meu que alega que sua hérnia de disco é devida a uma corrente de ar poderia reivindicar ser chamado de psicossomático e, dessa maneira, qualificar-se a receber nossa atenção neste trabalho.

3. Em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London, Tavistock, 1958; New York, Basic Books, 1975; London, Hogarth Press, 1975).

Material Ilustrativo

Quando vou buscar exemplos clínicos, fico naturalmente esmagado pela massa de material. Deve haver uma centena de maneiras de avançar a partir daqui em expor meu ponto de vista.

Caso de Anorexia Nervosa

Há certos aspectos comuns nos casos de anorexia, ainda que, em determinado caso, a criança possa ser quase normal e, em outro, ela (às vezes ele) possa estar muito enferma. Uma criança pode quase morrer de inanição em um distúrbio de fase e, apesar disso, recuperar-se espontaneamente, enquanto que, em outro exemplo menos perigoso, pode permanecer sendo uma baixa psiquiátrica.

Descreverei de modo sucinto uma menina de dez anos que se acha em análise. Encontra-se fisicamente bem porque está recebendo comida como se fosse remédio. Ela não come absolutamente nada como comida. Podem imaginar que esta menina tenha muita desconfiança da conversa entre seus médicos físicos e seu analista. Ao mesmo tempo, e de modo total e consciente, ela se apóia em uma cooperação estreita entre o analista, os médicos e o pessoal de enfermagem. Existem muitas cisões; enfermeiras e médicos são classificados pela paciente entre aqueles que entendem e aqueles que nunca poderiam entender. Todo o esforço é feito, por parte de todos os interessados, para evitar o momento em que a lógica apareça em cena e torne clara a existência da dissociação na paciente. A pior coisa possível seria forçar este tema. Um dos médicos lhe disse: "Você está desperdiçando seu tempo; deveria fazer as lições da escola". Isto produziu uma ameaça de ansiedade de extrema intensidade e a situação só foi salva porque a sessão analítica veio logo após este perigoso acontecimento. A paciente sabia que podia confiar que o analista proibisse o ensino. Mas não precisei fazer nada porque ela logo encontrou um dos outros médicos, "um dos que entendem", e ele naturalmente proibiu o ensino e ajeitou todo o problema. Podia-se confiar, no entanto, que uma das enfermeiras da enfermagem, bem como uma das faxineiras, dissesse algo sem tato, isto é, algo que ignorasse a dissociação existente na paciente. Acredito que, atualmente, ninguém que se encontre distante quinze quilômetros desta menina diria-lhe na realidade para *comer*, pois a sua necessidade muito grande de ser deixada em paz a este respeito tornou-se conhecida e relutantemente aceita.

Temos outra maneira de descrever este aspecto referente ao mesmo caso. Durante muitos meses, nesta análise, as sensações, agonias e sonhos da paciente apareceram sob a forma de um material urgente relacionado à barriga. Havia um mundo inteiro de objetos que caíam em sua frente. Em um sonho, havia arquivos e até mesmo portas de aço com bordas agudas que lhe causavam agudas dores de barriga, e que não podiam ser alteradas por interpretações relativas a objetos internos. Certo dia (depois de anos) ela relatou uma *dor de cabeça*. Aqui, pelo menos, havia uma mudança quanto ao estado dissociado, uma vez que uma dor de cabeça podia ser aceita como se achando associada a uma confusão de idéias e de responsabilidade. Interpretei então que ela estava me falando a respeito de uma doença de sua *mente* e, portanto, saí fora de uma equipe psicossomática para assumir o papel de psicoterapeuta. Isto persistiu e agora, já há muitos meses, raramente me tem sido feito algum relato em termos de barriga. Agora, como paciente psiquiátrica, ela consegue me fornecer material que posso interpretar em uma terminologia de objetos internos, se a isso me sentir disposto, e posso trabalhar com a paciente sobre a natureza da fantasia que faz de seu interior e do que se pode encontrar lá, como chegou lá e do que fazer com isso. Na

fase anterior, em contraste, havia uma fuga para sintomas delirantes relativos à barriga, e uma denegação do conteúdo mental.

Se esta paciente estivesse agora lendo este trabalho não se acharia à vontade, porque se daria conta de que os médicos que cuidam dela são amigos de seu analista. Os pacientes psicossomáticos estão sempre se queixando de que seus vários médicos não cooperam, mas ficam ansiosos quando eles de fato se reúnem para debater o caso. Misericordiosamente, meus colegas de pediatria não são inteiramente devotados a este ponto de vista do psicólogo dinâmico ou do psicanalista, e, dessa maneira, uma certa cisão acha-se realmente presente no meio ambiente médico; isto faz a criança sentir que possui aliados, seja qual for o lado que aconteça estar em seu conflito interno, o qual surge da dissociação⁴.

Na prática da psicossomática, o que o psicoterapeuta precisa é da cooperação de um médico físico *não demasiadamente científico*. Isto soa muito mal e estou esperando oposição quando faço esta reivindicação. Contudo, tenho de declarar o que sinto. Ao fazer a análise de um caso psicossomático, gostaria que o meu equivalente médico físico fosse *um cientista em férias da ciência*. Do que se precisa é ficção científica, ao invés de uma aplicação rígida e compulsiva da teoria médica com base na percepção da realidade objetiva.

Uma Paciente Adulta

Uma paciente psicanalítica minha, na metade da vida, dependeu de muitas outras pessoas e situações, além do analista, no curso de seu tratamento. Permitam-me relacionar alguns deles:

- O clínico geral da família e um grupo de ginecologistas e patologistas.
- Seu osteopata.
- Seu dermatologista.
- Seus analistas anteriores.
- Sua massagista.
- Seu cabelereiro, especialmente *o outro* que cura a sua alopecia ocasional sem cobrar.
- Um espiritualista clarividente.
- O pastor religioso especial.
- A babá dos filhos, muito cuidadosamente escolhida, de maneira a ser suficientemente boa no cuidado de bebês e, portanto, capaz de transformar-se em uma enfermeira psiquiátrica para a própria paciente.
- A garagem muito especial para o carro dela.
- Etc.

Temos aqui uma "disseminação de agentes responsáveis", secundária a uma desintegração ativa na economia da personalidade da paciente. A integração, em sua análise, tem sido uma anulação gradual da disseminação organizada de agentes terapêuticos e da dissociação múltipla de sua personalidade, pela qual ela se defendia contra a perda de identidade em uma fusão com a mãe. Está claro que, inicialmente, a paciente utilizava todos essas ajudas de maneira dissociada? Havia um revoar de um para qualquer dos outros e, como existia uma dissociação múltipla essencial, a

4. 1965-66. Desde que isto foi escrito, em 1964, a natureza da enfermidade desta paciente se alterou. Hoje ela não é mais um caso psicossomático. Tem um grave distúrbio do desenvolvimento emocional e está utilizando a análise para alívio do conflito e da agonia mentais, sem empregar a defesa psicossomática. (Nota posterior: a paciente saiu-se bem.) — D.W.W.

paciente não se encontrava nunca, ao mesmo tempo, em um só lugar e em contato com cada um e todos os aspectos do cuidado que organizara.

No decurso do tratamento, porém, uma mudança muito grande ocorreu. Assisti a todos esses agentes se estabelecerem gradualmente como *aspectos da transferência*. Quando a paciente chegou perto desta realização, foi capaz, pela primeira vez, de amar alguém, o seu marido. A cisão da personalidade achava-se relacionada a uma necessidade que a paciente tinha de resgatar uma identidade pessoal e evitar fundir-se com a mãe. Para mim foi um dia memorável aquele em que a paciente me telefonou por engano, quando pretendia chamar seu açougueiro⁵.

Um caso de Colite

Em um terceiro caso, para equilibrar o que já foi narrado, um desfecho menos feliz pode ser relatado. Uma criança estava fazendo análise comigo por causa de colite, certamente um bom exemplo do tipo de transtorno que aparece juntamente com a cisão que estou tentando descrever. Infelizmente, fui incapaz de perceber suficientemente cedo que a pessoa doente, neste caso, era a mãe. Era ela quem tinha a cisão essencial e a criança quem tinha a colite, mas foi esta última que me foi trazida para tratamento.

Eu estava me saindo muito bem com a criança e pensei que tinha a cooperação da mãe. Certamente tinha a sua amistosidade. Quando a menina completou oito anos de idade, disse-lhe que podia ir para a escola, como desejava fazer, e isto produziu uma mudança na atitude inconsciente da mãe. A criança foi para a escola, mas cedo ficou verdadeiramente muito doente.

Descobri então que fora aos oito anos que a mãe havia tido, ela própria, um caso de recusa à escola, e, certamente, isto por sua vez tinha a ver com a própria psicopatologia da mãe. Esta, embora inconsciente do fato, não podia permitir que a filha, que estava vivendo sua vida por ela novamente, saísse fora do padrão.

Após o inesperado colapso de meu tratamento, descobri que a criança estivera aos cuidados de vários clínicos gerais e também de um pediatra, bem como, em determinada vez perto do final de meus cuidados, estava indo a um hipnotizador e a outro psicoterapeuta. Não demorou muito para que tivesse o cólon removido por um cirurgião e eu saí fora do caso, com meu afastamento mal sendo notado. Não fui nem mesmo dispensado. Três meses antes, no entanto, eu tinha todo o caso em minhas mãos, segundo parecia, e achava ter a confiança plena da família; certamente tinha a confiança da criança, na medida em que era um ser humano autônomo, mas infelizmente, era exatamente isto o que ela não era.

Desconheço o desfecho do caso e não tive disposição de perguntar. Meu erro foi tratar a criança quando a doença se achava na mãe, e a enfermidade incluía a dissociação psicossomática essencial que é o tema deste trabalho. Não que houvesse negligenciado a psicopatologia da mãe, a qual a filha conhecia, e que foi todo o tempo um elemento importante no trabalho realizado entre a menina e eu mesmo, mas havia esquecido a necessidade inconsciente, tremendamente poderosa, que existe em uma mãe desse tipo, de espalhar os agentes responsáveis e manter o *status quo* do qual, aqui, a moléstia somática da criança fazia parte integrante. A mãe podia ter um corpo sadio enquanto a enfermidade se encontrasse na filha.

5. No caso de a paciente ler estas palavras, desejaria declarar que esta descrição não é apenas inadequada por todas as maneiras; não é nem mesmo exata, mas a estou utilizando para ilustrar uma idéia. (Nota posterior: esta paciente saiu-se bem.) D.W.W.

Recapitulação

Uma multiplicação de exemplos clínicos não fará avançar meus argumentos. Não existe área do desenvolvimento da personalidade que deixe de ser envolvida em um estudo do transtorno psicossomático. Uma ameaça grave de desintegração pode achar-se oculta em uma câibra do pescoço; uma irritação insignificante da pele pode esconder uma despersonalização; o rubor pode ser tudo o que aparece de um fracasso infantil em estabelecer um relacionamento humano através do ato de urinar, talvez porque ninguém o olhe e admire na fase da potência da micção. Ademais, o suicídio pode ser concentrado em uma parte dura do maléolo interno, produzida e mantida por constantes pontapés; delírios de perseguição podem ser clinicamente confinados ao uso de óculos escuros ou ao apertar dos olhos; uma tendência anti-social pertencente a uma privação grave pode apresentar-se como simples enurese; a indiferença a enfermidade incapacitantes ou dolorosas pode constituir um alívio quanto a uma organização sexual sadomasoquista; a hipertensão crônica pode ser o equivalente clínico de um estado psiconeurótico de ansiedade ou de um fator traumático de longa duração, tal como um pai ou uma mãe que são amados, mas são também casos psiquiátricos. Poderia-se prosseguir desta maneira, mas tudo isto constitui terreno familiar.

Minha afirmação é que *estas coisas não constituem, por si próprias, transtorno psicossomático*, e tampouco justificam o uso de um termo especial ou a organização de um *Grupo Psicossomático* dentro da profissão médica e cirúrgica geral. O que faz sentido deste agrupamento é a necessidade que alguns pacientes têm de manterem os médicos em dois ou mais lados de uma cerca, por causa de uma necessidade interna, e também que esta necessidade interior faz parte de um sistema defensivo altamente organizado e vigorosamente mantido, com as defesas voltadas contra os perigos que surgem da integração e da conquista de uma personalidade unificada. Estes pacientes precisam de nós para serem cindidos (mas, contudo, essencialmente unidos nos antecedentes longínquos que não se podem permitir conhecer).

Durante longo tempo fiquei intrigado com os nossos fracassos em classificar as enfermidades psicossomáticas e com nossa incapacidade de enunciar uma teoria, uma teoria unificada deste grupo de moléstias. Quando descobri uma maneira de dizer a mim mesmo o que o transtorno psicossomático realmente é, descobri-me com uma classificação já pronta, que fornecerei (pelo que valha). Primeiro, porém, permitam-me reenunciar minha tese principal, vinculando-a com a teoria do amadurecimento no crescimento individual.

O Elemento Positivo na Defesa Psicossomática

A enfermidade psicossomática é o negativo de um positivo, com este último sendo a tendência no sentido da integração em vários de seus significados, inclusive aquele a que me referi (1963)⁶ como personalização. O positivo é a tendência herdada que cada indivíduo tem de chegar a uma unidade da psique e do soma, uma identidade experiencial do espírito, ou psique, e da totalidade do funcionamento físico. Uma tendência conduz o bebê e a criança no sentido de um corpo que funciona, no qual e a partir do qual se desenvolve uma personalidade que funciona, completa com defesas contra a ansiedade de todos os graus e espécies. Em outras palavras, como Freud disse há muitas décadas atrás, o ego se baseia em um ego corporal. Ele poderia ter

6. "Os Doentes Mentais na Prática Clínica", em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983; London, Hogarth Press, 1965).

continuado dizendo que, *na saúde*, o *self* mantém esta aparente identidade com o corpo e com seu funcionamento. (Toda a complexa teoria da introjeção e da projeção, assim como a conceptualização em torno do termo "objeto interno", constitui desenvolvimento deste tema.)

Este estágio no processo integrador poderia ser chamado de estágio do "EU SOU" (Winnicott, 1965)⁷. Gosto deste nome porque ele me recorda a evolução da idéia do monoteísmo e a designação de Deus como o "Grande EU SOU". Em termos de brinquedos infantis, este estágio é comemorado (embora em idade mais tardia daquela que tenho em mente agora) pelo jogo "Eu sou o rei do castelo; você é o patife sujo". É o significado de "eu" e "eu sou" que é alterado pela dissociação psicossomática.

A cisão entre psique e soma é um fenômeno regressivo que emprega resíduos arcaicos no estabelecimento de uma organização de defesa. Em contraste, a tendência no sentido da integração psicossomática faz parte do movimento para a frente no processo desenvolvimental. A "cisão" é aqui a representante da "repressão", que constitui o termo apropriado em uma organização mais sofisticada.

Classificação

Se isto for verdade, então seria possível classificar a enfermidade psicossomática de acordo com a teoria dos processos de amadurecimento, incluindo duas idéias principais:

1. Um estado primário não-integrado, com tendência no sentido da integração. O resultado depende de
 - Reforço do ego da mãe, baseado em sua capacidade de adaptar-se, fornecendo ao ego do bebê uma realidade na dependência.
 - Fracasso materno, o que deixa o bebê sem os elementos essenciais para o funcionamento dos processos maturacionais.
2. Integração psicossomática, ou a conquista da "morada" da psique no soma, e de que isto venha a ser seguido pela fruição de uma unidade psicossomática na experiência.

No processo de integração, o bebê (no desenvolvimento sadio) ganha um ponto de apoio na posição "EU SOU" ou "rei do castelo" do desenvolvimento emocional e, então, não apenas a fruição do funcionamento do corpo reforça o desenvolvimento do ego, mas este último também reforça o funcionamento do corpo (influencia o tônus muscular, a coordenação, a adaptação às mudanças de temperatura, etc.). O fracasso desenvolvimental nestes aspectos resulta na incerteza da "morada", ou conduz à despersonalização, na medida em que a morada tornou-se um aspecto que pode ser perdido. O termo "morada" é utilizado aqui para descrever a residência da psique no soma pessoal, ou vice-versa.

Na posição "EU SOU" ou "rei do castelo", o indivíduo pode ou não, por razões internas ou externas (e o bebê ainda é altamente dependente), conseguir lidar com a rivalidade que isto engendra ("você é o patife sujo"⁸). Na saúde, a rivalidade se torna um estímulo adicional ao crescimento e ao sabor de viver.

7. Vários Capítulos em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983) e *The Family and The Individual Development* (London, Tavistock, 1965).

8. Esta palavra [sujo] implica aqui: "Você não é (como eu sou) um bebê de útero capaz de integração e autonomia, mas sim um produto excretório de sua mãe, sem forma ou processo maturacional". D.W.W.

Portanto, o transtorno psicossomático relaciona-se a

Ego fraco (a depender grandemente de uma maternagem não suficientemente boa), com um estabelecimento débil de morada no desenvolvimento pessoal;

e/ou

Batida em retirada do EU SOU e do mundo tornado hostil pelo repúdio que o indivíduo faz do NÃO-EU para uma forma especial de cisão que ocorre na mente, mas que se dá ao longo de linhas psicossomáticas.

(Aqui, um detalhe ambiental persecutório real pode determinar a batida em retirada do indivíduo para alguma forma de cisão).

Desta maneira, a enfermidade psicossomática implica uma cisão na personalidade do indivíduo, com debilidade da vinculação entre psique e soma, ou uma cisão organizada na mente, em defesa contra a perseguição generalizada por parte do mundo repudiado. Permanece na pessoa enferma individual, contudo, uma tendência a não perder inteiramente a vinculação psicossomática.

É este, então, o valor positivo do envolvimento somático. O indivíduo valoriza a vinculação psicossomática potencial. Para entender isto, tem-se de lembrar que a defesa é organizada não apenas em termos de cisão, que protege contra o aniquilamento, mas também em termos de proteção da psique-soma quanto a uma fuga para uma existência intelectualizada ou espiritual, ou para façanhas sexuais compulsivas que ignorariam as reivindicações de uma psique que é construída e mantida em uma base de funcionamento somático.

Uma complicação adicional. Naturalmente, quando a personalidade se acha dissociada, as dissociações no meio ambiente são exploradas pelo indivíduo. Exemplo disso seria o uso que se possa fazer de uma tendência na mãe no sentido da desintegração ou despersonalização, da discórdia dos pais, do rompimento da unidade familiar ou do antagonismo (especialmente o antagonismo inconsciente) entre família e escola. Da mesma maneira, faz-se uso das cisões (a que me referi) na questão da provisão médica.

Aqui se pode fazer uma volta à minha idéia principal, que é a de que a existência de um grupo "psicossomático" ou psicossomático de médicos depende da necessidade que o paciente tem de que nos separemos para fins práticos, mas permaneçamos teoricamente unidos por uma disciplina e uma profissão comuns.

Nossa difícil missão é ter uma visão unificada do paciente e da doença, *sem parecer fazê-lo de uma maneira que vá à frente da capacidade que o paciente tenha de alcançar integração em uma unidade*. Com frequência, com muita frequência, temos de nos contentar em deixar o paciente ter e manipular a sintomatologia, em uma relação de alternância com os nossos colegas correspondentes, sem tentar curar a doença real, que é a cisão de personalidade do paciente organizada a partir da debilidade do ego e mantida como defesa contra a ameaça de aniquilamento no momento da integração.

A enfermidade psicossomática, tal como a tendência anti-social, possui este aspecto esperançoso, o de que o paciente se acha em contato com a possibilidade de unidade psicossomática (ou personalização) e dependência, ainda que a sua condição clínica ilustre ativamente o contrário disto através da cisão, de variadas dissociações, de uma tentativa persistente de cindir a profissão médica e do cuidado onipotente do self.

II. Nota Adicional sobre Transtorno Psicossomático

Datado de 16 de setembro de 1969

Já foi apontado que as doenças crônicas da pele acham-se relacionadas, de maneira obscura, ao transtorno psicótico da mente. Obviamente, algumas moléstias crônicas são fisicamente determinadas. A grosso modo, o enunciado é que a irritação ou desconforto crônicos da pele dão ênfase à membrana limitadora do corpo (e, portanto, da personalidade), e que por trás disto acha-se a ameaça de despersonalização e de uma perda das fronteiras corporais, bem como da impensável ansiedade quase física que pertence ao processo inverso do que é chamado integração.

Exemplo desta ansiedade impensável é o estado no qual não existe moldura no quadro; nada para conter o entrelaçamento de forças na realidade psíquica interna e, em termos práticos, ninguém para sustentar o bebê.

Uma paciente, mulher de meia-idade, chegou a um reconhecimento muito completo deste estado de coisas em si mesma e conseguiu adicionar ao quadro clínico certos detalhes que possuem valor para mim, como observador. Juntamente com várias formas de prurite crônica, algumas a aparecerem de modo espontâneo e outras produzidas ou exageradas pelo coçar, a paciente identificou outras maneiras que tinha de manter-se em seu corpo. Se poderia dizer que somente recentemente ela se havia dado conta da ameaça de despersonalização. O que havia sabido era a respeito de sua pele e de seu interesse na doença crônica de pele de um amigo, mas ela também tem uma técnica para repousar que significa que nunca repousa. Na cama, nunca fica parada. Nunca se deita por causa da dificuldade em respirar, a qual mantém através do excesso de fumo. Sempre descansa em algum tipo de posição exagerada, de maneira que está consciente de si mesma em termos físicos. Sempre dá um jeito para que todos os seus músculos se encontrem tensionados. Disse ela: — Não consigo parar. Posso chegar até o ponto de pensar porque faço estas coisas e até mesmo compreender do que se trata, mas tenho de continuar todo o tempo.

Este material foi fornecido pela paciente em um dia no qual descreveu a maneira pela qual se sentia separada de sua família, por não haver sido capaz de fazer-se gostar de uma cerimônia familiar. Sentira que havia sido incapaz de participar do rito religioso que tinha a ver com um novo bebê, porque todo ele se achava vinculado ao momento de separação entre um bebê e a mãe. Associou isto com um pensamento súbito que tivera (enquanto engajada em uma prática obsessiva fútil) de que teria de abandonar a análise porque esta não pode levar a parte alguma. Ela reconheceu de maneira bastante fácil, neste estágio, que não quer que a análise chegue a parte alguma e, a fim de efetuar esse gesto, teve de esquecer o que me dissera na ocasião anterior, qual seja, de que certamente dera recentemente um grande passo à frente e fora capaz de ter um período de tempo em que realmente vivera no presente. Em outras palavras, seus sintomas principais haviam estado temporariamente inativos durante um período de semanas. Por causa da dissociação essencial de sua natureza, ela sabe que está muito doente quando se acha muito enferma, e sabe que está bem quando se sente bem, mas estes dois estados não se vinculam, e, a fim de obter um vínculo, tem de pensar que eu sei a respeito de seus dois estados. Relacionou isto a fracasso no estágio em que a mãe fica sentada, contente e ocupada, mas disponível, enquanto a criança brinca. No extremo da experiência de fracasso no relacionamento bebê-mãe e nas memórias do fracasso vem o grito que a paciente está sempre não-

experienciando. É sempre verdadeiro dizer, quando se passa em revista uma das sessões desta paciente, que, se ela pudesse gritar, ficaria bem. O grande não-acontecimento de todas as sessões é o grito. Naturalmente, não teria qualquer utilidade incentivar a paciente a gritar, e não seria valioso introduzir algo assustador ou prejudicial para provocar o choro. A paciente geralmente sabe que não gritar é o tema principal por trás de todo o material que produz, mas como pode ele alterar este estado de coisas? Sente-se apanhada em uma armadilha, como disse nesta ocasião, e lembra-se do maior choro que teve, ocorrido ao retornar do funeral da mãe, quando recebeu uma carta de sua locadora, a respeito de uma trivialidade qualquer. Esta carta fora suficientemente persecutória, ao chegar no exato momento em que chegou, para produzir algo próximo de um grito, e é um alívio aproximar-se do grito, ainda que com base errada. Ela é sadia demais para conseguir organizar, como alguns pacientes fazem, uma situação paranóide e, então, gritar com medo de alguma ameaça. Com esta paciente, é necessária uma abordagem diferente.

Se tomarmos a situação em que ela é uma criança a brincar enquanto a mãe se acha ocupada com alguma atividade tal como o coser, este é o padrão bom em que o crescimento está se dando. A qualquer momento a criança pode fazer um gesto e a mãe transferirá seu interesse da costura para ela. Se a mãe se acha preocupada e a princípio não nota a necessidade da criança, esta só precisa começar a chorar e logo a mãe se acha disponível. No padrão mau que se encontra na raiz da enfermidade desta paciente, a criança chorou e a mãe não apareceu. Em outras palavras, o grito que ela está buscando é o *último grito que se dá antes de a esperança ser abandonada*. Desde então, o gritar não tem mais uso, por falhar em seu propósito. O melhor que o analista pode fazer neste ponto é fornecer compreensão, pois isto começa a alterar o padrão mau que deteve o crescimento emocional e aponta para o padrão bom, no qual o choro acontecia. A compreensão profunda, por parte do analista, com base no material apresentado por esta paciente, conduz naturalmente no sentido do gritar, isto é, no sentido de gritar de novo, desta vez com esperança.

A relevância disto com relação à parte anterior deste enunciado, que teve a ver com a interação psicossomática, é que o não-acontecimento do não gritar é, em si próprio, uma negação ou expulsão de uma das coisas muito importantes que ligam a psique e o soma, quais sejam, chorar, gritar, berrar, protestar iradamente. Já é possível predizer que esta paciente, ao tornar-se capaz de gritar, terá um fortalecimento imenso do inter-relacionamento psicossomático e uma diminuição da necessidade de empregar a experiência um tanto artificial de interação psicossomática, tal como descrita acima.

Surge naturalmente a pergunta: esta paciente realmente precisa gritar na sessão analítica? A resposta poderia ser sim, mas ela já teve um *sonho* em que acontecia gritar. Juntamente com o sonho, veio-lhe um alívio clínico no estado desperto, ou seja, antes de relatar o sonho, ela relatou que fora capaz de cantar em uma situação comunitária, algo que não fora capaz de fazer durante anos, e também ao mesmo tempo, em seu comportamento na situação transferencial, fora capaz de fazer um ruído, bem como gritar e protestar (de maneira civilizada) quando eu me achava atrasado para a sessão e ela ficava com medo de que eu estivesse doente ou a houvesse esquecido. A chave para a situação, portanto, é o sonho. Mas este só se torna possível em resultado da análise, na qual a esperança a respeito do gritar retorna e é recapturado desde a época anterior à sua doença, quando o padrão bom transformou-se em padrão mau, quer em certo momento de sua época de bebê, quer de modo espalhado através de um período de tempo.

Clinicamente, aparece juntamente com estas mudanças no sentido da interação psicossomática um aumento de interesse, por parte da paciente, na forma de seu corpo e na textura de suas roupas. Constituirá prova direta do sucesso da análise

nesta área se a paciente tornar-se capaz de relaxar na cama e em sua vida desperta, para existir no aqui e no agora, ao invés de em uma lacuna situada entre o passado e o futuro.

Nesta sessão, a paciente referiu-se à sessão anterior, na qual eu lhe havia dado como interpretação o seguinte: "é esse não-grito que se acha no caminho, isto é, o temor de não ser ouvida ou a desesperança a respeito de o gritar produzir um efeito". Disse ela: "Quando você me disse isso, achei cruel. Que utilidade tem dizer-me uma coisa terrível desse tipo?" Eu havia juntado como meu fracasso na transferência, especialmente ao ponto de não me achar disponível quando ela chegara para a sessão anterior. Ela agora disse: "Foi realmente bastante arguto. Não é apenas uma reação física ao grito o que importa, sabe, é a compreensão. O que você disse me pareceu horrível. O fato era que *você* sabia e *eu* não, e esta é a única maneira possível de corrigir o fracasso de o meu último grito ter resultado".

O resto do trabalho desta sessão relacionou-se com a necessidade que esta paciente tem de lidar com o tema da separação em termos simplesmente da cicatriz existente tanto nela quanto na mãe. A parte que unia as duas está faltando em ambas. Esta forma de separação teve de ser plenamente explorada nesta paciente, após o que haverá (como já podemos ver) um retorno à exploração da separação em termos de raiva, mordidas e outras formas de agressão. É aqui que a paciente sabe que se torna uma pessoa total e a mãe igualmente, e as duas podem separar-se sem cicatrizes e sem a mutilação que a paciente toda a sua vida aceitou como evidente e desempenhou papel em sua fantasia de ser uma cidadã de segunda classe, por ser mulher.

Após esta hora, ela capacitou-se a perceber a possibilidade de uma separação quanto ao analista, com ambos permanecendo totais e contendo alguma coisa do outro, bem como capazes de se identificarem um com o outro. Mas estas são questões mais sofisticadas e parecem estar a uma longa distância, neste exato momento do tratamento desta paciente, e do presente, no qual a separação significa cicatrizes e lacunas.

21

A Psicologia da Loucura: Uma Contribuição da Psicanálise

*Trabalho preparado para a
Sociedade Psicanalítica Britânica, outubro de 1965*

A prática da psicanálise durante 35 anos não pode passar sem marcas. Para mim, sucederam mudanças em minha formulação teórica e tentei enunciá-las à medida que se consolidavam em minha mente. Amiúde, o que descobri já fora descoberto e até mesmo melhor enunciado, seja pelo próprio Freud, seja por outros psicanalistas ou por poetas e filósofos. Isto não me detém de continuar a colocar por escrito (e a ler, quando um público se acha disponível) os mais recentes produtos de minha mente.

No momento, acho-me seduzido pela idéia de que a teoria psicanalítica tem algo a oferecer com relação à teoria da loucura, isto é, a loucura que clinicamente se encontra quer sob a forma de um medo da loucura, quer sob algum outro tipo de manifestação insana. Gostaria de tentar enunciar isto, ainda que descubra que estou apenas enunciando o (psicanaliticamente) óbvio.

Possuímos a única formulação realmente útil, que existe, da maneira pela qual o ser humano psicologicamente se desenvolve de um ser completamente dependente e imaturo para um estado maduro relativamente independente. A teoria é excepcionalmente complexa e difícil de ser enunciada de modo sucinto, e sabemos que existem grandes lacunas no nosso entendimento. Apesar disto, existe a teoria, e, desta maneira, a psicanálise efetuou uma contribuição que é de modo geral aceita, mas usualmente, não-reconhecida.

Com freqüência foi dito, com referência à teoria psicanalítica, que no desenvolvimento da criança normal há um período de psicose. Uma afirmação mais correta seria que, no auge da fase do complexo edipiano, antes do início do período de latência, é de se esperar todo tipo de sintoma sob forma passageira. De fato, a "normalidade", nesta faixa etária, pode ser descrita nos termos desta sintomatologia, de maneira que a anormalidade torna-se relacionada à ausência de algum tipo de sintoma ou à canalização da sintomatologia em determinada direção. É a rigidez das defesas que constitui a anormalidade nesta fase, não as próprias defesas. Estas não são anormais e estão sendo organizadas pelo indivíduo lado a lado com o seu surgimento desde a dependência, no sentido da existência independente baseada em um senso de identidade. Isto vem para o primeiro plano de maneira nova e importante na adolescência.

É nesta fase que a provisão cultural, tal como se manifesta no meio ambiente imediato da criança ou na configuração familiar, altera a sintomatologia, embora,

naturalmente, não produza as pulsões e as ansiedades subjacentes a ela. Aquilo a que nos referimos como sendo sintomas neste contexto, não deve ser chamado desse modo na descrição de uma criança, por causa do fato de a palavra "sintoma" ter conotações de patologia. Duas questões laterais à este tema podem ser mencionadas. Uma que é muito interessante é apresentada por Erik Erikson, que mostra que as comunidades podem moldar o que está sendo aqui chamado de sintomatologia em direções que acabarão por ser valiosas para a comunidade localizada¹. A segunda diz respeito ao efeito de um colapso do meio ambiente imediato da criança neste estágio, de maneira que, de fato, ela não é capaz de apresentar a sintomatologia variada que é apropriada, mas tem de se conformar ou assumir uma identificação com algum aspecto do meio ambiente, perdendo por isso experiência pessoal.

O tema da sintomatologia polimorfo-perversa da infância, que foi descrita por Paula Heimann², aplica-se nesta ampla área das manifestações que pertencem ao período de pré-latência e que seriam denominadas sintomas, viessem elas a aparecer clinicamente quando o indivíduo houvesse atingido a idade em que se espera seja adulto. Pode-se entender como surgiu a idéia de que, na teoria psicanalítica, todas as crianças eram psiconeuróticas, mas a um exame mais atento, descobrimos que isto não faz parte da teoria. Apesar disso, somos capazes de diagnosticar enfermidades em crianças desta idade que têm de ser chamadas de psiconeuróticas, porque não são psicóticas, e descobrimos que a base de nosso diagnóstico não é a observação da sintomatologia, mas sim uma avaliação cuidadosamente considerada da organização da defesa, especialmente a sua rigidez generalizada ou local.

Com a ampliação em retrospectiva da teoria psicanalítica, e todos os novos trabalhos sobre psicologia do ego e sobre o estágio da dependência absoluta do bebê quanto à mãe, etc., chegamos a um novo tema. Atingimos variadas teorias que vinculam a prática psicanalítica à terapia da psicose. Neste contexto, por "psicose" se quer dizer uma enfermidade que tem seu ponto de origem nos estágios do desenvolvimento individual anteriores ao estabelecimento de um padrão individual de personalidade. Obviamente, o apoio do ego da figura ou figuras dos pais é da máxima importância neste estágio muito inicial, mas que, apesar disso, pode ser descrito em termos do bebê individual, a menos que exista distorção causada por fracasso ambiental ou anormalidade.

A psicanálise chega agora à consideração da etiologia da enfermidade que pertence ao território da esquizofrenia (note-se que, neste contexto, é necessário pular sobre os problemas da etiologia da tendência anti-social e da depressão, cada uma das quais precisa de tratamento separado.)

Existe grande resistência, especialmente entre psiquiatras que não são psicanaliticamente orientados, à idéia da esquizofrenia como sendo psicológica, isto é, pelo menos teoricamente capaz de prevenção ou cura. Em qualquer dos casos, os psiquiatras têm os seus próprios problemas. Todo psiquiatra possui uma carga imensa de casos grave. Está sempre ameaçado pela possibilidade de suicídio entre os pacientes que se acham a seu cuidado imediato e existem pesados ônus associados com a tomada de responsabilidade pela certificação e decertificação, bem como com a prevenção de coisas tais como o assassinato e o mau trato de crianças. Além disso, o psiquiatra tem de lidar com a pressão social, uma vez que todos aqueles que precisam de proteção quanto a si próprios ou precisam ser isolados da sociedade inevitavel-

1. Erik H. Erikson, *Childhood and Society* (New York, Norton, 1950).
2. Paula Heimann, *A Contribution to the Re-Evaluation of the Oedipus Complex: The Early Stages*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 33 (1952); também em *New Directions in Psycho-Analysis*, de autoria de Melanie Klein et al. (London, Karnac Books, 1977).

mente vêm acabar sob os cuidados dele e, ao final, não pode recusá-los. Ele pode recusar um caso, mas isto só significa que alguém mais terá de aceitá-lo. Dificilmente se pode esperar que a psiquiatria dê boas-vindas a um estudo do paciente psicótico individual quando um estudo desse tipo parece demonstrar que a etiologia da enfermidade não é inteiramente de herança, embora esta e os fatores constitucionais sejam com frequência importantes.

A tendência do estudo psicanalítico da psicose, contudo, é no sentido da teoria da origem psicológica. Surpreendentemente, parece que, nas psicoses, existe não apenas o fator de herança, mas também um fator ambiental que opera no estágio mais inicial, ou seja, quando a dependência é absoluta. Em outras palavras, as tensões e os estresses internos que pertencem à vida e são inerentes ao viver e ao crescer, parecem ser tipicamente encontrados na normalidade que se relaciona à psicose, com esta última constituindo prova de fracasso. Em comparação, escavando-se a etiologia do paciente psicótico, chega-se a dois tipos de fator externo, a hereditariedade (que, para o psiquiatra, é algo externo) e a distorção ambiental na fase da dependência absoluta do indivíduo. Em outras palavras, a psicose tem a ver com distorções ocorridas durante a fase da formação do padrão de personalidade, enquanto que a psicose pertence às dificuldades que são experienciadas por indivíduos cujos padrões de personalidade podem ser tomados como evidentes, no sentido de serem suficientemente formados e saudáveis.

A teoria ou teorias extremamente complexas do desenvolvimento infantil muito inicial levou o público observador a indagar uma questão que é semelhante à pergunta "Todas as crianças são neuróticas?". A nova pergunta é: "Todo o bebê é louco?" Esta é uma questão que não pode ser respondida em poucas palavras, mas a primeira resposta deve certamente ser negativa. A teoria não envolve a idéia de uma fase de loucura no desenvolvimento infantil, mas apesar disso, deve-se deixar aberta a porta para a formulação de uma teoria em que uma certa experiência de loucura, seja o que for que isto possa significar, é universal, e isto quer dizer ser impossível pensar em uma criança que tenha sido tão bem cuidada em sua primeiríssima infância que não houve ocasião para uma tensão excessiva de sua personalidade, tal como se achava integrada em determinado momento. Tem-se de conceder, contudo, que, muito grosseiramente falando, existem dois tipos de seres humanos, quais sejam, aqueles que não têm consigo uma experiência significativa de colapso mental na primeiríssima infância e aqueles que a têm, e que portanto, dela precisam fugir, flertar com ela, temê-la, e, até certo ponto, estar sempre preocupados com sua ameaça. Pode-se dizer, e com verdade, que isto não é justo.

É importante enunciar este fato, o de que o estudo psicanalítico da loucura, seja o que for o que signifique, está sendo efetuado principalmente com base na análise dos que são chamados de casos limítrofes [*borderline*]. Não é provável que os progressos na compreensão da psicose provenham do estudo direto do paciente insano e muito gravemente sucumbido. Na atualidade, portanto, o trabalho dos analistas achase aberto à crítica de que o que é verdadeiro para o caso *borderline* não se aplica ao caso de colapso ou de loucura organizada. Indubitavelmente, se descobrirá que existem diferenças significativas entre a loucura — que é às vezes acessível ao exame e até mesmo ao tratamento no caso limítrofe — e a loucura do caso de colapso total. Apesar disso, por enquanto, tem-se de fazer o trabalho que pode ser feito e ele pode ser um desenvolvimento natural da aplicação da técnica psicanalítica aos aspectos mais profundamente perturbados das personalidades de nossos pacientes.

Parece improvável que exista uma loucura que pertença inteiramente ao presente. Esta maneira de encarar a loucura recebeu um importante reforço dos trabalhos efetuados sobre a paralisia geral do insano. Esta doença é causada por uma enfermidade física do cérebro e, no entanto, é possível perceber na psicologia do paciente uma

moléstia que pertence especificamente a esse paciente e à sua personalidade e caráter, e os detalhes relacionam-se à história inicial do paciente. Da mesma maneira, um tumor no cérebro pode produzir uma doença mental que se assemelhará a uma enfermidade psiquiátrica que se achava latente nesse indivíduo, mas que não se teria tornado manifesta não fosse a moléstia física.

Caso: Um menino, aos meus cuidados, foi trazido ao hospital porque estava começando a ser intimidado pelos outros na escola. Ele desenvolveu esta tendência de modo muito constante e gradual e foi esse desenvolvimento constante que chamou a atenção para o fato de que poderia existir uma causa física para a enfermidade. Em poucos meses contados do começo indefinido, ele se tornara uma pessoa que provocava a perseguição e o castigo. Estava sofrendo de um cisto da sela túrcica e, à medida que este aumentava de tamanho, dando origem à pressão intercranial, com edema de papila, ele se tornou um caso paranóide rematado. Após a retirada do quisto, gradativamente retornou a ser o que era antes do desencadeamento da doença, inteiramente livre da tendência paranóide. O cisto não pôde ser inteiramente retirado e, após alguns anos, houve um retorno da doença, juntamente com um novo crescimento do quisto.

Atualmente, Ronald Laing e seus colaboradores estão chamando a nossa atenção para a maneira pela qual a esquizofrenia pode ser o estado normal de um indivíduo em crescimento ou que cresceu em um meio ambiente dominado por pessoas com traços esquizofrênicos. Seu material clínico é muito convincente, mas, de momento, ele falha em levar a lógica de sua atitude a uma consideração da mesma coisa em termos do relacionamento parento-filial no período de dependência absoluta ou quase absoluta. Estendesse ele seu trabalho nessa direção, descobriria que o que está apresentando é ainda mais verdadeiro, e chegaria perto de efetuar um enunciado importante com referência à etiologia da esquizofrenia. Nesse meio-tempo, está fazendo observações significantes a respeito de certos pacientes esquizofrênicos e seu trabalho já pode ser aplicado no campo do tratamento de administração de algumas pessoas mentalmente enfermas que são rotuladas de esquizofrênicas.

Em meu trabalho "Psicose e Cuidado Infantil"³, que apresentei em 1952, surpreendi a mim mesmo dizendo que a esquizofrenia é uma doença de deficiência ambiental, isto é, uma enfermidade que depende mais que a psicose de certas anormalidades ambientais. É verdade que há também fatores herdados poderosos em alguns casos de esquizofrenia, mas deve-se recordar que, do ângulo puramente psicológico, fatores herdados são ambientais, isto é, externos à vida e à experiência da psique individual. Nesse artigo, estava me aproximando do enunciado a respeito da loucura, que desejo fazer aqui e agora.

Em minha abordagem a meu tema central, mas muito simples, quero incluir também a idéia do medo da loucura. Isto é algo que domina a vida de muitos de nossos pacientes. Sobre este tema escrevi que se pode tomar como axioma que a loucura que é temida já foi experienciada⁴. Em minha opinião, esta afirmação contém uma verdade importante, mas contudo, ela não é inteiramente verdadeira. Torna-se necessária uma modificação do enunciado e isto me levará ao âmago de minha comunicação.

3. Em *Collected Papers: Through the Pediatrics to Psycho-Analysis* (London, Tavistock, 1958; New York, Basic Books, 1975; London, Hogarth Press, 1975).

4. "Classificação: Existe uma Contribuição Psicanalítica à Classificação Psiquiátrica?" (1959-1964, em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983; London, Hogarth Press; International Universities Press, 1965). Ver também o Capítulo 18 deste volume, "O Medo do Colapso".

Para continuar com o tema nestes termos, um número significativamente grande de pessoas, algumas das quais entram em análise ou colocam-se sob cuidados psiquiátricos, vivem em um estado de medo que pode ser remontado a um medo da loucura. Ele pode assumir a forma de medo da incontinência ou medo de gritar em público, pode ser pânico ou medo do pânico, que é ainda pior, e pode ser uma sensação de calamidade imminente, bem como variados outros medos muito graves, e cada um deles contém um elemento que se acha fora do funcionamento da lógica. Um paciente, por exemplo, pode ser dominado por um medo de morrer que nada tem a ver com o medo da morte, mas é inteiramente uma questão de um medo de morrer sem que ninguém se encontre junto a ele na ocasião, isto é, sem ninguém junto a ele que se interesse por alguma maneira derivada diretamente do relacionamento parento-filial muito inicial. Pacientes desse tipo podem organizar a vida de maneira a jamais se acharem sós.

Ao tentar receber a comunicação que estes pacientes tentam fazer quando lhes damos chance, como fazemos especialmente na psicanálise, o que encontramos assemelha-se a um medo da loucura que virá. É de valor para nós, se é que não o é realmente para o paciente, saber que o medo não é da loucura por vir, mas da loucura que já foi experienciada. É um medo do retorno da loucura. Se poderia esperar que uma interpretação ao longo destas linhas aliviasse a situação, mas, na realidade, é improvável que produza alívio, exceto na medida em que o paciente obtém alívio de uma compreensão intelectual do que tem probabilidade de aparecer no curso da análise ulterior. A razão pela qual o paciente não obtém alívio é que ele tem interesse em recordar a loucura que foi experienciada. Na realidade, grande quantidade de tempo pode ser gasta em relembrar e reviver exemplos de loucura que se assemelham a lembranças encobridoras. A necessidade do paciente é recordar a loucura original, mas, na realidade, esta pertence a um estágio muito inicial, anterior à organização no ego daqueles processos intelectuais que podem abstrair experiências que foram catalogadas e apresentá-las para uso em termos de lembrança consciente. Em outras palavras, a loucura que tem de ser lembrada só pode ser lembrada em seu reviver. Naturalmente, há dificuldades muito grandes quando um paciente tenta reviver a loucura e uma das maiores é encontrar um analista que entenda o que está acontecendo. É muito difícil para o analista, no presente estado de nosso conhecimento, lembrar neste tipo de experiência que é objetivo do paciente chegar à loucura, isto é, ser louco no *setting* analítico, a coisa mais próxima que o paciente pode jamais fazer para lembrar. A fim de organizar o *setting* para isto, ele às vezes tem de ser louco de maneira mais superficial, ou seja, tem de organizar o que a Dra. Little chama de transferência delirante⁵, e o analista tem de recebê-la, aceitá-la e compreender o seu desempenho.

Exemplificando, uma menina que se acha na escola traz para a análise a idéia de que lhe estão dando excessivo trabalho de casa e que está sendo pressionada demais na escola. Traz isto como material muito urgente o qual a ajuda a chegar a um extremo de agonia, com uma dor de cabeça séria e horas a gritar. Ela conseguiu me dizer que, na realidade, sua professora não a está pressionando demais e, também, que não lhe deram trabalho de casa em excesso. Não me é sequer possível, ao fazer interpretações, falar a respeito da idéia de um professor rigoroso, que exige demais de sua aluna. Em termos da professora e do trabalho de casa, a paciente está me dizendo que estou exigindo demais dela e que qualquer palavra saída de mim, mesmo uma interpretação

5. Margaret I. Little, *On Delusional Transference (Transference Psychosis)*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 39 (1958); também em Little, *Transference Neurosis and Transference Psychosis* (New York, London: Jason Aronson, 1981).

correta, é uma perseguição. O sentido deste exercício é que, sem ser louca demais no sentido secundário, esta paciente é capaz então de chegar à reexperiência da loucura original, ou, pelo menos, chega a um extremo de agonia que é vizinho de porta dessa loucura.

Num caso como esse, qualquer tentativa por parte do analista de ser *são* ou lógico, destrói o único caminho que a paciente pode forjar de volta à loucura que necessita ser recuperada na experiência, por não poder ser recuperada na lembrança. Desta maneira, o analista tem de ser capaz de tolerar sessões inteiras ou até mesmo períodos de análise em que a lógica não é aplicável em qualquer descrição da transferência. O paciente acha-se então sob uma compulsão — surgida de alguma *premência básica que os pacientes têm no sentido de tornarem-se normais* — de chegar à loucura e essa compulsão é ligeiramente mais poderosa do que a necessidade de afastar-se dela. Por esta razão, não há um desfecho natural, à parte o tratamento. O indivíduo acha-se para sempre apanhado em um conflito, delicadamente equilibrado entre o medo da loucura e a necessidade de ser louco. Em alguns casos, é um alívio quando o trágico acontece e o paciente fica louco, porque, ao admitir-se uma recuperação natural, o paciente, até certo ponto, “recordou” a loucura original. Isto, contudo, nunca é completamente verídico, mas pode ser verdadeiro o suficiente, de maneira que um alívio clínico é obtido pelo fato do colapso. Pode-se ver, que se, em tal caso, o colapso é atendido por uma premência psiquiátrica à cura, todo o sentido do colapso é então perdido, pois, ao entrar em colapso, o paciente tinha um objetivo definido e o colapso não é tanto uma enfermidade quanto um primeiro passo no sentido da saúde.

Neste ponto, é necessário recordar o pressuposto básico, pertencente à psicanálise, de que as defesas se organizam em torno da ansiedade. O que vemos clinicamente quando encontramos uma pessoa enferma é a organização das defesas e sabemos que não podemos curar o nosso paciente através da análise das defesas, embora grande parte de nosso trabalho se dedique a fazer exatamente isso. A cura só chega se o paciente pode chegar à ansiedade em torno da qual as defesas foram organizadas. Podem haver muitas versões subseqüentes disto, e o paciente chega a uma após outra, mas a cura só chega se o paciente atingir o estado original de colapso.

É agora necessário tentar enunciar o que se acha errado com o enunciado do axioma de que o medo da loucura é o medo da loucura que foi experienciada. Primeiro, é necessário ser inteiramente claro a respeito de determinado ponto, qual seja, o de que as palavras “o medo da loucura” ordinariamente referir-se-iam ao temor que alguém possa ter ou deva ter do pensamento da insanidade; não apenas o horror da doença em si, com todo o sofrimento mental nela envolvido, mas também o efeito social sobre o indivíduo e até mesmo sobre a família, do fato do colapso mental, que a comunidade teme e, portanto, odeia. Este é o significado óbvio das palavras que estão sendo empregadas aqui, sendo necessário apontar que, neste estudo específico, elas estão sendo usadas de modo diferente. Estas mesmas palavras estão sendo utilizadas para descrever o que podemos descobrir a respeito da motivação inconsciente em pacientes que estiveram em análise por longo tempo e que se tornaram, por um meio ou outro, talvez mediante a passagem do tempo e o processo de crescimento, capazes de tolerar e lidar com ansiedades que eram impensáveis em seu *setting* original.

Em segundo lugar, há algo de errado com o enunciado, mesmo no *setting* especializado em que está sendo fornecido neste Capítulo. Não é realmente verdadeiro dizer que o paciente está tentando recordar a loucura que houve e em torno da qual defesas se organizaram. A razão disto ser assim é que, no lugar original em que as defesas se organizaram, a loucura não foi experienciada, porque, pela natureza do que está sendo debatido, o indivíduo não foi capaz de experienciá-la. Surgiu um estado de coisas a envolver um colapso das defesas, defesas que foram apropriadas na idade

e no *setting* do indivíduo. O apoio do ego por parte de uma figura genitorial tem de ser levado em consideração aqui, com referência a ter sido ele um apoio confiável ou inconfiável. No caso mais simples possível, houve portanto uma fração de segundo em que a ameaça da loucura foi experienciada, mas a ansiedade neste nível é impen-sável. Sua intensidade acha-se mais além da descrição e novas defesas organizam-se imediatamente, de maneira que a loucura, de fato, não foi experienciada. Por outro lado, contudo, ela foi potencialmente um fato. Tentando encontrar uma analogia, vi um bulbo de jacinto a ser plantado em uma tigela. Pensei: há um odor maravilhoso trancado naquele bulbo, embora soubesse, naturalmente, não existir um lugar no bulbo em que o odor se ache trancado. A dissecação do bulbo não proporcionaria a quem a fizesse, a experiência de uma fragrância de jacinto, se o lugar apropriado estivesse por ser alcançado. Apesar disso, existe no bulbo um potencial que acabará se tornando no perfume característico, quando a flor se abrir. Isto não passa de uma analogia, mas poderia transmitir um retrato do que estou tentando enunciar. Faz parte importante de minha tese que a loucura ou o colapso de defesas originais, se viesse a ser experienciado, seria indescritivelmente doloroso. O mais próximo que dele podemos chegar é tomar o que se acha disponível na ansiedade psicótica, tais como:

- a. desintegração;
- b. sentimentos de irrealidade;
- c. falta de relacionamento;
- d. despersonalização ou falta de coesão psicossomática;
- e. funcionamento intelectual ex-cindido;
- f. queda eterna;
- g. terapia eletroconvulsiva (ECT)*, com pânico como sentimento generalizado, o que pode conter qualquer um dos acima mencionados.

Apesar disso, podemos observar, que sempre que chegamos clinicamente a qualquer uma dessas coisas, sabemos que existe alguma organização do ego capaz de sofrer, o que significa prosseguir sofrendo de maneira a ficar ciente do sofrimento. Tem-se de tomar o cerne da loucura como sendo algo muito pior, por causa do fato de que ele não pode ser experienciado pelo indivíduo, que, por definição, não possui a organização de ego para sustentá-lo e, dessa maneira, experienciá-lo.

Pode valer a pena utilizar um símbolo, X, e dizer que o bebê ou a criança pequena possuem uma organização do ego apropriada ao estágio de desenvolvimento e que algo acontece, tal como uma reação a uma invasão ou choque (um fator externo que se permitiu passar, por causa de um funcionamento ambiental falho), e que então ocorre um estado de coisas chamado X. Este estado pode resultar em uma reorganização das defesas. Isso pode acontecer uma ou muitas vezes, ou, talvez, muitas vezes em um determinado padrão. Da organização das defesas fica-se com um quadro clínico e o diagnóstico é efetuado com base na organização defensiva. Esta, por sua vez, depende até certo ponto, para suas características, de uma contribuição oriunda do meio ambiente. O que é absolutamente pessoal ao indivíduo é X.

Chego agora a uma tentativa de reenunciar o axioma original. O indivíduo que chega a estas coisas no curso de um tratamento está repetidamente tentando alcançar X, mas naturalmente, ele só pode chegar tão perto de X quanto a nova força do ego, mais o apoio ao ego na transferência, possa tornar possível. A continuação da análise significa que o paciente continuamente chega a novas experiências na direção que leva

* ECT corresponde às iniciais da expressão inglesa para terapia eletroconvulsiva. A sigla em português corresponderia à TEC, mas considera-se o termo original já familiar na literatura de língua portuguesa. (N. dos R.)

a X e, da maneira que descrevi, essas experiências não podem ser lembradas como lembranças. Elas têm de ser vividas no relacionamento transferencial e, clinicamente, aparecem como loucuras localizadas. Constantemente o analista fica perplexo por descobrir que o paciente é capaz de ficar cada vez mais louco durante alguns minutos ou por uma hora no *setting* do tratamento e, às vezes, a loucura se espalha por sobre os limites da sessão. Exige considerável experiência e coragem saber onde se está, nas circunstâncias, e perceber o valor que tem, para o paciente, chegar cada vez mais perto do X que pertence a esse paciente individual. Entretanto, se o analista não for capaz de olhar para isso dessa maneira, — mas por medo, por ignorância ou pela inconveniência de ter em suas mãos um paciente tão enfermo, tende a desperdiçar estas coisas que acontecem no tratamento —, ele não poderá curar o paciente. Ele constantemente se descobre corrigindo a transferência delirante ou, por uma maneira ou outra, trazendo o paciente de volta à sanidade, ao invés de permitir que a loucura se torne uma experiência administrável, da qual o paciente possa efetuar uma recuperação espontânea. Encarada desta maneira, a psiquiatria que se baseia no atendimento da necessidade social e no tratamento de grande número de pacientes acha-se, na atualidade, em uma fase de combater o inimigo errado, algo que é trazido à tona no trabalho de Ronald Laing e seus colaboradores. Não importa acharmos que não podemos sempre concordar com a teoria deles ou com a apresentação que fazem de sua teoria. De qualquer modo, a minha tese neste trabalho compele-me a dar as boas-vindas a muitas das afirmações desses trabalhadores no campo.

É lamentável que a teoria que estou apresentando aqui, mesmo que esteja correta, certamente não conduza a um passo imediato à frente no que tange a afetar a psicoterapia. Aqueles que estão encontrando estes problemas em suas práticas psicanalíticas não acharão que este detalhe da teoria lhes torne possível efetuar amanhã um trabalho melhor. Na realidade, na melhor das hipóteses, pode fornecer-lhes uma certa compreensão e, naturalmente, levá-los a águas mais profundas. Apesar disso, há alguns casos em que o paciente continua a tentar obter auxílio de nós, mas contudo, não podemos chegar a um ponto final satisfatório. Naturalmente, estes casos são de vários tipos e um dos tipos que estou sugerindo pode ser melhor entendido com base na tese que estou apresentando, e uma das vantagens aqui é que, se o analista entende o que está se passando, ele se capacita a tolerar as tensões muito consideráveis pertinentes a este tipo de trabalho. Infelizmente, há apenas uma maneira de evitar essas tensões, qual seja, um diagnóstico melhor que evite aceitar-se o tipo de caso que inevitavelmente conduza a essas águas profundas. Então, se descobrirmos um método pelo qual possamos evitar aceitar esses casos, temos de ser honestos e admitir em alta voz que precisamos, mesmo em nossa teoria, do auxílio psiquiátrico que de certa maneira desprezamos por não basear-se na psicologia, isto é, nos tratamentos físicos. Ocorreu-me, talvez erradamente, que de uma aceitação geral desta idéia que estou anunciando, quando ela chegar à literatura técnica que é lida pelo público pensante, possa provir algum alívio. É impossível prever, mas me parece existir uma grande quantidade de medo do colapso e, se pudesse vazar que o colapso que é temido é um colapso que já causou o pior, há pelo menos a possibilidade de limar os bordos deste medo.

O Conceito de Trauma em Relação ao Desenvolvimento do Indivíduo dentro da Família

*Amálgama de duas versões semelhantes de um ensaio
escrito em março e maio de 1965*

A vasta área coberta pela expressão "a família" já foi estudada de muitas maneiras. Aqui, se fará uma tentativa de relacionar a função da família à idéia de trauma, e isto tem de envolver um estudo do trauma como conceito em metapsicologia. O vínculo entre as duas idéias é que a família fornece à criança que cresce uma *proteção quanto ao trauma*.

Abordarei primeiro o problema do trauma desde o ângulo clínico e, depois, debatarei sucintamente a sua teoria.

Um Trauma que Envolveu uma Paciente

Áchava-me empenhado na análise e administração do caso de uma criança, uma menina a chegar à idade da puberdade e que tinha uma incapacidade física entrelaçada com o seu distúrbio emocional. Tive a sorte de ter esta menina em bons cuidados pediátricos durante o período de tempo em que um tratamento acessório, ao longo de linhas físicas, foi necessário, e consegui manter-me em contato íntimo com ela durante o período de hospitalização.

Por causa de minha posição especial, soube da menina que um pervertido adulto andava visitando a enfermaria de crianças, apesar do cuidado usual que é tomado em um bom hospital infantil. Achei isto difícil de acreditar e, a princípio, tendi a considerar a suspeita que a menina tinha de estar alucinando. Relatei imediatamente, contudo, o que me havia sido contado por ela e, ao final, tornou-se claro que tudo o que havia contado havia estado realmente acontecendo.

Naturalmente, quis que essa menina fosse para casa, porque, como repentinamente se tornou óbvio, a família e o lar de uma criança melhor a protegem contra o trauma. Mas ela própria foi incapaz de considerar, quer a remoção para sua casa, quer a transferência para ambientes alternativos do hospital. Na realidade, o único procedimento foi, para mim, primeiro recuperar-me do trauma eu próprio e, depois, permitir que o hospital lidasse com o problema à sua maneira. Havendo sido estabelecidos os fatos, o hospital rapidamente entrou em ação e um senso de segurança foi restabelecido.

A menina, na ocasião, estava produzindo material que demonstrava achar-se ela no estágio pré-púbere. Exemplificando, um desenho significativo mostrava uma menina sem sofisticação, com um vestido de folhas costuradas, sendo ensinada a dançar por um leopardo negro. As mãos dela achavam-se estendidas, na mão direita duas maçãs que acabara de colher para comer e um pássaro azul na mão esquerda. O contraste entre a inocente menina e o leopardo potencialmente sinistro da sexualidade que se pode encontrar nesta fase pré-sexual. Foi neste estágio do desenvolvimento da menina que o perverso apareceu em sua vida e todas as crianças da enfermaria do hospital ficaram em perigo. Se poderia dizer que apenas esta menina entendeu o perigo; todas as outras trataram o assunto ficando excitadas de modo geral, com medo de fantasmas ou esperando que todo barulho significasse um homem a entrar pela janela. Minha paciente achava-se em posição especial, por ser capaz de relatar a mim todos os detalhes e é de se notar que não podia contar aos pais (em quem certamente confia) o que estava acontecendo. A princípio, não podia sequer contá-lo às enfermeiras e, quando o contou a uma delas, o assunto não foi levado a sério nem, tampouco, relatado à enfermeira-chefe. Até mesmo o genitor de uma das outras crianças não o levou a sério.

De fato, é quase impossível pensar em um perverso na enfermaria infantil de um hospital, à noite. A denegação é a reação natural, ou, alternativamente, uma frenética atividade reativa. Os pais deixam os filhos em hospitais apenas por um processo de idealização do hospital e do quadro de pessoal e, em minha longa experiência com hospitais infantis, os médicos, as enfermeiras e o pessoal auxiliar não apenas se comportam de modo confiável, mas também, na realidade, tentam reproduzir as condições pertinentes à família, condições projetadas para proteger as crianças quanto a traumas grosseiros. Infelizmente, esta proteção quanto ao trauma grosseiro não abrange a proteção quanto aos traumas mais sutis, que podem ser piores para as crianças e os bebês do que aqueles traumas grosseiros que chocam os adultos, quando ocasionalmente acontecem. Um trauma grosseiro, do tipo do ocorrido neste caso, é impedido na família pelos tabus contra o incesto, que geralmente funcionam.

Minha paciente fez o comentário: "Não é justo". Só podia concordar com ela e lhe disse isso. Ela não pôde colocar em palavras a natureza completa do trauma, o fato de que a doce inocência que pertence à fase de seu desenvolvimento emocional e que ela, de modo inteiramente correto, retratou em termos de balé, estava sendo estragada pela introdução prematura da sexualidade de um homem, isto é, de uma segunda pessoa objetivamente percebida. A imagem subjetiva do leopardo subitamente se transforma no que a menina chamou de "um homem sendo malvado". Ela conseguiu acrescentar que ele poderia realmente ser uma pessoa inteiramente humana, talvez solitária, mas era certamente malvada no contexto do trauma e da experiência que ela teve deste.

Posso acrescentar que este trauma não maculou a "inocência" desta menina, em grande parte por causa do fato de ela se achar intimamente em contato comigo, uma pessoa profissionalmente envolvida, alguém em quem, havia descoberto, podia confiar por maneiras tanto grosseiras quanto sutis. Não posso dizer, contudo, que as outras crianças não tenham sido machucadas. E, naturalmente, o fato de ela possuir sua própria família e confiar absolutamente em todos os membros dela foi o fator constante que a capacitou a acreditar em mim e utilizar-me.

Não haver sido a minha paciente adversamente afetada também se deve ao fato de que, em sua análise, foi importante o trauma muito sutil, e não o trauma grosseiro, bem como ela ter podido me usar. Para ilustrar isto, forneço um exemplo de uma sessão típica que continha um movimento para a frente:

A paciente reclinou-se no divã como de costume e falou muito suavemente disto e daquilo. Eu precisa ficar (como era usual com ela) muito próximo a fim de conseguir ouvir. Nesses momentos, ela fica muito sensível a quaisquer mudanças na sala e tenho de evitar perturbá-la fazendo mudanças descuidadas. Por muitas maneiras, a paciente precisa ter-me sob o seu controle e tenho de lhe dar atenção plena. Sigo suas necessidades alterando o calor da lareira exatamente como ela quer ou abrindo ou fechando a janela e, talvez, suprimindo-a de lenços de papel e outros objetos que ela sabe acharem-se disponíveis. Estando as condições quase perfeitas, ela começa a querer que eu fale, mas não existe material para usar e sei (pela experiência passada) que, se falar, acabarei por perturbá-la. Digo, mal importa o quê: — Você precisa que eu fique sob seu controle, como se uma parte de você... Antes que vá mais longe ela já se acha freneticamente perturbada. Enrosca-se e se retrai e fica inconsolável: Chora e está, claramente, *profundamente ferida*. Há agora um fator tempo envolvido, de maneira que não posso parar até que saiba que a fase passou; tem-se de permitir que esta chegue a uma conclusão natural.

Sou auxiliado por meu entendimento teórico do que a Dra. Margaret Little chama de transferência delirante¹. Não tenho de trazer à conversa nada de grosseiro, tal como a questão deste pervertido e a sua invasão da enfermaria das crianças. Tudo o que preciso fazer é aceitar o papel que me foi atribuído. Desta maneira, dentro do âmbito de uma poderosa transferência positiva, a menina fica ferida e tenta atingir a aflição e o choro a que não pode chegar por si própria. Ao final, a fase se resolve e a paciente torna-se capaz de dizer: "Você pareceu estar zangado comigo quando disse..."

Ela estava então emergindo de um episódio paranóide, que tinha a seguinte configuração:

1. Eu estava me encaixando com sua idéia de uma pessoa que se acha em seu controle onipotente, quase parte dela.
2. "Movimentei-me" muito ligeiramente e de imediato fiquei fora de seu controle.
3. A parte seguinte era inconsciente; ela me odiava.
4. Ela sabia que eu era um perseguidor.
5. Ela percebeu que isto tinha sido um delírio.
6. Tornou-se então capaz, de maneira muito reduzida, de tentar alcançar (3) o ódio de mim (em que confiava) por minha minúscula excursão fora da área de sua onipotência.

Nesta experiência, a paciente sentira-se real por causa da aflição e do choro. Ela *sempre se sente horrível*, mas, durante um quarto de hora, sentira-se horrível *a respeito de alguma coisa*.

Já estava na hora de a sessão (prolongada, nesta ocasião, em dez minutos) terminar e a paciente preparou-se para ir. Este tipo de sessão, com uma aflição máxima, traz-lhe alguma satisfação, enquanto que outras sessões parecem-lhe irreais, especialmente se permitiu-se ter prazer em alguma atividade e fazer-me ter prazer, dessa maneira ficando com uma falsa impressão de que tudo está bem com ela. Tudo não está bem.

E agora, quando ela se ia, dei-me conta de que ela sabia, de início, que tudo isto estava sujeito a acontecer. Quando a sessão começara, ela dissera: "Queria que esta fosse uma das vezes em que era Mamãe quem deveria vir buscar-me". Eu conhecia bem este sinal e estivera portanto preparado para o que aconteceria, embora não pudesse dizer qual a forma que o delírio desse dia assumiria. Minha tarefa era primeiro cooperar com o processo de sua idealização de mim e, depois, partilhar do

1. Margaret I. Little, *On Delusional Transference (Transference Psychosis)*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 39 (1958); também em Little, *Transference Neurosis and Transference Psychosis* (New York, London: Jason Aronson, 1981).

ônus da responsabilidade pelo rompimento da idealização através de seu ódio, ódio que lhe viria como um delírio de eu estar zangado com ela. *Ela alcança ambivalência por esta maneira, apenas um pouquinho.*

Pode-se notar que este trabalho fica bem atrás do problema despertado pelas visitas do perverso masculino, exceto que as palavras "Não é justo" proporcionam um vínculo. Não é justo para o objeto idealizado (subjetivo, quase) demonstrar sua independência, sua própria separação, sua liberdade do controle onipotente dela.

Se esta análise alcançar êxito, será por causa de uma longa série destes minúsculos traumas, *encenados pela paciente*, e que envolvem fases de transferência delirante.

A Experiência de um Trauma por uma Paciente

Não seria difícil, para um analista, encontrar exemplos de eventos deste tipo em seu trabalho clínico atual. Aqui temos outro exemplo, tirado da mesma semana de minha experiência clínica.

Uma paciente adulta possui uma defesa muito bem organizada contra a esperança. Em uma análise anterior, e agora em minha análise dela, nada jamais tornou-se consciente. Seja o que for que aconteça já foi previsto pela paciente. Existe, em todo o quadro, um desespero que nunca se altera, de maneira que esta pessoa potencialmente valiosa aceita a derrota em toda a linha e vive em um humor brandamente deprimido. Ela "sabe que a análise não pode ter sucesso".

Este estado de coisas começou quando um início de infância excepcionalmente feliz terminou abruptamente porque o pai morreu e a mãe imediatamente tornou-se melancólica. A melancolia desta última achava-se claramente presente em sua atitude excepcionalmente vivaz, imaginativa e causadora de felicidade para com sua filha única, que durou até o momento do falecimento do marido, com a melancolia permanecendo até a sua própria morte. Na sessão que estou escolhendo para relatar, uma coisa nova acontecera: a paciente achou que minha *interpretação principal devia estar certa* e, contudo, ela não havia previsto isso. A interpretação fora, portanto, "traumática", no sentido de ultrapassar as defesas. Este trauma benigno refletia o novo sentimento da paciente a respeito do trauma maligno.

Na época, eu estava vendo a paciente só uma vez por semana e na semana que precedera esta sessão específica a paciente tivera de vir em hora diferente. Ela chegou na hora costumeira e foi embora quando lhe foi dito, à porta, que cometera um equívoco. Na sessão a que estou me referindo (uma semana mais tarde), ela começou a me falar a respeito disso e de como vira no rosto da pessoa que atendera à porta um olhar de crítica, quase um "você foi travessa".

Prosseguiu então dizendo o quanto ela gostava dessa pessoa, que quase sempre a faz entrar em minha casa. Seguiu-se o material depressivo costumeiro. Ficara contente em ir embora e não ter a sessão. Outras coisas foram relatadas e a pior era a seguinte: seu amigo reagira de maneira terrível a algo que ela dissera. Tinha a ver com uma criança adotada que era feliz, mas a quem não haviam falado da adoção. Minha paciente dissera: "Bem, espero que eles venham a dizê-lo à criança em breve", e seu amigo ficara muito zangado e atribuíra tudo a uma atitude psiquiátrica em relação à vida, engendrada nas pessoas que se acham em análise. O mau-humor do amigo durou longo tempo e foi intolerável. Isto foi relatado como sendo totalmente devastador, mas sempre havia aquele mesmo humor triste da paciente, que reduz tudo à mesma coisa: algo potencialmente bom, até mesmo maravilhoso, mas naturalmente, estragado.

Houve outros exemplos disto no material da paciente. Um deles tem a ver com uma nova versão do incidente que conduziu à sua tentativa de suicídio. Ela havia ido,

com toda a boa fé, solicitar uma oportunidade extraordinária de fazer um trabalho especial (na universidade), por causa de um fracasso num exame devido ao ônus da melancolia da mãe, e, inesperadamente, fora acusada de reivindicar privilégios especiais. Isto conduziu a uma nova versão do momento do trauma original, quando foi procurar a mãe após a morte do pai, esperando encontrar a costumeira mãe proporcionadora de felicidade e, ao invés dela, descobrira uma pessoa nova, uma pessoa irritável, irrazoável e que não mais tinha uma relação especial com a minha paciente (então uma criança de seis anos).

Pode-se notar que (como eu viera a esperar nesta análise) este material novo não era geralmente novo; a paciente sempre soubera tudo isto, mas nesse dia, sentira vontade de fornecer-me um quadro mais claro do que sempre recordara claramente.

Veio então a minha interpretação. Isto não era mais que uma vinculação destes exemplos de trauma com o episódio na porta com a pessoa que, ao invés de deixá-la entrar, dissera-lhe que havia cometido um equívoco. Foi neste ponto que a minha paciente experienciou o seu primeiro "trauma" analítico, ou "trauma benigno", se se puder permitir a expressão. Ela ficou estupefata. Não fizera essa vinculação, ela própria. Podia perceber que era válido, mas não podia "aceitá-lo" imediatamente.

Viu então o que não havia visto antes, isto é, reconheceu o delírio que se achava no centro do episódio à porta. Na realidade, a pessoa à porta fora delicada, mas minha paciente vira-lhe o rosto como proibidor e acusatório. Sua reação fora a que teria a um perseguidor. (Tal pessoa representava a mim na transferência e, de fato, a paciente também dissera isto à mim, quando chegou a isso na sessão seguinte: quando eu estava ordinariamente compreensivo e, certamente, não-raivoso, disse que, por uma razão ou outra, ela se ressentia com o fato de eu ser delicado).

Era agora possível ver aqui o padrão, o mesmo padrão que descrevi acima, em meu relato da sessão da meninazinha. Esta paciente adulta chegara com todas as suas defesas abaixadas, "sabendo" que lhe seria permitido entrar. A pessoa à porta estaria dentro da área de sua onipotência, seria parte do "meio ambiente expectável médio". Mas não foi. Aqui seguiu-se um ódio inconsciente desta pessoa e o que foi consciente foi um delírio de crítica por parte daquele, do qual a paciente escapou com vivacidade, sentindo-se com sorte por poder ir embora.

Agora a paciente havia experienciado, na *transferência delirante*, a perseguição que constitui um passo necessário no sentido da experiência do ódio de um objeto bom, sendo este o estofa da desilusão. Talvez pela primeira vez, em um decênio de análise, a paciente houvesse chegado a uma mudança nas defesas, defesas originalmente organizadas com relação à mudança súbita e imprevisível na mãe que se seguiu à morte imprevisível do pai².

Um Exemplo Semelhante

Acrescentarei aqui um terceiro exemplo, que me veio às mãos enquanto eu redigia estas notas.

Em um caso a que estou assistindo, uma paciente foi como de costume ao seu analista e apertou a campainha. Ela se encontrava em um estado especial que tem a

2. Little, *Delusional Transference*. W. R. Bion, *Attacks on Linking*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 40 (1959); também em Bion, *Second Thoughts* (Londres, Heinemann Medical Books Ltda., 1967). Winnicott refere-se ao valor do conceito de Little em *Dependence in Infant-care*, in *Child-care and in The Psycho-Analytic Setting* (1963), em *Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983); London, Hogarth Press; New York, International Universities Press, 1965).

ver com a esperança nesta pessoa, que é geralmente desesperançada. Evidentemente, a campainha não ressoou, de maneira que a apertou de novo, após o que alguém chegou e abriu a porta. Quando esta paciente começou sua sessão, disse ela: "Então você estava aí o tempo todo, enquanto eu esperava do lado de fora". (A implicação disto era: você me odeia!) O analista não sabia o que estava acontecendo e diz-se (talvez erradamente) que respondeu: "Você se dá conta do que é que está dizendo?" (Com efeito, isto foi uma censura.) A paciente ficou em desespero por causa disto.

É possível examinar de novo este material e ver que o analista (tal como relatado por esta paciente) deixou de interpretar de acordo com as linhas da transferência delirante. Ela poderia não ter dito nada ou poderia ter dito: "Você me odiou quando a campainha da porta não tocou e ninguém apareceu para deixá-la entrar, mas você não sabia a respeito deste ódio de mim e o que viu foi o meu ódio de você".

Neste caso, fiz a experiência de fornecer a esta paciente este fragmento de informação estranho à sua análise. O resultado foi que ela se lembrou de haver sentido o mais intenso e amargo ódio por sua analista quando passou pela porta desta, a caminho da sala de espera. Ela não poderia ter relatado isto porque não se achava ciente de tal, mas de qualquer modo, "teria sido tão louco..." (transferência delirante).

Aqui, temos em ação o mesmo mecanismo que foi descrito nos outros casos. Em cada um deles há uma traumatização, com ódio aparecendo clinicamente como um delírio de ser odiado.

A Consulta Terapêutica

Outro tipo de experiência clínica que para mim constituiu um vínculo entre a idéia da família e a de trauma surge de um estudo que estou fazendo do que chamo de Consulta Terapêutica. Estou tentando demonstrar que, em um tipo muito comum de caso psiquiátrico infantil, existe uma possibilidade de fazer-se psicoterapia eficaz e profunda fazendo-se uso pleno de uma só entrevista ou de um número limitado delas. Se minha tese estiver correta, torna-se então urgentemente necessário poder diagnosticar de acordo com a adequabilidade do caso para um tratamento desse tipo. Neste tipo de caso, a criança bem pode achar-se, clinicamente, gravemente perturbada.

Um denominador comum destes casos é a existência de uma família que funciona como tal ou, pelo menos, de uma situação familiar. Na realidade, onde existe enfermidade psiquiátrica grave em um ou outro dos pais, ou onde o lar já se acha rompido ou possui uma inconfiabilidade intrínseca, então é improvável que este tipo de terapia rápida funcione.

Em outras palavras, o trabalho principal em tais casos é efetuado pela família e dentro desta, e o terapeuta age efetuando na criança uma mudança que é qualitativamente exata e quantitativamente suficiente para capacitar a família a funcionar de novo, com respeito a essa criança. Uma vez enunciada, a idéia é facilmente aceita. Estes casos são importantes pelo fato de possuírem um vínculo estreito com a terapia de uma outra criança que está todo o tempo sendo feita em qualquer família que esteja funcionando, independentemente de ajuda psiquiátrica ou profissional especializada.

Descrição Sucinta de um Caso de Psiquiatria Infantil

Phyllis me foi trazida, com a idade de 16 anos, por causa de dificuldades de personalidade que ainda não se haviam organizado em uma configuração de enfermidade.

No decurso de uma importante entrevista psicoterapêutica, disse ela: "sempre sinto que me acho de pé ou sentada no pináculo de uma torre de igreja. Quando olho em volta, não encontro apoio em parte alguma e estou apenas me equilibrando".

De modo claro esta ansiedade poderia achar-se relacionada a um medo de um aspecto inconfiável das experiências infantis de Phyllis; poderia referir-se a algum tipo de fracasso de sustentação por parte da mãe, numa época em que Phyllis era imatura no sentido de ser dependente.

Ora, acontece que tenho notas deste caso, tomadas quando Phyllis me foi trazida, ainda criança pequena, na realidade com um ano e nove meses de idade, quando sua mãe se achava com seis meses de gravidez. Nessa idade, o desenvolvimento direto dela havia sido interrompido e, na realidade, Phyllis nunca se recuperara corretamente disso. Foi quando tinha um ano e nove meses que ela reagiu ao lhe dizerem que teria de ir embora, para ficar com a avó (com quem tinha um bom relacionamento) até o novo bebê nascer. Presumivelmente, nesta idade, ela estava também fisicamente ciente das mudanças físicas ocorridas na mãe. Dois dias após haver-lhe sido dada essa notícia, ela reagiu por uma semana recusando-se a comer e gritava sem parar. Após isto, estabilizou-se num nervosismo e irritabilidade e num certo problema de manejo. Assim começou a sua enfermidade.

Pareceria que diversos fatores estiveram em ação aqui:

1. Quando criança pequena, Phyllis não fora capaz de lidar com a gravidez da mãe e tudo o que a acompanhava. É difícil dar informações a uma criança de um ano e nove meses; ou a criança não recebe mensagem alguma ou, então, a mensagem recebida é uma de mudança total da atitude dos pais ou de súbita desilusão

2. Talvez os pais não tenham manejado bem esta questão, embora se possa contar com que eles, de maneira geral, comportem-se de maneira sensível.

3. Anunciar a mudança, uma mudança já esperada por causa das formas da mãe, em termos de: "Você vai ir embora...", pode ter sido um método mau, tornando ainda mais difícil para a criança pequena do que seria normal nessa idade lidar com a gravidez da mãe através de uma identificação com esta. Em minhas notas, vejo haver relatado, algum tempo mais tarde, que Phyllis fez uma tentativa de assemelhar-se à mãe, ao desenvolver uma compulsão a empinar o abdôme e andar de modo empertigado, numa imitação canhestra daquela.

Por qualquer que fosse a causa, Phyllis tornou-se altamente perturbada na ocasião em que a mãe achava-se grávida. Tem-se de presumir que ficou ciente de uma ameaça de "ansiedade impensável", a ansiedade primitiva ou arcaica que bebês bem-cuidados não experienciam na realidade, antes de se acharem aparelhados para lidar com o fracasso ambiental através do autocuidado (maternagem introjetada). As ansiedades desse tipo incluem:

- queda eterna;
- desintegração;
- despersonalização;
- desorientação.

Eu soubera da reação desta criança à ameaça na ocasião, e foi interessante para mim receber da Phyllis de 16 anos a versão sofisticada desta percepção da ameaça à sua existência que pertencia à idade de um ano e nove meses. Toda a sua vida ela se sentira como se estivesse *apenas se equilibrando*. As palavras "no pináculo de uma torre de igreja" não acrescentam nada de importância geral, mas as palavras "de pé ou sentada" possivelmente derivam de suas experiências reais no colo da mãe antes de seu segundo aniversário, data por volta da qual a irmã nasceu.

Pode-se ver deste exemplo que os pais, ao formarem suas famílias, têm grande influência sobre o desenvolvimento emocional dos filhos. Cometem erros, mas também planejam e pensam em como introduzir idéias a crianças pequenas em lingua-

gem apropriada, e, por milhares de maneiras, os pais protegem os filhos quanto à *traumatização*. Neste caso, havia uma traumatização localizada e esta teve um efeito sobre a personalidade da criança. Os pais tinham feito tudo o que podiam para consertar o que acontecera há tanto tempo atrás, mas precisaram de ajuda. Esta ajuda foi-lhes fornecida em uma entrevista psicoterapêutica com a menina, na qual o problema pessoal desta foi trazido para o primeiro plano, à própria maneira da criança. Isto é anamnese através da criança, a única maneira pela qual os detalhes de uma história clínica podem ser realmente utilizados no processo psicoterapêutico. Pode-se dizer que um tratamento em escala completa, com o principal trabalho que é feito sendo relativo à neurose (ou psicose) transferencial, é uma anamnese prolongada.

Neste caso, os pais carregaram o ônus da enfermidade da filha durante oito anos e estavam capazes e dispostos a continuar a carregá-lo, embora ambos tivessem consideráveis dificuldades pessoais. Precisavam, contudo, de um certo auxílio, através do qual a menina se tornasse capaz de fazer uso daquilo que a família tinha a oferecer-lhe através de seu funcionamento normal.

Descrição Sucinta de Outro Caso de Psiquiatria Infantil³

Temos aqui a reação de uma menina mais velha ao nascimento de uma irmã. Esta criança de oito anos conseguiu colocar-me em contato com a sua reação, ocorrida aos três anos de idade, no momento de sua traumatização por uma concatenação de circunstâncias. Havia razões (que não precisam ser fornecidas aqui) para que a mãe houvesse ficado fisicamente enferma e, também, seriamente deprimida por ocasião do nascimento da irmã da menina. Na realidade, durante algumas semanas, nessa época, a criança teve de experienciar a rejeição dela por parte de sua mãe muito boa, uma vez que esta havia ficado temporariamente transtornada, ao ponto de odiar o novo bebê e a outra filha. Durante o período, o bebê foi cuidado dentro do *setting* familiar, principalmente pelo pai, mas apesar disso, sofreu um eclipse com relação à mãe.

Um pesadelo (relatado a mim em determinada consulta terapêutica, quando a menina contava oito anos de idade) levou-a de volta a essa data em que tinha três anos. A Figura 1 mostra como ela se dirigiu para a mãe e o novo bebê, levando consigo "latas de comida de bebê" e preparada para lidar com a nova situação por várias identificações cruzadas, tais como ser a mãe, ser o bebê e ela própria ajudar a fazer crescer o bebê.

A rejeição que encontrou (por causa do transtorno puerperal da mãe) inverteu tudo isto e a Figura 2, na realidade, a mostra no momento de tornar-se uma criança carente. Um dos sintomas de seu estado foi uma compulsão a furtar e, a princípio, ela furtou latas de comida de bebê, pela qual desenvolveu um desejo insaciável.

O primeiro desenho, então, ilustra o pesadelo, e o segundo a sua lembrança de tornar-se realmente "carente ou privada", isto é, repentinamente fora de contato com a mãe. O bebê encolhe porque a comida de bebê não atinge seu alvo e, por trás da criança carente, existe água, água venenosa que ameaça fazer encolher (o oposto de crescer) o bebê e a mãe (e ela própria). A água eram lágrimas amargas, lágrimas que não podiam fluir-lhe dos olhos em tristeza, e a água também se refere à enurese que se tornou um sintoma temporário manifesto.

3. Descrito com minúcias como Caso 17, "Ruth", em Winnicott, *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry* (London, Hogarth Press; New York, Basic Books, 1971).

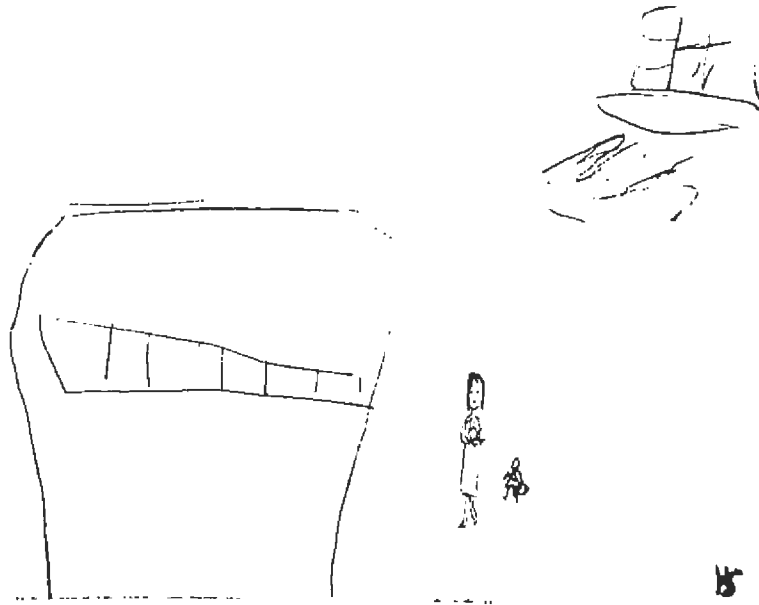


Figura 1



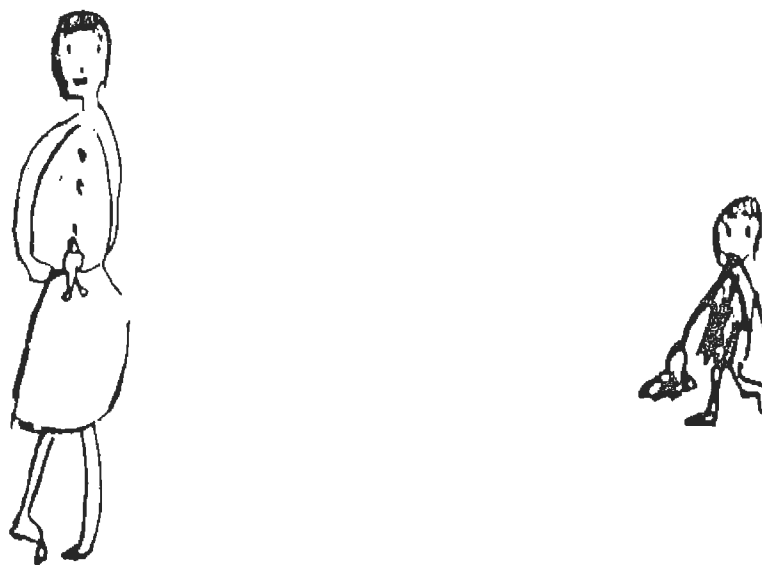
*Este detalhe da Figura 1
é reproduzido no tamanho em que foi desenhado*

A primeira Figura, o pesadelo, fornece a esperança, e a segunda o desespero devido à repulsa para a qual a menininha se achava totalmente despreparada. Por causa da enfermidade da mãe, psicossomática e depressiva, esta família fracassou em proteger esta criança quanto ao trauma por ocasião do nascimento do bebê, de maneira que a capacidade que a criança tinha de identificar-se com a mãe malogrou-se.

Neste caso, a família tratou bem do bebê e também acabou por fazer o mesmo com a menina, exceto quanto a uma parte em que necessitou de auxílio especializado proporcionado por mim. Uma só entrevista bastou, após a qual a família prosseguiu com a sua função de cuidar dessas duas crianças e da seguinte, quando chegou.



Figura 2



*Este detalhe da Figura 2
é reproduzido no tamanho em que foi desenhado*

Comentário Geral

A família média está todo o tempo impedindo e ajeitando os distúrbios nesta ou naquela criança, geralmente sem ajuda profissional. Para um psicoterapeuta, é certamente um erro usurpar o funcionamento familiar total, exceto quando este funcionamento está fadado ao fracasso por causa de alguma falha inerente. Quando a família está funcionando, o objetivo do terapeuta deve ser capacitar a criança que está sendo trazida para tratamento a fazer uso daquilo que a família pode, na realidade, fazer melhor e de modo mais econômico do que qualquer outra pessoa, a saber, o cuidado mental global durante todo o período, até que a recuperação tenha se dado.

Sucinta Descrição de Outro Caso⁴

Este caso ilustra a capacidade que uma criança tem de enunciar seu problema pessoal. Um menino com características esquizóides começou a degenerar em seu trabalho escolar, apesar de sua alta inteligência. Ele era bem-tolerado na escola, embora tivesse se tornando cada vez mais esquisito. Foi encaminhado a mim por seu clínico geral, por causa de uma incapacidade crescente de retornar à escola desde casa, pois, quando a ela devia voltar, sempre desenvolvia uma enfermidade obscura e febril.

Seus pais o trouxeram e dediquei-lhe uma longa consulta terapêutica, no curso da qual me forneceu o seu problema básico sob a forma de uma abstração tirada de um "abstrato" que havia pintado (Figura 3).

Interpretei-lhe que se tratava de *um enunciado de aceitação e recusa simultâneas*. O resultado assemelhou-se ao abrir de uma comporta. Clinicamente, o menino melhorou a partir da ocasião desta muito rica e recompensante (isto é, recompensante desde meu ponto de vista) consulta e amadureceu em quase todos os aspectos.

A questão aqui é que este tipo de trabalho, feito em uma só entrevista, só é possível quando a família da criança está funcionando, e, neste caso, trabalhando em conjunto com a escola. A família (auxiliada pela escola) fez quase todo o trabalho, tanto antes quanto depois da entrevista psicoterapêutica, mas era necessário esse esclarecimento que os pais não podiam fornecer e, na realidade, o menino não lhes teria dado a oportunidade de fazê-lo. Em determinado aspecto, a mãe havia-lhe falhado na primeira infância e, depois, ficou tarde demais para ela fazer o que fracassara em efetuar na ocasião apropriada. Ela e o marido podiam fazer e fizeram bem tudo o mais.



Figura 3

Temos aqui um exemplo positivo da confiança de um menino em sua família e em cada um dos pais, com esta confiança capacitando-o a fazer uso de mim e escavar, de modo profundo e imediato, seus próprios problemas pessoais de estrutura de personalidade.

Houve traumas na primeiríssima infância deste menino que os pais não puderam impedir, mas que, na realidade, quase tornaram-no um caso de esquizofrenia infantil. Ao invés, ele desenvolveu-se em uma pessoa esquizóide, uma pessoa que cada vez mais precisava tentar solucionar um só problema. Este e outros problemas semelhantes teriam permanecido sem esperança e insolucionados dentro dele se houvesse se tornado um caso de esquizofrenia infantil, ou, talvez, um daqueles estranhos deficientes mentais que apresentam um brilhantismo intelectual desigual.

4. Descrito com minúcias como Caso 9, "Ashton", em *Therapeutic Consultation in Child Psychiatry*.

Do Anormal ao Normal

A consulta terapêutica é eficaz quando existe uma família que funciona, mas a ajuda profissional é necessária para capacitar um menino ou uma menina a utilizar a família que facilita os seus processos de amadurecimento.

Isto se vincula, de modo claro, com o trabalho feito pela família que funciona com respeito a seus membros, os quais, de tempos em tempos, necessitam e obtêm atenção individual.

Vincula-se também com aquela parte da função familiar que tem a ver com o *Princípio de Realidade* e com o processo de desilusão tal como, por exemplo, os ajustes pessoais relacionados à chegada de irmãos ou irmãs, etc. No topo disto encontra-se o complexo Edipiano, o ajuste que o indivíduo faz ao fato da triangulação nos relacionamentos interpessoais.

Em termos dos estágios iniciais da integração do indivíduo e de outros processos maturacionais, a mãe (em particular) desempenha seu papel de ser aquela que desilude o bebê, e a base de seu trabalho com respeito a isto é o estágio inicial no qual (através da adaptação especializada) ela concede a cada bebê a ilusão da experiência da onipotência. O êxito da função de desilusão da mãe e da família deve ser medido em termos da capacidade que a criança tenha de *ambivalência*, mas a base para a ambivalência é esta *experiência de onipotência* relativa a um objeto. A reflexão ambiental da ambivalência envolve a idéia de trauma e isto leva a uma consideração da natureza deste.

A Natureza do Trauma

A idéia de trauma envolve uma consideração de fatores externos; em outras palavras, é pertinente à dependência. O trauma é um fracasso relativo à dependência. O trauma é aquilo que rompe a idealização de um objeto pelo ódio do indivíduo, reativo ao fracasso desse objeto em desempenhar sua função⁵.

O trauma, portanto, varia de significado, de acordo com o estágio do desenvolvimento emocional da criança, e, assim:

A. De início, o trauma implica em um colapso na área da confiabilidade no "meio ambiente expectável médio", no estágio de dependência quase absoluta. O resultado de tal colapso mostra-se no fracasso ou relativo fracasso, no estabelecimento da estrutura da personalidade e organização do ego.

B. A desadaptação constitui a segunda parte da função materna, com a primeira sendo o fornecimento de oportunidade ao bebê de ter uma *experiência de onipotência*. Normalmente, a adaptação da mãe leva ao fracasso adaptativo graduado, que, por sua vez, conduz à função que a família tem de gradualmente introduzir o Princípio da Realidade à criança.

Um estudo do trauma, portanto, envolve o investigador em um estudo da história natural do meio ambiente relativa a um indivíduo em desenvolvimento. O meio ambiente é adaptativo e, depois, desadaptativo; a mudança da adaptação para a desadaptação está intimamente relacionada ao amadurecimento de cada indivíduo e, dessa maneira, ao gradual desenvolvimento, nesse indivíduo, dos complexos mecanismos mentais que acabam por tornar possível uma mudança da dependência no sentido da independência.

5. Winnicott, *Weaning* (1949), *The Child, The Family and The Outside World* (Penguin, 1964; Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1987).

Dessa maneira, existe um aspecto normal do trauma. A mãe está sempre "traumatizando", dentro de um arcabouço de adaptação, e, desse modo, o bebê passa da dependência absoluta para a dependência relativa. Mas o resultado não é como o do trauma, por causa da capacidade que a mãe tem de sentir a capacidade do bebê, momento a momento, de empregar novos mecanismos mentais. O senso que o bebê tem do não-eu depende do fato do funcionamento da mãe neste campo do cuidado maternal⁶. Os pais, agindo juntos, e, depois, o funcionamento da unidade familiar continuam este processo de desilusão da criança⁷.

Clinicamente, é comum descobrir que uma mãe não consegue desmamar a criança. Queixa-se ela de que a última "não desmama". Bem pode acontecer que a mãe se ache em uma fase depressiva, na qual o ódio (tanto ativo quanto passivo) não está acessível à consciência ou para uso em relacionamentos. A mãe, na realidade, não consegue desempenhar seu papel no processo de desilusão, do qual o desmame constitui uma expressão⁸. Em outras palavras, uma mãe normal ou sadia é capaz de armar-se de ambivalência no relacionamento objetal e poder utilizá-la de modo apropriado.

A mesma dificuldade pode aparecer sob a forma de uma recusa escolar pela criança, com a mãe geralmente não se achando ciente do papel que está desempenhando. A criança pode estar consciente do fato de que o que não pode suportar é a incapacidade materna para lidar com sua perda.

C. O trauma, no sentido mais popular do termo, implica uma quebra da fé. O bebê ou a criança construíram uma capacidade de "acreditar"⁹, e a provisão ambiental primeiro se ajusta a ela, mas depois, fracassa. Desta maneira, o meio ambiente persegue pelo fato de atravessar as defesas. O ódio reativo do bebê ou da criança divide o objeto idealizado e isto pode ser experienciado em termos de um delírio de perseguição por parte de objetos bons. Onde a reação é de raiva ou ódio apropriados, a expressão "trauma" não é bem aplicada. Em outras palavras, onde há uma raiva apropriada, o fracasso ambiental não se situou mais além da capacidade do indivíduo de lidar com a sua reação.

D. Quanto mais a criança alcança integração, mais gravemente ela pode ser ferida se for traumatizada; ferida, ou feita sofrer, significando algo oposto a ser impedida de alcançar integração. Eventualmente, no complexo Edípiano, nos inter-relacionamentos como os que se dão entre três pessoas totais, a criança precisa passar por um período em que a confiabilidade pessoal dos pais seja experienciada a fim de que o equipamento total (mecanismos de projeção e introjeção) possa ser usado, e no qual possa tornar-se estabelecida uma realidade psíquica pessoal ou interior que torna a fantasia uma experiência comparável ao relacionamento objetal real. Uma apresentação total deste tema precisaria incluir o conceito dos fenômenos transicionais¹⁰. O resultado de tal crescimento no indivíduo é uma capacidade para a ambivalência.

E. Ao fim das contas, o trauma é a destruição da pureza da experiência individual por uma demasiada intrusão súbita ou imprevisível de fatos reais, e pela geração de ódio no indivíduo, ódio do objeto bom experienciado não como ódio, mas delirantemente, como sendo odiado.

6. Joan Riviere, "On the Genesis of Psychical Conflict in Earliest Infancy", *International Journal of Psycho-Analysis*, 17 (1936).

7. Winnicott, *The World in Small Doses* (1949), em *The Child, The Family and the Outside World*.

8. Winnicott, *Weaning*.

9. Winnicott, "Moral e Educação" (1963), em *O Ambiente e os Processos de Maturação*.

10. Winnicott, *Transitional Objects and Transitional Phenomena* (1951), em *Collected Papers: Through Pediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; Hogarth Press, 1975).

A Família

É a própria mãe do bebê que tem mais probabilidade de fazer o que é ambientalmente necessário para o bebê, simplesmente por causa de seu relacionamento total com ele. Da mesma maneira, é a família que tem mais probabilidade de proporcionar o que corresponde a isso com relação à vida mais sofisticada da criança e do adolescente. Grupos sociais limitados continuam o que a família iniciou e, na saúde, a criança em amadurecimento torna-se cada vez mais capaz de tomar parte na manutenção da estrutura grupal e do funcionamento grupal.

O funcionamento familiar pode ser encarado como preventivo do trauma, desde que se permita que o significado da palavra "trauma" *mude com o crescimento da criança, da primeira infância para a maturidade plena, com o crescimento que vai da dependência para a independência*. Com base nisto, a família pode ser estudada não somente como uma atitude estruturada dos pais, parentes próximos e irmãos e irmãs, mas também como algo que é em parte *produzido pelas necessidades urgentes das próprias crianças*, necessidades surgidas da dependência e do fato de que o processo individual de amadurecimento só se torna realizado em um meio ambiente facilitador.

23

Notas sobre Retraimento e Regressão

Redigidas para um seminário de dezembro de 1965

A fim de focar uma sessão de quarta-feira de maneira a que ela possa ser entendida, tenho de referi-me ao dia anterior. Na terça, a paciente já se achava desiludida e se tornando despida de afeto. Ela utilizou duas coisas: a formalidade do médico que fora extraordinariamente bom com ela nos E. U. A. e uma frase infeliz de um livro da autoria de Searles. Constituiu característica desta sessão o fato de que, embora se achasse ocupada com estas questões de uma maneira que todo o mundo se achava nelas incluído, e eu também, de tempos em tempos emergia de seu casulo para dizer-me, fixando-me com o olho de uma maneira que lhe é característica e pertence a seu bom relacionamento com sua boa babá: "Você sabe, não é, que eu gosto muito de você, de verdade?" Ela se achava obviamente lutando com outros sentimentos a meu respeito aos quais não conseguia chegar, mas que podia encontrar, até certo ponto, no relacionamento com os dois médicos.

A quarta-feira foi um desses dias característicos que certamente alarmam o inexperiente. Ela era uma pessoa diferente, embora eu me ache muito familiarizado com o que parece quando é essa pessoa diferente. Poderia-se dizer que está indignada "com Deus a seu lado". A palavra correta para a sessão de quarta-feira era retraimento. *Este foi o primeiro dos pontos para debate.* Com esta paciente, é extremamente importante que eu entenda a diferença existente entre regressão e retraimento [*withdrawal*]. Clinicamente, os dois estados são praticamente os mesmos, mas será visto, contudo, que existe uma diferença extrema entre os dois. Na regressão há dependência e, no retraimento, uma independência patológica. Aprendi na escola desta análise que o retraimento é algo que faço bem em permitir, e, na primeira parte da análise, ele foi o aspecto importante e resultou em muitas horas em que absolutamente nada era feito. O processo era silencioso e referia-se ao que acontece na dependência extrema. Quando o retraimento se torna uma característica alternativa importante, o paciente sempre fica muito zangado quando eu o tomo equivocadamente por regressão ou não me dou conta de que o retraimento tem de ser tratado de modo diferente. Mais difícil é o fato de que, na prática, assiste-se à mudança de retraimento para a regressão, à medida que o paciente se torna capaz de identificar o que há de positivo em nossa atitude. Compreender-se-á que, no retraimento, a expectativa é de meio ambiente persecutório. De qualquer modo, nessa quarta-feira a paciente estava quase tão retraí-

da quanto é possível, completamente oculta sob duas mantas e enfiada entre duas almofadas. De modo inteiramente repentino, emergiu, e então estava tão raivosa quanto lhe é possível ser, que não é pouco. Continuou direito até o final da sessão, começando por uma crítica a mim por deixá-la ficar retraída, passando por todas as deficiências que pode facilmente encontrar e enumerar em minha técnica, e, finalmente, levantando-se e indo embora quase exatamente na hora certa, dizendo que certamente não voltaria para desperdiçar seu tempo daquela maneira.

Tinha havido no passado episódios mais agudamente mortificantes como este, mas nunca, acho eu, um em que houvesse um sentimento tão real de que a paciente sabia o que estava querendo dizer. Eu, naturalmente, não me defendi de maneira alguma (ou espero que não o tenha feito); considerei que ela havia terminado sua análise e acompanhei-a mais além da porta, até seu carro, junto com a enfermeira que vem com ela, e esperei até que partissem. Foi o motorista quem acenou para mim de maneira amistosa.

Este foi o segundo ponto para debate: a reação extremada de uma transferência delirante e a necessidade de apenas aceitá-la. Acho que se precisa ter uma grande confiança em si para apenas aceitar tudo isto, sem dizer nada em voz alta em autodefesa. Felizmente, neste caso, não havia questão de suicídio e, assim, pude apenas pensar: — Bem, na pior das hipóteses, a paciente não quer mais nada comigo. Sabia, no entanto, que ela não tem ninguém mais a quem ir, mas ainda assim, poderia ter entrado em colapso a ponto de ir ver toda uma série de terapeutas marginais, sobre os quais conhece um bocado.

Neste caso, o dia seguinte, quinta-feira, trouxe a sua recompensa. A paciente havia retornado a um relacionamento afetuoso. Toda a sua maneira de estabelecer contato com as mantas e as almofadas era diferente. Achava-se obviamente em um estado de cooperação inconsciente de a análise ser operante, de maneira que conseguiu contar-me sonhos que tinham validade. Finalmente, disse que havia se sentido extremamente culpada a respeito do que acontecera, tanto que ia me trazer dois pêssegos para o meu fim de semana. *Isto forneceu o ponto seguinte para debate.*

Havia duas coisas aqui. Primeiro, tive um debate com ela a respeito de os analistas aceitarem presentes, por eu saber que ela se achava plenamente ciente do que existe escrito a respeito do assunto. Apontei-lhe a diferença existente entre o neurótico e o psicótico com respeito a isto. Lembrei-lhe que ela praticamente não sabe do que trata a psicose. Se um paciente neurótico me traz um presente, tendo a recusá-lo, porque sei que terei de pagar por ele em moeda inflacionada. No caso de um psicótico, contudo (e aqui eu estava realmente pretendendo incluir as ansiedades depressivas que não se acham inteiramente acessíveis à paciente), descobri que os presentes têm a ver com um dano que já foi causado. Em outras palavras, quase sempre os aceito, e descobri que não há muita diferença entre aceitar dois pêssegos e aceitar um humor cooperativo ou uma atitude afetuosa. Estava naturalmente preocupado com que os dois pêssegos simbolicamente representassem seios idealizados, mas contentei-me em deixar o assunto por aí e acabei por ser recompensado, acho eu.

A segunda coisa tinha a ver com a capacidade da paciente, neste ponto, de falar a respeito de quão horrível ela havia sido. Examinou a hora anterior em termos de haver sido “cortante” em suas observações, e isso era uma descrição correta. Lembrou a mim e a si própria de que quando se sente tal como se sentira, é capaz de dilacerar quem quer que esteja perto e realmente ferir.

Um sonho tinha a ver com pular do nono andar de um prédio de apartamentos (o apartamento de seus pais fica no nono andar) em cima de meu apartamento, sem aparentemente ferir-se, ficando o meu apartamento provavelmente no andar térreo.

No dia seguinte, quando chegou, seu estado de mente e sua atitude continuavam. Na realidade, trouxe-me chocolate Bittra, o que me pareceu constituir uma

melhora quanto aos pêssegos e a idealização que estes trazem em si. Houve outro sonho de pular de um aeroplano, que aparentemente era bastante exibicionista e não conduziu a dano algum, e houve também um sonho de que havia um homem em algum lugar e, por mais que fizesse, não conseguia fazer com que ele lhe prestasse atenção. Estava determinada, contudo, a fazê-lo com que a notasse, mesmo que isto significasse usar a saia moderna que fica acima dos joelhos. Até o presente, havia desprezado fazer alguma coisa para atrair um homem, porque, se ele não se achava já atraído, tudo o que pudesse fazer não valia nada.

Uma Nova Luz sobre o Pensar Infantil

Palestra introdutória, pronunciada em uma conferência para membros do magistério realizada no Centro de Educação Adicional de Devon, em 3 de janeiro de 1965

Minha contribuição não é tanto uma contribuição positiva ao tema específico do pensar, quanto um comentário, desde o ângulo da psiquiatria infantil, sobre *o pensar como função*. Terão de permitir que me mostre ignorante dos textos daqueles que fizeram do tema do pensar uma especialidade própria. Minha esperança é que o que tenho a dizer os ajude a colocar as outras coisas que ouvirem em relação com a teoria geral do desenvolvimento da personalidade humana, da pessoa humana. Existe uma teoria geral que tem de deixar espaço para tudo, inclusive o que ainda não é conhecido e o que ainda não é considerado, e há também estudos específicos do pensar, alguns dos quais tratarão em sua conferência.

Estava pensando... Vocês poderiam ter programado a sua conferência de acordo com as maneiras pelas quais a palavra é usada. Quando *penso* [*think*] no que me meto fico aterrorizado. Primeiro me descubro *rodeando* [*thinking round*] o assunto, astutamente esperando safar-me pela exploração de uma distração. Mas então me descubro *considerando* [*thinking around*] a palavra "pensar". Começo então a *inventar ou imaginar* [*think up*] uma maneira de apresentar a comunicação que quero fazer. De vez em quando *penso* [*think*] em algumas palavras que é melhor deixar de dizer e faço uma nota mental: da próxima vez, *pense* [*think*] antes de aceitar este tipo de convite! Contudo, seria *impensável* [*unthinkable*] escapar de minha obrigação apresentando a desculpa de estar com gripe ou gota, de maneira que mergulho no assunto, apesar da advertência do poeta de que *pensar* [*think*] é ficar cheio de mágoa.

Não há alternativa; tenho de *refletir bem* [*think out*] sobre esta coisa, sem esperanças de poder fazê-lo *de modo completo* [*think it through*]. Depois, terei de aceitar o que será *pensado* [*thought of*] de meus esforços, e não levá-lo a mal. Após, naturalmente *pensarei* [*think of*] em todas as coisas em que não *pensei* [*thought of*]. Quão melhor teria sido ter pensado antes [*thought forward*] e predito as críticas de vocês.

Suponho que se pode examinar cada um destes significados da palavra "pensar" e tentar aplicá-los a uma criança de um ano de idade.

Pensar [*think*] — reconhecer, identificar (pertence a vários tipos de amadurecimento)¹

Rodear [*think round*] — tentar astuciosamente circundar (um ano & animais)

Considerar [*think around*] — examinar com carinho (6 anos + ou -)

Inventar [*think up*] — criar na ausência de sua musa (2 anos & animais)

- Pensar [*think*] — não falar (5 anos, latência)
 Impensável [*unthinkable*] — medo do superego (desenvolve-se com a formação do superego)
 Pensar [*think*] — ter uma visão abrangente (desenvolve o significado através da vida)
 Refletir bem [*think out*] — efetuar uma dissecação mental deliberada (perguntar a Piaget)
 Refletir completamente [*think through*] — completar uma tarefa limitada de pensar (maturidade)
 Pensar [*think off*] — veredicto após consideração devida (2 anos + ou -)
 Pensar em [*think of*] — lembrar (antes de um ano)
 Pensar em [*think of*] — rememorar (depois de um ano)
 Pensar antes ou antever [*think forward*] — predizer conseqüências (muito cedo)

Uma criança de um ano pode não imaginar ou inventar [*think up*], mas ela certamente pensa [*thinks*]. Na medida em que possui um cérebro, ela o usa, mas as palavras que fala são três ou, talvez, apenas uma. Talvez pense com as palavras que entende, mas não pode usar. Existe obscuridade aqui. Seria imprudente perder tempo discutindo a data em que uma criança pensa. É certamente melhor comparar o pensamento com outras funções que têm existência paralela. Podemos encontrar funções que alguns chamariam de pensar e que outros se absteriam de incluir nessa categoria.

Não tentarei criar pensamentos originais aqui. Usarei simplesmente idéias que já me vieram antes e que empreguei em conferências e textos. Descobri (sem reivindicar originalidade) que temos de presumir que nada do que foi registrado se perde, pelo menos a partir da data do nascimento e, provavelmente, exatamente antes dessa data. Naturalmente, o que não é registrado não se acha em consideração (e há muito a dizer-se a respeito da maneira pela qual coisas, acontecimentos ou sensações só podem ser registradas tal como foram experienciados). Existe uma coisa chamada despertar prematuro do ego e, por outro lado, alguns bebês demoram em parecer notar qualquer coisa que não sejam as suas próprias sensações e funcionamento. As crianças autistas possuem em grau extremado esta tendência a ser e permanecer introvertidas.

Eu dividiria o que tenho a dizer em duas partes:

1. Catalogar (na saúde), e
2. a mente tornar-se explorada em defesa (O Pensar como substituto materno*)

1. Catalogar

Na saúde, parece que tudo o que é registrado é catalogado, categorizado e comparado. Estritamente falando, isto não é pensar, mas envolve o aparelho eletrônico que é utilizado no pensar. Presumivelmente, no pensar propriamente dito há um direcionamento deliberado da mente para uma tarefa mental específica que tem um certo objetivo limitado, ainda que, talvez, efêmero. Pode ser que a palavra "deliberado" precise ser renunciada em uma frase que admita motivação consciente e inconsciente.

Tenho apenas de olhar em torno e encontro isto enunciado melhor do que posso fazê-lo:

1. As palavras entre parênteses nesta lista foram escritas a mão após a palestra haver sido datilografada. [N. dos Orgs].

* Nas páginas adiante, D.W.W., ao se referir ao segundo item, utiliza o título colocado em parênteses para situar o leitor; já que estes textos não foram revisados pelo autor originalmente. (N. dos R.)

Sabemos muito pouco a respeito da ordenação pré-cognitiva do pensamento incipiente, mas desconfio que poderíamos descobrir mais a respeito de alguns de seus aspectos explorando de modo mais intenso, através de técnicas tais como a eletromiografia, as posturas íntimas e os movimentos expressivos do corpo. Nesse meio tempo, como se esperaria, os escritores criativos proporcionam exemplos de enunciados nominalmente discursivos que, ao serem examinados, apresentam algumas das características do simbolismo apresentacional e, às vezes, traços de uma matriz mais rica, talvez mais confusa, da qual suas palavras e imagens emergiram².

Pode-se fazer uma lista das propriedades do bebê humano:

Funcionamento corporal, sensório-motor

Elaboração imaginativa do funcionamento corporal (fantasia)

Adicione-se: A faculdade de catalogar, categorizar e comparar

a. nem sempre conscientes

As memórias

b. conscientes

museu

galeria (particular)

exposição

teatro

A função de comparação desenvolve vida própria e permite que se façam predições, o que se coloca a serviço da necessidade de preservar a onipotência. Paralelamente a isto, a elaboração da função, enriquecida por lembranças, se transforma em imaginação criativa, sonho e brinquedo (também a serviço da onipotência)

Desta maneira, o pensar vem a existir como aspecto da imaginação criativa; ele serve à sobrevivência da experiência de onipotência e é um ingrediente da integração.

Alguns bebês especializam-se no pensar e buscam palavras; outros especializam-se em experiências auditivas, visuais ou outras experiências sensoriais, e em lembranças e imaginação criativa do tipo alucinatório; estes últimos podem não buscar palavras. Não se discute se um é normal e o outro, anormal. Pode ocorrer um mal-entendido no debate, devido ao fato de que determinada pessoa que fala pertence ao tipo pensante e verbalizante, enquanto que outra pertence ao tipo que alucina no campo visual ou auditivo, ao invés de expressar o *self* em palavras. De alguma maneira, as pessoas que usam palavras tendem a reivindicar sanidade e os que têm visões não sabem como defender sua posição quando são acusados de insanidade. O argumento lógico, em realidade, pertence aos que verbalizam. O sentimento ou um sentimento de certeza, ou verdade, ou "real" pertence aos outros.

A psicanálise teve muita dificuldade em ajustar-se às necessidades daqueles que vêem e escutam primeiro e pensam depois. Os junguianos, em contraste, tenderam a atender aqueles que conceptualizam sem malabarismos verbais, e alguns acham que os junguianos não são tão bons na lógica e na realidade partilhada.

Dessa maneira, minha primeira idéia refere-se ao desenvolvimento do pensar a partir do catalogar, do categorizar e do comparar e estas funções começam muito cedo em verdade, ainda que levem tempo para desenvolver uma complexidade plena.

2. O Pensar como Substituto Materno

A segunda idéia tem a ver com a maneira pela qual o intelecto do bebê pode ser explorado. Em primeiro lugar, o intelecto é um aspecto da função de catalogar,

2. D. W. Harding, *The Hinterland of Thought*, em *Experience into Words: Essays on Poetry* (London, Chatto and Windus, 1963).

categorizar e comparar, permitindo que as lembranças se tornem acessíveis até elas se perderem na repressão primária ou secundária. O intelecto, então, possui seu próprio funcionamento, dependente da qualidade do aparelho eletrônico e, também, da maneira pela qual o desenvolvimento emocional do indivíduo está se formando.

A exploração do intelecto pode começar muito cedo, em uma percepção prematura do ego. Diz uma paciente: "Quando nasci, sentei-me e comecei a lecionar: Faça isso desta maneira". Ela mantém esta configuração pelo resto da vida. Em determinado ano ela realmente disse: "Farei o que gosto", e vê sua vida como um seguimento deste enunciado de filosofia pessoal.

Para demonstrar o que quero dizer, tomo um quadro simplificado de um bebê a ser alimentado. Ele se encontra em um estágio de dependência muito grande e a mãe está desempenhando bem o seu papel, adaptando-se às necessidades do bebê e sendo capaz de fazê-lo por causa de sua capacidade de entregar-se temporariamente a esta única tarefa: o cuidado de seu bebê. Ela se acha estreitamente identificada com ele e é capaz de pôr-se em seu lugar, por assim dizer.

A adaptação é um fato, e muito próxima de 100%, mas rapidamente se torna menos do que isso, de acordo com o desenvolvimento do bebê, que concede à mãe cada vez mais liberdade. O que é que se desenvolve no bebê? É a sua inteligência.

O bebê pensa consigo mesmo (enquanto grita) que tem realmente razão em fazê-lo, porque os ruídos que escuta fora de cena indicam que algo está vindo que atenderá exatamente as suas necessidades. Ele também tem as suas lembranças. Pode gritar, mas não está aflito, porque manteve a esperança, sabendo (por reunir dois mais dois) que o alívio se acha à mão, o alívio quanto a uma necessidade premente e a um senso de ameaça à onipotência. Este desenvolvimento da compreensão que o bebê tem, do que está se passando, resulta na incapacidade crescente da mãe de *fracassar em adaptar-se* às necessidades de seu bebê.

Um bebê rodeia a questão através do pensar e um outro o faz por meio da fantasia e por fruir imaginativamente a experiência, antes que ela se torne real.

Se tomarmos agora o caso de um bebê cujo fracasso da mãe em adaptar-se é rápido demais, podemos descobrir que ele sobrevive por meio da mente. A mãe explora o poder que o bebê tem de refletir, de comparar e de entender. Se o bebê possuir um bom aparelho mental, este pensar transforma-se num substituto para o cuidado e a adaptação maternas. O bebê "serve de mãe" para si mesmo através da compreensão, compreendendo demais. Trata-se de um caso de *Cogito, ergo in me potestate sum*.

No caso extremo, a mente e o pensar do bebê capacitaram este que agora cresce e adquire um padrão desenvolvimental, a passar sem os aspectos mais importantes do cuidado maternal de que todos os seres humanos necessitam, quais sejam, a confiabilidade e a adaptação às necessidades básicas. Tal como o "uísque", a nossa própria compreensão é mais confiável do que foi a figura materna.

Isto resulta na inteligência inconfortável de alguém cuja boa cabeça tornou-se explorada. A inteligência está ocultando um certo grau de privação. Em outras palavras, existe sempre, para aqueles cujo cérebro foi explorado, a ameaça de um colapso da inteligência e da compreensão para o caos mental ou para a desintegração da personalidade.

A inteligência e o pensar podem ser medidos, usados e apreciados, mas deve-se lembrar que a inteligência pode ser explorada e que ela pode ocultar coisas tais como a privação e a ameaça de caos. Um colapso parcial é clinicamente representado por uma organização obsessiva, com a desorganização achando-se sempre na virada da esquina.

O movimento para a frente no desenvolvimento emocional de um indivíduo se dá pelo distanciamento de um estado desorganizado e no sentido da integração, do

caos para a compreensão, da ignorância para o conhecimento e o poder de predizer, da dependência para a independência. O pensar é um dos aspectos do processo integrador, indo à frente da participação plena.

Repetindo a minha segunda idéia: enquanto que o pensar é um aspecto da imaginação criativa do indivíduo, ele pode tornar-se explorado na economia individual, em defesa contra a ansiedade arcaica e contra o caos, e contra tendências desintegradoras ou lembranças de colapso desintegrador relacionado com a privação.

Num sentido positivo, o pensar faz parte do impulso criativo, mas existem alternativas ao pensar e elas possuem algumas vantagens sobre ele. Exemplificando, o pensamento lógico leva longo tempo e pode nunca chegar lá, mas o lampejo de intuição não leva tempo e chega lá imediatamente. A ciência precisa de ambas estas maneiras de progredir. Achamo-nos aqui buscando palavras, pensando e tentando ser lógicos; e incluindo um estudo do inconsciente que permite uma imensa ampliação do raio de ação da lógica. Ao mesmo tempo, porém, precisamos ser capazes de buscar símbolos e criar imaginativamente e em linguagem pré-verbal; precisamos ser capazes de pensar alucinatoriamente.

Comentário Sobre Neurose Obsessiva e “Frankie”

*Versão escrita de observações efetuadas
no XXIV Congresso Psicanalítico Internacional,
Amsterdan, julho de 1965¹*

No debate, fiz dois comentários separados, um tendo a ver com a natureza da neurose obsessiva e o outro com o caso em debate.

Com referência à teoria da neurose obsessiva, tentei formular um conceito de um funcionamento intelectual ex-cindido [*split-off*], que acredito constituir aspecto essencial de um caso rematado de neurose obsessiva. Os conflitos pertinentes à personalidade localizaram-se nesta área intelectual ex-cindida. É por causa desta cisão que nunca pôde sair qualquer resultado dos esforços e atividades do neurótico obsessivo. O melhor que pode acontecer é que, de momento, a pessoa obsessiva tenha conseguido colocar uma certa ordem no lugar da idéia de confusão. Trata-se de uma alternância infundável e ela tem de ser contrastada com a tentativa universal dos seres humanos de prover a experiência de algum tipo de estruturação da personalidade ou da sociedade em defesa contra a experiência do caos. Aqui existe a possibilidade de um resultado, porque o trabalho não está sendo feito na área ex-cindida da personalidade.

Com referência ao caso, limitei minhas observações a um estudo do tratamento de Frankie, tal como relatado em fiel detalhe por sua analista infantil². Prefaciei minhas observações pelo lembrete de que, se nos achamos aptos a debater o caso em detalhe, é porque nos achamos em dívida com o seu relatório e, em verdade, a descrição deste tratamento analítico tem sido corretamente usada por mais de uma década no ensino da técnica psicanalítica. Fiz uma tentativa de examinar de modo crítico o seu manejo da primeira entrevista.

Frankie começou sua primeira sessão construindo um hospital que foi separado em um “departamento de senhoras”, um “departamento de bebês” e um “departamento de homens”. No saguão, um menino solitário de 4 anos de idade achava-se sentado completamente sozinho, em uma cadeira situada em posição elevada.

1. Do *International Journal of Psycho-Analysis*, 47 (1966), a ser consultado para um resumo do artigo debatido e outras observações. Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.
2. Ver Berta Bornstein, *The Analysis of a Phobic Child*, em *The Psycho-Analytic Study of the Child*, vol. 3/4 (London, Imago, 1949).

Os detalhes posteriores do jogo mostraram que esse era um lugar onde bebês nascem, e o jogo, relata a analista, foi repetido na análise durante muitas semanas. Ele “revelava a intensidade da fúria do menino contra a mãe e a irmã”. Indubitavelmente, o material justificava esta presunção e as interpretações que se seguiram. O detalhe que escolhi para debate era que, no próprio início, havia o menino, “sentado completamente sozinho, em uma cadeira situada em posição elevada”. Senti que se poderia tomar este detalhe e conceder-lhe a mais completa importância possível, porque foi isto o que ele trouxe à análise, com a idade de 5 anos e meio. Em uma atmosfera onde havia mães e bebês, embora ele de fato tenha separado os bebês recém-nascidos das mães, havia a idéia de mães (e pais, também) preocupados, como seres humanos, com bebês. Isto se aplica à sustentação, por parte da mãe, do bebê no útero e, também, ao cuidado geral pós-natal a seu bebê. Frankie, evidentemente, queria tornar claro que, de seu ponto de vista, ele se achava sentado em uma cadeira situada em posição elevada; em outras palavras, era sustentado por uma coisa, um aparelho, ou seja o que for que se queira chamá-lo. Esta coisa é uma função ex-cindida da mãe, não fazendo parte da atitude dela. Chamei a atenção para o fato de que este detalhe poderia ter importância muito grande neste caso, provavelmente sendo aquilo que, acima de tudo o mais, o menino desejava transmitir à analista. Há material que vem em apoio desta idéia, porque a analista escreve que

Frankie fora uma criança planejada, que a gravidez dela decorrera sem problemas e que se sentira feliz e contente em antever a chegada de seu primeiro bebê. O parto fora normal, a criança era sadia, mas contudo, no primeiro momento em que segurou o bebê nos braços, sentira-se alheia a ele. O choro do menininho dera-lhe uma impressão estranha e desconfortável. Sentira-se inteiramente diferente em relação à sua segunda-criança, uma menina.

Num debate ulterior, há lugar para pensar-se que a mãe, em seu primeiro relacionamento com o menino, sofreu a interferência de aspectos inconscientes derivados do relacionamento dela com o irmão. Sugeri que a totalidade do caso poderia ser descrita girando em torno deste detalhe, incluindo até mesmo a fobia básica de elevadores. Não existe nada que uma criança possa fazer a respeito de ser sustentada por uma função ex-cindida, exceto pensar na mecânica de ela funcionar de modo bom ou mau. Haveria uma alternância entre a exultação (ou algum equivalente desta) e o ser deixado cair, e a descrição da análise ulterior deste paciente quando rapaz certamente não contradiz esta idéia. Fui mais além e disse que, embora uma grande quantidade de trabalho bom houvesse sido feita nessas análises, não se pode chegar à cura deste homem, a menos que este primeiro detalhe de sua análise, à idade de cinco anos e meio, possa ser atendido e o desamparo dele com respeito a ser cuidado por uma função materna ex-cindida, em vez de por uma mãe, possa ser atingido no *setting* transferencial.

Este comentário é feito com base na teoria do relacionamento bebê-mãe que leva em consideração um estágio de dependência absoluta, isto é, um estágio antes que o bebê tenha separado a mãe dos pormenores da provisão do cuidado infantil³. Tem de haver uma época na história de todo bebê em que, do ponto de vista deste, surge a idéia de um reconhecimento da mãe que provê. Naturalmente, se houver uma cisão ambiental, ou seja, uma mãe e algum dispositivo mecânico que supre as necessidades de cuidado infantil, então a tarefa inerente do bebê com respeito ao reconhecimento de

3. Winnicott, “A Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil” (1960), em *O Ambiente e os Processos da Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983; London, Hogarth Press; New York, International Universities Press, 1965).

que os detalhes desse cuidado são expressão do amor de uma pessoa, torna-se não apenas mais difícil, mas na realidade, impossível. De alguma maneira ou outra, na transferência, cabe ao analista a tarefa muito pesada de corrigir a cisão ambiental que, na etiologia do caso, tornou a síntese impossível para o bebê.

Reconheço que, ao criticar estas duas análises desta maneira, estou tentando usar com efeito o material muito rico proporcionado por elas, numa tentativa de efetuar uma sugestão que possa demonstrar ser construtiva, neste caso ou em um caso semelhante.

Nota Sobre o Relacionamento Mãe-Feto

Sem data: provavelmente redigido em meados da década de 60

Existem muitas maneiras de colocar em palavras a relação de uma mãe com o bebê que ela carrega e dá à luz. Em primeiro lugar, naturalmente, acha-se o simples enunciado biológico.

Nos textos psicanalíticos existem copiosas referências às fantasias conscientes e inconscientes da mãe a respeito do filho. Com frequência encontramos a expressão "bebê" igualada a pênis, fezes, dinheiro ou peças de mobília, almofadas, etc. Ouvimos também falar da identificação da mãe com o bebê e de sua identificação desse bebê com um ou outro dos pais dela, e o amor, o ódio e o medo do bebê podem ser explicados ao longo destas linhas.

O relacionamento mãe-feto também pode ser enunciado com vantagens nos seguintes termos: se a capacidade biológica da mãe em produzir um bebê vivo íntegro e real é representada por 100%, sua capacidade psicológica pode ser enunciada como uma percentagem aproximada. Por isto quero dizer que mãe alguma é 100% capaz de produzir na fantasia uma criança viva e total. Algumas mães, em verdade, mal chegam à capacidade de 50%, e imagine-se a sua confusão, então, quando se descobrem frente a frente com um bebê que, dizem haverem trazido ao mundo e no qual, contudo, não acreditam inteiramente. Ele é apenas semi-humano, apenas semivivo, apenas semicompleto ou apenas semi-sadio. Pode cair em pedaços se não for mantido junto pelas roupas ou pelas faixas. Sua barriga pode estar cheia de vento, ao invés de vísceras, ou pode não haver nada dentro dele, exceto mijo e merda. Ou ele pode ter uma das deformidades bem-conhecidas, cabeça d'água, palato fendido, pé torto, ou os chamados estigmas da degenerescência. Pode ser um monstro.

De qualquer modo, não é ele, nem ela, mas sim uma *coisa* [IT].

Se um bebê *realmente* nasce com um defeito ou deformidade, o efeito prejudicial disso sobre a mãe e o pai pode ser bastante espantoso, proporcionando o oposto da tranquilização contra temores de incapacidade de produzir um ser humano 100% perfeito. Sei de um caso em que a enfermidade de um homem vinha desde quando sua esposa dera luz a um monstro.

A amamentação concede à mãe (e ao pai, por procuração) uma segunda oportunidade. O cuidado e a amamentação pessoais fazem a mãe sentir que a criança é real,

isto é, se ela previamente duvidou disso, devido à sua capacidade inferior a 100% de produzir um bebê na fantasia.

Os abortos espontâneos com frequência dão testemunho desta condição. Digamos que um aborto espontâneo de três meses representa uma capacidade de 33,33%. Se uma mulher grávida achar-se em análise e o analista foi incapaz de chegar a tempo à interpretação das fantasias que a paciente tem em relação à sua parte interna (ou das partes internas em geral), a paciente pode fazer um aborto espontâneo quase como um ato de honestidade. É como se ele estivesse alegando o que existiria de falso, se ela fosse continuar com a gravidez e produzir um bebê íntegro. Só existe esperança se o analista puder trazer as fantasias do interior do corpo para a análise e, dessa maneira, enfrentar o interior biológico afastando de sua função secundária de depositário de fantasias conscientemente repudiadas.

A pista para a análise deste aspecto da maternidade é a interpretação da relação da fantasia com o funcionamento orgástico (principalmente oral) na situação transferencial. Desta maneira, o mundo interno da fantasia passa a ser sentido como real, algo que não precisa ser secreto e que se pode pessoalmente possuir; ao mesmo tempo, o analista assiste ao desaparecimento da *colocação* até então compulsiva, pela paciente, do material de fantasia pós-incorporativo *dentro da barriga*.

A função biológica pode então prosseguir sem perturbações e a mãe levar seu feto a termo íntegro, e não precisa ficar doente, mesmo que passe pela triste experiência de dar à luz um bebê deformado.

Ausência e Presença de um Sentimento de Culpa, Ilustradas em Duas Pacientes

Sem data: provavelmente redigido em 1966¹

I

No curso do tratamento analítico de uma mulher que precisou escavar muito fundo e nas fases muito iniciais de sua vida chegamos a um estágio em que meus equívocos estão se tornando cada vez mais importantes, equívocos que cometo e acho que todos os outros analistas devem cometer ou, de uma ou outra maneira, falhar. Não existe dúvida de que o padrão do fracasso do analista — se ele estiver livre de uma configuração estabelecida, sua própria — é pertinente ao padrão em que o meio ambiente do próprio paciente lhe falhou em um estágio importante. O problema é que, no trabalho muito sensível que podemos às vezes fazer no decurso de um período limitado de tempo, podemos ser capazes de dar ao paciente algo melhor do que ele ou ela obtiveram no começo, ainda que, naturalmente, apenas sob forma simulada. Não cuidamos um paciente 24 horas por dia, tal como os pais cuidam os filhos, e a mãe, o seu bebê. De certa maneira, aprende-se a temer os finais deste período em que se fez um trabalho muito sensível na adaptação às necessidades do paciente. O fim chega por alguma maneira em que outros interesses desviam nossa atenção, de maneira que o paciente não se acha mais na posição de “filho único”, não é mais a nossa preocupação. O paciente então leva um choque, dilacera-se, e a culpa é nossa. A única coisa que podemos fazer é reconhecer o fato, quando confrontados com ele. As dificuldades surgem do trabalho muito sensível e bom que acabamos de fazer. Fizemos surgir esperanças. O paciente foi capaz de nos deixar deslocar um genitor ou uma figura genitorial insatisfatória. Agora, naturalmente, quando falhamos o fracasso é pior, porque, quando tivemos êxito, o que fizemos foi melhor.

Acabei de chegar a este ponto com uma paciente e o resultado é muito aflitivo, tanto para a paciente quanto para mim. Por mais que me diga que eu acabaria por ser aquele que fracassa, não posso deixar de sentir-me completamente horrível, porque posso facilmente ver que o erro que cometi poderia ter sido evitado. Neste caso

1. Isto foi encontrado entre os papéis de Winnicott, junto com a conferência “The Absence of Sense of Guilt” (1966), que aparece hoje em seu livro *Deprivation and Delinquency* (London e New York, Tavistock, 1985). [N. dos Orgs.]

particular, permiti-me ser enganado por um momento em que a paciente parecia estar quase normal e querendo falar a respeito de meu trabalho e de minha vida. Apesar de tudo o que sei e acredito, caí nesta armadilha e eventualmente, em um estado de anseio por ter alguém com quem falar a respeito de mim, fiz uma ou duas referências a preocupações alternativas minhas. A princípio, naturalmente, a paciente achou isso fascinante e ficou contente em saber a respeito de eu ser vivo e de minha vida e outros interesses. Em breve, contudo, a reação começou, como eu sabia que aconteceria assim que abri a boca. Dentro de poucos dias, a paciente achava-se completamente destruída e a culpa era minha. A agonia por que passou foi tremenda e, se houvesse cometido suicídio em várias ocasiões, o teria feito para evitar exatamente essa agonia. Quem quer que não se ache empenhado neste trabalho poderia achar que aqui o assunto acabaria. A paciente ficaria com muita raiva de mim por eu ser exatamente como a sua mãe, apenas pior que esta, porque de início havia sido melhor. Mas não foi isto o que aconteceu. Esta paciente entrou em um estado em que sentiu que tinha de ser abominável. Ninguém teria possibilidade de fazer esse tipo de coisas exceto em reação a alguma horrível qualidade nela que levava todos a fazerem o pior.

Será visto aqui que ela fabricou uma situação na qual experienciava sentimentos de culpa muito graves, em torno dos quais poderia facilmente organizar sua vida, se não cometer suicídio baseado na expiação. Poderia ser um caso de trajes penitenciais e cinzas e nenhum desfecho. Como analista dela, tive oportunidade de vir a conhecer isto que lhe acontece com grandes detalhes e posso perceber que o que ela realmente não pode suportar é que eu possa ter cometido um equívoco ou lhe falhado, não porque ela seja abominável, mas por causa de algo a meu respeito, algo de que ela não teria possibilidade de estar ciente por se achar fora de sua esfera de influência. É isto o que ela não pode manejar e a totalidade de sua vida constitui ilustração disto. Se me fosse permitido simplificar um pouco, poderia dizer que o que fiz de errado foi exatamente equivalente ao que a mãe dela fez ao ficar grávida e dessa maneira interromper o relacionamento de filha única. Isso foi administrado de maneira bastante má e, de qualquer modo, a mãe teve de conceder atenção à sua gravidez bastante cedo, isto é, antes que a minha paciente contasse um ano de idade. Nessa tenra idade, um bebê ainda não conseguiu uma gama ampla de defesas e, na realidade, não chegou ainda realmente a acordo com o fato de existir um universo externo àquele do qual ele é o centro. A mãe, aqui, encontra-se apenas no processo de introduzir a criança aos duros fatos que recebem o nome de Princípio da Realidade. Noutra maneira de dizê-lo, esta criança, com um ano de idade, não podia saber absolutamente nada a respeito da união dos pais em todas as suas formas, algo com que poderia haver lidado à idade de dois ou três anos, identificando-se com um ou outro em alguma forma do ato de união.

O meu fracasso, portanto, foi algo que ela teve de tentar trazer para dentro da área de sua própria onipotência, e só poderia fazer isso por conhecer muito bem suas próprias horríveis idéias e impulsos, sentir-se culpada e, dessa maneira, explicar o que eu havia feito em termos de retribuição. É verdade que esta paciente com frequência desejou destruir-me, mas isto, no que é mais real, tem a ver com os aspectos muito primitivos de seu amor, onde amar é relacionar-se objetivamente. Trata-se de algo que pode desenvolver-se em comer e em idéias de incorporar aquilo que é valorizado. O que a minha falha causara fora desviar para um caminho lateral a paciente quanto a este tema principal, de maneira que ela agora queria matar-me, não como parte do amor, mas em reação a eu haver rompido os processos de seu crescimento. Talvez se possa perceber por esta ilustração que esta paciente não sentiria culpa se tivesse de matar-me hoje, porque tenho de ser morto e ela é simplesmente o agente do destino. O lugar onde, no processo de desenvolvimento, um senso verdadeiro de culpa existia, era justamente lá onde ela era capaz de perceber que, amando-me, ela me comeria, e

que as idéias em torno de tudo isto envolveriam a minha destruição. Ela estava apenas chegando perto disso que sente como real para ela quando chega lá. Falhando-lhe, fiz o que os pais dela haviam feito, e a sua mãe fazer-lhe isto tão cedo proporcionou-lhe uma vida inteira de tentar sentir-se culpada, sem nunca conseguir.

Repetidas vezes ela conseguiu elaborar o histrionismo do remorso em torno da destruição compulsiva, mas nada disso jamais lhe parecera real, ainda que, em verdade, a destruição pudesse ser bastante real. A partir disto é possível perceber o que queria dizer uma paciente que veio até mim há cerca de quinze anos e cujas primeiras palavras foram: "Quero que você me ajude a descobrir a minha própria maldade". Esta paciente tivera um meio ambiente muito terrível desde o início e foram-lhe necessários anos de análise para conseguir chegar ao lugar onde ela soubesse a respeito da maldade que encontraria em si mesma em um bom meio ambiente.

II

Gostaria de examinar um tipo bastante diferente de paciente, a fim de tentar olhar de um novo ponto de vista o significado do senso de culpa. Esta paciente é uma mulher que provavelmente seria diagnosticada como potencialmente esquizofrênica. No curso de um tratamento ela é esquizóide em fases recorrentes, embora também assemelhe-se mais a uma psiconeurótica em grande parte do tempo. Ela não gostaria que eu dissesse isto, porque valoriza a parte esquizóide de sua personalidade e despreza a psicose. Entenderão que a psicose acha-se muito próxima de coisas tais como ambivalência e conciliação e todas as coisas que chamamos de sadias. A vida só é possível com base na conciliação. O método democrático é uma conciliação acordada, e o mesmo é a socialização. A parte esquizóide da enfermidade desta mulher a faz desprezar a conciliação. Há um certo tipo de idealização que é essencial para o seu bem-estar. Um dos resultados disto é que a sua doença tende a permitir-lhe alcançar o que quer e ela é inteligente o bastante para fazer isto funcionar em grau espantoso. Se consegue o que quer, não há então conciliação, e ela pode dar-se ao luxo de esperar. Para esta mulher, o senso de culpa pode ser completamente esmagador. Nada tem a ver com a idéia que a sociedade faz do que é bom ou mau e ela abandonou sua religião porque, tal como se apresentava a ela, a igreja parecia lhe fornecer um senso de valores que era arbitrário. Onde se sente esmagada pela culpa é quando sente haver traído a si própria. Sente que preferiria ficar doente o resto da vida do que ficar bem se isto significasse aceitar a conciliação. Isto a torna muito difícil como pessoa. Entre outras coisas, esta mulher teve consideráveis dificuldades sexuais, a começar pela convicção de que, se realmente amasse um homem, ele se afastaria dela. Gradativamente, conseguiu ser capaz de permitir a um homem apaixonar-se por ela, e um homem de quem gosta muito. Houve uma longa série a culminar por algo que poderia realmente, seria de pensar, transformar-se em um casamento. Têm havido algumas experiências sexuais entre essas duas pessoas. Como se pode imaginar com este tipo de caso, não existe qualquer culpa associada a ter sexo ou não ter sexo. A ocasião em que a paciente sentiu culpa de um tipo extremado foi quando houve apenas a possibilidade de que pudesse ficar grávida. A partir deste ponto, ela retirou sua condescendência sexual e gradualmente começou a organizar o rompimento do relacionamento.

Seus sonhos demonstraram que, se viesse a ficar grávida, isto só poderia acontecer com alguém que ela ainda não encontrou e que é exatamente a pessoa certa. Tem sido uma luta para ela sequer encarar a possibilidade de que a pessoa certa nunca apareça. O fato é que a pessoa certa teria sido um homem do passado, nas circunstân-

cias ordinárias seu pai, alguém que apareceria em sua vida por causa do amor de sua mãe pelo seu homem. O homem certo apareceria em sua vida como uma complicação em um relacionamento básico com a mãe. No caso dela, o relacionamento básico com a mãe era deficiente. O relacionamento entre os pais fora problemático e, de qualquer modo, o pai quisera um menino e nunca tivera muito interesse por ela como menina, de modo algum. Por todas as razões, portanto, o homem certo não apareceu, de maneira que o que lhe resta não é procurar um parceiro para casar, mas sim procurar o que perdeu, o primeiro caso amoroso dentro da família. Ela pode não conseguir encontrar um homem que esteja, primeiramente, disposto a desempenhar o papel que lhe foi atribuído, sendo o homem certo, com o sexo sob um tabu, e, depois, capaz e disposto a gradualmente transformar-se e tornar-se um marido no decorrer do tempo.

Estou fornecendo isto como ilustração do tipo de senso de culpa que é muito arrebatado e pertence à catástrofe da traição de si. Comparados com ele, os ensinamentos moralistas parecem bastante débeis. A variedade comum de moralista olharia para esta mulher e diria que ela tem uma deficiência do senso de culpa. Pode-se demonstrar que ela é uma ladra, uma mentirosa e uma trapaceira, e que não tem senso de culpa a respeito de sexo extramarital. Não lhe ocorreria preocupar-se com que um homem em que estivesse interessada fosse casado. Revela-se, contudo, que todo o seu padrão de vida é determinado por um senso de valores absolutos, que a capacitam a perceber, de um só olhar, se um quadro abstrato é verdadeiro ou falso. Gosto de fornecer isto como exemplo porque eu, por exemplo, posso olhar para uma abstração e não saber como começar a julgá-la, porque ela não toca em algo que particularmente me seja pertinente. Com esta paciente, não existe dúvida, o julgamento é imediato e acontece corresponder de modo muito próximo ao juízo da norma ordinária da crítica artística altamente sensível. Para esta paciente, uma linha falsa em um quadro abstrato é tão pior do que imoral que outra linguagem tem de ser encontrada para a sua descrição ou a pintura simplesmente tem de ser rejeitada. Por outro lado, uma abstração que soa verdadeira possui imenso valor. Juntamente com isto, como se pode imaginar, esta paciente só pode começar a existir e a sentir-se real em um meio ambiente onde a arquitetura e todos os outros aspectos do meio ambiente não-humano sejam de alto padrão. Isto é muito espinhoso e difícil de encontrar, e alguns dos melhores tempos que a minha paciente teve foram passados em um mosteiro onde não havia nada feio. Imagino que se ela ficar bem, será capaz de viver entre tudo o que é sórdido, como a maioria de nós tem de fazer, mas se pode ver que esta paciente não pode olhar para o futuro e dizer: — Quero ficar bem, exatamente por causa desta perda de coisas sagradas, em troca de algo que será feio, mal-enjambrado e sórdido.

Sobre os Elementos Masculinos e Femininos Ex-cindidos [Split Off]

Em 2 de fevereiro de 1966, perante um Encontro Científico da Sociedade Psicanalítica Britânica, Winnicott leu um trabalho intitulado "Os Elementos Masculinos e Femininos Ex-cindidos a Serem Clinicamente Encontrados em Homens e Mulheres: Inferências Teóricas". Posteriormente, ele incluiu-o como subseção do Capítulo 5 de seu livro *Playing and Reality* (1971).

O presente Capítulo começa por uma reprodução desse trabalho (Seção I). Na Seção II encontram-se três exemplos de material clínico, o primeiro escrito em 1959 e os outros em 1963, que foram encontrados, datilografados, na pasta "Idéias" de Winnicott. Eles se relacionam ao mesmo paciente e ao mesmo tema geral do trabalho e foram provavelmente utilizados tanto para o ensino, quanto em seu pensamento preliminar em torno do tema da dissociação entre os elementos masculinos e femininos. Material ulterior relativo a este paciente pode ser encontrado nos Capítulos 10 e 15 deste volume.

A Seção III contém a parte principal da resposta de Winnicott a comentários feitos a seu trabalho, escrito para o *Psychoanalytic Forum*. Os comentários foram efetuados por Margaret Mead, Masud Khan, Richard Sterba, Herbert Rosenfeld e Decio Soares de Souza. Embora tanto os comentários quanto a resposta a eles tenham sido escritos em 1968-69, eles apareceram, juntamente com o artigo original, no *Psychoanalytic Forum*, em 1972.

Os Organizadores

I. Os Elementos Masculinos e Femininos Ex-cindidos Encontrados em Homens e Mulheres

*Artigo lido perante a Sociedade Psicanalítica Britânica,
em 2 de fevereiro de 1966¹*

Nada existe de novo, dentro ou fora da psicanálise, na idéia de que homens e mulheres possuam uma "predisposição no sentido da bissexualidade".

Tento usar aqui o que aprendi a respeito da bissexualidade em análises que se dirigiram passo a passo no sentido de um certo ponto e enfocaram determinado detalhe. Nenhuma tentativa será feita aqui de remontar-se os passos através dos quais uma análise chega a este tipo de material, mas se pode dizer que geralmente uma grande quantidade de trabalho tem de ser feita antes que este material se torne significativo e exija prioridade. É difícil ver como todo este trabalho preliminar possa ser evitado. A lentidão do processo analítico é manifestação de uma defesa que o analista tem de respeitar, tal como respeitamos todas as defesas. Embora seja o paciente que está todo o tempo ensinando o analista, este último tem de ser capaz de saber, teoricamente, a respeito dos assuntos que interessam aos aspectos mais profundos ou centrais da personalidade, para que não fracasse em reconhecer e a atender novas exigências à sua compreensão e técnica quando, finalmente, o paciente torna-se capaz de trazer questões profundamente enterradas para o conteúdo da transferência, por esse meio fornecendo oportunidade para a interpretação mutativa. O analista, ao interpretar, mostra o muito e o pouco da comunicação do paciente que ele é capaz de receber.

Como base para a idéia que desejo apresentar aqui, sugiro que a criatividade é um dos denominadores comuns de homens e mulheres. Em outra linguagem, contudo, a criatividade é prerrogativa das mulheres, e, em outra linguagem ainda, constitui uma característica masculina. É esta última, entre as três, que me interessa no que segue aqui.

Dados Clínicos

Caso Ilustrativo

Proponho iniciar por um exemplo clínico, referente ao tratamento de um homem de meia idade, casado, com família, e bem-sucedido em uma das profissões liberais. A análise progrediu ao longo das linhas clássicas. O homem havia tido uma longa análise e não sou, de maneira alguma, seu primeiro psicoterapeuta. Um grande trabalho já foi feito por ele e por cada um de nós, terapeutas e analistas, por nossa vez, e muita mudança foi ocasionada em sua personalidade. Mas ainda existe algo que ele afirma tornar-se impossível parar. Sabe que o que veio buscar não foi atingido. Se tentar realizar as perdas, o sacrifício será grande demais.

Na fase atual desta análise, chegou-se a algo que é novo para *mim* e tem a ver com a maneira pela qual estou lidando com o elemento não-masculino em sua personalidade.

Certa sexta-feira o paciente veio à análise e fez seu relatório de maneira muito semelhante à usual. O que me impressionou nesse dia foi que o paciente estava falando a respeito de *inveja do pênis*. Utilizo este termo de modo pensado e tenho de admitir o fato de que ele era apropriado aqui, em vista do material e da apresentação deste. Obviamente a expressão “inveja do pênis” não é costumeiramente aplicada na descrição de um homem.

A mudança pertinente a esta fase específica aparece na maneira pela qual manejei isso. Nesta ocasião particular, disse-lhe: — Estou escutando uma garota. Sei perfeitamente bem que você é homem, mas estou escutando uma garota e falando com uma. Estou-lhe dizendo: Você está falando sobre inveja do pênis.

Quero enfatizar que isto nada tem a ver com homossexualidade.

(Foi-me apontado que minha interpretação, em cada uma de suas duas partes, poderia ser imaginada como relacionada ao brincar e, até onde possível, afastada da interpretação autoritária que é vizinha da doutrinação).

Ficou-me claro, pelo efeito profundo que causou a interpretação, que minha observação fora de alguma maneira adequada e, em verdade, eu não estaria relatando este incidente neste contexto se não fosse pelo fato de que o trabalho iniciado nessa sexta-feira na realidade resultou em um círculo vicioso. Eu me acostumara a uma rotina de bom trabalho, boas interpretações, bons resultados imediatos e, depois, à destruição e à desilusão que se seguiam a cada vez, por causa do reconhecimento gradual, pelo paciente, de que algo fundamental permanecera inmutado; havia este fator desconhecido que mantivera este homem trabalhando em sua própria análise por um quarto de século. Viria o seu trabalho comigo a ter o mesmo destino que o realizado com os outros terapeutas?

Nesta ocasião, houve um efeito imediato, sob forma de aceitação intelectual e alívio, e, depois, efeitos mais remotos. Após uma pausa, o paciente disse: “Se eu fosse falar a alguém a respeito dessa garota, seria chamado de louco”.

A questão poderia ter sido deixada repousar aí, mas fico contente, em vista dos acontecimentos subseqüentes, por ter ido em frente. Foi minha observação seguinte que me surpreendeu e fechou a questão. Eu disse: “Não é que *você* tenha contado isto a alguém; sou *eu* que vejo uma garota e escuto-a falar, quando, na realidade, há um homem em meu divã. O louco sou *eu*”.

Não tive de elaborar este ponto, porque ele deu no alvo. O paciente disse que agora se sentia são em um meio ambiente louco. Em outras palavras, fora agora liberado de um dilema. Como disse subseqüentemente: “Eu mesmo nunca poderia dizer (sabendo ser homem): sou uma garota. Não sou louco assim. Mas você o disse, e falou para ambas as partes de mim”.

A loucura que era minha capacitou-o a ver-se como uma garota *desde a minha posição*. Ele próprio sabe que é homem e nunca duvida sê-lo.

É evidente o que estava acontecendo aqui? De minha parte, precisei passar por uma profunda experiência pessoal para chegar à compreensão que sinto haver agora atingido.

Este estado complexo de coisas possui uma realidade especial para este homem porque ele e eu fomos impulsionados à conclusão (embora incapazes de prová-la) de que sua mãe (que não vive mais) viu um bebê menina quando o viu quando bebê, antes de vir a pensar nele como menino. Em outras palavras, este homem teve de ajustar-se à idéia dela que seu bebê seria e era uma menina. (Fora o segundo filho, e o primeiro também fora menino.) Temos boas provas, provindas da análise, de que no manejo inicial, a mãe o segurava e dele tratava por todos os tipos de maneiras físicas como se não conseguisse percebê-lo como masculino. Com base neste padrão, ele dispôs posteriormente as suas defesas, mas era a “loucura” da mãe que via uma menina onde existia um menino, e isto fora trazido diretamente para o presente por eu haver dito: “O louco sou eu”. Nessa sexta-feira ele foi embora profundamente comovido e sentido que esta fora a primeira mudança significativa em análise em longo

tempo (embora, como já disse, tivesse havido um progresso contínuo no sentido de um bom trabalho sendo feito)¹.

Gostaria de fornecer mais detalhes relativos a este incidente de sexta-feira. Quando ele retornou, na segunda-feira seguinte, disse-me que estava doente. Era-me inteiramente claro que tinha uma infecção e lembrei-o de que sua esposa a teria no dia seguinte, o que de fato aconteceu. Apesar disto, ele estava me convidando a *interpretar* esta doença, que começara no sábado, como se fosse psicossomática. O que tentou me dizer foi que na noite de sexta tivera uma relação sexual satisfatória com a esposa, de maneira que *deveria* ter-se sentido melhor no sábado, mas ao invés de sentir-se melhor, caíra doente e sentira-se doente. Consegui deixar de lado o transtorno físico e falar a respeito da incongruência de ele sentir-se enfermo e após a relação sexual, que sentira dever ser uma experiência curativa. (Ele poderia, em verdade, ter dito: "Estou com gripe, mas apesar disso, sinto-me melhor comigo mesmo".)

A minha interpretação continuou ao longo das linhas iniciadas na sexta-feira. Disse-lhe: "Você sente que deveria estar satisfeito que houve aqui uma interpretação minha que liberou um comportamento masculino. *A garota com quem eu estava falando, contudo, não quer que o homem se libere, e, em verdade, não está interessada nele.* O que ela quer é o reconhecimento pleno de si própria e de seus próprios direitos sobre o corpo de você. A inveja do pênis dela inclui especialmente a inveja de você, como homem". Prossegui: "O sentir-se doente é um protesto do *self* feminino, dessa menina, porque ela sempre teve esperança de que a análise em realidade descobrisse que esse homem, você mesmo, é e sempre foi uma garota (e *ficar doente* é uma gravidez pré-genital). O único final para a análise que essa garota pode buscar é a descoberta de que você na realidade é uma menina". A partir disto, podia-se começar a entender a convicção dele de que a análise nunca poderia terminar².

Nas semanas subsequentes houve grande quantidade de material a confirmar a validade de minha interpretação e minha atitude, e o paciente sentiu que podia ver agora que sua análise deixara de achar-se sob sentença de interminabilidade.

Posteriormente, pude ver que a resistência do paciente deslocara-se agora para denegação da importância de eu haver dito: "O louco sou eu". Ele tentou fazer passar isto como sendo apenas a minha maneira de exprimir as coisas, uma figura de retórica que podia ser esquecida. Descobri, contudo, que aqui se encontra um daqueles exemplos de transferência delirante que deixam igualmente intrigados pacientes e analistas, e o ponto crucial do problema do manejo acha-se exatamente aqui, nesta interpretação, a qual confesso quase não me permiti fazer.

Quando me concedi tempo para pensar a respeito do que havia acontecido, fiquei intrigado. Não existia aqui nenhum conceito teórico novo, nenhum novo princípio de técnica. Na realidade, eu e meu paciente já havíamos percorrido este terreno antes. Contudo, tínhamos aqui algo novo, novo em minha própria atitude e novo em sua capacidade de fazer uso de meu trabalho interpretativo. Decidi render-me ao que quer que isso pudesse significar em mim e o resultado pode ser encontrado neste trabalho que estou apresentando.

Dissociação

A primeira coisa que notei foi que nunca antes eu aceitara plenamente a dissociação completa entre o homem (ou a mulher) e o aspecto da personalidade que tem o sexo oposto. No caso deste paciente, a dissociação era quase completa.

1. Para um exame detalhado do papel-de-espelho da mãe no desenvolvimento infantil, ver *Mirror-Role of Mother and Family* (1967), em *Playing and Reality* (London, Tavistock; New York, Basic Books, 1971; Penguin, 1974). — D. W. W.
2. Entender-se-á, espero, que não estou sugerindo que a doença física muito real deste homem, gripe, fosse ocasionada pelas tendências emocionais que coexistem com as físicas. — D. W. W.

Aqui, então, descobri-me com um novo fio para uma velha arma, e fiquei pensando como isto afetaria ou poderia afetar o trabalho que eu estava fazendo com outros pacientes, homens e mulheres, meninos e meninas. Decidi, portanto, estudar este tipo de dissociação, deixando de lado, mas não esquecendo todos os outros tipos de cisão.

Elementos Masculinos e Femininos em Homens e Mulheres³

Havia neste caso uma dissociação que estava a ponto de romper-se. A defesa da dissociação estava dando lugar a uma aceitação da bissexualidade como sendo uma qualidade do *self* total ou unitário. Vi que estava lidando com o que poderia ser chamado de *elemento feminino puro*. A princípio, foi uma surpresa para mim que só pudesse chegar a isto examinando o material apresentado por um paciente do sexo masculino⁴.

Uma outra observação clínica é pertinente a este caso. Uma parte do alívio que se seguiu à nossa chegada ao novo patamar para o trabalho conjunto, provinha do fato de que podíamos agora explicar por que as minhas interpretações, feitas com bons fundamentos, a respeito do uso de objetos, de satisfações eróticas orais na transferência, de idéias orais-sádicas com respeito ao interesse do paciente no analista como objeto parcial ou como uma pessoa com seio ou pênis, porque essas interpretações, repito, nunca haviam sido mutativas. Elas eram aceitas, mas e daí? Agora que a nova posição havia sido atingida, o paciente sentiu um senso de relacionamento comigo, e um senso extremamente vívido. Tinha a ver com identidade. O elemento feminino puro e ex-cindido encontrara uma unidade primária comigo como analista, e isto proporcionou ao homem um sentimento de haver começado a viver. Fui afetado por este detalhe, como aparecerá em minha aplicação à teoria do que descobri neste caso.

Adendo à Parte Clínica

É recompensante passar-se em revista o próprio material clínico atual mantendo-se em mente este exemplo de dissociação, o elemento ex-cindido de menina em um paciente do sexo masculino. O tema pode rapidamente tornar-se vasto e complexo, de maneira que umas poucas observações têm de ser escolhidas para menção especial.

3. Continuarei a utilizar esta terminologia ("elementos masculinos e femininos") por enquanto, por não conhecer outros termos descritivos adequados. "Ativo" e "passivo" certamente não são expressões corretas, e tenho de continuar a argumentação usando os termos que se acham disponíveis. — D. W. W.
4. Seria lógico aqui acompanhar o trabalho que esse homem e eu fizemos juntos com um trabalho semelhante que envolvesse uma paciente mulher ou menina. Exemplificando, uma jovem me lembra de um velho material pertencente ao início de sua latência, quando ansiava por ser um menino. Ela perdeu muito tempo e energia desejando um pênis para si. Precisava, contudo, de uma compreensão especial, que ela era uma garota evidente e feliz por sê-lo, e ao mesmo tempo sabia (com uma parte 10% dissociada) e sempre soubera ser um menino. Associada com isto havia uma certeza de haver sido castrada e, dessa maneira, privada de potencial destrutivo; juntamente com isto havia o assassinato da mãe e a totalidade de sua organização masoquista de defesa, que era central à sua estrutura de personalidade.

Fornecer exemplos clínicos aqui envolve-me no risco de distrair a atenção do leitor quanto a meu tema principal; além disso, se minhas idéias forem verdadeiras e universais, cada leitor terá então casos pessoais que ilustrem o lugar da dissociação, antes que da repressão, relacionada a elementos masculinos e femininos em homens e mulheres — D. W. W.

a. Pode-se, para própria surpresa, descobrir que se está lidando com a parte ex-cindida e tentando analisá-la, enquanto que a pessoa principal em funcionamento aparece apenas sob forma projetada. Isto é semelhante a tratar uma criança apenas para descobrir que se está tratando um ou outro dos pais, por procuração. Todas as variações possíveis sobre este tema podem aparecer-nos.

b. O elemento do outro sexo pode achar-se completamente ex-cindido, de maneira que, por exemplo, um homem pode não ser capaz de estabelecer qualquer vínculo com a parte ex-cindida. Isto se aplica especialmente quando a personalidade, sob outros aspectos, é sadia e integrada. Onde a personalidade em funcionamento já se acha organizada em cisões múltiplas, o acento recai menos sobre "eu sou sadio" e, portanto, há menos resistência contra a idéia "eu sou uma menina" (no caso de um homem) ou "eu sou um menino" (no caso de uma menina).

c. Pode-se encontrar clinicamente uma dissociação quase completa do outro sexo, organizada em relação a fatores externos em data muito inicial, misturados a dissociações posteriores organizadas como defesa, baseadas mais ou menos em identificações cruzadas. A realidade desta defesa organizada posterior pode militar contra a revivência pelo paciente, na análise, da cisão reativa anterior.

(Há aqui um axioma, qual seja, o de que o paciente sempre se aferrará à exploração completa dos fatores pessoais e *internos*, que lhe concedem uma certa medida de controle onipotente, antes de permitir a idéia de uma reação grosseira a um fator ambiental, seja ele distorção ou fracasso. A influência ambiental, má ou até mesmo boa, surge em nosso trabalho como uma idéia traumática, intolerável por não operar dentro da área da onipotência do paciente. Compare-se a alegação do melancólico de ser responsável por *tudo* o mal.)

d. A parte ex-cindida e do outro sexo da personalidade tende a permanecer de uma só idade ou a crescer lentamente. Em comparação com isto, as figuras verdadeiramente imaginativas da realidade psíquica interior da pessoa amadurecem, inter-relacionam-se, envelhecem e morrem. Exemplificando, um homem que dependa de garotas mais jovens para manter vivo o seu *self* ex-cindido de menina, pode gradualmente tornar-se capaz de empregar, para este intuito especial, garotas de idade matrimonial. Se viver até os noventa, no entanto, é improvável que as garotas dessa maneira empregadas cheguem aos trinta. Num paciente masculino, contudo, a garota (que oculta o elemento puro de menina de formação anterior) pode ter características de menina, ter orgulho dos seios, experienciar inveja do pênis, ficar grávida, não ser aparelhada com órgãos genitais internos masculinos e até mesmo possuir aparelhamento sexual feminino e gostar da experiência sexual feminina.

e. Uma questão importante aqui é a avaliação de tudo isto em termos de saúde psiquiátrica. O homem que inicia meninas na experiência sexual, bem pode ser alguém que se acha mais identificado com a menina do que consigo próprio. Isto lhe fornece a capacidade de despertar o sexo da menina e satisfazê-la. Paga por isso obtendo apenas uma pequena satisfação masculina ele próprio, e paga também em termos de sua necessidade de buscar sempre uma nova menina, com isto sendo o oposto da constância objetiva.

No outro extremo temos a moléstia da impotência. Entre os dois reside toda a gama da potência relativa, misturada com dependência de vários tipos e graus. O que é normal depende da expectativa social de determinado grupo social em determinada época específica. Não se poderia dizer que, na extremidade patriarcal da sociedade, a relação sexual é o estupro, e que, na extremidade matriarcal, o homem com um elemento feminino ex-cindido que tem de satisfazer muitas mulheres é altamente valorizado, ainda que, assim procedendo, ele se aniquile?

Entre os extremos, temos a bissexualidade e uma expectativa de experiência sexual que é menor que ótima. Isto combina com a idéia de que a saúde social é brandamente depressiva — exceto nos feriados.

É interessante que a existência deste elemento feminino ex-cindido na realidade impeça a prática homossexual. No caso de meu paciente, ele sempre fugiu de avanços homossexuais no momento crítico porque (como veio a perceber e me contou) colocar a homossexualidade em prática estabeleceria a sua masculinidade, que (desde o *self* do elemento feminino ex-cindido) ele nunca desejara conhecer ao certo.

(Nos normais, em que a bissexualidade é um fato, as idéias homossexuais não conflitam desta maneira, em grande parte porque o fator anal — que é uma questão secundária — não atingiu supremacia sobre a felação e, na fantasia de uma união por felação, a questão do sexo biológico da pessoa não é importante).

f. Parece que, na evolução do mito grego, os primeiros homossexuais foram homens que imitavam mulheres, de maneira a aproximar-se tanto quanto possível de um relacionamento com a deusa suprema. Isto pertenceu a uma era matriarcal, da qual surgiu um sistema divino patriarcal, com Zeus como cabeça. Zeus (símbolo do sistema patriarcal) deu início à idéia do menino amado sexualmente por homens e, junto com isto, ocorreu a rejeição das mulheres a uma condição inferior. Se este for um enunciado verdadeiro da história do desenvolvimento das idéias, ele fornece o vínculo de que preciso se quiser juntar minhas observações clínicas a respeito do elemento feminino ex-cindido, no caso de pacientes masculinos, com a teoria do relacionamento objetal. (O elemento masculino ex-cindido em pacientes do sexo feminino é de importância igual para o nosso trabalho, mas o que tenho a dizer a respeito do relacionamento objetal pode ser formulado em termos de apenas um dos dois exemplos possíveis de dissociação).

Resumo das Observações Preliminares

Em nossa teoria, é necessário aceitar-se a existência de um elemento masculino e um elemento feminino, tanto em meninos e homens, como em meninas e mulheres. Estes elementos podem achar-se mutuamente ex-cindidos em alto grau. A idéia exige de nós tanto um estudo dos efeitos clínicos deste tipo de dissociação, quanto um exame dos elementos masculino e feminino em si mesmos destilados.

Efetuei algumas observações dos primeiros, quais seja, os efeitos clínicos; quero agora examinar o que estou chamando de elementos masculino e feminino destilados (não pessoas masculinas e femininas).

Elementos Masculinos e Femininos Puros

Especulação sobre o Contraste em Tipos de Relacionamento Objetal

Comparemos e contrastemos os elementos masculinos e femininos sem amálgama no contexto do relacionamento objetal.

Quero dizer que o elemento que estou chamando de “masculino” circula em termos de um relacionamento ativo ou de um passivo deixar-se com ele relacionar, com cada uma das atitudes sendo respaldada pelo instinto. É no desenvolvimento desta idéia que falamos da pulsão instintual que existe na relação do bebê com o seio e com a amamentação, e, subseqüentemente, com relação a todas as experiências que envolvem as principais zonas erógenas e a pulsões e satisfações subsidiárias. Minha

sugestão é que, em contraste, o elemento feminino puro relaciona-se com o seio (ou com a mãe) no sentido de *o bebê tornar-se o seio (ou a mãe), no sentido de que o objeto é o sujeito*. Não consigo ver pulsão instintual nisto.

(Há também a ser lembrado o emprego da palavra "instinto" que provém da etologia; contudo, duvido muitíssimo que a impressão [*imprinting*] seja uma matéria que afete o bebê humano recém-nascido de algum modo. Direi aqui e agora que acredito que todo o tema da impressão é irrelevante para o estudo do relacionamento objetal inicial dos bebês humanos. Ele certamente nada tem a ver com o trauma da separação aos dois anos, ou seja, o próprio lugar em que sua importância primordial foi presumida.)

A expressão objeto subjetivo tem sido usada na descrição do primeiro objeto, *o objeto ainda não repudiado como sendo um fenômeno não-eu*. Aqui, neste relacionamento de elemento feminino puro com o "seio", temos uma aplicação prática da idéia do objeto subjetivo, e a experiência disto prepara o caminho para o sujeito objetivo, isto é, a idéia de um *self*, e o sentimento do real que surge do senso de ter-se uma identidade.

Por complexa que a psicologia do senso do *self* e do estabelecimento de uma identidade acabe por se tornar, à medida que um bebê cresce, não surge qualquer senso de *self*, exceto com base neste relacionamento no sentido de SER. Este senso de ser é algo que antecede a idéia de ser-um-só-com, porque ainda não existiu nada mais, exceto a identidade. Duas pessoas separadas podem *sentir-se* em união, mas aqui, no local que estou examinando, o bebê e o objeto *são* um só. A expressão "identificação primária" talvez tenha sido usada para designar exatamente isto que estou descrevendo, e estou tentando demonstrar quão vitalmente importante esta primeira experiência é para o início de todas as experiências subseqüentes de identificação.

As identificações projetiva e introjetiva originam-se ambas deste lugar em que cada um é o mesmo que o outro.

No crescimento do bebê humano, à medida que o ego começa a organizar-se, isto que estou chamando de relacionamento objetal do elemento feminino puro estabelece o que é talvez a mais simples de todas as experiências, a experiência de *ser*. Aqui encontramos uma verdadeira continuidade de gerações, sendo ela o que é passado de uma geração para a outra, por via do elemento feminino de homens e mulheres e dos bebês do sexo masculino e feminino. Penso que isto já foi dito antes, mas sempre em termos de mulheres e meninas, o que confunde a questão. Trata-se dos elementos femininos tanto em homens quanto em mulheres.

Em contraste, o relacionamento objetal do elemento masculino com o objeto pressupõe a separação. Assim que a organização do ego se acha disponível, o bebê concede ao objeto a qualidade de ser não-eu e separado, e experiencia satisfações do id que incluem a raiva relativa à frustração. A satisfação pulsional realça a separação existente entre o objeto e o bebê e conduz à objetivação do objeto. A partir daí, do lado do elemento masculino, a identificação precisa basear-se em complexos mecanismos mentais, aos quais se tem de dar tempo para que apareçam, desenvolvam-se e se estabeleçam como parte do novo aparelhamento do bebê. Do lado do elemento feminino, porém, a identidade exige tão pouca estrutura mental que esta identidade primária pode constituir uma característica desde muito cedo e as fundações para o simples ser pode ser assentada (digamos) desde a data do nascimento, ou antes, ou logo depois, ou a partir de onde quer que a mente se tenha liberado dos empecilhos ao seu funcionamento, que sejam devidos à imaturidade ou a dano cerebral associado com o processo de nascimento.

Os psicanalistas talvez tenham concedido uma atenção especial a este elemento masculino ou aspecto pulsional do relacionamento objetal, mas porém, negligenciado a identidade sujeito-objeto para a qual estou chamando aqui a atenção e que se encontra na base da capacidade de ser. O elemento masculino *faz*, enquanto que o elemento

feminino (em homens e mulheres) é. Aqui ingressariam aqueles indivíduos do sexo masculino do mito grego que tentaram ser um só com a deusa suprema. Temos aqui também uma maneira de enunciar a inveja muito profundamente assentada de pessoas do sexo masculino quanto às mulheres, cujo elemento feminino os homens tomam como certo, às vezes erradamente.

Parece que a frustração pertence à busca da satisfação. À experiência de ser pertence algo mais, não a frustração, mas a mutilação. Quero estudar este detalhe específico.

Identidade: Criança e Seio

Não é possível enunciar o que estou aqui chamando de relação do elemento feminino com o seio sem o conceito de mãe suficientemente boa e insuficientemente boa.

(Tal observação é ainda mais verdadeira nesta área do que o é na área comparável abrangida pelos termos "fenômenos transicionais" e "objetos transicionais". O objeto de transição representa a capacidade da mãe de apresentar o mundo de uma maneira tal que o bebê, a princípio, não tem de saber que o objeto não é criado por ele. Em nosso contexto imediato, podemos conceder importância total ao significado da adaptação com a mãe, quer dando ao bebê a oportunidade de sentir que o seio é o bebê, quer não o fazendo. O seio aqui é um símbolo, não de fazer, mas de ser.)

Ser um fornecedor suficientemente bom de elemento feminino deve ser uma questão de detalhes muito sutis de manejo, e, ao considerar-se estes assuntos, podemos valer-nos dos textos de Margaret Mead e Erik Erikson, que conseguem descrever as maneiras pelas quais o cuidado materno, em vários tipos de culturas, determina em idade muito inicial os padrões das defesas do indivíduo e também os diagramas para a sublimação posterior. São questões muito sutis as que estudamos com respeito a *esta* mãe e *esta* criança.

A Natureza do Fator Ambiental

Retorno agora à consideração do estágio muito inicial em que o padrão está sendo assentado através da forma pela qual a mãe, por maneiras sutis, maneja o seu bebê. Tenho de me referir com detalhes a este exemplo muito especial do fator ambiental. Ou a mãe tem um seio que *é*, de maneira que o bebê também possa *ser*, quando bebê e mãe ainda não se acham separados na mente rudimentar daquele, ou então a mãe é incapaz de efetuar esta contribuição, caso em que o bebê tem de desenvolver-se sem a capacidade de ser ou com uma capacidade prejudicada de ser.

(Clinicamente, precisa-se lidar com o caso do bebê que tem de safar-se com uma identidade com um seio que é ativo, que é um seio de elemento masculino, mas não é satisfatório para a identidade inicial que precisa de um seio que *é*, não de um seio que *faz*. Ao invés de "ser como" este bebê tem de "fazer como" (ou deixar que lhe seja feito), o que, desde nosso ponto de vista aqui, constitui a mesma coisa.)

A mãe que é capaz de fazer esta coisa muito sutil a que estou me referindo não produz uma criança cujo *self* "feminino puro" é invejoso do seio, uma vez que, para essa criança, o seio é o *self* e o *self* é o seio. Inveja é um termo que poderia ser aplicado na experiência de um fracasso atormentador do seio como algo que *É*.

Agora, quero dizer: "Após ser — fazer e ser-lhe feito. Mas primeiro, ser".

Nota Adicional sobre o Tema do Furtar

O furtar pertence ao elemento masculino em meninos e meninas. Surge a questão: o que corresponde a isto em termos do elemento feminino em meninos e meninas? A resposta pode ser que, com respeito a este elemento, o indivíduo usurpa a posição da mãe e o assento ou trajes dela, desta maneira derivando da mãe deseabilidade e capacidade de sedução dela furtados.

II. Material Clínico

Datado de 1959

Após um longo fim de semana em que o paciente estivera lidando com a realidade externa, ele chegou muito cheio de tudo isto, mas o seu interesse nesses detalhes em breve começou a decrescer. Disse ele: "Parece que a sessão de quinta-feira foi há longo tempo atrás". Eu lhe disse: "Sim, um longo tempo desde que lhe veio a idéia a respeito do cueiro". A essa hora ele já estava de volta à sessão de quinta-feira e disse que realmente não havia abandonado a impressão pertencente a esses três últimos dias de análise, apesar de tudo o que estivera acontecendo. Daí, continuou de modo lento e claro ao longo da linha iniciada na semana passada. O tema que se desenvolveu foi o da exploração de seu *self* feminino. Sempre soubera muita coisa a respeito do elemento homossexual e previamente relatara grande quantidade de fantasias compulsivas a propósito de ser uma mulher. Aqui, contudo, chegou a um novo aspecto deste problema, um aspecto que tinha a aparência de poder ser produtivo. Produziu ele algum tipo de idéia na qual não havia saída, nenhuma possibilidade de alterar algo.

Em minha interpretação, acabei por dizer-lhe que se ele fosse um bebê a ser tratado por uma mãe da maneira que havíamos reconstruído na semana passada, não havia realmente qualquer saída para ele, nenhuma alternativa, exceto ele explorar todas as partículas em si de ser mulher e querer sê-lo. Qualquer coisa a título de protesto neste estágio inicial teria sido completamente fútil.

Gradualmente, ele conseguiu chegar à idéia de livrar-se da mãe, de toda a atitude dela e do cueiro, mas o importante é que estava me trazendo um desamparo absoluto. Naturalmente, ele poderia lidar magicamente com a situação. Poderia abandonar seu corpo e, dessa maneira, livrar-se do cueiro. Fisicamente, contudo, não tinha nenhuma escolha. A compreensão disto foi-lhe muito penosa e, apesar disso, levava-o a poder desenvolver o tema de existir nele um elemento que se sente feminino. Com respeito a tudo isto, a posição de seus órgãos genitais era apenas uma complicação esquisita, algo em que ele não podia acreditar, e recordei-o da pistola de brinquedo que havia deixado sobre a cama do andar térreo, no sonho, enquanto passava por ela e subia até o sótão.

Daqui, chegamos ao relacionamento com sua mãe, em termos de mulher e filha, e o paciente desenvolveu este tema com respeito ao relacionamento com sua presente namorada, com quem a sua impotência não é importante e, na realidade, encontra-se no caminho tanto quanto estaria a potência dele, porque a principal coisa que tem no relacionamento deles é a qualidade de um relacionamento entre duas mulheres.

Na segunda sessão das três desta semana, o paciente rapidamente retornou à análise e a esta coisa nova, a capacidade de considerar o seu *self* feminino. Ele foi bastante lento em chegar aos detalhes e fiz-lhe alguma interpretação lembrando-o da alternativa que era uma negativa absoluta, no sentido de não existir qualquer possibilidade de ele lidar com ela. A alternativa significa a eliminação de sua mãe em um estágio infantil muito inicial, e ele não é capaz de fazer isto a não ser matematicamente, o que não adianta. Apenas por um momento o paciente tentou seguir-me, mas então disse que esta posição em que se achava com referência a seu *self* feminino era tremendamente importante para ele e que precisava de tempo para situar-se nela e descobrir o que havia a ser descoberto lá. Coisas bastante sutis apareceram, tais como, por exemplo, ele descobrir-se não tocando o peito e pensando: "Oh, ele vai pensar que estou brincando com o meu seio". Era evidente que havia um grau extremado da experiência dele próprio como mulher e que nunca se permitira chegar a esta posição antes. Com muita frequência, sentia que tinha de organizar suas defesas e sair dessa curiosa posição. Às vezes, insultava seu analista anterior, uma mulher, que não fora capaz de encontrar nele esta coisa que agora se descobria ser tão importante. Não era que fosse realmente inconsciente.

Concedi-lhe toda a sessão para a exploração destes fenômenos, e uma das coisas a que ele chegou foi um enunciado de algo muito difícil em seu relacionamento com a esposa. Não tinha idéia, quando se casara com ela, que iria descobrir que ela tem uma perversão que corresponde exatamente ao que tão facilmente poderia tornar-se uma perversão nele. Ela acha que sexualmente é altamente excitante ele demonstrar qualquer manifestação de seu *self* feminino, tal como, por exemplo, comendo demais nas férias e ficando com uma barriga grande. Havia aqui um perigo muito grande e a fonte do medo que sente da esposa. Este foi talvez o detalhe inesperado mais importante que surgiu da experiência da sessão.

A terceira sessão foi pela manhã e chegou a ela vindo de uma experiência que ocorrera durante a noite. Descobrira estar muito menos assustado quanto à esposa. Coisas exasperantes haviam acontecido, mas ele ficara menos exasperado. Rapidamente recapturou a atmosfera das duas sessões anteriores e houve uma pausa. Neste momento, veio-me à mente a palavra "zombaria". Coloque-o deste modo porque acho que se poderia fazer um debate útil em torno do tipo de coisa que vou agora descrever. Ela refere-se aos processos inconscientes do analista. Eu estava inteiramente preparado para abandonar a idéia de zombaria, mas olhando em redor, pude ver exatamente ao que ela pertencia. Tinha a ver com a atitude da esposa e, portanto, da mãe, com referência às suas manifestações de *self* feminino. Deixei que a idéia desaparecesse e, depois, examinando a situação, descobri que podia intervir com uma interpretação da zombaria. Fui ajudado pelo material, tal como, por exemplo, o sigilo a respeito deste aspecto dele próprio. Permiti-me expressar a interpretação que se achava em minha mente, qual seja, a de que o perigo, desde o ponto de vista dele, era que a esposa (ou a mãe) zombassem dele com referência a este *self* feminino.

Datado de 1963

O paciente chegou muito tarde, o que era extremamente fora do comum. Estava furioso, enraivecido, cheio de um ódio imenso pela esposa, repleto de detalhes. Talvez o mais difícil fosse que, no meio de tudo, quando ela disse: "Lamento ter sido tão horrível", ele houvesse tido uma reação sexual que teve de esconder dela e afastar-se tão rapidamente quanto possível.

Parecia provável que o conflito em torno disto fosse responsável por grande parte de sua aflição. Com a namorada, brincara um pouco, tal como poderia brincar com a filha, mas ela interpretou como ódio e isso o derrubara. Aquilo de que se deu conta foi que estivera pensando em autodestruição.

Toda a sessão foi uma confusão e nenhuma interpretação minha foi de qualquer utilidade. O paciente achava-se exasperado. O que acabou por fazer algum bem foi minha interpretação de que a análise continuara em seu relacionamento com a esposa, mas aqui e agora, seja o que fosse que pudesse ter sido em outras ocasiões, ele estava elaborando a sua exasperação com a mãe e sua absoluta desesperança com relação a lidar com ela, exceto por esse método com que agora havia quase perdido contato, mas que lhe fora tão importante na semana passada, a exploração plena de seu *self* feminino.

Ele acabou por sentir que eu havia realmente enfrentado a situação quando lhe disse que o relacionamento em casa era tão semelhante ao seu relacionamento com a mãe por não existir homem e, portanto, ele não podia vir a mim porque não adianta, não existe homem a quem vir. Não há possibilidade de existir um pai em cujo joelho ele pudesse sentar-se, olhando para a mãe, etc.

Isto foi exatamente o que o paciente precisava, mas tomou-me a sessão inteira para chegar lá e, no decorrer desse período, eu fizera muitas interpretações falsas, muitas delas muito argutas e cada uma delas tornando-me mais ridículo (tema da zombaria).

Incidentalmente, havia o curioso tema de que este homem sentia que, se havia tido relações sexuais com a esposa, embora se houvesse sentido satisfeito e ela também, isto não podia ser, porque significaria que fora infiel à amante, com quem, no entanto, tinha uma relação muito débil como homem e mulher e, na realidade, está abandonando temporariamente este relacionamento porque é insatisfatório e trata-se realmente de um relacionamento entre duas mulheres. Ao final, elaboramos que ele estava com medo de chegar a um acordo com todos reagindo com a relação sexual, por medo que eu fosse levado a uma trilha falsa. Podia ele confiar que eu soubesse que não se acha naquele ponto de desenvolvimento ou que faria sentido de uma coisa desse tipo? Na transferência, portanto, a coisa é que ele está lidando com a esposa que é a sua mãe e isto me elimina e torna-lhe impossível chegar a mim como homem.

Datado de 1963

O paciente chegou e descreveu os vários distúrbios neuróticos que eram principais. Parecia que estávamos chegando a algo novo e isto sempre agrada a este paciente. Se digo algo novo ou útil, ou algo verdadeiro, ele ganha confiança em mim e isto imediatamente produz um efeito benéfico, por causa de sua incapacidade de acreditar em um pai forte, a menos que esteja realmente experienciado algo que ampare uma crença desse tipo. É algo bem-conhecido neste caso que o efeito imediato de qualquer

interpretação, se chega a ser boa, é muito maior do que seria justificado pela própria interpretação. Depois, naturalmente, pagamos por isto e a desilusão se instala por causa da melhoria limitada que resultou do trabalho que foi feito. Isto já tinha acontecido muitas dúzias de vezes e nós dois conhecíamos tudo a respeito da configuração. Aqui, o trabalho relacionava-se com o sintoma principal, ou talvez eu deva dizer com o sintoma que se apresenta de modo mais claro, qual seja, o seu extremo embaraço por usar óculos. Isto tem uma longa história e o tema tem sido deixado temporariamente pendente, uma vez que muito trabalho já se fez sobre ele e sobre as variadas maneiras pelas quais os óculos simbolizam objetos parciais, em particular seios. Este é o único sintoma a respeito do qual ele assevera não haver falado à esposa.

Nesta ocasião particular, havia razões para apontar que os óculos, nas circunstâncias descritas, eram um símbolo fálico, e esta era a primeira vez em que apareciam desta maneira. Naturalmente, eles são também símbolos do seio. A sessão poderia ter prosseguido ao longo destas linhas e não teria havido dificuldade em preencher todo o tempo com um desenvolvimento do tema. Incidentalmente, o paciente havia naquele dia me contado um sonho que me fez pensar em outra direção. Sonhara que estava dançando sobre a água e ficara pensando por que nenhuma das outras pessoas podia fazer isto. Em outras palavras, as outras pessoas afundariam. Forneceu-me ele este sonho de uma maneira tal que poderia facilmente ter sido perdido no outro tipo de material. Ao fazer interpretações, aponte que este era um exemplo da maneira pela qual toda a sua sintomatologia obviamente bastante neurótica, surgia repetidas vezes para análise, como uma defesa contra uma ansiedade de tipo inteiramente diferente, uma defesa contra a ansiedade psicótica. Disse-lhe que, do meu ponto de vista, a coisa importante na sessão fora o sonho, que indicava uma denegação de cair eternamente, ou, talvez, de afogar-se, ou de algo que isto simboliza.

O paciente foi colhido de surpresa por eu haver ultrapassado a sua defesa. A princípio, ficou irritado, mas isto logo se transformou em ficar verdadeiramente muito satisfeito, por poder sentir que eu havia dito algo de novo, importante e útil. Como de costume, houve o exagero do resultado, devido ao fato de que, por fazer uma interpretação de significado importante, eu provara que pelo menos um homem se achava vivo e potente, como analista. Disse ele que isto se achava de alguma maneira vinculado com beber uísque e que não podia entender, se tinha ansiedade a respeito de desintegração, queda e despersonalização, como podia ser que ele produzisse exatamente esses sintomas através do uso do uísque. Interpretei isto como uma tentativa de sua parte de ganhar controle de todas as ansiedades desintegradoras, produzindo-as de maneira ordenada e bem-conhecida através da ação do álcool, que inclui a recuperação desde o estado alcoólico.

Não pude ver o paciente no dia seguinte. Ele ficou irritado a respeito, mas isto não perturbou a análise. Pode ter contribuído para ele faltar o dia seguinte, a quarta-feira. Na quinta-feira chegou e me disse que fora extremamente importante que eu houvesse feito aquela interpretação na segunda, pois na terça estivera em uma festa em que se achavam presentes muitos fantasmas do passado; em outras palavras, encontrara importantes figuras homossexuais que haviam pertencido à sua era perigosamente homossexual, quando contava de 20 a 25 anos de idade. Sentira-se muito falso e esquisito apresentando a esposa a um ex-parceiro homossexual. Se eu houvesse deixado a interpretação daquelas ansiedades mais profundas para depois do encontro com essas pessoas, é improvável que houvéssimos chegado ao ponto que havíamos atingido na segunda-feira. Inversamente, foi-lhe também muito importante, na terça-feira, sentir que "meu analista tratou disto na segunda-feira". Disto, passamos para uma dissecação daquilo que é denegado pelo sonho de dançar sobre o Danúbio Azul. Afundar na água para ele significa, conforme se elaborou, abandonar-se a delírios, à loucura. No estágio de quinta-feira, isto significa abandonar-se ao conhecimento, em

um sentido muito mais profundo do que tivera conhecimento antes de ser mulher. Nesta posição, descobriu-se inesperadamente gostando de mim e, tão perto disso quanto possível, apaixonado por mim. Isto significava que podia agora amar alguém e explicava por que nunca havia podido abandonar-se antes na posição homossexual, na qual sempre, em um momento decisivo, havia-se retraído da homossexualidade e dela fugira para três casamentos.

Tudo isto parecia-lhe muito real e ele o estava comparando com o trabalho que havíamos feito, e que estava também indubitavelmente correto, sobre relações objetais infantis iniciais, e que havia resultado, logo antes da presente fase, em ele chegar de maneira bastante cautelosa a um interesse oral no órgão genital masculino. Durante toda a análise deste homem, a idéia da felação fora muito estranha e afastada de seu caso, algo sobre o que se podia falar, mas sem que sentisse que tinha algo a ver com ele.

III. Resposta à Comentários

Redigido em 1968-1969

Minha primeira reação à leitura dos comentários ao meu trabalho é de ficar satisfeito porque os assuntos que levantei parecem haver estimulado o debate. Fico agradecido aos debatedores pelo trabalho a que se deram.

Não é minha intenção tentar responder a detalhes, porque me parece que cabe ao leitor julgar. Gostaria de efetuar os três conjuntos de comentários, após ter lido o que foi escrito:

A

Central ao meu artigo é a experiência clínica que foi minha neste único caso que descrevo. Originalmente, tive a intenção de fornecer diversas experiências comparáveis, a ilustrarem estas questões não apenas em outros pacientes, mas também em pacientes do outro sexo. Ficou evidente, contudo, que material clínico demais, tornando o artigo demasiado longo, viria em detrimento da coisa principal que eu queria dizer.

Estou naturalmente ciente da aceitação universal da bissexualidade na teoria psicanalítica. Estive chamando a atenção para o alto grau de dissociação que pode ser encontrado com respeito às identificações masculinas e femininas. Também isto nada tem de novo. O ponto principal de minha comunicação foi a maneira por que foi necessário, tal como o vi, lidar com o fator ambiental em termos da transferência. Poder-se-ia dizer que o paciente se achava na busca do tipo certo de analista louco e que, a fim de atender às suas necessidades, tive de assumir esse papel. É este detalhe especial que considere ser a parte importante do artigo, uma questão de manejo da transferência e a tensão sobre os sentimentos contratransferenciais produzida pela aceitação do papel atribuído.

B

Pode certamente resultar confusão de eu passar do material clínico para um debate teórico. Assim que se entra no campo da teoria, abandona-se o terreno firme e começa-se um relacionamento com todos aqueles que escreveram sobre o mesmo tema, embora, naturalmente não se possa fingir ou ter esperança de achar-se em contato com toda a literatura técnica. O que se precisa, porém, é uma enumeração dos outros mecanismos empregados quando um paciente manifesta características sexuais que são diferentes daquelas que o seu sexo biológico justifica. Há toda a gama que vai de um alto grau de sofisticação até os fenômenos básicos, inclusive o manejo muito inicial e, mais além disso, a hereditariedade. Entre os mecanismos sofisticados deve-se encontrar uma identificação cruzada que pode ser, quase inteiramente, uma organização de defesa. Por outro lado, identificações cruzadas podem, elas próprias, ser determinadas por expectativas que provêm do meio ambiente. Para contribuir para a situação familiar, um menino ou uma menina podem precisar explorar características sexuais outras que não as biológicas. No meu paciente, havia o extremo da necessidade inconsciente que a mãe tinha de uma menina, e que determinou o manejo por ela de seu bebê nos estágios muito iniciais. O resultado em meu paciente foi que, embora ele mantivesse a certeza de sua identidade masculina, conduziu consigo, até este ponto da análise que descrevi, a convicção de que, a fim de ter um relacionamento com a mãe, tinha de ser uma menina. Em outras palavras, a loucura neste caso achava-se na mãe e não no paciente, embora clinicamente este tivesse se sentido louco e não pudesse livrar-se da psicoterapia que foi compelido a seguir, mas que sabia ser um caso perdido. O notável que aconteceu foi que a minha manipulação da transferência em termos de eu ser um analista louco liberou-o desta terrível fixação à psicoterapia.

C

Seguindo a consideração destes detalhes teóricos, permiti que meus pensamentos me conduzissem ao conceito de elementos masculinos e femininos em meninos e meninas. Descobri-me grandemente enriquecido por esta maneira de pensar que era um tanto nova para mim, de maneira que, ao considerar este tipo de problema, eu estava agora não mais pensando em meninos e meninas ou homens e mulheres, mas sim em termos dos elementos masculinos e femininos que pertencem a cada um deles. Isto me fez ver que os termos "ativo" e "passivo" não têm validade nesta área. Ativo e passivo são duas facetas da mesma coisa em termos de algum outro tipo de consideração que vai mais fundo e que é primitiva. Numa tentativa de formular isto, encontrei-me na posição de comparar *ser* com *fazer*. No extremo dessa comparação, descobri-me examinando um conflito essencial dos seres humanos, um conflito que já deve ser operante em data muito inicial, o conflito entre ser o objeto que tem também a propriedade de ser e, por contraste, uma confrontação com o objeto que envolve uma atividade e um relacionamento objetal respaldados pelo instinto ou pulsão.

Isto revelou ser um novo enunciado do que tentara descrever antes, em termos do objeto subjetivo e do objeto que é objetivamente percebido, e fui capaz de reexaminar, em benefício meu, o tremendo efeito que é causado aqui, sobre o bebê humano imaturo. Pela atitude da mãe e, depois, dos pais, em termos de adaptação à necessidade. Em outras palavras, descobri-me reexaminando a movimentação para o princípio da realidade a partir... do quê? Nunca fiquei satisfeito com o emprego da palavra "narcísico/a" em conexão a isto, porque todo o conceito do narcisismo deixa de fora as tremendas diferenças que resultam da atitude e do comportamento geral da mãe.

Sobrou-me, desta maneira, uma tentativa de enunciar de forma extrema o contraste entre o ser e o fazer.

A base para este outro comentário foi a separação de toda a idéia de meninos e meninas e de homens e mulheres da idéia de dois princípios básicos, aqueles que chamo de elementos masculinos e femininos. Suponho que é aqui que causo confusão, mas não posso retirar-me neste estágio do argumento, e prefiro permitir que este estágio intermediário permaneça. O que quero fazer é explorar mais. Quero chegar atrás de todas as sofisticações de sexo cruzado, identificações cruzadas e até mesmo expectativas cruzadas (onde um bebê ou criança só pode contribuir para um dos pais em termos do sexo que não é biológico) e quero ir até aonde me encontro ao mesmo tempo arrastado e impulsionado. Quero chegar de maneira nova a um conceito que, fora de dúvida, tem raízes nos textos de outros analistas.

Quero chegar a um enunciado de um dilema básico no relacionamento:

a. O bebê é o seio (ou objeto, ou mãe, etc.); o seio é o bebê. Isto se encontra na extremidade última da falta inicial de estabelecimento que o bebê tem de um objeto como não-eu, no lugar onde o objeto é 100% subjetivo, onde (se a mãe se adapta suficientemente bem, mas não doutra maneira) o bebê *experiencia* onipotência.

b. O bebê é confrontado por um objeto (seio, etc.) e precisa chegar a um acordo com ele, com poderes limitados (imaturos) do tipo que se baseia nos mecanismos mentais das identificações projetiva e introjetiva. Aqui precisamos notar que, mais uma vez, a experiência de cada criança depende do fator ambiental (atitude, comportamento da mãe, etc.).

No arcabouço deste conceito, que lida com um problema humano universal, pode-se ver que bebê=seio é uma questão de ser, não de fazer, enquanto que, em termos de confrontação, o encontro do bebê e do seio envolve o fazer.

Na psicopatologia, alguns dos maiores bloqueios ao envolvimento instintual — ou pulsional — aparecem quando paciente=objeto se transforma violentamente em paciente-confronta-e-é confrontado-pelo-objeto, a envolver uma mudança desde uma defesa aconchegante para uma posição de ansiedade de alto grau e uma percepção súbita de imaturidade. Não posso evitá-lo, mas exatamente neste estágio pareço ter abandonado a escada (elementos masculinos e femininos) pela qual subi até o lugar onde experienciei esta visão.

O Conceito de Regressão Clínica Comparado com o de Organização Defensiva

Artigo lido em um Simpósio de Psicoterapia no McLean Hospital, Belmont, Massachusetts, em 27 de outubro de 1967¹

É-me necessário tornar clara a minha posição desde o início. Neste artigo, não estou partindo de experiências clínicas especializadas relativas à administração hospitalar de pacientes esquizofrênicos. Tem de se presumir que a minha experiência clínica de casos adultos seja a de um psicanalista que, goste ele disso ou não, se torna envolvido no tratamento de pacientes fronteiriços (*borderline*) e daqueles que, talvez inesperadamente, tornam-se esquizóides durante o tratamento.

Em minha clínica de psiquiatria infantil, contudo, tive todos os tipos de casos aos meus cuidados e assisti ao autismo ou esquizofrenia da infância desenvolver-se; isto talvez justifique minha aceitação deste convite, que considero ser uma honra.

Preciso que me seja permitido vagar pelo campo teórico, desonrado pela carga clínica que pertence mais à prática do que à mesa de conferências. Podemos adotar este curso, acredito, sem nos separar da fonte de nosso trabalho, que deve ser sempre os seres humanos que vêm até nós ou que nos são trazidos por causa das dificuldades da vida.

Pareceu-me ser uma boa idéia utilizar esta oportunidade para classificar um pouco para mim mesmo a inter-relação de duas idéias, a da esquizofrenia como regressão e a da esquizofrenia como organização de defesa. Pode acontecer que, ao praticar desta maneira minhas escalas e arpejos, eu possa proporcionar material para debate. Não estou interessado em ser original, nem em citar outros autores e pensadores (ou mesmo Freud).

Em benefício daqueles cujo trabalho os leva na direção dos tratamentos físicos, seja-me permitido dizer que os ignorarei aqui, simplesmente porque, seja o que for que já é conhecido ou será descoberto a respeito da bioquímica, da neuropatologia ou da farmacologia relativa à esquizofrenia, existirão ainda lá os pacientes, pessoas como nós, com uma história em cada caso do desencadeamento do transtorno e com uma carga de esforço e sofrimento pessoais, com um meio ambiente que é simplesmente mau ou bom ou, então, que confunda a um grau que pode ser desorientante até mesmo relatar.

1. Publicado em Eldred e Vanderpol, orgs., *Psychotherapy in the Designed Therapeutic Milieu, International Psychiatry Clinics*, vol. 5, nº 1 (Boston; Little, Brown, 1968).

O que tenho a dizer, portanto, não será nem pró nem contra os especialistas nos aspectos físicos do transtorno, e, se falhar em referir-me ao trabalho do psicólogo puro ou acadêmico, aqui também devo ser entendido como me achando, muito simplesmente, ocupado em outro ponto.

Para se examinar a teoria da esquizofrenia, tem-se de ter uma teoria de trabalho do crescimento emocional da personalidade. Esta é em si mesma uma matéria tão ampla que eu não teria possibilidade de fazer-lhe justiça em uma breve resenha. O que tenho de fazer é presumir a teoria geral da continuidade, de uma tendência inata no sentido do crescimento e da evolução pessoal, e a teoria da doença mental como uma interrupção no desenvolvimento. Esta última traz consigo a idéia de uma dinâmica no sentido da cura, isto é, de que se um bloqueio ao desenvolvimento é afastado, então disso decorre o crescimento, por causa das poderosas forças que pertencem às tendências herdadas no ser humano individual.

Posso também dizer que o enunciado do desenvolvimento da primeira infância e da infância em termos de uma progressão de zonas erógenas, que nos serviu bem em nosso tratamento dos psiconeuróticos, não é tão útil no contexto da esquizofrenia quanto o é a idéia de uma progressão da dependência (a princípio, quase absoluta) para a independência, tema com que lidei em certa extensão em diversos artigos².

Aqui, prestamos tributo pleno à provisão ambiental, tal como, por exemplo, à natureza da mãe em sua apresentação do mundo ao seu bebê que não conhece nada mais. Do começo, pode-se atribuir valor total ao fator ambiental, que se situa em segundo lugar apenas em relação às tendências herdadas do bebê. A medida que a criança adquire autonomia e uma identidade, que se sente real e percebe objetivamente o meio ambiente como fenômeno separado, assim também o meio ambiente se torna (na saúde) cada vez mais relegado ao segundo plano, exceto que na doença — tal como na esquizofrenia — tem-se sempre de lembrar que *o meio ambiente pode continuar a ser um fator adverso, por causa do fracasso do indivíduo em obter suficiente autonomia*.

Não seria possível ir adiante na teoria essencial do desenvolvimento pessoal aqui e agora, embora nada possa ser mais relevante para o tema.

Para mim, a pista para o conflito subjacente à doença que denominamos de psicose reside dentro do indivíduo. O analista do paciente psiconeurótico acha-se envolvido, como é bem-sabido, na análise do inconsciente reprimido do indivíduo.

Em contraste, onde jaz a esquizofrenia, o analista ou quem quer que esteja tratando o paciente ou administrando o caso, encontra-se envolvido na elucidação de uma cisão na pessoa do paciente, o extremo de uma dissociação. *A cisão toma o lugar do inconsciente reprimido do psiconeurótico*.

Tentei esclarecer minhas idéias sobre este tema particularmente em "Psicoses e Cuidado Infantil". Forneço aqui um diagrama de minha idéia da cisão básica na enfermidade psicótica, mas clinicamente a cisão, sendo subtotal, pode aparecer em várias formas de dissociação, tais como *Self* Verdadeiro e Falso *Self*, e na vida intelectual ex-cindida do viver psicossomático⁴.

2. Ver "Psicoses e Cuidado Infantil" (1952), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London; Tavistock, 1958; New York, Basic Books, 1975; London; Hogarth Press, 1975), e três artigos em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1983; London: Hogarth Press; Nova Iorque, International Universities Press, 1965); "A Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil" (1960), "Da Dependência para a Independência no Desenvolvimento do Indivíduo" (1963), e "Dependência no Cuidado do Lactente, no Cuidado da Criança e na Situação Psicanalítica" (1963).
3. Ver "Distorção do Ego em termos de Falso e Verdadeiro *Self*" (1960), em *Os Processos Maturacionais e o Meio Ambiente Facilitador*.
4. Ver *Mind and Its Relation to The Psycho-Soma* (1949), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis*.

Obviamente, a natureza da dissociação que aparece clinicamente pode ser influenciada pela natureza das expectativas oriundas do meio ambiente, de maneira que um paciente pode estar padecendo de expectativas patológicas nesse meio. Os pais podem ter querido uma criança do outro sexo, por exemplo, ou ter desejado um gênio ou uma criança que não tivesse impulsos agressivos. Estas expectativas patológicas podem reforçar dissociações potenciais no indivíduo.

Tudo isto é bem sabido e bem-aceito. O que segue é menos seguro, mas continuarei a utilizar uma linguagem dogmática.

A cisão na pessoa aconteceu e se organizou por causa de um fracasso ambiental. Houve um fracasso do "meio ambiente expectável médio". Em meus termos, um bebê é geralmente cuidado por uma mãe "suficientemente boa". Bem, ou a mãe suficientemente boa teve de falhar (talvez houvesse ficado doente), ou, então, não era suficientemente boa. Não estou distribuindo culpas, mas apenas buscando a etiologia.

Estas questões são mais obviamente aplicáveis à esquizofrenia da primeira infância e da infância, mas temos de encontrar uma maneira de aplicá-las à esquizofrenia dos adolescentes e de pessoas adultas, mesmo quando, segundo parece, as coisas correram bem no início da infância e o transtorno apenas apareceu clinicamente em idade posterior. O fato é que a dependência inicial continua a ter significado, especialmente na adolescência, e talvez, de maneira disfarçada, através de toda a vida. (Exemplificando, a dependência de um princípio religioso pode não se apresentar, a menos que alguma experiência torne insustentável esse princípio.)

Para mim, uma mãe suficientemente boa, pais suficientemente bons e um lar suficientemente bom realmente proporcionam à maioria dos bebês e das crianças pequenas a experiência de não terem sido significativamente decepcionados. Desta maneira, as crianças médias têm a oportunidade de construir uma capacidade de acreditar em si mesmas e no mundo: elas constroem uma estrutura sobre a acumulação da confiabilidade introjetada. Elas são desditosamente ignorantes de sua boa sorte e acham difícil entender aqueles entre seus companheiros que carregam consigo, durante toda a vida, experiências de impensável ansiedade e uma deficiência no setor da confiabilidade introjetada. É entre estas últimas pessoas que a enfermidade, quando ocorre, tende a assumir uma forma que rotulamos de esquizofrênica, antes que psico-neurótica ou depressiva.

Tenho de inserir uma nota aqui, apesar de minha disposição de manter fora tudo o que não seja necessário à exposição de meu tema principal; ela tem a ver com o fato de que fracassos na confiabilidade ambiental nos estágios iniciais produzem no bebê fraturas da continuidade pessoal, por causa das reações ao imprevisível. Estes eventos traumáticos conduzem consigo uma ansiedade impensável ou um sofrimento máximo⁵.

Chego aqui ao ponto em que tenho de confessar que, em determinada época, pensei na esquizofrenia e nos tipos esquizóides de transtorno clínico como sendo regressões, de maneira que juntei-me à caçada dos pontos de fixação. Isto constituiu uma sobra da correspondente caça às feiticeiras, na tentativa de enunciar a etiologia da psicose em suas variadas manifestações.

Minha atitude mudou quando vi que tenho de pensar em dois tipos de regressão, e uma delas é simplesmente uma retroação em uma direção que constitui o oposto do movimento para a frente do desenvolvimento. Vê-se aspectos regressivos aparecem e reconhece-se que os mecanismos de crescimento do indivíduo tornaram-se bloqueados. O outro tipo de regressão é inteiramente diferente, embora clinicamen-

5. Ver *A Integração do Ego no Desenvolvimento da Criança* (1962), em *O Ambiente e os Processos de Maturação*.

o objeto (o terapeuta e a sua sala) sobrevivem à raiva do paciente. Nenhum tratamento de casos *borderline* pode achar-se livre de sofrimento, tanto do paciente quanto do terapeuta.

Adendo a “A Localização da Experiência Cultural”

Datado de 18 de dezembro de 1967

Desde que escrevi o artigo sobre “A Localização da Experiência Cultural”¹ vim a ter gradualmente uma necessidade inesperada de algo que correspondesse à experiência cultural, mas que se achasse localizado dentro desta, ao invés de fora. Foi sobre material apresentado por pacientes que baseei o texto deste adendo a meu artigo anterior, mas apesar disso, estou me valendo de minha experiência pessoal ao tentar ilustrar o que quero dizer. Talvez valha a pena registrar que me descobri precisando muito de dormir, sentado no chão de meu quarto, de frente para a sua extremidade escura. Isto aconteceu enquanto eu estava tentando descobrir o que era que eu desejava formular. Adormeci pensando que talvez acordasse descobrindo que um certo caso ilustraria adequadamente o jogo do *squiggle** e fiquei surpreso com o que surgiu. O sonho me disse o que era que eu estava tentando formular e, quando despertei, antes de abrir os olhos, sabia ao certo que estava de frente para a janela; naturalmente, porém, também sabia, assim que comecei a pensar, que estava voltado na outra direção. Concedi-me um longo tempo para apreender a sensação plena desta experiência de espelho. Finalmente, quando achei que já havia tido bastante dela e sabia ao certo, por sentir, que se abrisse os olhos veria a janela, proporcionei-me o luxo da experiência completa de despertar e descobrir-me de frente para o outro lado, com as costas para a janela.

Agora tinha bem claro a que se referia, o que se passava em minha mente e me dirigi diretamente para o outro quarto para escrever algo que o formulasse.

No artigo anterior, afirmei que há necessidade de algum espaço potencial para a localização do brincar e da experiência cultural em geral. A impressão deliberadamente fornecida era de que este espaço potencial, se existisse, ficaria fora da linha que divide o interno do externo. Quero agora referir-me a um espaço potencial que fica do lado de dentro dessa linha.

1. *The Location of Cultural Experience* (1967), em *Playing and Reality* (London: Tavistock; New York: Basic Books, 1971; Penguin, 1974).

* Literalmente, *jogo do mbisco*; método inventado por D. W. W. em que o terapeuta traça uma forma linear simples e a criança continua o desenho. (N. do T.)

31

O Brincar e a Cultura

Palestra feita para o Imago Group, em 12 de março de 1968

A idéia que tenho é que um enunciado satisfatório relacionado a experiências em matérias culturais ainda não foi efetuado pela psicanálise. Possivelmente não tenha havido sequer uma tentativa direta de enfrentar este problema específico. Será de importância para mim receber referências a tentativas desse tipo que tenham sido feitas, na literatura psicanalítica ou a ela afim. Muita coisa em verdade foi escrita a respeito da realidade psíquica, tal como experienciada pelo indivíduo que está vivo. De modo semelhante, muita coisa foi escrita sobre o relacionamento objetal e o relacionamento total do ser humano com o meio ambiente ou com a realidade externa partilhada.

Houve algumas tentativas de se dirigir ao que me interessa aqui nas observações que se relacionam à afeição, comparadas com o relacionamento objetal instintualmente pulsionado. No negativo, “a criança sem afeição” é uma expressão que chama a atenção para a importância da capacidade da qualidade do sentimento afetivo. O conceito de sublimação traz o analista na direção do que estou tentando estudar. Também se pode dizer que o brincar acha-se tão próximo quanto possível do tema de minha pesquisa. Com relação ao brincar, no entanto, há na literatura psicanalítica uma ligação estreita com o instinto modificado pelo deslocamento, etc.

Pode-se considerar que a abordagem ortodoxa levou o estudioso da metapsicologia a um enunciado completo do ser humano e da experiência viva. Minha tese é de que, por alguma razão (que pode ser estudada como um assunto em si) nenhum lugar para a experiência cultural foi concedido pelos psicanalistas no enunciado da existência humana. Estou fazendo aqui a presunção de que a experiência cultural surge como extensão direta do brincar das crianças e, em verdade, dos bebês, desde a idade do nascimento e talvez antes.

Existe obviamente uma associação estreita entre o brincar e a idéia da fantasia e do sonho. O brincar também se relaciona com jogos e coisas tais como a imaginação ativa, onde se tenta deliberadamente fazer uso de elementos surpreendentes que a imaginação ocasiona.

Quando vou a um concerto e lá encontro um colega de psicanálise, fico às vezes pensando se conhecemos tanto quanto gostaríamos de conhecer a respeito da experiência que ambos estamos tendo. Há certamente uma diferença inerente entre ir a um

concerto e sonhar; também não há dúvida de que nenhum de nós vai ao concerto simplesmente para sentar perto de alguém ou porque estamos apaixonados pela pianista. Achemo-nos em uma experiência viva que tem direito a ser considerada uma coisa em si. Podemos estender esta observação à pergunta: pelo que você vive? Qual é a motivação básica?

É possível que descubramos que é nesta área da experiência cultural que muitos de nós vivemos a maior parte do tempo em que estamos despertos e, se transferirmos esta idéia para a infância, podemos perceber imediatamente que estamos falando a respeito do brincar.

Indubitavelmente o conceito do objeto transicional e dos fenômenos transicionais me levaram a querer estudar esta área intermediária que tem a ver com a experiência de viver e que não é nem sonho e nem relação de objeto. Ao mesmo tempo em que não é nem um nem outro destes, é também ambos. É este o paradoxo essencial e, em meu artigo sobre fenômenos transicionais a parte mais importante (em minha opinião) é a alegação que faço de que precisamos *aceitar o paradoxo*, não resolvê-lo. Os objetos e fenômenos transicionais são universais e variáveis. O estudo desses fenômenos proporciona um campo de pesquisa valioso para o estudioso do crescimento e desenvolvimento humanos, não apenas por que o introduz à infinidade da variabilidade nos seres humanos, mas também por que tem os seus próprios limites, há semelhanças entre os elementos e estes podem ser classificados. Em outras palavras, ele tem algumas das qualidades do brincar, no fato de a criança que está brincando utilizar materiais da realidade externa ou partilhada para a expressão de material onírico. O sonho pessoal acha-se lá, mas duas crianças podem construir casas semelhantes por causa do denominador comum existente nos materiais de construção e também por causa dos elementos arquetípicos do sonhar. Duas crianças, mesmo gêmeos idênticos, não podem ser iguais, se a realidade psíquica pessoal for incluída por baixo das marcas superficiais da personalidade. Apesar disso, as crianças podem assemelhar-se umas às outras e, de qualquer modo, elas se assemelham mutuamente no fato de usualmente haver dois olhos e um nariz e uma boca, etc.

Sugiro que, se olharmos para a filosofia e, momentaneamente, ignorarmos os detalhes imensamente importantes de conteúdo, podemos ver em operação uma dinâmica que eu chamaria de não-aceitação do paradoxo inerente. Para mim, o paradoxo é inerente. Em termos de objeto transicional, é ele que, embora o objeto se encontre lá para ser achado, o objeto foi criado pelo bebê. Poderíamos referir-nos aqui ao *limerick* de Ronald Knox* e, em teologia, a mesma coisa aparece na interminável discussão em torno da pergunta: existe um Deus? Se Deus é uma projeção, ainda assim há um Deus que me criou de maneira tal que possuo em mim o material para essa projeção? Etiologicamente, se posso utilizar aqui uma palavra que geralmente se refere a enfermidades, o paradoxo tem de ser aceito, não solucionado. O importante para mim deve ser: possuo em mim ter a idéia de Deus? Se não, então a idéia de Deus não tem valor para mim (exceto de modo supersticioso).

Este problema vai direto ao âmago da dificuldade que alguns de nós temos com relação ao conceito raiz de Melanie Klein, ainda que alguns dos enunciados de Bion tendam a abrir caminho para uma resolução de um conflito difícil de manejar sobre princípios básicos. É possível utilizar a ênfase que Melanie Klein dá à projeção e à introjeção se, na base, abre-se lugar para o elemento criativo do indivíduo, que tem de ser fundamental para este, mas que não precisa ser fundamental para o observador. Etiologicamente, tudo o que o bebê realiza surge de sua qualidade de estar vivo, inclusive a questão da função cerebral. É aqui que a idéia da dependência absoluta

* Ver Capítulo 11, "O Destino do Objeto de Transição" (N. do T).

nada mais que uma interpretação. Comentários interpretativos já foram explorados e certamente discutidos em grande extensão em inumeráveis horas de supervisão, de maneira que talvez haja necessidade de efetuar um estudo ulterior ao longo destas linhas no presente momento.

O propósito da interpretação deve incluir um sentimento que o analista tem de que foi feita uma comunicação que precisa ser reconhecida. Esta é talvez a parte importante da interpretação, mas este intuito muito simples acha-se amiúde escondido entre um monte de outras questões, tal como a instrução com referência ao emprego de símbolos. Como exemplo disto, se poderia tomar uma interpretação do tipo "os dois objetos brancos no sonho são os seios", etc. Tão pronto o analista tenha embarcado neste tipo de interpretação, ele abandonou a terra firme e acha-se agora em uma área perigosa onde está utilizando as suas próprias idéias, e estas podem estar erradas do ponto de vista do paciente, no momento.

Na forma mais simples, o analista devolve ao paciente o que este comunicou. Pode facilmente acontecer que o analista ache que isto é uma ocupação fútil, porque, se o paciente comunicou algo, qual é o sentido de dizê-lo de volta, exceto, naturalmente, pelo intuito de informar ao paciente de que o que ele disse foi ouvido e que o analista está tentando alcançar corretamente o sentido.

Fornecer uma interpretação de volta dá ao paciente oportunidade de corrigir os mal-entendidos. Há analistas que aceitam tais correções, mas há também aqueles que, em seu papel interpretador, assumem uma posição que é quase inexpugnável, de maneira que, se o paciente tenta fazer uma correção, o analista tende antes a pensar em termos da resistência daquele do que em termos da possibilidade de que a comunicação tenha sido errada ou insatisfatoriamente recebida.

Aqui, está-se já examinando variedades de psicanalistas, das quais existem muitas, e, indubitavelmente, uma das tarefas de ser um analisando é vir a saber como é o analista, o que ele espera e qual a linguagem que fala, e que tipo de sonhos pode utilizar, etc. Isto não é inteiramente inatural, por se assemelhar bastante ao que acontece com uma criança que tem de vir a conhecer que tipo de pais existem para serem usados como pais. Apesar disso, em um debate entre analistas, tenderia a ser tomado como certo que muitos pacientes são incapazes de fazer uso de analistas que exigem que o paciente faça mais que uma certa porção de adaptação, ou, para dizê-lo ao contrário, fazer uso de analistas que não são capazes ou não estão dispostos a fazer mais que uma certa adaptação às necessidades do paciente.

O princípio que estou enunciando neste momento é que o analista reflete de volta o que o paciente comunicou. Este enunciado muito simples a respeito da interpretação pode ser importante pelo próprio fato de ser simples e evitar as tremendas complicações que surgem quando se pensa em todas as possibilidades que podem ser classificadas na premência interpretativa. Se este princípio muito simples é enunciado, ele imediatamente precisa de elaboração, e sugiro que necessita de elaboração do seguinte tipo: área limitada da transferência de hoje, o paciente tem um conhecimento exato de um detalhe ou de um conjunto de detalhes. É como se houvesse uma dissociação pertencente ao lugar a que a análise chegou hoje. É útil lembrar que, desta maneira limitada ou desta posição limitada, o paciente pode estar dando ao analista uma amostra da verdade, isto é, de algo que é absolutamente verdadeiro para o paciente, e que, quando o analista o devolve, a interpretação é recebida pelo paciente que já emergiu, até certo ponto, desta área limitada ou condição dissociada. Em outras palavras, a interpretação pode mesmo ser dada à pessoa total, enquanto que o material para a interpretação derivou apenas de uma parte da pessoa total. Como pessoa total, o paciente não teria sido capaz de ter fornecido o material para a interpretação.

Desta maneira, as interpretações fazem parte de uma construção de *insight*. Detalhe importante é que a interpretação foi dada dentro de um certo número de minutos ou mesmo segundos do material muito rico em *insight* que foi apresentado. Ela certamente é dada na mesma sessão analítica. A interpretação correta, dada no dia seguinte, após uma supervisão, não tem utilidade, por causa desta operação muito poderosa de um fator temporal. Em outras palavras, desde uma área limitada, o paciente tem *insight* e fornece material para uma interpretação. O analista recebe esta informação e a fornece de volta para o paciente; o paciente, a quem ele a devolve, não se acha agora mais na área de *insight* com referência a este elemento ou constelação psicanalítica particular.

Com este princípio em mente, é possível sentir que a reflexão de volta para o paciente do que este já disse ou transmitiu, não é uma perda de tempo, mas em verdade, pode ser a melhor coisa que o analista pode fazer na análise desse paciente, nesse dia específico.

Há uma certa oposição a esta maneira de olhar as coisas, porque os analistas gostam de exercer as habilidades que adquiriram e têm muito que podem dizer a respeito de qualquer coisa que apareça. Exemplificando, em resposta a uma pergunta, um paciente bastante calado conta ao analista muita coisa a respeito de um de seus interesses principais, que tem a ver com o tiro aos pombos e a organização deste tipo de esporte. É extremamente tentador para o analista, neste ponto, utilizar este material, que é mais do que o que ele com freqüência obtém em duas ou três semanas, e, indubitavelmente, ele poderia falar a respeito da morte de todos os bebês não nascidos, sendo o paciente um filho único, e poderia falar também sobre as fantasias destrutivas inconscientes na mãe, por esta ter sido um caso depressivo e haver cometido suicídio. O que o analista sabia, contudo, era que todo o material provinha de uma pergunta e que não teria aparecido se o analista não o houvesse convidado, talvez simplesmente pela impressão de que estava perdendo o contato com o paciente. O material, portanto, não era material para interpretação, e o analista teve de reter tudo o que pôde imaginar com referência ao significado simbólico da atividade que o paciente estava descrevendo. Após certo tempo, a análise voltou a ser silenciosa e é o silêncio do paciente que contém a comunicação essencial. As pistas para este silêncio estão apenas lentamente surgindo e, diretamente, não existe nada que este analista possa fazer para que o paciente fale.

Mal se precisa mencionar que, com freqüência, o paciente produz material que o analista pode de forma útil interpretar noutro sentido. É como se o analista pudesse usar os processos intelectuais, tanto os seus quanto os do paciente, para avançar um pouco. O principal é a reflexão de volta para o paciente do material apresentado, que pode ser um sonho. Apesar disso, os dois juntos podem brincar de usar o sonho para obter um *insight* mais profundo. Existe aqui um grande perigo, porque a interação pode ser agradável e até mesmo excitante e fazer tanto o paciente quanto o analista sentirem-se muito gratificados. Apesar disso, existe apenas uma certa distância até onde o analista pode, com segurança, levar o paciente mais além do lugar em que este já se encontra.

Exemplo disso seria o seguinte: uma paciente apresenta um sonho recorrente, um sonho que lhe dominou a vida. Está morrendo de fome e só lhe sobra uma laranja, mas vê que esta foi mordiscada por um rato. Ela tem fobia a ratos e o fato de o roedor haver tocado a laranja torna impossível que ela a use. A aflição é extrema. Trata-se de um sonho ao qual esteve sujeita toda a vida. Diagnosticamente, ela entra na categoria de criança carente. O analista não precisa fazer nada a respeito deste sonho, porque o trabalho já foi feito no sonhar e, depois, no lembrar e no relatar. Estes últimos são resultados do trabalho já feito no tratamento e têm a natureza de um prêmio resultante do aumento da confiança. A matéria pode ser deixada af e o analista pode

esperar que mais material apareça. Neste caso particular que estou descrevendo, havia uma razão externa para o analista não poder permitir-se esperar, porque não ia haver oportunidade para outras sessões. Ele fez a interpretação, portanto, correndo por isso o risco de estragar o trabalho que já havia sido feito, mas também abrindo a possibilidade de que a paciente pudesse ir mais além imediatamente. Esta é uma questão de julgamento e o analista sentiu aqui que o grau de confiança era tal que ele podia prosseguir e até mesmo cometer um erro. Disse ele: "A laranja é o seio da mãe, que foi uma mãe boa desde o ponto de vista de você, mas foi a mãe que você perdeu. Os ratos representam tanto o seu ataque ao seio quanto o ataque do seio a você. O sonho tem a ver com o fato de que, sem auxílio, você está empacada, porque, embora ainda se ache em contato com o seio original que pareceu bom, você não pode fazer uso dele, a menos que possa ser ajudada através do estágio seguinte em que você excitadamente ataca o seio para comê-lo como comeria uma laranja".

Aconteceu que, neste caso, a paciente conseguiu utilizar esta interpretação imediatamente, e produziu dois exemplos: um deles ilustrava o relacionamento dela com a mãe, antes de perdê-la, e outro era uma lembrança da época da perda real da mãe. Desta maneira, a paciente obteve liberação emocional e houve uma acentuada mudança clínica para melhor.

Qualquer analista pode fornecer inumeráveis exemplos de interpretações que os pacientes foram capazes de usar e que os levaram mais além do ponto que haviam atingido quando estavam apresentando o material específico à sessão. Apesar disso, este exemplo particular salienta de maneira simples a dinâmica essencial da interpretação que vai mais além do reflexo de retorno do material apresentado.

No ensino de estudantes, contudo, não se pode enfatizar demais que é melhor ater-se ao princípios de refletir de volta o material apresentando, do que ir ao outro extremo das interpretações argutas, que, ainda que precisas, podem sem embargo levar o paciente mais além do que a confiança transferencial permite, de maneira que, quando o paciente deixa o analista, a revelação quase miraculosa que a interpretação representa repentinamente transforma-se numa ameaça, por se achar em contato com um estágio de desenvolvimento emocional que o paciente ainda não atingiu, pelo menos como personalidade total.

33

O Pensar e a Formação de Símbolos

Sem data; provavelmente redigido em 1968

Nossa atenção foi recentemente atraída para o processo de pensar tal como se relaciona com a metapsicologia psicanalítica, notavelmente por Bion¹.

Quero aqui examinar um dos aspectos deste vasto tema, e, ao fazê-lo, colocarei de lado muitos aspectos do pensar que se acham estreitamente relacionados com o meu tema escolhido, que é o relacionamento entre o pensar e a formação de símbolos.

Um enunciado sobre a origem ontológica do pensar já se acha contido em um artigo anterior de minha autoria, "A Mente e sua Relação com a Psique-Soma" (1949)². Enunciei neste artigo a idéia de que o pensar começa como uma maneira pessoal que o bebê tem para lidar com o fracasso graduado de adaptação da mãe. O pensar faz parte do mecanismo pelo qual o bebê tolera tanto o fracasso da adaptação à necessidade do ego, quanto a frustração do instinto que produz *tensão-tensão*, particularmente o primeiro.

Uma patologia deste processo, que também procurei assimilar nesse trabalho, aparece quando há uma adaptação atormentadora ou um fracasso da adaptação (devido a uma atitude inadequada da mãe), de maneira que a necessidade de pensar aumenta e, em verdade, produz uma escalada (para utilizar uma expressão moderna na necessidade de "pensar", de modo que o pensar se torna forçado como função, ou adquire uma nova função. Escrevi: "(...) encontramos o funcionamento mental tornando-se uma coisa em si, praticamente substituindo a mãe boa e tornando-a desnecessária". Acrescentei: "Clinicamente, isto pode acompanhar a dependência da mãe real e um falso crescimento pessoal, com base em submissão".

Ver-se-á disto que, em minha opinião, o pensar ou funcionamento mental precisa, nesses casos, ser estudado em sua psicopatologia, ou seja, como algo que perdeu seu lugar como aspecto especializado do funcionamento da psique (cf. psique-soma) e adquiriu uma função nova ou secundária.

Nos casos a que estou me referindo, o pensar tornou-se ex-cindido da sociedade psique-soma e assumiu uma parte do papel da mãe. A dependência mudou. A dependência da mãe mostrou ser relativamente insatisfatória e a dependência da

1. Ver Wilfred Bion, *Second Thoughts* (London: Heinemann Medical Books Ltd., 1967).

2. Em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London, Hogarth Press, 1975).

mente e de pensar assumiu o lugar da confiança na mãe suficientemente boa. Mais além disto, há um grau extremado de cisão (ou desespero a respeito da integração) que compensa a ausência de qualquer relacionamento entre o pensar e a função de maternagem suficientemente boa. Até mesmo o pensar fracassou.

Neste artigo, estou explorando mais a área em que se reteve um certo grau de sucesso desta defesa, na qual o pensar atua como substituto do cuidado materno e na qual se desenvolve um falso *self*, sob a forma de um intelecto explorado. A defesa não fracassou inteiramente.

No artigo a que me referi ("A Mente e sua Relação com a Psique-Soma"), forneci o caso de uma criança que estava se desenvolvendo ao longo destas linhas e que teve uma idéia de um estado ideal: tornar-se mentalmente deficiente. A implicação é que todo o tempo existe uma tensão na economia do bebê, mesmo quando a defesa intelectual teve algum sucesso; o indivíduo anseia por uma alternativa e, não sendo capaz de encontrá-la no cuidado e na dependência materna, tem de surgir na economia da mente de uma criança desse tipo uma tendência no sentido da alternativa de uma perda de vigor intelectual, ou uma perda da mente e do funcionamento mental.

(Ver-se-á que este é um exemplo de uma "castração" primária, baseada na perda de uma função do ego. Melhor conhecida é a verdadeira ansiedade castratória em encontrar expressão secundária na idéia de perda do intelecto.) (cf. a AFANÍSIA, de Jones)³.

A base de meu estudo ulterior, então, é a maneira pela qual, normalmente, o bebê em desenvolvimento pensa e leva em consideração fracassos adaptativos, bem como a maneira pela qual uma provisão ambiental atormentadora ou não suficientemente boa, explora o pensamento do bebê e até mesmo faz esse pensar assumir o lugar de algum elemento do meio ambiente expectável médio.

Material Clínico Introdutório

O caso que me levou a querer ligar o pensar com a formação de símbolos é o de uma mulher que está se aproximando do fim de uma longa e tediosa análise por um analista que é colega meu, eu próprio me achando envolvido de maneira auxiliar. A paciente, que é professora, estava lidando com uma interrupção de verão em sua análise fazendo um curso de atualização em cerâmica. Sua reação à interrupção teve dois aspectos:

- a. Atividade bem-sucedida na cerâmica.
- b. Desesperança a respeito do planejamento de suas responsabilidades de ensino do período seguinte. Sua queixa era de que *não podia pensar*. Isto não era um aspecto novo, e, em verdade, em determinada ocasião, uma incapacidade de utilizar seu intelecto muito bom fora o problema principal.

É possível descrever o estado das férias desta professora de maneira exata por causa de um incidente que ela sentiu fazer realmente parte de sua análise, embora tivesse acontecido quando se achava ausente, hospedando-se com alguém (X).

A paciente estava fazendo o jejum na cama. Levantou-se a fim de levar a bandeja para a cozinha e derrubou tudo no chão, quebrando uma valiosa porcelana e fazendo sujeira em toda parte. Sentiu um extremo de exasperação e o incidente perturbou-a profundamente.

3. Ver Ernest Jones, "Early Development of Female Sexuality" (1927), em *Papers on Psycho-Analysis* (London: Balliere, Tindall & Cox, 1950).

Podia-se descobrir queixando-se (mas apenas comigo lá, por saber que estava empregando uma série de delírios):

1. Fora culpa de Y, porque Y dera a X a bandeja e esta era escorregadia.
2. Ela gritou e X não a escutou, por achar-se fora da casa.
3. De qualquer maneira, X deveria ter estado lá, cuidando dela, e, então, o acidente não teria acontecido.
4. Se o analista da paciente houvesse chegado na ocasião e assumido tudo e a consolado, então todo o incidente teria se tornado parte da análise e não teria sido uma experiência desperdiçada.
5. Um analista bom teria estado lá, cuidando dela, levando a bandeja consigo, e não teria havido incidente.

Mas a mulher não era louca e podia *pensar*, bem como explicar a si mesma:

1. Seria absurdo esperar que um analista cuidasse de uma paciente durante as férias (férias do analista).
2. De qualquer maneira, o analista provavelmente não teria aparecido exatamente no minuto certo.
3. Se houvesse aparecido, talvez houvesse limpado a sujeira e consolado a paciente, ou, pelo menos, teria verbalizado a necessidade de a paciente ter este tipo de experiência, que teria corrigido o padrão de experiência esperada, pertencente à primeira infância da paciente.
4. Um analista realmente bom teria estado lá, concedendo à paciente um cuidado especial, e, então, não teria havido nenhum incidente infeliz. Nesse caso, a paciente teria podido sentir confiança em seu meio ambiente e em si própria, em um grau que a capacitaria a ficar com raiva do elemento de fracasso no padrão do meio ambiente de sua primeira infância e início da infância propriamente dita.

Na realidade, isto era o que estava realmente acontecendo, uma vez que a paciente sentia que todo o evento fazia parte da análise e pertencia às férias de uma análise que está começando a ser bem-sucedida.

O caso dá origem à consideração geral de que o êxito na análise deve incluir o delírio do fracasso, a reação do paciente à análise como um fracasso. Este paradoxo precisa ser levado em consideração. O analista tem de poder aceitar este papel de analista que fracassa, tal como aceita todos os outros papéis que surgem das neuroses e psicoses transferenciais do paciente. Muitas análises fracassaram no final porque o analista não podia permitir um fracasso delirante, devido à sua necessidade pessoal de provar a verdade da teoria psicanalítica através da cura de um paciente. A psicanálise não cura, embora seja verdade que um paciente pode fazer uso dela e alcançar, com o processo adjuntivo, um certo grau de integração, socialização e autodescoberta que não teria alcançado ou não poderia alcançar sem ela.

34

Sobre “O Uso de um Objeto”

Este Capítulo contém material relacionado ao “uso de um objeto”, conceito desenvolvido por Winnicott perto do fim de sua vida. Ele fez o seu principal enunciado do conceito em uma palestra perante a Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, em 12 de novembro de 1968; subseqüentemente, ela apareceu no *International Journal of Psycho-Analysis*, 50 (1969), e, depois, em versão ligeiramente modificada, em seu livro postumamente publicado, *O Brincar e a Realidade* (1971). Para a conveniência do leitor, esta última versão é reproduzida aqui como Parte I.

O resto do Capítulo consiste em textos que pertencem explicitamente ao desenvolvimento do conceito de Winnicott, bem como um artigo mais tardio que o emprega. A maior parte destes textos não foi anteriormente publicada; exceção a isso é a Parte III, que contém algumas das notas que Winnicott tomou no trem a caminho de casa, desde Dartington Hall, onde estivera pensando e falando a respeito do tema da liberdade e do controle nas escolas progressivas. Incluímos estas notas, embora elas já tenham sido publicadas em *Privação e Delinquência* (1984), por conterem a primeira referência que pudemos encontrar ao “uso de um objeto” como tal. É evidente, contudo, a partir do relato que Winnicott faz de um sonho datado de 1963, e de sua carta a um colega que o acompanhou (ambos na Parte II), que certos aspectos de seu conceito haviam se tornado explícitos ainda mais cedo que isso. Ele vinculou o sonho à redação de sua resenha do livro de Jung *Memories, Dreams, Reflections*; para a resenha em si, ver o Capítulo 57 do Volume II do presente livro. A Parte IV contém um artigo curto, “O Uso da Palavra *Uso*” escrito em fevereiro de 1968, e ao qual Winnicott concedia alguma importância, pois tem um lugar nas listas de artigos que fez em 1968 com vistas à publicação. A Parte V é uma ilustração clínica utilizada por Winnicott para a sua palestra de 1968 em Nova Iorque e é seguida por “Comentários sobre Meu Artigo *O Uso de um Objeto*”, Parte VI. Os comentários foram feitos em resposta ao debate ocorrido ao final da mesma palestra e, em particular, a uma observação da autoria do Dr. Bernard Fine, no sentido de Winnicott haver passado por alto sobre a importância do “componente libidinal das pulsões instintuais e a capacidade delas em ajudar o objeto a sobreviver”. Escritos em dezembro de 1968, quando Winnicott estava apenas se recuperando da enfermidade que o havia afligido em Nova Iorque após haver feito a palestra, eles foram parcialmente datilografados e, depois, terminados à mão; é provável que, se pretendesse dar-lhes publicação, ele lhes houvesse dado maior polimento. A última parte do Capítulo contém o artigo inacabado e também virtualmente não editorado “O Uso de um Objeto no Contexto de *Moisés e o Monoteísmo*”, escrito em janeiro de 1969. Aqui o conceito de Winnicott é vinculado ao texto de Freud e isto lhe

permite trazer o pai para o primeiro plano da vida do bebê de uma maneira que é raramente encontrada alhures em sua obra teórica.

De dois outros trabalhos que não se acham incluídos aqui poder-se-ia dizer que pertencem, pelo menos em parte, ao mesmo grupo. Um deles é uma palestra intitulada "Amamentação como Comunicação", lida na ausência de Winnicott (devida à sua doença) em uma conferência do National Childbirth Trust em 28 de novembro de 1968 e hoje publicada em seu livro *Babies and Their Mothers* (1987). Ela contém uma descrição do valor que tem para o bebê a amamentação, em termos de sobrevivência do seio. O outro trabalho é "O Lugar da Monarquia", escrito em 1970, que debate a monarquia também em termos de seu valor de sobrevivência. Ele pode ser encontrado na compilação da autoria de Winnicott e intitulada *Home is Where We Start From* (1985).

Os Organizadores

I. O Uso de um Objeto e o Relacionamento através de Identificações

Baseado em um trabalho lido perante a Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, em 12 de novembro de 1968

Neste Capítulo, proponho-me apresentar para debate a idéia do uso de um objeto. O tema afim de relacionar-se a objetos parece-me já haver recebido a nossa atenção plena. A idéia do uso de um objeto, contudo, não tem sido tão bem examinada e pode mesmo não ter sido especificamente estudada.

Este trabalho sobre o uso de um objeto origina-se de minha experiência clínica e encontra-se na linha direta de desenvolvimento que é peculiarmente minha. Não posso presumir, naturalmente, que a maneira pela qual minhas idéias se desenvolveram tenha sido seguida por outros, mas gostaria de apontar que houve uma seqüência, e a ordem que nesta possa existir pertence à evolução de meu trabalho.

O que tenho a dizer no presente Capítulo é extremamente simples. Embora se origine de minha experiência psicanalítica, não diria que poderia ter-se originado de minha experiência psicanalítica de dois decênios atrás, porque nesta ocasião não teria possuído a técnica de tornar possíveis os movimentos transferenciais que desejo descrever. Exemplificando, foi somente em anos recentes que me tornei capaz de esperar e esperar pela evolução natural da transferência que surge da confiança crescente do paciente na técnica e no *setting* psicanalíticos e evitar romper este processo natural efetuando interpretações. Notar-se-á que estou falando a respeito de fazer interpretações e não das interpretações como tais. Estarrece-me pensar quantas mudanças profundas impedi ou retardei em pacientes situados em certa categoria classificatória pela minha necessidade pessoal de interpretar. Se pudermos esperar, o paciente chega ao entendimento de modo criativo e com imensa alegria, e eu hoje desfruto dessa alegria mais do que costumava desfrutar da sensação de haver sido arguto. Acho que interpreto principalmente para deixar o paciente conhecer os limites de minha compreensão. O princípio é que é o paciente, e somente ele quem tem as

respostas. Nós podemos ou não capacitá-lo a abranger o que é conhecido ou tornar-se ciente disso com aceitação.

Em contraste com isto, vem o trabalho interpretativo que o analista tem de fazer, e que distingue a análise da auto-análise. Este interpretar pelo analista, se é que quer ter efeito, deve achar-se relacionado à capacidade que o paciente tem de *situar o analista fora da área dos fenômenos subjetivos*. O que se acha então envolvido é a capacidade do paciente de usar o analista, o que é o tema deste trabalho. No ensino, tal como na alimentação de uma criança, a capacidade de usar objetos é aceita como evidente, mas em nosso trabalho, é-nos necessário nos interessar pelo desenvolvimento e pelo estabelecimento da capacidade de usar objetos e identificar a incapacidade de um paciente em usá-los, onde isto constitui um fato.

É na análise do tipo de caso *borderline* que se tem oportunidade de observar os delicados fenômenos que apontam para uma compreensão dos estados esquizofrênicos verdadeiros. Pela expressão "*caso borderline*" quero significar o tipo de caso em que o cerne do distúrbio do paciente é psicótico, mas ele possui sempre suficiente organização psiconeurótica para ser capaz de apresentar uma psicose ou um transtorno psicossomático quando a ansiedade psicótica central ameaça irromper de forma grosseira. Em casos desse tipo, o psicanalista pode entrar em conluio durante anos com a necessidade que o paciente tem de ser psiconeurótico (em oposição a louco) e ser tratado como tal. A análise vai bem e todos estão satisfeitos. O único inconveniente é que a análise nunca termina. Ela pode ser terminada e o paciente pode mesmo mobilizar um falso *self* psiconeurótico para fins de término e expressão de gratidão. Na realidade, porém, ele sabe que não houve mudança no estado subjacente (psicótico) e que analista e paciente alcançaram êxito em entrar em conluio para ocasionar um fracasso. Mesmo este fracasso pode ter valor, se analista e paciente o reconhecerem. O paciente está mais velho e as oportunidades de morte por acidente ou enfermidade aumentaram, de maneira que o suicídio real *pode* ser evitado. Além disso, foi divertido enquanto durou. Se a psicanálise pudesse ser uma maneira de vida, poderia-se então dizer de um tratamento desse tipo, que ele fez o que se imaginava que fizesse. Mas a psicanálise não é uma maneira de vida. Todos nós esperamos que os nossos pacientes terminem conosco e nos esqueçam, e que descubram que o viver em si é a terapia que faz sentido. Embora escrevamos trabalhos sobre estes casos fronteiriços, ficamos internamente perturbados quando a loucura que neles existe permanece, sem ser descoberta e enfrentada. Tentei enunciar isto de maneira mais ampla em um artigo sobre classificação¹.

Talvez seja necessário estender-me um pouco mais para fornecer minha própria opinião sobre a diferença existente entre relação de objetos e o uso de objetos. Na relação com objetos, o sujeito permite que se dêem certas alterações no *self*, alterações de um tipo que nos levou a inventar o termo "*catexia*" [ou investimento psicoenergético]. O objeto tornou-se significante. Mecanismos de proteção e identificação estiveram operando e o sujeito acha-se esvaziado a um ponto em que algo dele é encontrado no objeto, embora enriquecido pelo sentimento. Ao acompanhar estas mudanças há um certo grau de envolvimento físico (ainda que ligeiro) no sentido da excitação, na direção do clímax funcional de um orgasmo. (Neste contexto, deliberadamente omito referir-me ao aspecto do relacionar-se, que constitui um exercício em identificações cruzadas. Ele tem de ser omitido aqui porque pertence a uma fase de desenvolvimento que é subsequente e não anterior àquela em que estou interessado neste trabalho, a saber, o afastamento da autocontenção e do relacionar-se com objetos subjetivos no domínio do uso do objeto.)

1. 1959-1964: em *O Ambiente e os Processos de Maturação* (Porto Alegre: Artes Médicas, 1983; London: Hogarth Press; New York, International Universities Press, 1965).

Relacionar-se com objetos é uma experiência do sujeito que pode ser descrita em termos do sujeito como algo isolado. Quando falo do uso de um objeto, contudo, estou tomando o relacionar-se com objetos como certo, e adiciono novos aspectos que envolvem a natureza e o comportamento do objeto. Exemplificando, o objeto, se é que vai ser usado, tem de necessariamente ser real no sentido de fazer parte da realidade partilhada e não ser um feixe de projeções. É isto que, penso eu, contribui para o mundo de diferença que existe entre relacionamento e uso.

Se estiver com razão em relação a isto, decorre então que o debate do tema do relacionar-se é um exercício muito mais fácil para os analistas que o exame do uso, uma vez que o relacionar-se pode ser examinado como um fenômeno do sujeito, e a psicanálise sempre gosta de poder eliminar todos os fatores que são ambientais, exceto na medida em que se pode imaginar o ambiente em termos de mecanismos projetivos. Ao examinar o uso, porém, não há escapatória: o analista tem de levar em consideração a natureza do objeto, não como projeção, mas como coisa em si.

Por enquanto, deixarei o assunto nisso, no que o relacionar-se pode ser descrito em termos do sujeito individual e que o uso não pode ser descrito, exceto em termos da aceitação da existência independente do objeto, de sua propriedade de ter estado lá todo o tempo. Verão que são justamente estes problemas os que nos interessam quando examinamos a área para a qual tentei chamar a atenção em meu trabalho sobre o que chamei de fenômenos de transição ou transicionais.

Mas esta mudança não ocorre automaticamente, pelo processo maturacional em si. É este detalhe que me interessa.

Em termos clínicos: dois bebês estão sendo amamentados ao seio. Um deles está se alimentando do *self*, uma vez que o seio e o bebê ainda não se tornaram (para o bebê) fenômenos separados. O outro está se alimentando de uma fonte diferente-de-mim, ou um objeto a que se pode dar um tratamento descuidado e sem efeitos sobre o bebê, a menos que o objeto retalie. As mães, tal como os analistas, podem ser boas ou não suficientemente boas; algumas podem e outras não podem fazer o bebê passar do relacionar-se para o uso.

Gostaria de inserir aqui um lembrete de que o aspecto essencial no conceito dos objetos e fenômenos transicionais (de acordo com a minha apresentação do assunto) é o *paradoxo*, e a *aceitação do paradoxo*: o bebê cria o objeto, mas este estava lá esperando para ser criado e para tornar-se um objeto psicoenergeticamente investido. Tentei chamar a atenção para este aspecto dos fenômenos transicionais alegando que, segundo as regras do jogo, todos nós sabemos que nunca desafiaremos o bebê a fornecer uma resposta à pergunta: foi você quem criou isso ou o encontrou?

Estou agora pronto a ir diretamente ao enunciado de minha tese. Parece que estou com medo de chegar lá, como se temesse que, uma vez enunciada, o propósito de minha comunicação chegue ao fim, por ser tão simples.

Para usar um objeto, o sujeito tem de ter desenvolvido uma *capacidade* de usar objetos. Isto faz parte da mudança para o princípio da realidade.

Não se pode dizer que essa capacidade seja inata, nem, tampouco, que o seu desenvolvimento em um indivíduo seja tomado por certo. O desenvolvimento de uma capacidade de usar um objeto é outro exemplo do processo maturacional como algo que depende de um meio ambiente facilitador².

2. Ao escolher *The Maturational Processes and the Facilitating Environment* como título de meu livro da Biblioteca Psicanalítica Internacional (1965), estava demonstrando quanto fui influenciado pela Dra. Phyllis Greenacre (1960) no Congresso de Edimburgo. Infelizmente, falhei em não colocar no livro um reconhecimento deste fato. — D. W. W.

Na seqüência, pode-se dizer que primeiramente temos o relacionamento com objetos, e depois, ao final, temos o uso de objetos. Entre eles, contudo, situa-se a coisa mais difícil, talvez, do desenvolvimento humano, ou o mais enfadonho de todos os fracassos iniciais que nos chegam para consertar. Essa coisa que se situa entre o relacionar-se e o uso é a colocação, pelo sujeito, do objeto fora da sua área de controle onipotente, isto é, a percepção que o sujeito tem do objeto como fenômeno externo, não como entidade projetiva, e, na realidade, o reconhecimento dele como uma entidade por seu próprio direito³.

A mudança (do relacionar-se para o uso) significa que o sujeito destrói o objeto. Disto um filósofo de poltrona poderia argüir que, portanto, não existe na prática coisa tal como o uso de um objeto: se o objeto é externo, então o objeto é destruído pelo sujeito. Mas se o filósofo saísse de sua poltrona e se sentasse no chão com seu paciente, ele descobriria que existe uma posição intermediária. Em outras palavras, descobriria que, após "sujeito relaciona-se com objeto" vem "sujeito destrói objeto" (quando se torna externo) e, depois, pode vir "*objeto sobrevive* à destruição pelo sujeito". Mas pode haver ou não sobrevivência e uma nova característica chega assim à teoria do relacionamento com objetos. O sujeito diz ao objeto: "Destruí você" e o objeto acha-se lá para receber a comunicação. A partir daí, o sujeito diz: "Alô, objeto!" "Destruí você". "Amo você". "Você tem valor para mim por sobreviver à minha destruição de você". "Enquanto estou amando você, estou todo o tempo destruindo você na *fantasia*" (inconsciente). Aqui começa a fantasia para o indivíduo. O sujeito pode agora *usar* o objeto que sobreviveu. É importante notar que não se trata apenas de o sujeito destruir o objeto porque este está situado fora da área de controle onipotente. É igualmente importante enunciar isto ao contrário e dizer que é a destruição do objeto que o situa fora da área de controle onipotente do sujeito. Destas maneiras, o objeto desenvolve sua própria autonomia e vida, e (se sobrevive) contribui para o sujeito, de acordo com suas próprias propriedades.

Em outras palavras, por causa da sobrevivência do objeto, o sujeito pode agora começar a viver uma vida no mundo dos objetos e tem assim a ganhar de maneira imensurável, mas o preço tem de ser pago pela aceitação da destruição continuada na fantasia inconsciente relativa ao relacionamento com objetos.

Deixem-me repetir. Esta é uma posição à qual o indivíduo pode chegar em estágios iniciais de crescimento emocional somente através da sobrevivência real dos objetos psicoenergeticamente investidos que estão, na ocasião, em processo de tornarem-se destruídos por serem reais e de se tornarem reais por serem destruídos (sendo destrutíveis e consumíveis). A partir daí, havendo sido atingido este estágio, os mecanismos projetivos ajudam no ato de *notar o que está lá*, mas eles não são a *razão pela qual o objeto está lá*. Em minha opinião, isto é um afastamento da teoria que tende à uma concepção da realidade externa apenas em termos dos mecanismos projetivos do indivíduo.

Agora, já procedi a quase todo o meu enunciado. Não inteiramente, contudo, porque não me é possível tomar por evidente uma aceitação do fato de que o primeiro impulso na relação do sujeito com o objeto (objetivamente percebido, e não-subjetivo) é destrutivo. (Anteriormente, utilizei a palavra "descuidado", numa tentativa de dar ao leitor uma oportunidade de imaginar algo nesse ponto, sem indicar o caminho de modo demasiado claro).

O postulado central desta tese é que, enquanto o sujeito não destrói o objeto subjetivo (material de projeção), a destruição aparece e se torna um aspecto central na medida em que o objeto é objetivamente percebido, tem autonomia e pertence à realidade "partilhada". Esta é a parte difícil de minha tese, pelo menos para mim.

3. Em minha compreensão deste ponto, fui influenciado por W. Clifford M. Scott (comunicação pessoal, por volta de 1940). — D. W. W.

Entende-se geralmente que o princípio da realidade envolve o indivíduo em raiva e destruição reativa, mas a minha tese é que a destruição desempenha o seu papel na construção da realidade, situando o objeto fora do *self*. Para que isto aconteça, são necessárias condições favoráveis.

Trata-se simplesmente de examinar o princípio da realidade com uma lente de alto poder. Tal como o vejo, estamos familiarizados com a mudança pela qual os mecanismos de projeção capacitam o sujeito a tomar conhecimento do objeto. Isto não é o mesmo que reivindicar que para o sujeito o objeto existe por causa da operação dos mecanismos de projeção do sujeito. A princípio, o observador utiliza palavras que parecem aplicar-se a ambas as idéias, a um só e mesmo tempo, mas num exame mais atento, vemos que as duas idéias não são de maneira alguma idênticas. É exatamente para este ponto que dirigimos o nosso estudo.

No ponto do desenvolvimento que se acha em exame, o sujeito está criando o objeto no sentido de encontrar a própria externalidade, e tem de se acrescentar que esta experiência depende da capacidade que o objeto tenha de sobreviver. (É importante que, neste contexto, "sobreviver" signifique "não retaliar".) Se for numa análise que estas coisas estão acontecendo, então o analista, a técnica analítica e o *setting* analítico, todos eles entram nisso como sobrevivendo ou não sobrevivendo aos ataques destrutivos do paciente. Esta atividade destrutiva é a tentativa que o paciente faz de situar o analista fora da área de controle onipotente, isto é, do lado de fora, no mundo. Sem a experiência da destrutividade máxima (objeto não-protegido), o sujeito nunca situa o analista do lado de fora e, portanto, nunca pode fazer mais que experienciar uma espécie de auto-análise, utilizando o analista como projeção de uma parte do *self*. Em termos de alimentação, então, o paciente só pode alimentar-se no *self* e não pode utilizar o seio para ficar gordo. O paciente pode até mesmo fruir a experiência analítica, mas fundamentalmente, não mudará.

E se o analista é um fenômeno subjetivo, o que dizer a respeito da remoção do refugio? É necessário um enunciado ulterior em termos de produção⁴.

Na prática psicanalítica, as mudanças positivas que ocorrem nesta área podem ser profundas. Elas não dependem do trabalho interpretativo, mas sim da sobrevivência do analista aos ataques, que envolve e inclui a idéia da ausência de uma mudança de qualidade para a retaliação. Estes ataques podem ser muito difíceis de serem suportados pelo analista⁵, especialmente quando são expressos em termos de delírio ou mediante uma manipulação que faz o analista realmente fazer coisas que são tecnicamente más. (Refiro-me a uma coisa do tipo de ser inconfiável em momentos em que a confiabilidade é tudo o que importa, assim como à sobrevivência, em termos de manter-se vivo e de ausência da qualidade de retaliação.)

O analista tem vontade de interpretar, mas isto pode estragar o processo e, para o paciente, pode parecer uma espécie de autodefesa, com o analista desviando o ataque do paciente. É melhor esperar até que a fase termine e, então, discutir com o paciente o que esteve acontecendo. Isto é certamente legítimo, porque, como analistas, têm-se as próprias necessidades, mas a interpretação verbal neste ponto não é o aspecto essencial e traz consigo os seus próprios perigos. O aspecto essencial é a sobrevivência do analista e o caráter intacto da técnica psicanalítica. Imagine-se quão traumático pode ser o falecimento real do analista quando este tipo de trabalho se acha em processo, embora mesmo a morte real do analista não seja tão ruim quanto

4. A tarefa seguinte para alguém que trabalhe no campo dos fenômenos transicionais é reenunciar o problema em termos de remoção. — D. W. W.
5. Quando a analista sabe que o paciente porta um revólver, então, segundo me parece, este trabalho não pode ser efetuado.

o desenvolvimento, nele, de uma mudança de atitude no sentido da retaliação. Trata-se de riscos que simplesmente têm de ser corridos pelo paciente. Usualmente, o analista passa por estas fases de movimento na transferência e, após cada uma delas, chega à recompensa em termos de amor, reforçada pelo pano de fundo da destruição inconsciente.

Parece-me que a idéia de uma fase do desenvolvimento que essencialmente envolve a sobrevivência do objeto afeta a teoria das raízes da agressão. Não adianta dizer que um bebê de alguns dias inveja o seio. É legítimo, contudo, dizer que, seja qual for a idade em que um bebê começa a conceder ao seio uma posição externa (fora da área de projeção), isto significa que a destruição do seio tornou-se uma característica. Quero significar por isto o impulso real a destruir. É parte importante daquilo que uma mãe faz: ser a primeira pessoa a conduzir o bebê através desta primeira versão, das muitas que serão encontradas, de ataque ao qual se sobrevive. Este é o momento certo no desenvolvimento da criança, por causa da sua relativa debilidade, de maneira que se pode com bastante facilidade sobreviver à destruição. Mesmo assim, contudo, trata-se de algo delicado, pois é muito fácil para uma mãe reagir de modo moralístico quando o seu bebê morde e machuca⁶. Mas esta linguagem que envolve "o seio" é jargão profissional. Toda a área de desenvolvimento e manejo, na qual a adaptação está relacionada à dependência acha-se envolvida.

Ver-se-á que, embora "destruição" seja a palavra que estou utilizando, esta destruição real pertence ao fracasso do objeto em sobreviver. Sem ele, a destruição permanece sendo potencial. A palavra "destruição" é necessária, não por causa do impulso do bebê a destruir, mas por causa do risco de o objeto não sobreviver, o que também significa experimentar mudança em qualidade ou em atitude.

A maneira de examinar as coisas que pertence à minha apresentação deste Capítulo torna possível uma nova abordagem a todo o tema das raízes da agressão. Exemplificando, não é necessário conceder à agressão inata mais do que lhe é devido, na companhia de tudo o mais que é inato. Indubitavelmente, a agressão inata deve ser variável em sentido quantitativo, da mesma maneira pela qual tudo o mais que é herdado é variável entre os indivíduos. Em contraste, são grandes as variações que se originam das diferenças nas experiências de diferentes bebês recém-nascidos, de acordo com serem eles ou não conduzidos através desta fase muito difícil. As variações desse tipo no campo da experiência são verdadeiramente imensas. Ademais, os bebês que tenham sido bem-cuidados, através desta fase, têm probabilidade de serem mais agressivos *clínicamente* do que aqueles com quem isso não aconteceu, e para quem a agressão é algo que não pode ser abrangido ou algo que só pode ser mantido sob a forma de uma tendência a ser um objeto de ataque.

Isto envolve uma nova redação da teoria das raízes da agressão, uma vez que a maior parte do que já foi escrito por analistas foi formulado sem referência ao que está sendo debatido neste Capítulo. Na teoria ortodoxa encontra-se sempre o pressuposto de que a agressão é reativa ao encontro com o princípio da realidade, enquanto que aqui é a pulsão destrutiva que cria a qualidade da externalidade. Isto é central à estrutura de meus argumentos.

Permitam-me examinar por um momento o local exato deste ataque e sobrevivência na hierarquia dos relacionamentos. Mais primitivo e inteiramente diferente é o aniquilamento. O aniquilamento significa "nenhuma esperança"; a catexia se enfraquece porque nenhum resultado completa o reflexo a produzir condicionamento. Por

6. Na realidade, o desenvolvimento do bebê é imensamente complicado se acontecer ele nascer com um dente, de maneira que o ataque das gengivas ao seio nunca pode ser posto à prova.
— D. W. W.

outro lado, o ataque raivoso relativo ao encontro com o princípio da realidade é um conceito mais sofisticado, pós-datado à destruição que aqui postulo. *Não há raiva* na destruição do objeto a que estou me referindo, embora se possa dizer que há alegria com a sobrevivência do objeto. A partir deste momento, ou originando-se desta fase, o objeto *na fantasia*, está sempre sendo destruído. Esta qualidade de "sempre sendo destruído" torna a realidade do objeto sobrevivente sentida como tal, fortalece o tom do sentimento e contribui para a constância objetual. O objeto agora pode ser usado.

Quero concluir com uma nota sobre usar e uso. Por "uso" não quero dizer "exploração". Como analista, sabemos o que é ser usado, que significa que podemos perceber o fim do tratamento, ainda que este se ache a vários anos de distância. Muitos de nossos pacientes chegam com este problema já solucionado: eles podem usar objetos, podem nos usar e podem usar a análise, tal como usaram seus pais, seus irmãos e irmãs e seus lares. Contudo, existem muitos pacientes que precisam que possamos lhes dar uma capacidade de nos usar. Esta, para eles, é a tarefa analítica. No atendimento das necessidades desses pacientes, precisaremos saber o que estou dizendo aqui a respeito de nossa sobrevivência à destrutividade deles. Um pano de fundo de destruição inconsciente do analista é erigido e nós sobrevivemos a ele ou então, alternativamente, temos aqui mais uma outra análise interminável.

Resumo

O relacionar-se com objetos pode ser descrito em termos da experiência do sujeito. A descrição do uso de objetos envolve a consideração da natureza do objeto. Estou oferecendo para debate as razões pelas quais, em minha opinião, a capacidade de usar um objeto é mais sofisticada que a capacidade de relacionar-se com objetos, e o relacionar-se pode se dar com um objeto subjetivo, mas o uso implica que o objeto faz parte da realidade externa.

Pode-se observar a seguinte sequência: (1) Sujeito *relaciona-se com* objeto. (2) Objeto acha-se em processo de ser encontrado, ao invés de colocado pelo sujeito no mundo. (3) Sujeito *destrói* objeto. (4) Objeto sobrevive à destruição. (5) Sujeito pode *usar* objeto.

O objeto está sempre sendo destruído. Esta destruição se torna o pano de fundo inconsciente para o amor de um objeto real, ou seja, um objeto situado fora da área do controle onipotente do sujeito.

O estudo deste problema envolve um enunciado do valor positivo da destrutividade. Esta, mais a sobrevivência à destruição pelo objeto, situa este último fora da área dos objetos estabelecidos pelos mecanismos mentais projetados do sujeito. Desta maneira, é criado um mundo de realidade partilhada que o sujeito pode usar e que pode retroalimentar a substância diferente-de-mim no sujeito.

II. Um Sonho de D. W. W. Relacionado a uma Resenha de um Livro de Jung

Relato incluído em carta escrita a um colega, em 29 de dezembro de 1963

Este foi um de uma longa linha de sonhos significantes que tive antes, durante e após a análise. Eles aparecem como um resultado do trabalho feito e cada um deles se aproveita de um novo crescimento do ego ou de novos esclarecimentos. Este sonho teve importância especial para mim porque esclareceu o mistério de um elemento de minha psicologia a que a análise não podia chegar, a saber, a impressão de que eu ficaria bem se alguém abrisse a minha cabeça (da frente para trás) e de lá tirasse algo (tumor, abscesso, bolsa, supuração) que existe e se faz sentir exatamente no centro, por trás da base do nariz.

O sonho levou longo tempo, certamente vinte minutos, e ele e sua análise ocuparam cerca de duas horas da noite. Não foi um pesadelo porque nunca ameaçou a capacidade que meu ego tem de suportar tensão.

Há uma quantidade imensa de detalhes que são pessoais e podem ser ignorados. Posso descrever o sonho em termos de sua metapsicologia sem perder nada, porque uma vez sonhado e aceito, ele cumpriu sua tarefa, por assim dizer, e o resultado se acha permanentemente comigo.

O sonho pode ser fornecido em suas três partes.

1. Havia uma destruição absoluta, eu fazia parte do mundo e de todas as pessoas e, portanto, estava sendo destruído. (O importante, nos estágios iniciais, foi a maneira pela qual no sonho a destruição pura libertou-se de todas as suavizações, tais como relacionamento objetal, crueldade, sensualidade, sadomasoquismo, etc.)

2. Havia então destruição absoluta e eu era o agente destruidor. Aqui tínhamos então um problema para o ego: como integrar estes dois aspectos da destruição?

3. A parte três então apareceu e, *no sonho*, despertei. Como despertara, sabia que havia sonhado tanto (1) quanto (2). Havia portanto solucionado o problema, pelo uso da diferença existente entre os estados de vigília e sonho. Ali estava eu, desperto, no sonho, e sabia que havia sonhado ser destruído e ser o agente destruidor. Não havia dissociação, de maneira que os três eus achavam-se inteiramente em contato uns com outros. Recordo sonhar eu (2) e eu (1). Isto foi sentido como imensamente satisfatório, embora o trabalho efetuado me houvesse feito exigências tremendas.

Comecei então a despertar.

O que primeiro soube foi que estava com *uma dor de cabeça muito forte*. Podia ver minha cabeça cindida ao meio, com uma folha negra entre as metades direita e esquerda. Descobri as palavras "dor de cabeça de rachar" chegando a mim e me despertando, e percebi a propriedade da descrição. Isto me permitiu gradualmente voltar ao estado desperto e, no decurso de meia hora, a dor de cabeça me deixou. Enquanto jazia lá, suportando a dor de cabeça, todo o sonho veio a mim e, com ele, o sentimento de que agora conhecia um significado importante do número três. Eu tinha estes três *selves* essenciais, o eu (3) que podia, por sua vez, lembrar sonhar ser o eu (2) e o eu (1). Sem o eu (3) tenho de permanecer cindido, solucionando o problema alternadamente em sadismo e masoquismo, utilizando o relacionamento com objetos, isto é, relacionando-me com objetos objetivamente percebidos.

Tive a percepção aguda, na terceira parte do sonho e quando desperto, de que a destrutividade pertence ao relacionar-se com objetos que se acham fora do mundo

subjetivo ou da área de onipotência. Em outras palavras, primeiro existe a criatividade que pertence ao estar vivo, e o mundo é apenas um mundo subjetivo. Depois vem o mundo objetivamente percebido e a destruição absoluta dele e de todos os seus detalhes.

Estava também ciente, enquanto o sonho fluía sobre mim antes de ficar inteiramente desperto, de que estava sonhando um sonho para Jung e para alguns de meus pacientes, assim como para mim mesmo. Jung parece não ter contato com os seus próprios impulsos primitivos destrutivos e dá apoio a esta idéia em seus textos. Quando brincava, ainda criança pequena, ele construía e depois destruía, repetidas vezes. Ele não se descreve como brincando de modo construtivo em relação a *ter destruído* (na fantasia inconsciente). Em minha revisão, relatei isto a uma dificuldade que Jung pode ter tido por ter sido cuidado por uma mãe deprimida (se isto for verdade).

Extrato da Carta que Acompanha o Sonho

Incluo o meu Sonho.

Ele se refere a uma camada profunda de destrutividade, mas ainda assim, a um manejo um tanto sofisticado (no sentido do ego) dessa destrutividade.



Esta linha situa-se entre o funcionamento na área da onipotência e fora dele. Se for simples atravessá-la, então a linha é o lugar para a destruição 100%.

Na saúde, o bebê é auxiliado por lhe serem fornecidas (pela mãe dedicada comum) áreas de experiência de onipotência, ao tempo em que faz experiências com incursões além da linha, na terra devastada da realidade destruída. Esta terra mostra ter características suas próprias, ou valor de sobrevivência, etc., e, de modo surpreendente, a criança individual descobre que a destruição total não significa destruição total.

III. Notas Escritas no Trem, Parte 2

Redigido em abril de 1965

Desenvolvimento do Tema do Controle

Axioma. Não é proveitoso debater-se o controle separadamente de um enunciado sobre o diagnóstico da criança ou adulto que tem possibilidade de vir a situar-se sob controle.

Quando se considera a questão do diagnóstico daqueles que estão sujeitos a controle, um fator importante será a maturidade (relativa) do indivíduo, tal como vista na história e na qualidade do relacionamento com o objeto amoroso primário que ele estabeleceu. Sugiro que poderíamos proveitosamente especular da seguinte maneira:

O que pode um ser humano fazer com um objeto? No início, a relação é com um objeto subjetivo. Gradativamente, sujeito e objeto tornam-se separados e temos então a relação com o objeto objetivamente percebido. O sujeito destrói o objeto.

Isto se divide em: (1) sujeito preserva objeto; (2) sujeito *usa* objeto; (3) sujeito *destrói* objeto.

1. Isto é a idealização.

2. Uso do objeto: uma idéia sofisticada, uma conquista do crescimento emocional sadio, não atingida exceto na saúde e com o decorrer do tempo.

Nesse meio-tempo parece

3. que surge clinicamente como um rebaixamento da representação do objeto desde a perfeição para algum tipo de ruindade (denegrir sujar, rasgar, etc.) Isto protege o objeto, porque apenas o objeto perfeito é digno de destruição. Isto não é idealização, mas sim denegrecimento.

No curso do crescimento do indivíduo, torna-se possível à destruição ter representação adequada na fantasia (inconsciente), que é uma elaboração do funcionamento corporal e experiências instintuais de todas as espécies.

Este aspecto do crescimento capacita o indivíduo a ficar preocupado com a destruição que acompanha o relacionamento com objetos e a experienciar culpa relativa às idéias destrutivas que acompanham o amar. Com base nisto, o indivíduo encontra a motivação para o esforço construtivo, para dar e para consertar (a reparação e a restituição, de Klein).

A questão prática aqui surge da distinção entre

1. estragar o objeto bom é torná-lo menos bom e, dessa maneira, menos sujeito a ataques, e

2. a destruição que se acha na raiz do relacionamento com objetos e que, na saúde, canaliza-se para a destruição que se dá no inconsciente, na realidade psíquica interna do indivíduo, em sua vida onírica e suas atividades lúdicas, e na expressão criativa.

A última não precisa de controle; o que se necessita aqui é a provisão de condições que permitam o crescimento emocional do indivíduo, contínuo desde a primeiríssima infância até a ocasião em que as complexidades da fantasia e do deslocamento se tornam acessíveis ao indivíduo em sua busca de uma solução pessoal.

Em contraste, o denegrecimento compulsivo, a sujeira e a destruição que pertencem à primeira, uma alteração do objeto que visa torná-lo menos excitante e menos digno de destruição, isto precisa da atenção da sociedade. Exemplificando: a pessoa

anti-social que entra em uma galeria e retalha um quadro da autoria de um velho mestre não está acionada pelo amor à pintura e, na realidade, não está sendo tão destrutiva quanto o amante da arte é quando preserva a pintura, usa-a plenamente e, na fantasia inconsciente, a destrói repetidas vezes. Apesar disso, o ato isolado de vandalismo afeta a sociedade e esta tem de proteger-se. Este exemplo bastante grosseiro pode servir para mostrar a existência de uma ampla diferença entre a destrutividade que é inerente ao relacionamento objetal e a destrutividade que se origina da imaturidade de um indivíduo.

Da mesma maneira, o comportamento heterossexual compulsivo possui uma etiologia complexa e se acha muito afastado da capacidade que um homem e uma mulher têm de se amarem de maneira sexual, quando decidiram estabelecer juntos um lar para possíveis filhos. No primeiro caso, acha-se incluído o elemento do estrago do que é perfeito ou de ser estragado, e não mais perfeito, em um esforço para diminuir a ansiedade. No último caso, pessoas relativamente maduras lidaram com a destruição, com a preocupação e com o senso de culpa dentro de si e ficaram livres para planejar utilizar o sexo de modo construtivo, sem negar os elementos rudes que existem na fantasia sexual total.

É algo surpreendente descobrir-se quão pouco o amante romântico e quão muito pouco o adolescente heterossexual sabem *a respeito da fantasia sexual total*, consciente e inconsciente, com sua competitividade, sua crueldade, seus elementos pré-genitais de destruição grosseira e os seus perigos.

Aqueles que abanam a Bandeira Progressista, na educação, precisam estudar estas coisas, pois doutra maneira muito facilmente tomarão equivocadamente a heterossexualidade como saúde, e a acharão conveniente quando a violência não surge, apenas se apresentam como o pacifismo reativo irracional da adolescência, que tem somente pequena relação com as realidades cruas do mundo real, no qual um dia esses adolescentes ingressarão como adultos competitivos.

IV. O Uso da Palavra *Uso*

Datado de 5 de fevereiro de 1968

I

Ficamos tão acostumados às palavras através de seu uso e tornamo-nos tão embotados quanto ao seu emprego que, de tempos em tempos, precisamos tomar cada uma delas e examiná-las, e determinar, na medida em que formos capazes disso, não apenas como a palavra veio a existir através da poesia da etimologia, mas também as maneiras pelas quais a estamos utilizando agora.

Decidi examinar a palavra "uso" porque quero ver o que foi que quis dizer quando terminei uma conferência pública com as seguintes palavras: "e é talvez o maior cumprimento que podemos receber se formos tanto encontrados quanto usados"⁷.

7. *Communication between Infant and Mother, and Mother and Infant Compared and Contrasted* (1968), em Winnicott, *Babies and Their Mothers* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1987).

Ao dizer isto estava falando de modo geral, mas pelo contexto, podia-se ver que estava me referindo especificamente ao uso que o paciente pode fazer do analista, e também me referindo ao protótipo, o uso que o bebê faz da mãe em uma experiência sadia do par entregue à amamentação.

Pode-se verdadeiramente dizer, na descrição de um longo tratamento psicanalítico, que o paciente usou o analista todo o tempo, especialmente se incluímos o "consumir" [*wasting*] com a palavra "usar". Apesar disso, com certos pacientes, chega um momento ou um lugar da análise em que se pode dizer que, embora o paciente, em certo sentido, não tenha até então usado o analista, agora e a partir de agora ele o está usando. Algo aconteceu no paciente que torna correta esta mudança de linguagem. Seguindo isto de perto dá-se a correspondente alteração na experiência do paciente, que agora se descobre sendo usado. Isto pode dar grande satisfação ao paciente e ser uma recompensa para os anos de tateamento às cegas que a análise pode parecer ser.

Levei em consideração o fato de que, com muitos pacientes, estas questões não são altamente significantes, enquanto que, para outros, é a própria mudança que estava sendo procurada. Como tantas vezes se mostra verdadeiro quando examinamos um mecanismo psicanalítico, trata-se de uma questão de diagnóstico, e, se fôssemos melhores em diagnóstico, pouparíamos a nós mesmos e a nossos pacientes um bocado de tempo e desespero.

II

É pertinente indagar neste ponto: qual foi o estado que veio antes do uso, antes de o analisando usar o analista? É possível descrever não somente a libélula, mas também o processo de metamorfose e, em verdade, a própria crisálida? Isso verdadeiramente seria bom.

Não será que antes da mudança para o uso, o paciente (sujeito) protege o analista (objeto) quanto a ser usado? No caso extremo, o sujeito é deixado com um objeto ideal, ou um objeto idealizado, perfeito e inatingível.

No refinamento, há o uso pelo desperdício, isto é, o ódio pode ser expresso em termos de esbanjamento. Mas o senso de desperdício é algo que é sentido pelo objeto que é protegido. Compete ao observador decidir se um exemplo de não-uso porta consigo sentimentos de ódio, e, neste estágio de minha exposição, estou interessado apenas com o não-uso como a surgir automaticamente da proteção do objeto pelo sujeito.

Aqui está o sujeito e lá se acha o objeto, mas na experiência do primeiro, não pode haver uso do segundo. Na prática, o analisando não pode usar o analista, de maneira que a tarefa primordial deste é capacitar aquele a tornar-se capaz de usar, com o corolário de tornar-se capaz de ser usado.

Obviamente, as ilustrações mais evidentes deste estado de coisas têm de ser aqueles inumeráveis casos que nunca são encontrados, porque o sintoma do paciente exclui qualquer uso que se possa fazer do analista. Juntamente com isto vemos muitos tratamentos que constituem uma extensão infinita do não-uso, mantidos indefinidamente em andamento pelo temor da confrontação com a dificuldade em si, que é uma incapacidade de usar e ser usado. Os analistas têm de partilhar com os pacientes desse tipo a responsabilidade por tratamentos que pertencem a esta categoria de desconfortos.

Com frequência acontece que estudamos casos extremos, a fim de obter *insight* quanto aos problemas comuns que em verdade tornam-se agudos e até mesmo dominantes em certas ocasiões ou em certas fases de um tratamento, mas que precisam ser pesados junto com muitos outros fatores, quando a pessoa que é o sujeito de uma história clínica está sendo descrita. Pacientes relativamente sadios podem chegar, em

seu tratamento, a uma época de crise na qual se pode dizer que nada mais importa a não ser a resolução de exatamente este problema: como pode o sujeito vir a ser capaz de usar o objeto, e ser usado?

V. Ilustração Clínica de *O Uso de um Objeto*

*Apresentado perante a Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque,
em 12 de novembro de 1968*

Refiro-me a um homem casado de 50 anos, uma pessoa erudita tida em alta estima nos círculos acadêmicos. Ele é muito sensível e, fora de dúvida, não muito satisfatório como marido, em nível físico. Há, contudo, uma compreensão muito boa entre ele e a esposa, que partilham de seu lar, de suas famílias e de interesses culturais.

Este homem é extremamente não-agressivo e tende todo o tempo a achar que é sua própria culpa quando as coisas não dão certo. Juntamente com sua falta de agressão tem uma obstinação que proporcionou-lhe uma alternativa, de maneira que, em realidade, detém posição elevada em seu trabalho. Sabe a respeito de sua falta de agressividade, mas gosta de si como é. Não seria bom para ninguém dizer-lhe para ser agressivo. Por outro lado, possui certos sintomas que o incomodam bastante. Os dois principais, inter-relacionados, são:

1. Ele sabe que é capaz de ser altamente criativo em seu próprio campo particular, mas alcançou apenas pouco, certamente muito menos do que é capaz de atingir. Tende a encher seu tempo com trabalhos administrativos, de maneira a não notar o fato doloroso de não estar sendo criativo. É uma pessoa bem-conhecida, contudo, por causa da pequena área em que foi capaz de funcionar bem, em um estágio anterior.

2. Ele é incomodado por compulsões imprevisíveis, que assumem a forma de blasfêmia. É como se tivesse de pensar em algo que é sagrado ou santo ou puro, e cuspir sobre esse algo ou sujá-lo. Ele é muitíssimo uma vítima da fobia do pecado contra o Espírito Santo.

À medida que a análise deste homem se aprofunda cada vez mais, descobre-se que está sofrendo de uma reação a um padrão ambiental no qual a inadequação teve a natureza de um pai fraco e uma mãe forte. O controle da agressão não se achava disponível da parte do pai, a mãe tinha de supri-lo, e ele teve de usar a fúria dela, mas com o resultado de ter cortada a possibilidade de usar a mãe como refúgio. O sintoma disso na atualidade é a falta de sono.

Quando se chega para dar auxílio a este homem, muito facilmente lhe parece que o analista e a psicanálise, através de sua teoria, estão convidando-o a ficar agressivo, coisa que não quer tornar-se. Tem muita tendência a entender mal as interpretações e a reconstruir o que foi dito em termos de um convite no sentido da agressão real. Gradativamente uma mudança está-se dando, por causa da capacidade que o homem tem de sonhar e de, no sonho, chegar mais à agressividade que ao masoquismo.

No dia que escolhi para uma descrição ligeiramente mais detalhada, ele chega se desculpando por não haver feito nenhum trabalho de casa. Isto eu sei que significa

que descobrirá que o fez, mas inconsciente, e que não teve de usar sua pronta defesa de elaboração deliberada ou consciente em sonhos e a integração de sessões analíticas passadas pelo emprego de seu intelecto muito bom.

Há geralmente uma posição logo alcançada que tem a ver com a sua indisposição a tornar-se agressivo, como se fosse isso o que o analista estivesse lhe pedindo para fazer. Fez uma citação de Blake: "Temo a fúria de meu vento". E debateu a maneira pela qual Blake tinha todos esses medos primitivos de agressão contra a figura materna, mas como conseguiu sublimar talvez o próprio vento que tanto temia. Isto conduziu à declaração do paciente de que achava ser melhor abandonar a tentativa de fazer a análise de seus problemas e de como seria melhor se ele, como Blake, pudesse encontrar uma maneira de usar a vida pela qual solucionasse seu problema pessoal até onde se poderia esperar que um homem de sua idade o fizesse. Como poderia ele retornar aos primitivos impulsos e temores da primeira infância? Isto levou a um exame do Deus do homem médio do Século XVII, comparado com o Deus da atualidade.

Seguiu-se uma descrição de Cromwell e seu ambiente social e da natureza muito real do Deus da época de Cromwell. Mencionou ele o caso de um homem que teve um pensamento maligno e um pássaro deixou-lhe cair sobre a cabeça excremento que cheirou tão mal, que o homem morreu dentro de três dias. Para este homem da era de Cromwell, Deus podia ser usado como um substituto para a ausência de um pai furioso, mas na época atual, a idéia de um Deus furioso só podia ser vista como um fenômeno subjetivo e, portanto, não tinha utilidade. Tudo o que podia fazer era retornar ao triste fato de que o pai fora um homem fraco e que a fúria residia na mãe, e, dessa maneira, ele nunca poderia chegar a um acordo com o pai que havia odiado. Sentia-se desesperançado a respeito de tudo isto.

Achávamo-nos agora em uma posição em que já havíamos nos encontrado antes. Ali estava Blake ou um homem semelhante a Blake. Há duas alternativas. Uma é que ele nunca solta gases e, portanto, retém a crença de que seu vento é infinitamente poderoso e destrutivo, ou seja, produtor de um meio ambiente retaliatório. A alternativa, este homem do tipo de Blake não podia atingir. Não podia soltar gases, assumindo os riscos nisso envolvidos e, talvez, descobrindo que o mundo e as pessoas imediatas que o rodeavam não se haviam alterado.

Meu paciente encontra-se nesta posição em que sempre protege a mãe, por ter de preservá-la a fim de poder ter qualquer descanso ou relaxamento. Dessa maneira, não tem conhecimento de que a mãe poderia sobreviver a seu ato impulsivo. Um pai forte capacita a criança a correr o risco, ao se pôr no caminho ou se achar lá para corrigir as coisas ou impedi-las através de sua fúria.

O resultado em meu paciente, como é costumeiro nestes casos, foi que ele teve de adotar o autocontrole dos impulsos em uma etapa muito inicial, antes de estar preparado para fazê-lo com base em uma figura paterna introjetada. Isto significa que tornou-se inibido, e esta inibição teve de ser de toda espontaneidade e impulso, no caso de alguma partícula do impulso poder ser destrutiva. A inibição maciça necessariamente envolveu o seu gesto criativo, de maneira que ele ficou inibido, não-agressivo e não-criativo.

Após isto, estudei a situação e, naturalmente, percebi o trabalho de casa deste homem. Ele trouxera consigo um sonho sem sabê-lo; houvesse-o sabido, isto teria sido deliberado, consciente e intelectual demais. O que fizera, aquela história de Cromwell, fizera-o inteiramente por acaso, quase como se fizesse parte de um debate amistoso que pertence ao início de algumas sessões. Tomado como um sonho, Cromwell fora um homem violento que de fato cortara a cabeça da figura paterna, o Rei. O paciente, que sabe muito sobre história, conseguiu preencher toda a história de Cromwell, mostrando quão bem ela expressava o sonho que não sabia haver trazido consigo, no

qual ele, como Cromwell, havia encontrado a furiosa figura paterna (na realidade sob a forma do Deus do Século XVII e do diretor de sua escola) e havia castrado essa figura em termos da execução do Rei. Na história, o resultado não foi tão bom desde o ponto de vista de Cromwell, embora seja provável que, visto de modo geral, o ato de Cromwell tenha sido benéfico como jogada política e não ter sido um caso claro de motivação destrutiva. No caso de meu paciente, ainda resta a ser elaborado o que é representando pela sobrevivência da monarquia, ou, pelo menos, a sobrevivência do sistema político, talvez melhorado pela agressividade sem freios de Cromwell.

Meu paciente ainda se acha trabalhando na direção do sonho no qual ele próprio achar-se-á na posição de Cromwell, ao invés de nesses canhestros e compulsivos atos de provocação que nunca podem produzir um Deus vingador para um homem do século XX que é agnóstico e que nunca poderão alterar o fato de que o pai, um homem digno de amor, foi de fato o membro fraco do casal paterno.

VI. Comentários sobre Meu Artigo *O Uso de um Objeto*

Datado de 5 de dezembro de 1968

Comentário I

Em minha opinião, a idéia principal incorporada nesse artigo torna necessário escrever de novo uma área importante da teoria psicanalítica. Enunciarei isto da seguinte maneira:

O Dr. Fine referiu-se à teoria libidinal, claramente enunciada em termos de Hartmann, Kris e Loewenstein e dos *Mecanismos de Defesa* de Anna Freud, etc. Continuamos a ensinar a respeito dos estágios libidinais e das zonas erógenas por causa da verdade desta parte de nossa teoria. Ensinaamos também que, na saúde, ocorre uma *fusão* das pulsões libidinais e agressivas (embora aqui possamos entrar em dificuldades, porque, de início, as pulsões agressivas acham-se associadas ao erotismo muscular e não à raiva ou ao ódio).

Minhas pesquisas cuidadosas, utilizando muitos casos longos e uma quantidade verdadeiramente grande de material curto da psiquiatria infantil, mostra-me que a parte da fusão de nossa teoria acha-se não apenas certa, mas também errada. É no lugar em que ela está errada que estou tentando efetuar uma contribuição.

Há uma fase anterior a essa em que faz sentido o conceito de fusão. No desenvolvimento inicial do indivíduo, não é um caso de fusão, porque o que existe na atividade que caracteriza a qualidade de estar vivo do bebê começa como uma unidade. Para chegar rapidamente à idéia que tenho em mente poder-se-ia usar com proveito a idéia do fogo que sai da boca do dragão. Cito Plínio, que (prestando tributo ao fogo) indaga: "Quem pode dizer se, em essência, o fogo é construtivo ou destrutivo?"⁸ Em verdade, a base fisiológica para o que estou me referindo é o primeiro hálito e os hálitos subseqüentes, a exalação.

8. Ver. B. Farrington, *Greek Science* (London, Pelican Books, 1953).

O artigo que apresentei dá à psicanálise oportunidade de repensar este tema. Neste estágio inicial vitalmente importante, a qualidade viva “destrutiva” (fogo-ar ou outra) do indivíduo é simplesmente um sintoma de estar vivo e nada tem a ver com a raiva desse indivíduo com as frustrações que pertencem ao encontro do princípio da realidade.

Como tentei enunciar, a pulsão é destrutiva. A sobrevivência do objeto conduz ao uso do objeto e, isto, à separação de dois fenômenos:

1. fantasia, e
2. colocação real do objeto fora da área das projeções.

Esta premência destrutiva muito inicial, portanto, tem uma função positiva vital (quando, pela sobrevivência do objeto, ela funciona), a saber, a objetivização do objeto (o analista na transferência). Esta tarefa é contornada na personalidade esquizóide ou no caso *borderline*, e, presumivelmente, na enfermidade esquizofrênica (ver Comentário II).

Vejo que tudo isto pode ter alguma falha, mas se puder tornar claro o meu argumento, ele pode, pelo menos, ser debatido.

Na prática, o resultado poderia ser de grande importância, lançando luz até mesmo sobre a característica adolescente na qual o bom não é o que é entregue pela benignidade dos pais, mas sim o que é forçado à existência pela destrutividade adolescente individual. A tarefa dos pais e da sociedade aqui (tal como acontece com mãe e bebê) é de sobrevivência, e isto inclui sobrevivência com a qualidade da não-retaliação, isto é, uma contenção do que o adolescente individual traz sem ficar provocado, ainda que submetido à provocação. Mas isto já é uma aplicação de meu novo (acredito eu) princípio da capacidade de usar um objeto a que o sujeito chega mediante as experiências que envolvem a sobrevivência do objeto.

Comentário II

Dou-me conta de que é esta idéia de um primeiro impulso destrutivo a que é difícil de apreender. É isto que precisa de atenção e debate. Para ajudar, desejo apontar que estou me referindo a coisas tais como a avidez [*eagerness*] e preciso incluir coisas como a expiração, a salivação, a queimadura, e certas experiências sensoriais tais como a extrema sensibilidade sensorial que pertence aos minutos que se seguem imediatamente ao nascimento, bem como características especiais de cheiro, fenômenos que são intoleravelmente, ou quase intoleravelmente, reais para o bebê, mesmo em condições suficientemente boas de sustentação e manejo. Aqui, tem-se de permitir que a obscuridade tenha um valor superior ao do falso esclarecimento.

Parece provável que Rilke, pela utilização de *Raum* e *Welt*, apresente esta mesma idéia em termos ambientais. *Raum* [espaço] é um espaço infinito em que o indivíduo pode operar sem passar pela experiência arriscada de destruição e sobrevivência do objeto; *Welt* [mundo], em contraste, é o mundo na medida em que o objeto, pela sobrevivência, tornou-se objetivizado pelo indivíduo, e pode ser usado.

VII. O Uso de um Objeto no Contexto de *Moisés e o Monoteísmo*

Datado de 16 de janeiro de 1969

Em *Análise Terminável e Interminável*, uma obra-prima tardia de enunciado claro e indogmático, Freud parece-me estar lutando por usar o que ele sabe ser verdade, por causa de suas experiências analíticas, para ocultar o que não sabe. Quase escrevi o que ele ainda não sabe, uma vez que é-nos difícil acreditar que tenha deixado a nós prosseguir as pesquisas que a sua invenção da psicanálise torna possíveis e, mesmo assim, não possa participar quando damos um passo à frente.

A primeira parte de *Moisés e o Monoteísmo* é um belo exemplo de uma idéia apresentada com força, clareza e convicção, mas sem fazer propaganda, apesar disso, e, em verdade, com humildade. Na última parte, Freud pode ser visto como reafirmando a crença na repressão e (como pareceria a mim) ultrapassando-se em sua formulação do monoteísmo como importante por causa da verdade universal do pai amado e da repressão disto em sua forma original e rematada (id). Mas o leitor sabe que o argumento não suporta um exame atento. Não é que Freud esteja errado a respeito do pai e do laço libidinal que se torna reprimido, mas tem-se de notar que uma certa proporção de pessoas no mundo não chegam ao complexo edipiano. Elas nunca avançam tão longe em seu desenvolvimento emocional e portanto, para elas, a repressão da figura paterna libidinizada tem apenas pouca relevância. Se se olhar para pessoas religiosas, certamente não é verdade dizer que os princípios monoteístas só pertencem àqueles que atingiram o complexo edipiano. Uma grande parte da religião acha-se ligada com a quase-psicose e com os problemas pessoais que se originam da grande área da vida do bebê que é importante antes que se chegue a um relacionamento de três corpos, como o que se dá entre pessoas totais⁹.

Freud labutava sob condições desfavoráveis. Ele só podia utilizar a psicanálise até onde ela havia chegado na época em que estava escrevendo. Ninguém o culparia por isto, especialmente porque Freud estava sempre preparado para deixar um poeta, um filósofo ou a sua própria intuição descreverem o caminho para fenômenos que não haviam sido abrangidos pela metapsicologia da época.

Ele chegou a uma expressão de suas próprias insatisfações perto do final de *Análise Terminável e Interminável*, enquanto, de maneira generosa, expressava satisfação com os textos de Empédocles. Este homem notável (nascido por volta de 485 a.C.), de um período notável do nascimento e crescimento da ciência na Grécia, formulara um estado de *amor-conflito* tanto para o homem quanto para o universo, e isto se aproxima tanto quanto se pode chegar da formulação freudiana de instintos de vida e de morte. Freud ficou satisfeito.

É meu intuito apresentar a idéia de que Empédocles, o grego, pode ter isso um passo à frente de Freud, pelo menos em um aspecto importante. (Para advertir o leitor, devo dizer que nunca fui apaixonado pelo instinto de morte e ficaria feliz em

9. Melanie Klein tentou contornar esta dificuldade utilizando toda a terminologia do complexo edipiano na descrição de lutas internas pelo poder, como entre elementos que não adquiriram forma humana. Isto ajudou, mas não chegou, como temos de fazer quando consideramos estas questões, a uma declaração de que Freud estava trabalhando sob condições adversas. — D. W. W.

poder aliviar Freud do ônus de carregá-lo para sempre em suas costas de Atlas. Para começar, o desenvolvimento da teoria a partir de um enunciado do fato de que a matéria orgânica tende a retornar ao inorgânico possui peso muito pequeno em termos de lógica. Não há um relacionamento claro entre os dois conjuntos de idéias. Além disso, a biologia nunca ficou feliz com esta parte da metapsicologia, embora, de modo geral, haja lugar para a mutualidade entre ela e a psicanálise ao longo de toda a linha, até chegar ao ponto do instinto de morte.)

É sempre possível que a formulação do instinto de morte tenha sido um dos lugares em que Freud se aproximou de um enunciado abrangente, mas não pôde fazê-lo porque, embora soubesse tudo o que sabemos a respeito da psicologia humana, remontando à repressão do id em relação a objetos psicoenergizados, ele não sabia o que os casos fronteirços e os esquizofrênicos iriam nos ensinar nas três décadas subseqüentes ao seu falecimento. A psicanálise iria aprender que muita coisa acontece nos bebês que se acha associada com a necessidade, e separada do desejo e dos representantes (pré-genitais) do id a clamarem por satisfação.

Em outras palavras, Freud, no arcabouço de seu próprio e bem-disciplinado funcionamento mental, não sabia que temos hoje de lidar com um problema como o seguinte: o que há na presença real do pai e do papel que ele desempenha na experiência do relacionamento entre ele e a criança e entre a criança e ele? O que isto causa ao bebê? Pois há uma diferença, que depende de o pai achar-se lá ou não, se é capaz de estabelecer um relacionamento ou não, se é sã ou insano, se tem a personalidade livre ou rígida.

Se o pai morre isto é importante, bem como quando ele falece, exatamente, na vida do bebê, e há muita coisa também a ser levada em conta que tem a ver com a *imago* do pai na realidade interna da mãe e com o destino desta imago aí. Encontramos hoje todas estas questões aparecendo para revivescência e correção no relacionamento transferencial, questões que não são tanto de interpretar, mas de experienciar.

Ora, uma coisa em tudo isto tem importância muito especial. Ela tem a ver com o ego imaturo, tornado forte pela adaptação suficientemente boa da mãe às *necessidades* do bebê. (Não se deve deixar que isto se perca dentro do conceito da satisfação, pela mãe, das pulsões instintuais do bebê.)

À medida que o bebê se desloca do fortalecimento do ego devido a ser ele reforçado pelo ego da mãe para a posse de uma identidade sua, própria, isto é, à medida que a tendência herdada à integração faz o bebê avançar no meio ambiente suficientemente bom ou expectável médio, a terceira pessoa desempenha ou parece desempenhar um grande papel. O pai pode ou não ter sido um substituto materno, mas em alguma ocasião ele começa a ser sentido como se achando lá em um papel diferente, e é aqui que sugiro que o bebê tem probabilidade de fazer uso do pai como um diagrama para a sua própria integração, quando apenas se torna às vezes uma unidade. Se o pai não se encontra lá, o bebê tem de fazer o mesmo desenvolvimento, mas de modo mais árduo, ou utilizando algum outro relacionamento que seja bastante estável com uma pessoa total.

Desta maneira, pode-se ver que o pai pode ser o primeiro vislumbre que a criança tem da integração e da totalidade pessoal. É fácil passar desta interação entre introjeção e projeção para o importante conceito, na história do mundo, de um monoteísmo, não de um deus único para mim e outro deus único para você¹⁰.

É fácil fazer a presunção de que, como a mãe começa como um objeto parcial ou uma conglomeração de objetos parciais, o pai vem a ser apreendido pelo ego da mesma maneira. Mas eu sugiro que, num caso favorável, o pai começa como totalida-

10. Ver *Moisés e o Monoteísmo*, *Standard Edition*, vol. 22, pág. 128.

de (isto é, como pai, não como substituto materno) e mais tarde se torna dotado de um importante objeto parcial, que ele começa como algo integral na organização do ego e na conceptualização mental do bebê.

Não se poderia dizer que, *poeticamente*, Freud estava pronto para esta idéia, não que o monoteísmo tenha a sua raiz na idéia reprimida do pai, mas que as duas idéias de ter um pai e do monoteísmo representaram as primeiras tentativas do mundo para reconhecer a individualidade do homem, da mulher, de cada indivíduo? (Lembrem-se que os gregos tinham escravos, o que diminui a nossa consideração pelos impressionantes *insights* de seus grandes pensadores, especialmente dos séculos que rodearam a data de nascimento de Empédocles. A ciência teve de esperar alguns séculos antes de recomençar — com base no direito universal — a ser um indivíduo livre ou autônomo e integrado.)¹¹

Posso apoiar minha tese citando Freud, que escreveu que, de acordo com Empédocles, o poder do amor *esforça-se por aglomerar as partículas primeiras dos elementos* (do universo e do homem), *dos quatro elementos em uma unidade única*, enquanto que o poder do conflito “busca desfazer, anular, etc., etc.”. Temos aqui então a idéia da atividade do ego de *aglomerar*, que não é relacionar-se com objetos. Dentro em pouco tentarei levar meu argumento mais além, por uma contribuição que sinto que precisa ser feita com referência a este dualismo, *philia* (amor) e *neikos* (conflito, disputa)¹². Acredito que um passo à frente possa agora ser dado.

Antes de descrever este novo detalhe, quero me referir a uma nota de rodapé de Freud. Sou um tanto viciado em suas notas de rodapé e citações, que ele talvez permita ir mais além do que ele podia ir em termos da teoria prevalecente na época de seus textos.

Refiro-me a: “Breasted (1906) o chama (Amenófis) de *o primeiro indivíduo na história humana*”¹³. Aqui, para mim, Freud está enunciando a tese que estou-me esforçando por apresentar à minha própria e trabalhosa maneira. Sente-se que não me era possível levantar isto no texto, por não poder lidar com ele em termos de representação, mecanismos de defesa e interação de id, ego e superego. Sinto que Freud daria as boas-vindas a um trabalho novo que fizesse sentido do comentário de Breasted em termos de algo universal no desenvolvimento emocional do indivíduo, qual seja, a tendência integradora que pode conduzi-lo a um *status* de unidade.

Acho-me agora livre para efetuar a contribuição que, sinto, tem possibilidade de ir mais à frente da posição do Freud. Isto que quero apresentar é uma culminação de uma tendência em meu pensar, e posso hoje ver evidências dessa tendência em meus artigos de um decênio atrás. (Ver, por exemplo, “Raízes da Agressão”, em *A Criança, A Família e o Mundo Externo*. É o único capítulo novo no livro, e ele também implicou o desajeitado título de meu *O Ambiente e os Processos de Maturação*.)

Recentemente tentei dar vida às minhas idéias em um trabalho lido perante a Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque (12 de novembro de 1968), mas pelos trabalhos dos que o debateram, soube que não havia de maneira alguma me feito claro, de maneira que a idéia, tal como apresentada lá e então, era inaceitável na ocasião. Revisei esse trabalho¹⁴. Dei-lhe o nome de “O Uso de um Objeto” e quis nele enunciar que, no desenvolvimento emocional de qualquer bebê, existe uma época de *dependência*, em que o *comportamento do meio ambiente* faz parte integrante do desenvolvimento da criança, e que isto não pode ser omitido, isto é, não existe enunciado do desenvolvimento de um bebê, dependente do apoio do ego de uma figura materna ou paterna,

11. Farrington, *Greed Science*.

12. Ver “Análise Terminável e Interminável”, *Standard Edition*, vol. 23.

13. *Moisés e o Monoteísmo*, p. 21.

14. Ver Seção I deste Capítulo. — [N. dos Organizadores]

que deixe fora de consideração os fatores ambientais. Isto é simplesmente dizer que é *verdade* que, no começo, o bebê não alcançou ele próprio uma percepção, reconhecimento e repúdio do NÃO-EU. Isto é algo em que tenho de acreditar, por causa de meu trabalho clínico.

Para ilustrar o que queria dizer, examinei o estágio inicial das pulsões no bebê individual. Tracei uma distinção nítida entre o destino (em termos de padrão de personalidade) de um bebê cujos primeiros esforços foram aceitos e o de um bebê a cujos primeiros esforços se reagiu. É um enunciado remanescente da posição paranóide de Klein, mas com a diferença de ser fornecido em termos do meio ambiente a correr *pari passu* com as pulsões individuais de vida. A retaliação assume o lugar dos medos de talião.

É necessário aqui repensar algo que viemos a aceitar (a aceitar porque, na análise dos casos "analísáveis", é tão verdadeiro), qual seja, que um dos fenômenos integradores no desenvolvimento é a fusão do que aqui permitir-me-ei chamar de instintos de vida e de morte (amor e conflito: Empédocles). O ponto crucial de meu argumento é que a primeira pulsão é; ela própria, *uma só coisa*, algo que chamo de *destruição*, mas poderia ter chamado de pulsão combinada amor-conflito. Esta unidade é primária. É isto o que surge no bebê pelo processo maturacional natural.

O destino desta unidade de pulsão não pode ser enunciado sem referência ao meio ambiente. A pulsão é potencialmente "destrutiva", mas ser ela destrutiva ou não depende de como é o objeto; o objeto *sobrevive*, isto é, mantém o seu caráter, ou *reage*? No primeiro caso, então não há destruição, ou não muita, pelo menos, e há um momento seguinte em que o bebê pode tornar-se e gradualmente se torna cômico de um objeto psicoenergizado, mais a *fantasia* de ter destruído, machucado, danificado ou provocado o objeto. O bebê, neste extremo de provisão ambiental, continua em um padrão de desenvolvimento da agressividade pessoal que proporciona o pano de fundo de uma fantasia contínua (inconsciente) de destruição. Aqui podemos utilizar o conceito de reparação kleiniano, que vincula o brinquedo e o trabalho construtivos com este *pano de fundo de fantasia* (inconsciente) de destruição ou provocação (talvez a palavra certa ainda não tenha sido encontrada). Mas a destruição de um objeto que sobrevive, que não reagiu nem desapareceu, conduz ao uso.

No outro extremo, o bebê que encontra um padrão de reação ou retaliação ambiental progride de maneira inteiramente diferente. Este bebê acha que a reação partida do meio ambiente é a realidade do que deveria ser o seu próprio impulso provocativo (ou agressivo, ou destrutivo). Este tipo de bebê nunca pode experienciar, possuir ou ser movido por esta raiz pessoal para a agressão ou a fantasia destrutiva, e, portanto, nunca pode convertê-la na destruição de *fantasia* inconsciente do objeto libidinizado.

Ver-se-á que estou tentando reescrever uma parte limitada de nossa teoria.

Esta premência
provocativa
destrutiva
agressiva
invejosa (Klein)

não é um fenômeno do princípio do prazer-sofrimento. *Nada tem a ver com a raiva pelas inevitáveis frustrações associadas ao princípio da realidade*. Ela precede este conjunto de fenômenos que são verdadeiros quanto aos neuróticos, mas não quanto aos psicóticos¹⁵.

15. Aqui, volto-me para Bettelheim em busca de apoio. Acho-o difícil de ler porque ele diz tudo e não há nada a ser dito que se possa ter certeza de que não foi dito por ele. Mas tem-se de lê-lo porque ele pode estar exatamente certo, ou mais aproximadamente certo que outros autores.

Para fazer progresso no sentido de uma teoria operável da psicose, os analistas devem abandonar toda a idéia da esquizofrenia e da paranóia, tal como vistas em termos de regressão quanto ao complexo edipiano. A etiologia destes transtornos levamos *inevitavelmente* a estágios que precedem o relacionamento de três corpos. O corolário estranho é que existe, na raiz da psicose, um *fator externo*¹⁶. É difícil para os psicanalistas admitir isto, após todo o trabalho que tiveram chamando a atenção para os fatores internos, ao examinarem a etiologia da psicose.

... Isto se aplica especialmente a seus capítulos iniciais de *The Empty Fortress* (New York: Free Press, 1967; London: Collier-Macmillan Ltd., 1967). — D. W. W.

16. Ver Winnicott, "Psicoses e Cuidado Infantil" (1952), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London, Hogart Press, 1975).

esforço no sentido da recuperação está sendo feito para lidar com o ódio de outra pessoa, principalmente o da mãe. Naturalmente, é necessário que o analista se ache na posição da mãe na transferência, quando estas questões ficarem maduras para interpretação. O analista descobre que o paciente genuinamente quer ficar bem só atua como tranquilização durante um tempo limitado e numa área limitada. O paciente acaba por saber, delirantemente, que o analista deseja empurrá-lo de volta para o desenvolvimento emocional, ou para dentro do estado de não-nascido ou, por uma maneira ou outra, destruir os pontos em crescimento do paciente.

Estas fases de uma análise são difíceis e o paciente precisa ter grande confiança no lado mecânico do procedimento analítico para chegar ao estado delirante no qual o analista é hostil. Em casos favoráveis, ele pode usar outras figuras do meio ambiente. Uma criança pode chegar à análise queixando-se de um professor ou de uma escola que a perseguem e pode-se mesmo saber, através de indagações, que o professor é de fato ordinariamente permissivo. O paciente pode desta maneira elaborar um senso tremendo de perseguição e, assim, comunicar-se com o analista sem ser louco demais. A mesma coisa, feita em termos diretos do delírio de que o analista é seu antagonista, torna-se intolerável para o paciente, por causa de sua loucura.

Pode-se imaginar que muitos pacientes façam o melhor que podem para provocar o analista a odiá-los, de maneira que possam chegar a esse estado, com o delírio cuidadosamente envolto pela observação correta, e o paciente utilizará os erros técnicos do analista e os explorará em grande escala, a fim de chegar a ser perseguido sem perder o senso de ser são. Em nosso trabalho, podem ser encontrados todos os graus possíveis disto, nos quais o paciente precisa chegar ao que é, em sua forma mais simples, o ódio da mãe. O que se torna muito claro é a diferença muito grande que existe entre ser o ódio da mãe ou o ódio reprimido e inconsciente da mãe o que se acha em consideração. Em outras palavras, as crianças parecem ser capazes de lidar com o fato de serem odiadas e isto, naturalmente, é simplesmente uma maneira de dizer que podem enfrentar e fazer uso da ambivalência que a mãe sente e demonstra. O que elas não podem jamais usar satisfatoriamente em seu desenvolvimento emocional é o ódio reprimido e inconsciente da mãe, que apenas encontram, em suas experiências de vida, sob a forma de formação reativa. No momento em que a mãe odeia, ela demonstra uma ternura especial e não existe maneira por que uma criança possa lidar com este fenômeno.

36

A Experiência Mãe-Bebê de Mutualidade

Redigido em 1969¹

Embora seja geralmente conhecido existir uma sutileza quase infinita no manejo que a mãe faz de seu bebê, a teoria psicanalítica levou longo tempo para chegar a esta área da experiência viva. Não é difícil perceber algumas das razões para o atraso. A psicanálise, em seus primórdios, tinha de enfatizar a força dos sentimentos e dos sentimentos conflitantes e de explorar as defesas erguidas contra eles. Em termos de infância, ela ocupou-se por diversas décadas com o complexo edipiano e todas as complicações que surgem dos sentimentos de meninos e meninas que se tornaram pessoas totais, relacionadas com outras pessoas totais.

A psicanálise, gradativamente, começou a invadir as experiências de crianças mais jovens, explorou os conflitos existentes dentro da psique e desenvolveu os conceitos abrangidos por palavras e humores, bem como as perseguições oriundas de dentro e de fora. O psicanalista esteve sempre lutando a batalha em favor do indivíduo, contra aqueles que atribuem os problemas à influência ambiental.

Gradualmente, o inevitável aconteceu e os psicanalistas, conduzindo consigo sua crença exclusiva na importância dos detalhes, tiveram de começar a examinar a dependência, isto é, os estágios iniciais do desenvolvimento da criança humana, quando a dependência é tão grande que o comportamento daqueles que representam o meio ambiente não podia mais ser ignorado.

Achamo-nos agora exatamente no estudo dessas influências mútuas muito iniciais. Temos de esperar encontrar resistências ao trabalho que fazemos, desta vez não por causa do funcionamento da repressão e da ansiedade naqueles que confrontam nosso trabalho, mas uma resistência que tem a ver com o sentimento de que uma área sagrada está sendo invadida. É como se uma obra de arte estivesse sendo submetida a um processo analítico. Pode-se estar certo de que a capacidade de apreciar plenamente essa obra não será destruída pelos refletores que estão sendo apontados sobre ela? Poderia-se em verdade argumentar que estes fenômenos muito iniciais deveriam ser deixados em paz e eu, que me descobri a fazer um estudo deles, não poderia senão insistir que o que pensamos conhecer a respeito dessas intimidades não constitui

1. Publicado em Anthony e A. Churchill, (1970).

material útil de leitura, seja para artistas, seja para jovens mães. O tipo de coisa que pode ser debatida quando examinamos estes fenômenos iniciais não pode ser ensinada. É singular, entretanto, que certas pessoas, até mesmo pais e mães, gostem de ler a respeito destas coisas após haverem passado pelas experiências.

De nossa parte, como psiquiatras, temos outra razão pela qual devemos ir em frente com nosso trabalho de exame das sutilezas do relacionamento genitor-bebê. Temos de levar em consideração que esta é uma área de pesquisa que pode lançar luz sobre o grupo de transtornos que são rotulados de psicóticos ou esquizóides, ou seja, que não são transtornos afetivos ou aqueles denominados de psiconeuróticos. Na realidade, se em nosso trabalho psicanalítico ou em qualquer outro tipo de psicoterapia encontramos temporariamente envolvidos com processos esquizóides em nossos pacientes, sabemos que estaremos lidando, em nossos consultórios, com os mesmos fenômenos que caracterizam as experiências de mães e bebês. Seremos apanhados nas necessidades imensas do bebê dependente e, na contratransferência, com os maciços processos de reação que nos mostram, até certo ponto, o que acontece com os pais, quanto têm um filho. Como psiquiatras, portanto, não nos resta alternativa senão ir em frente e tentar descrever algo do que encontramos, tomando o cuidado de não apresentar nossas opiniões sob a forma de conselhos a mães e pais e a pessoas que têm crianças a seu cargo, mas de manter o que dizemos em reserva, para o uso de colegas que devem também encontrar-se envolvidos, de tempos em tempos, com pacientes que desenvolvem uma dependência que é quase absoluta.

É um alívio que a psicanálise tenha atravessado a fase, que durou meio século, na qual, quando os analistas se referiam a bebês, só podiam falar em termos das pulsões eróticas e agressivas do bebê. Era tudo questão de instinto pré-genital, de erotismo oral e anal e reações à frustração, com alguns acréscimos bastante bravios, feitos em termos de comportamento natural agressivo e idéias destrutivas, *agressivité*. O trabalho deste tipo teve o seu valor e continua a tê-lo, mas hoje é necessário que os analistas que se referem à natureza do bebê vejam o que mais se acha lá para ser visto. Para o analista ortodoxo, se ele examinar melhor, há alguns choques à sua espera.

O Objeto Subjetivo

A fim de estudar a maneira pela qual o bebê humano chega à capacidade de objetivar, é necessário aceitar que, a princípio, não existe tal capacidade. Para conceder isto, o teórico precisa ser capaz de abandonar alguns princípios dos quais esteve corretamente orgulhoso em todos os anos que se passaram desde que Freud forneceu-nos o conceito do complexo edipiano, a idéia da sexualidade infantil e a técnica psicanalítica de investigação, que é a mesma que a técnica psicanalítica de terapia.

Nesta área nova, a idéia do indivíduo antes que a do meio ambiente (uma contribuição psicanalítica importante) precisa ser modificada ou até mesmo abandonada. Quando se diz que o bebê é dependente, e, de começo, absolutamente dependente, e isto é realmente o que se quer dizer, decorre então que a maneira pela qual o meio ambiente se apresenta tem importância, por ser uma parte do bebê.

Um bebê não é o que se poderia postular pela avaliação do potencial desse bebê. Ele é um fenômeno complexo que inclui o seu potencial e *mais* o seu meio ambiente. Para entender esta idéia podemos olhar para uma criança de dois anos e dizer: esta criança não tem sido a mesma desde que o novo bebê nasceu. Em muitos casos, podemos diagnosticar padrões de enfermidade, e estes padrões (mostrados como rigidez das organizações de defesa) exigem tratamento. Não se deve permitir que a existência dos padrões de enfermidade obscureça a realidade de que a criança em questão é uma criança *com um irmão ou uma irmã mais novos*. Com o mesmo potencial,

a criança seria diferente se fosse o filho mais novo ou filho único, ou se um bebê houvesse nascido e, depois, morrido. Ninguém objetaria a esta idéia em termos de uma criança de dois anos de idade, o que, naturalmente, não altera o fato de ser possível fornecer uma psicoterapia eficaz com respeito à psicopatologia da criança. A psicopatologia, contudo, é algo diferente da saúde e do efeito, sobre a criança, dos inumeráveis aspectos ambientais que dizem respeito à criança que não se acha longe da dependência absoluta e percorreu apenas um pedacinho do caminho que leva à independência.

Para trazer de volta o argumento aos estágios muito iniciais, a importância do meio ambiente para o bebê — quando há uma dependência quase absoluta — é tal que *não podemos descrever o bebê sem descrever o meio ambiente*.

O estágio de dependência absoluta ou quase absoluta tem a ver com o estado, no começo, do bebê que ainda não separou um NÃO-EU do que é EU, do bebê que ainda não se acha aparelhado para desempenhar esta tarefa. Em outras palavras, o objeto é um objeto subjetivo, não objetivamente percebido. Mesmo que seja repudiado, posto longe, o objeto ainda é um aspecto do bebê.

Como surge o estágio seguinte? Seu desenvolvimento e estabelecimento não são devidos à operação das tendências herdadas do bebê (no sentido da integração, da busca objetual, do conluio psicossomático, etc.). Em qualquer caso, ele pode nunca acontecer, apesar de tendências herdadas perfeitamente boas no bebê. Este desenvolvimento se dá *por causa das experiências que o bebê tem do comportamento adaptativo da mãe* (ou substituto materno). O comportamento adaptativo da mãe torna possível ao bebê encontrar fora do *self* aquilo que é necessário e esperado. Através da *experiência* da maternagem suficientemente boa, o bebê passa para a percepção objetiva, havendo herdado a tendência a fazer isso e tendo-lhe sido dados a aparelhagem perceptual e a oportunidade.

A fim de compreender o papel desempenhado pela mãe é necessário ter um conceito tal como o que descrevi em “Preocupação Materna Primária”². Tentei mostrar que podemos esperar uma maternagem suficientemente boa das mães de todo o mundo, e das eras passadas, por causa de algo que acontece às mulheres durante a gravidez, algo que dura algumas semanas após o nascimento do bebê, a menos que um distúrbio psiquiátrico na mãe impeça que esta mudança temporária em sua natureza ocorra.

Além disso, é necessário poder pensar em um bebê como começando a ter uma certa capacidade de objetividade, mas ainda assim, sendo de modo geral incapaz de objetivar, com um movimento para frente e para trás nesta área de desenvolvimento.

Comunicação

A fim de esclarecer nossos conceitos, podemos com utilidade colocar-nos a pensar em termos de comunicação. Para explicar como isto pode ajudar, quero dar um exemplo.

Desde o nascimento pode-se ver que um bebê ingere alimento. Digamos que o bebê descobre o seio e suga e ingere uma quantidade suficiente para satisfação do instinto e para o crescimento. Isto pode acontecer quer o bebê tenha um cérebro que um dia se desenvolverá como bom, quer o cérebro do bebê seja na realidade deficiente ou danificado. Aquilo que precisamos saber é a comunicação que acompanha ou não o processo de alimentação. É difícil ficar seguro a respeito de tais assuntos através do

2. Em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York, Basic Books, 1975; London, Hogarth, 1975).

instrumento da observação de bebês, embora realmente pareça que alguns bebês observam o rosto da mãe de maneira significativa mesmo nas primeiras semanas. Com doze semanas, contudo, os bebês já podem fornecer-nos informações com as quais podemos fazer mais que adivinhar que a comunicação é um fato.

Ilustração 1. Embora os bebês normais variem consideravelmente em seu ritmo de desenvolvimento (especialmente quando medido através de fenômenos observáveis), pode-se dizer que com doze semanas eles são capazes de brincar assim: instalado para mamar, o bebê olha para o rosto da mãe e a sua mão se levanta, de maneira que, de brincado, ele está amamentando a mãe por meio de um dedo que coloca na sua boca.

Pode ser que a mãe tenha desempenhado um papel no estabelecimento deste detalhe de brinquedo, mas mesmo que seja verdade, isso não invalida a conclusão que tirei do fato de este tipo de brincar poder acontecer³.

Tiro disto a conclusão de que, embora todos os bebês ingiram comida, não existe uma comunicação entre o bebê e a mãe, exceto na medida em que se desenvolve uma situação de alimentação mútua. O bebê dá de comer e a experiência dele inclui a idéia de que a mãe sabe o que é ser alimentada.

Se isto acontece para todos verem com 12 semanas de idade, então, de uma maneira ou outra, pode (mas não precisa) ser verdadeiro, de alguma maneira obscura, em uma data anterior.

Desta maneira, assistimos concretamente a uma *mutualidade* que é o começo de uma comunicação entre duas pessoas; isto (no bebê) é uma conquista desenvolvimental, uma conquista que depende dos seus processos herdados que conduzem para o crescimento emocional e, de modo semelhante, depende da mãe e de sua atitude e capacidade de tornar real aquilo que o bebê está pronto para alcançar, descobrir, criar⁴.

Os bebês se alimentam, e isto pode significar muito para a mãe, e a ingestão de comida concede ao bebê gratificação em termos de satisfações pulsionais. Uma outra coisa, contudo, é a comunicação entre o bebê e a mãe, algo que é uma questão de experiência e que depende da mutualidade que resulta das identificações cruzadas.

Melanie Klein fez plena justiça ao tema das identificações projetivas e introjetivas, e é com base em seu desenvolvimento das idéias deste tipo de Freud que podemos construir esta parte da teoria em que a comunicação tem uma importância maior do que é costumeiramente chamado de "relacionamento objetal"⁵.

Ao fornecer esta ilustração, permaneci próximo do arcabouço familiar dos enunciados psicanalíticos referentes ao relacionamento objetal, pois quero manter abertas as pontes que levam da teoria mais antiga para a mais nova. Apesar disso, estou obviamente perto da declaração que Fairbairn fez em 1944, de que a teoria psicanalítica estava enfatizando a satisfação pulsional às expensas do que ele chamou de "busca objetal". E Fairbairn estava trabalhando, como me acho aqui, com as maneiras pelas quais a teoria psicanalítica precisava ser desenvolvida ou modificada, se é que o analista queria ter esperanças de tornar-se capaz de lidar com fenômenos esquizóides no tratamento dos pacientes⁶.

3. Ver "Começando a Conhecer o Seu Bebê" (1944), em *The Child, the Family and the Outside World*.

4. Isto tem relacionamento direto com a expressão "realização simbólica", de Sechehaye, que significa capacitar uma coisa real a tornar-se um símbolo significativo de mutualidade em um *setting* especializado. Ver M. A. Sechehaye, *Symbolic Realization* (New York: International Universities Press, 1951). — D. W. W.

5. Melanie Klein, *The Psycho-Analytic of Children* (London: Hogarth Press, 1954).

6. Ver W. R. D. Fairbairn, *Psycho-Analytic Studies of the Personality* (London, Tavistock, 1952), pág. 88: "uma vez que são apenas estruturas do ego que podem buscar relacionamentos com objetos" (o grifo é meu). — D. W. W.

Nesta altura, é necessário interpolar uma referência ao fato óbvio de que a mãe e o bebê chegam ao ponto da mutualidade por maneiras diferentes. A mãe foi um bebê que foi cuidado; ela também brincou de bebês e de mães; experienciou talvez a chegada de irmãos e irmãs, cuidou de bebês mais moços em sua própria família ou em outras famílias, e talvez tenha aprendido ou lido a respeito de cuidado infantil e pode ter opiniões firmes, suas próprias, sobre o que está certo e errado no tratamento de bebês.

O bebê, por outro lado, está sendo um bebê pela primeira vez, nunca foi mãe e, certamente, jamais recebeu quaisquer instruções. O único passaporte com que o bebê chega às barreiras alfandegárias é a soma das características herdadas e tendências inatas no sentido do crescimento e do desenvolvimento.

Conseqüentemente, enquanto que a mãe pode identificar-se com o bebê, até mesmo com um bebê não-nascido ou no processo de nascer, e de maneira altamente sofisticada, o bebê traz para a situação apenas uma capacidade em desenvolvimento de chegar a identificações cruzadas na *experiência de mutualidade* que é tornada um fato. Esta mutualidade pertence à capacidade que a mãe tem de adaptar-se às necessidades do bebê⁷.

Mutualidade Não-Relacionada a Pulsões

É possível ingressar agora nas águas profundas da mutualidade que não se relacionam diretamente com as pulsões ou com a tensão instintual. Encaminhado-nos para isto, um outro exemplo pode ser fornecido.

Tal como muita coisa do que sabemos a respeito destas experiências muito iniciais da primeira infância, este exemplo deriva do trabalho que tem de ser feito na análise de crianças mais velhas ou adultos, quando o paciente se acha em uma fase, longa ou curta, na qual a regressão à dependência é a característica principal da transferência. O trabalho deste tipo sempre tem dois aspectos, o primeiro deles sendo a descoberta positiva, na transferência, de tipos iniciais de experiência que foram deixados passar ou foram distorcidos no próprio passado histórico do paciente, no relacionamento muito inicial com a mãe; o segundo é o uso que o paciente faz das falhas do terapeuta em técnica. Essas falhas produzem raiva, e isto tem valor, porque a raiva traz o passado para o presente. Por ocasião da falha inicial (ou relativa), a organização do ego do bebê não se achava suficientemente organizada para uma questão tão complexa quanto a raiva a respeito de um assunto específico.

Os analistas com uma rígida moralidade analítica que não permite o contato, perdem muita coisa do que está agora sendo descrito. Uma coisa que nunca souberam, por exemplo, é que o analista dá um pequeno repuxão sempre que adormece por um momento ou mesmo deixa a mente vaguear (como bem pode acontecer) para alguma fantasia sua própria. Este repuxão é o equivalente de um fracasso de sustentar, em termos de mãe e bebê. A mente deixou o paciente cair. (Estes casos nos provocam tensão. Há longos períodos de sossego, às vezes em uma temperatura ambiente mais alta do que aquela em que o analista gostaria de trabalhar.)

Ilustração 2.8 Um menino de seis anos de idade foi capaz de dar-me informações precisas, em uma consulta terapêutica de uma só sessão, a respeito da maneira por que sua mãe adormeceu enquanto o segurava, quando ele tinha 14 meses de idade.

7. A palavra "necessidade" tem importância aqui tal como "pulsão" tem na área da satisfação do instinto. A palavra "desejo" está fora de lugar, por pertencer a uma sofisticação que não se pode presumir no estágio de imaturidade que se acha em consideração. — D. W. W.
8. Descrita por extenso como Caso 4, "Bob", em *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry* (London: Hogarth Press; New York: Basic Books, 1971); também no *International Journal of*

Isto foi o mais perto que ele pôde chegar de fornecer-me a informação de que a mãe tinha uma moléstia depressiva nessa data, que começou com ela desenvolvendo uma tendência a adormecer.

Na linguagem deste artigo, o menino experienciou uma série de fracassos de comunicação nos pontos em que a mãe se tornou retraída.

Minha compreensão da comunicação da criança nesta sessão única capacitou o menino a avançar em seu desenvolvimento. Um ano mais tarde, quando o vi, era um menino normal que trouxe seu irmão mais moço para ver-me, e isto fora sua própria idéia. Ele se lembrava do trabalho que havíamos feito juntos.

Ilustração 3. Este exemplo é tirado da análise de uma mulher de 40 anos (casada, dois filhos) que fracassou em alcançar recuperação completa em uma análise de seis anos com uma colega minha. Concordei com esta em ver o que a análise com um homem poderia produzir, de maneira que iniciamos um segundo tratamento.

O detalhe que escolhi para descrição tem a ver com a necessidade absoluta que esta paciente tinha, de tempos em tempos, de ficar em contato comigo. (Temera dar este passo com uma analista mulher, por causa das implicações homossexuais.)

Uma variedade de intimidades foi tentada, principalmente aquelas que dizem respeito à alimentação e ao manejo de bebês. Houve episódios violentos, e acabou por ela e eu ficarmos juntos, eu com a cabeça dela em minhas mãos.

Sem uma ação deliberada por parte de qualquer de nós, desenvolveu-se um ritmo de embalo. O ritmo era bastante rápido, cerca de 70 por minuto (cf. batimentos cardíacos) e tive algum trabalho para adaptar-me a tal ritmo. Sem embargo, lá nos achávamos, com a *mutualidade* expressa em termos de um leve, mas persistente movimento de embalo. Sem palavras, estávamos nos comunicando um com o outro, e isto estava se dando em um nível de desenvolvimento que não exigia que a paciente tivesse maturidade mais avançada daquela que se descobrira possuindo na regressão à dependência da fase da sua análise.

Esta experiência, amiúde repetida, foi decisiva para a terapia, e a violência que havia conduzido a ela foi somente então vista como sendo uma preparação e um teste complexo da capacidade do analista de atender às variadas técnicas de comunicação da primeríssima infância.

Esta experiência partilhada de embalo ilustra aquilo a que quero me referir nos estágios iniciais do cuidado do bebê, cujas pulsões instintuais não se acham especificamente envolvidas. A coisa principal é uma comunicação entre o bebê e a mãe em termos da anatomia e da fisiologia de corpos vivos. O tema pode ser facilmente elaborado e os fenômenos importantes serão as provas cruas de vida, tais como os batimentos cardíacos, os movimentos da respiração, o calor do seio, movimentos que indicam a necessidade de uma mudança de posição, etc.

Cuidado Básico

Estas técnicas primitivas que têm a intercomunicação como subproduto conduzem naturalmente a interações ainda mais primitivas ou fundamentais que têm a natureza de comunicações silenciosas, ou seja, a comunicação só se torna ruidosa quando fracassa.

Aqui me encontro, penso eu, na área abrangida pela expressão de Hartmann, "o meio ambiente expectável médio", embora não possa estar certo de que ele pretendia referir-se a estas comunicações silenciosas muito iniciais.

O que tenho a dizer aqui é abrangido pelo termo "sustentação" [*holding*]. Uma ampliação abrangente da palavra "sustentação" permite que este termo descreva tudo

... (continuação da referência da página anterior) ... *Psycho-Analysis*, 46 (1965), sob o Título "Um Estudo Clínico do Efeito de um Fracasso do Meio Ambiente Expectável Médio sobre o Funcionamento Mental de uma Criança".

o que uma mãe faz no cuidado físico de seu bebê, inclusive largá-lo quando chega o momento para a experiência impessoal de ser sustentado por materiais não-humanos adequados.

Ao considerar estas questões, é necessário postular um estudo da mãe que se acha (temporariamente) tão identificada com o bebê, de maneira que sabe sem pensar mais ou menos do que o bebê precisa, e, na saúde, ela faz isto sem perder a sua própria identidade⁹.

Tentei alhures desenvolver o tema dos processos desenvolvimentais do bebê que, para tornarem-se reais, precisam da sustentação da mãe. A comunicação “silenciosa” é uma comunicação de confiabilidade que, na realidade, protege o bebê quanto a *reações automáticas* às intrusões da realidade externa, com estas reações rompendo a linha de vida do bebê e constituindo traumas. Um trauma é aquilo contra o qual um indivíduo não possui defesa organizada, de maneira que um estado de confusão sobrevém, seguido talvez por uma reorganização de defesas, defesas de um tipo mais primitivo do que as que eram suficientemente boas antes da ocorrência do trauma¹⁰.

O exame do bebê a ser sustentado mostra que a comunicação é silente (a confiabilidade tomada como certa), ou traumática (produzindo a experiência da ansiedade impensável ou arcaica).

Isto divide o mundo dos bebês em duas categorias:

1. Bebês que não foram significativamente “desapontados” na primeira infância e cuja crença na confiabilidade conduz à aquisição de uma confiabilidade pessoal que é ingrediente importante do estado que pode ser denominado de “no sentido da independência”. Estes bebês têm uma linha de vida e mantêm uma capacidade de se deslocarem para frente e para trás (desenvolvimentalmente) e se tornarem capazes de correr todos os riscos, por se acharem bem-garantidos.

2. Bebês que foram significativamente “desapontados” uma vez ou em um padrão de fracassos ambientais (relacionados ao estado psicopatológico da mãe ou do substituto materno). Estes bebês portam consigo a experiência da ansiedade impensável ou arcaica. Sabem o que é estar em um estado de confusão aguda ou conhecem a agonia da desintegração. Sabem o que é ser deixado cair, cair eternamente, ou cindir-se em desunião psicossomática.

Em outras palavras, experienciaram trauma, e suas personalidades têm de ser construídas em torno da reorganização de defesas que seguem os traumas, defesas que devem precisar reter aspectos primitivos, tais como a cisão da personalidade¹¹.

Naturalmente, o mundo dos seres humanos não é constituído de exemplos destes dois extremos. Aqueles que começaram bem — como a maioria dos bebês certamente começa — podem ser desapontados em estágios posteriores e sofrer traumas de um certo tipo; *per contra*, bebês que foram seriamente desapontados em estágios iniciais podem ser quase “curados” de seus desastrosos começos por cuidados terapêuticos fornecidos em estágios posteriores.

Apesar disso, é valioso para o estudioso da natureza humana manter em mente os dois extremos. É valioso especialmente para o psiquiatra e para o psicoterapeuta

9. Na psicopatologia, ela pode achar-se tão identificada com o bebê que perde a sua capacidade materna e, se retiver ainda alguma sanidade, entrega o bebê aos cuidados de uma babá. Desta maneira, ela fica vicariamente bem-sustentada e pode-se ver nisto uma busca natural daquilo que o paciente pode obter na transferência analítica, em fases de regressão à dependência. — D. W. W.

10. Masud Khan desenvolveu este aspecto do trauma; ver M. M. R. Khan, *Ego Distortion, Cumulative Trauma, and the Role of Reconstruction in the Analytic Situation*, *International Journal of Psychoanalysis*, 45 (1964), e também *The Priority of the Self* (London: Hogarth Press, 1974). — D. W. W.

11. Estados fóbicos são organizações frouxas que defendem contra fracassos de defesa. — D. W. W.

conhecerem estas questões, uma vez que um estudo da etiologia e da psicopatologia dos estados esquizóides e dos aspectos especiais da transferência esquizóide ou psicótica conduz ao retorno imediato à reorganização de defesas de qualidade primitiva que se segue à experiência de estados agudos de confusão na primeiríssima infância; estes, por sua vez, seguem-se a traumas ocorridos na área em que o bebê (para um desenvolvimento sadio) deve poder tomar a confiabilidade como certa, a área que é quase abrangida por um emprego ampliado da expressão *holding*. Mas a sustentação confiável de um bebê é algo que precisa ser comunicado, e isto é questão das experiências do bebê. Exatamente aqui a psicologia envolve a comunicação em termos físicos, dos quais a linguagem é a mutualidade na experiência.

Sobre as Bases para o *Self* no Corpo

I. As Bases para o *Self* no Corpo

Redigido em 1970¹

Minha intenção ao escrever este artigo é explorar material clínico que lança luz sobre o inter-relacionamento existente entre a criança que cresce e o seu corpo. O tema é obviamente muito amplo e uma especialização em determinada área leva automaticamente à negligência em outras. Sem embargo, é possível tomar a palavra “personalização”, que utilizei em outro contexto, e ver como ela é ilustrada por material clínico detalhado na psiquiatria infantil e na psicanálise. Adotei a expressão “personalização” como uma espécie de tipo positivo de despersonalização, termo que já foi usado e debatido de modo bastante completo. Vários significados são dados à palavra “despersonalização”, mas de modo geral, eles envolvem a perda de contato da criança ou do paciente com o corpo e com o funcionamento corporal, implicando isto a existência de algum outro aspecto da personalidade. Pretendeu-se, com o termo “personalização”, chamar a atenção para o fato de que a morada desta outra parte da personalidade no corpo, e um vínculo firme entre o que quer que se ache lá e que chamamos de psique, em termos desenvolvimentais representa uma conquista da saúde. Trata-se de uma realização que se torna gradualmente estabelecida, e não é doentia, mas em verdade, um sinal de saúde que a criança possa usar relacionamentos nos quais há uma confiança máxima, e em tais relacionamentos às vezes desintegrar-se, despersonalizar-se e até mesmo, por um momento, abandonar a premência quase fundamental de existir e sentir-se existente. As duas coisas, portanto, andam juntas no desenvolvimento sadio: o senso de segurança em um relacionamento mantendo a oportunidade para a anulação repousante dos processos integrativos, ao mesmo tempo em que facilita a tendência geral herdada que a criança tem no sentido da integração, e, como estou acentuando neste artigo, na questão da morada ou habitação do corpo e o funcionamento corporal.

O desenvolvimento para a frente acha-se muitíssimo associado com a morada, tal como com outros aspectos da integração, mas ele é, sob todos os sentidos, assustador para o indivíduo interessado se não for deixado aberto o caminho de volta à

1. Publicado na *Nouvelle Revue de Psychanalyse* (primavera 1971) e no *International Journal of Child Psychotherapy* (1972).

dependência total. E isto é particularmente verdadeiro no campo clínico, dos dois aos cinco anos de idade, após o que, em termos de experiência clínica, o retorno à dependência se torna obscurecido em toda uma série de sofisticações. Na adolescência há um novo período em que, por causa das vastas implicações do novo e rápido avanço em termos de encontrar e enfrentar o mundo, há recorrência de uma necessidade a manter aberto um caminho de volta para a dependência. Clinicamente, isto tende a manifestar-se na fase da pré-puberdade, quando o adolescente está com 12 a 14 anos de idade, após o que a dependência pode muito facilmente tornar-se absorvida pela dependência natural que se acha livre de elementos regressivos relativos aos pais e que já volta o olhar para o *status* de adulto, que é chamado estar apaixonado, e nas experiências de todos os tipos possíveis que rodeiam um estado desse tipo.

O termo “personalização”, que utilizei em meu próprio benefício, pode não ser aceitável de maneira geral, mas ele me capacitou a reunir os exemplos em meu trabalho clínico que são relevantes a este aspecto de realização no desenvolvimento humano. Um caso importante, de meu ponto de vista, é um que não me proponho fornecer em detalhes neste contexto, por já havê-lo publicado com pormenores alhures². Aqui, quero referir-me ao caso em minha própria linguagem.

História Clínica

Refiro-me a uma importante entrevista com um menino, Iiro, de nove anos e nove meses. Com frequência descrevi esta entrevista como sendo uma ilustração da comunicação com uma criança, porque não havia linguagem comum entre o menino e eu. Trocamos desenhos com base no jogo do rabisco [*squiggle game*] e tínhamos um intérprete. A despeito destes empecilhos, o menino comunicou-me sua necessidade especial, que dizia respeito tanto ao seu próprio desenvolvimento quanto a uma complicação na atitude da mãe com respeito à incapacidade física dele. Na realidade, Iiro achava-se sob tratamento quase constante no Departamento de Ortopedia por causa de sua *sindactilia*. O cirurgião dissera que o menino cooperava quase bem demais e ficara pensando qual seria a razão disso. O menino passara por inúmeras operações em suas mãos e pés. Na condição da *sindactilia*, os dedos e os artelhos se acham soldados entre si e isto não constitui uma indicação clara para o cirurgião, que gostaria de criar dedos e artelhos a partir do estado caótico que existe. Trata-se de uma doença hereditária, e Iiro, situado no meio de uma família bastante grande, fora o único que a herdara. Um pouco da urgência para o uso da habilidade do cirurgião ortopédico provinha do fato de a mãe apresentar a mesma condição e só poder aceitar este menino na base de fazer todo o possível para curá-lo de uma deformidade pela qual ela se sentia responsável. Com base em ter feito todo o possível por ele, descobrira-se gostando mais do menino do que de qualquer outro de seus filhos. Aqui tínhamos uma situação clara, portanto, de um menino trazido da enfermaria ortopédica para me ver, um menino feliz, simpático e inteligente, que, apesar disso, juntamente com a mãe, achava-se constantemente em busca de nova ajuda ortopédica, pedindo em verdade uma cirurgia plástica melhor da que o cirurgião era capaz de colocar em prática.

O interesse deste caso reside no fato de que, em nível mais profundo, este menino comunicou algo mais que sua necessidade de ser deixado normal, de maneira a poder tocar flauta. O que ele indicou foi que fazia sentido ter feito todo o possível por cirurgia (embora não soubesse, naturalmente, do tremendo senso de culpa da

2. Caso 1, “Iiro”, em *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry* (London: Hogarth Press; New York, Basic Books, 1971).

mãe), mas que precisava de determinada coisa, que era a seguinte: tinha de estar certo de que, primeiro de tudo, era amado como o fora quando nascera ou em algum início teórico de sua existência. Se aceito como deformado, que implicava que seria normal nascer com pés e mãos como as suas, então ele prestaria todo tipo de cooperação à mãe e ao cirurgião. Comunicou isto sem motivação consciente, mas em termos de seu grande amor pelos patos, e viu o primeiro desenho como sendo um pé palmado de pato. Mais adiante, na entrevista, conseguiu utilizar uma enguia como simbólica de seu estado inicial, isto é, antes que a questão de braços e pernas, e dedos e artelhos, se tornasse importante. Diversos pontos de interesse teórico acompanham um exame deste caso. Obviamente, uma criança não sabe a respeito de uma disparidade como esta no começo. Gradualmente, com o decurso do tempo, ela tem de reconhecer o fato da deformidade. É possível que ele nunca houvesse reconhecido este fato até a entrevista comigo, quando contava nove anos e nove meses de idade. Aquilo a que o menino tem de poder ajustar-se é a atitude da mãe e de outras pessoas com respeito à sua deformidade, e acaba por tornar-se necessário ver a si mesmo como anormal. De começo, contudo, a normalidade para a criança deve ser a sua própria forma e função somática. Tal como começa, assim tem de ser aceito, e assim tem de ser amado. É uma questão de ser amado sem sanções.

É muito fácil transportar estas observações para um exame das necessidades das crianças que são deformadas. Ser amado no início significa ser aceito, e constitui uma distorção, do ponto de vista da criança, se a figura materna tiver uma atitude do tipo: "Amarei você se for bom, se for limpo, se sorrir, se beber tudo", etc. Estas sanções podem vir mais tarde, mas de começo, a criança tem um diagrama de normalidade que é em grande parte questão da forma e do funcionamento de seu próprio corpo. Pode-se pensar que certamente estas questões têm a ver com uma idade posterior, quando a criança tornou-se uma pessoa relativamente sofisticada. Não se pode negligenciar a observação, contudo, que estas são questões dos primeiríssimos dias da vida da criança. É verdadeiramente no início que a criança precisa ser aceita como tal e beneficia-se de uma aceitação desse tipo. Um corolário seria que quase toda criança foi aceita nos últimos estágios antes do nascimento, isto é, quando se está pronto para o nascimento, mas o amor é demonstrado em termos do cuidado físico que é usualmente, mas não sempre, satisfatório quando se trata do feto no útero. Neste termos, a base para o que chamo de personalização, ou a ausência de uma tendência especial à despersonalização, começa antes mesmo do nascimento da criança, e é certamente muitíssimo significante, uma vez que a criança tem de ser sustentada por pessoas cujo envolvimento emocional precisa ser levado em conta, assim como suas reações fisiológicas. O começo daquela parte do desenvolvimento do bebê, que estou chamando de personalização, ou que pode ser descrita como uma habitação da psique no soma, tem de ser encontrado na capacidade que a mãe ou a figura materna tenham de juntar o seu envolvimento emocional, que originalmente é físico e fisiológico.

No desenvolvimento deste tema poderia-se tomar caminhos diversos. Meu método será utilizar outro exemplo clínico, escolhido por estar disponível em minha mente.

Lembro-me de uma consulta que uma moça, Jill, de 17 anos, teve comigo em 1968. Ela usou esta consulta de maneira positiva e, de fato, a entrevista capacitou-a a avançar com seu desenvolvimento, que se havia detido. Da carta de sua mãe que recebi antes da consulta soube o seguinte:

Jill vem se sentindo um pouco perdida. Pode parecer que seus problemas sejam principalmente sociais ou educacionais. Suas queixas manifestas e nítidas são principalmente a respeito de si mesma "*vis à vis* o mundo". Ela não faz amigos com facilidade. Sente-se estúpida e falta-lhe um senso de propósito. Sinto que estas queixas dela podem estar mascarando um ressentimento mais profundo contra sua família, ou à falta dela, ou contra mim, por diversas razões que não pode expressar. São certamente

“eles” que de alguma maneira falharam em aparelhá-la com autoconfiança, de maneira que, em vez de juntar-se à batalha por liberdade de seus contemporâneos, ela se acha, por assim dizer, empacada na porta, possivelmente ainda com esperanças de suprir o que perdeu, antes de poder avançar.

E a mãe acrescentou uma nota biográfica:

Ela nasceu em 1950: amamentada durante nove meses e, embora pequena, um bebê satisfatório e voraz. Quanto estava com três anos, seu pai (que era da geração de *meu* pai) faleceu. Não acho que o impacto da morte dele tenha sido indistinto ou embotado para ela. Por longo tempo, depois, falou dela e de seu efeito sobre nós duas. Fazia desenhos representando as duas situações diferentes: a dela e a minha. Tinha, e ainda tem, um avô e vários tios, mas em sua vida do dia-a-dia não houve nenhuma figura masculina sistematicamente acessível ou realmente importante.

Dava a impressão de ser uma criancinha ordinariamente feliz, amiúde bastante alegre. Tinha bons recursos quanto ao brinquedo imaginativo. Quando estava com 12 anos, tive um colapso (depressão grave) e fiquei por dez meses em um hospital psiquiátrico. Ela nunca falou muito a respeito deste tempo. Uma vez, quando perguntada, disse: “Eu sabia que você voltaria, é claro”.

Entrevista

O que segue é minha descrição da entrevista, ditada a partir de notas tomadas horas após a sua realização.

Jill, 17 anos. Consulta: 7.2.68.

Primeira e única filha. O pai faleceu quando estava com 3 anos. Acréscimo à família: Tommy (adotado), que vi uma vez em consulta. Ele tinha então seis anos e ela oito. O pai era 30 anos mais velho que a mãe.

Jill chegou sozinha. Era uma pessoa franzina, vestida com um vestido cinza de veludo piquê. Poderia ter 13 anos. Uma das primeiras coisas que disse foi que já estava com quase 18. Evidentemente, era bastante constrangida por parecer tão franzina.

A princípio, houve um período bastante emperrado, em que não estava certo como poderíamos usar um ao outro. Passei pelas preliminares normais a respeito de sua vinda. Viera por que fora mandada ou por que estava querendo ajuda? Respondeu que era apenas na escola que havia problemas e que seu trabalho lá a preocupava. Tinha um bloqueio mental quando escrevia redações e isto a deixava muito deprimida. Com grandes detalhes, descreveu a maneira pela qual coligia material para uma redação e, quando chegava a hora de reuni-lo, logo atingia um lugar aonde não podia ir em frente. Gostaria de ingressar na universidade, mas sentia-se fadada a falhar em candidatar-se a ela, porque não estava segura de quere entrar lá, onde, afinal de contas, haveria apenas uma continuação de tudo o que acontecera na escola secundária.

Em outras palavras, ela seria novamente detida pelo bloqueio em seu funcionamento mental.

Não tinha muitos amigos, embora freqüentasse a escola secundária. Parecia achar que as disciplinas que estava estudando não eram realmente dignas de estudo. Uma delas era arte, e ela ficava obcecada com a pergunta: que tipo de arte vale alguma coisa?

Falei um pouquinho a respeito dela e de seu ambiente, quando lhe disse que sabia que estava morando com a mãe, sem pai, e informei-a também de que a mãe me havia contado a respeito de suas próprias depressões e do fato de que a vida de Jill fora perturbada pelo colapso da mãe quando Jill tinha 12 anos (dez meses no hospital).

Havia algo que Jill estava tentando me dizer, que era que ela sempre achara que as coisas estavam realmente bem em sua vida, até algum incidente, provavelmente

um acidente, desde a época na qual ela tinha sentido uma falta de confiança em um desfecho definitivo que pudesse ser satisfatório. Começou a descrever isso. Disse que sempre achara que poderia enroscar-se sobre si mesma e que isso seria uma defesa bem-sucedida, mas desde o acidente, não mais sentira que pudesse confiar nessa defesa. Falamos a respeito disto e parecia claro que ela sentia que alguma parte dela a ressaltar achava-se em perigo provindo do meio ambiente, mas que, se viesse a se enroscar, então essa parte não ficaria em perigo. Naturalmente, o que vinha à mente era a idéia de um pênis com ansiedade castratória, mas isto parecia ser uma linguagem rude demais para descrever o que estava acontecendo na mente desta moça. Pude explorar sem dano em torno dessa área e ficou-me a idéia de que essa não era uma maneira suficientemente boa de descrever a sua ansiedade. Em certo ponto, passamos para o jogo do rabisco. Achei que ela ficaria mais à vontade com algo que estivéssemos fazendo juntos e certamente pareceu funcionar assim. De maneira que fomos em frente, como se fôssemos crianças juntas, e tudo pareceu inteiramente natural.

1. O meu primeiro rabisco foi por ela transformado em uma espécie de cisne.
2. O primeiro dela eu transformei em uma cabeça de moça, com um comprimento de cabelo semelhante ao de Jill.
3. O meu rabisco seguinte ela transformou, muito imaginativamente, em um cão, visto sob um ângulo curioso, desde trás.
4. Seu rabisco seguinte foi por mim transformado no que ela chamou de um potro.
5. Com o seguinte, meu, ela nada pôde fazer. Disse: "Já tem coisa demais nele". Isto correspondia a algo que ela já havia dito sobre a vida, de quão complexa ela pode ser em qualquer momento determinado, com todos os tipos de possibilidade se aglomerando.
6. Transformei o rabisco seguinte dela em um vaso. Ela concordou que era uma forma reconhecível para um vaso de vidro e pareceu aliviada que houvéssemos chegado a algo mais simples e circunscrito.
7. Do seguinte que fiz, ela simplesmente disse: "Isso é uma cadeira moderna".
8. Transformei o traço seguinte dela em algum tipo de cachorrinho. Isto levou ao fato de que a família de Jill tinha um *border terrier* como animal de estimação.
9. Ela transformou o meu rabisco seguinte em arquitetura, uma sala de concertos de uma variedade muito moderna. Ela havia trabalhado no escritório de um arquiteto durante alguns meses, fazendo serviços domésticos, mas evidentemente gostara da idéia da arquitetura como profissão.
10. O seguinte dela eu transformei em um par de óculos como os meus.

Em algum lugar, enquanto tudo isto estava acontecendo, estivemos conversando. A respeito de seus sonhos, ela disse que eles não eram bons. Eram algo como cair na rua ou escada abaixo. Suas pernas cediam, etc. contou-me que sua perna esquerda era realmente um centímetro mais curta que a direita, fato que não era aparente, embora ela estivesse usando uma minissaia muito curta, mas evidentemente, tinha grande significado para ela.

Ela mencionou a idéia de que, num sonho, sentiu-se como se um membro lhe faltasse. Quando retornamos ao assunto de não ser capaz de concentrar-se, disse-lhe que, ao considerar o seu próprio *self*, ela sentia que, se reunisse todos os fragmentos e desse uma olhada para ver como poderia juntá-los, haveria algo faltando, tal como acontecia quando coligia material para uma redação. Reuni isto com o fato fora de dúvida de que ela tinha tido de viver sua vida sem ter um pai. Parecia não haver sentimento algum a respeito da morte deste, exceto que ela ficava irritada quando pessoas que o haviam conhecido falavam a seu respeito, de maneira que ela se sentia muito deixada de fora. Era algo que eles sabiam e ela não.

Foi aqui que ela me contou a respeito de sua defesa (enroscar-se) haver-se rompido após um acidente de rua. Ela havia tido um acidente no qual quebrara os dentes

da frente e ficara muito constrangida a respeito disto, que a fazia cecear. Contou quão estúpido fora. Ela estava esvaziando um carrinho de mão, com o cão preso em uma trela, porque o coelho estava solto. O cão ficou assustado e ela virou-se para ralar com ele, mas o cabo do carrinho deu um pulo e quebrou-lhe os dentes. Disse ela: "É irônico. Eu estava ralhando com o cachorro e fui eu quem saiu ferida". O acidente causou-lhe um choque considerável e fora de dúvida perturbou também a mãe, por alterar a aparência da menina. Nisto, reconheci a existência de um fator verdadeiramente externo, semelhante à morte do pai quando ela tinha três anos. Ela falou a respeito do pai ser muito velho, de qualquer modo.

Por algum tempo debatemos os sentimentos dela a respeito de ser um menino ou uma menina. Ela quisera muito ser um menino, desde a época em que Tommy nascera, quando tinha sete ou oito anos, até ela completar dez; hoje, provavelmente preferiria ser uma menina. Sondei a existência de inveja do pênis de Tommy, mas ela simplesmente disse que conhecia tudo a respeito das diferenças entre meninos e meninas antes de Tommy aparecer. Tem-se de notar que Tommy sempre foi um menino muito difícil. Jill continuou dizendo que, quando estava com 12 anos, a mãe ficara doente. Perguntei-lhe a respeito de sonhos em que ela fosse um menino, e sua resposta foi que, definitivamente, não tinha esse sonho. Tinha algumas amigas, talvez três.

Chegou então a parte importante da consulta. Foi seu desenho do membro quebrado e arrancado no sonho, a coisa que sempre sentia a respeito de si mesma. Retornou a ele depois e falou a respeito de sua cor. Era como se fosse um coto de perna. Sua carne era pálida e cor de malva, como a carne de um cação [*dogfish*] (dissecação de biologia). Era uma cor morta. Falando a respeito, disse que era capaz de pensar nele mais como um membro tirado fora a dentadas por um animal bravo do que como algo machucado em um acidente. Isto me fez lembrar do cão durante o acidente em que, "ironicamente", haviam sido os próprios dentes dela os arrancados.

Acabei por fazer uma interpretação, dizendo pensar que isso era o mais próximo que ela podia chegar à sua reação à morte do pai. Ela não se lembrava dele como pessoa e não sentira pesar por sua perda. Apesar disso, quando falecera, um pedaço de sua vida morrera com ele, de maneira que havia algo faltando. Ao mesmo tempo, se podia dizer que ela arrancara fora a mordidas algo dele, porque tínhamos de lembrar a importância de seus dentes, que havia debatido em conexão com o acidente com o carrinho de mão. Falei a respeito da maneira pela qual crianças pequenas de três anos brincam com os dedos do pai, ou a corrente do relógio, ou alguma coisa dele, e mordem-na, e que se podia presumir com bastante certeza que ela brincara desta maneira com o pai. A morte e o afastamento dele parecer-lhe-iam então como se ela houvesse realmente mordido, ao invés de brincar de morder, resultando isto em uma fantasia do arrancamento de um dedo ou o que fosse.

Ela conseguiu receber isto como algo merecedor de consideração.

Ao final, expressou um certo espanto com o desenho do membro que se achava ali para ser examinado e que trouxera este tema central tanto para o primeiro plano, isto é, sua impressão de que, em qualquer exame de si própria, descobriria-se com algo lhe faltando. Revelou-se que o membro que fora arrancado desta maneira era o esquerdo, que era também o mais curto dela.

Fizemos uma espécie de resumo no final e debatemos o possível valor de uma entrevista como aquela e, também, a possibilidade de que pudesse ficar perturbada por ela. Ao final, foi bastante positiva. Disse simplesmente: "Estou contente por ter vindo. Adeus". E foi embora de modo amistoso.

Meu comentário para ela foi que a palavra apropriada era "triste". Se ela pudesse livrar-se da ansiedade a respeito de haver algo faltando, poderia ser capaz de descobrir que o enunciado apropriado era ser muito triste para uma menina o pai morrer quando ela tem três anos.

Comentário

Este caso poderia ser tomado para ilustrar a maneira pela qual, embora uma criança pequena possa não saber que um de seus membros é mais curto que o outro, chega uma ocasião em que descobrirá que a atitude de pais e médicos, particularmente a da mãe, com ansiedades hipocondríacas consolidando-se ocasionalmente em uma moléstia depressiva, torna necessário aceitar o fato de que há algo de errado em algum lugar. Neste caso, a deformidade era tão ligeira que poderia ter sido ignorada completamente.

Apesar disso, quando Jill veio a dispor, a si e a sua personalidade, em torno do fato de não ter um pai e o detalhe de havê-lo perdido com a idade de três anos, quando, de acordo com a saga familiar, gostava muito dele, ela transformou este fato insignificante no sonho de uma perda tirada fora a mordidas por um animal selvagem. O mesmo mecanismo achava-se em ação em sua vida mental e, até a consulta, fora incapaz de progredir em seu crescimento emocional ou intelectual. Aconteceu que foi capaz de retomar seu desenvolvimento após a consulta e o acompanhamento demonstrou que uma psicoterapia eficaz fora realmente alcançada.

A integração no ser humano em desenvolvimento assume uma ampla variedade de formas, uma das quais é o desenvolvimento de um arranjo operacional satisfatório entre a psique e o soma. Isto começa anteriormente à época em que é necessário adicionar os conceitos de intelecto e verbalização.

A base de um *self* se forma sobre o fato do corpo, que, sendo vivo, não apenas tem formas, mas também, funções. As observações relevantes para isto (que chamei de personalização, a fim de vinculá-la com o transtorno denominado despersonalização)³ são feitas primariamente no estudo direto de bebês e suas mães a interagirem de modo natural. Como adjunto útil a tais observações, chamo a atenção para o auxílio que se pode derivar de um estudo de crianças com anormalidades físicas. Neste artigo, só houve espaço para dois exemplos, mas eles podem bastar para ilustrar a maneira pela qual detalhes clínicos podem lançar luz sobre tais fenômenos complexos. Muitas anormalidades físicas não são de natureza tal que um bebê possa estar consciente delas como anormalidades. Na realidade, o bebê tende a presumir que o que se acha lá é normal. Normal é o que está lá. Constitui amiúde um fato que o bebê ou a criança se dê conta da deformidade ou da anormalidade através da percepção de fatos inexplicados, tal como a atitude daqueles ou de alguns daqueles situados no meio ambiente imediato.

Um exemplo muito complexo seria fornecido pelo fato da deficiência mental, onde o aparelho para lidar com percepções complexas acha-se ele próprio incapacitado pela mesma deformidade que está causando a distorção ambiental. Não examinei aqui um caso desse tipo. Será possível, penso eu, extrair desses casos um só princípio que tenha aplicação quase universal, e posso utilizar a mensagem que foi passada por Iiro, escolhido para meu primeiro caso. Na realidade, o que ele disse ao debater sua *sindactilia* congênita foi: "Cooperarei com quem quer que possa ajudar a corrigir minha anormalidade, desde que eu seja, primeiro de tudo, aceito e amado tal como sou". Ser aceito e amado "tal como sou" significava para Iiro "Como me conheci pelo conhecimento de meu próprio corpo, antes de encontrar pessoas que me enxergaram como anormal, e elas estavam certas porque, como gradualmente vim a ver e entender, eu sou deformado".

3. "Desenvolvimento Emocional Primitivo" (1945) e "A Mente e Sua Relação com a Psique-Soma" (1949), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London: Hogarth Press, 1975).

Desta maneira, mesmo um bebê deformado pode crescer e transformar-se em um bebê sadio, com um *self* que não é deformado e um senso do *self* que se baseia na experiência de viver como uma pessoa aceita. Distorções do ego podem provir de distorções na atitude daqueles que cuidam da criança. Uma mãe com um bebê está constantemente apresentando e reapresentando o corpo e a psique do bebê um à outra, e pode-se facilmente ver que esta tarefa fácil, mas importante, torna-se difícil, se o bebê tem uma anormalidade que faz a mãe sentir-se envergonhada, culpada, assustada, excitada ou desesperançada. Em tais circunstâncias, ela pode dar o melhor de si, e não mais que isso.

Corolário disto é que o psicoterapeuta não precisa dizer: "esta criança não pode ser ajudada por causa da anormalidade física". O *self*, o senso do *self* e a organização do ego da criança podem, todos eles, estar intactos, por se basearem num corpo que era normal para a criança no período formativo.

Com referência a este artigo, o principal tem a ver com a palavra *self*. Fico pensando se poderia escrever algo a respeito desta palavra, mas naturalmente, assim que me ponho a fazê-lo, descubro que há muita incerteza, mesmo em minha própria mente, sobre o que quero dizer. Descobri que havia escrito o seguinte: Para mim o *self*, que não é o ego, é a pessoa que é eu, que é apenas eu, que possui uma totalidade baseada no funcionamento do processo de maturação. Ao mesmo tempo, o *self* tem partes e, na realidade, é constituído dessas partes. Elas se aglutinam desde uma direção interior para exterior no curso do funcionamento do processo maturacional, ajudado como deve ser (maximamente no começo) pelo meio ambiente humano que sustenta e maneja e, por uma maneira viva, facilita. O *self* se descobre naturalmente localizado no corpo, mas pode, em certas circunstâncias, dissociar-se do último, ou este dele. O *self* se reconhece essencialmente nos olhos e na expressão facial da mãe e no espelho que pode vir a representar o rosto da mãe. O *self* acaba por chegar a um relacionamento significativo entre a criança e a soma das identificações que (após suficiente incorporação e introjeção de representações mentais) se organizam sob a forma de uma realidade psíquica interna viva. O relacionamento entre o menino ou a menina e suas próprias organizações psíquicas internas se modificam de acordo com as expectativas apresentadas pelo pai e pela mãe e por aqueles que se tornaram importantes na vida externa do indivíduo. São o *self* e a vida do *self* que, sozinhos, fazem sentido da ação ou do viver desde o ponto de vista do indivíduo que cresceu até ali e está continuando a crescer, da dependência e da imaturidade para a independência e a capacidade de identificar-se com objetos amorosos maduros, sem perda da identidade individual.

II. Dois Outros Exemplos Clínicos

Sem data; provavelmente escrito em 1970⁴

Estes exemplos clínicos e as considerações teóricas a que dão origem fazem-me pensar em dois outros casos que podem adequadamente aplicar o tema da personalização e da morada psicossomática. Um deles se refere a uma jovem com uma grave incapacidade e o outro a uma menina sadia que aconteceu possuir uma pele escura. Com estes dois casos esta contribuição tem de findar, embora a elucidação do problema geral esteja apenas começando.

Hannah, 18 Anos de Idade

Hannah me foi encaminhada por uma organização dos serviços sociais voluntários. A Assistente Social principal escreveu:

Nascida com ligeira espinha bífida, isto é, uma certa inchação ao final da espinha do tamanho aproximado de uma noz, esta cresceu com o passar dos anos; pés e pernas foram afetados, teve um quadril deslocado, mas não hidrocefalia. Hannah parece não ter tido nenhum tratamento até a idade de quatro anos, quando foi admitida ao hospital; deu baixa pensando que iria marcar uma operação de rotina e nem ela nem a mãe tinham qualquer idéia de que Hannah seria mantida no hospital. A mãe acha que muitas das dificuldades de Hannah originaram-se disto. Teve ileostomia com a idade de dez anos. Tanto os pais quanto a criança foram muito afetados; a mãe não se achava suficientemente preparada para o que iria acontecer. De volta para casa, quando Hannah foi ver seu médico particular, ele observou na frente dela: "Você parece um menino agora, não é, Hannah, mas ficou com aquilo no lugar errado". Teve muitos problemas com sujar-se em seguida à operação, coisa com que o hospital lidou ordenando que enemas diários lhe fossem aplicados pela enfermagem distrital, o que continuou durante meses até os pais protestarem.

Durante 1961, 1962 e 1963, recebeu mais tratamento hospitalar para as pernas e os pés. Em janeiro de 1964, Hannah foi admitida, a seu pedido, ao hospital, para remoção da protuberância em sua espinha que, achava ela, havia crescido demais para permitir-lhe usar uma saia apertada. Neste estágio, Hannah achava-se muito consciente de querer ser perfeita em seu corpo e, por esta razão, havia-se submetido a tratamento intensivo para as pernas e os pés e queria agora corrigir a espinha. A operação foi de vulto, demorando duas horas, e Hannah passou muito mal após a cirurgia. Infelizmente, não obteve sucesso completo com essas operações. Foi aconselhada a usar suportes de metal para as pernas, mas recusa-se a fazê-lo. Recentemente perguntou ao cirurgião se lhe amputaria ambas as pernas, de maneira a ela poder ficar então com pernas artificiais de aparência perfeita, mas isso foi recusado. Tem usado desde então um novo tipo de suportes que se ajustam à perna de modo a parecer uma, mas como eles têm juntas no joelho e no tornozelo e só chegam até logo acima dos joelhos, não corresponderam realmente ao esperado. Hannah ainda sente muito que é aleijada, falou demoradamente com a mãe a respeito disto, dizendo que para ela é pior do que para alguém que seja mais deficiente, porque as pessoas esperam que ela seja normal. Ainda se sente muito mal a respeito das pernas e tenta ocultá-las usando botas compridas, calças, etc. Também, acho que, não resolveu os seus sentimentos a respeito da ileostomia e ela própria expressou o desejo de conversar com um psiquiatra.

4. Estes exemplos foram encontrados junto com o artigo precedente nos papéis de Winnicott. — [N. dos Organizadores]

Nossa organização de assistência social tem-se mantido em estreito contato com a mãe de Hannah e, em determinada ocasião, esteve-lhe dando apoio intensivo. Ela tem sido uma mãe maravilhosa para a criança e permite-lhe expressar os sentimentos, mas como observou outro dia, sente que Hannah realmente precisa de outrem que não ela, com quem possa conversar.

Segue-se um relato da entrevista de Hannah comigo, ditado a partir de notas tomadas na ocasião.

Consulta 10.1.68

Hannah veio me ver sozinha, a consulta havendo sido marcada pela agência de assistência social voluntária.

Família intacta.

Hannah: 18 anos.

Irmã: 24 anos.

Conversamos sobre assuntos variados. Ela viera me ver diretamente da escola de arte.

Pai: gerente de lojas. Fora desenhista e isto pode ter influenciado Hannah em sua escolha de uma escola de arte.

Antes de me instalar para trabalhar com Hannah, levantei a questão da motivação. Disse-lhe que podia ter vindo simplesmente por ter sido impulsionada a vir, ou podia ter querido vir por sua própria vontade. Após refletir, ela disse: "Bem, ambos".

Após uma pausa, vi que ela estava olhando para o quadro em minha parede, de maneira que introduzi o assunto da pintura e do desenho. Imagino que não havia notado que olhara para o quadro, porque disse; "É engraçado, mas freqüento a escola de arte". Descreveu a si mesma como "não realmente má em arte". Apesar de sua idade, pensei que poderíamos usar a técnica do jogo do rabisco, pelo menos como um gambito de abertura, e ela a pegou com muita rapidez. Mostrou ser uma desenhista lenta e cuidadosa. Pediu-me para alcançar-lhe a bolsa que continha seus óculos e falamos a respeito do anel dela, que havia adquirido por 2 selins e 6 pennies, mas que valia cinco libras. Desta maneira, estivemos rapidamente estabelecendo um contato pela interação. Usamos folhas inteiras tamanho *in quarto* (em vez das folhas meio *in quarto* que utilizo com as crianças mais jovens) por me parecer que isso seria mais apropriado, em vista do fato de ela ser estudante de arte e estar já com 18 anos.

1. O meu primeiro rabisco ela transformou em um peixe sendo apanhado em uma rede. Tinha um anzol na boca.

2. Transformei o rabisco dela em uma planta.

3. O meu ela cuidadosamente transformou em uma abstração, chegando gradualmente a algo que se mostrou satisfatório para ela. Falou a respeito da incapacidade de dizer-se o que é a beleza. Observou que, em uma abstração, pode-se fazer o que se quiser. Disse que ficaria bonita em cores ou em uma folha grande de papel.

4. O dela, ela transformou na face distorcida de um homem, mas também podia ser a de uma mulher. Chamou-a de Celia, por alguma razão pessoal.

5. Comecei a transformar o dela em uma sereia. Ela ajudou-me nisso, de maneira que, ao final, o desenho fora um esforço conjunto. Falei a respeito da sereiazinha de Copenhague. Ela ficou pensando como surgira a lenda da sereia. Apontei-lhe que a idéia de uma sereia proviera de mim, embora fosse o rabisco dela, e ela disse: "Oh, sim, eu havia esquecido".

Tinha havido aqui o perigo de nos atolarmos no tema da sereia, introduzido por mim, embora o rabisco certamente não exigisse necessariamente essa idéia. Ao invés, ela passou para algo que lhe era mais importante e tinha a ver com o prazer que auferia com a escola de arte.

Fez o comentário de que as escolas matam e debateu a dificuldade em que se acha, porque embora o ensino mate a originalidade, apesar disso, quando foi para a escola de arte, não podia desenhar coisa alguma e agora pode. Acha-se aqui em um conflito que ainda não está resolvido em sua mente.

Pode ter acontecido que, ao jogar o jogo do rabisco, estivéssemos já fazendo uma contribuição para a compreensão deste conflito central.

6. Fiz deliberadamente o meu rabisco de um tipo circular. Disse ela: "Tudo o que posso ver são pessoas; ora, bem, farei uma pessoa de novo". Chamou essa pessoa de Phil (nome que pode aplicar-se tanto a um menino quanto a uma menina). "Papai odeia garotas de cabelos longos. Eu odeio gente de cabelo curto. Acho bonitos os cabelos longos. Definitivamente o número 6 é um garoto". O número 6 tem a ver com vários rapazes que conhece. "Eles usam cabelo comprido e isso nada tem a ver com quererem ser meninas. Por que é que fazem tanta onda a respeito de rapazes com cabelos compridos? Veja a Idade da Pedra. Nunca saí com nenhum deles, *nem ninguém com quem eu tenha saído o fez*."

Daí, consegui levá-la à idéia de sonhar. "Meus sonhos são, na maioria, assustadores. Tive um a outra noite. Era a respeito de mamãe. O senhor o acharia maluco. São todos ridículos. Quando estou acordada, fico pensando porque sonhei sonhos tão ridículos e depois, quando adormeço, todos começam a se derramar. Nesse sonho, mamãe disse que ia morrer. Todos sabiam. Disse ela: 'Ponha-me em meu caixão antes de ir para a escola'. De maneira que lá estava ela, na sala de estar, em seu caixão. Toda a vez que eu entrava ficava com medo que estivesse morta".

7. Ilustrei este sonho a respeito da morte de sua mãe.

Daí ela continuou falando a respeito das duas tendências opostas em seu relacionamento com a mãe. Passou a dar-se melhor com ela depois que começou a freqüentar a escola de arte, mas houve uma longa fase em que as coisas foram muito ruins, e mencionou as idades de 13, 15 e 16 anos. "Era tudo discussão mesquinha. A respeito de coisas que não tinham importância". Um exemplo seria: "Você não pode ver que a cadeira tem de ficar lá e não aqui?" Acrescentou um comentário geral: "Quando se pensa que se pode ficar com raiva com os assuntos mundiais e aí aparece alguém que fica com raiva porque uma cadeira está lá ao invés de estar aqui!" Adicionou: "Não sou realmente do tipo que discute. Atualmente, acabaríamos rindo disso".

A respeito do pai: "Oh, ele não seria capaz de assustar um ganso" e obviamente desprezava algo a respeito dele e admirava algo a respeito da mãe.

Fica-se com a impressão aqui de que a discussão tinha como sua raiz uma ligação homossexual suprimida ou talvez totalmente inconsciente entre ela e a mãe, a qual não podia ser levada a um desfecho satisfatório. Não existe intimidade, até onde pude descobrir, entre ela e a irmã mais velha.

Ela prosseguiu, a respeito de sonhos: "Eles não são lógicos. Assemelham-se a uma outra vida. Depois de se morrer, o que acontece? É como se, no caso de morrer enquanto se está adormecida, e aí se tem os sonhos. Céu ou inferno".

Após uma pausa, disse: "Assim, vou para o inferno, mas não matei ninguém".

Eu trouxe à baila a questão de sua espinha bífida e de sua condição geral devida à deformidade congênita. Apontei-lhe achar que ela estava explorando ao máximo possível o seu senso de culpa e responsabilidade pelas coisas, indicando o quanto ela gostaria de achar que seus problemas eram realmente problemas naturais, a surgirem das coisas agressivas, destrutivas e odiosas existentes em sua própria natureza. O difícil para ela, sugeri, era que o problema principal não tinha absolutamente nada a ver com ela. Era o que as pessoas chamariam de "ato de Deus" ou funcionamento do puro acaso.

Ela cooperou comigo ao ponto de passar por um momento para este lado do argumento e falar que não é justo que pessoas nascidas com tal condição não possam tornar-se normais. Debatesmos a lógica de um sentimento de culpar Deus por isso.

Falamos a respeito do final do sonho. Ela despertara para ver se a mãe estava viva. "No sonho, ela tinha realmente morrido". Presumo que isto era de fato também a morte dela própria.

Não foi possível tomar notas de todo o debate que tivemos a respeito deste tema. O que sei é que terminei por uma declaração de sentimentos positivos. Senti-me tão atraído por esta pessoa boa, mas basicamente deformada, que achei que deveria colocar meus sentimentos em palavras. Certamente não ignorei a deformidade que a deixa baixa e muito esquisita quando caminha, e que, naturalmente, envolveu-a em um longo período de incontinência. Disse, contudo, com facilidade e verdade: "Você tem um rosto bonito".

Ao final desta consulta, Hannah foi embora achando, penso eu, que não havia-mos estado debatendo uma deformidade, mas sim uma pessoa, ela própria, estudante de uma faculdade de artes, e alguém que tinha toda a intenção de ganhar a vida por si própria. Se obtive alívio, foi da maneira um tanto inusitada por que chegamos ao seu ressentimento com a injustiça pertinente ao fato de ela haver nascido com uma deformidade congênita de tipo grave.

Palpitaria que o desenho da mãe no caixão foi um aspecto importante da consulta, por havê-la colocado muito estreitamente em contato com a idéia de morte e de vingança, tudo dentro de um arcabouço que permite a existência de amor no relacionamento entre ela e a mãe.

Em minha carta à agência, escrevi:

É incerto até onde esta sessão única foi de qualquer valor para Hannah. Ela chegou com considerável dificuldade, por causa de seus problemas com os membros inferiores, mas de uma maneira ou outra, transpôs a neve congelada e permaneceu comigo durante uma hora. Provavelmente deveríamos ter tido duas horas, mas não consegui tempo para isto em minha agenda.

Fizemos um contato bastante bom de um certo tipo, no qual não fiz qualquer tentativa de chegar às questões práticas que são bastante importantes em seu caso. Provavelmente ela recebe muitos conselhos a respeito disso, de qualquer modo. Achei mais importantes deixar desenvolver-se entre nós um relacionamento em que a sua personalidade pudesse florescer, na medida em que fosse capaz de fazê-lo. Achei-a surpreendentemente bem-integrada. Tem um rosto bastante bom e ele mostra ser uma indicação precisa de como ela é. Talvez o que não tenha sido capaz de fazer é chegar ao seu ressentimento com a injustiça que é nascer com uma deformidade congênita. De quem se pode ter raiva?

Muito rapidamente cheguei à idéia do interesse dela em quadros por que estava olhando para os que se acham dependurados em minha parede. Dessa maneira, continuamos o nosso relacionamento em termos de desenhos, jogando a princípio um jogo como se ela fosse muito mais moça.

Como sabem, ela freqüenta uma escola de arte e, portanto, estava interessada na diferença entre ser ensinada a desenhar com exatidão e a liberdade de usar um lápis sobre papel com espontaneidade e nada a ver com desenhar bem. Juntos, chegamos a algumas coisas que tinham importância, inclusive um sonho assustador que, acredito, foi-lhe importante comunicar a alguém. Muito corretamente, contudo, ela defendeu os desenhos contra serem examinados para ver que idéias continham, porque o desenho, para ela, tem a ver com o prazer e a auto-expressão e não com o fornecimento de material para interpretação.

De momento, não preciso dizer-lhe nada mais a respeito desta paciente, porque não é isto o que estão querendo de mim. Para ter uma indicação referente a procedimentos futuros, acho que tenho de esperar para ver que tipo de efeito esta consulta teve sobre Hannah. Temos de esperar algumas semanas. Minha impressão imediata é de que Hannah não precisa de auxílio psiquiátrico e que pode dar conta sozinha.

Apesar disso, ela poderia gostar de continuar a visitar-me duas ou três vezes por ano, de maneira a haver alguém fora da família que esteja assistindo ao seu progresso, inteiramente à parte de seu progresso físico. Gostaria de deixar isso bastante no ar. Foi uma missão agradável ver Hannah, por causa de algo muito real que existe nela.

A Agência respondeu-me da seguinte maneira, após receber uma carta da mãe de Hannah:

A mãe disse que tentou dissuadir Hannah de ir vê-lo naquela noite de muita neve, mas Hannah insistiu em fazê-lo. Estava muito emocionada pelo fato de sua carta marcando a consulta haver sido enviada diretamente a ela. Sugeriu também a Hannah que não fosse trabalhar naquela manhã, mas que ficasse em casa até a hora de sair para a consulta, mas Hannah recusou isso. Recusou também considerar a sugestão da mãe para que mudasse as roupas para algo mais adequado que o seu velho casaco e calças compridas. Hannah replicou-lhe: “Bem, ele quer me ver como sou, não é, de maneira que vou assim”. Quando Hannah voltou para casa, após sua entrevista com o senhor, os pais perguntaram-lhe como se havia dado e ela respondeu: “Ele é bastante bom” e, depois, nada mais. A mãe disse que não havia pressionado Hannah porque a agência havia-a antecipadamente advertido que a moça poderia não querer dizer nada, mas que ficou muito espantada com a resposta dela, uma vez que sempre que Hannah fora ver um médico a respeito de suas condições físicas, depois fornecera à mãe um relatório praticamente literal do que ela dissera e do que o médico dissera! Desde que viu o senhor, Hannah não tem estado repisando a sua condição, como fizera antes. Entretanto, ainda insiste em usar calças compridas e recentemente recusou ir a um baile. Depreendi que a mãe tinha esperado que o senhor fosse fazer uso de uma varinha de condão!

Em resposta às perguntas da mãe, a assistente social disse-lhe que o senhor tinha gostado de conhecer Hannah, que estava pronto a vê-la de novo e que achara-a muito bem-integrada, considerando tudo por que passou. A mãe expressou uma certa ambivalência a respeito de Hannah vê-lo de novo, mas concordou que deveríamos falar sobre isso com a própria Hannah, quando ela estiver de férias.

Ficamos interessados em seus comentários a respeito do pai e da irmã. Durante o longo tempo em que conhecemos a família, sempre tivemos a impressão de que o pai fora muito empurrado para a periferia. A assistente social diz ainda que a irmã, que é cabelereira, acha-se também fora do quadro, com o relacionamento intenso sendo entre Hannah e a mãe.

Em minha resposta, escrevi:

Fico bastante satisfeito com a maneira pela qual Hannah relatou negativamente o que havia acontecido entre ela e eu. Odiaria pensar que a visita dela a mim fora apenas uma outra visita a um médico, como tantos que visitou a respeito de sua condição física. Tenho esperanças de que pressão nenhuma, de espécie alguma, seja aplicada a Hannah para que fale sobre o que houve, porque na realidade seria-lhe muito difícil relatá-lo, mesmo que quisesse fazê-lo. Eu próprio o esqueci, mas, se Hannah e eu estivéssemos sentados juntos no consultório, lembraria.

Acho que o importante foi que nos encontramos como duas pessoas e não como um médico e uma paciente com uma deformidade. Podem com toda a segurança deixar que seu relacionamento comigo se exaure. Em uma ocasião ou outra, é muito provável que ela diga que gostaria de me ver de novo, caso em que farei o possível para adaptar seu pedido à minha agenda. Pode ser que ela não precise me ver de novo; isso seria ainda mais satisfatório, indicando uma independência que acredito que ela possa conseguir, embora, naturalmente, com referência à sua deformidade, tenha de haver dependência quanto a habilidades cirúrgicas especializadas.

Algumas semanas mais tarde, recebi uma nova carta da Assistente Social:

Ao falar a respeito de Hannah, a mãe disse que ela agora fizera amizade com uma moça mais velha que freqüentara uma escola secundária e achava-se agora indo à

mesma escola de arte que Hannah freqüenta. Aparentemente, começara a fazer amizade com esta moça antes de ver o senhor, mas recusara-se a juntar-se a ela em quaisquer atividades fora de casa. Desde que Hannah o visitou, porém, começou a ir a uma igreja muito moderna com essa moça; o vigário dela é um homem moço que realiza o culto em um café e, em vez do tipo costumeiro de serviço religioso, mantém uma espécie de "Programa de Perguntas e Respostas", onde incentiva os jovens a fazerem tantas perguntas quantas quiserem. Hannah agora vai lá regularmente com essa moça e decidiu também freqüentar a escola noturna, que já começou, para ver se pode formar-se em matérias do G. C. E.*, tal como a amiga.

Após a mãe nos falar a respeito disto, ela interrompeu-se de repente e disse: "Bem, talvez isto tenha sido o resultado de ela ter ido ver o Dr. Winnicott, porque nunca teria feito este tipo de coisa no passado". Indagou-se então se deveria perguntar a Hannah se gostaria de ir vê-lo de novo, mas foi-lhe dito que seria melhor deixar isto a cargo de Hannah.

Seis meses mais tarde, foi-me enviado um relatório de acompanhamento:

Pensamos que o senhor gostaria de saber como Hannah está-se saindo. Nossa assistente social foi ver sua mãe na semana passada e ela nos disse que Hannah tivera uma melhora lenta e continuada desde que foi vê-lo no ano passado.

Começou agora a interessar-se por roupas e parou de usar calças compridas todo o tempo; está agora usando vestidos e uma saia. Usa também botas de cano comprido, mas naturalmente, elas se acham muito em moda. Foi também voluntariamente a uma escola técnica, a fim de prestar seus exames de G. C. E., de maneira a poder freqüentar o curso integral de arte em sua própria escola.

Continua a reunir-se com pessoas e a fazer amizades com adolescentes normais, e tem em verdade uma vida social muito cheia, o que se acha em grande contraste com a maneira pela qual costumava esconder-se em casa e recusar-se a encontrar outras pessoas jovens. Mostra-se alegre e à vontade, e não mais resmunga continuamente a respeito de suas condições.

Em um acompanhamento final (dois anos mais tarde) foi-me informado:

Sei de uma coisa de que Hannah parece ter-se beneficiado consideravelmente pela visita que fez ao senhor. Fala com freqüência a seu respeito e tem parecido muito mais confiante desde aquela época. Hannah parece ter falado particularmente à mãe sobre os desenhos que o senhor a fez traçar e parece também ter estado fazendo a sua própria interpretação!

O desfecho favorável não precisa ser um resultado direto da consulta, embora se possa razoavelmente reivindicar que nenhum dano seguiu-se ao trabalho que fizemos e não fizemos juntos nesse único contato profissional.

A inferência importante é que, embora o estado físico desta jovem tenha permanecido deplorável e feio e continuasse a exigir interferência ortopédica do tipo remediável, a atitude de Hannah para com sua incapacidade mudou, de maneira que sua personalidade pôde avançar em seus processos desenvolvimentais que haviam sido seriamente detidos.

Fator importante foi a cooperação fácil da mãe, que não precisou ser vista por mim, e tampouco se precisou dizer-lhe o que fazer ou que atitude adotar.

O aspecto essencial, segundo me parece, foi que a moça sentiu-se amada e aceita como o fora antes de ser bastante bruscamente forçada a reconhecer que sofria de uma incapacidade física congênita que era ao mesmo tempo aleijante e feia.

* *General Certificate of Education*, Certificado Geral de Educação, fornecido a estudantes de escolas secundárias na Inglaterra e no País de Gales, que para consegui-lo se submetem a um exame. (N. do T.)

Mollie, Oito Anos de Idade

O outro caso é o de Mollie, uma menina de oito anos. Ela fora adotada com a idade de um ano por uma boa família onde já existia outra menina de três anos. Desde a adoção nasceu um menino, que conta agora três anos.

Os pais adotivos não se deram conta, durante um ano ou dois, que haviam recebido uma criança muito inquieta, seriamente afetada pelas constantes mudanças de manejo que caracterizaram-lhe o primeiro ano de vida.

Toda a família amou Mollie e aceitou-a inteiramente, mas não se podia negar que sua constante perseguição ao irmão pequeno estava tendo um efeito adverso sobre a personalidade em desenvolvimento dele.

A mãe consultara uma Clínica de Orientação Infantil e fora-lhe dito que deveria procurar um lugar para Mollie que não fosse a sua casa: uma escola interna ou uma adoção alternativa. A mãe achou isto errado e consultou-me a fim de saber a minha reação à proposta, que a horrorizara. A mudança poderia ajudar seu garotinho, mas terminaria com toda esperança de levar a inquieta Mollie a alguma forma de integração social.

Na consulta terapêutica comigo aconteceu muita coisa que tem de ser omitida. Houve fases difíceis, por causa da extrema inquietação de Mollie.

O que desejo relatar é a inesperada virada de acontecimentos que sucedeu após havermos estado jogando o jogo do rabisco por cerca de uma hora. Mollie evidentemente ganhara confiança e repentinamente introduziu um novo tema. Tinha a ver com o fato de ela ter vindo a perceber que tem pele escura (seus pais reais sendo etnologicamente africanos), enquanto que a família que a adotara era inglesa e de pele clara.

É necessário pensar em Mollie como uma criança que tinha grande dificuldade em deixar a mãe ir para a sala de espera e que estava constantemente se reafirmando em relação a ela, dando-lhe um beijo ou um abraço afetuoso e, de modo geral, demonstrando um amor genuíno pela mãe, ainda que fosse clinicamente exagerado pela ansiedade.

Havíamos chegado ao desenho nº 19 de nosso jogo, e ele era de três porcos, o pai, a mãe e o bebê. Ela pôde me informar que as crianças da escola haviam-lhe gritado, da maneira que as crianças fazem: "Porca adotada".

Repentinamente, ela pegou o jogo nas mãos e disse: "Vou desenhar o meu traseiro". O desenho nº 20 era o desenho de seu traseiro, a princípio limpo e sem marcas. Quase imediatamente ela fez marcas agressivas de lápis sobre as nádegas. Sua verbalização foi: "Oh, como eu queria ser branca" (tal como o menino a quem persegue).

Poder-se-ia ter pensado que ela estava fornecendo um quadro de incontinência, mas eu sabia que esta não era a interpretação correta. Mollie estava ilustrando o denegrecimento. Em sua mente, a idéia de porco levava à de comer e à fantasia canibalística, e ela rapidamente tornou não-atraentes as nádegas. Em outras palavras, ela as transformara em porcos maus, porcos que ninguém queria comer.

Tive de ser muito rápido para fazer uso desta comunicação inesperada, porque Mollie parecia ter apenas a mais tênue esperança de que seria entendida, e, certamente, com sua mente consciente, não tinha idéia do que estava me dizendo e ilustrando.

Disse-lhe: "Você desenhou as maçãs do rosto de sua mãe, e, ao mesmo tempo, os dois seios. Os bebês brancos e a mãe branca querem comer um ao outro e isso significa que se amam. Surgem então medos a respeito de comer e ser comido e as coisas boas têm de ser estragadas, se não se quer que sejam destruídas. Mas primeiro vem o comer, o canibalismo e a destruição".

Enquanto continuava a desenhar, ela disse: "Sim, sou escura, mas gosto mais de branco". O desenho nº 21 foi de um corpo de mãe e uma mistura de destruição de seios com um denegrecimento do corpo como defesa, mas com o sacrifício da qualidade imaculada. Para ela, por ser de pele escura, o branco é uma idealização; para as

crianças brancas, porém, o branco é uma fase inicial e inteiramente natural, e ela se sente privada dessa fase, como se tivesse de começar com uma desvantagem.

Ela estava lutando para enfrentar o que apenas gradualmente viera a descobrir a respeito de si. Sua família aceitava-a inteiramente como era, e de fato era muito bela, apropriadamente à idade, com uma pele perfeita.

Como se para mostrar que conhecia aquilo que havia sido privada, desenhou o de nº 22, que a mostrava a dar um pontapé na mãe. Disse: "Dei um pontapé em mamãe". Aqui, ficou ansiosa e correu ao encontro da mãe, a fim de restabelecer o relacionamento afetuosos.

Houve algumas referências oblíquas a temas laterais sexuais: o traseiro do pai; meu divã fez-la pensar em um médico a visitá-la ou ao pai, e provavelmente (adivinha!) havia visto o pai sendo injetado com penicilina na nádega, durante uma doença. Além disso, o lápis que estava usando tinha uma tampa e ela tirou esta de sua ponta e disse que estava tirando as calças dele. Falou a respeito de um traseiro nu. Havia aqui muita coisa que poderia ser acompanhada, quer em outras sessões de tratamento, quer em conversas com a mãe. Sem embargo, eu sabia que estávamos lidando com os mesmos fatores dinâmicos que fazem moças adolescentes com anorexia nervosa desenharem retratos de mulheres belas, mas com os rostos cobertos de manchas. As mesmas considerações teóricas têm de ser aplicadas para explicar a acne da adolescência. O conflito se dá na área do denegrecimento como defesa, e a brancura ou a luminosidade como expressão de idealização, exceto na medida em que possa ser uma experiência que é adequadamente elaborada nos estágios iniciais do desenvolvimento individual, quando a criança vive em um mundo subjetivo e logo antes de o objeto ter sido tornado externo por ser chutado, mordido, rasgado ou de alguma maneira estragado.

Mollie estava tentando explicar o efeito especial que sua descoberta de que tinha pele escura estava tendo sobre ela, fazendo-a sentir-se como se houvesse sido privada de um aspecto essencial do desenvolvimento da personalidade e da auto-realização muito iniciais.

Ela aceita sua condição, mas sente-se tolhida por ter de residir em uma pele escura, não por causa do que agora parece, mas por causa do que significaria em termos dos estágios mais iniciais da experiência.

38

Individuação

*Palestra proferida para o Departamento Médico
da Sociedade Psicológica Britânica, em outubro de 1970*

Nunca gostei desta palavra e nunca a uso. Minha aceitação deste convite para falar em um simpósio tem a ver com a idéia que sempre trago comigo, qual seja, a de que poderia aprender algo.

Uma olhada no *Oxford Dictionary* me mostra que a palavra tem sido aceita como respeitável por 300 anos, pelo menos, e que tem sido usada em debates filosóficos. Apesar disso, não consigo render-me a ela, talvez por razões infantis: há a raiz até o "d" de "individ", inclusive, e então, se se vai em frente e usa-se o "u", sinto que se deveria prosseguir da maneira ordinária, para produzir "individualização", cf. "civilização" e "civilização". Na língua alemã, é claro, o termo junguiano pode fazer sentido.

O que vocês querem de mim não é filosofia, mas um enunciado da maneira pela qual um indivíduo se torna um indivíduo, se é que chega a tal estágio.

Estamos falando a respeito dos processos maturacionais herdados do bebê e da criança, e de um reconhecimento de que estes processos não fazem progredir um menino ou uma menina, exceto na medida em que um meio ambiente facilitador impera, e um enunciado do meio ambiente facilitador e de suas qualidades essenciais leva-nos a território interessante, mas complexo e difícil. Escrevi a respeito disto tudo em minha própria língua e não tenho dúvidas de que algumas das palavras que uso em meus textos irritam vocês tanto quanto eu próprio me sinto irritado por esta palavra que se acha em exame. Não estamos discutindo uma palavra, mas um processo desenvolvimental. Direi imediatamente que acho que Jung chamou de modo útil a nossa atenção para o fato de que os seres humanos, exceto na medida em que se acham apanhados na rigidez de suas próprias defesas, continuam a crescer em todos os sentidos, até o momento da morte. O enunciado freudiano, por algumas décadas, pode ter parecido dar a impressão de que qualquer desenvolvimento que não tenha ocorrido até a idade de cinco anos, ou ao final da puberdade, quando o rapaz ou a moça passam da adolescência para o estado adulto, não ocorrerá mais de modo algum. Mas todos nós sabemos que isto é absurdo.

O bebê (menino ou menina) herda um processo desenvolvimental. Para descrever o que acontecem temos de saber não apenas a respeito desse processo, mas também sobre a provisão ambiental. Qualquer tentativa de descrever um bebê em desenvolvimento *sui generis* e *ipso facto* tem de fracassar. Se somos sábios, não tentamos.

Obviamente, o meio ambiente tem de possuir certas qualidades básicas. Um ser humano tem de achar-se lá, em algum lugar, e não acreditamos no mito de Rômulo e Remo porque uma loba simplesmente não tem o aparelhamento mental para identificar-se com um bebê humano.

Temo que possam estar familiarizados demais com o que se segue, seja qual for a linguagem que utilizemos. Aqui está o meu enunciado.

O bebê a princípio vive em um mundo subjetivo. Ele existe precariamente e na dependência da figura materna humana. Aqui, e em nenhum outro lugar, há uma experiência de onipotência. Alhures, onipotência é o nome que se dá a um sentimento ou a um delírio, mas no início teórico, o bebê vive desperto em um mundo onírico. O que se acha lá quando ele está acordado torna-se material para sonhos. Mais tarde, a alternância de adormecido e desperto deve tornar-se nítida e o mundo do bebê deixa de ser um mundo subjetivo.

Pensando a respeito da criança a caminho da objetividade (o encontro com o Princípio da Realidade), a natureza concede ao bebê uma posição intermediária, como claramente se mostra nos casos em que o bebê emprega um objeto de transição. A natureza concede isto, mas nós temos de fornecê-lo. Um objeto desse tipo representa, a um só e ao mesmo tempo, o bebê e a mãe. É ambos, embora não seja nenhum deles. Desta maneira, a vida é uma pirâmide invertida e o ponto sobre o qual ela repousa é um *paradoxo*. O paradoxo exige aceitação como tal e não precisa ser resolvido. Isto é loucura permitida, uma loucura que existe dentro do arcabouço de sanidade. Qualquer outra loucura é uma amolação, uma enfermidade.

Dessa maneira, a passagem do tempo, juntamente com a acumulação de uma experiência pessoal, contribui para as condições que são essenciais para que o processo herdado de crescimento conduza o menino ou a menina através de, ou para uma existência separada, uma existência que possa ser livre da fusão, mas ainda assim, permitir a reexperiência de estar "fundido com" (depois chamada de regressão).

Estamos admitindo um período de tempo, semanas, meses, anos, e esperando uma segunda oportunidade, de maneira que as experiências principais possam ser reencenadas pela criança em sua própria casa durante a adolescência. Se as primeiras tiveram realidade, é mais provável que as segundas a tenham também.

Mas a pré-condição é clara. Tem a ver com a mãe, e os dois pais juntos, a família, a família ampla e o ambiente social local, inclusive a escola, e assim por diante.

Para chegar-se ao aspecto essencial é necessário examinar-se a mãe ou figura materna. Dela é necessário, no começo, um estado especial a que mais uma vez apliquei o meu próprio termo descritivo. Chamo-o de "preocupação materna primária", um estado de coisas em que a mulher foi capaz de se permitir tornar-se temporariamente orientada para o bebê que ela gradualmente reconhece como um fato dentro de sua estrutura física. Ela conseguiu pôr de lado, temporariamente, suas auto-identificações masculinas, e foi ajudada pelo aparelho endócrino e por suas próprias experiências como bebê. Com determinado bebê, isso progride naturalmente, com outro o mecanismo range ou enguiça. É uma questão de saúde psiquiátrica na mãe saber ela que a identificação materna é temporária e que, com o tempo, dela vai se recobrar. A mãe é afetada por sua experiência total em seu relacionamento com o homem, que temporariamente lhe empresta o seu *self* feminino.

O bebê, menino ou menina, que se desenvolve em um ambiente que este tipo de mãe pode proporcionar, consegue viver durante um período suficiente em um mundo subjetivo no qual o mundo da realidade externa não incide. Nele desenvolve-se no bebê um senso de predizibilidade, e, desta maneira, as funções dos estágios iniciais muito delicados do crescimento da personalidade podem ser assentadas. Uma linha de vida que é pessoal começa a ser uma característica. Profilaxia, no contexto da saúde mental, é a provisão de uma facilitação suficientemente boa neste estágio inicial.

Tudo isto soa como inacreditavelmente complexo, mas para um grupo como o presente, qualquer enunciado simplificado deve parecer insatisfatório ou, até mesmo, um insulto à inteligência.

A coisa principal com que o iniciante tem de se acostumar é que, embora todo menino ou menina nascidos vivos neste mundo tenha, como se poderia dizer, um bastão de primeiro-ministro em sua fraldinha, este bastão pode permanecer sendo algo que poderia ter sido. Pode tornar-se um talento oculto, com o menino ou a menina individuais escondidos em uma estrutura falsa, uma personalidade falsa baseada na submissão e em ser bom. Ser bom desta maneira constitui um distúrbio de caráter.

Nenhuma descrição destas questões, por muito aparada que seja para ajustar-se ao Princípio da Realidade que é um relógio, pode omitir referência ao lugar da agressão. Permitam-me dizer que nunca podemos ir muito longe em nosso exame do tema da agressão se não pudermos perceber o seu valor positivo. Uma das maneiras de perceber isto é assistir à criança tornar-se separada da mãe e do meio ambiente, de modo geral. É axiomático que não exista relacionamento com um objeto subjetivo. O mundo acha-se lá, para com ele serem estabelecidas relações, apenas na medida em que é objetivamente percebido e é aquilo que chamamos de externo à criança. O mundo externo pode ser ingerido, introjetado ou incorporado, isto é, comido, pelo processo mental.

O que estou tentando dizer é que não podemos chegar a parte alguma em nosso estudo da agressão se, em nossas mentes, temos a agressão como irrevogavelmente vinculada ao ciúme, à inveja, à raiva pela frustração, ao funcionamento dos instintos que chamamos de sádicos. Mais aproximadamente básico é o conceito de agressão como parte do exercício *que pode conduzir à descoberta de objetos que são externos*. Mostro um desenho de criança que é comum, mas se estivessem estado lá, saberiam que ele representou um clímax de aventura na situação de confiança de uma consulta terapêutica em que a meninazinha separou-se de uma dependência clínica pesadamente carregada quanto à mãe. Houve muitas manifestações afetuosas que pareciam genuínas e, durante alguns segundos, a menina (de oito anos de idade) colocou a mãe *do lado de lá*, por chutá-la. Naturalmente, ficou assustada e precisou rapidamente restabelecer a mãe como disponível, acessível e responsiva sem vingança.

Verão o que quero dizer, e permitirão a supersimplificação, se eu me referir à maneira pela qual um dentre dois mundos está esperando por cada criança, e que faz toda a diferença aquele em que vocês e eu nascemos.

Um: um bebê dá um chute no seio da mãe. Ela fica satisfeita por seu bebê estar vivo e dando pontapés, embora talvez doa e ela não se permita ser machucada por brincadeira. Dois: um bebê chuta o seio da mãe, mas esta mãe tem a idéia fixa de que golpes no seio causam câncer. Ela reage, porque não aprova o pontapé e isto sobrepõe-se ao que quer que o chute possa significar para o bebê. A criança defrontou-se com uma atitude moralista e dar pontapés não pode ser explorado como maneira de situar o mundo ao qual ele pertence, que é o lado de fora.

É agora impossível para o menino ou para a menina sentirem-se preocupados, porque o código moral da mãe ergueu-se como um bloqueio ao crescimento natural no bebê de um senso de certo e errado, e de culpa e pesar.

Estes dois mundos são tão diferentes como água e azeite. Qualquer debate da "posição paranóide" em cultura pura é fútil, a menos que a provisão ambiental seja primeiramente avaliada e admitida.

Quando a externalidade foi estabelecida na classificação que o bebê faz do caos potencial da vida, acha-se pronto o caminho para um enriquecimento pessoal que não possui limites, baseado na experiência pessoal e fazendo uso dos mecanismos mentais que são usualmente chamados de projeção e introjeção. Juntamente com o crescimento

da vida imaginativa mental, isto faz a criança partir para uma vida de inter-relacionamento que é feita desde a base real de uma existência pessoal.

Um enunciado como este que tentei fazer poderia ser construído em termos de anormalidade em variados estágios, ocasionada pelas distorções ambientais que tornam a linha pessoal da vida uma coisa fragmentada.

É mais fácil, admito, concentrar-se na maneira pela qual a vida vai quando vai bem, quando o bebê, a criança, o adolescente e o adulto acham ser a vida uma experiência pessoal, não uma série organizada de reações à patologia ambiental.

Quando cada menino ou menina está vivendo a sua própria vida, ainda que imaginativamente envolvidos com outras pessoas, com o outro sexo e com a sociedade, podemos então ver que crescimento significa simplesmente vida e viver, e que não há final para a vida, exceto a morte. Estamos interessados aqui no senso de realização, mas se eu me realizo, tenho de lembrar que subi até aqui sobre os corpos mortos dos meus amigos que morreram lutando, ou a quem o acidente ou a doença permitiu-lhes apenas se realizarem em termos de seus semelhantes que aconteceu viveram por tempo suficientemente longo.

Mas suponho que, até certo ponto, sempre resta a tarefa de o indivíduo tornar-se cada vez mais independente, ainda que mantendo o buraco para ele rastejar de volta. E, dessa maneira, pode haver uma aplicabilidade de vida inteira para uma expressão tal como individualização (ou mesmo individuação).

P A R T E 2

**Psicoterapia Psicanalítica
com Crianças e Adolescentes**

39

Clínica Particular

*Artigo apresentado à conferência anual da
Sociedade Psicológica Britânica, Durham, 17 de abril de 1955*

É provavelmente verdade dizer que médicos e psiquiatras são ariscos no fornecimento de uma descrição de sua clínica particular. Se o trabalho é bom, parece publicidade, e, se é mau — bem, isso é mau para a reputação. Aprovo a modéstia implicada nessa reticência. Apesar disso, parece-me que a clínica particular acha-se em declínio, mas contudo, ela apresenta pontos em seu favor. Gostaria de ver a clínica privada ser comparada com a clínica ambulatorial e tenho confiança de que cada uma delas tem algo a oferecer à outra. Acredito que seria uma tragédia se a clínica particular, na psiquiatria infantil, viesse a desaparecer.

Nesta contribuição forneço-lhes todos os 54 casos que se me apresentaram na clínica particular em 1953. (Excluí os que chegaram no ano anterior ou nos dois últimos, e que podem estar aguardando entrevistas subseqüentes). A minha clínica é principalmente psicanalítica e decidi não descrever aquilo que ocupa a maior parte de minhas horas de trabalho. Tenho também a minha clínica no *Paddington Green Children's Hospital*, baseada na prática médica ambulatorial.

Esta meia centena de casos que se espremem em minha clínica a cada ano simplesmente surgem por causa da lei das proporções (refletem uma média).

Escolhi o ano de 1953 por achar-se suficientemente próximo, de maneira que me recordo claramente de cada caso, e também por situar-se suficientemente afastado para que um acompanhamento tenha valor. Em quase todos os casos descubro que posso conseguir um relatório recente.

Minha asserção é que a clínica particular proporciona um *método psiquiátrico econômico*. Há certos casos que precisam de uma clínica ambulatorial para administração e investigação completa e isto se revela especialmente verdadeiro quando é necessário um relatório para os magistrados de uma Corte Juvenil. Um psiquiatra que trabalhe em caráter particular dificilmente pode passar sem uma clínica e nada do que digo ou recomendo anula o valor das clínicas, de um tipo e de outro. Apesar disso, se os resultados pudessem ser comparados, então acho que, em termos de homens-horas, a clínica particular tem muito a dizer em seu favor.

Estou tentando espalhar os resultados do trabalho de um ano, de maneira a que possam julgar comparando-os com os das clínicas normais. Primeiro, porém, deixem-me fazer o seguinte comentário: a clínica particular é trabalho de equipe, consistindo

esta no psiquiatra e sua secretária. Não seria possível fazer este trabalho sem uma secretária que seja capaz de nele tomar parte, um trabalho que até certo grau é íntimo, e que é tornado seguro e produtivo apenas por ser mantido estritamente dentro do arcabouço do relacionamento profissional.

A equipe é pequena e, no interesse da descrição simples, não continuarei a referir-me a ela como tal. Em contraste, a clínica, para seu valor, depende do trabalho de uma equipe e uma das tarefas principais do psiquiatra clínico é a integração das informações coletadas.

Os 54 casos mencionados envolveram cerca de 100 homens-horas (mais o trabalho feito pela secretária). Acho que isto se compara de modo muito favorável com o trabalho que é feito em uma clínica, desde que os resultados sejam igualmente satisfatórios.

Em alguns poucos casos foi preciso um Q. I., ou ele foi efetuado por questão de interesse.

O corpo principal de minha comunicação é a minha tentativa de apresentar os 54 casos sob forma inteligível. Poder-se-á dizer que o trabalho foi efetuado no consultório e estou agora meramente interessado em referir-me a ele de maneira ordenada.

Decidi classificar os casos de acordo com o tipo de problema com que tive que lidar, antes que pelos diagnósticos psiquiátricos pessoais das crianças. Isto inevitavelmente envolve muita sobreposição parcial e, em alguns casos, a classificação tem de permanecer sendo arbitrária.

Para tornar-me claro de forma gráfica, cerquei cada número de caso com um quadrado, se acho que os pais obtiveram aquilo que vieram buscar. Utilizei aqui a palavra "proveitoso", mas o sucesso depende do padrão que se espera. Exemplificando, "sucesso" quando foi consultado a respeito de um estado psicótico significa simplesmente que lidei com a administração do caso ou expliquei o problema e a tarefa aos pais. Onde simplesmente me pediram conselho, utilizei o quadrado para indicar que o resultado foi satisfatório para os pais. No outro extremo acham-se as crianças que tinham *sintomas tratáveis*, inclusive os 13 da categoria H, e, aqui, meço o sucesso apenas em termos de cura clínica. É apenas aqui nesta categoria que a clínica particular ganha, acredito, por ser tão eficaz quanto a prática que se pode efetuar em uma clínica, e todas as questões laterais serem evitadas. A criança precisa de uma entrevista psicoterapêutica pessoal altamente especializada e até mesmo em uma clínica tem-se de fornecer isso, para que o caso não esteja destinado ao fracasso.

Considerações Gerais

Existem vários detalhes que podem ser apresentados para debate:

1. Na prática particular o psiquiatra tem o caso inteiro e assume responsabilidade integral. Quando isto pode ser mantido, o resultado é bom. A única desvantagem é que o médico, na clínica particular, sempre está com um frio no estômago; um dos casos acha-se sempre em uma fase difícil e é questão de sorte que vários casos não estourem ao mesmo tempo. Eu diria que, na prática de clínica, evita-se o frio no estômago de modo fácil demais: talvez a assistente social psiquiátrica goste dessa função.

2. Na clínica particular, é fácil ver os pais, a enfermeira, o clínico geral, a professora, quem quer que esteja interessado. Também se pode ver a criança primeiro, ou, então, pode-se ver os pais a sós e aconselhá-los a não trazerem a criança. Muita coisa se faz por telefone e lucra-se com o fato de os pais dos pacientes particulares terem o hábito de telefonar, e poderem fazer mais por telefone do que simplesmente marcar consultas. Às vezes pode-se evitar pacientes inteiramente por este meio, de maneira que eles nunca aparecem e poupam para si dinheiro e, para nós, tempo.

3. Com frequência é difícil, em trabalho de equipe, *iniciar a ação no momento correto*, na direção certa e desde o lado acertado. Na clínica particular, a única pessoa que é inteiramente responsável pode agir até mesmo em reação a um impulso, até mesmo no limiar da porta, enquanto a mãe e o filho entram na casa. Sugiro não ser incomum na prática das clínicas que uma manobra simples seja perdida por causa da complexidade da situação, ainda que essa manobra houvesse servido ao caso. Com frequência assistentes sociais psiquiátricas declararam que tiveram de perder oportunidades para agir por estarem coletando informações para a conferência sobre o caso, e não se achavam em posição de agir, ainda que soubessem que deviam fazê-lo.

4. Não há lista de espera na clínica particular, e isto é bom. Os casos apenas desfilam e, se não se pode encaixar um deles, ele é encaminhado a um colega.

Na realidade, em minha clínica não tive lista de espera, porque a clínica funciona dentro do arcabouço de um departamento ambulatorial médico comum, e quem quer que desejasse ver-me poderia fazê-lo na clínica ambulatorial, simplesmente esperando algumas horas em um banco duro, na manhã apropriada. Reconhece-se de modo geral que listas de espera são ruins em psiquiatria; o resultado delas é que os casos comuns que podem ser ajudados nunca chegam ao psiquiatra ou à equipe, e as crianças psicóticas e os delinquentes reivindicam atenção. É o caso comum que pode realmente ser ajudado, aquele que vai dar no departamento ambulatorial médico.

5. É indubitável que na clínica particular recebe-se o tipo de caso em que os pais são capazes de assumir uma parte responsável na busca da escola correta. Neste trabalho, muita coisa é feita pela colocação cuidadosa em escolas especiais e públicas, inteiramente à parte do diagnóstico de má-adaptação. É surpreendente o número de escolas para crianças normais que estão dispostas a aceitar algumas crianças que apresentam anormalidades tais como Q. I. baixo, complexo de "criança carente", um certo grau de psicose e distúrbios neuróticos (inclusive enurese). Isto não é coisa nova e eu próprio posso lembrar que em minhas duas escolas tínhamos um certo número do que hoje eu chamaria de casos psiquiátricos.

Estas são as idéias lançadas para debate, mas a questão principal gira em torno das duas perguntas: (1) são os resultados da clínica particular suficientemente bons? e, se forem, (2) existe uma vantagem em termos de homens-horas?

Se a clínica particular é boa e econômica, sugiro então que ela é boa para o psiquiatra, pelo fato de, podendo ser capaz de depender apenas de si, ele pode trabalhar melhor que na clínica ambulatorial com a equipe.

Particularmente, sugiro que as crianças que se saem melhor na clínica particular são aquelas que podem ser ajudadas de modo rápido e profundo pela consulta psicoterapêutica.

Clínica particular, 1953, 54 casos, 41 do sexo masculino e 13 do sexo feminino, que tomaram 100 horas. Números em reverso e sublinhados:

41 resultados proveitosos (reverso); 13 não-proveitosos (sublinhados).

A.	<i>Dominância de enfermidade psiquiátrica nos pais</i>	1.	<i>Dominância da enfermidade do pai</i>	2.	<i>Dominância da enfermidade da mãe</i>	3.	<i>Enfermidade psiquiátrica em ambos os pais</i>
		<u>3</u>	♂ 9 anos — 3 horas	<u>1</u>	♀ 20 meses — 1 hora	<u>14</u>	♂ 8 anos — 1 hora
			Dificuldades de escrita		Mãe não consegue brincar	<u>20</u>	Pai aconselhou terapia
		<u>4</u>	♀ 5 anos — 2 horas	<u>15</u>	♂ 10 anos — 1 hora	<u>22</u>	Pais inquietos
12	casos		Pai paranóide		Mãe não consegue cooperar		♂ 16 anos — 1 hora
5	proveitosos		Discute o tratamento	<u>35</u>	♂ 2 anos — 1 hora		Lar complexo
23	horas		dado pela ex-esposa à filha		Acessos de cólera		(Atualmente em hospital psiquiátrico)
				<u>36</u>	Mãe esquizóide	<u>24</u>	♂ 8 anos — 2 horas
					Inquietação		Controle excessivo dos pais
				<u>41</u>	Mãe caótica		(Nenhum efeito direto)
					♂ 11 anos — 1 hora	<u>38</u>	♂ 12 anos — 2 horas
					Enurese, etc.		Lar em rompimento
					Mãe em conflito de lealdades		
B.	<i>Casos antigos, novos problemas</i>	<u>18</u>	♀ 27 anos — 1 hora	<u>34</u>	♂ 19 anos — 1 hora		
2	casos		Psicanálise por D. W. W. dos 10-13 anos, por psicose		Insubmisso do exército (homossexual conhecido)		
1	proveitoso						
2	horas						
C.	<i>Aves de passagem</i>	<u>21</u>	♂ 8 anos — 2 horas	<u>33</u>	♀ 8 — 1 hora		
8	casos		Fazendo psicoterapia		Anorexia		
7	proveitosos	<u>26</u>	♂ 18 anos — 2 horas		Psicoterapia combinada		
12	horas		Ajudado a sair do exército	<u>40</u>	♀ 5 anos — 1 hora		
			Fazendo psicanálise		Fazendo psicanálise		
		<u>28</u>	♂ 4 anos — 3 horas		Psicanálise interrompida		
			Fazendo psicoterapia	<u>46</u>	♀ 5 anos — 1 hora		
		<u>30</u>	♂ 10 anos — 1 hora		Psicanálise combinada		
			Psicanálise combinada (sem sucesso, precisava nova análise)	<u>51</u>	♀ 14 anos — 1 hora		
					Fazendo psicoterapia		
					Encaminhada para diagnóstico e apoio		
D.	<i>Busca de orientação</i>	<u>7</u>	♂ 8 anos — 2 horas	<u>49</u>	♀ 3 anos — 1 hora		
7	casos		Segredo da mãe		Problemas "espásticos"		
6	proveitosos	<u>37</u>	♂ 9 anos — 1 hora	<u>50</u>	♀ 3 anos — 2 horas		
13	horas		Ambições dos pais		Mãe sem informações		
		<u>43</u>	♂ 7 anos — 1 hora	<u>54</u>	♂ 6 anos — 1 hora		
			Pai sem informações		Eczema — asma		
		<u>45</u>	♂ 12 anos — 5 horas				
			Morte do pai				

(continua...)

E.	<i>Dominância de Q. I. baixo</i>	1.		2.	<i>Mentalmente deficientes</i>
		2	♂ 13 anos — 3 horas	11	♂ 10 anos — 1 hora
			Encontrada escola		Culpa dos pais apaziguada
		19	♂ 6 anos — 1 hora	13	♂ 4 anos — 1 hora
5	proveitosos		Caso neurológico		Caso neurológico
8	horas		Encontrada escola		
		47	♂ 7 anos — 2 horas		
			Atitude dos pais corrigida		
F.	<i>Psicose infantil</i>	1.	<i>Maníaco-depressivos</i>	2.	<i>Esquizóides</i>
5	casos	10	♂ 16 anos — 1 hora	52	♂ 12 anos — 5 horas
3	proveitosos		Endócrino: acessos		Defeito secundário (situado)
13	horas	17	♀ 15 anos — 1 hora	53	♂ 7 anos — 1 hora
			Conhecida desde os 3 anos		Defeito secundário
			Psicanálise impedida pela mãe		Psicoterapia (cobertura médica)
		39	♂ 17 anos — 5 horas		
			Mãe responsável por acidente: mentalmente deficiente, acessos		
G.	<i>Complexo de "carente"</i>	5	♂ 16 anos — 1 hora	27	♂ 12 anos — 3 horas
2	casos		Psicanálise contra-indicada		Aconselhado contra a psicanálise quando em casa
1	proveitoso		(Mãe fazendo psicanálise)		(Mas a psicanálise foi bem-sucedida)
4	horas				
H.	<i>Problemas infantis pessoais tratáveis</i>	1.	<i>Psicossomático</i>	2.	<i>Puberdade</i>
13	casos	6	♂ 8 anos — 1 hora	8	♂ 11 anos — 2 horas
13	proveitosos		Cólica (apêndice?)		Ansiedades paranóides
24	horas	42	♀ 8 anos — 2 horas	31	♀ 14 anos — 1 hora
			Colite grave		Sistema paranóide
			Psicanálise contínua		
		3.	<i>Escola</i>	4.	<i>Conversão histérica</i>
		9	♂ 12 anos — 1 hora	14	♀ 14 anos — 2 horas
			Defesa masoquista		Paresia incapacitante
		12	♂ 15 anos — 1 hora	23	♀ 15 anos — 2 horas
			Choque pai-filho		Vômitos pela manhã
		29	♀ 11 anos — 1 hora	32	♂ 9 anos — 3 horas
			Inveja dos homens		Tique laringiano, compulsões (Depressão da mãe)
		44	♂ 15 anos — 2 horas		
			Choque pai-filho	5.	<i>Ansiedade</i>
				25	♂ 11 anos — 1 hora
					Reação à doença física da mãe
				28	♂ 8 anos — 5 horas
					Gêmeo hipersensitivo
					Ansiedade paranóide
					Compulsão homossexual

40

O Jogo do Rabisco [*Squiggle Game*]

Amálgama de dois trabalhos: um, não-publicado, escrito em 1964, e outro, publicado em 1968¹

Na minha prática da psiquiatria infantil descobri que um lugar especial tem de ser concedido à primeira entrevista, e gradualmente desenvolvi uma técnica para explorar por completo o material dessa entrevista. A fim de distinguir este trabalho da psicoterapia e da psicanálise utilizo a expressão "consulta psicoterapêutica". Trata-se de uma entrevista diagnóstica, baseada na teoria de que não se pode fazer nenhum diagnóstico em psiquiatria, exceto após o teste da terapia.

A base para este trabalho especializado é a teoria de que um paciente, criança o adulto, terá para a primeira entrevista uma certa capacidade de *acreditar* na obtenção de auxílio e de confiar naquele que o oferece. O que se necessita deste último é um *setting* estritamente profissional, no qual o paciente fique livre para explorar a oportunidade excepcional que a consulta proporciona para a comunicação. A comunicação do paciente com o psiquiatra referir-se-á às tendências emocionais específicas que têm forma atual e raízes que remontam ao passado ou se entranham profundamente na estrutura da personalidade do paciente e de sua realidade interior pessoal.

Neste trabalho, o consultor ou especialista não precisa tanto ser arguto quanto capaz de proporcionar um relacionamento humano natural e de livre movimentação dentro do *setting* profissional, enquanto que o paciente gradualmente se *surpreende* com a produção de idéias e sentimentos que não estiveram anteriormente integrados na personalidade total. Talvez o principal trabalho que se faz seja da natureza da integração, tornada possível pelo apoio no relacionamento humano, mas profissional — uma forma de sustentação [*holding*].

Embora ocorram oportunidades para comentários interpretativos, estes podem ser mantidos em um mínimo ou, em verdade, deliberadamente excluídos. Desta maneira, terapeutas adequadamente selecionados podem efetuar este trabalho enquanto se acham em processo de aprender como fazer uma psicoterapia que inclua uma interpretação verbalizada. As recompensas provindas deste trabalho são grandes, porque o terapeuta fica capaz de desta maneira aprender do paciente, e lhe é necessário estar pronto para aprender, antes que ávido por saltar sobre o material com

1. Publicado em *Voices: The Art and Science of Psychotherapy*, 4, nº 1 (1968).

interpretações. Na seleção dos terapeutas, tal como na escolha dos psicoterapeutas em geral, aqueles que se mostram ávidos por saltar sobre o material por via da interpretação devem ser considerados como temperamentalmente inadequados para a prática psicoterapêutica, e isto se mostra particularmente verdadeiro quanto à adequabilidade de conduzir consultas terapêuticas.

Ao efetuar este trabalho que chamo de "consulta terapêutica" com uma criança (ou um adulto, também), é necessário ser capaz de utilizar lucrativamente o tempo limitado e ter técnicas já prontas, por flexíveis que possam ser. Tem de se presumir que, em muitos destes casos, o que não é feito durante esta consulta não será feito de modo algum. A primeira consulta pode ser reduplicada, mas, se a criança necessita ver o terapeuta diversas vezes, então o caso já está se transformando em um caso no qual o trabalho de equipe da clínica está se tornando necessário e, muito possivelmente, precisar-se-á passar a criança à frente, para tratamento em psicoterapia de longo prazo.

É interessante que os casos que não precisam transformar-se em casos clínicos ou psicoterapia são relativamente comuns. Isto se deve parcialmente ao fato de que a maioria das crianças possui lares e escolas suficientemente bons, embora possam às vezes apresentar problemas clínicos agudos. Uma pequena ajuda dada a uma criança individualmente pode amiúde conduzir a melhores relacionamentos em toda a parte; a família e a escola estão esperando para fazer o resto do tratamento.

Com relação a qualquer técnica que o terapeuta esteja preparado para usar, a base é o brincar. Declarei em outro momento² que, em minha opinião, a psicoterapia tem de ser efetuada na sobreposição das duas áreas de brincar (a do paciente e a do terapeuta), ou, então, o tratamento tem de ser dirigido no sentido de capacitar a criança a tornar-se capaz de brincar — isto é, ter razões para confiar na provisão ambiental. Tem de se presumir que o terapeuta possa brincar e tenha prazer em brincar.

Uma técnica útil foi denominada de "Jogo do Rabisco", que é simplesmente um método para estabelecer contato com um paciente infantil. É um jogo que duas pessoas quaisquer podem jogar, mas geralmente, na vida social, o jogo rapidamente deixa de ter significado. A razão por que este jogo pode ter valor para a consulta terapêutica é que o terapeuta utiliza os resultados de acordo com o seu conhecimento sobre o que a criança gostaria de comunicar. É a maneira pela qual o material produzido no ato de brincar ou jogar é utilizado que mantém a criança interessada.

O método pode ser aprendido facilmente e tem a vantagem de facilitar grandemente a tomada de notas. Se um menino ou uma menina se comunicam pela fala ou pelo relato de sonhos, então a tomada de notas torna-se um problema verdadeiramente formidável, e tem de ser lembrado que não estou me referindo àqueles poucos casos que tratamos através de psicoterapias prolongadas, mas aos muitos que nos chegam para consulta. Cada um deles tem esperanças de obter mais do que um diagnóstico, cada um espera que uma necessidade seja atendida, mesmo que a ajuda só possa ser fornecida em relação a determinado detalhe ou a determinada área da imensa extensão da personalidade.

Apesar disso, hesitei em descrever esta técnica, que utilizei muito no decorrer de um certo número de anos, não apenas por ser um jogo natural que duas pessoas quaisquer podem jogar, mas também porque se começar a descrever o que faço, é provável que alguém comece a reescrever o que descrevo como se fosse uma técnica estabelecida, com regras e regulamentos. Aí, todo o valor do procedimento se perderia. Existe um perigo muito real em descrever o que faço; de que outros o tomem e o transformem em algo que corresponda a um Teste de Apercepção Temática. A diferença entre isto e um T. A. T. é, primeiro, que não se trata de um teste, e, segundo,

2. Ver *Playing: Creative Activity and the Search for the Self* em *Playing and Reality* (London: Tavistock; New York: Basic Books, 1971; Penguin, 1974).

que o terapeuta contribui com sua própria engenhosidade quase tanto quanto a criança o faz. Naturalmente, a contribuição do terapeuta é abandonada, por ser a criança e não ele quem está comunicando aflição.

O fato de o terapeuta jogar livremente sua própria parte na troca de desenhos, certamente tem grande importância para o sucesso da técnica; um procedimento desse tipo não faz o paciente sentir-se inferior por nenhuma maneira, tal como, por exemplo, um paciente se sente quando está sendo examinado por um médico a respeito da saúde física, ou, com frequência, quando lhe é aplicado um teste psicológico (especialmente um teste de personalidade).

Em um momento adequado após a chegada do paciente, geralmente após pedir ao genitor que o acompanha para ir para a sala de espera, digo à criança: "Vamos jogar alguma coisa. Sei o que gostaria de jogar e vou lhe mostrar". Há uma mesa entre a criança e eu, com papel e dois lápis. Primeiro apanho um pouco de papel e rasgo as folhas ao meio, dando a impressão de que o que estamos fazendo não é freneticamente importante, e então começo a explicar. Digo: "Este jogo que gosto de jogar não tem regras. Pego apenas o meu lápis e faço assim..." e provavelmente aperto os olhos e faço um rabisco às cegas. Prossigo com a explicação e digo: Mostre-me se se parece com alguma coisa a você ou se pode transformá-lo em algo; depois, faça o mesmo comigo e verei se posso fazer algo com o seu rabisco".

Isto é tudo o que existe a título de técnica, e tem-se de enfatizar que sou totalmente flexível mesmo neste estágio muito inicial, de maneira que se a criança quer desenhar, ou conversar, ou brincar com brinquedos, ou fazer música ou traqui-nagens, fico livre para adaptar-me aos desejos dela. Com frequência um menino querará jogar o que chama de "jogo de pontos", isto é, algo que pode ser ganho ou perdido. Apesar disso, em uma alta proporção de casos de primeira entrevista, a criança aceita por tempo suficiente longo os meus desejos e o que gosto de jogar para que algum progresso seja alcançado. Cedo as recompensas começam a aparecer, de maneira que o jogo continua. Amíúde, no decorrer de uma hora, fizemos juntos 20 a 30 desenhos e, gradualmente, a significância destes desenhos conjuntos tornou-se cada vez mais profunda e é sentida pela criança como fazendo parte de uma comunicação de importância.

É interessante notar, com relação aos próprios rabiscos, que:

1. Sou melhor neles do que as crianças são, e elas são geralmente melhores que eu nos desenhos.

2. Eles contêm um movimento impulsivo.

3. São loucos, a menos que sejam feitos por uma pessoa sã. Por esta razão, algumas crianças os acham assustadores.

4. São incontinentes, exceto por aceitarem limitações, de maneira que algumas crianças os acham travessos. Isto se acha aliado à questão de *forma e conteúdo*. O tamanho e o formato do papel constituem um fator.

5. Existe, em cada rabisco, uma integração que provém da integração que faz parte de mim; ela não é, acredito eu, uma integração tipicamente obsessiva, que conteria o elemento de *negação do caos*.

6. Com frequência o resultado de um rabisco é satisfatório em si mesmo. Assemelha-se então a um "objeto encontrado", por exemplo, uma pedra ou pedaço de madeira velha que um escultor poderia achar e estabelecer com uma espécie de expressão, sem precisar ser trabalhado. Isto tem atração para meninos e meninas preguiçosos e arroja luz sobre o significado da preguiça. Qualquer trabalho que seja feito estraga o que já inicia como um objeto idealizado. Um artista pode sentir que o papel ou a tela são belos demais, que não devem ser estragados. Potencialmente, eles

são obras-primas. Na teoria psicanalítica, temos o conceito de tela onírica (Lewin), o lugar no qual ou sobre o qual um sonho poderia ser sonhado³.

Tudo isto se acha vinculado ao estágio muito inicial de dependência máxima, quando o *self* do bebê não está formado. O ego é muito fraco, a menos que (como geralmente acontece) o ego da mãe lhe forneça apoio de ego. O bebê começa a viver com o ego da mãe, que ela lhe empresta por sua adaptação sensível às necessidades de seu bebê.

Tem-se de entender que não existem dois casos iguais e ficaria altamente desconfiado se dois casos se assemelhassem, porque pensaria então que estaria neles plantando algo oriundo de alguma necessidade minha própria. A descrição de apenas um caso tem de ser enganadora e um estudioso desta técnica certamente precisaria passar por um bom número de casos para perceber que, na realidade, não existem dois casos iguais. Por esta razão já publiquei uma dúzia, pouco mais ou menos, destes casos, e proponho-me a coligir diversos outros em um livro⁴.

Escolhi um dos casos⁵ para apresentá-lo aqui e não posso dizer que o tenha escolhido por qualquer razão especial.

(Aqui o leitor tem de estar disposto a tolerar a minha mudança de assunto. Estarei agora, inevitavelmente, descrevendo um caso, e não o jogo do rabisco. Ao final, retornarei ao tema principal e farei alguns comentários sobre o jogo, tal como foi utilizado pela criança e por mim próprio no caso.)

Caso de L., 7 anos e meio de idade, 19.1.66

A mãe trouxe L. e as duas esperaram por mim no consultório, onde eu havia colocado vários números da revista *Animais*. Isto sem dúvida influenciou o material da consulta.

História familiar;

Menina 12 anos

Menino 10 anos

L. 7 anos e meio

Menina 5 anos

Menino 3 anos e meio

Fiquei alguns minutos com as duas juntas, durante os quais conversamos sobre a revista de animais. Fiz L. ir comigo até a sala de espera que eu havia preparado — inclusive com café — para a mãe; tudo interessou L. Esta voltou comigo para o consultório sem qualquer dificuldade. Pusmo-nos rapidamente a jogar o Jogo do Rabisco [*Squiggle Game*] que simplesmente apresentei e com o qual ela aquiesceu. Não o conhecia como jogo.

L. é uma menina loura, de complexão frágil, parecendo muito doce, tal como uma criança pode parecer aos sete anos de idade, bastante independente e completamente confiante no contexto do relacionamento que tive com ela.

3. Bertram D. Lewin, "Inferences from the Dream Screen", *International Journal of Psycho-Analysis*, 29 (1948).

4. *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry* (Londres: Hogarth Press; Nova Iorque: Basic Books, 1971).

5. O material desta entrevista foi também utilizado em um livro intitulado *Handbook of the Psychotherapy of Children*, org. de G. Bierman (Munique: Ernst Reinhardt, 1968), que contém um capítulo pelo Dr. Winnicott com o título de "Enfrentando o Desafio do Caso na Psiquiatria Infantil".— D. W. W. (Hoje também publicado como Caso 3, "Eliza", em *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry*.)

Começamos com:

1. Eu:



Até onde sei, não haviam dito previamente a L. por que ela estava vindo verme. Ela obviamente se sentia muito à vontade com um lápis. Pegou o meu rabisco e colocou-lhe outra perna, deixando um espaço entre as pernas.

Perguntei: "O que é que isso quer dizer?"

Respondeu: "Algo que saiu errado".

Não é fora do comum, em minha experiência, uma criança "mergulhar" imediatamente em matérias profundas, da maneira como o fez.

Fiz uma nota mental de que a combinação do espaço onde a barriga poderia estar e as palavras "algo que saiu errado" poderia estar me fornecendo uma indicação definida, logo no próprio início da sessão, de que L. estava ciente de um problema e que este problema poderia ter a ver com a barriga. *Não falei coisa alguma.* Naturalmente, fiquei pensando se não poderia ser algum problema do tipo "Donde vêm os bebês?"

2. Desenho dela, que transformei em uma cabeça, algo de que pareceu gostar. Não o fiz por qualquer razão, apenas por que foi o que me descobri fazendo.

3. Desenho meu, que ela imediatamente transformou em um pássaro e, ao fazê-lo, mostrou a sua capacidade para auto-expressão no desenho.

4. Desenho dela, e debati com ela o que poderia ser. Ela ficou satisfeita com a idéia de roupa lavada dependurada em uma corda de roupa, embora isto não acontecesse na experiência diária da família. "Tudo vai para a lavanderia" pareceu ser o comentário. Não como contribuição significativa da parte dela, até onde eu podia dizer, mas sim por ela acompanhar o meu desenho com uma referência à vida do lar.

5. Desenho meu, que ela transformou em alguém com um chapéu comprido. Pareceu achar bastante engraçado que o chapéu saísse do lado da cabeça. Poderia ser um menino ou uma menina.

Interpolação

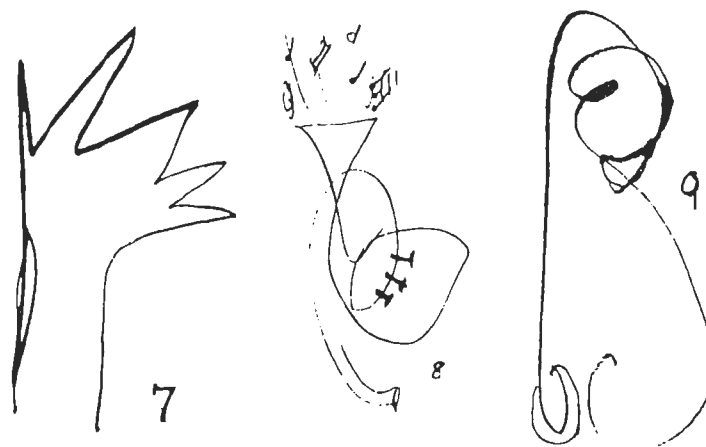
É necessário aqui me referir ao fato de que eu havia tido uma entrevista importante com a mãe, três meses antes. Esta entrevista, sobretudo, concentrou-se na mãe. Apesar disso, no curso de descrever L., a mãe me falou de um incidente que havia tido importância no início da infância da filha. O incidente referia-se a *chapéus*. Se eu houvesse deixado que o que a mãe me contara dominasse as idéias em minha mente,

teria talvez pensado que o desenho 5 indicava um tema principal de chapéus, mas como *sempre recebo a minha deixa da criança*, já havia sido informado nesta entrevista com L. que o tema principal referir-se-ia ao espaço entre as pernas da frente e de trás (desenho 1), fosse o que fosse que isso pudesse vir a significar. Contudo, chapéus indubitavelmente apareceram, como tema secundário. Descreverei o complexo dos chapéus ao final desta descrição da sessão com a criança.



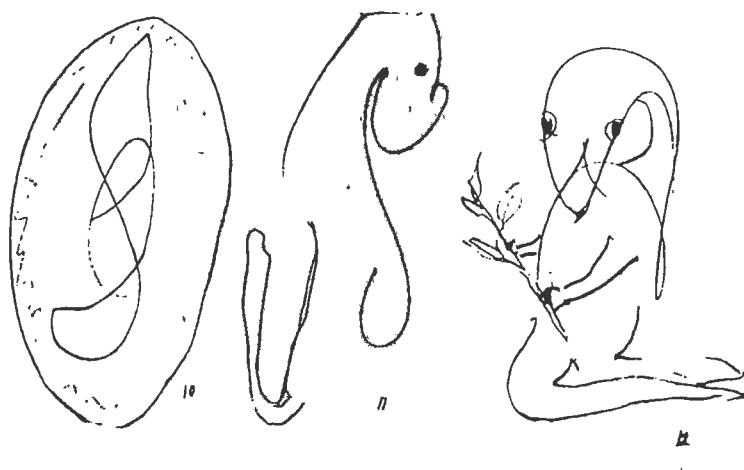
Continuação do Jogo

6. Desenho dela, que L. rapidamente viu como sendo um canguru com um chapéu. Ela fez algo aqui que enfatizou o tema do canguru e vinculou-o à idéia de um lugar de importância entre as pernas dianteiras e traseiras. Ela apontou que o canguru tinha os joelhos dobrados para cima, da maneira que os cangurus têm, e ilustrou isto desenhando os seus próprios joelhos levantados até o peito. Pode-se ver que um dos efeitos disso é ocultar a barriga e, de qualquer modo, o canguru é um animal que as crianças amiúde escolhem por causa da bolsa e para indicar uma gravidez visível, em vez de oculta.

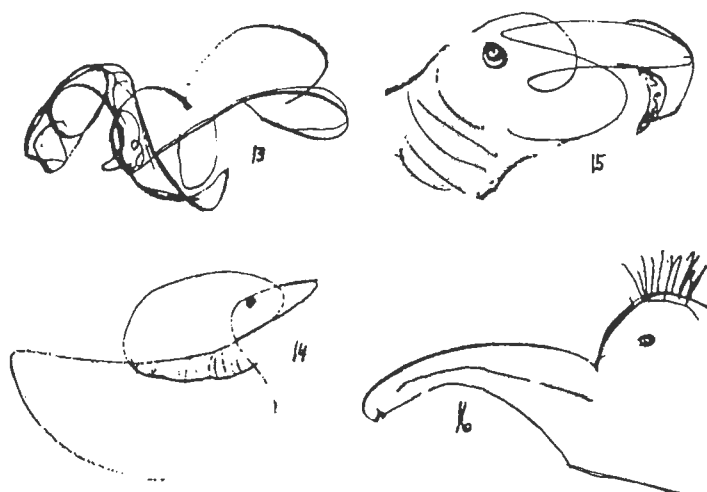


7. Desenho meu, que ela transformou em uma mão ou luva.
 8. Desenho dela. Juntos, o transformamos em uma trombeta.
 9. Desenho meu, que ela transformou em um "cão ou coisa assim". Notar-se-á que este desenho também contém um espaço entre a cauda e o lugar onde os membros ficariam. *Evidentemente, ela sentiu isto, porque retornou ao desenho 1 e colocou-lhe uma linha, fornecendo a barriguinha.*

10. Desenho dela, que debati com ela. Disse eu: "Esse realmente é completo em si; não precisa que se lhe faça nada. Fico pensando se isto não é (e aqui tive de obter dela os nomes que a família dava para os produtos da defecação) uma "cacaca". Se o animal não tem barriguinha, isto poderia ser o tipo de coisa que cairia dele".



Ela me olhou como se isso fosse interessante, mas também como se eu estivesse falando uma língua que não fosse a dela, e disse que era uma cobra. De maneira que desenhei um prato em torno do desenho e sugeri que poderíamos tê-lo para o almoço.



11. Desenho meu, que ela transformou em um cão feroz. Parecia estar "pronto a esmurrar alguém". Isto constituía prova da capacidade de L. em chegar a algo em sua natureza que não se apresenta em seu comportamento costumeiro ou no que ela

parece. (Incidentalmente, eu estava pensando em juntar o “esmurrar alguém” com a idéia da barriga que estava ausente, e fiz uma nota mental de que, naturalmente, ela havia tido de assistir a acontecimentos pertencentes às duas gravidezes que vieram após a dela, especialmente a segunda, quando tinha de 3 anos e meio a 4 anos de idade.)

12. Desenho dela, que transformei em “um elfo ou coisa assim”. Ela achou que ele ia comer as folhas do ramo. Gostou deste como desenho e como idéia imaginativa.

13. Desenho meu, com o qual ela lidou de maneira altamente imaginativa. “É algo que está indo por um túnel. Poderia ser uma toupeira”. Senti que nisto havia o simbolismo da defecação, do nascimento ou da relação sexual, e deixei o assunto assim, sem interpretar.

14. Ela transformou o dela em uma espécie de pato que se vê no escuro. Isto significava que nos achávamos próximos de idéias que aparecem na mente logo antes de dormir. Estávamos próximos de material onírico real.

15. Desenho dela, que transformei na cabeça de algum tipo de pássaro.

16. Desenho meu, com o qual ela lidou de maneira semelhante, fornecendo penas na cabeça da ave.

A esta altura, já se havia desenvolvido um jogo que tinha a ver com colocar os desenhos lado a lado sobre o chão; ela estava ficando bastante excitada a respeito de apanhar cada um deles assim que ficava pronto e colocá-lo ao final de uma fileira, de maneira que agora tínhamos desenhos a espalhar-se pela outra metade da sala. Quando ela ia depositar um desenho lá ou ver seu número, que a interessava também, eu dizia: “Adeus” e, quando regressava “Olá!” Ela não se achava superexcitada, mas estava vitalmente interessada no que se estava passando e estávamos ambos nos divertindo.

17. Desenho dela, que transformei em um pato (imitando-a e assim o dizendo). Dei-lhe um peixe para comer.

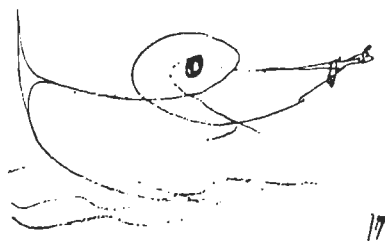
18. Desenho meu, que ela transformou em algo feroz.

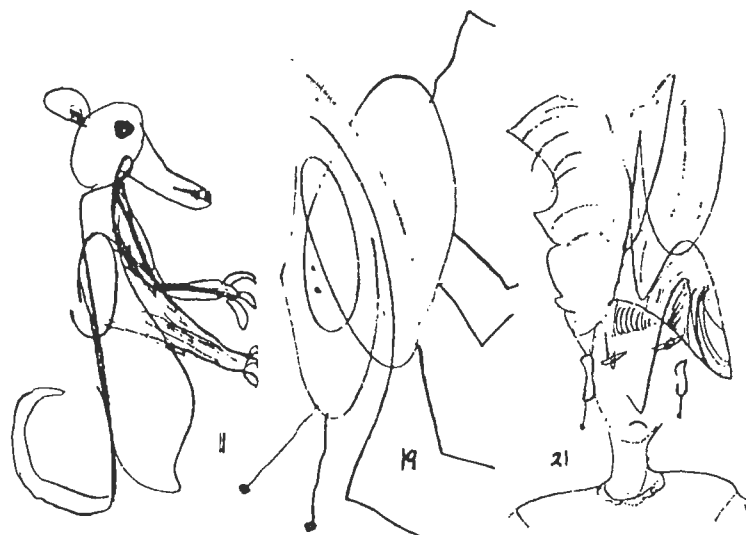
Por essa ocasião, eu já havia feito algumas indagações tentativas sobre sonhos que ela poderia ter tido, mas L. não estava achando fácil contar-me a respeito deles. Aventurara o comentário de que os seus eram horrendos. Apontei-lhe que havia evidentemente algo horrendo que faz parte dela, mas que ela não sabe o que fazer com isso, e relembrei-a do cão feroz (nº 11). O tema continuara neste desenho (nº 18) do “algo feroz que tem garras, orelhas grandes e um curioso olho grande que lhe permite ver no escuro”.

Eu disse aqui algo a respeito da maneira pela qual as coisas cairiam fora desde dentro se não houvesse barriga; talvez algo como o que ela desenhara caísse para fora.

Falei também a respeito das garras e das idéias dela de chegar ao que quer que se achasse dentro da barriga de Mamãe quando esta ia ter um dos dois bebês que chegaram depois de L. Isto constituiu uma idéia nova para ela. Não estava inteiramente segura de que se lembrasse de algo a respeito de a mãe achar-se em estado de gravidez. (Naturalmente, não utilizamos esta palavra.)

19. Desenho dela, com o qual comecei a fazer algo e que juntos transformamos em um inseto.

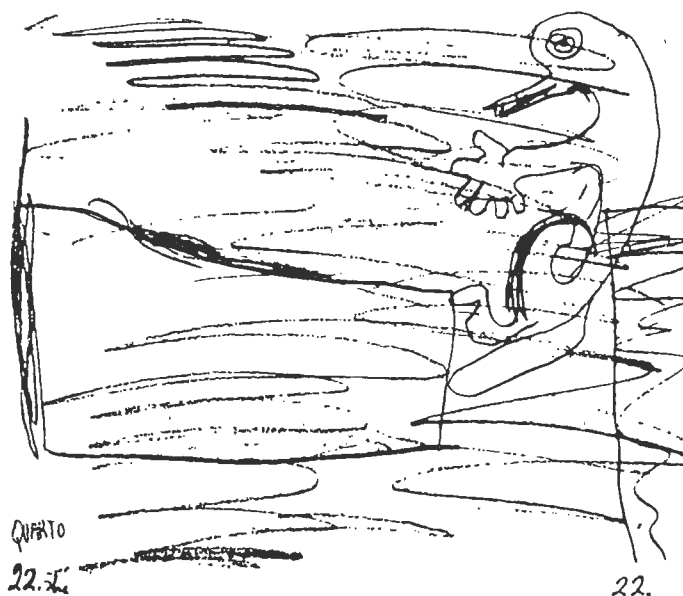




20. Desenho meu, bastante diferente dos outros rabiscos, e mais concentrado. Eu disse: "Esse é ridículo, não é?" e ela respondeu: "Não!" e rapidamente transformou-o em "algum tipo de animal com antenas ou sensores". "Tem um pé grande e uma cauda. Pode ser bom ou horrendo".

Em algum lugar aqui tentei obter dela alguma informação sobre se as coisas ferozes e horrendas eram masculinas ou femininas, mas não obtive uma indicação satisfatória.

21. Desenho dela, que transformei no que chamou de uma "senhora elegante". Enquanto eu estava desenhando este, ela já estava fazendo o seguinte, em uma folha de papel tamanho *in-quarto*.

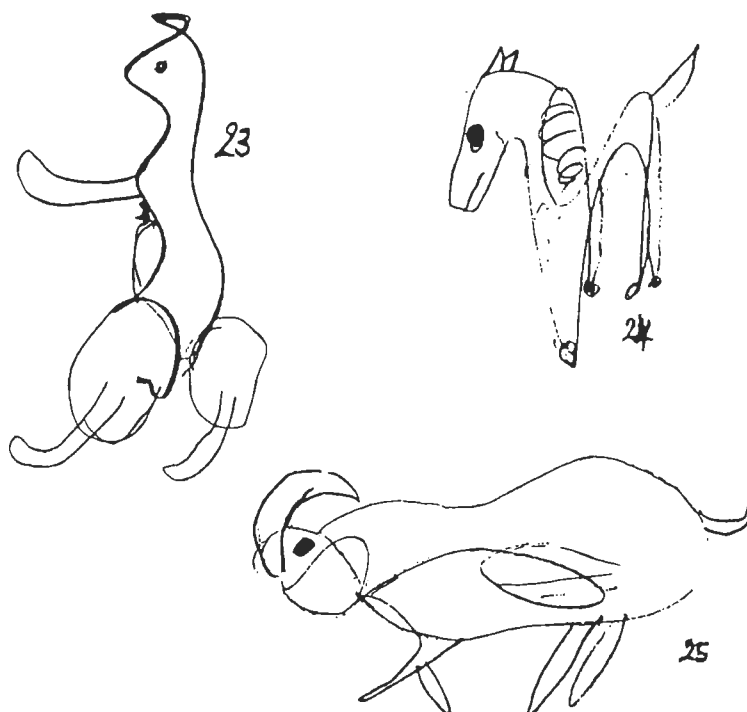


22. Este foi "muito difícil para ela fazer" e teve de ser "muito valente". "É um sonho assustador". Ela começou pela escuridão e depois colocou a cama, com ela deitada em cima. Depois disso, passou aos detalhes da COISA que mergulha sobre ela. Tem os joelhos dobrados para cima (da maneira que descreveu quando desenhou o canguru e que também me mostrou com o próprio corpo). Tem um pé grande, um pé pequeno e um olho só. De seu ponto de vista, esta coisa é "tão horrenda quanto possível".

Tentei obter dela o que a coisa faria a ela se a pegasse e tudo o que pôde dizer foi: "Seria horrendo para mim".

Explorei aqui em torno da idéia da estimulação sexual, quer sob a forma de uma sedução de algum tipo (improvável em seu ambiente familiar), quer sob a forma de masturbação. Utilizei palavras que ela pudesse entender. Não forcei o assunto de maneira alguma, mas deixei-a saber que sabia a respeito, e ela me olhou com olhos pensativos, como se essa fosse a primeira vez que havia autoconscientemente pensado a respeito da masturbação e dos sentimentos de culpa a ela relacionados. Evidentemente, aqui eu estava especulando, baseando minhas idéias no que pensava estar vendo acontecer. Prossegui muito cuidadosamente e certifiquei-me de que não estava de maneira alguma pondo em perigo o relacionamento que existia entre nós, possuidor de aspectos positivos muito poderosos, com o que se podia contar para cobrir grandes riscos.

Neste estágio, dei-lhe a escolha de fazer outra coisa ou desenhar, e ela decidiu fazer mais dois Jogos do Rabisco. Desta maneira, forneci-lhe toda oportunidade para afastar-se, mudar de assunto ou, então, brincar e ver o que poderia acontecer.

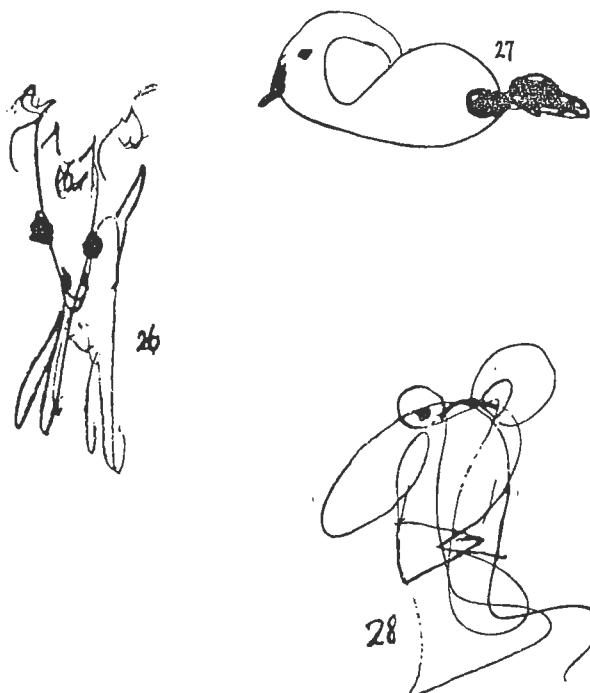


23. Desenho meu, que ela transformou em outro canguru. Desta vez o canguru tinha uma grande barriga ou bolsa, com um bebê canguru dentro dela. Os joelhos não estavam dobrados para cima. Falei a respeito do uso de um canguru para pensar sobre

uma barriga que tem um bebê dentro dela, sem na realidade chegar diretamente à idéia de a mãe estar grávida. Ela falou a respeito do canguru como sendo um animal que faz coisas com as pernas e pula. Furneci a L. um pouco mais de minha própria idéia de que aquela coisa muito horrível que vem até ela representa algo que nunca aceitou propriamente, qual seja, que tem sentimentos semelhantes a esses a respeito do bebê dentro da barriga da mãe. A COISA horrenda seria então um retorno de algo próprio seu, que ela podia sentir ser horrenda.

24. Desenho dela, que transformei em um animal do qual ela gostou. Parecia querer continuar, de maneira que deixei o jogo prosseguir.

25. Desenho meu, que ela transformou em um bode a arremeter. Presumi (mas não disse nada) que para L., como para outras pessoas, o bode é um símbolo do instinto masculino.



26. Desenho dela, que transformei em outro animal pequeno, que lhe agradou.

27. Desenho meu, que ela disse que ia ser um camundongo. De qualquer modo, tinha uma orelha grande. Chegamos agora ao desenho de que ela disse que seria o último da série.

28. Desenho final, dela, que L. transformou de modo bastante fantástico em uma cabeça de homem. Começou pelos óculos e era, de modo bastante óbvio, um retrato meu. O homem estava lendo um jornal. "Não, está cruzando os braços". Neste ponto, ela se achava muito livre e podia agora ver o que quer que quisesse ver em seus próprios rabiscos.

Estava agora pronta para ir embora, e eu lhe disse que iríamos encontrar Mamãe, de maneira que reunimos todos os desenhos, que ela queria reexaminar em sua ordem correta. Repassamos todos os detalhes importantes, inclusive a diversão e o trabalho interpretativo. Ela apanhou o grande desenho *in-quatro* do sonho (nº. 22) e colocou-o de lado como "diferente", e acho que se a mãe houvesse entrado, ela teria querido que esse desenho fosse mantido como privado a ela e a mim. De qualquer modo,

coloquei todos os desenhos na pasta e disse-lhe que lhe pertenciam, que podia tê-los em qualquer ocasião, se os quisesse, mas que eu os guardaria para ela. É prática costumeira minha dizer isto ao final, e as crianças muito raramente querem levar consigo para casa os desenhos do Jogo do Rabisco.

Ela foi então buscar a mãe. Enquanto saía pela porta da frente, em estado muito contente, disse-lhe: "Talvez nos encontremos de novo qualquer dia desses". Respondeu ela: "Espero que sim".

Comentário

O leitor que esteja estudando esta técnica e também tentando utilizar o material para efetuar uma avaliação do estado psiquiátrico de L. desejará examinar o que foi aqui apresentado sem auxílio. Fora de dúvida, várias opiniões poderiam ser expressas, com o acento colocado ora sobre determinado aspecto do caso, ora sobre outro.

Apesar disso, tem-se de fazer um comentário para que o leitor o utilize após efetuar um estudo pessoal do que se passou.

Observações Gerais

Esta menina inteligente inclui-se no significado do termo "normal", ou "sadio", em sentido psiquiátrico. Isto quer dizer que apresenta liberdade quanto a qualquer organização rígida de defesa. De maneira mais positiva, é capaz de brincar e de ter prazer nisso; aceita com facilidade o meu brincar e permite que o nosso brincar se sobreponha parcialmente, e mostra um senso de humor sem ser maníaca⁶.

L. é capaz de usar sua imaginação, e, após testar devidamente a situação, fica capacitada a me fornecer um sonho de importância, no qual aparece a *ferocidade*, o único aspecto que clinicamente falta à sua personalidade, tal como se apresenta àqueles que a conhecem.

Aparecem certos temas que chamam a atenção para áreas da organização da "personalidade total" de L. e que lhe causam alguns problemas, por causa do conflito, da ignorância e da confusão. Esses temas são os seguintes:

A. Tema principal

Algo errado (nº 1).

Espaço em vez de linha para a barriga (nº 1).

Linha colocada mais tarde (por ocasião do nº 9).

Tema do caniguru introduzindo a confusão a respeito da gravidez.

Gravidez genital entendida, mas fantasia pré-genital (trato alimentar de gravidez relativamente sob repressão.)

É como se ela houvesse recebido informações a respeito de os bebês provirem do útero, mas a informação não "pegou" por L. achar-se ainda lutando com bebês em termos do que vem de dentro — o sistema da fantasia alimentar. Não se pode decidir se a falha aqui proveio da mãe ou da criança, ou de ambas, por ser claro que a fantasia se centrava na COISA horrenda no sistema de fantasia do trato alimentar, e isto se

6. O termo "maníaco" implica, para mim, existir um humor de depressão que está sendo denegado, substituído por manifestações contradepressivas. — D. W. W.

achava relacionado às idéias horrendas ou destrutivas que ela pode ter tido em relação às COISAS na barriga da mãe que, às vezes, tornavam-na gorda.

A chegada de L. a estes assuntos no relacionamento comigo teve o efeito de torná-la uma pessoa muito mais relaxada, de maneira que os pais ficaram bem satisfeitos com o resultado clínico da consulta. Isto apontaria para a possibilidade de que L. estivesse pronta para uma explicação mais imaginativa e infantil sobre a origem dos bebês do que a que de fato recebeu.

B. *Tema Secundário*

Havia um interesse recorrente em chapéus e isto bem pode ter sido consequência do episódio importante a que a mãe se referiu e que eu ainda não relatei. Pode ser fornecido aqui sem interferir (espero) com os temas principais do caso.

Perto do final da entrevista da mãe comigo, que foi principalmente a respeito de si própria, ela me contou algo sobre o que se sentia culpada no manejo do início da vida de L. Disse ela: "Parece ridículo, mas foi isto o que aconteceu quando L. estava com 10 meses de idade. Tive de me afastar por alguns dias e o fiz de modo relutante, mas deixei as crianças (L. era então a mais jovem) sob a guarda de uma babá, nas rotinas da casa. Achei que tudo correria bem, mas devo ter-me sentido culpada porque, quando voltei precipitei-me para onde L. (o bebê) estava, sem tirar primeiro meu chapéu. O horrível foi que L. congelou. Não reagiu a nada que eu fizesse. Tomei-a e mantive-a nos braços e ela acabou por relaxar e tornar-se exatamente como fora antes de eu ter me afastado. Tudo retornou ao normal, exceto que L. agora tem uma fobia de chapéus. Por longo tempo, muitos meses, o bebê L. não passava por mulheres com chapéus.

Foi provavelmente por causa desta fobia de chapéus e a possibilidade de haver um resíduo da perda de três dias da mãe por L., aos 10 meses de idade, que a mãe decidiu trazê-la para consulta psiquiátrica, não por causa da enurese que realmente não preocupava a mãe de modo algum, e que desapareceu por volta da época da consulta.

Foi importante, como já foi indicado, que eu seguisse o material da criança e não o do tema subsidiário dos chapéus, que eu poderia ter reconhecido do que a mãe me contara a respeito dos primeiros anos de L.

C. *O Terceiro Tema*

O terceiro tema acabou por revelar-se o mais importante. Tinha a ver exatamente com o aspecto que estava faltando na personalidade de L., a *ferocidade* que apareceu primeiro no "algo feroz" (nº 18) e, depois, na COISA do sonho (nº 22). Esta ferocidade tinha a ver com seu temor das coisas que imaginava que estivessem crescendo dentro da barriga da mãe, baseada em uma visão de ingestão-retenção-eliminação (ou pré-genital) das funções corporais. Vinculava-se também às suas próprias pulsões agressivas, raiva pela mãe que estava se afastando dela por causa da nova gravidez, e o seu ataque, por medo, dos objetos horrendos imaginados dentro da mãe. Por trás disto tudo havia o ataque sobreposto aos conteúdos da mãe pertencente ao relacionamento objetual impulsionado pelo instinto, ou impulso amoroso primitivo, com uma pré-história da idéia de ataque ao conteúdo do seio, ou apetite voraz.

O trabalho efetuado nesta única consulta terapêutica foi suficiente para libertar o impulso amoroso primitivo dos impulsos raivosos secundários, e a consequência, clinicamente, foi a que a personalidade da criança tornou-se mais livre de modo geral e houve uma facilidade maior na movimentação de sentimentos entre ela e a mãe.

A parte principal deste trabalho foram as próprias descobertas da criança, ou seqüência ordenada, culminando por ela ficar capacitada a utilizar o sonho que tivera, mas do qual não tinha conseguido derivar benefícios plenos.

Em outras palavras, as interpretações não produziram resultado, mas ajudaram no sentido da descoberta, pela própria criança, do que já se achava lá, nela própria. É esta a essência da terapia.

Sumário

- a. Fez-se uma tentativa de descrever o Jogo do Rabisco.
- b. Trata-se de um jogo sem regras.
- c. Não existe nada de novo no jogo, e muito pouco que seja novo no uso dele em psicoterapia. O importante é o uso que se faz do material que o jogo pode produzir, especialmente neste tipo de trabalho de uma só sessão que chamo de "consulta (diagnóstica) terapêutica".
- d. Para descrever o jogo, portanto, foi necessário fornecer um exemplo, e isto envolveu uma descrição de caso. Mas não existem dois casos iguais e um só exemplo, portanto, pode ser enganador. O estudioso fica assim convidado a estudar este caso juntamente com outros casos publicados⁷.
- e. Em muitos de nossos casos, estamos, por assim dizer, rebatendo em um turno bom* e são estes casos (comuns) que proporcionam o melhor material para este tipo de trabalho em psiquiatria infantil. O que quer que haja de melhora clínica após a sessão, produz naturalmente uma reação favorável em casa ou na escola.
- f. Se o trabalho da sessão não produz um resultado clínico, então o caso naturalmente passa a ser classificado como um caso que necessita de uma abordagem diferente, tal como trabalho clínico ou uma longa fase de psicoterapia. Não se descobrirá que o Jogo do Rabisco domine a cena por mais de uma única sessão, ou, no máximo, duas ou três. É conveniente pensar em termos de primeiras sessões reduplicadas, de maneira que então se possa dizer que o Jogo do Rabisco ou seu equivalente é útil como técnica de primeira sessão.
- g. Iria contra minha intenção que o Jogo do Rabisco se tornasse padronizado ou descrito de modo demasiadamente claro. O princípio é que a psicoterapia é feita em uma sobreposição parcial da área de brinquedo da criança e da área de brinquedo do adulto ou terapeuta. O Jogo do Rabisco é um dos exemplos da maneira pela qual uma interação desse tipo pode ser facilitada.

7. Ver *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry*.

* Comparando com o jogo de críquete. (N. do T.)

41

O Valor da Consulta Terapêutica

Redigido em 1965¹

Existe um aspecto da psicanálise aplicada que veio a me interessar cada vez mais nas últimas duas décadas. Trata-se da exploração da primeira entrevista, ou das primeiras e poucas entrevistas.

Primeiramente, tenho de tornar muito claro que o que estou descrevendo não é psicanálise. Se estiver iniciando uma análise, não adoto o procedimento aqui descrito. Apesar disso, sou de opinião de que, a fim de preparar-se para efetuar este trabalho, o terapeuta deve tornar-se inteiramente familiarizado com a técnica psicanalítica clássica e levar até o “amargo” fim um certo número de análises conduzidas com base em sessões diárias, continuadas através dos anos. Só desta maneira é que o analista aprende o que tem de ser aprendido dos pacientes e só desta maneira é que ele domina a técnica de reter interpretações que têm validade sem importância imediata ou urgente.

Eu não diria que uma análise em plena escala é sempre melhor para o paciente do que uma entrevista psicoterapêutica. O tratamento pela psicanálise amiúde deixa a sintomatologia intocada durante um período de tempo durante o qual repercussões sociais podem complicar infinitamente a questão; ademais, o tratamento pode tornar necessário remover a criança de um lar suficientemente bom para um ambiente estranho e isto, mais uma vez, é uma complicação que seria melhor evitar. Em outras palavras, há casos em que uma mudança sintomática rápida é preferível a uma cura psicanalítica, ainda que se preferisse a última.

Independente disso, existe uma vasta demanda clínica por psicoterapia que não se acha relacionada de maneira alguma à oferta de psicanalistas e, portanto, se houver um tipo de caso que pode ser ajudado por uma ou três visitas a um psicanalista isso amplia imensamente o valor social do analista e ajuda a justificar sua necessidade de efetuar análises em plena escala, a fim de aprender seu ofício.

É bem sabido que a primeira entrevista de uma análise pode conter material que se apresentará para análise durante meses e até mesmo anos. Os estudantes são

1. Publicado em *Foundations of Child Psychiatry*, org. de Emanuel Miller (London, Pergamon Press, 1965).

aconselhados a tomarem notas cuidadosas das primeiras entrevistas, notas que possam ser usadas em todos os estágios posteriores e tornem possível uma reconstrução da análise em termos da descoberta de significados mais profundos e mais sutis em acontecimentos e associações livres fornecidas na primeira sessão.

Aquilo que estou chamando de entrevista psicoterapêutica faz o mais complexo uso possível deste material relativamente não-“defendido”. Há perigo real neste trabalho, mas contudo, há o perigo de não fazer-se absolutamente nada, e os riscos provêm da timidez ou da ignorância do terapeuta, antes que o paciente sinta que foi enganado.

O psicoterapeuta neste estágio da primeira entrevista é um objeto subjetivo.

Com freqüência a criança sonhará com o psiquiatra *na noite anterior* ao dia da entrevista, de maneira que, na realidade, o psiquiatra está se ajustando à idéia preconcebida do paciente. Em outra linguagem, o paciente traz para a situação uma certa medida de crença ou de capacidade de acreditar em uma pessoa compreensiva ou que o ajude. Traz também uma certa medida de desconfiança. O terapeuta aproveita-se de que o paciente traz e age até o limite da oportunidade que isto concede. O paciente vai embora sem ter feito uma percepção objetiva do terapeuta, e será necessária uma segunda visita para objetificar e despir o terapeuta de magia.

Existe uma diferença então entre esta técnica e a da psicanálise, no fato de que enquanto na última a neurose transferencial se desdobra gradualmente e é usada para interpretar, na entrevista psicoterapêutica há um papel já pré-ordenado para o terapeuta, baseado no padrão de expectativa do paciente. A dificuldade, para o terapeuta, é com freqüência sair-se tão bem quanto pode descobrir-se permitido a fazer. Muitos pacientes em verdade esperam ser basicamente entendidos de imediato e poder-se-ia dizer que nos ajustamos a isso ou, então, trabalhamos na base da “psicanálise ou nada”. Naturalmente, não podemos compreender de imediato, a menos que sejamos informados; e na primeira entrevista o paciente está amiúde disposto e em verdade ávido por informar o terapeuta, fornecendo tudo o que é necessário para a interpretação profunda e significativa.

Com freqüência acontece descobrirmos que uma criança forneceu tudo ao psicólogo que está efetuando um teste de inteligência e que o fato de que o material apresentado não conduziu à compreensão (não se achando isto incluído nos objetivos do psicólogo) mostrou ser traumático para a criança, levando a um fortalecimento da desconfiança e a uma indisposição a fornecer as pistas apropriadas². Por esta razão sempre vi os meus pacientes primeiro, encaminhando-os ao psicólogo quando necessário, após haver-me envolvido com o caso por fazer algo de importante na primeira entrevista ou nas primeiras poucas entrevistas.

Eu diria que é comum os pacientes saírem de uma primeira entrevista desiludidos e sem disposição para efetuar nova tentativa de buscar auxílio psiquiátrico por causa do fracasso do consultor em utilizar o material apresentado. É comparativamente raro um paciente ser ferido por interpretações erradas, feitas em uma tentativa genuína de usar o que é apresentado, com os equívocos e as omissões sendo devidas aos limites que são da natureza de todos os esforços humanos. Aprendi isto com meus pacientes psicóticos (esquizofrênicos limítrofes), que são excepcionalmente tolerantes quanto às limitações do entendimento por parte de um analista, embora possam ser, ao mesmo tempo, extremamente intolerantes quanto a irregularidades no comportamento do analista (sua inconfiabilidade, um desempenho desigual, exibição através da tranquilização do ódio inconsciente, mau gosto, etc.).

2. Isto se aplica especialmente a testes tipo T. A. T., nos quais o paciente chegou a inesperadas idéias, temores, estados. — D. W. W.

Técnica

A fim de obter o máximo de uma primeira entrevista, o terapeuta precisa ter muito cuidado em não complicar a situação. Precisam ser ditas e feitas toda a sorte de coisas que simplesmente pertencem ao fato de o terapeuta ser humano, não sem se dar ares de importância profissional e estar, apesar disso, ciente da "sacralidade" da ocasião. Isto se aplica independentemente da idade do paciente.

Uma meninazinha, de dois anos e meio de idade, viu-me cinco vezes. Pedira para ver alguém a quem pudesse perguntar a respeito de um medo que os pais não podiam entender e, quando obteve alguma ajuda de mim, insistiu em me usar mais até haver resolvido o problema. A cada vez ela se preparava para a entrevista e, após, dela emergia em estado relaxado. Da quinta vez, por exemplo, chegou (de trem) enroscada no colo do pai, sugando o polegar ou o dedo do pai. Esteve muito tensa até a sua chegada à minha porta e, assim que entrou, foi imediatamente para a minha sala e assumiu a sua posição no chão, entre os brinquedos. Após esta entrevista, ela (agora com três anos de idade), ficou em estado feliz, como de costume. Mostrou-se interessada em tudo que pôde ver no caminho de volta para casa, de trem. À tarde, esteve brincando de modo construtivo e com grande satisfação. À noite, fez uma observação que era apropriada ao trabalho da sessão.

Isto assemelhou-se à reação de uma criança a algumas sessões analíticas, mas em certo sentido, havia mais coisas em jogo, por causa da distância entre o lar da menina e o meu consultório, algo sobre o que na realidade falou durante a sessão.

Um menino de seis anos, com um Q. I. relativamente baixo, com o retardamento sendo secundário a uma psicose infantil, chegou para a sua primeira e única entrevista em estado de apreensão. A mãe escreveu-me: 'ele naturalmente quis saber aonde estávamos indo e tivemos de dar-lhe uma resposta definida, por causa de sua experiência aos quatro anos de idade, quando retirou as amígdalas. Eu não sabia exatamente o que dizer, de maneira que mencionei algo a respeito do aproveitamento na escola e o seu hábito às vezes irritante de chupar os dedos. De qualquer modo, após a entrevista com o senhor, ele mencionou que o senhor não lhe havia feito perguntas a respeito disso. Parecia que eu o havia ligeiramente enganado (...) Quando perguntou de novo porque havíamos ido visitá-lo e não havíamos levado os outros meninos, respondi que o senhor era um amigo e que havíamos achado que ele gostaria de conhecê-lo e que havíamos levado somente a ele por ele ser o filho maior. Ele ficou contente com esta resposta. Naquela manhã, estivera muito ansioso por ir diretamente ao senhor e não perder tempo com as compras que lhe havíamos proposto'.

Este menino fez um uso importante de sua entrevista, retornou 'encantado' e ficou com ciúme dos pais quando eles vieram ver-me, algumas semanas mais tarde.

É bom preparar antecipadamente os pais, talvez por telefone, que provavelmente será melhor para a criança que ela seja vista em primeiro lugar. O fato é que o genitor pode ter de ser negligenciado nesta primeira ocasião. É direito do paciente ser o paciente, e se o genitor não consegue cooperar com este arranjo, precisa-se então considerar se a pessoa enferma não será de fato o genitor, antes que a criança. Se é o genitor que é o paciente, então ele deve ser visto primeiro, caso em que será melhor não fazer nada com a criança, de maneira a evitar despertar esperanças que não possam ser atendidas.

É axiomático que se um *setting* profissional correto é fornecido, o paciente, isto é, a criança (ou adulto) que se acha em sofrimento, trará a aflição para a entrevista sob uma forma ou outra. A motivação é muito profundamente determinada. Talvez seja desconfiança o que se demonstra, ou uma confiança grande demais, ou a confiança é logo estabelecida e as confidências cedo se seguem. Seja o que for que aconteça, é o acontecer que é importante.

Um menino de oito anos teve uma entrevista muito rica comigo; havíamos trabalhado duro e eu fora capaz de fornecer-lhe ajuda com base nas pistas fornecidas. Na segunda entrevista, nada aconteceu. Concedi ao menino a sua hora inteira e tudo o que lhe disse foi: 'Não sei o que está acontecendo, mas sei que você tem razão em estar me controlando. Da última vez, você me ajudou a ajudá-lo; desta vez, não posso fazer nada'. E assim nos separamos. Nessa noite, o menino casualmente contou à mãe, enquanto se banhava, que um homem tentara assaltá-lo no parque. A mãe perguntou: 'Você contou ao Dr. Winnicott?' e ele respondeu: 'Não!' de maneira surpresa, como se não pudesse ter imaginado que isso fosse uma coisa importante para contar. Ele de fato me contara de maneira melhor, ficando desconfiado de mim e mantendo-me em seu controle. Vi-o no dia seguinte, como caso emergencial, e ele me proporcionou outra entrevista ricamente recompensadora, relatando o incidente e os seus próprios anseios homossexuais imaginativos, baseados em uma relativa privação paterna.

O importante de tudo isto foi a comunicação do menino, efetuada por não fazer nada acontecer, e a minha aceitação disso como sendo uma comunicação.

Não existem instruções técnicas nítidas a serem dadas ao terapeuta, uma vez que ele deve ficar livre para adotar qualquer técnica que seja apropriada ao caso. O princípio básico é o fornecimento de um *setting* humano e, embora o terapeuta fique livre para ser ele próprio, que ele não distorça o curso dos acontecimentos por fazer ou não fazer coisas por causa de sua própria ansiedade ou culpa, ou sua própria necessidade de alcançar sucesso. O piquenique é do paciente, e até mesmo o tempo que faz é do paciente. O final da entrevista pertence também a ele, exceto onde não existe estrutura na entrevista por causa de uma falta de estrutura na personalidade do paciente ou no relacionamento do paciente com objetos, caso em que esta falta de estruturação é ela própria comunicada.

Um estudante que tente estudar a minha técnica pessoal precisará estudar a maneira por que me comportei em uma longa série de casos e descobrir-se-á que o que fiz em cada exemplo pertencia a esse caso particular.

Tenho esperanças de que o único aspecto estabelecido que será observado, após um amplo exame de meus casos, será uma liberdade de minha parte em utilizar meu conhecimento e minha experiência para atender a necessidade do paciente específico, tal como demonstrado na sessão terminada que está sendo escrita.

Uma observação mais: é necessário efetuar este trabalho em um *setting* mais amplo em que haja oportunidade para que um caso deslize para outro tipo de categoria de psiquiatria infantil. Não há necessidade de caso algum fracassar (exceto onde nos falta a compreensão necessária, caso em que não há necessidade de autocrítica). Se a entrevista psicoterapêutica mostrar-se insatisfatória mesmo quando se pergunta 'Qual é o mínimo que precisamos fazer neste caso?', então um mecanismo mais complexo pode ser colocado em ação. O caso pode tornar-se um daqueles que necessitam de todo o sistema de administração psiquiátrica infantil.

É avisado, porém, não pensar em termos de *psicanálise* para os casos em que a consulta psicoterapêutica, com seu objetivo limitado, não alcança êxito; é melhor, se a psicanálise tem probabilidade de ser uma proposição prática, trabalhar-se desde o início com base em que a psicanálise será incentivada. A razão para isto é que um uso muito intenso da primeira entrevista tende a tornar difíceis os estágios iniciais de uma análise clássica, especialmente se esta tiver de ser feita por outra pessoa que não seja terapeuta inicial, que foi fundo e rápido na primeira entrevista, ao tentar efetuar um diagnóstico.

Sumário

1. Uma entrevista diagnóstica deve necessariamente ser uma entrevista terapêutica, uma vez que um dos principais critérios para a diagnose é a reação que indica o grau de rigidez ou relativa falta de rigidez da organização de defesa. O quadro clínico global pode ser enganador sem esta chave adicional para avaliação da personalidade do paciente.

2. Um *setting* humano é fornecido e é para dentro desse *setting* que o paciente traz e nele apresenta a tensão e o estresse imediatos.

3. O psiquiatra é um objeto subjetivo, e o uso que se faz da entrevista representa a capacidade que o paciente tem de acreditar em pessoas significantes, isto é, se o psiquiatra não interferir com o padrão da entrevista.

4. O psiquiatra necessita ter treino e experiência baseados em tratamentos longos, nos quais o trabalho é feito sobre o material transferencial, à medida que este gradualmente evolve, e que permite a percepção objetiva do analista pelo paciente.

5. Neste trabalho, reserva-se a interpretação para o momento importante e, depois, o analista fornece tanta compreensão quanto se acha em seu poder dar. O fato de o paciente haver produzido o material especificamente para interpretação concede ao terapeuta a confiança de que a interpretação é necessária e que é mais perigoso não interpretar do que interpretar. O perigo é que o paciente sinta-se confirmado na crença de que ninguém quer entender.

6. Isto não é interpretação 'selvagem', embora até mesmo esta possa transmitir a idéia de um desejo de entender.

Um menina de dez anos me disse: 'Não importa que algumas das coisas que o senhor diz estejam erradas, porque eu sei quais são as certas e quais as erradas'. Pouco mais tarde, no decurso do tratamento, ela me disse: 'Eu não continuaria a tentar adivinhar, se fosse o senhor' implicando com isso que podia tolerar o fato de eu não saber³.

3. Este artigo originalmente incluiu uma descrição do caso de 'Ashton', Caso 9 das *Therapeutic Consultations in Child Psychiatry* (London: Hogarth Press; New York: Basic Books, 1971).

Deduções a partir de uma Entrevista Terapêutica com uma Adolescente

*Artigo apresentado à XX Conferência Interclínica de
Orientação Infantil, na London School of Economics,
11 de abril 1964¹*

Minha contribuição a este debate prescreveu a si própria certos limites bastante estreitos. Muita coisa se pode obter de um exame da adolescência como fenômeno total. A minha idéia aqui é que acabamos por chegar ao rapaz ou à moça como indivíduos. Se é verdade que não se pode generalizar a partir de um só caso, então é mais verdade ainda que não se pode perceber o indivíduo em um levantamento amplo.

Definições

A palavra “puberdade” descreve um estágio do processo físico de amadurecimento. A adolescência é o estágio de tornar-se adulto através do crescimento emocional. É comum a rapazes e moças passarem pelo desenvolvimento púbere sem experienciarem a adolescência e sem chegarem à maturidade emocional que constitui a melhor parte do estado adulto.

A adolescência abrange um período de tempo durante o qual o indivíduo é um agente passivo dos processos de crescimento. Referi-me alhures² às *calmarias adolescentes*, à época em que não existe solução imediata para qualquer problema. A única cura para a adolescência é a passagem do tempo, a passagem de três a seis anos ao final dos quais o adolescente torna-se um adulto, isto é, torna-se capaz de identificar-se com figuras parentais e com a sociedade sem a adoção de falsas soluções.

Os adolescentes têm horror à solução falsa e isto os torna difíceis de manejar. Mas a sociedade reconhece a justeza desta dificuldade. Ou não reconhece?

Uma outra coisa ainda antes que eu descreva um caso: a adolescência está sempre conosco, mas temos de lembrar que isto não é comentário sobre rapazes e moças reais que são difíceis, uma vez que eles estão todo o tempo crescendo e tornando-se adultos. É sempre um conjunto novo de rapazes e moças que está fornecendo a variedade nova ou a fase nova de comportamento difícil.

1. Os artigos desta conferência foram publicados pela Associação Nacional de Saúde Mental. — Os Organizadores.
2. Ver *Adolescence: Struggling through the Doldrums*, em *The Family and Individual Development*, London: Tavistock; New York: Basic Books, 1965).

Jane, de 17 anos de idade, foi-me encaminhada por seu clínico-geral, que me escreveu:

Entendo que Jane sempre foi um grande problema, embora tenha de admitir que a acho uma pessoa muito encantadora e inteligente. Houve aparentemente algum distúrbio — sobre o qual nada me foi dito — e isso foi o começo do atual desarranjo. Jane afastou-se completamente de todos os relacionamentos familiares. Não penso existir qualquer dúvida de que ela tem uma intensa antipatia e sente um ciúme irrazoável da irmã, que, superficialmente, é a mais graciosa e realizada das duas irmãs. Há uma história familiar de doença e instabilidade mentais (...)

Agora, o que fariam vocês nestas circunstâncias? Conseguiriam coletar todos os fatos, ver os pais e, depois, ver a moça? Sugiro que a única maneira de fazer a anamnese de um caso é fazê-lo tal como provém do paciente, isto é, uma vez que se tenha decidido quem é a pessoa enferma do grupo. A anamnese feita a partir do próprio paciente possui uma verdade própria, ainda que os fatos possam ser inexatos ou contraditórios. Além disso, detalhes da anamnese, todos tal como surgem, podem ser utilizados pelo psicoterapeuta, enquanto que pormenores coletados com precisão por uma comissão dos fatos não têm valor, exceto para fins de uma conferência clínica.

Vi a própria Jane e, depois, ajustei o meu relacionamento com seus pais por telefone e carta. Neste caso, não vi ninguém da família, exceto Jane. Isto pode provocar uma tensão sobre a família, que reconheço plenamente — caso se achem presentes!

Neste ponto, tenho de lembrá-los que não existe nada mais difícil que decidir se está-se vendo um rapaz ou uma moça saudáveis que se acham passando pelas dores da adolescência ou uma pessoa que acontece estar enferma, psiquiatricamente falando, na idade da puberdade. Está-se vendo a adolescência, ou uma parada ou distorção da adolescência que é devida à doença? Tenho esperança de que o presente caso illustre esta dificuldade.

Primeira Consulta

Jane chegou, nos sentamos à uma mesa e o começo não foi difícil. Ela disse que o pai era professor de física em uma escola técnica e que a mãe também tinha um emprego; disse também que tinha uma irmã, quatorze meses mais velha que ela própria. Perguntei-lhe sobre a família, indagando: “E o seu pai é muito cerebral?” e ela pareceu achar que era, e que a irmã também era inteligente. Disse: “Obviamente fui criada em um grupo instruído e tomo essas coisas como evidentes”.

Permitam-me descrever Jane, tal como me apareceu em suas entrevistas, duas das quais descrevi a vocês. Nesta primeira entrevista, a própria Jane parecia ajustar-se ao papel. Tinha cabelos bastante longos e lisos, como um V invertido que partisse de sua testa e gradualmente se abrisse para mostrar um nariz e uma boca. Sobressaindo disto havia um queixo muito agudo e sua boca, certamente não-sensual, indicava uma abordagem intelectual; possivelmente havia uma protrusão deliberada da mandíbula inferior por cima da formação natural.

Na primeira entrevista tinha-se imediatamente a impressão de uma personalidade forte e de inteligência, e de alguém inteiramente capaz de cuidar de si própria. Jane não pareceu importar-se com o fato de eu estar tomando notas de maneira irregular. (se não o tivesse feito, vocês não estariam escutando isto.) Mantive um olho aberto para isto, por causa da desconfiança natural dos adolescentes, mas não tive problemas aqui. Quando ficou desconfiada, ela o disse.

Tudo isto foi uma representação bastante consciente. Da segunda vez que veio, estava francamente deprimida. Parecia estar. Na quarta entrevista, seis meses mais

tarde, havia-se tornado uma adolescente natural, em jeans muito apertados, e usava os cabelos de qualquer maneira. Não havia representação e nem humor. Quando veio pela quinta vez, ainda há pouco, estava com um casaco e uma saia e já se podia ver o estado adulto insinuando-se nela.

Quero que vocês — a menos que façam estas coisas vocês mesmos, e a maioria de vocês faz — cuidem a maneira pela qual a entrevista se desenvolve. Uma boa entrevista, em psiquiatria infantil, desenvolve-se de modo espontâneo, ou então se refreia. Tenho de ser eu mesmo, vivo e esperto, mas se sacudo as coisas, sou um mau entrevistador. Posso ser natural. Posso murmurar uma melodia, fazer rabiscos ou coçar a cabeça, mas, se tento fazer a entrevista seguir um padrão, estou interferindo com um processo natural, pois se pode tomar como *axiomático* que se uma criança, um adolescente ou um adulto está sofrendo, algo disto aparecerá na entrevista, se forem fornecidas condições que tenham possibilidades de levar à compreensão.

Continuando:

Jane descreveu os arranjos domésticos e isto envolveu-a em falar-me a respeito dos pais, o fato de não se darem bem juntos e viverem separados um do outro.

Disse ela sobre a mãe: “É inteligente muito mais profunda que eu; mamãe é a mais profunda de todos nós”. (pausa.) (Naturalmente, não posso fornecer as pausas, pois transformaria em uma palestra de duas horas, mas as pausas são importantes) “Eu própria me acho agora, tenho esperanças, fora da influência de minha irmã, mas foi uma luta real. Todos admitem que ela é excessivamente ciumenta. Agora foi embora para outra cidade. Está realmente em dificuldades e sujeita-se a casar-se com alguém que não é realmente adequado”.

Mais tarde, ela me deu uma versão diferente disto, mas o que é verdadeiro para o paciente AGORA é a verdade que eu estou procurando.

Aqui, perguntei-lhe: “Se você estivesse vindo aqui por sua própria vontade, como seria? O que estaria perguntando ou para o que me estaria usando?”

Queria certificar-me de que ela não estava apenas sendo submissa, vindo por causa da mãe.

Respondeu: “Estou vindo por minha própria vontade. Já há três ou quatro anos eu realmente deveria ter visto um psiquiatra. Não é que seja uma pessoa perturbada, realmente, mas a mamãe fica preocupada. Temos brigas, geralmente quando a minha irmã está em casa. Recentemente ela ficou cheia com mamãe e eu recusei-me a deixar envolver em tudo, de maneira que me retraí e isto significou ser cortada fora”.

Aqui, ela estava se referindo, à sua própria maneira, ao retraimento descrito pelo clínico-geral.

Jane continuou: “Naturalmente o senhor sabe que eu sempre adiciono melodrama e mentiras a tudo. Mamãe tem problemas de todos os lados. O senhor sabe, eu realmente gosto muito de minha irmã, mas ela é só quatorze meses mais velha que eu e isso é uma parte grande do problema, porque sempre competimos como se fôssemos iguais. Mas agora ela e eu estamos separadas. Graças a Deus que me separei de minha irmã. Ela é uma pessoa demonstrativa, enquanto que eu não sou. Ela não gosta de segredos. As pessoas acham que sou excêntrica e que não tenho qualquer contato com as convenções. Papai é bastante convencional”.

Temos aqui então uma descrição geral da situação em casa e uma referência específica ao fato de as dificuldades surgirem do fato de que apenas quatorze meses

separavam estas duas irmãs. Este tema acabou por desenvolver-se de maneira inesperada, perto do fim da segunda entrevista. De tempos em tempos, vocês serão recordados sobre este tema.

Perguntei-lhe a respeito do pai e da mãe e ela disse: "Não se dão bem. Meus pais nunca foram felizes juntos, com papai fora, sendo professor, fechado em seu mundinho. Houve uma fase, quando eu tinha 14 anos e a minha irmã 15, em que tínhamos ciúmes uma da outra em relação à *mamãe*. Fiquei surpresa quando isto surgiu, mas afora essa fase curta, não tive sobre mamãe ou qualquer pessoa o tipo de sentimentos que me fizessem ciumenta. Minha irmã, por outro lado, sempre foi de natureza ciumenta. De certa maneira, dei minha irmã a papai; ela podia confiar nele a respeito de questões sexuais de uma maneira que eu nunca pude. Quando éramos crianças, não sabíamos que papai e mamãe tinham desavenças, embora haja uma precoce observação minha que indica que posso ter sabido. Foi quando eu tinha nove anos; minha irmã perguntou à mamãe a respeito dela e de papai e me lembro que eu disse: "Não, não pergunte!" Eu não queria que mamãe respondesse. Senti-me desesperada porque sabia que ela teria de dizer que as coisas não andavam boas entre ela e papai. Estou sempre contente por estar viva e, às vezes, especialmente contente. Por outro lado, sou bastante cínica em minha maneira de lidar com a vida. Eu e minha irmã sempre soubemos os fatos da vida. Fui satisfatoriamente à escola até os seis anos e, depois, fui para uma escola onde era *realmente* feliz, e ainda guardo uma afeição por essa escola, mas fiquei cheia dela. Tornei-me infeliz, *mas era basicamente feliz, como sempre sou*. A escola acabou por tornar-se uma chatice e fui para um cursinho de preparação para o exame. Encontrei aí uma atmosfera relaxada. A grande coisa é que a frequência é mista e 50% dos estudantes são estrangeiros. Nesse curso, você é responsável por você mesma. Algumas moças não sabem como usar esta emancipação, mas a mim me convém. Não me saí com notas dez de modo algum, porque não acredito nessa conversa. O trabalho é fútil. Ou talvez eu seja preguiçosa e não goste de dar duro. Gosto da *idéia* de trabalho e, por fases, posso dar duro. Tenho amigas, diversos amigos, e gostam de mim, *de certa maneira*. Minha irmã, por outro lado, nunca foi popular. Isto foi algo que sempre nos distinguiu uma da outra. Ela teve de entrar direto em relacionamentos emocionais por não ter *amizades* e, quando descobriu a homossexualidade, passou a ver-se como atraente e se soltou. Agora está noiva, e provavelmente vai se casar muito em breve, como falei antes. Talvez o homem não seja adequado, mas é estrangeiro".

(Pelo tom, ela parecia que ligava "estrangeiro" com "fora da civilização". Vocês concordarão comigo, que, no inconsciente, "estrangeiro" significa "incesto", e, ao mesmo tempo, o contrário extremo do incesto, a exogamia.

"Sempre fui popular. O que realmente me preocupa é que não tenho padrões morais reais. Não posso achar que isto ou aquilo seja errado. Vou lhe falar do que quero dizer. Tenho uma amiga que é muito feliz em casa, diferentemente de mim, e ela se envolveu com um estrangeiro que é muito bonzinho, mas é também muito passado e ela caiu fora. Ela diz a respeito disto: "Bem, não sei, isso partiria o coração da mamãe. Deve ser maravilhoso ter algo como isso, que se pode dizer que lhe diz onde é que você se encontra (...) o senhor vê, eu realmente amo minha mãe muito profundamente, mas não quero nenhuma intimidade e nenhum envolvimento emocional. É por isso que quis um irmão mais velho, que pudesse ser uma mãe para mim sem ser mãe; ele poderia ter-me oferecido um ombro para chorar, mas eu nunca choraria no ombro de minha mãe. O senhor vê, eu realmente gosto de pessoas como mamãe, mas fico emocionalmente toda derretida. A minha irmã se sente terrivelmente culpada. Eu não me sinto culpada a respeito de nada. Minha irmã diz "Mamãe não compreende". Minha mãe não tem a minha hostilidade porque ela se ajusta com o que eu preciso". (Jane prosseguiu falando a respeito de si mesma, dizendo que não podia ser demonstrativa, que realmente amava profundamente a mãe): "O senhor vê, estou tentando ser um indivíduo, sim, estabelecer a minha própria identidade, e, enquanto estou fazendo isso, não posso dar-me ao luxo de assumir as preocupações de mamãe. O senhor vê, mamãe está aproximadamente todo o tempo em lágrimas, embora seja, realmente, uma pessoa muito controlada. Ela nunca tentaria fazer-me assumir as preocupações dela, mas eu facilmente poderia fazê-lo, e, *então não daria conta* (...) Atualmente, pareço andar um pouco cansada todo o tempo".

Toda a significação deste conflito em relação à mãe tornou-se mais evidente à medida que esta entrevista e a entrevista seguinte progrediram.

Falamos um pouco sobre sonhos, imaginação e então ela avidamente me falou a respeito de seus jogos iniciais de infância com a irmã. Disse ela: 'Minha irmã e eu éramos catalizadoras uma da outra. Em todos os tipos de jogos brincávamos juntas e tínhamos mundos de nós próprias e que partilhávamos, e havia realmente uma experiência imaginativa maravilhosa em tudo isso. O horrível foi quando tudo isso parou. Parou quando eu tinha 13 anos, na realidade por causa da mudança da casa em que todos nós morávamos e onde papai vive agora. Todos esses jogos achavam-se tão intimamente misturados com a casa que não puderam ser restabelecidos de novo em nenhum outro lugar'.

Jane então continuou falando sobre "a gloriosa irresponsabilidade da infância". Disse sobre esta última: "Você vê um gato e está com ele; é um sujeito, não um objeto".

Disse eu: "É como se você estivesse vivendo em um mundo de objetos subjetivos".

Respondeu ela: "Essa é uma boa maneira de dizê-lo. É por isso que escrevo poesia. Esse é o tipo de coisa que é o fundamento da poesia. Naturalmente — acrescentou — é apenas uma teoria ociosa minha, mas é como parece, e isso explica por que é que os homens escrevem mais poesia que as moças. Com estas, muito fica preso no cuidar de crianças ou ter bebês, e, depois, a vida imaginativa e a irresponsabilidade passam para os filhos. Mantendo um diário, mas agora só escrevo nele coisas que sinto em poemas; na poesia, algo se cristaliza".

Comparamos isto com a autobiografia, que, disse ela, achava pertencer a uma idade posterior. Disse: "Há uma afinidade entre a velhice e a infância. (Aqui, olhou para mim de modo bastante acentuado, enquanto falava.) Não mostro os meus poemas a ninguém porque, embora goste de cada um deles durante algum tempo, logo perco o interesse neles. Não estou interessada na pergunta: os poemas são realmente bons ou não, isto é, outras pessoas achariam que são bons?"

Perguntei-lhe a respeito de sonhos e isto conduziu ao assunto do devaneio e da abstração quanto ao mundo. Obviamente houve muito disto, que agora ela fazia sozinha, em vez dos jogos com a irmã. Disse ela: "Após o primeiro nível da escola secundária, entrei para uma escola de arte, mas perdi tempo nela. Tenho habilidade para o desenho e poderia ter-me saído melhor do que me saí, mas não fiz. Às vezes eu podia desenhar uma figura que, podia-se ver por sua posição, era a figura de uma *persona* deprimida. Isso pode ser feito como um retrato de alguém, mas na realidade sou eu mesma. O engraçado é que há uma *joie de vivre* sempre presente em mim, por deprimida que esteja. Parecem haver alguns recursos internos, de maneira que nunca *tenho de fazer* coisas; os outros parecem sempre *ter de fazer* uma coisa ou outra; eu não. Por outro lado, tenho algumas coisas que fazem as pessoas pensar que sou excêntrica; pareço ter de dizer coisas, como ter de ser natural. Não sou realmente excêntrica, mas as pessoas acham que sou esquisita".

Perguntei-lhe a respeito da questão de uma fachada e ela pegou o assunto. Disse: "Sou realmente muito introspectiva. Vivo em um subnível. Quando estou com pessoas, é apenas como se sentisse que elas existem. Encontrei em minha vida cerca de cinco ou seis pessoas que têm efeito sobre mim, que, quando estou na mesma sala com elas, sei que são ligeiramente perturbadas. Uma foi uma tia que se tornou esquizofrênica e suicida; ela me mostrou que sou muito sensível a algo nas pessoas que tem a ver com loucura. A coisa é que sinto o que está por baixo da superfície mais do que sinto o que está à superfície. O senhor vê, não posso brincar com uma fachada. O resultado é que, com rapazes, descubro-me entrando e saindo da cama com eles, porque não posso brincar com uma barreira ou uma fachada. Não posso achar que seja desprezível entrar e sair da cama com rapazes. *Simplesmente não posso ficar com a impressão de degradação ou baixeza*. Não há engano possível, nem hipocrisia. Por outro lado, digo mentiras e não sei por quê".

Aqui, ela disse: "A propósito, é inteiramente seguro, não é? O senhor não vai contar isso a mamãe?"

E eu respondi: "Sim, imagino que sou um objeto subjetivo; não é mais perigoso do que falar com você mesma".

Ela aceitou isto com muita facilidade e prossegui tomando notas, sem ela parecer importar-se de modo algum com isso.

Poderão ver que Jane estava fornecendo um quadro de uma afinidade com cada anormalidade psiquiátrica de cada vez. Sabia a respeito da melancolia, estava de acordo com a esquizofrenia e brincara com todas as defesas esquizóides, tal como despersonalização, desrealidade, cisão; aceitara uma divisão em *self* verdadeiro e *self* falso e tivera transtornos de pensamento. Havia problemas na área intermediária dos fenômenos transicionais, o lugar em que faíscas saltam em momentos de intimidade entre pessoas. Tinha um conhecimento mais que casual com a suspeita e as tendências paranóides. Na área psiconeurótica achava-se em contato com a homossexualidade (como apareceria mais tarde) e agora prosseguiu mostrando sua tendência anti-social relacionada à privação.

Perguntei-lhe a respeito de furtos, e ela disse: "Bem, só uma vez quando eu tinha sete anos tive um período em que estive constantemente apanhando *pennies* ou moedas de 3 *pence*, qualquer coisa desse tipo que houvesse lá por casa. Sempre me senti extremamente culpada a respeito disto e nunca contei nada a ninguém. É realmente ridículo, por ser tão insignificante".

Aqui, fiz uma interpretação. Falei-lhe sobre a dificuldade de ela realmente não saber por que furtava esses *pennies*; em outras palavras, achava-se *sob uma compulsão*, e ela ficou muito interessada nisto. Disse ela:

"Sei que as crianças furtam quando foram privadas de uma coisa ou outra, mas nunca pensei nisso antes, que, naturalmente, o problema é que eu *tinha de* furtar e não sabia por que, e é exatamente a mesma coisa com o mentir".

(Verão que ela havia lido toda a literatura e sabe de todas as coisas que pertencem a esta idade, mas de modo intelectual.)

"O senhor vê, é pateticamente fácil enganar as pessoas e eu sou uma atriz maravilhosa; não quero dizer que poderia representar no palco, mas uma vez seja apanhada em um engano, posso levá-lo à frente tão bem que ninguém é capaz de saber. A coisa é que é com muita frequência compulsivo e sem significação. Exemplificando, alguém me perguntou o que era que eu estava indo fazer em Londres e era-me inteiramente desnecessário contar uma mentira, mas rapidamente descobri-me dizendo que como meu amigo havia dito (e dei o nome de uma doença rara e exótica), eu tinha de ir ver um médico para saber se tudo estava bem comigo a esse respeito. Naturalmente posso perceber que se houvesse dito que estava indo ver um psiquiatra isso colocaria tudo em discussão e seria uma questão pública. Houve uma compulsão a contar uma mentira e o fiz com rapidez e facilidade".

Houve uma pausa do tipo balanço:

"O que realmente me preocupa a respeito de mim é que não tenho uma alma irmã. Não posso fingir que existe mais do que há em alguém, ou em algo, ou em qualquer situação. Gosto tanto de sexo quanto as outras garotas, mas comigo é diferente porque tenho de procurar um rapaz que assuma um relacionamento sexual sem qualquer compromisso. Tem de ficar absolutamente entendido que vai terminar em poucos dias. Isto, naturalmente, elimina qualquer rapaz que fosse apropriado para casamento. Parece não haver maneira de estar certa de *um* só rapaz ou de saber que quero *casar* com alguém".

Isto conduziu a uma conversa sobre a questão das dificuldades entre pais. Disse ela: "Papai é, ele próprio, uma pessoa carente".

(Ela acompanhou esta declaração com detalhes que não forneço porque desejo manter irreconhecível o caso. Ao longo de todo o artigo acho que notarão provas do *insight* que esta idade do desenvolvimento tem.)

Falei-lhe então a respeito de sua necessidade muito grande de uma figura paterna ou mesmo de um irmão mais velho. Respondeu que não tem nem mesmo um primo que possa usar: “Tenho um tio, mas ele não é realmente feliz com a mulher *dele*”.

Revelou-se que ela sente não ter absolutamente nenhuma pessoa do sexo masculino, mais velha e responsável, para quem se possa voltar.

Disse-lhe: “Você é, portanto, uma pessoa carente de pai” e terminamos a primeira entrevista com um enunciado tão claro quanto possível desta questão.

Jane foi embora em um estado muito relaxado e parecendo estar bem-disposta com a mãe, a quem fora buscar na sala de espera.

Ela escreveu pedindo para ver-me novamente após terem se passado dois meses.

A maioria de nós acha, penso eu, que convém ao adolescente se estivermos dispostos a trabalhar em uma base “à vista”.

Segunda Consulta

Desta vez Jane veio sozinha e encontrei-a na sala de espera, lendo. Tinha a aparência menos arrumada e não se parecia tanto com um arranjo formal; mostrava-se, em verdade, bastante desleixada. A “representação” havia sido abandonada e, ao invés, Jane achava-se claramente de humor deprimido. Foi muito acessível através de toda a entrevista, que durou uma hora e um quarto. Posso fornecer apenas parte da entrevista.

Comecei por perguntar: “Como vai sua mãe?”

Não havia realmente nenhuma necessidade especial de eu fazer algo, mas ao mesmo tempo, nenhuma razão especial para que não o fizesse.

Ela respondeu: “Anda muito cansada; eu sou realmente a sua principal preocupação. Minha irmã está casada agora e imagino que mamãe ache que sou a única coisa que sobra com que fazer alguma coisa. Estou todo o tempo preocupada com ela. O senhor vê, ela é a única pessoa da família chegada a mim. Ao mesmo tempo, tudo o que ela faz me irrita. Ela é aproximadamente a mãe mais tolerante e compreensiva que se pode pensar em ter e é muito inteligente. *Mas tenho de fazer tudo para mantê-la à distância.* Em vez de permitir que nos aproximemos, brigo com ela. Ela tenta ajudar. Vem e senta em meu quarto; não se importa que ninguém fale, mas todo o tempo, eu estou tensa. Confio nela totalmente. Sei que não vai me pressionar a fazer nada. Eu absolutamente odeio ferir mamãe, mas a estou ferindo todo o tempo”.

Quantas mães já não estiveram nesta posição, e intrigadas! Mais tarde, Jane e eu retornamos a este tema e fizemos uma tentativa de desfazer um pouco da rigidez desta defesa.

Perguntei-lhe a respeito de sua própria vida e ela respondeu: “Oh, sim, está bem, superficialmente. Tenho montes de amigos. Posso dizer que a vida é tanto boa quanto repugnante”.

Perguntei-lhe: “Está trabalhando?” e ela replicou: “Não faço absolutamente nada. Nosso apartamento não é um lar. *Ninguém mora em parte alguma.* O problema com a mãe é que ela não é capaz de fazer um lar. Não somos uma família. Isto aflige mamãe todo o tempo. Imagino que veja a si mesma como continuando sozinha toda a vida — para sempre. O problema é que mamãe sempre tem a idéia de que *pode* ser capaz de tirar papai para fora de si mesmo e voltar a uma vida com a família, mas não existe qualquer esperança disso e não sei por que é que ela não pode percebê-lo”.

Outra longa pausa.

“Não estou falando mais com minha irmã; após se casar, ela me tratou mal e foi o fim. Ela diz que me ama, mas sempre teve ciúmes de mim e me odeia”.

Era evidente, contudo, pela maneira pela qual disse isso, que algo de um relacionamento positivo com a irmã fora retido. Em entrevista posterior, relatou gostar muito do cunhado e referiu uma reaproximação completa.

Perguntei: "Por que sua irmã tem ciúmes de você?"

Respondeu Jane: "Bem, por que sempre tive uma natureza fácil de se dar comigo, e ela sempre foi difícil".

(Este foi um primeiro esforço por explicar. Logo isto se desenvolve em tema principal.)

"Mamãe disse que eu devia lembrar-me de perguntar ao senhor porque ando cansada todo o tempo". (Em outras palavras, relatar a depressão.)

Após uma conversa a respeito de seu médico que tenho de omitir, embora contenha detalhes importantes, fiz um novo comentário sob a forma de pergunta: "Será que você não está se defendendo contra um elemento sexual em seu relacionamento com sua mãe?"

Perceberão que estava tentando lidar com as rígidas defesas de Jane em seu relacionamento com a mãe, e seus sentimentos conflitantes para com a irmã. Esta idéia de uma defesa contra a homossexualidade fez sentido para ela e debateu isso com tanta facilidade que rapidamente me dei conta de que a dificuldade principal *não* residia ali, onde eu havia esperado encontrá-la. Ela disse perceber que sua "repulsa de todo contato com a mãe era o negativo do elemento sexual no relacionamento". Isto a fez retornar à idade de sete anos, época de dificuldade particular no relacionamento com a mãe e, portanto, época de defesa especial contra o elemento sexual.

Disse ela: "Não sei se mamãe lhe contou como eu era quando pequena. Minha irmã, naturalmente, era sempre ativa e gritava, mas eu era retraída e quieta e não fazia barulho. Ficava muito emburrada e me escondia em armários. O problema é sempre este, o de que mamãe só tem a mim, eu posso ser apanhada em alguma coisa, de maneira que embora minha irmã e eu odiemos uma à outra, é um grande alívio quando ela anda em volta. Pelo menos, existem então duas de nós".

Aqui, ela deixou implícita a tremenda necessidade que poderia surgir da infelicidade e solidão da mãe. Havia, no entanto, um elemento que eu não entendia e a explicação só surgiu após o desenvolvimento ulterior do tema de seu relacionamento com a irmã. Em outras palavras, desejávamos mais luz sobre a defesa contra a intimidade com a mãe.

Após debater o relacionamento com a mãe em certo detalhe, Jane disse: "Mamãe tem uma visão de solidão e eu não quero ser envolvida por ela. Ela se sente real e vê as pessoas como indivíduos e, naturalmente, há sempre um elemento sexual onde existem sentimentos".

Jane disse como ela própria odiava ser chegada, fosse a quem fosse de sua família. Tinha de dormir no quarto junto ao da mãe e podia ouvir a mãe respirar, e isto era odioso por ser próximo demais. E, então, continuou repetindo como ela tinha sorte pelo fato de a mãe ser uma pessoa excepcionalmente inteligente e compreensiva, e enfatizando também toda a sua aflição por ter de feri-la todo o tempo.

Disse ela: "Mamãe tenta ajudar, mas não posso deixá-la. Chego em casa às quatro da manhã e ela sabe perfeitamente bem que estive dormindo com um homem, mas nunca interfere, de maneira alguma".

Jane inseriu isto aqui para sugerir que dormia com um homem e chegava em casa tarde para ferir a mãe tanto quanto para ter um homem. A tendência geral da conversa aqui tinha a ver com a capacidade de Jane em administrar os seus próprios casos.

Disse ela: "O problema é que não posso suportar pressões sociais ou políticas, e odeio a competição. Se sou realmente deixada a mim própria, posso dar conta, *por causa de algo que funciona dentro de mim*".

Ela estava descrevendo sua própria organização do ego e sua capacidade de acreditar em algo em si mesma e, portanto, no mundo também. Foi isto o que proporcionou confiança em meu relacionamento com ela e capacitou-me a confiar nos próprios processos dela e superar a sua reticência. Algumas pessoas são também enfermas e sabe-se que não se pode fazer isso com elas.

Prosseguimos falando a respeito da posição de Jane com relação à homossexualidade; exemplificando, uma garota de 14 anos apegou-se a ela e Jane fomentou isso. Obviamente a garota tinha uma paixão por Jane. Não se encontraram durante certo tempo e, então, ela deu de cara com a garota em uma festa. Conversaram e ela descobriu-se falando de maneira horrenda, dando a entender que a jovem não tinha importância. Disse Jane: "Cheguei a me dar um pontapé ao ver-me falando daquele modo. Depois, fiquei com a certeza de a garota era agora minha inimiga e traduzi algo que aconteceu nesses termos. Aparentemente, a moça pareceu cruzar a rua para evitar encontrar-me. Apesar disso, descobri que isso era um *delírio* porque a garota continuou com sua paixão". Acrescentou Jane: "Garotas mais jovens estão sempre gamando por mim, e rapazes menores também".

Aqui se achava a familiaridade de Jane com as idéias de referência do paranóico e com a associação disto tudo com o homossexualismo.

Ela me forneceu então um retrato da vida em uma escola de moças. Disse ela: "Automaticamente as moças se separam em meninos e meninas e eu rapidamente tornei-me um rapaz neste processo de agrupamento". Descreveu então os relacionamentos entre as moças, quão fúteis as coisas se tornam no ponto de contato, coisas que nenhuma das duas moças aprovaria, coisas que são ditas e coisas que são feitas. Juntos, elaboramos o que isto tinha a ver com *manter as duas moças essencialmente separadas*. Obtive aqui um retrato das técnicas para o adiamento indefinido, antes que para chegar às vias de fato em um relacionamento. Jane prosseguiu descrevendo rapazes reais que ficavam loucos por ir para a cama com as garotas, não porque quisessem sexo ou porque gostassem das moças. Para eles, isso constituía uma técnica de lidar com o relacionamento, com o rapaz e a moça, cada um deles, desejando permanecer intacto e isolado. Desta maneira, que era a própria maneira de Jane, abordamos o tema principal, qual seja, o conflito subjacente à ambivalência de Jane em relação à irmã e a sua defesa contra a intimidade com a mãe.

Havia uma importância especial para ela desta fusão e defesa contra fusão. Não ingressamos nisso imediatamente. Em outras palavras, o ato sexual físico mantinha as duas personalidades livres quanto ao fundir-se e a outros mecanismos que pudessem ameaçar a qualidade intacta do indivíduo. Ela andava procurando e encontrando o tipo de rapaz que vai para a cama; eles têm um relacionamento sexual e, depois, se separaram. Encontraram-se e separaram-se e nenhum dos dois afetou o outro, e, a cada vez, um perigo foi evitado. Cada um dos dois manteve sua própria individualidade. De maneira que aqui novamente temos um tema que é especialmente importante para Jane, mas pertence também a todos os adolescentes. Seguiu-se aqui uma descrição da origem da atual depressão de Jane em uma tentativa fracassada de obter contato com o pai. Tenho de deixar isto de fora, mas no decurso do que foi descrito, ela disse: "Mãe esteve todo o tempo tentando ajudar, mas era-lhe impossível fazer coisa alguma exceto irritar-me". Disse para ela: "Não confie em mim, mas realmente, o senhor sabe, sou merecedora de confiança. Sei o que está acontecendo. Sei que não vou descarrilar, e, naturalmente, sei também que há sempre este histrionismo por cima de tudo o mais, tal como exagerar para irritar alguém ou competir com minha irmã".

Seguiu-se então o que para mim foi o surpreendente fragmento de *insight* relativo ao relacionamento de Jane com a irmã, a quem ama e odeia. Terminarei com o

relato deste pormenor, que esclareceu um pouco do mistério existente em seu relacionamento com a mãe. (Foi-me difícil tomar notas, como sempre o é nos momentos importantes de uma entrevista. Imagino que a maior parte das pessoas nesta sala saiba disso.)

Acho que eu disse: "Quer dizer que os estados retraídos e os seus amuos são a sua apólice de seguro". Ela concordou com isto, mas havia obviamente algo mais complicado que tinha de ser enunciado. Falamos a respeito do relacionamento com a irmã e algo que ainda persistia dos primeiros anos nesse relacionamento e de como ele se achava atualmente em uma fase negativa. Falei a respeito do relacionamento muito rico que ela havia tido com a irmã nos jogos da infância e ela tomou este assunto.

(Perceberão que eu estava ainda tentando chegar à *homossexualidade no relacionamento*, uma falsa linha de pesquisa, tal como se revelou.)

Jane não se achava indisposta a perceber a homossexualidade e já havia lidado de modo bastante livre com a idéia homossexual em relação à mãe. Mas disse-me que não era isto o que acontecia entre ela e a irmã. O relacionamento com esta última nos jogos é que *as suas personalidades se fundiam*. Elas eram dois aspectos da mesma pessoa, disse. Passou então para a história do desenvolvimento do relacionamento. Tínhamos aqui a irmã, uma criança ativa e berrenta que odiara totalmente o nascimento de Jane quando ela própria estava com 14 meses. A reação das duas irmãs não foi idêntica, é claro.

(Nessa época do crescimento elas tinham, naturalmente, sempre idades diferentes, mas estávamos lidando aqui com uma coisa específica: quatorze meses não é geralmente idade suficiente para uma reação total de uma criança no nascimento de um novo bebê. Há um bocado de diferença entre 14 meses, 16 meses ou 17 meses, não há? A identificação com a mãe e outros mecanismos não se acham ainda inteiramente desenvolvidos.)

Minha irmã me odiava e também me assumiu como um aspecto de si própria. Em reação a isso, permiti-me ser assumida como um aspecto dela e, alternativamente, desenvolvi uma técnica de retraimento. Os jogos, portanto, eram entre dois aspectos de uma só pessoa, e esses dois aspectos eram compostos das metades de cada uma de nós. A metade da minha irmã era a dominante.

Apesar da patologia de tudo isto, a riqueza extrema do intercâmbio nunca pôde ser perdida, embora, de momento, esteja desperdiçada, pois essas duas irmãs se acham agora separadas. Cada uma delas está tentando estabelecer um *self* unitário total. Um dia, possivelmente, haverá uma reunião por uma maneira ou outra que seja aceitável.

A maneira pela qual a paciente me transmitiu isto era suficientemente clara, mas eu não a passei de modo claro a vocês. Havia ela e metade dela achava-se envolvida com a irmã. Fora a decisão da irmã, por causa de sua incapacidade de ter um relacionamento maduro com esta idéia da chegada de um novo bebê. Desse modo, ela e a irmã eram como uma só pessoa total, mas sobrou para Jane uma metade que é a parte mais importante de si, que foi passar a maior parte de sua vida dentro de armários e retraída. Por ser retraída foi que veio a mim. E a irmã possuía sua outra metade que repudiava a idéia de uma irmã, era extrovertida em temperamento e levava uma vida que tinha de ser separada da irmã e tinha de negar a importância de Jane. As irmãs tinham de separar-se uma da outra para se estabelecerem como *selves** unitários.

* Em pertinência à decisão técnica de manter o termo *self* em inglês, devido ao seu uso corrente no linguajar psicanalítico em nosso idioma e por causa das complexidades implicadas em sua tradução, utiliza-se também seu plural, em inglês *selves*. (N. dos R.)

A partir deste *insight*, Jane conseguiu descrever um outro detalhe muito importante de seu problema. Ela enumerou toda a esquizofrenia que existia em ambos os lados da família. Disse que o que a incomodava em sua doença era haverem duas dela própria; uma ficava do lado de fora, olhando para a outra que era retraída e olhada. Isto parecia ser a coisa importante que Jane veio dizer-me, embora não soubesse de modo algum, ao chegar, o que era que estava vindo me contar.

Fiz aqui outra interpretação, levantando o que me havia sido contado. Conseguiu passar sobre o relacionamento com a irmã, tal como ela o havia descrito. Por fora da fusão, existiam a metade retraída de Jane e a metade extrovertida da irmã.

Disse-lhe que podia ver que o problema entre ela e a mãe era não apenas esta defesa contra a homossexualidade e contra o envolvimento na aflição e solidão essenciais da mãe. Podia ver que havia um perigo pior sentido por Jane, o de que se ela fizesse uso da mãe, então haveria, do lado de Jane, uma repetição do relacionamento de fusão do tipo que havia contido tanto perigo, bem como tanto de positivo nele, em relação à irmã. Em outras palavras, ela temia que a mãe assumisse o lugar da irmã nessa fusão, pois isto daria início de novo ao estado anormal de coisas que, historicamente, baseava-se no ódio da irmã e na adaptação de Jane a este ódio. A esperança de Jane residia em uma evolução para fora do estado retraído, mas isso significava que teria de tolerar sentir-se cindida e apegar-se à idéia de que tanto a observadora quanto a observada nessa cisão equivaliam a seu *self* unitário. Antes de relacionar-se à mãe, ela tinha de alcançar um *self* unitário ou identidade unitária.

Tudo isto fez sentido para Jane, por ser complexo e verdadeiro: qualquer simplificação não teria feito sentido algum e então passamos a uma discussão prática de como lidar com a Mãe.

Um ano se passou desde estas duas primeiras das cinco entrevistas “à vista”, e posso relatar um bom progresso, nem forçado adiante e nem retido. Ainda estou sendo usado como um irmão-mãe.

Conclusão

Espero que tenham obtido desta descrição de caso algo do que obtive da experiência real. Senti-me muito próximo da sensibilidade desta moça adolescente e de seu contato vivo com seus mecanismos primitivos e estados próximos da doença. Não há praticamente um só transtorno psiquiátrico que não tenha sido a florado, mas contudo, acho que a moça é sadia. Duvido que vá ser tão interessante ou tão penosamente próxima da verdade crua quando estiver com 25 anos. Aos 17, é uma jovem notável e desajeitada.

Incidentalmente, o processo da consulta psicoterapêutica conduziu Jane e a mim a este *insight* inesperado da etiologia de sua penosa cisão em seu relacionamento com a irmã, e ele proporcionou uma explicação do medo que a moça tinha de envolvimento com sua amada e solitária mãe. O impulso da reação da moça à situação psicoterapêutica fez-nos chegar a um fator etiológicamente importante e é isto que desejo acentuar especialmente na apresentação deste detalhe clínico, apenas o retrato de uma moça.

43

Um Caso de Psiquiatria Infantil que Ilustra a Reação Retardada à Perda

*Redigido para uma coleção de ensaios em memória
de Marie Bonaparte, 1965¹*

No dia de seu décimo primeiro aniversário, Patrick sofreu a perda do pai por afogamento. A maneira pela qual ele e sua mãe precisaram de auxílio profissional e o utilizaram ilustra a função do psicanalista na psiquiatria infantil.

No decurso de um ano, Patrick foi recebido em entrevista dez vezes e sua mãe quatro, e, nos quatro anos que se passaram desde a tragédia, mantive-me em contato, através de conversas telefônicas com a mãe, com o estado clínico do rapaz, assim como com o manejo dado pela mãe ao filho e a si própria. A mãe começou com muito pouca compreensão e psicologia e uma considerável hostilidade por psiquiatras, gradualmente desenvolvendo as qualidades e o *insight* que se faziam necessários. O papel que ela teve de desempenhar foi, com efeito, a amamentação mental de Patrick durante o colapso deste. Ela ficou muito encorajada por ser capaz de empreender esta pesada tarefa e alcançar sucesso nela.

Família

O pai trabalhava em uma das profissões liberais. Havia alcançado considerável sucesso e tinha perspectivas muito boas. Juntos, ele e a esposa tinham um grande círculo de amigos.

Dois filhos haviam nascido do matrimônio, um rapaz que se achava na universidade e Patrick, interno de uma escola preparatória bem-conhecida. A família tinha uma casa em Londres e um *cottage* para férias em uma linha do largo da costa. Foi no mar próximo ao *cottage* de férias que o pai se afogou, quando velejava com Patrick no dia do seu 11º aniversário.

1. *Drives, Affects, Behavior: Essays in Memory of Marie Bonaparte*, vol. 2, org. de Max Schur (New York, International Universities Press, 1965).

A Evolução do Contato do Psiquiatra com o Caso

A evolução deste caso é fornecida com detalhes e de modo tão exato quanto possível porque ele ilustra certos aspectos do trabalho psiquiátrico infantil que considero serem vitalmente importantes.

Sempre que possível chego à história de um caso através de entrevistas psicoterapêuticas com a criança. A história coligida desta maneira contém os elementos vitais e não tem importância que, sob certos aspectos, assim obtido, ela revele-se incorreta, pois ela própria envolve, de acordo com a capacidade que a criança tenha de tolerar os fatos. Faz-se um mínimo de indagações, por amor à apresentação e para o fim de preencher lacunas. Incidentalmente, o diagnóstico revela-se ao mesmo tempo. Por este método, fica-se capaz de avaliar o grau de integração da personalidade da criança, sua capacidade de sustentar conflitos e tensão, as defesas dela, tanto em força quanto em espécie, e pode-se fazer uma avaliação da família e da confiabilidade ou inconfiabilidade do meio ambiente geral. Em certos casos, pode-se descobrir ou situar com exatidão intrusões ambientais contínuas ou em continuação.

Os princípios aqui enumerados são os mesmos que caracterizam um tratamento psicanalítico. A diferença entre a psicanálise e a psiquiatria infantil é principalmente que, na primeira, tenta-se ter a oportunidade de fazer tanto quanto possível (e o psicanalista gosta de ter cinco ou mais sessões por semana), enquanto que na última pergunto-me: qual é o mínimo que se precisa fazer? O que se perde fazendo-se tão pouco quanto possível é balanceado por um lucro imenso, uma vez que na psiquiatria infantil tem-se acesso a um vasto número de casos (tais como o atual) para os quais a psicanálise não constitui uma proposta prática. Para minha surpresa, descobri que o caso psiquiátrico infantil tem muito a ensinar ao psicanalista, embora a dívida se ache principalmente no outro sentido.

Primeiro Contato

Uma mulher (que revelou-se ser a mãe de Patrick) telefonou sem qualquer aviso para dizer que havia relutantemente decidido assumir o risco de consultar alguém a respeito do filho, que se encontrava em uma escola preparatória, e que um amigo havia-lhe dito que eu provavelmente não era tão perigoso quanto a maioria da minha espécie. Eu certamente não teria podido ter previsto, neste estágio inicial, que ela se mostrasse capaz de acompanhar o filho através de uma doença séria.

Foi-me dito que o pai do menino se afogara em um acidente náutico, que Patrick até certo ponto fora responsável pela tragédia e que ela, a mãe, e o filho mais velho, achavam-se ainda muito perturbados e que o efeito do acidente sobre Patrick fora complexo. As provas clínicas de distúrbio em Patrick haviam sido retardadas e agora parecia desejável que alguém as investigasse. Patrick sempre fora devotado à mãe e, desde o acidente, havia-se tornado (como ela disse) "emocional".

Neste sucinto relato de uma longa conversa telefônica não tentei reproduzir a torrente de palavras da mãe, nem seu ceticismo com referência aos serviços psiquiátricos.

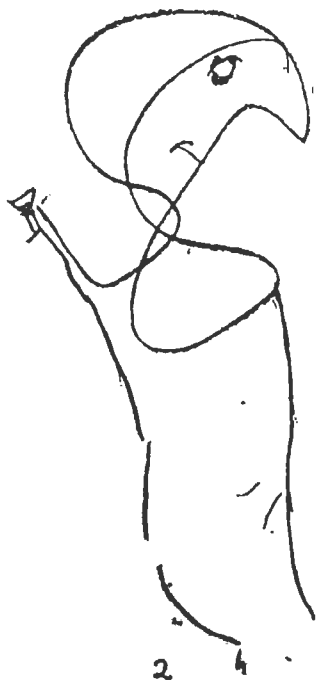
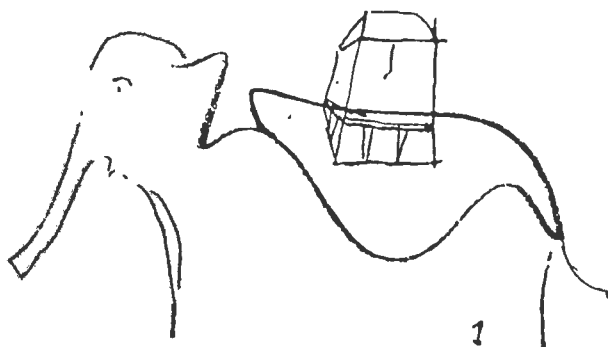
Primeira Entrevista com Patrick (dois meses após a conversa telefônica acima mencionada)

Patrick foi trazido pela mãe. Achei-o de complexão leve, com uma cabeça grande. Era obviamente inteligente, alerta e simpático. Concedi-lhe o tempo integral da entrevista (duas horas), e não houve ponto algum durante ela em que o relacionamento

entre ele e eu fosse difícil. Somente durante a parte mais tensa da consulta, foi-me impossível tomar notas. A descrição que segue foi redigida após a entrevista.

Patrick disse que não estava se saindo muito bem na escola, mas que "gostava de esforços intelectuais". Achávamo-nos sentados à uma mesa baixa e redonda, com lápis e papel à mão, e começamos a jogar o Jogo do Rabisco. (Neste jogo, faço um rabisco para que ele o transforme em algo e, depois, ele faz um outro, para que dele eu faça algo.)

1. Ele transformou o meu rabisco em um elefante.



2. Transformou o seu próprio em "uma abstração de Henry Moore". Demonstrou aqui achar-se em contato com a arte moderna e, posteriormente, tornou-se claro que isto é algo que pertence ao seu relacionamento com a mãe. Ela toma parte ativa em mantê-lo bem informado sobre o mundo artístico, que foi importante para ele desde a idade de cinco anos. Isto mostra também o seu senso de humor, que, prognosticamente, é importante, bem como sua tolerância da loucura, da mutilação e do

macabro. Poder-se-ia dizer que demonstra também que ele possui talento como artista, mas isto surge de modo mais claro em um desenho posterior. Sua escolha por transformar seu rabisco em uma abstração achava-se relacionada ao perigo, muito real em seu caso, de que, por causa de sua capacidade intelectual muito boa ele escapasse a tensões emocionais para um intelectualismo compulsivo e, por causa dos temores paranóides, que mais tarde se tornaram evidentes, pudesse haver aqui base para um sistema organizado de pensamento.

3. Transformei o rabisco dele em duas figuras, que chamou de “mãe segurando um bebê”. Eu não sabia, na ocasião, que já havia aqui uma indicação de sua principal necessidade terapêutica.

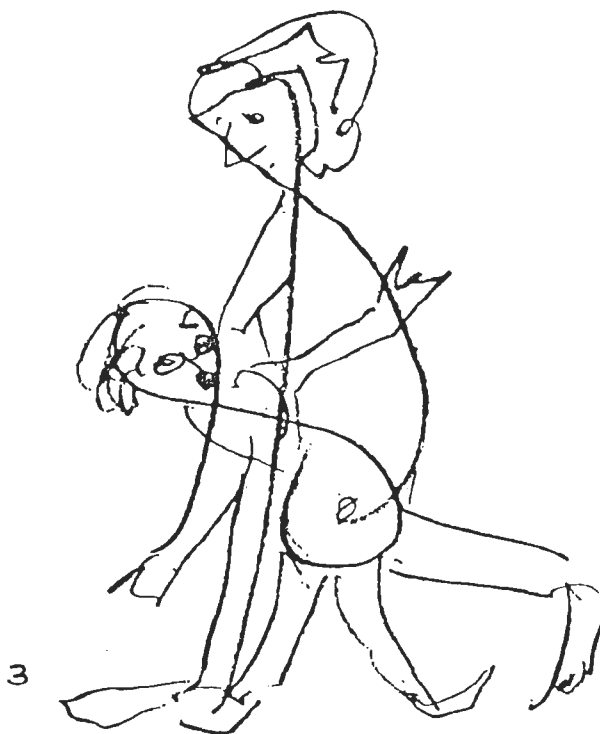
4. Ele transformou meu desenho em uma produção artística. Foi feita com rapidez e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Disse que era uma árvore existente em F. Eu não sabia, na ocasião, que F. fora o local da tragédia, mas neste desenho, já se achava incorporado o impulso a lidar com o problema que rodeava a morte de seu pai.

5. Foi este o seu desenho, feito a meu pedido, da ilha de férias, mostrando F.

6. Ele transformou o seu próprio desenho em “uma mãe repreendendo uma criança” e aqui podia-se perceber algo de seu desejo de ser punido pela mãe.

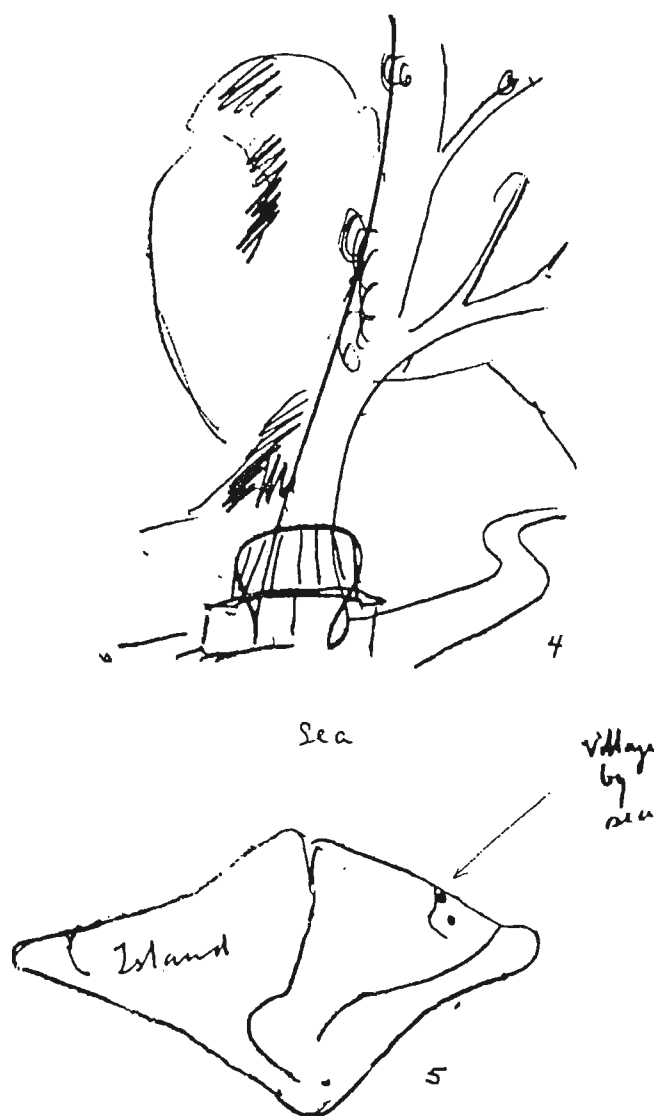
7. Ele transformou o meu em Droopy*.

8. Transformei o dele em algum tipo de figura cômica de menina.



9. Este foi importante. Ele transformou o meu rabisco em uma escultura de uma cascavel. “Poderia ter sido feita por um artista moderno”, disse ele. Neste caso, ele apropriou-se de um rabisco com toda a sua loucura e incontinência e transformou-o em uma obra de arte, por este modo conquistando controle de um impulso que ameaça ficar fora de controle.

* Personagem de desenho animado. (N. do T.)



10. No seguinte, ele transformou o seu próprio desenho em uma espécie de mão esquisita e disse que poderia ter sido desenhada por Picasso. Isto conduziu a uma discussão do pintor em que ele exibiu o seu conhecimento de Picasso de uma maneira que me soou um pouco precoce. Concordamos que a recente exposição do pintor na Tate Gallery fora muito interessante. Ele fora vê-la duas vezes. Disse que gostava mais do Picasso do período "rosa" e "azul" e parecia saber o que isto queria dizer, mas eu estava ciente de que ele falava uma linguagem pertencente à sua discussão destes assuntos com a mãe.

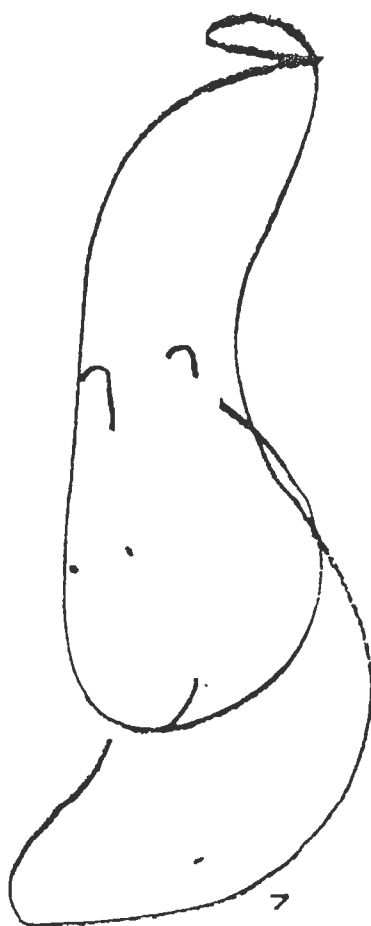
11. Este foi uma figura bastante surpreendente. Ele transformou meu rabisco em uma pessoa a escorregar em alguma comida de cachorro. Há um bocado de vida no desenho, mas não consegui descobrir por que esta idéia surgira. Pensei que estava debochando de mim ou, talvez, de todos os homens.

Ele começou então a falar e o desenho tornou-se menos importante. Aquilo de que falou incluiu o seguinte:



No primeiro período da escola tivera um sonho. Estivera doente com algum tipo de epidemia duas noites antes da metade do período, que, disse ele, é “uma época excitante para um novo vírus”. No sonho, a Zeladora lhe disse para levantar-se e ir para o saguão onde os vagabundos eram alimentados. A Zeladora gritou: “Estão todos aqui?” Havia 15, *mas um estava faltando*, e ninguém sabia quem era que faltava. Era esquisito, de certa maneira, porque não havia nenhuma pessoa extra. E então havia uma igreja sem altar, e uma sombra onde este havia se erguido.

O resto tinha a ver com um bebê pulando para cima e para baixo, do qual ele fez um desenho (nº 12). O bebê estava gritando, pulando para cima e para baixo sobre o colchão. Disse Patrick que o bebê tinha cerca de 18 meses de idade. Perguntei-lhe se havia conhecido bebês e respondeu: “Cerca de três”. Parecia, contudo, que no sonho estava se referindo à sua própria infância. Este sonho permaneceu obscuro, mas seu significado foi elucidado na quarta entrevista, quatro semanas mais tarde. Achou-se que havia uma referência ao pai morto na única pessoa que faltava.

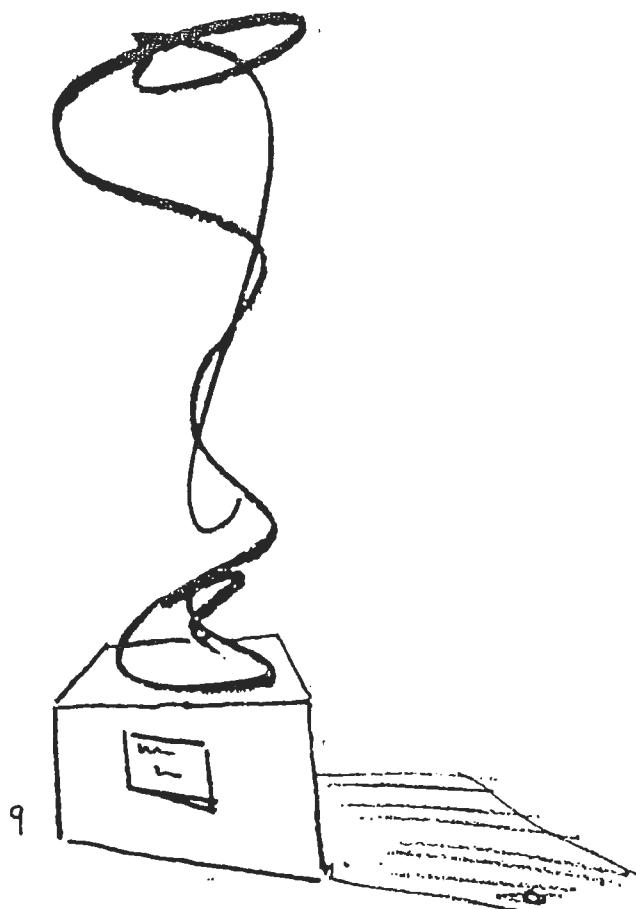




Neste estágio, eu não sabia que não lhe haviam contado em seguida a respeito da morte do pai.

13. Este foi o seu desenho da igreja com uma sombra em vez de um altar.

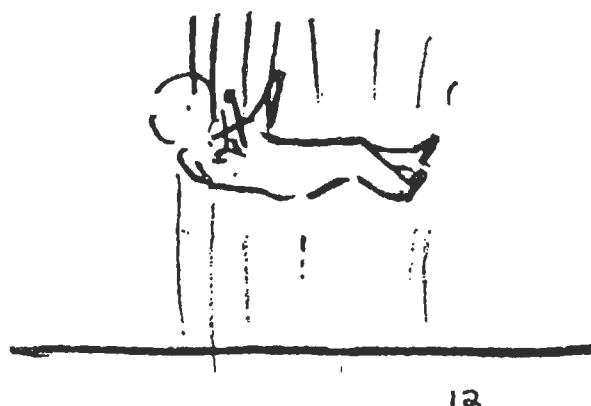
Perguntei-lhe: "O que seria um sonho bom?" e ele respondeu rapidamente: "Felicidade, ser cuidado. Sei que é isto o que quero".



Quando lhe fiz a pergunta, disse saber o que era a depressão, especialmente desde a morte do pai. Tinha amor por este, mas não o via muito. "Meu pai era muito bom. Mas o fato é que mamãe e papai estavam constantemente sob tensão". Prosseguiu falando a respeito do que havia observado: "Eu era o elo que os unia; tentei ajudar. Para papai, era afrontoso dispor antecipadamente algo. Este era um de seus defeitos, e mamãe, portanto, se queixava. Eles eram, na realidade, muito condizentes um com o outro, mas sobre pequenas coisas, começavam a discutir um com o outro e a tensão se formava repetidas vezes e a única solução para isto era eu reuni-los. Papai trabalhava demais. Ele pode não ter sido muito feliz. Era uma tensão grande para ele chegar em casa cansado e, então, a sua esposa lhe falhar". Em tudo isto Patrick demonstrou um grau inusitado de *insight*².

2. Foi esta qualidade de Patrick que me fez desejar apresentar este caso no livro de Marie Bonaparte, porque temos provas claras do profundo *insight* que Marie Bonaparte tinha quando se achava no estágio da latência; ver *Five Copy-Books* (London: Imago, 1950). — D. W. W.



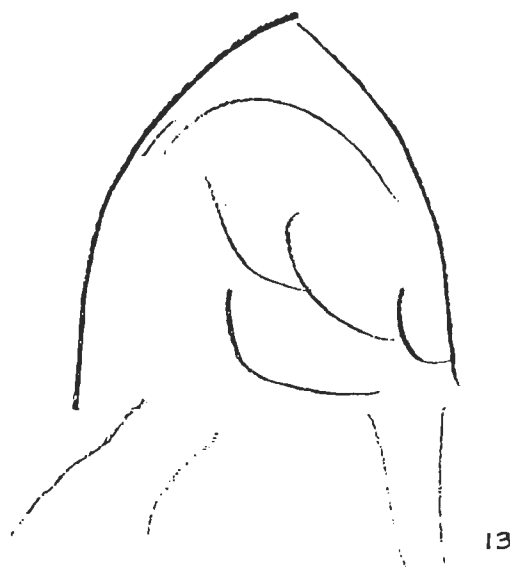


O resto desta longa e espantosa entrevista consistiu em repassarmos com grandes detalhes o episódio em que o pai faleceu. Disse que o pai "pode ter cometido suicídio"³ ou talvez fosse sua própria culpa (de Patrick); era impossível saber. "Após longo tempo na água começa-se a lutar por si próprio". Patrick tinha um cinto salva-vidas e o pai, nenhum. Ambos quase se afogaram, mas algum tempo após o pai haver afundado, quando estava quase escuro, Patrick foi resgatado por acaso. Durante algum tempo não se deu conta de que o pai havia morrido e, a princípio, foi-lhe dito que estava no hospital. Então Patrick disse que, houvesse o pai sobrevivido, ele achava que a mãe teria cometido suicídio. "A tensão entre os dois era tão grande que não era possível que pudessem continuar sem que um deles morresse". Havia, portanto, um sentimento de alívio, e Patrick indicou que se sentia muito culpado por causa disto. (Entender-se-á que isto não deve ser tomado com um retrato objetivo e final do relacionamento entre os pais. Era verdadeiro, no entanto, para Patrick.)

3. Há boas evidências de que nenhum dos pais era de fato suicida. — D. W. W.

Ao final, ele tratou dos temores muito grandes que havia tido desde o início da infância. Descreveu o seu grande medo associado com alucinações visuais e auditivas e *insistiu em que a sua doença, se estava doente, precedia a tragédia.*

14. Este é um desenho da casa de Patrick, assinalados os diversos lugares em que figuras masculinas persecutórias aparecem. A principal área do perigo situava-se na privada e só existia um único lugar para ele usar quando urinava, se é que queria evitar alucinações persecutórias.



Havia neste sistema fóbico uma qualidade que parecia pertencer de modo mais natural a uma idade emocional de quatro anos, antes que de 11, com fobias estreitamente associadas a alucinações. Toda a questão foi debatida em termos de vida onírica a derramar-se sobre a vida desperta e, juntamente com isto, a idéia da tragédia como uma alucinação, mas apesar disso, real. Patrick descreveu o pânico como estar-se em um pesadelo quando desperto. As alucinações que tem são fantasmas de um homem vingativo a retornar, mas elas antecedem a tragédia.

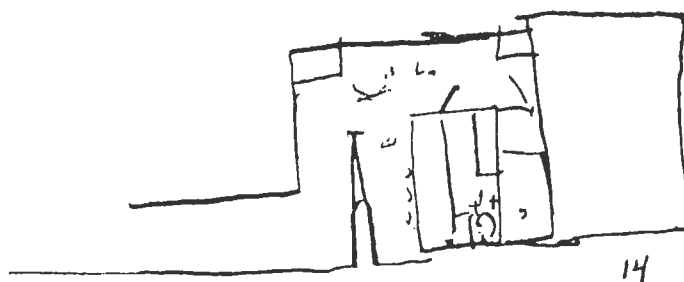
Notar-se-á que um desenho que veio com um impulso poderoso desde o inconsciente (nº 12) não teve significado para ele. Não fez nada a respeito dele, embora me parecesse transmitir uma qualidade maníaca de defesa. Ele demonstrou ser o mais importante dos desenhos, mas tive de esperar até a quarta entrevista (cerca de um mês depois) para obter um entendimento exato sobre ele.

O acento, nesta entrevista, recaiu sobre o incidente do afogamento, lembrado e descrito de maneira bastante desligada. Após duas horas, nós dois já havíamos tido o bastante. Provavelmente, ambos sabíamos que havia muito mais a ser feito, mas não dissemos isso um ao outro. O efeito sobre Patrick foi que ele conquistou confiança em mim e o efeito sobre mim mesmo foi que agora eu sabia bastante a seu respeito desde dentro dele.

Desta primeira entrevista obtive um vislumbre da personalidade e do caráter do paciente. Em acréscimo, aprendi:

1. Patrick estava começando a sentir-se culpado a respeito da morte do pai.

2. Ainda não se sentia triste.
3. Sentia-se ameaçado pela chegada de sentimentos que haviam sido por tanto tempo retardados.
4. Tinha um medo de doença, e havia base para isto na enfermidade oculta que datava dos primeiros anos, com uma tendência à alucinação.
5. Havia indicação de um importante fator desconhecido, representado pelo desenho inexplicado do bebê a saltar.



6. Na escola, tivera moléstias indefinidas, para as quais havia buscado o cuidado da Zeladora. Mais tarde, descobri que havia produzido os seus sintomas de modo deliberado, sem saber como obter de outro jeito o cuidado especial e pessoal de que precisava. Isto havia se dado no outono, quando supostamente se achava inteiramente feliz e bem, e "não afetado pela morte do pai".

7. Havia indicação forte de que Patrick tinha uma crença na existência de pessoas confiáveis e observei que esta sua fé podia ser usada, se necessário, para fins terapêuticos: na derrubada de suas defesas e no reviver regressivo de suas experiências. Em tal caso, ele precisaria de um alto grau de dependência em alguém. Na realidade, fui capaz de utilizar a mãe, que, apesar de dar uma impressão neurótica, mostrou ser capaz de agir como enfermeira psiquiátrica de Patrick. O sonho bom: "Felicidade, ser cuidado; sei que é isto o que quero" foi a indicação que posteriormente utilizei como indicador para a administração. Nada possuía para dizer-me, neste estágio, se a mãe poderia ou não atender à necessidade dele (ser cuidado); na realidade, parecia que pudesse ser a pior pessoa para isso, antes que a melhor.

Patrick retornou à escola interna.

O acontecimento seguinte foi um chamado de emergência, partido da mãe e de Patrick: poderia eu vê-lo imediatamente? Patrick havia fugido da escola e tomara o trem de volta para casa, carregado de livros latinos. Disse que retornara para casa a fim de estudar latim, uma vez que não conseguia fazê-lo na escola e estava desapontando esta. Fizera um esforço terrível para aprender latim todo o caminho no trem e, em casa, retirara-se para a cama, a fim de continuar o esforço intelectual. Notar-se-á que ele era totalmente incapaz de pedir ajuda, por causa da ameaça de colapso mental.

Segunda Entrevista com Patrick (duas semanas após a primeira)

Foi comparativamente uma entrevista com poucos acontecimentos. Patrick disse que pensara em fugir no período do outono. A coisa fora que um rapaz havia cometido um erro elementar e um professor dissera desse aluno que ele merecia ser surrado e que não merecia estar na escola. Patrick reagira de modo intenso a este incidente de

menor monta. Fez-se de doente e foi para a enfermaria. Ele geralmente apresentava uma disposição paranóide, com hipersensibilidade a qualquer idéia de castigo ou censura. O diretor de seu internato, normalmente uma pessoa benevolente em sua vida, tornara-se uma ameaça.

Clinicamente, Patrick tornara-se uma pessoa psiquiatricamente enferma, sem *insight* e com ansiedades do tipo paranóide.

Após um quarto de hora, ele abandonou a racionalização de que fora o medo do fracasso em latim que o trouxera de volta e disse abertamente que fora a primeira entrevista e o que obtivera dela o que o havia feito voltar, embora não houvesse sabido disto até concretamente ter vindo me ver. Descreveu como a leve palavra de desaprovação por parte do professor vinculava-se com vozes alucinatórias. Ele não temia ser concretamente punido, porque ser punido era, em sua mente, mantido separado das vozes alucinadas.

Aconselhei que ele ficasse em casa durante o fim de semana e arranjei isto com a escola. Os funcionários desta me disseram que consideravam a mãe de Patrick *perturbada demais para ser boa para ele*, mas insisti em que ele ficasse em casa.

Terceira Entrevista com Patrick (quatro dias mais tarde)

No domingo, Patrick deveria retornar à escola. Ele se trancou no banheiro e não saía, e tampouco queria ver-me. Foi persuadido a sair e trazido para ver-me como uma emergência. Tive que seduzi-lo para sair do carro esporte do irmão.

Esta terceira entrevista foi muito intensa e não consegui tomar notas. Constituiu uma comunicação em nível mais profundo, na qual Patrick me contou muita coisa a respeito de si e de sua família. Ao final, eu disse: "Você não vai retornar à escola, mas irá para o *cottage* de vocês na ilha. *Você está doente*. Enquanto estiver, pode ficar com a sua mãe e eu direi a ela o que fazer. Tratarei com a escola a respeito de você". O importante foi que lhe disse que estava doente.

Ele fez um último esforço para protestar, lembrando tudo o que estava esperando do período de verão na escola, especialmente a pintura, e, depois, com um suspiro de alívio, aceitou o que eu havia dito.

Comentário: Ele estava agora *oficialmente enfermo*. Este foi o momento decisivo da administração do caso. Poder-se-ia dizer que, a partir dele, Patrick deu início a um lento processo de recuperação. Clinicamente, porém, o primeiro salto para a frente ocorreu após a entrevista seguinte, na qual o fator desconhecido da primeira entrevista veio a ser elucidado.

A escola mostrou-se prestativa, ainda que cética. O diretor veio até Londres, fez uma visita a Patrick e ficou combinado que este retornaria à escola quando estivesse bem de novo, sem ser apressado ou apoucado.

Quarta Entrevista com Patrick (três dias depois)

Patrick veio sozinho. Disse que viera por uma razão específica, qual seja, a de que agora entendia o desenho do bebê a pular (nº 12)

Tentando chegar ao significado deste desenho inesperado, estivera conversando coisas com a mãe e esta lhe contara a história do comportamento dele quando tinha um ano e meio e ela tivera de afastar-se durante "seis semanas", para uma operação. Enquanto a mãe estivera ausente, ficara com amigos que imaginava serem adequados, mas eles o haviam deixado cada vez mais excitado. O pai o visitava todos os dias. Neste período, Patrick tornara-se superexcitável, parecendo feliz, sempre rindo e

pulando para cima e para baixo. Disse ele: "Era como no desenho e, quando mamãe me falou a respeito, lembrei-me das barras do berço". Quando a mãe retornou do hospital (continuou ele a contar-me), ele a viu no carro dela e subitamente toda a animação sumiu; ele subiu para o seu colo e adormeceu diretamente. Diz-se que dormiu durante 24 horas e que a mãe o manteve com ela todo o tempo. (Esta foi a primeira experiência que a mãe teve do cuidado psiquiátrico de Patrick, do qual estava a ponto de ter a segunda.)

Patrick estivera me descrevendo um incidente real, do qual lembrara a impressão que tivera. Foi um período de perigo com um ano e meio de idade, de um *crescendo* de defesa maníaca, que rapidamente se transformou em depressão quando do retorno da mãe. Evidentemente nessa época houvera perigo real de um rompimento do fio da continuidade de seu ser. A mãe voltara exatamente a tempo e soube que tinha de deixá-lo dormir em seu colo até que acordasse.

Patrick me contou tudo isto com um sentimento profundo e prosseguiu dizendo: "O senhor vê, eu nunca mais fui capaz de ficar inteiramente seguro quanto à mamãe desde então, e isto me fez apegar-me a ela, e isto significava mantê-la afastada de papai; eu mesmo não tinha muito uso para papai".

Em tudo isto Patrick estava descrevendo a enfermidade que *precedeu* a tragédia em que o pai morreria. Patrick sentiu, neste estágio, que havia conseguido contornar todo o episódio, que naturalmente poderia ter terminado de modo feliz, mas na realidade acabou em catástrofe. Disse que realmente havia esperado que a mãe ficasse satisfeita quando o pai morreria e o pesar inesperado dela havia simplesmente deixado-o confuso. Não conseguira reagir ao episódio real do afogamento (exceto pelos transtornos psicossomáticos na escola) até a primeira entrevista comigo, ou seja, oito meses após a tragédia.

Patrick foi embora desta entrevista *imensamente aliviado* e sua mãe relatou uma melhora clínica acentuada, que persistiu e gradualmente conduziu à recuperação dele.

Patrick tornou-se então capaz de criticar a mãe sem perder o amor por ela. Em suas palavras: "Dois dias com ela, ótimo! Outros dois, horrível!"

Incidentalmente, descrevendo uma exposição de arte a que foi com um amigo, disse ele: "Quadros e pintura, é por isso que estou vivo". Ele podia agora me dizer: "Depressão quer dizer que o mundo chega a um fim".

A Regressão como Característica no Estado Clínico

Começou então um período indefinido de regressão. Ele transformou-se em um menino de quatro anos, indo a toda a parte com a mãe e segurando-lhe a mão. Ninguém sabia quanto tempo isto iria durar. Patrick passava no *cottage* de férias grande parte do tempo. Então uma gata perdida teve quatro gatinhos. Patrick pareceu identificar-se completamente com a mãe gata. Acabou por trazer os gatinhos para Londres, para que eu os visse, e abriu o fecho *zipper* de sua sacola em minha sala; dela pularam fora quatro gatinhos que se espalharam pela casa toda.

A mãe me telefonou (três semanas mais tarde) para informar-me que uma carta lhe havia sido entregue em mãos, escrita por Patrick em uma letra muito infantil. A carta dizia:

1. Você me ama?
 2. Muito obrigado.
 3. Posso ver logo o Dr. D. W. W.?
- E, assim, uma nova visita foi marcada para o dia seguinte.

Quinta Entrevista com Patrick

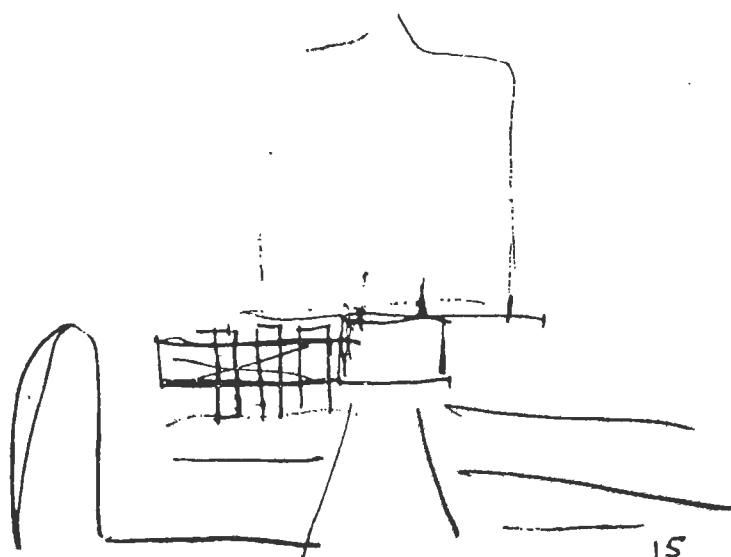
Patrick tivera um sonho e ficara assustado o dia inteiro. Este sonho foi sonhado para a entrevista e é interessante que ele soubesse que estava sujeito a ter esse sonho, de maneira que me pediu uma entrevista vários dias antes de sonhá-lo. Foi um sonho longo, um pouco do qual consegui anotar.

O Sonho

Havia uma igreja e a igreja tinha um altar (cf. sonho anterior da igreja sem altar). Havia três caixas e era geralmente entendido que nelas haviam cadáveres. Achava-se que a mais distante, à esquerda, tinha mais probabilidade de transformar-se em fantasma, mas na realidade foi a mais próxima que se tornou um. Ele apresentou alguns sinais de vida e sentou-se. Tinha um rosto sério e parecia ter morrido afogado. De modo bastante curioso, este fantasma era feminino. Era uma menina e, descrevendo-a, ele utilizou a palavra "prístina". (Era bastante característico dele usar uma palavra como essa.) Disse que isso era presságio.

Um pouco da análise deste sonho foi efetuada no decurso da análise de outros sonhos: Ao final, revelou-se que ele sentira que o fantasma era o fantasma do pai, mas do aspecto feminino deste. Disse então que as brigas entre o pai e a mãe eram entre o *self* masculino da mãe e o *self* feminino do pai. Na realidade, como disse, não perdera inteiramente um pai, porque um pai ainda se achava presente na mãe.

O sonho prosseguiu de maneira bastante prolixa. Grosseiramente falando, tinha a ver com uma mulher e uma escola na ilha. Eles chegavam lá com um amigo de escola. Havia algo a respeito da tradição do serviço religioso na escola e era por isso que as caixas se encontravam em frente do altar. Os mais velhos sabiam o que havia nas caixas. Foi dito a Patrick para subir até o altar e ele subitamente soube que havia pessoas mortas nas caixas. Após, houve dois outros episódios, ambos a envolver água. Eles foram assistir a um jogo de críquete. Havia algo de cinzento nele. Ele viu que a escola ia desmoronar, por causa de erosão pela água, de maneira que 300 meninos se afogaram. Então a sua mãe e a mulher estavam com dois meninos. A água estava subindo cada vez mais alto, a lamber as casas que começaram a desmoronar. A água cobriu o carro esporte do irmão. O amigo de escola pareceu ter-se perdido no decorrer disto, mas ele e a mãe escaparam no carro esporte, que, a esta altura, havia reaparecido.



Das associações espontaneamente fornecidas, estava claro a respeito deste sonho que o medo da água unira-se ao desmoronamento geral da moral durante o episódio do afogamento. *Relatando este sonho, Patrick chegou muito perto da agonia real da situação de afogamento*, embora na primeira sessão, quando me contara esse episódio, não tivesse conseguido chegar a um afeto profundo.

Ele me perguntou duas outras coisas. A primeira tinha a ver com sua avó, que havia tido um derrame. Disse Patrick: "O senhor poderia me dizer o que se pode fazer para alterá-la, de maneira a que não seja tão difícil com mamãe, ou, então, como tornar-me possível suportá-lo quando ela fica realmente completamente impossível?" Respondi-lhe que não tinha maneira de alterar qualquer das duas coisas, de modo algum. Nada havia a fazer a não ser sobreviver ao horror da situação, particularmente, a existente entre a mãe e a avó, um relacionamento a possuir uma história que remontava aos primeiros dias da mãe e que, como Patrick disse, explicava grande parte das dificuldades pessoais desta.

A outra pergunta tinha a ver com as experiências de Patrick durante a última semana de férias. Um rapaz com quem estivera acampado provocativamente derrubara as cordas de retenção de sua barraca e Patrick lhe dissera: "Está bem, vou-me embora". O menino lhe respondera: "Nunca quis você, e meu pai também nunca o quis, tampouco". Isto foi muito perturbador. Disse que achava que outros rapazes seriam capazes de lidar com este tipo de coisa em um amigo, mas para ele, o comportamento do rapaz produziu uma crise. Quando a mãe o foi apanhar com o carro, ele irrompeu em pranto. Enfatizou que achava que não devia ficar tão perturbado assim a respeito de um incidente desse tipo. Forneceu tudo isto como exemplo da maneira por que fica perturbado e isto se junta à reação à crítica feita a outro rapaz pelo professor de latim, antes de ele haver fugido da escola. (Se as pessoas não são amistosas, elas então rapidamente se tornam associadas, em sua mente, ao potencial paranóide latente.)

Comentário: Patrick agora tivera tempo de entrar em contato com os seus sentimentos de culpa e com a agonia plena de seu moral em desmoronamento, quando assistira ao pai afogar-se e ele próprio quase se afogara também, mas fora salvo.

Sonhando este sonho, ele demonstrou que havia conquistado controle sobre o episódio, e, ao lembrá-lo e relatá-lo, mostrara ainda a força de sua organização do ego; também ao providenciar para ver-me mostrara sua capacidade de acreditar na mãe, e em mim como substituto paterno, e em nosso trabalho conjunto como figuras de pais a agirem em acordo.

Sexta Entrevista com Patrick (nove dias mais tarde)

Patrick utilizou esta entrevista para entrar em detalhes a respeito de sua depressão, relacionada às ausências da mãe. Isto se achava ligado, de maneira complexa, às exigências feitas à mãe pela própria mãe dela. Contou-me também que a ameaça de depressão sempre estivera com ele, pelo menos desde o episódio ocorrido quando tinha um ano e meio de idade.

Primeira Entrevista com a Mãe (um mês depois, cinco meses após a conversa inicial por telefone)

Esta foi a primeira entrevista pessoal que tive com a mãe. A principal razão por que eu não a havia visto fora que o caso me viera em uma ocasião em que eu não tinha vaga alguma, e tinha de ser econômico no emprego de meu próprio tempo. O relato

seguinte baseia-se em notas tomadas durante a entrevista. Nesta época, Patrick havia regredido a um estado de dependência e imaturidade, aos cuidados dela própria e das pessoas da localidade. Aqui a confiabilidade básica da mãe havia-se mostrado.

A mãe, primeiro de tudo, falou a respeito de seu relacionamento com a própria mãe, cuja velhice exagerava a sua natureza exigente habitual. Prossegui falando a respeito de Patrick e das ansiedades dele sobre o estudo e a escola. Parece que, durante seu período de regressão, ele obtivera permissão para freqüentar uma escola local, sempre que tivesse vontade. Então Patrick encontrou um professor cego.

Insisti, e, assim procedendo, apoiei a mãe em suas próprias idéias, que o que quer que fosse feito a título de instrução neste estágio tinha de ser feito apenas se Patrick realmente o quisesse, e não se deveria permitir testes de espécie alguma. A mãe descreveu quão sensível Patrick podia ser: "Uma só palavra sarcástica o aniquila. Ele facilmente sente o chão lhe fugir de debaixo dos pés". Expliquei que a missão dela era esperar por movimentos progressivos espontâneos e de maneira alguma esperar algo de Patrick neste estágio. A mãe disse que Patrick já achava que estava ficando melhor e que o dissera nas seguintes palavras: "Se eu ainda estivesse doente o Dr. W. me veria imediatamente, não veria?" Isto se dera em reação a eu havê-lo feito esperar por uma consulta, a primeira vez em que o fizera esperar desde que se colocara sob os meus cuidados. Tomei grande cuidado, durante esta consulta, em apoiar a intuição da mãe, ou o que ela chamava de seus "instintos", especialmente por ela sentir a falta do apoio que costumava receber do marido em seu manejo dos filhos. Patrick já havia começado a pensar a respeito de sua posição na escola, quando de sua volta, e preocupar-se com a possibilidade de ter de permanecer em uma classe inferior durante um ano, enquanto os seus amigos subissem de turma. (Durante esta consulta, muita coisa foi dita que era importante desde o ponto de vista da mãe, mas que não pôde ser anotada na ocasião.)

Sétima Entrevista com Patrick (alguns dias mais tarde)

Logo após esta consulta surgiu uma complicação devida ao fato de a escola não acreditar na enfermidade de Patrick: provas escritas foram enviadas pela escola e o resultado foi quase uma catástrofe. Patrick penosamente soergueu-se de seu estado retraído e tentou enfrentar o desafio. Ao mesmo tempo, perdeu toda a sua capacidade de relaxamento e tornou-se seriamente ansioso e "perseguido". Por algum tempo ele emergiu de seu estado regredido e dependente.

Dei um jeito de ver Patrick imediatamente e disse-lhe que eu *proibia totalmente* todos os testes e exames, e que ele deveria jogar fora os papéis. Na realidade, disse-lhe: "Ponha-os na privada e puxe a descarga" o que era apropriado às circunstâncias, mas quando relatadas à mãe, estas palavras pareceram-lhe perigosas. A mãe tinha as ansiedades que um genitor tem sobre as autoridades escolares e ficou com medo que eu empregasse essas palavras em minha carta ao diretor da escola. Minha interferência talvez inábil com referência às provas escritas causou consternação na escola e, de qualquer modo, não era compreensível ao diretor do internato e ao médico da escola que aquele rapaz ficasse longe da escola, levando uma vida descuidada aos cuidados de sua mãe "neurótica", sem qualquer figura paterna em sua vida, e negligenciando completamente a sua educação. Contudo, era exatamente isso o que ele precisava.

O resultado imediato desta consulta e de eu tomar a decisão a respeito das provas escritas de maneira firme foi que Patrick reconquistou sua maneira relaxada e retornou rapidamente a um estado retraído e regredido, tornando-se mais uma vez completamente feliz no *cottage* campestre. Desta maneira, fez sem ansiedade um bocado de trabalho com as provas escritas, e chamou isto de "brincar com elas".

O Primeiro Aniversário do Episódio de Afogamento

Foi importante que a mãe me tivesse pedido para discutir com ela, por telefone, as disposições a serem tomadas para o primeiro aniversário. Tinha havido uma tendência a preparar uma espécie de festa, a que viriam um bocado de pessoas, e haveria o tipo de atividade febril que esconderia a ferida. Isto teria sido uma nova versão do episódio do bebê a pular. Com minha ajuda, a mãe e Patrick conseguiram ficar sozinhos juntos na tarde desse primeiro aniversário da tragédia, que era também, naturalmente, o aniversário de Patrick.

Depois, a mãe descreveu-me o que acontecera. Disse que Patrick parecia excessivamente cansado e, em verdade, estavam ambos exaustos. Ficaram sentados juntos toda a tarde, a ouvirem o tique-taque do relógio. Dessa maneira, o tempo passou. Então Patrick disse: "Oh, graças a Deus que passou, não foi nem a metade de quanto ruim eu achei que iria ser". Imediatamente, pareceu um rapaz muito mais sadio. O seu rosto "se soltou". Poder-se-ia dizer que a regressão e o estado retraído mudaram neste ponto para uma progressão, um movimento para a frente no sentido da independência e da participação.

Oitava Entrevista com Patrick (seis meses após o contato inicial)

Patrick chegou e relatou um sonho que havia tido. Estava conversando com Sir X (um escritor e crítico de arte bem conhecido, e amigo da família). Foi dada ênfase à palavra *Sir*. Ele fora muito gentil. O "Sir" provavelmente relacionava esta figura paterna à idéia de seu diretor do internato. Desta maneira, Patrick estava me relatando o retorno de figuras paternas vivas em sua realidade psíquica interna. Havia muito mais no que Patrick falou que tinha a ver com homens, e também com o seu irmão mais velho.

Nona Entrevista com Patrick (dois meses mais tarde, um ano e meio após o episódio do afogamento)

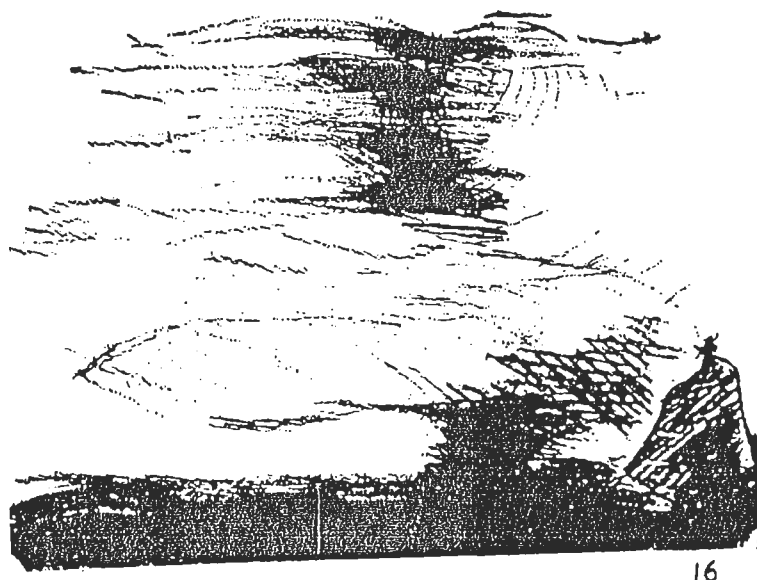
Foi mais ou menos um *evento social* e conversamos sobre uma ampla gama de assuntos e Patrick desenhou um arranha-céu que denominou de "Pôr do Sol no Rio" (nº 16).

Carta à Escola

Antes desta nona entrevista escrevi à escola recomendando o retorno de Patrick, e incluí na carta o seguinte parágrafo:

"Quero enfatizar que acho que Patrick teve um colapso bastante sério. Diria que agora se recuperou dele e que provavelmente encontra-se em estado melhor do que se achava antes da morte do pai. Certos sintomas do início da infância desapareceram. Existe um sintoma residual que pode ocasionar um pequeno problema e tem a ver com a sua extrema sensibilidade com relação a louvor e reprovação. Pode ser útil que aqueles que estão trabalhando com ele saibam que não são as grandes coisas que preocupam Patrick; ele não fica realmente perturbado se alguém ficar muito zangado com ele, porque isto é real e acha-se relacionado à situação real objetivamente percebida. O que facilmente perturba Patrick é apenas uma pequena reprovação ou louvor e o efeito destes pode ser inteiramente fora de proporção com algo de real. Penso que ele sabe disso e tentará controlar-se quanto as reações excessivas. Se tiverem de ficar manifes-

tamente zangados com Patrick, isto não é do tipo de coisa que acredito que cause problemas”.



Do ponto de vista da escola, Patrick achava-se em estado satisfatório. O pessoal administrativo em breve esqueceu que ele estivesse enfermo e, provavelmente, achou difícil acreditar que Patrick havia tido de fato um colapso grave.

Segunda Entrevista com a Mãe (após a última entrevista com Patrick)

Esta segunda entrevista com a mãe foi importante, e necessária por causa da raiva da mãe comigo, a qual precisava encontrar expressão. No decorrer da entrevista surgiu que eu a havia colocado em uma tensão muito grande e, em verdade, sabia que havia feito isso. Eu havia de fato lhe pedido para *postergar sua própria reação à morte do marido* a fim de cuidar de Patrick, e confiara em que ela assumiria responsabilidade por ele durante o seu colapso. Ademais, havia muitas maneiras, algumas delas indubitavelmente razoáveis, pelas quais a mãe de Patrick descobrira-se irritada comigo. Eu a havia deixado “em uma perna só”. Após expressar de modo completo a sua insatisfação comigo e informar-me que a escola também se achava muito zangada comigo, ela tornou-se amistosa e grata. Contou-me então como ajudar Patrick havia ajudado ela própria.

Terceira Entrevista com a Mãe (uma semana mais tarde)

Consegui conferir com a mãe os detalhes de ela haver deixado Patrick sozinho quando ele contava um ano e meio de idade. Foi *depois* de minha longa entrevista com o menino que ela contou isso a Patrick. Enquanto estava lhe contando, ele ficou intensamente interessado e disse: “Lembro-me de bater num berço”. A razão por que

a mãe contou-lhe esta história foi que, após a primeira consulta comigo, quando ele ficou muito mudado por causa de seu contato comigo, ela começou a pensar no passado.

Ela conversou com uma amiga que lhe disse que o lugar para onde Patrick havia sido mandado quando ela se afastara dele com um ano e meio de idade não era um bom lugar, e ela soubera disso na ocasião. Acrescentou: "Foi uma família em que todos são muito dinâmicos e as crianças são treinadas de modo vigoroso". Recontar estes detalhes fez a mãe pensar em um incidente ainda mais inicial. Com cinco dias de vida, Patrick fora hospitalizado durante seis semanas por causa de vômitos e o seu peso caíra de quatro quilos e meio para três. Com seis semanas, a mãe levou-o de volta para casa, após o que "ele pegou peso como uma bomba".

Quarta Entrevista com a Mãe (seis meses mais tarde, dois anos após a morte do marido)

A mãe relatou que Patrick havia feito bons progressos. Achava-se no topo de sua classe na escola (não uma classe alta) e estava gostando do estudo; o relatório escolar era bom. Disse que ele estava mais feliz e dormindo bem, e que suas fobias, que havia tido em casa desde menino, haviam desaparecido gradualmente. Aproveitara as férias, estando sempre ocupado à sua própria maneira, e ficara com um amigo de escola no *cottage*, que deixara pronto para a mãe.

O *insight* do menino é demonstrado pelos planos que estava fazendo para o segundo aniversário da tragédia. Descobriu que havia acertado ir com amigos a outra ilha! Quando se deu conta da data para a qual esta expedição havia sido planejada, disse: "Esse dia não. Não. Não seria bom estar no mar então". E, assim, cancelou essas férias que estivera aguardando. Não havia desejo de contornar o momento trágico. Ainda não ficava muito à vontade quando estava próximo do mar e fez o comentário: "Engraçado que já faz quase dois anos" implicando que ainda se achava muito próximo do sentimento pertinente à tragédia. A mãe o estava ajudando a planejar um dia muito simples para o segundo aniversário da tragédia.

Reconstrução da Enfermidade de Patrick

1. Efeito desconhecido da hospitalização por seis semanas aos cinco dias de idade, com súbita melhora clínica a datar do momento do retorno do bebê à casa.

2. A perigosa separação da mãe com um ano e meio de idade. A família com a qual foi deixado incentivava uma defesa maníaca, mas com o retorno da mãe, houve uma recuperação súbita sob a forma de depressão, clinicamente oculta pelo sono de 24 horas no colo daquela.

3. Seguindo-se a isto, houve um laço entre o menino e mãe que tinha por trás de si não apenas amor, mas também a incerteza dele quanto à confiabilidade dela. *Houve aqui uma privação relativa*, que tornou Patrick um tanto ligado à mãe e interferiu no desenvolvimento de seu relacionamento com o pai.

4. O desenvolvimento da personalidade de Patrick durante o período de latência foi distorcido e, como a mãe o colocou, pareceu que ele estivesse destinado a tornar-se fixado na mãe.

5. Aconteceu então a tragédia, que, embora parcialmente acidental, foi sentida por Patrick como planejada por seus processos inconscientes.

6. Seguiu-se então o retardo no desenvolvimento da reação de Patrick à tragédia. Ele pareceu não ter sido afetado e retornou à escola interna. Aqui, contudo, tendia

a ir para a enfermaria em razão de transtornos obscuros. Ele planejou estes últimos, mas sem saber porquê.

7. A primeira entrevista comigo, ocasionada pela mãe, que começou a sentir que Patrick estava se tornando hipersensível e sujeito a transtornos psicossomáticos. Tínhamos aqui um estado clínico paranóide de gravidade crescente. A mãe também sabia que Patrick não havia reagido à tragédia. Nesta entrevista, Patrick deu-se ao trabalho de fazer-me entender que *as suas dificuldades haviam começando muito tempo antes*, e fez um desenho que, em entrevista posterior, forneceu a pista para o trauma original.

8. Falta à escola por razão subsidiária. Na segunda entrevista, Patrick sabia que havia vindo ver-me em busca de auxílio e que se achava ameaçado de um colapso mental. Um estado regressivo de retraimento pôde aparecer, em vez da moléstia paranóide por causa do fato de sua crença em mim, que havia sido engendrada na primeira entrevista.

9. *Minha decisão de que ele estava enfermo* e que não devia retornar à escola por um período indefinido. Isto rapidamente levou-o a atingir um nível profundo de regressão à dependência e a tornar-se retraído. A mãe enfrentou esta dependência de modo mais que satisfatório. Para fazer isso, teve de pospor sua própria reação à perda do marido.

10. A chegada de sentimentos apropriados à tragédia (quinta entrevista). Nas profundezas de seu colapso, Patrick trouxe para a entrevista o sonho, que conduziu-o a vivenciar o afeto que não havia sido experienciado, quer na ocasião do episódio traumático, quer subsequente. Após experienciar esses sentimentos, Patrick começou a perder a sua necessidade de estar doente e começou a recuperar-se.

11. Retorno à escola interna. Estava agora quase bem e não havia ficado muito atrasado nos trabalhos escolares. Ingressou em sua velha classe por outro ano e aceitou a situação. Ele rapidamente retomou o crescimento emocional apropriado à sua idade.

Comentário final

Patrick teve uma reação retardada a uma tragédia em que esteve envolvido aos onze anos de idade. O retardo deveu-se parcialmente ao fato de já estar enfermo por ocasião da tragédia e pode-se dizer que o episódio trágico fez parte da enfermidade total do menino. Esta enfermidade teve como um fator etiológico um perigoso período de separação da mãe quando tinha um ano e meio de idade. (Possivelmente um padrão para sua reação a esta doença tenha sido estabelecido por sua enfermidade anterior e separação dos cinco dias às seis semanas de vida, no início desta.) A doença aguda, por cujo tratamento foi responsável, começou com a tragédia e a reação retardada; pode-se dizer que esta moléstia encontra-se hoje no fim⁴. O resultado total é que Patrick perdeu a maior parte da enfermidade de que padecera *antes* da tragédia, da natureza de uma reação à privação, e que se caracterizava por um certo grau de fixação à mãe, por uma distorção esquizóide em seu teste de realidade (sistema fólico), por uma tendência a "recusar" a depressão e por um distúrbio de personalidade a conduzir no sentido da homossexualidade com um colorido paranóide.

4. Acompanhamento: quatro anos após a tragédia, pode-se dizer que o desenvolvimento do menino é natural e sadio. — D. W. W.

A principal provisão terapêutica foi a maneira pela qual a mãe do menino enfrentou a regressão dele à dependência e, juntamente com isto, houve um auxílio específico fornecido por mim próprio a pedido.

Distúrbios Físicos e Emocionais em uma Adolescente

Redigido em janeiro de 1968¹

Minha contribuição a esta compilação de estudos tem de ser clínica. Proponho-me a descrever um caso. Um caso só não prova nada, mas pode ilustrar muita coisa, inclusive fenômenos que, embora significantes, não se mostram nas investigações científicas convencionais.

O Caso de G.

Fui consultado pelos pais de uma jovem que tem 14 anos de idade. G. sempre fora uma criança saudável e enérgica e certamente fora muito desejada pelos pais. A família era uma unidade estável e uma sociedade em funcionamento. Muitos sentimentos eram experienciados na situação do lar e G. havia demonstrado afeição e agressividade, e o que o pai descreveu como uma ampla gama de sentimentos. G. tinha uma irmã quatro anos mais velha que ela e sempre se sentira desafiada e fizera uma tentativa muito grande de competir com a irmã. Havia um menino, três anos mais moço, e, com relação a ele, G. havia tido fases de ciúme manifesto.

Resumidamente, uma descrição de G. seria a descrição de uma criança a crescer. Ela podia ser descrita como se desenvolvendo de maneira extrovertida. Houve um incidente na vida desta moça, tal como na vida de tantas outras, do qual soube por causa da confiança que os pais tinham em mim. Tratou-se de um encontro com um homem que tinha uma perversão que assumia a forma de uma compulsão a seduzir crianças. Na realidade, ele tentara fazê-la urinar em sua frente, de maneira exposta. O incidente foi encerrado, mas deixou G. com um certo aumento de frequência da micção. Aos onze anos, G. começou a menstruar e havia sido preparada para isto. Clinicamente, tornou-se desajeitada por volta desta ocasião, canhestra, de caminhar bamboeante; e o repúdio do papel feminino tornou-se uma característica. Juntamente com isto houve um aumento de interesse por meninos e uma identificação com a mãe,

1. Rascunho de um capítulo para um livro didático de obstetrícia e ginecologia; não foi na realidade publicado. — Os Organizadores.

que cuidava da casa. A partir dos doze anos, tornou-se bastante pesada, lânguida e quieta, e desenvolveu um corrimento vaginal do tipo leucorréico. O corrimento era considerável e tornava necessária muita lavagem extraordinária de roupas.

Um médico competente foi consultado e, após um exame físico, disse aos pais que a menina estava fisicamente enferma e recomendou uma amigdalotomia, com apendicectomia posterior. Tudo isto baseou-se em achados clínicos e investigações posteriores foram feitas, as quais pareceram confirmar o diagnóstico do médico. É possível que o médico não tenha impressionado os pais como havendo adequadamente avaliado a personalidade e a história da menina em termos do desenvolvimento desta garota adolescente a partir de uma meninazinha e um bebê, tomando em consideração o lugar dela na família. Os pais ficaram intrigados, porque haviam visto estas coisas se desenvolverem e acharam que algo estava sendo ignorado.

Neste ponto, fui consultado e pude ver todos os relatórios e concedi à mãe tempo para contar-me a história do desenvolvimento da criança.

Na entrevista com a mãe, consegui ficar informado da maneira pela qual todos os sintomas haviam começado e como se entrelaçavam com os humores da menina e suas experiências reais, bem como de um grupo de sintomas, tais como roer unhas, que não tinham possibilidade de fazer parte da enfermidade física que havia sido diagnosticada por meu colega médico.

Em estrita confidência, a mãe conseguiu contar-me que o incidente com o homem se dera quando a menina tinha quatro anos e que ele manipulava os órgãos genitais dela. Poder-se-ia anotar aqui que este tipo de detalhe é com frequência omitido quando os pais fornecem uma história clínica, por não terem idéia de que tipo de atitude o médico terá para com os pais e as crianças. Alternativamente, fornecem estes detalhes de maneira que é desproporcional, de modo que a reação do médico é dizer que eles estão concedendo ênfase demais a um só acontecimento. Neste caso, não há dúvida de que o incidente fora até certo ponto ocasionado pela criança e pelo estado em que se achava na ocasião, desenvolvendo-se como se achava de maneira extrovertida e sempre um tanto excitada.

Tive uma entrevista com a própria G., e em resultado desta e de um exame geral de todo problema, decidi incidir intensamente do lado de um diagnóstico de *saúde*, complicado por distúrbios emocionais e físicos que pertencem a um certo tipo de desenvolvimento. Eu sabia, naturalmente, que não existem meias-medidas nesta questão. Tinha de apoiar o meu colega de medicina ou, então, pronunciar um enunciado muito definido, de tipo oposto ao dele, e assumir os riscos nisso envolvidos. O risco só poderia ser à minha própria reputação, de vez que era possível manter o caso sob revisão e uma modificação de diagnóstico não teria apresentado dificuldades.

Dessa maneira, disse à menina, ali mesmo, que a considerava bastante sadia. Disse-lhe ainda que a leucorréia era uma característica que acompanhava regularmente fantasias e sonhos de tipo sexual, tais como os que ela, em sua idade, estaria tendo, e descobri que ela entendia do que eu estava falando. Tive de presumir que a "massa" que fizera meu colega pensar em apendicite era uma "massa" ovariana, associada com a atividade de todo o aparelho genital.

Não lhe fiz exame físico e, naturalmente, fiquei mais inclinado a evitar o exame da região genital, quando soube do incidente com o perverso. Até onde eu podia dizer, G. não se lembrara deste incidente ou, pelo menos, não ficara obsecada com a sua lembrança.

A menina saiu de minha sala diagnosticada como sadia e normal, e acompanhei isto por uma declaração muito definida aos pais, enunciando muito simplesmente que o que estávamos encarando ali não era uma enfermidade, mas uma menina a desenvolver-se de certa maneira.

Em resultado desta consulta e de minha atitude, a menina ficou muito aliviada e os pais reagiram à melhora imediata de sua saúde geral. O pai escreveu-me que a consulta tivera um efeito muito acentuado em G., que começara a sentir-se brilhante e o que ele chamou de "seu *self* costumeiro" a partir da data da consulta. O corrimento vaginal rapidamente diminuiu em quantidade e deixou de ser um problema. Não se pensou mais a respeito dos problemas físicos e G. não teve as amígdalas retiradas, nem, tampouco, submeteu-se a uma apendicectomia.

O conflito a respeito da identificação com meninos ou com meninas continuou e gradativamente elaborou-se em uma solução, à medida que G. crescia e atingia a puberdade.

Quatro anos depois fui novamente consultado pelos pais e acompanhei o trabalho com quatro outras entrevistas pessoais com G.

Por esta ocasião, as queixas de G. eram mais definidamente psiquiátricas. Incluía medo de morrer, "sentir os batimentos cardíacos", medo de câncer e de apendicite, etc. Disse ao pai que sabia o que era que a preocupava, mas preferia não contar-lhe, e, por esta razão, veio ver-me.

Nesta época, contava 18 anos de idade e achava-se muito envolvida em relacionamentos heterossexuais. O pai conseguira ver o que surgiu de modo muito claro na consulta, ou seja, que existia ainda um conflito de papéis sexuais. Ele sentira-se triste com isto, porque G. era uma jovem mulher do ponto de vista dos observadores, e muitíssimo amada como tal.

Na entrevista, descobri que G. estava gradualmente solucionando o seu conflito de papéis sexuais pela escolha muito cuidadosa de um homem a quem pudesse entregar o *self* masculino bastante intensamente desenvolvido que fazia parte de sua vida de fantasia. Isto não afetara o seu estado clínico, de maneira que ninguém em contato com ela poderia pensar em G. como masculina. Era bastante óbvio que a moça estava chegando rapidamente à idéia de casamento e do cuidado de crianças suas próprias. Neste contexto, não teria valor para mim descrever o conteúdo destas entrevistas psicoterapêuticas, mas vale à pena mencionar que a vida onírica e de fantasia de G. era muito fortemente colorida por leões, tigres e outros símbolos de apetite voraz, tal como o fora quanto meninazinha. Achava-se bastante claro que a amamentação de seus bebês seria uma questão de grande importância para ela.

O distúrbio psiquiátrico mostrou ser temporário e G. prosseguiu com seu desenvolvimento pessoal, sem outras consultas comigo e sem auxílio psiquiátrico.

Dezesseis anos mais tarde, fui consultado por G. por causa de sua filha de oito anos. Ela tinha também outra criança. Vi essa menina de oito anos três vezes em consulta terapêutica e me foi fornecido um material muito rico que ilustrava o seu problema pessoal. O detalhe importante do ponto de vista do que está sendo enunciado neste Capítulo é que esta garotinha sadia, a viver também em uma boa família, conseguiu, dentro dos limites da técnica especializada da entrevista, informar-me a respeito de sua reação ao elemento masculino na mãe, de quem, a propósito, gostava muito.

Em resumo, a amamentação muito copiosa pela mãe agira para ela como bastante mais do que usualmente age, para uma mulher, como expressão de uma atividade masculina. Esta menina, tal como a mãe, tinha um conflito muito grande com referência aos papéis sexuais, e falou a respeito dele longamente, desenhando figuras para ilustrar suas observações, como as crianças fazem durante o que chamo de consulta terapêutica. Forneceu um sonho e a ilustração representava um saco de veneno. "Parece-me com um porco". Mais tarde, desenvolveu esta idéia em termos da mãe, garantindo-me que esta é realmente muito boa, mas que era aquilo o que sonhava sobre a mãe. Em determinado ponto, tornou-se dramática ao descrever o que faria com os seios da mãe. Gritou: "Não quero nada de seu leite horrendo". E, então, cuspiu. Desenhou depois uma mulher cujos seios pendiam na frente como os cordões

do roupão do pai, que desenhara em outra figura, e, então, disse: "Acho que deveria haver buracos ao invés de seios".

Não é de se esperar que o leitor deste Capítulo ache convincente este material, por causa das seguintes circunstâncias. Em primeiro lugar, o leitor não se acha necessariamente em contato com o tema extremamente complexo e especial do desenvolvimento emocional do ser humano, inclusive o conteúdo de fantasia da mente da criança. Em segundo lugar, não é possível, neste contexto, fornecer a descrição completa das quatro entrevistas, o que poderia na realidade ser feito, pois notas exatas foram tomadas e os desenhos da criança ilustram todos os passos.

O que se pode enunciar é que, do ponto de vista de mim próprio, que conduzia a entrevista, esta criança foi capaz de mostrar-me, sem qualquer indução minha, que estava reagindo a uma expressão vigorosa da identificação masculina que detectara na mãe e que a perturbava. Ela, naturalmente, teria gostado de encontrar isto tudo no pai, que, talvez, seja mais maternal que masculino.

Deve-se entender que, em termos psiquiátricos, estas pessoas, adultos e crianças, não devem ser descritas como enfermas. Trata-se mais de possuírem elas certos padrões que, se exagerados e fixados, poderiam então ser diagnosticados como padrões de enfermidade. O importante que está sendo enfatizado é que, para minha surpresa, a criança tomou para descrição o próprio elemento na mãe que havia aparecido na apresentação que a última me fizera de si própria décadas antes e que haviam sido uma característica da vida de infância da mãe.

Voltando-se o olhar para a totalidade do complexo, pode-se perceber que a leucorréia que forneceu a razão para a consulta original com o médico e que tão facilmente poderia ter levado a uma série desnecessária de operações, era uma parte muito pequena de um problema total de personalidade que não se achava sequer fora da ampla área do conceito de saúde que se tem de empregar na prática da psiquiatria infantil.

Comentário

É provável que este tipo de contribuição clínica possa causar um choque ao leitor de um livro que tem como título "As Fundações Científicas da Obstetrícia e da Ginecologia". Apesar disso, é necessário que aqueles que fazem observações muito cuidadosamente controladas e que tiram conclusões de seu trabalho sejam lembrados de que, na prática da medicina, não é possível ignorar a personalidade total e o padrão familiar sem o perigo de causar-se mais mal que bem.

O clínico é aquele que fornece o material para o trabalho científico, não o patologista ou o especialista em testes mecânicos. É possível então que haja neste livro um lugar para este esboço sucinto de uma situação clínica imensamente complexa.

A Loucura da Mãe tal como Aparece no Material Clínico como Fator Estranho ao Ego

Redigido para um livro sobre psicoterapia psicanalítica, 1969¹

Em um caso meu, recente, a intrusão súbita de material "estranho" precisou ser notada, compreendida e interpretada. O paciente era um menino de seis anos que me foi encaminhado por ser incapaz de fazer uso de sua boa inteligência; ao invés, abria buracos a dentadas em suas luvas, casaco, gravata e malha, e só defecava em um urinol, perto de um dos pais. Ademais, exigia uma rotina que era estrita em muitos detalhes e restringia-se aos alimentos que podia comer.

Não há necessidade de uma descrição detalhada do caso aqui, onde tenho o objetivo limitado de descrever a entrevista psicoterapêutica que ele teve comigo na única ocasião em que o vi. A entrevista teve um bom efeito porque consegui separar a confusão existente na mente do menino da confusão introduzida em sua vida por certas características da mãe. O leitor pode tomar como certo que este filho único era amado pelos pais e que a família não se achava em perigo de romper-se. O pai era um profissional liberal e a mãe havia tido sua própria formação como professora.

A fim de fornecer um retrato útil da sessão, tenho de pedir ao leitor que siga muitos detalhes que precisam ser relatados simplesmente porque fornecem continuidade ao material.

O menino e eu jogamos juntos o Jogo do Rabisco, e foi-me fácil descobrir sua capacidade de gostar de jogar e jogar com ele. Foi isto o que aconteceu juntamente com os desenhos: após um debate sem método de seu lar e situação familiar, preparamos o papel e dois lápis e eu comecei fazendo o primeiro rabisco.

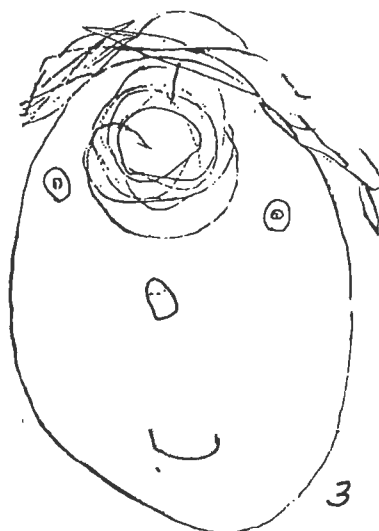
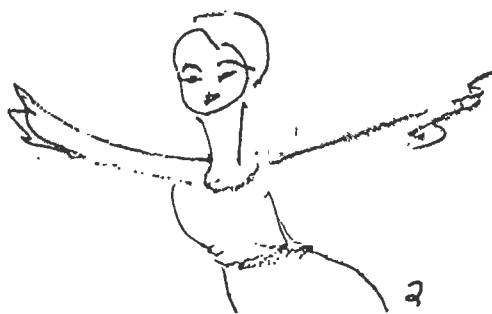
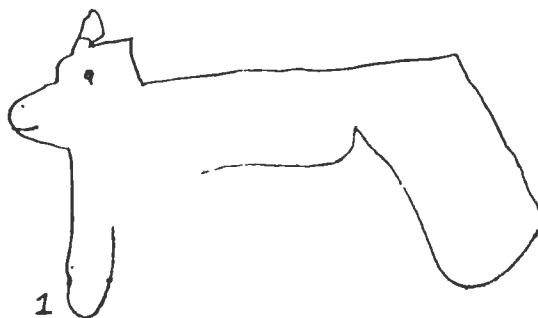
1. Desenho meu, que ele transformou em um burro, fornecendo alternativas: porco, vaca, cavalo, cachorro. "Ele tem um olho gozado". Aqui, no "olho gozado", já tínhamos uma referência ao imprevisível.

2. Desenho dele, que ele disse ser uma cabeça, e eu lhe forneci um corpo de menina.

3. Desenho meu, que ele transformou em uma cabeça engraçada. Note-se a recorrência do tema de "gozado" ou "engraçado", indicando a sua importância. Ele fez uma referência que pertencia à avaliação que a mãe fizera de mim. Aparentemente-

1. Publicado em *Tactics and Techniques in Psychoanalytic Therapy*, org. de Peter L. Giovacchini (London: Hogarth Press; New York: Jason Aronson, 1972).

te, ela tem um livro de minha autoria e ele o havia visto; disse: "O senhor faz um bom desenho de cabeças". Acho que os elaborados rabiscos sobre a testa referiam-se a miolos, como se fosse um retrato de mim visto através dos olhos da mãe. "O homem tem um nariz engraçado, com três narinas. Suas orelhas ficam atrás, de maneira que não se pode vê-las."



Ele me falou sobre outras coisas que podia desenhar, inclusive um ônibus, e estava muito interessado em conseguir *crayons* coloridos. Ele já me havia usado para falar a respeito da idéia de algo engraçado sobre a mente. Eu, naturalmente, não fiz

interpretações. Podia-se pensar nas três narinas como loucas, mas dentro da área das atividades de brinquedo do menino.

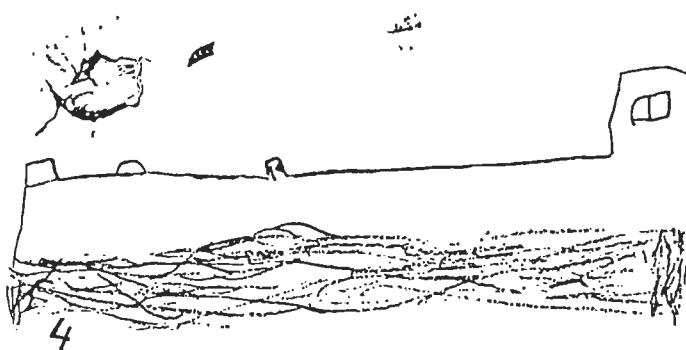
4. Aqui, o papel se rasgou no processo de um desenho vigoroso. Ele não conseguiu desenhar nada a princípio.

5. Este tinha um certo mistério. Pertencia a ele e; ao alto, no canto, ele fez uma marca. A marca fazia também parte de um M. Há um trocadilho com o seu nome aqui. Disse ele: "Não é nada!" Havia chegado a uma defesa extrema, porque, se não for nada, não pode ser morto ou ferido pelo pior trauma imaginável.

Acompanhei o tema, falando-lhe aqui do desenho como sendo uma maneira de tirar alguma coisa de sua cabeça para o papel. Ele falou a respeito da maneira pela qual o trem às vezes tem de parar para permitir que um trem expresso passe. Disse: "O nosso trem fica bloqueado porque eles têm de mudar as agulhas e, depois, podemos retornar de novo".

Aqui, ele mal conseguiu evitar que o lápis caísse no chão, e estas e outras pequenas coisas pareceram significativas, indicando existir caos antes que ordem em suas experiências imediatas. Agora, o lápis deslizou para o chão. Apesar disso, ele não se achava em estado assustado, e poder-se-ia dizer que encontrara uma posição da qual podia olhar para o trem expresso que passava.

Fizemos aqui um intervalo. Utilizei a pausa para perguntar-lhe a respeito de sonhos. Respondeu ele: "Não sei". Agora, ele retornara a fazer o nº 4. "É uma locomotiva. Essa é uma janela boa. Parece uma janela real de locomotiva, um trem a vapor".



He said: "It's a nothing"

marks
(mark)

5.

Ele estava se aproximando do traumático trem expresso, que evidentemente o fazia lembrar a Mãe: "Em Battersea Park, há um trem que se parece com um trem a vapor, mas na realidade, é um diesel. Mamãe acha que é um trem a vapor!" Prosseguiu falando sobre os trens a vapor que vê no metrô. Ele gosta de ver mudanças reais de agulhas de estrada de ferro e já viu uma delas um monte de vezes, em várias viagens feitas a Victoria Station; para trás e para frente. "Vi no jornal que algo do outro lado do mundo estava pegando fogo. As pessoas não morreram; bem, não enquanto foi um incêndio pequeno".

As imensas potencialidades de perigo são indicadas — um comentário sobre o fogo na locomotiva a vapor: "Oh, esquecemos o tênder do carvão". E ele começou a tentar acrescentá-lo à parte de trás da locomotiva; muitos outros pequenos detalhes se perderam neste ponto, e então ele repentinamente manifestou algo inteiramente novo e estranho à tendência geral do material.

Chega o Agente Traumático

Neste ponto, ele começou a comportar-se inteiramente em desacordo com seu caráter. Eu mal podia reconhecê-lo como sendo o mesmo menino. Uma coisa nova havia surgido e se apossado dele, e essa coisa nova tinha a ver com escutar um barulho engraçado: um barulho de explosão. Poderia ter vindo da lareira a gás, um tipo de barulho que acontece quando ela está vazando. Foi até lá para examiná-la, mas não havia cheiro de maneira que não estava vazando.

Não era possível ter certeza de se ele estava alucinando ou recordando em termos auditivos. Tentei pescar algo fazendo uma interpretação a respeito de escutar os pais no outro quarto, ao que ele respondeu com um forte "Não" e disse: "Foi muito acima, nas colinas ou, talvez, até mesmo na nascente do Tâmnisa".

Continuei com o meu tema, dizendo: "Tal como se pudesse ser o começo de Mark, algo a acontecer entre mamãe e papai".

Ele acompanhou meu tema, num esforço por concordar, dizendo: Comecei dentro de Mamãe e terminei fora de Mamãe, no hospital. Não havia barulho, só bebês chorando".

Disse eu: "Fico pensando se não haveria um barulho dentro de Mamãe" e ele replicou que estava com os olhos fechados, de maneira que não poderia ouvir. Eu próprio me achava perplexo e pareço ter perseverado com esta interpretação da cena primária por me achar perdido.

Era difícil tomar notas da maneira caótica pela qual o material estava aparecendo. Ele fez ruídos ilustrativos do tipo de barulhos que estava escutando ou lembrando, e eles pareciam incluir a palavra "não"; este tipo de coisas repetiu-se muitas vezes. Era tudo frenético ou agitado. Ele interrompeu isso perguntando: "O que é que o senhor está fazendo; escrevendo mais livros?" com referência às notas que eu estava tomando. Assim, escrevi "Mark" em letras muito grandes e de várias maneiras diferentes. Comentou ele: "Isso não é uma letra boa; é um rabisco".

Acredito que foi aqui que o número 4 foi rasgado por Mark ao assinalar a sua marca de modo cada vez mais vigoroso. Descobriu então que havia perdido completamente o seu lápis. Isto pareceu importante, embora, durante certo tempo, ele houvesse transferido o interesse para um velho canivete que encontrou na caixa de lápis. Juntos exploramos isto e ele: "Tenho permissão para ter um canivete". Com este ele deu pontadas no papel e, às vezes, na mesa; foi neste ponto que foi feita a maior parte dos danos causados ao nº 4. Por diversas vezes, a folha sofreu novos danos e acho que ele estava mostrando por que é que tinha de ser nada, se é que queria deixar que a

"coisa" traumática chegasse. Havia também aqui o tema da penetração que já havíamos obtido da origem de Mark.

Ele se achava então explorando a lata que continha lápis e *crayons*. Tinha eu uma "borracha"? (Eu não tinha.) "Deus do Céu!" E assim por diante. O jogo havia agora terminado e ele começou a andar em volta, procurando algum novo tema. Tirou algo de seus bolsos direito e esquerdo e o enfiou em seus ouvidos direito e esquerdo; pareceu legítimo supor que estava lidando com os sons alucinados e, além disso, que havia vindo preparado para lidar com eles, trazendo pedaços de papel — à sua esquerda e à sua direita — para usar em relação a isto.

Ele estava manifestando um estado confuso, mas rapidamente mudou de assunto e referiu-se ao meu jardim de cobertura, que podia ver da janela. Referiu-se a uma história em uma revista de histórias em quadrinhos e ficou pensando onde a revista poderia estar. Provavelmente mamãe estava com ela, na sala de espera, pensou. Desta maneira, a Mãe real retornou-lhe à mente e pude ver que *o trem expresso tinha sido uma Mãe louca*. Ainda me achava inseguro quanto ao terreno em que pisava, contudo, e posterguei a efetivação da interpretação principal.

A ansiedade revelou-se ainda mais por ele dizer: "Eu poderia estar indo para casa em breve, ou agora". Referiu-se ao medo de barulhos e divertiu-se um pouco com a idéia de a cadeira sair caminhando e comportar-se como se fosse dar um pontapé na Mãe ou ser derrubada.

Fiz uma referência à loucura que isto representava. Ou ele ou eu dissemos: "Tudo ficou maluco" e houve algumas risadas. Falei eu, a respeito da cabeça: "Ela tem olhos, mas não tem ouvidos" e ele respondeu: "Tem sim, mas ela caiu e agora está de cabeça para baixo".

Houve um momento de um mundo louco e algum tipo de som tal como "Woof, woof", dentro da cadeira maluca e, depois, o barulho prosseguiu do outro lado da cadeira. Fiz uma observação a respeito de um lugar maluco dentro da cabeça dele ou, possivelmente, dentro da mãe, e comeci a ficar com a convicção de que aquele menino estava me trazendo um quadro de sua mãe como uma pessoa enferma.

Continuando com o tema da cena primeva, disse eu: "E então Mamãe fez um barulho grande e ele foi chamado de Mark". Acabei por definitivamente dizer: "*Mamãe às vezes fica louca quando você está lá. É isto o que você está me mostrando*".

Ele estava se distraindo, falando a respeito do cuidado que tem de se ter com aparelhos elétricos. Disse: "Nasci menino".

Respondi: "Você nasceu um grande barulho!" E ele replicou: "Não foi!"

Estava agora querendo ir embora, mas dizendo que não estava assustado, simplesmente queria ver a mãe, de maneira que fomos juntos ao encontro dela.

Comentário

Após examinar de novo a mãe, dei-me conta de que ela conduz consigo um grave problema pessoal e, quando lhe falei a respeito disto, ela estava muito disposta a admitir que com muita frequência era uma pessoa enferma.

Mais tarde, a mãe disse que ficara muito contente de que eu houvesse percebido, pela maneira pela qual o menino se comportava, que ela realmente fica louca na frente do filho, e sabia que era isso o que o estava perturbando. Ela própria está fazendo tratamento para a sua condição mental.

Neste exemplo de consulta terapêutica, é possível ver um menino de seis anos comunicar um padrão de personalidade complexo e dinâmico, não um perfil, mas uma representação em profundidade, integrada em um contínuo espaço-tempo.

Ele rapidamente sente as condições especiais da situação profissional e desenvolve a confiança necessária em mim. Baseado nesta premissa, brinca com a loucura pessoal, testando para ver se eu posso suportar os olhos "gozados" e as narinas tríplices. Depois, demonstra a maneira pela qual aprendeu as defesas extremas do nada e da invulnerabilidade. Ele não é mais que uma marca, uma marca que pode facilmente passar sem ser notada. Acontece ter o nome de Mark e utiliza isto de maneira brincalhona.

Agora, o palco se acha pronto. Ele está lá, brincando comigo, e tudo está bem. Ele me avisa a respeito dos trens que têm de entrar em uma linha secundária para deixar passar o expresso. Nos termos dos detalhes do trem a vapor, fala-me a respeito de uma imensa potencialidade de destruição: fogo no outro lado do mundo.

Então, subitamente, fica louco, mas é mais verdadeiro dizer que fica *possuído pela loucura*. Não é mais ele, mas sim uma pessoa louca a quem vejo, alguém que é completamente imprevisível. O trem expresso está passando correndo pela estação, enquanto que o trem local está parado em um desvio. O "nada" está sendo destruído pelo "algo" enlouquecido.

Então a loucura da mãe passa e o menino começa a querer usar a mãe como uma mãe que se importa com ele e de quem precisa para voltar para casa. O menino deixa a minha casa em um estado feliz. Está confiante nesta mãe cujo enlouquecimento agora me foi mostrado, um enlouquecimento que se tornou objetivado e limitado por suas próprias fronteiras. Mark agora tornou-se algo, em vez de nada, e pode brincar de novo, até mesmo brincar com absurdos que, fazendo parte de sua própria loucura, são mais cômicos e risíveis do que traumáticos.

Penso que fui necessário em meu papel especial de alguém que pudesse vê-lo, pensar a seu respeito (miolos argutos na cabeça), experienciar contato com ele (comunicação através de brincar), reconhecer e respeitar suas organizações de defesa (e a defesa extrema de ele não ser "nada"), e, então, assistir a seus estados de ser possuído pela loucura de uma mãe, quando sua própria mãe fica louca na frente dele. Ele também precisava de meu outro contato com a sua mãe, pelo qual pude saber que, quando não insana, ela é uma mãe boa e responsável, assim como boa e responsável esposa do pai do menino.

Onde fica ele quando é nada? Acredito que, na consulta, ele apoiou-se em ter eu uma imagem mental dele em minha cabeça, a qual ele podia chamar de volta após o trem expresso haver passado e o trem local poder sair do desvio.

Nota Adicional

Embora não seja este o intuito deste artigo, quero adicionar que houve uma considerável melhora clínica em seguida a esta consulta terapêutica. Ela se mostrou no desaparecimento do bloqueio em aprender de que os professores do menino se queixavam e apresentou-se também na atitude geral dele em casa, em seu progresso no sentido da independência e em sua nova capacidade de funcionar normalmente com referência às excreções.

PARTE 3

**Sobre o Trabalho de Outros
Analistas**

46

Susan Isaacs

I. Obituário¹

1948

Susan Isaacs faleceu em 12 de outubro, com a idade de 63 anos. Poucos em nossa época podem ter tido influência maior na criação e na educação de crianças; em verdade, a tendência moderna no sentido do pleno reconhecimento do aspecto humano da escola pré-primária e da educação subsequente muito deve ao seu trabalho.

A Dra. Isaacs era filha de William Fairhurst, de Bolton, Lancashire, e de Miriam Sutherland. Educada na Escola Secundária de Bolton e nas Universidades de Manchester e Cambridge, ela tornou-se estudante pesquisadora em Cambridge, no Laboratório Psicológico, em 1912, e, depois, conferencista em psicologia no *Darlington Training College*. Em 1924 foi convidada para ser diretora da *Malting House School* em Cambridge. Foi durante os três anos seguintes que ela coletou os abrangentes dados sobre o comportamento, os pensamentos e os sentimentos das crianças que brilhantemente apresentou em seus dois livros, *Intellectual Growth in Young Children* (1930) e *Social Development in Young Children* (1933).

Em 1933 foi nomeada chefe do novo Departamento de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Londres, no Instituto de Educação, e deteve essa posição com excepcional sucesso durante dez anos. No decurso desse período, um grande número de professores e educadores experimentados foi enriquecido pelos novos conhecimentos amplos e profundos que ela pôde transmitir e, acima de tudo, por seu senso vívido de toda criança ser uma personalidade viva e completa, que precisa ser imaginativamente percebida e compreendida por seu próprio direito.

A Dra. Isaacs voltou-se para o novo *insight* oferecido pela psicanálise freudiana assim que essa obra tornou-se geralmente conhecida na Inglaterra, filiando-se à Sociedade Psicanalítica Britânica em 1921. Foi nomeada psicóloga da equipe da Clínica de Psicanálise de Londres em 1931 e permaneceu fazendo parte dela até o seu falecimento, havendo contribuído notavelmente, de várias formas, para o trabalho científico da Sociedade e o trabalho prático do Instituto. Foi um membro valioso do Comitê de Formação e do Conselho.

A Dra. Isaacs era uma escritora clara, assim como professora e conferencista; seus livros e trabalhos científicos são bem-conhecidos hoje dos estudiosos de psicologia.

1. Publicado em *Nature*, 4 de dezembro de 1948.

gia. Seu pequeno manual para mãe e professores, *The Nurse Years*, escrito em 1929, é conhecido em todo o mundo e recebeu nos Estados Unidos a Medalha do *Parent's Magazine*. *The Children We Teach* constitui outro livrinho seu, amplamente popular. Um dos livros publicados logo antes de sua morte é *Childhood and After*, que contém ensaios e estudos de psicologia clínica pertencentes ao período mais tardio de sua vida. Um capítulo dele, intitulado *Children in Institutions*, originalmente um relatório apresentado ao Comitê de Cuidado de Crianças do Ministério do Interior, também conhecido como Comitê Curtis, em 1945, foi provavelmente o documento isolado mais importante consultado por esse Comitê.

Os dotes da Dra. Isaacs baseavam-se em uma combinação de fatores intelectuais e emocionais. Seu interesse apaixonado pelas condições, primeiro, da educação de crianças pequenas, e, segundo, de sua criação geral no lar, surgiu de suas próprias experiências. O falecimento de sua mãe quando ela tinha apenas seis anos, dando fim a uma doença fatal e incapacitante que começara quando Susan mal contava quatro anos, levou-a a encontrar em sua primeira escola elementar em uma cidade do Lancashire, na década de 1880, refúgio e consolo para a tragédia de casa, mas também a muito rapidamente tornar-se uma rebelde contra suas múltiplas restrições e insuficiências. Esta avidez desapontada é o sentido agudo do que a "escola" poderia ser, mas que na realidade não era, permaneceu como pano de fundo de sua mente através de todo o seu crescimento e muito fez para modelar o seu trabalho posterior na vida.

Tornou-se-lhe claro, já em um estágio inicial de seu desenvolvimento, que a mera crítica e o simples abandono dos métodos existentes não podiam trazer resultados construtivos. Ela rapidamente assimilou e adotou as mais avançadas idéias educacionais correntes na ocasião, e sua reação imediata aos novos ensinamentos da psicanálise mostrou que nenhuma oposição ou resistência convencional poderia manter-se no caminho de sua aceitação sem hesitações de algo que lhe oferecia horizontes mais amplos e uma compreensão mais profunda. Da mesma maneira, em estágio posterior, quando as idéias de Melanie Klein foram pela primeira vez apresentadas na Grã-Bretanha, ela esteve entre os primeiros a sentir as novas fontes de conhecimento que estavam então se abrindo. Percebeu como essas idéias novas podiam ser desenvolvidas para o benefício geral da criação de toda criança e, a partir desse momento, perseguiu esse conhecimento e aplicou-o de modo incansável até o fim.

Sua característica intelectual de realce era uma apreensão extremamente rápida e abrangente do assunto em tela e uma capacidade de classificá-lo e resumi-lo, de apresentá-lo com notável clareza, e de debetê-lo sob diversos ângulos. Sua capacidade excepcional de instantaneamente traduzir seus pensamentos e impressões em expressão verbal, serviu de instrumento poderoso para todos os seus outros dons.

Foi característico de Susan Isaacs que, ao descobrir que existia muito que não havia ainda abrangido, especialmente na obra de Melanie Klein, decidiu-se ela (embora já fosse membro da Sociedade Psicanalítica Britânica) começar de novo como "candidata" e acompanhar todo o curso. Dessa maneira desenvolveu-se ainda mais, passando por uma segunda e longa análise pessoal, e enriqueceu grandemente a sua própria obra e a contribuição que acabou por fazer à pesquisa psicanalítica geral. Em seus últimos anos, devotou-se quase inteiramente à clínica analítica real e achava que esse era o mais satisfatório dos variados tipos de trabalho que havia feito.

Em seu marido, Nathan Isaacs, teve um amigo e apoiador constante, e, também, um crítico construtivo.

II. Prefácio a *Susan Isaacs*, de D.E.M. Gardner

*Datado de 9 de setembro de 1968.*²

Quando Susan me telefonou e me disse que estava doente e que iria morrer, fiquei muito zangado. Um ano depois, quando a vi pela última vez, ela me recordou a minha reação irada.

Parecia um desperdício muito grande que essa pessoa muito real e ativa fosse deixar de existir, simplesmente por causa de um câncer.

Susan e eu viemos a nos conhecer quando éramos ambos estudantes do Instituto de Psicanálise, em meados da década de 30. Ela já havia feito o seu trabalho básico na *Malting House School* e foi por volta dessa época que o Departamento de Desenvolvimento Infantil do Instituto de Educação foi criado para ela. Como psicanalista, estava fazendo uma segunda formação, havendo ficado insatisfeita com a primeira, e isto significava uma segunda análise e uma nova convulsão pessoal.

Foi de grande importância para mim que Susan me houvesse convidado para dar uma série de palestras a cada ano para seus estudantes do Curso de Desenvolvimento Infantil. Fiquei mais que surpreendido. Ela simplesmente me soltou lá, apesar de minhas imaturidades, e, durante alguns anos, fiz palestras para seus estudantes, baseado em minha experiência pediátrica. Gradativamente essas palestras desenvolveram-se em uma série, dez a cada ano, que tentava cobrir o tema do desenvolvimento emocional do indivíduo. Não apenas foi gentil da parte de Susan convidar-me e deixar-me desenvolver meu próprio método e ponto de vista, mas também pode ter sido inteiramente brilhante de sua parte ver que o uso desse tipo de um colega teria possibilidades de não levar a nada. Mas isto era típico dela. Ela era excepcionalmente superior, generosa e, ao mesmo tempo, humana, vulnerável, modesta e bem-humoradamente tolerante. Quando ouvi Nathan criticar cruelmente as idéias e formulações dela, fiquei enfurecido, mas descobri que ela valorizava nele exatamente isso e que fazia um uso positivo de sua impiedosidade, assim como de seu formidável intelecto.

Coube a mim suprir casos infantis para a formação em análise infantil de Susan e assisti com interesse o seu manejo sensível da situação familiar total, coisa difícil de fazer quando se está empenhado em aprender ao mesmo tempo em que se faz um tratamento psicanalítico a envolver sessões diárias durante anos. Nunca tive apreensões a respeito do curso desses tratamentos, embora, naqueles dias, trabalhássemos em um meio ambiente potencialmente hostil.

Naturalmente, houvesse eu sabido que a doença chegaria e abreviaria a nossa amizade, teria tomado a dianteira e faria muito mais uso do que fiz de tudo o que ela tinha a oferecer, mas parecia haver tempo de sobra e, de qualquer modo, todos nós precisávamos nos recuperar da guerra.

E então a vida desta alma vigorosa chegou a um fim e a nós, que sobrevivemos, restou-nos a indignação. Este estudo biográfico compilado por Doroty Gardner proporciona-me um momento de felicidade, por recapturar um pouco da realidade de uma pessoa verdadeiramente grande, uma pessoa que teve uma influência tremenda para o bem sobre a atitude dos pais e dos professores em relação às crianças a seu encargo. Esta tentativa de reconstrução servirá a seu intuito se trouxer Susan viva àqueles que nunca a conheceram, de maneira a que alguns possam sentir-se inclina-

2. Londres: Methuen, 1969.

dos a lerem seus livros por serem apresentados a ela como um ser humano lutador, esforçado e radiante, um ser que parecia destinado a alcançar algo de importante que não podemos agora definir, pois sua morte interrompeu o processo. Ainda há lugar para o estudo do que ela realmente afetou.

Marion Milner

Nota Crítica de *On Not Being Able to Paint*¹

1951¹

Que ninguém pense que este livro versa apenas sobre pintar ou não pintar. Contudo, ele tinha de ter esse título porque foi dessa maneira que a sua redação começou. O propósito real do livro só se torna claro à autora no decorrer de sua experiência de escrever e, na realidade, o livro é, ele próprio, um exemplo de seu tema principal. Este tema, que gradualmente se torna claro ao leitor, já é pressagiado em uma citação inicial: "Conceitos nunca podem ser simplesmente apresentados a mim; eles têm de ser entrelaçados na estrutura do meu ser, e isto só pode ser feito através de minha própria atividade" (M. P. Follett, *Creative Experience*).

O conceito central que é apresentado ao leitor e apreendido pela escritora mediante a redação do livro tem a ver com a maneira subjetiva de experienciar e com o papel disto no processo criativo. Dessa maneira, o livro, em certo sentido, é um apelo em favor do reconhecimento da subjetividade como possuindo o seu próprio lugar e modo de funcionamento, tão legítimo e necessário quanto a objetividade, mas diferente. No que tange à educação, aponta-se que a subjetividade deve ser entendida pelos professores, pois, doutra maneira, a objetividade a que se visa fica em perigo de uma distorção fatal. A pintura entra no assunto como um trampolim do qual se saltou; foi a surpresa de descobrir o poder de fazer desenhos "livres" que concentrou a atenção da autora neste problema da subjetividade ou ação subjetiva.

O conceito do papel da subjetividade que emerge possui dois aspectos principais, um tendo a ver com a ilusão e o outro com a espontaneidade. Ambos se acham ligados com o que a autora chama de a interação das diferenças, da qual a criatividade surge, mas se se quer permitir a interação em si mesmo, tem-se de estar preparado para o sofrimento mental. Uma interação desse tipo precisa de várias descrições, de acordo com o nível que está sendo considerado. Em um estágio comparativamente tardio de desenvolvimento emocional, aquilo que é familiar na literatura psicanalítica a respeito do conflito inconsciente entre amor e ódio nos relacionamentos interpessoais é importante, e, em verdade, preparou o caminho para todos os outros enunciados. Um conflito desse tipo envolve o problema da preservação do objeto amado

1: Este livro foi escrito sob o nome de Joanna Field; Londres, Heinemann, 1950. A resenha de Winnicott apareceu no *British Journal of Medical Psychology* (1951). — Os Organizadores.

quanto ao ódio e quanto aos ataques eróticos (quer na realidade, quer na fantasia) e, neste *setting*, a criação é vista como um ato de reparação. Se considerar-se estágios anteriores do desenvolvimento emocional do indivíduo, tem-se de usar outra linguagem, tal como a declaração de que a criatividade mágica constitui uma alternativa ao aniquilamento mágico.

Se entendo a autora de modo correto, ela deseja fazer uma declaração ainda mais fundamental a respeito da criatividade. Ela quer dizer que esta resulta do que é, para ela (e, talvez, para todos), o transe humano primário. Este transe surge da não-identidade daquilo que se concebe e do que há para perceber. Para a mente objetiva de outra pessoa que esteja vendo de fora, aquilo que é externo a um indivíduo nunca é idêntico ao que está dentro desse indivíduo. Mas pode haver, e tem de haver, para a saúde (assim implica a autora), um ponto de encontro, uma sobreposição parcial, um estágio de ilusão, intoxicação, transfiguração. Nas artes, este ponto de encontro é, de modo preeminente, encontrado através do veículo, aquele fragmento do mundo externo que assume a forma da concepção interna. Na pintura, na escrita, na música, etc., um indivíduo pode encontrar ilhas de paz e, dessa maneira, obter um alívio momentâneo quanto ao transe primário dos seres humanos sadios.

Os psicanalistas estão acostumados a pensar nas artes como fugas realizadoras de desejos quanto ao conhecimento desta discrepância existente entre o interno e o externo, o desejo e a realidade. Para alguns deles, pode ser um certo choque encontrar uma psicanalista que tira a conclusão, após um estudo cuidadoso, que essa ilusão realizadora de desejos pode ser a base essencial de toda a verdadeira objetividade. Se estes momentos de fusão de sujeito e objeto, interno e externo, são em verdade mais que ilhas de paz, este fato possui então importância muito grande para a educação, pois o que é uma ilusão quando vista de fora não é bem-descrita como ilusão quando vista de dentro, pois essa fusão que ocorre quando se sente que o objeto é um só e o mesmo que o sonho (como acontece quando nos apaixonamos por alguém ou por algo) é, quando vista desde dentro, uma realidade psíquica para a qual a palavra ilusão não se mostra apropriada. Este é o processo pelo qual o interno se torna concretizado em forma externa e, como tal, torna-se a base, não apenas da percepção interna, mas também de toda a percepção verdadeira do meio ambiente. Assim, a própria percepção é vista como sendo um processo criativo. Na prática, os psicanalistas, tal como outras pessoas, amam as artes e valorizam o trabalho daqueles que lidam com a ilusão. Este livro está-lhes mostrando uma maneira pela qual podem alinhar a sua teoria não apenas com a sua psicoterapia, mas também com as suas vidas cotidianas.

Ademais, a autora está lembrando os psicanalistas e todos os professores que ensinar não é suficiente; cada estudante tem de criar o que há para ser ensinado e, dessa maneira, chegar a cada estágio de aprendizagem a seu próprio modo. Se ele temporariamente se esquece de reconhecer dívidas, isto é facilmente esquecido, uma vez que, em lugar de pagá-las, ele redescobre com frescor e originalidade, e também com prazer, e tanto o estudante quanto o tema crescem na experiência.

O segundo fio da meada do livro, qual seja, o papel da espontaneidade na criatividade, é também algo que os psicanalistas tendem a permitir mais em uma prática do que em sua teoria. Eles estão bem-acostumados a teorizar a respeito dos efeitos de um controle demasiadamente rígido da espontaneidade, imposto nos interesses da vida social e das boas maneiras. O que eles, e também outros professores, estão menos acostumados a considerar é o efeito embrutecedor sobre o espírito criativo que tem a insistência demasiadamente grande não apenas nas boas maneiras, mas também na objetividade. Esta insistência na objetividade concerne não apenas à percepção, mas também à ação, e a criatividade pode ser destruída por uma insistência demasiadamente grande em que, ao agir, tem-se de saber antecipadamente o que se está fazendo.

Ernest Jones

I. Obituário¹

1958¹

O falecimento de Ernest Jones tem importância primordial para todo o mundo psicanalítico. Para a Sociedade Psicanalítica Britânica esta importância naturalmente se intensifica, uma vez que Jones criou a Sociedade e por muitos anos dominou-a através de sua personalidade e dedicação. Para alguns membros, especialmente aqueles cujas raízes analíticas estendem-se à década que se seguiu à I Guerra Mundial, a morte de Jones significa uma grande perda pessoal.

Jones nasceu no sul do País de Gales. Sua educação ocorreu na *Swansea Grammar School* e no *University College*, de Cardiff, e foi no *University College Hospital*, em Londres, que fez a sua formação médica. Desde os primeiros estágios da vida profissional de Jones houve sinais inequívocos de sua excepcional capacidade. Tinha um dos mais belos intelectos e, ao mesmo tempo, um ardente impulso a trabalhar arduamente e a concentrar-se no trabalho que se achava à mão. Seus interesses neste estágio inicial incluíram a medicina clínica, a cirurgia, a neurologia, a patologia, e também a psiquiatria clínica, embora a última, tal como a conhecemos agora, fosse então quase inexistente. Indubitavelmente a amizade de Wilfred Trotter foi-lhe importante neste estágio. Trotter e Jones associaram-se em sua "descoberta" de Freud. Ali achava-se um colega destinado a estar na primeira fila da cirurgia que contribuiu positivamente, em anos posteriores, para a teoria do comportamento e coesão grupal. Uma amizade desse tipo foi sem dúvida valiosa durante o estágio descrito em sua autobiografia², quando Jones estava penosamente começando a descobrir que médicos, cirurgiões e psiquiatras não queriam ter o seu terreno invadido pela disciplina de uma ciência nova.

Em 1910, Trotter casou-se com a irmã de Jones. O desenvolvimento e a evolução desta amizade acham-se bem-descritos na autobiografia.

1. Publicado no *International Journal of Psycho-Analysis* (1958). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.
2. *Free Association: Memories of a Psycho-Analyst* (London: Hogarth Press, 1959).

Jones qualificou-se como médico em 1900, com Medalha de Ouro tanto em medicina quanto em obstetrícia. Em 1903 novamente foi-lhe concedida essa medalha no exame de Londres para doutor em medicina. Filiou-se ao *Royal College of Physicians* em 1904 e recebeu o Diploma de Saúde Pública (Cambridge) em 1905. Após a qualificação, teve diversas nomeações para hospitais: o *University College Hospital*, em Londres; o *National Hospital*, na *Queen Square*, Londres; o *Hospital for Sick Children*, *Greast Osmond Street*, Londres, e o *Royal Ophthalmic Hospital*, Londres. Deteve o posto de patologista no *West End Hospital for Nervous Diseases* e foi conferencista em neurologia prática na *London School of Clinical Medicine*. Ele rapidamente tornou-se ativo entre estudantes e colegas, bem como em encontros científicos, e havendo-se formado ainda moço, treinou muitos outros para o grau de Doutor em Medicina trabalhando através de um *University Correspondence College*, na *Red Lion Square*, Londres, W.C., dirigido por um certo Sr. E. S. Weymouth. Continuou com isto por cerca de 20 anos, mesmo quando se encontrava no Canadá, apesar de o trabalho ser exigente. Acabou por ser sua esposa Katherine quem o persuadiu a preservar suas energias nesse sentido.

Jones começou cedo a publicar trabalhos, e a quantidade de sua produção foi sempre grande, do que dá evidência a relação de suas obras publicadas (ver a bibliografia de autoria de Grinstein)³.

Talvez seja interessante examinar os seus textos deste estágio inicial, em que já surgem provas de seus imensos poderes de aplicação e das amplas leituras associadas com toda a sua obra escrita. Em 1907, em um artigo sobre "Cirrose Alcoólica do Fígado em Crianças"⁴, Jones fornece 185 referências! Outro exemplo a ilustrar a quantidade de trabalho que Jones estava pronto a efetuar na preparação de um artigo, pode ser mencionado o trabalho sobre "A Questão do Lado Afetado na Hemiplegia nas Lesões Arteriais do Cérebro"⁵. O objetivo deste artigo era expor uma falácia existente nos ensinamentos da época, qual seja, a de que a lesão da hemiplegia tende ser encontrada com mais frequência em um lado do que no outro. Jones cita 5.281 casos publicados e o artigo termina por sete páginas cerradamente impressas de referências, cerca de mil no total!

A mesma atitude com respeito a trabalhos publicados aparece em data posterior no livro *On the Nightmare*⁶, e também no artigo "A Significação Simbólica do Sal"⁷, assim como em muitos outros livros e artigos.

Fica-se pensando o que teria acontecido se Jones não houvesse descoberto a obra de Freud. É possível que tivesse explorado a sua capacidade intelectual e perdido contato com as questões comuns do sentimento? Ao especular-se desta maneira, é interessante examinar o seu artigo "A Importância da Sensação Prictopática"⁸. Este trabalho termina assim:

Conclusão. As sensações que apresentam os seis aspectos aqui agrupados sob a designação de prictopáticos são devidas a uma divisão entre as sensibilidades estésicas e os sentimentos mnêmicos autossomatognósticos de uma parte do corpo, clivagem que resulta de uma desagregação histórica a implicar o último grupo de processos mentais; o grau com que os aspectos são assinalados constitui uma medida precisa da extensão desta divisão.

3. Alexander Grinstein, *The Index of Psychoanalytic Writings*, prefácio de Ernest Jones, vol. 2. (New York; International Universities Press, 1957).
4. *British Journal of Children's Diseases* (1907).
5. *Quarterly Journal of Medicine*, 3, nº 11 (1910).
6. London: Hogarth Press, 1931.
7. *Essays in Applied Psycho-Analysis*, vol 2 (London, Hogarth Press, 1951), pág. 22.
8. *Journal of Nervous and Mental Diseases*, 35, nº 7 (1908).

Em textos subseqüentes, Jones pareceu evitar exatamente o tipo de sagacidade especializada que é aqui ilustrada.

Foi justamente nesta época que Jones se achava assimilando a contribuição de Freud. Havia adquirido domínio da língua alemã e, como estudante pós-graduado em Munique, familiarizara-se com a neurologia e a psiquiatria alemãs. No ano seguinte, 1909, contribuiu para o *Journal of Abnormal Psychology* com uma descrição da psicanálise. Evidentemente esta última e o novo interesse na vida emocional do indivíduo haviam ocasionado nele uma mudança profunda.

Incidentalmente, a palavra "prictopático" parece ter sido invenção sua. Deve-se enfatizar que Jones não tinha tendência a instituir termos novos e criticava aqueles que assim facilmente o faziam. Sua palavra "racionalização", porém, faz hoje parte da língua inglesa, e o valor de sua expressão "afanisia" ainda não foi inteiramente explorado.

Uma série de golpes severos interrompeu a linha de sua carreira em Londres e é afortunado que tenhamos deles uma descrição precisa em sua autobiografia, uma vez que produziram uma visão distorcida de Jones, que perdurou até os principais atores do drama haverem falecido. Em uma tentativa de reabilitar-se, Jones trabalhou no Canadá durante o período de 1908 a 1912, com o apoio de Osler. Lá tornou-se Professor Adjunto de Psiquiatria na Universidade de Toronto. Ao mesmo tempo, manteve-se em contato com Freud e com o grupo que estava se tornando associado a Freud e à obra deste em Viena. O relato que o próprio Jones faz de sua relação com Freud nesta ocasião pode ser encontrado nas páginas da biografia de Freud, bem como seu amor pela Europa e sua determinação de acabar por voltar a clinicar em Londres.

Enquanto residia no Canadá, Jones manteve contato com neurologistas e psiquiatras dos E. U. A. Tornou-se redator-adjunto do recentemente fundado *Journal of Abnormal Psychology*, de Morton Prince, revista que, por causa deste último, "aceitava artigos psicanalíticos quando outros periódicos deles se esquivavam" (autobiografia).

Jones encontrou Freud e o acompanhou quando este fez sua visita aos Estados Unidos para conferências na *Clark University*.

Nos E. U. A. Jones foi parcialmente responsável pela fundação da Associação Psicopatológica Americana (1910) e, enquanto Brill dava início à Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, Jones organizou a Associação Psicanalítica Americana, destinada aos psicanalistas espalhados através dos Estados Unidos (autobiografia).

A I Guerra Mundial separou Jones dos outros analistas. Nesta ocasião ele fez uma importante contribuição para o tema do traumatismo causado por explosão de granadas [*shell-shock*]. Quando os contatos foram renovados, Freud pôde relatar descobertas semelhantes às de Jones; as primeiras haviam sido publicadas em alemão⁹ por Ferenczi e outros. Foi em grande parte devido a Jones que o intercâmbio científico entre psicanalistas de países inimigos houvesse sido retomado no primeiro momento possível após a cessação das hostilidades.

Durante a guerra, Jones estava clinicando em caráter particular em Londres e empenhado no processo de tornar integrado o Grupo Britânico. Ele formara a Sociedade de Psicanalistas de Londres em 1913, mas acabou por dissolvê-la, porque um de seus membros importantes favorecia Jung. A sociedade reconstituída foi denominada de Sociedade Psicanalítica Britânica, e passou a atuar em 1919, com Jones como presidente, o Dr. Douglas Bryan como secretário e o Dr. W. H. B. Stoddart como tesoureiro. Os outros membros fundadores foram o Dr. H. Devine, o Sr. Eric Hiller, o Dr. David Forsyth, o Sr. J. C. Flugel, a Srta. Barbara Low, a Sra. Joan Riviere e o Major

9. Freud, Ferenczi, Abraham, Simmel e Jones, *Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Diskussion am 5. Internationalen Psychoanalytischen Kongress, Budapest, 1910* (Viena: Deuticke).

Sanford Read. Nos anos seguintes à guerra, um certo número de outras pessoas tornou-se interessado e participou da organização. Elas incluíam o Dr. R. M. Riggall, o Dr. James Glover, o Dr. John Rickman, a Srta. Ella Sharpe, o Sr. James Strachey e a Sra. Alix Strachey, o Dr. Edward Glover e a Dra. Sylvia Payne. Em conjunto com o Dr. Rickman, o Dr. Jones criou a *International Psycho-Analytical Press*, em colaboração com a Hogarth Press, e fundou o *International Journal*, de que foi o redator-chefe de 1920 a 1939, a princípio com a assistência de Joan Riviere como redatora de traduções, responsável pela tradução de alemão.

Por volta da mesma época a Sociedade Psicológica Britânica estava passando por uma transformação ampla. Nas palavras de Jones:

Flugel era o Secretário e eu era Presidente do Conselho que a estava efetuando. Um dos resultados foi a fundação de uma Seção Médica especial, que mostrou ser um foro valiosíssimo para o debate de nossas idéias com outros psicólogos médicos. Para elevar o seu prestígio, conseguimos que W. H. R. Rivers, o eminente antropólogo, fosse o seu primeiro presidente, mas os sete seguintes foram todos psicanalistas, como muitos o foram desde então¹⁰.

Durante este tempo Jones estava desenvolvendo uma clínica particular, estabelecendo o passo para os psicanalistas que, desde essa época, combinaram o trabalho de consulta de um tipo bastante especializado com a sua prática analítica. Jones desempenhou o papel principal no estabelecimento de um esquema de formação que pôde ser oficialmente adotado como formação psicanalítica neste país. Neste estágio, houve necessariamente uma boa quantidade de mal-estar, resultante do fato de que certos importantes e obviamente habilitados praticantes da psiquiatria que se candidataram à filiação à Sociedade, não puderam ser aceitos a menos que estivessem dispostos a passar por uma análise didática, que não é diferente, por qualquer maneira importante, de uma análise terapêutica. Alguns dos efeitos disto ainda podem ser percebidos nos dias de hoje. Vemos quão necessário foi que se estabelecesse o princípio de que a característica principal da formação é a análise pessoal. Este é apenas um exemplo da maneira pela qual Jones utilizou todas as suas forças para apoiar Freud e a psicanálise, e isso em uma ocasião em que a última ainda se achava em processo de estabelecer-se, e de maneira alguma certa quanto aos princípios básicos que deveriam sustentar os programas para a formação de futuros analistas.

Poder-se-ia dizer que Jones admirava Freud e achou possível acreditar no trabalho deste tanto quanto o próprio Freud acreditava. A avaliação que Jones fez desse trabalho parece ter sido invariavelmente positiva, com o resultado de haver podido contribuir de maneira importante nesses estágios iniciais, e não estamos certos de que, sem ele, teríamos chegado a um acordo sobre a política da formação.

Os estudantes que estavam preparados para efetuar a análise e a aprender como se fossem aprendizes encontraram em Jones um professor entusiástico, um professor pronto a entender as suas ansiedades e a fornecer auxílio e conselhos práticos.

Durante as duas décadas entre as guerras, enquanto a Sociedade estava se estabelecendo e desenvolvendo o que poderia ser chamado de uma personalidade, e enquanto o Instituto se organizava, Jones se achava sempre lá, com o dedo nos controles. Raramente houve uma Reunião Científica ou uma Reunião de Comitê sem a presença de Jones.

Em 1940, Jones decidiu morar perto de Midhurst, por causa da guerra, mas manteve-se em contato com a Sociedade e com os analistas que trabalhavam na Clínica. Renunciou à presidência em 1940, pois decidira não retornar a Londres, mas

10. *Sigmund Freud: Life and Work*, vol. 3 (London, Hogarth Press, 1957), p. 12.

concentrar-se principalmente em escrever, ao tempo em que continuava com um certo número de pacientes particulares que podiam morar na campanha. Desta maneira, foi capaz de fazer pleno uso de seus dotes literários. O trabalho executivo podia agora ser deixado para outros. Em verdade, pode ter sido difícil para Jones abandonar a sua posição central, porque a história do desenvolvimento da Sociedade era uma história que só ele sabia, por fazer parte da história dele mesmo. Como iria saber se a Sociedade iria continuar a lutar pelas coisas que ele pessoalmente havia inventado e os princípios básicos que havia estabelecido?

Jones deslocou-se então para a posição de estadista mais velho, lançando a responsabilidade pelos assuntos da Sociedade sobre os ombros daqueles que estivessem dispostos a aceitá-la. Seguiu-se uma democratização desses assuntos, o que, como se revelou, foi bom para a saúde da Sociedade Britânica.

Essas duas décadas entre as guerras foram abarrotadas por uma vida científica e particular muito cheia. Sua primeira esposa, Morfydd Owen, talentosa música galesa, falecera em 1918, sem que do casamento resultassem filhos¹¹. Jones casou-se com Katherine Jokl em 1919 e deste matrimônio nasceram quatro crianças: Gwenith¹², Merwyn, Nesta e Lewis.

É difícil compreender como Jones tenha podido fazer tanto quanto fez nesses 20 anos, desenvolvendo sua vida de casa com os filhos, mantendo controle da Sociedade Britânica que rapidamente se expandia, enquanto mantinha contato constante com Freud e os grupos continentais, e, ao mesmo tempo, permanecendo estreitamente associado com os rápidos desenvolvimentos que ocorriam nos E. U. A.

Uma das mais importantes realizações práticas de Jones foi o estabelecimento da palavra "psicanálise" como algo aceito neste país com referência ao trabalho e ao método de Freud. Para conquistar isto, Jones e Edward Glover assistiram muitos encontros efetuados sob os auspícios da Associação Médica Britânica e o resultado foi a aceitação, pela profissão médica na Grã-Bretanha, da vinculação essencial entre a expressão "psicanálise" e o nome de Freud. Quando a Sociedade Psicanalítica Britânica em 1928 indagou de Jones o que gostaria de receber como presente que comemorasse essa realização, ele pediu uma cadeira a ser utilizada pelo presidente nos Encontros Científicos. Aceitando a cadeira em uma pequena cerimônia, ele disse que não haveria conquistado o seu objetivo sem a ajuda de duas pessoas: Edward Glover e sua própria esposa Katherine. Foi nesta ocasião que cometeu um lapso lingual que causou considerável diversão. Disse que estava certo que o presente seria grandemente apreciado não apenas por ele próprio, mas também por seus predecessores na cadeira!

A Dra. Sylvia Paine fez referência a esta cerimônia em seu discurso por ocasião da apresentação do retrato dele em julho de 1946. Este retrato, da autoria de Rodrigo Moynihan, encontra-se hoje na sede da Sociedade Psicanalítica Britânica.

Ao aceitar este retrato, Jones pronunciou um Discurso de Despedida à Sociedade. Isto será lembrado como uma ocasião essencialmente não-emocional, e, embora fosse uma ocasião para tristeza, não foi uma em que todos os presentes se sentissem tristes. Ele terminou o discurso por uma declaração de sua crença no poder supremo da verdade, algo que o capacitara a "advogar com certa confiança uma tolerância maior para com as diversidades ou mesmo divergências que são às vezes apresentadas"¹³.

11. Ver notas biográficas à Edição Comemorativa das Obras Musicais de Morfydd Owen.

12. Gwenith faleceu com 7 1/2 anos de idade, e esta morte causou a Jones profundo pesar, equivalente ao que sentira por ocasião do falecimento da primeira esposa (autobiografia). — D. W. W.

13. *A Valedictory Address, International Journal of Psycho-Analysis*, 27 (1946).

O trabalho científico de Jones é bem-conhecido e é, em todos os aspectos, tão novo e valioso para os estudiosos de hoje quanto o foi na época em que foi apresentado ou escrito. Pode-se ter uma idéia da influência que Jones deve ter tido durante este período por um estudo da relação das muitíssimas sociedades e organizações "de fora" a que ele se dirigiu, embora a maioria de seus trabalhos houvessem sido escritos, quer para o *Journal*, quer para serem pronunciados perante diversas sociedades psicanalíticas na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ou perante a Sociedade Psicológica Britânica e sua Seção Médica. Sair para dirigir-se a grupos, desta maneira, envolve muito sacrifício de horas de lazer e fica-se pensando como Jones pode ter encontrado tempo como o fez para as suas muitas outras atividades, inclusive patinação, esporte em que sua esposa Katherine também encontrava prazer, xadrez e, especialmente, a leitura. Ele foi sempre um leitor de grande amplitude e tinha uma lembrança precisa do que havia lido. Fosse o que fosse o que houvesse estado fazendo, sempre lia durante meia hora antes de dormir, dando preferência à História e assuntos afins. Raramente lia ficção. Dormia bem e, portanto, não utilizava a leitura como sedativo.

No final da década de 30, como é bem-sabido, Jones interessou-se por trazer Freud e sua família, assim como muitos outros analistas (cerca de 50 ao todo), para este país, longe da perseguição nazista. Estas atividades ilustram o comentário feito por Joan Reviere, que escreveu que um dos aspectos da personalidade de Jones que fazia parte do instrumento principal pelo qual o sucesso dele foi alcançado, era a sua capacidade notável de empreender ação: "Imperturbado pelos obstáculos, ele aplicava toda energia e todos os meios disponíveis para fazer avançar o objetivo supremo (...). O que quer que fosse necessário devia ser feito e seria feito"¹⁴.

A história de Jones aposentado em *The Plat, Elsted*, seu lar muito belo em Sussex, dando para os South Downs, constitui uma história de invejável riqueza, e muitos analistas o visitaram lá. Aposentado, ficou não apenas livre para levar uma vida familiar muito mais chegada e para cultivar rosas, mas livre também para ler mais, escrever e organizar os seus trabalhos para publicação, todo o tempo continuando com uma certa clínica psicanalítica particular. Ele continuou sendo redator-chefe da Biblioteca Psicanalítica Internacional até a publicação do quinquagésimo volume, inclusive.

Por volta do ano de 1947, Jones foi convidado a escrever a biografia de Freud. Isto envolvia uma decisão difícil e ele e a esposa Katherine debateram a questão por algum tempo, antes de ele acabar por aceitar. Incidentalmente, isto significava o adiamento da redação de sua própria autobiografia, que ansiava por escrever e que nunca conseguiu completar. Entraria na história que sua esposa datilografou 1.500 cartas pessoais de Freud, todas escritas em alemão!. Isto foi feito porque Jones dissera que tinha uma memória visual e que não poderia utilizar corretamente as cartas se tivesse de trabalhar para entender cada uma delas. A biografia, um ato final de devoção a Freud e à psicanálise, bem como aos psicanalistas do futuro, foi escrita apesar de sua saúde afetada. Em 1947 Jones tivera uma trombose coronária grave, mas se recuperara bem. Em 1957, porém, tivera uma segunda e, a partir da época desta segunda trombose, nunca mais esteve inteiramente bem, às vezes melhor, outras, não tanto. Costumava dizer quão feliz fora na questão da saúde física, mas na realidade, dificilmente poderia ter conhecido a saúde como alguns a conhecem. Ele sofria de um distúrbio sangüíneo herdado, o mal de Gaucher, mas isto não o prejudicava muito. Padeceu, contudo, de reumatismo crônico, e, por causa disto nunca se achava livre de dor. Acabou por desenvolver câncer da bexiga (por volta de janeiro de 1956) e dele se recuperou, mediante tratamento local, apenas o suficiente para conseguir fazer a sua

14. Obituário, *British Medical Journal*, 22 de fevereiro de 1958.

viagem aos Estados Unidos (abril de 1956), quando pronunciou três das Conferências do Centenário de Freud¹⁵. Foram elas: "A Natureza do Gênio" (Nova Iorque); "Nossa Atitude para com a Grandeza" (Chicago), e "A Psiquiatria Antes e Depois de Freud" (Chicago). Padecia muitíssimo, contudo, com o tumor canceroso, que acabou por matá-lo. O grau de dor que sofreu acha-se evidente a quem quer que leia seu breve comentário sobre a dor no *Journal* de Maio-Agosto de 1957¹⁶.

Em seu retorno dos Estados Unidos dirigiu as Celebrações do Centenário de Freud em Londres, desvelando a placa colocada na casa daquele, em Maresfield Gardens 20, repetindo as duas conferências "A Natureza do Gênio" e "Nossa Atitude para com a Grandeza", e pronunciando também uma palestra pelo rádio (*British Broadcasting Corporation*). Uma gravação desta palestra acha-se disponível e ela ilustra admiravelmente a capacidade de Jones em erguer-se à altura de uma ocasião.

Aqueles que não conheceram Ernest Jones gostarão de saber como era ele. Fisicamente, era de estatura baixa, como muitos membros da raça galesa; tinha uma cabeça bastante grande, complexão pálida e penetrantes olhos castanhos. Era vibrante, com uma percepção sensível do meio ambiente e da matéria que era de interesse no momento. Olhando-se os seus olhos e boca durante a leitura de um artigo, podia-se adivinhar seus sentimentos a respeito dele e, especialmente, sua detecção rápida de uma idéia nova. Ele não era alguém com quem se pudesse ficar, como se poderia fazer com um pescador num cais, sem troca de idéias. Tinha muito pouca conversa social. Em casa, era repousante e capaz de ficar mentalmente em repouso; o que se encontrava no contato ordinário com ele era o seu interesse vivaz em tudo a que se dedicava e a sua rápida apreensão do que era bom e do que era mau ou falso. Gostava de associar-se com qualquer coisa que pudesse revelar-se valiosa e isto lhe forneceu um nariz sensível à originalidade e um desejo de apoiar idéias novas. Seu interesse no que era novo refletiu-se em uma das contribuições notáveis que fez a este país, a saber, o seu convite a Melanie Klein para trabalhar em Londres e o incentivo que deu ao trabalho dela, especialmente durante a primeira década após sua chegada aqui em 1926.

As idéias eram mais importantes para Jones do que qualquer outra coisa e elas tinham de suportar o teste. Joan Riviere escreve que uma característica importante do caráter dele consistia em

uma aguda faculdade de percepção, de *insight* — uma propensão a reconhecer provas de valor intrínseco quando e onde elas apareciam e a reagir com um instinto seguro de afirmação a esse reconhecimento. A força e a persistência deste traço de seu caráter eram a mola mestra de sua obra; ele o dominava e desequilibrava aquelas inibições que fazem a maior parte de nós negligenciar ou perder o contato com várias coisas boas que se acham acessíveis. Esta capacidade de reconhecer o valor não se limitava de modo algum à sua apreciação da obra de Freud; ela desempenhou parte importante em seu papel de líder, capacitando-o a utilizar elementos, em pessoas diferentes, de muitos tipos diferentes, até mesmo conflitantes, a fim de servir ao intuito principal em vista. Ela foi também, evidentemente, a fonte de outra característica: a ampla gama de seus interesses¹⁷.

Tem-se de fazer alguma referência ao fato de que aqueles que entravam em contato com Ernest Jones ficavam às vezes ferroados por algo em sua maneira de estabelecer contato. Não é fácil saber exatamente o que era o que as pessoas experienciavam, mas fosse o que fosse, tinha de ser aceito. Sua mãe lhe dissera que ele tinha uma língua ferina. Sua própria rapidez celta não era sempre equiparada por uma

15. *Sigmund Freud: Four Centenary Addresses* (New York, Basic Books, 1956).

16. *International Journal of Psycho-Analysis*, 38 (1957).

17. Obituário, *British Medical Journal*.

rapidez semelhante da parte da outra pessoa, e isto podia facilmente conduzir a um momento de mal-estar, em que se sentia que algo havia saído errado, quando, na realidade, tudo estava bem. Jones tinha uma apreensão aguda de todo assunto pelo qual se interessava e parecia que esperava que houvesse uma preparação semelhante por parte daqueles com quem estava falando. Quando estes, na realidade, não dominavam o seu assunto de maneira comparável à dele, tendiam a ter uma impressão de inferioridade intelectual, com frequência demasiada bem-fundamentada nos fatos.

Tem-se de fazer a pergunta: quão fundo esta característica de agudez penetrava na estrutura de sua personalidade? Pode-se ter uma compreensão melhor de Jones lendo-se a sua autobiografia, que mostra o crescimento espantoso de seu mundo, da provinciana Gower para a psicanálise mundial. Independentemente desse estudo, porém, parecia que alguma resposta já pode ser fornecida por um levantamento geral de seus textos, porque se pode definitivamente dizer que nos ensaios e conferências de Jones existem muito poucos sinais de amargor ou de uma astuta manutenção de escores, e isto deve certamente indicar que a acerbidade constituía um fenômeno relativamente superficial. Talvez seja apenas no artigo "O Complexo de Deus"¹⁸ que se pode perceber um pouco dela, que indubitavelmente afetava os contatos sociais de Jones fora de seu lar e que, tem-se de supor, achava-se relacionada às características que ele livremente admite haver demonstrado nos primeiros anos de sua vida profissional. À medida que envelhecia, parece mais capaz de desvencilhar-se dessa característica.

Tem-se de recordar o fato de que Jones não apenas suportou o impacto da resistência pública inicial à teoria da sexualidade infantil, mas também que foi ele que teve de descobrir essa resistência, pelo menos quando se tornou uma realidade na Inglaterra. Foi ele quem foi tomado de surpresa e quem se descobriu profissionalmente no ostracismo. Poucos teriam se recuperado de experiências como as que ele enfrentou. Este isolamento pode ter sido um pouco determinado pela maneira de estabelecer contato, que pareceu, a alguns dos que o enfrentaram, como sendo um ataque em defesa, quando provavelmente era um ataque destinado a estimular uma reação significativa.

Com relação a isto é instrutivo reler o parágrafo que Jones ofereceu a Freud como adequado a *Moisés e o Monoteísmo*, que estava para ser publicado na Inglaterra. O parágrafo não contém menção à reação inglesa à idéia da sexualidade na infância, mas refere-se apenas à tolerância religiosa que caracteriza este país.

Em nenhum outro país europeu tanta tolerância foi demonstrada para com as descobertas da psicanálise quanto na Inglaterra. Isto se acha de acordo com a profunda confiança que ela tem na importância da liberdade de pensamento. E hoje já faz alguns séculos que a tradição inglesa tem sido a de que a discussão franca e sincera de problemas teológicos e religiosos deve ser incluída nessa liberdade; em verdade, historicamente, foi a origem dela¹⁹.

De alguém que havia sofrido um ostracismo profissional pode-se reivindicar que esta declaração é generosa.

É impossível enfatizar demais a generosidade e a bondade que jaziam por trás de uma atitude que amiúde era acerbica. O vulto de amoroso cuidado que Jones gastava em manuscritos que lhe eram enviados por colegas de todas as partes do mundo era espantoso, e também estava pronto a elogiar quando sentia que podia honestamente fazê-lo. O entusiasmo pelo estabelecimento da psicanálise como ciência

18. *Essays in Applied Psycho-Analysis*, vol. 2, pág. 244.

19. *Ibid.*, prefácio.

era constante e ia de par com isto uma antipatia pelo medíocre, especialmente em um trabalho científico.

Na época em que a maioria dos analistas que se acham hoje vivos vieram a conhecê-lo, Jones já se achava livre para relaxar a defesa da psicanálise e a necessidade de estabelecer a sua própria posição pessoal no mundo. Era agora fácil para quem quer que tivesse intenções sérias, chegar rapidamente à cálida apreciação de Jones e à sua avidez por apoiar e ajudar. Naturalmente, ele continuou a sentir e a demonstrar intolerância por analistas que tentavam evitar as implicações do inconsciente, e também a criticar aqueles que, através de suas atividades propagandísticas, revelavam suas próprias dúvidas inconscientes.

Contemplando esse homem e considerando a contribuição continuada que fez durante o período de meio século, é natural pensar no ambiente em que ele trabalhou. Sua esposa Katherine desempenhou papel muito importante em sua vida, proporcionando-lhe paz e felicidade e participando ativamente nos interesses dele.

II. Discurso Fúnebre

*Pronunciado no Crematório de Golders Green, 14 de fevereiro de 1958*²⁰

Compete a mim, como atual presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica, representar a Sociedade neste momento solene.

Ao final de sua longa vida, achamo-nos aqui para prestar tributo a um homem de excepcional calibre. Com 79 anos ele faleceu, mas foi cedo. Achava-se em plena posse de seus poderes e tinha ainda mais a contribuir, não fosse a moléstia ter ultrapassado o lento, mas inevitável progresso da idade. Este é o nosso único pesar. Quanto ao resto, desejaria que diga que reconhecemos uma vida muito plena, plenamente vivida.

Ernest Jones era um galês, nascido em Gales. Não é incomum a este país produzir homens e mulheres com grandes personalidades e belas mentes. Espalhados pelas aldeias galesas existem filósofos e eruditos que atingem fama apenas em sua própria localidade. De vez em quando, por uma razão ou outra, eles se estendem à comunidade mais ampla e então, como foi o caso de Jones, pode não ser a Grã-Bretanha, mas o mundo o que forma a arena natural em que o drama da vida do homem é representado.

Foi sugerido pelo próprio Jones que o fato de ele ser um galês na comunidade britânica fê-lo compreender melhor do que outros poderiam a posição especial da raça judaica, de que Freud foi membro tão eminente.

Deve ter sido evidente desde o início que Jones era excepcionalmente brilhante. Não tenho o registro de seus anos escolares. Na ocasião em que se qualificou como médico no *University College Hospital*, onde acabou por falecer, estabelecera-se como consultor de ouro em diversos assuntos, e poderia evidentemente chegar à eminência em qualquer campo que escolhesse tornar seu. Jones era certamente um dos trabalha-

20. Publicado no *International Journal of Psycho-Analysis* (1958). Copyright (C) *Institute of Psycho-Analysis*.

dores do mundo. Sua capacidade de trabalho, sempre em marcha acelerada, era fenomenal, e adorava burilar um trabalho, do que dão testemunho as 80 contribuições reunidas nas cinco edições de seus ensaios, cada um deles uma pequena obra-prima.

Sua capacidade de ler e recordar o que lia era imensa, e persistiu até o fim de sua vida. Não era apenas em seu trabalho que Jones situava-se no topo. Tinha muitos interesses pessoais e parece nunca haver deixado de imprimir a sua marca no que quer que fizesse. Uma das desvantagens de sua longa vida é que, inevitavelmente, aqueles que se acharam associados com ele nos primeiros estágios de sua carreira já se encontram, na maioria, falecidos. Jones estava empenhado em escrever a sua autobiografia, e é de se esperar que tenha tido tempo de colocar por escrito muitos detalhes que nos ajudarão, como estudiosos deste grande homem, em nossa tentativa de entender mais um exemplo de gênio. Na época em que o próprio Jones aparece em sua biografia de Freud ele já havia passado por muitas coisas. Em 1908, quando pela primeira vez apareceu como convidado da Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras, Jones contava 29 anos.

Só posso tentar adivinhar a vida do jovem e brilhante clínico que parecia ter o mundo da neurologia aos seus pés, mas que escolheu trabalhar com Freud, tornando-se assim impopular entre seus colegas médicos. Ao recordar Jones, é necessário que nós próprios nos lembremos que lhe foi necessário enfrentar a tormenta de insultos. No início da década de 20, quando eu próprio cheguei à cena, encontrei uma profissão médica hostil a Jones, e esta hostilidade encontrou expressão direta no retardamento quase indefinido de sua eleição para membro do *Royal College of Physicians*. A menos que reconheçamos os antagonistas a Jones e à psicanálise na profissão médica da época, não podemos avaliar corretamente a sua contribuição à psicanálise neste país.

Gradativamente ocorreu uma mudança de clima e ser psicanalista não é mais algo que se deva esconder. Jones recebia apoio de amigos, mas tem-se de presumir que a hostilidade geral de seus colegas de profissão era-lhe matéria de grande pensar. Ele, tanto quanto qualquer outro, teria gostado de um reconhecimento precoce do seu valor. Fora de dúvida, não era santo. Indubitavelmente, desejava ser querido e conhecido em seu tempo, mas foi-lhe necessário permanecer relativamente obscuro por diversas décadas. Foi este o preço que pagou pelo seu rápido reconhecimento da importância de Freud e por sua resoluta lealdade ao mestre escolhido. Certamente, quando consideramos o fato da ambição pessoal, temos de admirar Ernest Jones não menos pelo fato de ele haver-se não apenas contentado, mas de ter sentido orgulho em trabalhar com outro homem que sentia ser, em todos os respeitos, maior que ele próprio.

É difícil imaginar entre dois homens um relacionamento mais proveitoso que o de Jones e Freud. Eu diria que eles não eram de modo algum semelhantes. Havia um fio agudo no espírito de Jones que não parece ter contrapartida no Freud que Jones nos descreve. Jones não idealizou Freud. Ele percebeu o valor e a originalidade de sua contribuição, ajudou a prover um ambiente em que as novas idéias podiam ser debatidas e desenvolvidas e, para este fundo comum psicanalítico, contribuiu ele próprio de modo muito rico.

A Ernest Jones devemos a introdução da obra de Freud neste país e a criação de nossa Sociedade Científica. Foi ele quem fundou a nossa revista e 50 livros foram publicados, sob a sua direção, pela Biblioteca Psicanalítica Internacional. Neste momento, contudo, não estamos tão interessados em relacionar as suas contribuições quanto em recordar o homem.

Foi característico de Jones que ele houvesse sensatamente se retirando para a campanha enquanto ainda se achava apto a desfrutar a vida de família e o seu jardim. Aposentado, trabalhou, naturalmente, tão arduamente como sempre, tratando pacientes, lendo, escrevendo. Em *The Plat, Elsted*, a família cresceu em torno dele e aqueles que o visitavam nunca deixavam de sentir-se enriquecidos pela experiência. Certa-

mente, nada mais se poderia esperar, mas quando já contava 70 anos, tornou-se seu grande privilégio e imensa tarefa escrever a biografia de Freud e a história do desenvolvimento das idéias deste. A fim de fazê-lo, ele e a Sra. Jones empaparam-se completamente de Freud, a um ponto tal, foi-me dito, que podiam jogar jogos em que perguntavam um ao outro o que Freud teria estado fazendo em tal ou qual data, às quatro horas da tarde. O resultado deste ato final de devoção a Freud foi uma biografia que alcançou fama mundial.

E agora chegamos ao final da vida deste homem. A Sociedade, seus Membros, Membros Associados, Estudantes e futuros Estudantes desejam oferecer à sua viúva nossa solidariedade e nosso amor. Nós a amamos por causa de nossa afeição por Jones e também por ela própria, como alguém tão obviamente feliz em ser esposa dele, mãe de seus filhos e companheira no estudo de Freud. Pensamos também em seus três filhos, sua nora e seus netos, e gostaríamos que soubessem que algo de Ernest Jones continua nos corações daqueles que o conheceram. Ele continuará a ser importante para todos aqueles que, em gerações futuras, se beneficiarão diretamente da posição que assumiu em defesa da reivindicação de Freud de que a natureza humana pode ser estudada de modo científico: a totalidade da natureza humana, sem exceção.

49

Dorothy Burlingham

Resenha de *A Study of Three Pairs of Identical Twins*¹

1953

Para aqueles que estão pensando em, da próxima vez, tentarem a experiência de nascerem gêmeos, o meu conselho é escolher pais que morem perto de uma biblioteca. Poucos pais podem dar-se ao luxo de adquirir o livro da Sra. Burlingham, mas, contudo, podem gostar de acompanhar a sorte dos três pares de gêmeos idênticos, de cujo desenvolvimento os detalhes são de modo claro e fiel descritos em tabelas. Tabelas desse tipo são caras de imprimir, mas são indispensáveis aqui, e a Imago Publishing Co. deve ser congratulada por lançar uma produção tão bela quando valiosa.

O estudo constitui um registro do trabalho que foi feito, e o comentário, que compreende apenas metade do livro, destina-se presumivelmente aos que trabalham no campo, uma vez que nas conclusões pessoais da Sra. Burlingham, ao final dos capítulos, são utilizados certos termos que só seriam corretamente entendidos por aqueles que conhecem o uso psicanalítico atual. Retornarei a este ponto mais tarde, quando oferecer certas críticas.

Há muito tempo se sabe que a Sra. Burlingham tem um interesse especial em gêmeos, e não apenas nos três conjuntos de gêmeos idênticos que são aqui apresentados. Um livro suplementar sobre gêmeos não-idênticos fica sendo avidamente aguardado. Neste volume, através de um planejamento cuidadoso, as massas de fatos são dispostas para nosso benefício, fatos que foram registrados em uma época de ataques aéreos máximos, em grande parte por pessoas cuja própria relação com o lar e com o país fora tão rudemente perturbada que se lhes poderia desculpar a paralisia. Isto não é mencionado no livro, embora haja referências inevitáveis a bombas, abrigos antiaéreos e separações causadas pela guerra.

Os detalhes das vidas cotidianas das crianças são apresentados de maneira tal, com a ajuda da impressão em três cores, que se pode seguir sem dificuldade o desenvolvimento de cada criança e de cada par, e logo se vem a conhecer as crianças bastante bem. Talvez seja melhor para o leitor começar pelas tabelas do conjunto de gêmeos que é apresentado por último, porque estes já contavam três anos e sete meses quando foram colocados sob observação e fica-se em terreno familiar em seguida,

1. London: Imago, 1953. A resenha de Winnicott apareceu em *New Era in Home and School* (março de 1953).

assistindo-se ao desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais positivos e negativos, da vida instintiva e da organização das defesas contra a ansiedade e o intolerável conflito interno.

Exemplificando, é fácil, a partir das tabelas, e seguindo a cor e a coluna apropriadas, ver-se que Mary, aos três anos e onze meses, assumiu um papel masculino. Aos quatro, disse: "Sou Papai". Por volta desta época, confrontada com o pai, hesitou, enquanto Madge correu para encontrá-lo e beijá-lo. Este estado de coisas achava-se relacionado a um papel submisso que estava sendo desempenhado pela última. Após Madge ter estado ausente por doença, contudo, os papéis até certo ponto se invertiram. Foi então Madge quem disse: "Papai não deve ser morto". Este é apenas um dos muitos tipos de temas que podem ser estudados a partir das tabelas por quem quer que tenha uma oportunidade limitada para o estudo de gêmeos reais em desenvolvimento e em um meio ambiente controlado, mas contudo, humano. Muitas das observações destas crianças recordam-nos as de Susan Isaacs, Piaget, Gesell; elas são interessantes, mas atualmente, em grande parte suplantadas por observações diretas feitas por estudiosos no trabalho prático. Exemplo: Madge (5 anos e 2 meses): "Hoje vai ser ontem amanhã?" como exemplo da concepção que a criança faz do tempo. Esta e outras observações comparáveis possuem valor adicional por se acharem relacionadas ao clima emocional e ao *setting* ambiental (neste caso, a ausência de Mary, a outra gêmea, por causa de doença).

Ambos os outros conjuntos de gêmeos chegaram às *Hampstead Nurseries* com quatro meses. Bill e Bert, assim como Bessie e Jessie, haviam sido evacuados junto com as mães logo após o nascimento. Ambos os pares não tinham pai. As observações deles, retroagindo aos primeiros meses, fornecem dados que só podem ser superados por estudos psicanalíticos complementares para o desenvolvimento da teoria do crescimento emocional dos seres humanos.

A primeira pergunta que será feita é: quando os gêmeos se tornaram cientes um do outro? Bill e Bert começaram a tomar notícia um do outro aos sete meses, e Jessie e Bessie, aos oito. Em cada caso houve uma defasagem de tempo entre o primeiro reconhecimento e o reconhecimento mútuo. O início da reação à mãe foi muito anterior, mas era difícil de separar de uma reação geral às enfermeiras, que eram também conhecidas pelos gêmeos. Com este importante comentário restritivo, poder-se-ia dizer que ambos os bebês (Bill e Bert) tomaram conhecimento da visita da mãe a partir dos quatro meses, o tempo mais primitivo de observação. Com Jessie e Bessie, a reação à mãe começou vários meses antes que reagissem uma à outra. Aos quatro meses, Jessie sorriu para a mãe, e, aos sete meses, ela e Bessie tiveram contato com ela, o que acredito significar que haviam formado um relacionamento humano com a mãe.

Estas reações mostram o caráter tardio da reação mútua observável entre os gêmeos destes dois pares, e possuem também um interesse inteiramente à parte do estudo da geminalidade. É claro que os que os estavam observando não tinham interesse pessoal nisso, mas estavam apenas, dia a dia, tomando notas do que havia para ver e ouvir.

Dou esta amostra para tentar estimular o apetite do leitor, de maneira a que o livro seja corretamente lido e utilizado.

A Sra. Burlingham gradualmente demonstra que, com gêmeos, não existe a semelhança inata. Logo eles começam a copiar-se mutuamente. Copiam um ao outro por várias razões distintas, tal como, por exemplo: para agradar a si mesmos e agradar a mãe; para distrair-se mutuamente; por causa de uma dependência que um tem do outro; por causa da identificação, com um incorporando o outro e, assim, imitando-o compulsivamente; para chegar a um equilíbrio entre ter tudo ou renunciar a tudo, mediante a justiça e a exigência de um tratamento igual, e assim por diante.

Há, no relacionamento de gêmeos, uma oportunidade única para o trabalho de equipe e a Sra. Burlingham tem um comentário a fazer sobre a luz que um estudo da geminalidade tem possibilidades de lançar sobre as origens da gangue, tal como, por exemplo, a de delinquentes.

Aos dois anos e cinco meses Jessie e Bessie foram separadas por causa de doença. Quando disseram a Bessie para deitar-se, ela respondeu: "Eu não sou Bessie, eu sou Jessie" e deitou-se de modo normal quando foi chamada de Jessie. A Sra. Burlingham aponta a identificação com o objeto amoroso perdido que é ilustrada aqui e em outras partes do material. Meu comentário é que, com gêmeos, o lado mágico da identificação é facilitado, o que significa que o lado imaginativo pode ser contornado, de maneira que existe menos qualidade depressiva na reação, com esta última dependendo mais da incorporação (imaginativa), antes que da introjeção (mágica). O resultado da primeira é a ansiedade devida aos elementos destrutivos da idéia de incorporação e o da outra é a posse simples pelo objeto amoroso inalterado.

Como crítica, diria que algumas das conclusões da Sra. Burlingham são prejudicadas pelo emprego de termos que têm um público limitado. Exemplificando (pág. 16): "Com base no princípio do prazer, todos os bebês reagem ao que quer que lhe dê sensações de prazer (...)" O termo "Princípio do prazer" é pertinente a uma síntese mental teórica de Freud, e os que se acham familiarizados com o crescimento da teoria psicanalítica entenderão o que significa. Mas a expressão não acrescenta nada e torna o significado do que a Sra. Burlingham quer dizer sujeito a um mau entendimento, especialmente porque o parágrafo termina pela frase "o desejo de agradar à *deux*, em que "prazer" é utilizado da maneira comum e não como um termo técnico com conotação específica. Como termo técnico, ele pertence a um período de teorização em que o elemento que busca objetos na experiência erótica inicial estava sendo negligenciado nos textos psicanalíticos, ainda que (acredito eu) não na prática.

Poderia trazer outras críticas deste tipo, mas permanece o fato de que o livro possui valor real e pode ser usado como uma fonte para o estudioso e como exemplo para aqueles que têm observações detalhadas a apresentar.

A Sra. Burlingham concede o respeito devido à idéia de gêmeos e o contraste que existe entre ser gêmeo e imaginar ser gêmeo. Acho que existe mais a ser dito a respeito da situação real de ser gêmeo. Exemplificando, na ocasião em que os gêmeos começam a demonstrar que se notam mutuamente já houve bastante espaço para um desenvolvimento emocional bom ou insatisfatório. A Sra. Burlingham expõe inteiramente a teoria do relacionamento entre gêmeos em termos de relacionamento interpessoal e, em verdade, como algo profundamente afetado pela satisfação e pelos aspectos frustrantes da situação triangular ordinária (pais e criança), ou seja, o complexo edipiano. Mas os gêmeos são gêmeos antes de chegarem a ser seres humanos totais relacionados a seres humanos totais. Há muito material neste livro para um estudo destas questões muito iniciais.

É correto começar por estudar gêmeos como sendo pessoas que se desenvolvem através desses estágios iniciais (em que o fracasso denota uma predisposição à insanidade) até o estágio do complexo edipiano, em que o fracasso significa neurose.

Mas as primeiras tarefas do bebê me parecem ser subenfatizadas neste livro, e, contudo, elas são provavelmente relevantes. Por tarefas iniciais refiro-me ao seguinte: o desenvolvimento do senso de *self* como uma unidade, integração da personalidade; o desenvolvimento de um senso de existir no corpo, de ocupá-lo, nem mais nem menos; também a aceitação gradual da natureza ilusória de todo contato emocional entre pessoas, da qual decorre ser a percepção objetiva apenas um termo relativo, que se refere a algo que perde o significado assim que fica fora de passo com o processo correspondente de percepção subjetiva, ou de criatividade.

Sei que isto é uma maneira muito pessoal de dizê-lo, mas através dela, talvez possa transmitir a idéia de que há coisas importantes a serem aprendidas com gêmeos e que podem ajudar no estudo das raízes da sanidade e da insanidade. Provavelmente, é mais uma vez a psicanálise, antes que a observação direta, que pode nos fornecer o que se precisa aqui. Tive, em longa análise, dois pacientes que eram gêmeos, e, em cada caso, foi por causa de um distúrbio estabelecido anteriormente ao estágio do complexo edipiano que o meu auxílio foi buscado.

A Sra. Burlingham com facilidade me apoiará quando acentuo o valor do estudo psicanalítico que tem de acompanhar a observação direta e elucidá-la. Sei que ela teve uma grande experiência de gêmeos a que não se faz referência neste livro.

Isto, que escrevi espichando o pescoço enquanto me situo sobre a plataforma que é o livro dela, de maneira alguma modifica a minha opinião do livro, que é a de que ele não possui igual.

W.R.D. Fairbairn

Resenha (escrita com M. Masud R. Khan) de *Psychoanalytic Studies of the Personality*¹

1953

Fairbairn efetuou uma tentativa sincera e ousada de revisar a metapsicologia psicanalítica à luz de sua própria experiência clínica e mediante a reflexão privada que fez enquanto se aplicava à tarefa terapêutica. O leitor poderá enriquecer-se por partilhar da evolução gradual de uma teoria pessoal que é claramente apresentada através do método de uma ordem cronológica na disposição dos trabalhos. Quer se concorde ou discorde da teoria de Fairbairn, há muita coisa a ganhar de um estudo de sua maneira de encarar as coisas.

Um resenhista encontra-se em uma posição menos afortunada que a do leitor comum, uma vez que Fairbairn faz uma reivindicação específica e tem de ser a esta que se dirigem a avaliação e a crítica. A reivindicação é de que a teoria de Fairbairn suplanta a de Freud. Se ele está certo, então ensinamos Fairbairn e não Freud aos nossos estudantes. Se se pudesse escapar desta reivindicação, poder-se-ia desfrutar dos textos de um analista que desafia tudo e que coloca a evidência clínica antes da teoria aceita, que não é um adorador perante um altar. Mas a reivindicação se acha lá. Incidentalmente, Fairbairn escreve como se praticamente não houvessem outros teóricos psicanalíticos, exceto Freud, Abraham e Klein, de maneira que, para que uma resenha seja completa, ela deve incluir as citações dos outros autores que Fairbairn parece não ter levado em conta. Isto, contudo, não será tentado.

O primeiro artigo, "Fatores Esquizóides na Personalidade" (1940) talvez seja a contribuição mais estimulante e recompensante de todo o livro. Aqui, Fairbairn sugere que a compreensão dos estados, processos e síndromes esquizóides, e nada mais, pode produzir a compreensão mais profunda das origens da personalidade humana e a verdadeira base desta. A expressão "esquizóide" naturalmente passa por um imenso alargamento nas mãos dele, e Fairbairn está ciente de que abrange quase todas as facetas do viver humano, se examinada da maneira que ele sugere. E é assim que deveria ser, de acordo com o autor, porque (pág. 8) "o fenômeno esquizóide fundamental é a presença de cisões no ego (...)" e "(...) uma certa medida de cisão do ego

1. London: Tavistock, 1952. Esta resenha apareceu no *International Journal of Psycho-Analysis* (1953). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis. Para comentários posteriores feitos por Winnicott a respeito de Fairbairn, ver o Pós-escrito a este volume. — Os Organizadores.

acha-se invariavelmente presente no nível mental mais profundo — ou (para expressar a mesma coisa em termos tomados de empréstimo a Melanie Klein) a *posição básica da psique é invariavelmente uma posição esquizóide*". Acrescenta o autor: "Isto não se aplicaria, naturalmente, ao caso de uma pessoa teoricamente perfeita cujo desenvolvimento houvesse sido ótimo, mas não existe realmente ninguém que desfrute de sorte tão feliz". As provas de que todos, sem exceção, são esquizóides nos níveis mais profundos provêm parcialmente do estudo dos sonhos, porque todas as figuras do sonho "representam seja (1) alguma parte da personalidade do que sonha, seja (2) um objeto com quem alguma parte de sua personalidade tem um relacionamento, comumente na base da identificação, na realidade interna".

O autor faz o seguinte comentário (págs. 8-9, 1940): "o fato de que o que sonha ser caracteristicamente representando no sonho por mais de uma só figura não é capaz de ter outra interpretação exceto que, no nível da consciência [*consciousness*] onírica, o ego do que sonha acha-se cindido. O sonho representa assim um fenômeno esquizóide universal". É importante para o estudioso da teoria de Fairbairn apreender isto, uma vez que os conceitos que o autor tem de estrutura psíquica evoluem a partir da análise de um sonho (relatado nas págs. 95 e segs., 1944); é aqui que ele finalmente chega à conclusão de que "os sonhos são essencialmente, não realizações de desejos, mas dramatizações ou *shorts* (no sentido cinematográfico) de situações que existem na realidade interna" e que as "figuras representam quer parte do 'ego', quer objetos internalizados". Daí (pág. 99) "as situações retratadas nos sonhos representarem relacionamentos existentes entre situações endopsíquicas, e o mesmo se aplica a situações retratadas em fantasias despertas". Em artigo muito anterior (1931: "A Análise de um Paciente com uma Anormalidade Genital"), ao estudar o fenômeno da personificação nos sonhos do paciente, ele havia concluído (pág. 221): "O aparecimento de personificações estáveis nos sonhos do paciente parece indicar a maneira pela qual os fenômenos de personalidade múltipla se originam. Isto sugere que estes fenômenos resultam da invasão do campo consciente por constelações estruturais operantes que se tornam diferenciadas no inconsciente, sob a pressão da necessidade econômica. Sugere também que a divisão tripartida da mente, da autoria de Freud, deve ser considerada como representando uma descrição de constelações estruturais características, de natureza similar, antes que uma análise da mente em entidades componentes". A redução desta "divisão tripartida da mente" a entidades rígidas, por um lado, e a instâncias antropomórficas, por outro, é resultado de outros teóricos analíticos que não Freud. Na metapsicologia deste último, a ênfase incide sobre as propriedades funcionais destas estruturas mentais hipotéticas. A rota metapsicológica que o Dr. Fairbairn segue é muito simples e direta: de personificações a objetos internos e, daí, a estruturas endopsíquicas.

De passagem, deve-se também notar que, embora Fairbairn esteja oferecendo uma teoria total, ele não oferece qualquer hipótese para explicar o trabalho onírico na formação dos sonhos. Da mesma maneira, em sua teoria da estrutura psíquica, ele sequer considera o fato de que uma metapsicologia deve ser capaz de postular alguma hipótese a respeito do funcionamento mental, *e.g.*, a memória, a alucinação. Freud ofereceu uma teoria muito definida do funcionamento mental em *A Interpretação dos Sonhos* (último capítulo) e a sua hipótese de que a libido e os processos primários são regulados pelo princípio do prazer-sofrimento deriva tanto desta área de observação quanto do estudo dos transtornos emocionais.

É possível tirar-se algo do trabalho de Fairbairn sobre sonhos, considerando o relacionamento de seu conceito de introjeção do objeto mau ao trabalho de Freud sobre compulsão à repetição. Se o objeto mau introjetado (a fim de ser coagido ou controlado) constitui uma experiência penosa, isto é, algo percebido, mas não tolerado, então a experiência introjetada repetidamente clama por atenção e dá origem a um

tipo específico de sonho. O conceito de compulsão à repetição nos faz atravessar o período que precisamos para a compreensão de que, para chegar atrás da compulsão à repetição, o paciente tem de redescobrir a situação penosa externa tal como foi originalmente percebida, embora na ocasião não pudesse ser tolerada como um fenômeno situado fora do controle onipotente.

Mas isto é adiantar-se. É necessário retornar para examinar o que o autor considera ser o estado de coisas na primeira infância, exatamente lá onde o processo esquizóide se acha em operação, onde os estados esquizóides que aparecem mais tarde são criados. Existe muito material valioso na parte do livro em que isto é considerado.

Nosso interesse principal deve ser pela teoria que o autor tem sobre as estruturas endopsíquicas. Inspirando-se nas pesquisas sobre fenômenos esquizóides feitas por Freud, Bleuler e Abraham, o autor chega à conclusão de que se as manifestações clínicas de ordem esquizóide têm um ponto de fixação na fase oral inicial, então certamente deve haver uma vinculação muito estreita entre a cisão do ego e uma atitude libidinal de incorporação oral; na realidade, que uma fixação na fase oral inicial desempenha papel proeminente na determinação do padrão da atitude esquizóide.

Na primeira infância, o "primeiro relacionamento social estabelecido pelo indivíduo é o que se dá entre ele próprio e a mãe, e o foco deste relacionamento é a situação de amamentação, na qual o seio da mãe fornece o ponto focal de seu objeto libidinal [do bebê] e a boca dele o ponto focal de sua própria atitude libidinal". Nesta citação (1940) já encontramos todas as características da maneira que Fairbairn tem de olhar para um bebê (isto é, se realmente está olhando para um bebê) que preparam o caminho para a sua construção teórica final. Deve-se notar aqui a designação do relacionamento mãe-criança como "relacionamento social", a igualação do bebê com o indivíduo adulto que ele vai ser, a caracterização do seio como "seu objeto libidinal [do bebê]", e a atribuição de uma "atitude libidinal" à boca do bebê.

Poder-se-ia alegar, em favor do autor, que ele está verbalizando um estado primário pré-verbal, mas o exame do desenvolvimento da hipótese mostrará ao leitor que isto não pode ser levado em consideração no que segue. Fairbairn começa por um bebê que é um ser humano total, um ser que experiencia a relação com o seio como um objeto separado, um objeto que experienciou e a respeito do qual tem idéias complicadas (pág. 11). É esta maneira de trabalhar que faz o autor teorizar categoricamente que a "libido busca objetos", etc. Ele, entretanto, como veremos mais tarde, acha muito difícil manter consistentemente esta opinião segundo a qual o bebê é sempre uma entidade separada, a buscar objetos desde dentro de sua própria existência como entidade.

Retornando ao texto, Fairbairn elabora o assunto fornecendo quatro aspectos principais desta atitude oral inicial (págs. 11-12):

1. Embora o relacionamento emocional envolvido seja essencialmente um relacionamento entre a criança e a sua mãe como pessoa, embora se deva reconhecer que seu objeto libidinal é realmente a mãe como um todo, apesar disso seu interesse libidinal acha-se essencialmente focado no seio dela, e o resultado é que, na proporção em que ocorrem distúrbios no relacionamento, o próprio seio tende a assumir o papel de objeto libidinal, isto é, o objeto libidinal tende a assumir a forma de um órgão corporal ou *objeto parcial* (em contraste com a de uma pessoa ou objeto total).
2. A atitude libidinal é essencialmente uma atitude em que o aspecto de *domar* predomina sobre o de *dar*.
3. A atitude libidinal se caracteriza não apenas por tomar, mas também por *incorporar* e *internalizar*.
4. A situação libidinal é uma situação que confere importância tremenda aos estados de *plenitude* e *vazio* (...).

Fairbairn não torna inteiramente claro qual é a natureza e quais são as causas dos distúrbios no relacionamento mãe-bebê (§ 1, supracitado). Entretanto, de observações feitas em outros lugares, pode-se reunir a sua opinião. Sugere ele (pág. 13) que "a orientação no sentido de objetos parciais encontrada em indivíduos que apresentam características esquizóides é, em grande parte, um fenômeno regressivo determinado por relacionamentos emocionais insatisfatórios com os pais e, particularmente, com as mães, em um estágio da infância subsequente à fase oral inicial em que a orientação se origina. O tipo de mãe que é especialmente inclinada a provocar uma regressão desse tipo é a mãe que fracassa em convencer o filho, através de expressões de afeição espontâneas e genuínas, que ela o ama como pessoa".

Nesta citação e contexto, não está claro se a mãe apenas "provoca a regressão" a esse estado inicial ou se é a criadora dele.

No § 4 (não integralmente citado) Fairbairn menciona "circunstâncias de privação", mas sem tornar claro se elas são o resultado de uma deficiência no cuidado da mãe ou inevitáveis no cuidado infantil. Ao se sustentar que as duas são o mesmo, por causa da maturidade imperfeita de todas as pessoas (inclusive as mães), tem-se de se dizer então que Fairbairn não encontrou uma linguagem que abranja tanto o normal quanto o anormal.

Na página 23 o autor examina minuciosamente "as fontes daquele senso de diferença dos outros que caracteriza os indivíduos com um elemento esquizóide em sua personalidade". Escreve ele que o aspecto seguinte salienta-se de modo proeminente: "No início da vida, eles ficaram com a convicção, quer através da aparente indiferença, quer da aparente possessividade por parte de suas mães, que elas não os amavam e valorizavam realmente como pessoas por seu próprio direito". Esta observação, como muitas outras deste livro, é valiosa e penetrante; infelizmente, a estrutura teórica do autor, que deve ser o nosso interesse principal, estraga a nossa apreciação desses lampejos de *insight* clínico. A contribuição mais valiosa de Fairbairn é a idéia de que, na raiz da personalidade esquizóide, acha-se este fracasso por parte da mãe em ser sentida pelo bebê como amando-o por seu próprio direito como pessoa.

É muito difícil perceber se Fairbairn considera esse fracasso materno como sendo verdadeiramente um fracasso da mãe ou a projeção sobre ela do próprio ódio da criança. Há muita coisa no livro que sugere que a última visão é a principalmente sustentada. Por exemplo (págs. 110-111):

É a experiência de frustração libidinal que invoca a agressão do bebê com relação a seu objeto libidinal e, dessa maneira, dá origem a um estado de ambivalência (...). Do ponto de vista subjetivo do bebê, é a mãe que se torna um objeto ambivalente (...). Uma vez que se lhe mostra intolerável ter um objeto bom que é também mau, ele busca aliviar a situação cindindo a figura da mãe em dois objetos (...), uma vez que a realidade externa parece não ceder, ele dá o melhor de si para transferir o fator traumático na situação para o campo da realidade interna, onde sente que as situações se encontram mais sob seu próprio controle (...). É sempre o objeto "mau" que é internalizado no primeiro caso, pois acho difícil ligar qualquer significado à internalização primária de um objeto bom que é tanto satisfatório quando dócil; do ponto de vista do bebê (...) a internalização de objetos é essencialmente uma medida de coerção, e não é o objeto que satisfaz, mas sim o insatisfatório que o bebê procura coagir.

(De passagem, parece irrealizável correlacionar estes enunciados com o trabalho de Melanie Klein, uma vez que este foi estabelecido com grande clareza e as descobertas de Fairbairn parecem entrecruzar-se com as de Klein. Seria fácil pedir a Fairbairn para fazer um estudo mais atento do trabalho de Klein sem citá-la, mas por outro lado, temos de conceder a um colega o direito de expressar suas opiniões à sua própria maneira, mesmo quando o seu trabalho corre de modo paralelo a um trabalho que está sendo efetuado alhures. É uma pena, contudo, que sejam usados termos que

sugerem familiaridade com trabalhos como os de Klein, em que ela deu às "posições" do desenvolvimento emocional os nomes de "depressiva", "paranóide" e "esquizóide", respectivamente.)

Esta internalização para coagir é certamente um mecanismo de defesa, e um mecanismo que tem sido bem-descrito e aceito na literatura analítica. Fairbairn está, assim, considerando a introjeção como um mecanismo específico de defesa, e não como um processo primário como tal, nem, tampouco, como uma espécie de relacionamento objetal. É difícil perceber como o ser humano poderia construir fontes internas de força, ou a matéria básica do mundo interno que é pessoal e, em verdade o *self* simplesmente recebendo em si objetos "maus", através da operação de um mecanismo de defesa. Isto certamente não passa de uma caricatura da teoria de Klein, se é que se acha de algum modo relacionado a essa teoria, o que parece duvidoso, exceto pelo fato de as expressões se sobreporem parcialmente.

Esta é a posição do autor em 1944. É importante notar que, em um adendo a este artigo, escrito em 1951, ele próprio achou insatisfatório este estado de coisas e busca corrigir-se remontando ao trabalho de 1941 e escrevendo: "O objeto que é originalmente internalizado não é um objeto que corporifique o aspecto exclusivamente 'mau' e insatisfatório do objeto externo, mas o objeto pré-ambivalente (...). A internalização do objeto pré-ambivalente seria então explicada com base em apresentar-se em certa medida insatisfatória e, em certa medida, satisfatória. Nesta pressuposição, a ambivalência será um estado que surge pela primeira vez no ego original não-cindido, em relação não com o objeto externo, mas com um objeto pré-ambivalente internalizado".

Mas isto faz o autor cair em outras contradições, possivelmente piores, e, de qualquer modo, pareceria que se esta nova virada em sua teoria fosse verdadeira, então o seu ponto principal (o de que a libido busca objetos) não mais é bom. Isto poderia ser enunciado pelo método de inverter-se o argumento.

Em sua "sinopse" (1951, pág. 163), o autor fornece uma teoria do desenvolvimento do ego. Seu primeiro princípio é: "O desenvolvimento do ego se caracteriza por um processo pelo qual um estado original de dependência infantil, baseado na identificação primária com o objeto, é abandonado em favor de um estado de dependência adulta ou madura baseado na diferenciação entre objeto e *self*".

Este estado de dependência infantil se caracteriza pela "identificação" primária. Ora, o autor definiu "identificação primária" para nós em uma nota de rodapé (pág. 145): "Emprego o termo 'identificação primária' aqui para significar o investimento [psicoenergético] de um objeto que ainda não foi diferenciado" (o grifo é nosso), "(ou foi apenas parcialmente diferenciado) de si mesmo pelo sujeito investidor. Este processo difere, naturalmente, do processo ordinariamente descrito como 'identificação', a saber, uma tendência emocionalmente determinada a tratar um objeto diferenciado (ou parcialmente diferenciado) como se não fosse diferenciado, quando ele é investido [de energia psíquica]. O último processo deveria ser corretamente descrito como 'identificação secundária'".

Ora, se o objeto não é diferenciado, ele não pode operar como objeto. Ao que Fairbairn está-se referindo então é um bebê com necessidades, mas sem "mecanismo" através do qual implementá-las, um bebê com necessidades que não "buscam" um objeto, mas sim a *dis-tensão*, uma libido a buscar satisfação, uma tensão instintual a procurar um retorno a um estado de repouso ou ausência de excitação, o que nos traz de volta a Freud.

A provisão de uma saída por parte da mãe não faz parte das atividades mentais do bebê, mas é algo que pode (ou não) ser-lhe fornecido. É bem sabido que, *se tudo correr bem*, o bebê individual pode desenvolver-se até um ponto em que pode começar a relacionar o objeto à sua necessidade, a buscá-lo, a criá-lo, a coagi-lo, etc.

Tal como em muitos outros casos, ficamos aqui com a impressão de que o senso intuitivo e clínico de Fairbairn o conduz até o fim do caminho, enquanto que a sua teoria fica atolada algumas milhas atrás. A sua mãe (do tipo esquizóide), que fracassa em proporcionar o sentimento de que ama o bebê como pessoa, é certamente a mãe que não pode atender às próprias necessidades individuais do bebê à medida que elas surgem no próprio início, fazendo a diferença entre a provisão e a não-provisão de uma saída para o bebê, no início, repetidas vezes, quando a libido busca, não um objeto, mas satisfação.

Mais uma vez Fairbairn, que não concede lugar para a criatividade (psíquica) primária em sua teoria, poderia reivindicar haver indicado a sua crença nela pela citação de seu comentário (pág. 141): "(Uma casa) é um objeto que é buscado, mesmo que, para ser encontrada, tenha primeiramente de ser feita". Em parte alguma ele enuncia a maneira pela qual o bebê faz o primeiro objeto (teórico). Em sua teoria, a criatividade psíquica primária não constitui uma propriedade humana; uma série infinita de introjeções e projeções formam a experiência psíquica do bebê. A teoria de Fairbairn se alinha aqui com a que nos foi dada por Melanie Klein, que também não permite que tributo seja prestado à idéia de criatividade psíquica primária.

Na teoria estritamente freudiana, pode-se dizer que este ponto não surgiu, uma vez que o lugar no trabalho clínico em que a questão da criatividade primária surge para consideração não foi atingido. O analista se interessa por toda a gama de realidade e fantasia associada com os relacionamentos interpessoais e o alcance gradual da maturidade nos elementos instintuais desses relacionamentos; apesar disso, não se faz aqui qualquer alegação de que essas questões abranjam toda a gama da experiência humana. Pareceria que apenas comparativamente, de modo recente, os analistas começaram a sentir a necessidade de uma hipótese que abrisse lugar para áreas de experiência de primeira infância e de desenvolvimento do ego que não se achem basicamente associadas ao conflito instintual e onde haja intrinsecamente um processo psíquico tal como o que aqui denominamos de "criatividade (psíquica) primária". Parece ser uma pena que Fairbairn, que tão incisivamente descreveu o caráter esquizóide, com o seu senso de futilidade e vazio, em suas sínteses mentais teóricas, não fizesse uso de uma hipótese que lhe teria fornecido uma pista quanto às raízes desse senso na experiência da primeira infância.

Pareceria que, enquanto Fairbairn esteve se desenvolvendo pessoalmente em acordo com o trabalho psicanalítico honesto, sua teoria foi adversamente afetada pelo fato de ele não haver estado em contato clínico com bebês e casais a criá-los. Em conseqüência, ele deixa de notar as tremendas diferenças que existem entre as necessidades de bebês "totais" (por jovens que sejam) que experienciam relacionamentos objetivos de qualidade oral e aquelas de bebês situados no início teórico, que estão emergindo de um estado caracterizado pela identificação primária, por haverem experimentado a maternagem. Por causa disso, ele jogou fora o seu valioso estudo da dependência na primeira infância. Em qualquer debate do desenvolvimento emocional do bebê não se deve primeiro decidir se a criança realmente tornou-se ou não (por ser tratada como uma pessoa por seu próprio direito, com necessidades e tensões individuais) um ser separado com respeito a esta questão da identificação primária?

Fairbairn encontra-se quase na posição de um daqueles que fazem psicoterapia inteiramente fora do grupamento psicanalítico. O seu trabalho está sujeito a perder-se por não achar-se integrado ao corpo geral da teoria em desenvolvimento. Isto, se for verdade, enfraquece a sua posição quando argumenta que o seu corpo teórico suplantou o de Freud, pelo menos em certos aspectos importantes. Embora partilhando de muitas das insatisfações de Fairbairn, e ainda que se possa derivar idéias valiosas das suas sugestões, fica-se apesar disso, ao final, com a impressão de que as idéias em

desenvolvimento de Freud forneceram e ainda fornecem um campo mais fértil que a teoria desenvolvida de Fairbairn.

Chama-se particularmente a atenção para três detalhes:

1. A seção sobre identificação emocional (pág. 275), em que a ansiedade de separação é correlacionada à identificação: "Tão íntima é a conexão existente entre identificação e dependência infantil que, psicologicamente falando, elas podem ser tratadas como sendo o mesmo fenômeno".

2. A "reabilitação" (pág. 292), em oposição ao "tratamento" de certos casos de neurose de guerra e de pervertidos sexuais, idéia que pode ser comparada com a sugestão que foi feita de que um estudo do aspecto de administração do procedimento psicanalítico no tratamento de estados agudos de regressão (preparatório para a interpretação correta dos derivados instintuais e fantasias inconscientes na neurose de transferência) proporciona uma linha proveitosa de pesquisa para a ampliação do uso das técnicas terapêuticas psicanalíticas.

3. A classificação de dois tipos de onipotência (pág. 213), um deles "representado na onipotência da mania e da esquizofrenia, enquanto que o segundo tipo parece característico dos estados obsessivos e paranóides". É como se no primeiro houvesse uma regressão e, no último o paciente fizesse avançar a onipotência inicial e a colocasse em ação como técnica defensiva sob o controle do ego. Isto ainda deixa espaço para um terceiro uso da onipotência, talvez o normal, onde ela reforça as atividades sublimatórias rotineiras, investindo-as assim com um potencial ilusional que é tanto enriquecedor quanto gratificador do ego.

Trata-se de um livro muito valioso e, em verdade, estimulante, fornecendo os frutos do trabalho de uma vida de um colega; como tal, será amplamente lido e não pode deixar de constituir um estímulo a novas reflexões.

51

John Bowlby

I. Resenha de *Maternal Care and Mental Health*¹

1953

Na ocasião em que esta resenha for impressa, este livro já terá sido amplamente lido e com justiça elogiado em quase toda parte. Desejo associar-me a essa apreciação do livro e do trabalho que ele representa, bem como da tendência específica do Dr. Bowlby, que o faz dirigir-se no sentido de uma tradução das descobertas psicanalíticas do último meio-século para a ação social. Quero oferecer críticas, mas sem deixar de admirar e apoiar.

O livro é dividido em duas partes. Na primeira descrevem-se os efeitos adversos da privação materna, e é aqui que se pode procurar a contribuição especial de Bowlby. Acha-se ele convencido de que esforços têm de ser feitos no sentido de apresentar as questões psicológicas sob forma estatística, de maneira a que aqueles que se acham acostumados a artigos científicos (da espécie que é apreciada por cientistas em todos os tipos de trabalho) possam avaliar as reivindicações daqueles de nós que têm a mente clínica e desprezam ligeiramente as cifras. Tal como em sua monografia anterior, *Forty-four Juvenile Thieves: Their Characters and Home-life*, também aqui Bowlby justifica a sua tese, pelo menos com respeito ao assunto em debate, e reuniu os relatórios de trabalhos que foram feitos nos variados países que visitou e que puderam ser colocados sob forma estatística. Ele seria o primeiro a admitir que estatísticas não têm valor, a menos que sejam baseados em dados que estejam acima de qualquer censura, e, em verdade, são exatamente estes dados que são difíceis de reunir na nossa especialidade. Poder-se-ia imaginar que em quase todos os outros tipos de transtorno psicológico não seria encontrada concordância suficiente sobre qualquer enunciado simples dos fenômenos observados para funcionar o método estatístico. Neste tema particular de privação materna e seus resultados, há certas simplificações justificáveis, mas os clínicos ficarão todo o tempo preocupados de que Bowlby tenha supersimplificado o assunto, a fim de demonstrar um ponto específico através de estatísticas. Provavelmente haveria concordância geral quanto a um enunciado tal qual o de que, *para o fim de investigação estatística*, simplificações têm de ser feitas, mas isso não faz mal, desde que haja um retorno do simplificado para o complexo, antes da construção de novas teorias.

1. Geneva: W. H. O., 1951; também H. M. Stationery Office. Esta resenha apareceu no *British Journal of Medical Psychology* (1953):

Seria possível exagerar o tema da privação. A fim de manter simples a questão, Bowlby teve de deixar de fora toda a consideração dos *recursos* que as *crianças normais* têm à sua disposição e em virtude dos quais elas não se tornam crianças carentes quando se acham inevitavelmente afastadas dos pais, desde que *não por muito tempo*. Provavelmente, algumas crianças são mais feridas pelo fato de que o ursinho de pelúcia com quem vão para a cama não pode ser levado para o hospital com eles, ou então pelo fato de o ursinho ser levado e lá misturado com todos os outros brinquedos, ou esterilizado, ou destruído, do que pela perda temporária do genitor real. Não existe nada no que Bowlby escreve que contradiga uma idéia como esta, mas acho ser necessário que nos recordemos de que a natureza humana é complexa demais para ser avaliada pelo método estatístico; pode-se lidar desta maneira com certos tipos de *doença*, particularmente moléstias que são bastante estereotipadas.

Na segunda parte, em que a prevenção da privação materna é debatida, Bowlby estende-se amplamente sobre o assunto, fornecendo-nos o benefício de sua experiência, enriquecida pelo estudo que faz da literatura técnica a respeito. Ele é generoso em suas citações. Toda a apresentação mostra quanto tempo e reflexão dedicou ao assunto; esta parte tem valor prático e será apreciada pelo amplo público do mundo. Encontramo-nos quase sempre em concordância com as opiniões expressadas e eu isolaria de modo especial a afirmação de que "é no interesse da saúde mental do bebê adotado que ele seja adotado logo após o nascimento". Na prática, tornou-se cada vez mais difícil fazer isto. Também certamente é sensato que um bebê que vai ser entregue pela mãe não receba o seio primeiro, e que ele seja entregue à técnica dos pais adotivos desde o primeiro momento possível. A idéia de que o que acontece durante algumas semanas após o nascimento não faz diferença para a psique é algo que teremos de abandonar, e quanto mais cedo, melhor.

Gostaria de fazer uma só crítica; ela deve permanecer sendo uma opinião pessoal e pode ser que outros leitores não concordem com ela. Acho um dos capítulos, o que versa sobre problemas teóricos, muito insatisfatório, e parece-me que poderia ter sido deixado inteiramente de fora. Possivelmente foi inserido em um estágio posterior, de maneira que o autor pode estar pretendendo, reescrevê-lo. Pediria particularmente a ele que reconsiderasse a frase em que diz que "a maquinaria psíquica que desenvolvemos dentro de nós para harmonizar as nossas necessidades diferentes e até mesmo conflitantes, e buscar a satisfação dela em um mundo realisticamente apreendido, é o *nosso ego* (o grifo é meu)". Sugiro que o enunciado de que alguma maquinaria psíquica "é o ego" só pode resultar em confusão nas mentes daqueles que são novos à psicologia, especialmente por ser a palavra "ego" utilizada de modo variado por diversos grupos de pessoas. O inverso ter-me-ia parecido mais satisfatório, ou seja, que os psicanalistas chamam de ego essa maquinaria psíquica, enquanto que outros têm a liberdade de chamá-la por algum outro nome.

À parte essa frase canhestra, há nesse capítulo teórico, em minha opinião, uma pobreza de tratamento que é decepcionante. Os enunciados teóricos, nos outros capítulos, são muito mais satisfatórios, embora mais popularmente formulados. Se tiver de haver um capítulo teórico, é esse então o lugar onde se deve indicar existirem fatores internos muito complexos, com os quais não se pode lidar num livro como este de maneira alguma. Em certo ponto, Bowlby tenta ser positivo: "Elas [crianças gravemente carentes] são personalidades ineficazes, incapazes de aprender com a experiência e, conseqüentemente, seus próprios piores inimigos. O problema teórico é entender como a privação produz este resultado. As duas abordagens principais à solução do problema são as descobertas de Goldfarb com referência ao dano do pensamento abstrato nesses pacientes, e os achados clínicos relativos à incapacidade que têm estas crianças de se identificar ou introjetar. Cada uma das abordagens nos conduz até uma certa distância, mas ainda não chegou o dia em que levem a um corpo unificado de teoria".

Duvido muito que as descobertas de Goldfard a respeito do pensar abstrato nos levem muito longe. De fato, seria perigoso espalhar por aí a idéia de que as crianças que têm uma boa capacidade de pensamento abstrato ficam por isso capacitadas a não roubar. Pode-se muito bem perceber que, na totalidade do "complexo de carente", pode-se encontrar um certo dano específico da capacidade de pensamento abstrato. Os diversos fenômenos possuem uma causa comum. O que é de se temer é que leitores novos do assunto pensem que a criança anti-social pode ser em grande parte explicada pela presença de uma dificuldade em pensar. Na realidade, o problema tem muitíssimo a ver com o afeto, com a culpa inconsciente e com coisas tais como medo da loucura e medo da perda de identidade e de contato com a realidade externa. Se o autor realmente sustenta o que escreveu neste capítulo, tenho então de expressar minha discordância quanto a ele, mas acho que, ou eu abordei o assunto do lado errado ou ele então escorregou neste capítulo, que reescreverá na nova edição que já se deve revelar necessária.

Ao ler este livro, tem-se de ter o seu intuito constantemente em mente, e, exceto no capítulo referido, parece-me que Bowlby manteve sua platéia à sua frente. Por causa disto, presumivelmente, embora tenha mencionado a psicanálise, não citou Freud em sua bibliografia. O inconsciente não é ignorado, mas não é trazido para o primeiro plano. Isto é compreensível, mas não constitui um fato que foi a análise detalhada no dia-a-dia de adultos e crianças, juntamente com o desenvolvimento gradual da teoria psicanalítica, aquilo que tornou o trabalho do Dr. Bowlby possível e oportuno?

Existe hoje um filme, da autoria de Dr. Bowlby e sua equipe, que ilustra de modo excelente fatos contristadores a respeito de uma criança que se torna carente, embora, felizmente, seja capaz de recuperar-se². Todos os que trabalharam em uma enfermaria infantil de hospital tiveram oportunidade de assistir ao que este filme sucintamente descreve e de assisti-lo repetidas vezes. Nunca pude entender por que tão poucas pessoas vêem essa coisa por si próprias, até que me dei conta de que, se o fizessem, achariam o trabalho de enfermaria penoso demais. O filme, usado de modo correto, poderia ter um efeito muito grande e não devemos esperar que a equipe dele jamais faça um melhor. O perigo é que, por forçar fatos a um público que não está disposto a sofrer, possam haver reações e contra-reações e um novo tipo de confusão. A prevenção disto repousa naqueles que estão a cargo da apresentação do filme.

2. *A Two-Year-Old Goes to Hospital*, feito com James e Joyce Robertson.

II. Debate de *Grief and Mourning in Infancy*³

1953

A

Acho muito difícil tomar parte neste debate e, no entanto, desejo fazê-lo. O Dr. Bowlby generosamente referiu-se a mim e a meus textos, e estudou também os textos de muitos analistas e etologistas. Do que tenho de queixar-me? O fato é que não acho que ele tenha entendido algumas coisas que considero importantes e tenho de tentar tornar claro o que quero dizer.

Quase preferiria que ele houvesse fornecido as suas próprias opiniões, independentemente das de outros autores. Isto nos reduz ao uso de nosso próprio julgamento a respeito de deprivações. De qualquer modo, não existe mal nisso, se então puder haver uma redescoberta genuína de velhos fatos ou antigas teorias. Algo de novo e valioso sempre surge quando coisas velhas são enunciadas de maneira nova. O Dr. Bowlby, contudo, parece estar ansioso por mostrar onde é que ele suplanta os escritores analíticos anteriores, e é aqui que o acho inconvincente. É uma pena, porque o Dr. Bowlby tem algumas coisas importantes a contribuir. Nunca me canso de enunciar e reenunciar o fato de que a sua propaganda em favor da evitação de rompimentos desnecessários no relacionamento mãe-bebê deu a volta ao mundo, embora ache também que o elemento de propaganda necessário conduziu a uma moda no cuidado infantil e às inevitáveis reações que seguem a propaganda e a conversão excessiva.

Mas quero também juntar-me ao Dr. Bowlby em um movimento no sentido de ampliar a base de ensino em análise infantil, uma vez que acredito nos achar em perigo causado pelo fato de passarmos por analistas de crianças treinados por homens e mulheres que (alguns deles) têm muito pouca experiência de crianças e de cuidado infantil.

Existe algo nesse caminho, contudo, e não sei ainda quão sério é o bloqueio. Com referência ao capítulo específico do livro de Bowlby que trata do luto, sinto-me muito pouco à vontade e desejo examinar as razões para esse meu mal-estar.

Permitam-me dizer primeiro que a idéia de tristeza não é uma idéia que fosse comumente mencionada na década de 20. A idéia me veio de Merrill Middlemore, que trabalhava comigo no começo dessa década. Ela olhou para o rosto de um menino que era meu paciente e disse: "Um caso de melancolia". Até então isso se referia a crianças que achavam a vida difícil, mas repentinamente, percebi que a palavra "depressão" estava à espera para ser usada na descrição dos estados clínicos de crianças e bebês, e rapidamente alterei toda a minha linguagem.

Na mesma época, estava começando a aprender com Melanie Klein a respeito dos mecanismos da depressão e das defesas contra a depressão. Ela já insistia nelas há dez anos ou mais e tornara-me possível trazer para minha teoria e meu trabalho

3. O artigo do Dr. Bowlby foi lido em um Encontro Científico da Sociedade Psicanalítica Britânica em outubro de 1959 e subsequenteemente publicado em *The Psycho-Analytic Study of the Child*, 15 (1960). Duas versões datilografadas da contribuição que Winnicott preparou para o debate foram encontradas entre seus papéis e, como diferem substancialmente, incluímos ambas aqui. A primeira acha-se assinalada no alto com as palavras "Somente extratos lidos, na realidade", e a segunda com "Mais ou menos como pronunciada. D. W. W." — Os Organizadores.

analítico as observações que fizera em muitas centenas de crianças cujos distúrbios psicológicos começavam nas primeiras semanas, até mesmo dias, de suas vidas, e que eram casos psiquiátricos em pleno andamento, antes da época em que o complexo edipiano desses dias se achasse maduro.

Ora, foi nesses primeiros dias de meu trabalho com Melanie Klein que vim a saber a respeito dos estágios de luto, de protesto, e da negação do luto e da depressão que se solidifica na defesa maníaca. Nunca fui um grande leitor, embora houvesse lido *The Psycho-Analysis of Children*, de Melanie Klein, por inteiro duas vezes (em Dartmoor) assim que saiu em inglês. O que sei é que Bowlby não é a primeira pessoa a descobrir a transformação gradual do pesar em indiferença endurecida.

Minhas diferenças com Melanie Klein têm a ver com a minha impressão de que, quando ela nos está falando a respeito dos mecanismos iniciais, ela o fez em termos que nos fazem pensar que está falando a propósito de bebês reais. Mas Bowlby me faz acorrer em apoio dela, mesmo que não precise de mim ou não me queira.

Sinto-me exatamente do mesmo modo a respeito de Anna Freud, cujo trabalho vim a conhecer muito mais tarde do que conheci o de Melanie Klein. Realmente não me importa muito o que Anna Freud e Dorothy Burlingham escreveram, pois é um milagre que o tenham escrito. O importante foi o trabalho que fizeram, sob condições que exigiam coragem pessoal de alta ordem. Lembro-me das condições que exigiam coragem pessoal de alta ordem. Lembro-me das condições que prevaleciam em Londres no segundo ano da guerra e do abrigo antiaéreo na Enfermaria de Guerra de Crianças, que tinha de prestar contas aos Ministérios.

Tal trabalho não foi feito para que um livro pudesse um dia ser escrito e denominado *Young Children in Wartime: A Year's Work in a Residential War Nursery*. Foi feito porque a Senhorita Freud sabia que bebês separados das mães em uma idade inicial eram incapazes de alcançar algo tão normal quanto o luto, e que algo tinha de ser feito. Enviei-lhe o primeiro caso e fiquei contente por ter algum lugar aonde mandar a criança!

Talvez se possa perceber disto tudo que emoções foram despertadas em mim pela tentativa obviamente genuína de Bowlby de ser justo com todos.

O que podemos esperar obter de Bowlby é a idéia de que os bebês humanos, tal como os animais, podem de início ser muito simplesmente afetados por alguma condição ambiental, de maneira que sorriem sem primeiro experienciar o humor que nós (por projeção) achamos que devem estar sentindo, já que sorriem. Esta é uma ampliação da idéia de que um sorriso de bebê pode ser evocado por um toque no rosto ou pelo vento. Quero dizer que tentei arduamente utilizar estas idéias em meu trabalho analítico e não consegui ver como elas o afetam, mesmo quando se trata de adultos regredidos à dependência infantil (que encaro como sendo o melhor material para observações a respeito dos fenômenos da primeira infância e do cuidado de bebês).

Corro o risco de um dia pensarem em mim como um velho "caturra" e digo achar que, para o analista, a contribuição da etologia é *um beco sem saída*. Gosto da etologia por causa do que ela nos diz a respeito dos animais, mas considero que Bowlby falhou de modo assinalado em demonstrar como ele aplica suas opiniões dos reflexos infantis iniciais à área de desenvolvimento pelo filme *A Two-Year-Old Goes to Hospital*. À época em que um bebê está com um ano de idade, já sabemos realmente um bocado de coisas sobre ele, e a complexidade dos dois anos é tremenda, se recordarmos toda a elaboração da fantasia inconsciente e do conflito inconsciente. Considero que quem quer que pretenda acrescentar algo ao que já sabemos das reações de uma criança de dois anos à perda do objeto, deve primeiro demonstrar que sabe o que é fazer a análise de uma criança dessa idade, ou da criança de dois anos que existe em qualquer paciente, de qualquer idade.

De modo mais específico, acho que Bowlby omitiu fazer referências à mudança que se dá do relacionamento com um objeto *subjetivo* para o relacionamento com um objeto que é *objetivamente percebido*. Isto é especialmente pertinente ao período que segue o fim do primeiro meio-ano e (com variações tremendas de criança para criança) torna-se algo bastante complexo aos dois ou três anos de idade. Este processo de desilusão pertence à saúde e não é possível referir-se à perda de objeto por uma criança sem fazer referências ao estágio de desilusão, e aos fatores positivos ou negativos nos estágios iniciais deste processo, que dependem da capacidade que a mãe tenha de fornecer ao bebê a ilusão sem a qual a desilusão não faz sentido.

Tudo isto é jogado de lado pela implicação de Bowlby de que há um fenômeno de perda objetal muito simples, bastante semelhante ao da falha de um reflexo por causa de ausência do estímulo.

A questão que Bowlby está examinando é tão mais rica do que ele parece sugerir, que temo que possamos perder de vista tudo aquilo que a reação à perda pode significar por nos engajarmos em alguma controvérsia a respeito de corvos ou patinhos.

B

Uma de minhas dificuldades é o Dr. Bowlby dizer que sua tese é que "perda da figura materna no período que vai de por volta dos seis meses até três, quatro ou mais anos de idade é um acontecimento de alto potencial patógeno *por causa dos processos de luto a que habitualmente dá origem* e que, nesta idade, muito prontamente tomam um curso patológico".

Consideraria ele dizer isso em outras palavras?

A perda da figura materna certamente não é patógena por causa dos processos de luto, pois isso deixaria de fora todo o conceito do luto como uma realização. Viemos a pensar em uma longa série de delicados mecanismos, ao final dos quais o bebê chega à capacidade de sentir luto. Quando as coisas saem erradas, pensamos em termos de uma perda da capacidade de sentir luto, a perda de algo que foi alcançado no desenvolvimento emocional do indivíduo. Foi muito especificamente em resultado do trabalho de Melanie Klein que temos muito a dizer a respeito da patologia de crianças pequenas e pessoas mais velhas cuja capacidade de sentir pesar foi super-retesada. O ensinamento de Melanie Klein intitulado "A Defesa Maníaca" impressionou-me tanto por sua importância que escrevi meu trabalho para tornar-me membro da Sociedade⁴ sobre este assunto e, tal como o entendo, a expressão "defesa maníaca" abrange todos os processos de negação do luto, o qual, apesar disso, é mantido como depressão teórica. Eu próprio tentei participar do desenvolvimento do conceito ulterior do efeito mais profundo da perda de objeto ou descuido de apoio do ego. Enunciei isto em termos das condições emocionais primitivas e utilizei os termos "perda de contato com a realidade externa", "perda do relacionamento entre psique e soma" e "desintegração". Em meu trabalho sobre estes assuntos posso ter-me valido intensamente do trabalho de outros. Na linguagem que uso, ao descrever o desenvolvimento emocional de bebês nos estágios antes e durante o estabelecimento gradual de sua capacidade de sentir luto, não consigo encontrar lugar para essas palavras de Bowlby, que ele na realidade sublinha: *por causa dos processos de luto a que [a perda da figura materna] habitualmente dá origem*. O luto implica amadurecimento emocional e

4. 1935; *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London: Hogarth Press, 1975), Cap. 11.

saúde. Parecer-me-ia, portanto, que Bowlby não foi cuidadoso no enunciado de sua tese central, da qual depende a totalidade do resto de seu artigo.

Gostaria de escolher um ou dois outros pontos para comentário. Um tem a ver com a avaliação que Bowlby faz da teoria de Melanie Klein, naquilo que ela chama de "posição depressiva". Parece ele implicar que Melanie Klein está-se referindo ao relacionamento do bebê com um objeto parcial. Ora, isto me parece uma concepção completamente equivocada de toda a teoria. Em primeiro lugar, o objeto parcial é um objeto total do ponto de vista do bebê, exceto até onde este se ache cindido ou desintegrado. Todo o sentido da posição depressiva é, acredito eu, a reunião gradual, na mente do bebê, do objeto limitado do desejo instintual e o objeto total da personalidade total da figura materna. O relacionamento do bebê com o objeto parcial é, muito definidamente, apenas uma parte da história. Foi por esta razão que alguns de nós tentaram com que Melanie Klein não datasse a sua posição depressiva cedo demais, porque ela tem a conotação de um estado de coisas altamente sofisticado, isto é, um reconhecimento pleno da mãe como ser humano e a vinculação a isto da idéia do seio como parte dela. A propósito, não parece haver razão para que a palavra "seio" não seja usada, quando estamos falando deste modo, para representar qualquer tipo de continente, ou parte da mãe, com que o bebê se torne familiarizado. No trabalho da Sra. Klein existem menções freqüentes ao ataque do bebê ao corpo. Esta é a fantasia do bebê, mas estamos usando as nossas palavras, e podemos dizer "corpo", ou "seio", ou o que quisermos. Examinando a infância através da infância mais tardia, como fazemos na psicanálise, chegamos à idéia de um seio que é um corpo, e um útero e uma vagina e uma bexiga e uma cabeça e um músculo bíceps. A questão principal não é afetada por estas palavras que utilizamos.

De modo sucinto, gostaria de mencionar um ou dois outros pontos. Um é que Bowlby pareceu não deixar, em seu enunciado, espaço para o simbolismo e para o estabelecimento (na saúde) de objetos que representem tanto o *self* quanto a mãe. Ele naturalmente sabe que o trauma que é sofrido quando uma criança é separada da mãe com freqüência não é a perda desta última, mas sim a perda da coisa que chamo de objeto transicional. Ele sabe também que, se a mãe é perdida por tempo demasiado, o objeto transicional começa a perder valor como símbolo. Estas coisas acham-se diretamente no próprio centro do assunto de uma reação à perda da mãe, e são muito mais importantes para nós que o estudo dos animais, mesmo daqueles animais que empregam objetos transitacionais.

Parece-me que o Dr. Bowlby está falando como se não existisse uma coisa chamada fantasia na primeiríssima infância. Os psicanalistas ficam constantemente surpresos, contudo, em descobrir quanta fantasia existe em uma data inicial. O conflito inconsciente não parece encontrar lugar na psicologia de Bowlby e ele parece não nos conceder espaço para o conceito do objeto que morre e revive dentro do bebê, isto é, no aparelho psíquico, que é alojado pela criança sadia no corpo em funcionamento. Em consequência destas omissões, não parece existir lugar, na psicologia de Bowlby, para uma descrição daqueles bebês que, por causa de um manejo grosseiro e equivocado nos primeiríssimos estágios, não se aproximam de algo tão sadio quanto a capacidade de sentir luto e, talvez, nem mesmo se tornem integradas em qualquer estágio.

Outro ponto ainda. Durante o período a que Bowlby faz referência especial, seis meses a três ou quatro anos, a criança se encontra no processo de mudança de um objeto subjetivo para outro que é objetivamente percebido. Bowlby achar-se-ia em terreno muito mais firme se visse ser especialmente importante para o bebê que mudanças externas não sejam efetuadas enquanto este processo de objetificação, ou seja o que for que decidamos chamá-lo, está se realizando. Isto seria argumentar ao longo das linhas com que estamos familiarizados dentro da Sociedade e estabeleceria uma vinculação com o conceito do estabelecimento do princípio da realidade.

Desejo chamar a atenção para o fato de que, em minha opinião, seria errado deduzir disto que o objeto subjetivo pode ser perdido com impunidade. Trata-se de um assunto muito complexo e que não pode ser enunciado em poucas palavras. Pareceria que o objeto subjetivo dos primeiros meses possa ter mudado aos olhos do que observa, e, contudo, possivelmente, não ter mudado para o bebê. Exemplificando, uma mamadeira pode ser trocada por outra; até mesmo uma mamadeira pode substituir o seio. Existe muita coisa mais que permanece semelhante. É a mesma pessoa quem está alimentando o bebê ou, então, há uma mudança de pessoas, mas as técnicas sobrepõem-se parcialmente de modo suficiente. Apesar desta flexibilidade que pertence aos relacionamentos objetais nos primeiros meses em que o objeto é subjetivo, penso que a perda do objeto subjetivo é uma catástrofe de vulto, algo pertencente à ordem de coisas que são descritas pelas expressões "ansiedade psicótica", ou a "falha básica" da nomenclatura de Balint, ou uma falha do apoio do ego na ocasião em que o ego do bebê só tem força por causa do apoio confiável que lhe vem da figura materna, etc. Esta é a área em que nos descobrimos debatendo a origem da psicose infantil e a origem da tendência ao transtorno psicótico, que pode apresentar-se em qualquer idade da vida do indivíduo.

Michael Balint

I. Tipos de Caráter: O Temerário e o Cauteloso¹

Datado de 25 de outubro de 1954

Com freqüência é útil examinar as qualidades mistas dos normais comparando-as com as qualidades opostas que podem ser encontradas entre os enfermos. Balint sugeriu que há importância em contrastar dois tipos extremos de padrão de comportamento no estudo da mistura de dependência e independência nos sadios. Ele aplicou nomes a esses tipos, mas como não acho que sejam necessários, omito-os aqui².

Existem aqueles que buscam e encontram prazer em emoções, que se soltam, e que, no ato da participação emocionante, desconhecem o perigo. Há também aqueles que gostam de ter algo a que segurar-se e que se aferram a quase tudo quando lhes é apresentado uma situação emocionante, sabendo que é perigosa mesmo quando, de fato, não o é.

Balint chama utilmente a atenção para a maneira pela qual o problema destes tipos contrastantes se vincula com o da regressão.

Poder-se-ia dizer que o temerário amante das emoções efetua uma regressão no sentido do estado do narcisismo primário; lá se acha ele, ou ela, artificialmente colocado em uma situação que faz parte dele ou dela — como se uma caricatura estivesse sendo feita do estado inicial em que o indivíduo só conhece o meio ambiente como fazendo parte do *self* e ainda não repudiou o NÃO-EU. Nós, como observadores, percebemos os perigos, mas o indivíduo interessado está cego. Esta cegueira pode achar-se oculta no desenvolvimento da habilidade pessoal ou escondida na confiança na habilidade técnica de outras pessoas, constituindo isto uma forma sutil de aferrar-se a eles.

No segundo tipo de padrão de comportamento, onde o aferrar-se a um objeto é a característica principal e o perigo é presumido, existe talvez uma fuga para a frente

1. Em 20 de outubro de 1954, o Dr. Balint leu perante uma Reunião Científica da Sociedade Psicanalítica Britânica um artigo intitulado *Funfairs, Thrills and Regressions*, que posteriormente se tornou parte do material de seu livro *Thrills and Regressions* (London: Hogarth Press, 1959). Winnicott achava-se presente à reunião e parece ter escrito estes comentários alguns dias mais tarde, após refletir sobre o que havia sido dito. — Os Organizadores.
2. Uma descrição completa destes tipos de caráter aparece em *Thrills and Regressions*; ver também Balint, *A Falha Básica* (Porto Alegre, Artes Médicas, 1993; London: Tavistock 1968). — Os Organizadores.

(ao invés de para trás), no sentido de um relacionamento com objetos que, no desenvolvimento do indivíduo, ainda não se tornaram apropriadamente externos, repudiados, NÃO-EU.

Não nos surpreenderá que exista um estado a meio caminho entre os dois extremos, ao qual cada um destes acha-se relacionado e do qual ambos constituem fuga. Sugiro que central a estas duas organizações defensivas acha-se o estabelecimento pessoal do estado que é melhor descrito através da palavra SOU. Este estado de SOU, quando se transforma num fato, imediatamente desenvolve-se em SER ou CONTINUANDO A SER, [*going on being*], isto é, um fator temporal nele se torna incluído.

Se estas organizações defensivas aparecem em relação ao estabelecimento do estado de SOU, é necessário examiná-lo e ver qual a ansiedade que é pertinente a esse estado. Na saúde, o cuidado materno que traduz o amor para os variados termos físicos e efetua uma adaptação suficientemente boa às necessidades variantes faz o bebê atravessar os primeiros momentos do SOU e as experiências iniciais de SER, permitindo que o senso de existência se torne estabelecido. Um cuidado materno que seja insatisfatório apresenta-se na ansiedade potencial ao estado de SOU. SER implica uma atitude para com aquilo que é NÃO-EU. Poder-se-ia dizer que o momento de SOU é imediatamente seguido por uma expectativa de invasão ou intrusão [*impingement*] que produz reação, ou, em outras palavras, de uma destruição do estado de SOU. Essenciais ao estado de SOU são os processos inatos do indivíduo e a continuidade desses processos no tempo, e a reação à invasão ou choque rompe a continuidade do ser. Um fracasso ambiental no momento crítico traz ameaça de desintegração, e um novo padrão defensivo situa-se ao longo da linha de reação à invasão ou choque, o qual é base da personalidade paranóide. (A perseguição real, repetida, constitui parte essencial desta defesa inconfortável.)

Estas questões mostram-se obscuras na observação direta de bebês, mas tornam-se intensamente importantes nas regressões e progressões controladas que aparecem na prática analítica.

Aqueles bebês que têm sorte no manejo que lhes é dado no começo parecem vir a EXISTIR e a sentir-se reais de modo quase automático. Quando um indivíduo não tem sorte e é manejado mal no início (mãe deprimida, ansiosa, enferma, etc.), também está fadado a organizar um certo grau de padrão defensivo de comportamento, que envolve uma regressão a uma caricatura da identificação primária ou um distender-se para a frente no sentido de um relacionamento com objetos externos. Desta maneira, eu, pessoalmente, acho construtiva a idéia de Balint.

O estado de SOU ganha novo significado à medida que o bebê se desenvolve, e acha-se sempre sob ameaça, exceto na medida em que a adaptação ambiental é satisfatória ou se torna, como gradualmente acontece, uma matéria que a própria criança pode produzir ou parcialmente fornecer. Os problemas da adolescência podem com freqüência serem vistos como sendo uma variação nova a este tema básico do SER, que recebe uma nova ameaça por causa das pulsões biológicas que rompem a dependência no lar. Na puberdade, então, encontra-se naturalmente, mesmo entre aqueles que virão a ser adultos sadios, uma separação entre aqueles rapazes e moças que buscam a emoção e aqueles que se cuidam. Na saúde, porém, tem de ser sempre verdade que nenhum dos extremos seja dominante, e, para aqueles que tiverem muita sorte no começo, a questão do SOU não apresenta dificuldades. Mas é necessário apontar que o estado de SOU, o estado de SER e o sentimento de realidade em existir não constituem um fim em si, mas uma posição a partir da qual a vida pode ser vivida.

Acabamos por descobrir que o mundo contém os três grupamentos: aqueles para quem a questão da EXISTÊNCIA não é uma dificuldade; aqueles para quem existe esperança de sentirem-se reais e que sabem não mais que esse sentimento chega em raros momentos, tal como quando uma bomba está caindo, e aqueles situados no meio

que são apanhados em uma luta de vida inteira no estabelecimento da existência pessoal, que alcançam na companhia de outros que combatem a mesma luta, e sob a influência integradora de uma filosofia.

Retornando à primeira infância, pode-se logo ver que estes mesmos problemas aparecem e reaparecem em todos os variados *settings* com que estamos familiarizados. Os bebês que passarem por uma provação podem sucumbir a uma provação ulterior, mas é claro que, na medida em que a provação inicial é vencida, a criança acha-se em bom estado para lidar com o mau manejo em estágios posteriores. Infeliz ou felizmente, permanece sendo verdade que, no estágio mais inicial, aquele do momento do primeiro SOU, a dependência do meio ambiente é absoluta. Não é de espantar que, na história da religião, encontremos este estágio de desenvolvimento pessoal entregue a Deus!

Muito cedo na história de qualquer bebê encontramos este mesmo problema de dependência-independência retratado no ato de sugar o polegar (ou equivalente). No crescimento natural, há um longo período em que o bebê não precisa lidar com o aspecto EU ou NÃO-EU do polegar. O bebê aferra-se ao polegar e também encontra prazer na separação quanto a ele. Ou o bebê, através do polegar, aferra-se à boca e desfruta da separação da boca, e assim por diante. Com o decurso do tempo, descobre-se que o polegar faz parte do *self* e, por essa época, uma nova capacidade se desenvolveu, o uso da fantasia. O polegar representa um objeto externo ou NÃO-EU, é simbólico dele, como diríamos. Achando-se o objeto externo suficientemente acessível, o polegar pode ser usado como seu substituto. Permite-se que esta transição, ela própria, efetue-se de maneira lenta e gradual, seguindo o próprio tempo do bebê. Objetos transicionais são fornecidos ou adotados, os quais (quando o bebê está des-cansando do árduo processo de classificar o mundo e o *self*) são aconchegados ou empurrados para longe, sem serem classificados como símbolos do polegar ou do seio. Na saúde, então (que pretende implicar um manejo sadio), existe amplo tempo para o desenvolvimento natural.

Onde, através do manejo equivocado, interfere-se com os processos naturais, o bebê desenvolve defesas, de acordo com a aparelhagem herdada de estágios anteriores. Exemplo de manejo grosseiramente equivocado é o impedimento de sugar o polegar. O bebê cujo sugar o polegar é impedido (presumindo-se um manejo satisfatório anterior, de maneira que momentos de SOU já constituíram um fato) pode organizar padrões defensivos de conduta ao longo das linhas sugeridas por Balint: denegação da necessidade de relacionamento e concessão de ênfase excessiva a relacionamentos com objetos mais claramente externos. Sugiro que a alternância das duas defesas pode ser facilmente observada na clínica.

As mesmas defesas alternativas podem reaparecer ou serem produzidas em todos os outros estágios. Exemplificando, o apegar-se às fezes pode alternar-se com a incontinência ou um caminhar e trepar muito precoce, bem como os rudimentos da "gazeta" (dependência da técnica pessoal), alternam-se com uma dependência extrema do cuidado (dependência da técnica dos que se acham encarregados do bebê).

No estado muito mais complexo da posição depressiva (Klein), em que a criança possui um mundo pessoal interno pelo qual é responsável, no qual a interação de forças rudes dá origem a humores de esperança e desespero, identifica-se uma organização defensiva (chamada de defesa maníaca), na qual o acento recai sobre a denegação da depressão. A defesa permite que se tire férias do desespero. Rycroft³ sugeriu que o estudo da defesa maníaca pode ser enriquecido pelos dois extremos de padrão de comportamento de que Balint fala. Segundo essa sugestão, da qualidade da defesa

3. O Dr. Charles Rycroft tomou parte do debate do artigo de Balint, em 20 de outubro de 1954.
— Os Organizadores.

maníaca e, talvez, de uma tendência à adoção dessa defesa, podem derivar elementos desde as primeiras e muito iniciais organizações defensivas que se originam na ameaça ao estado SOU ou à integração. A tendência à oscilação maníaco-depressiva certamente se assemelha à alternância da denegação da dependência e da dependência exagerada (aferrar-se) de objetos NÃO-EU. As alternativas de Balint neste caso tanto evitam as ansiedades pertencentes ao estabelecimento do estado central de SOU quanto a "depressão" ou preocupação central, ou senso de responsabilidade, pertencente à posição depressiva. Pode-se tirar férias da responsabilidade. A oscilação maníaco-depressiva em si não concede oportunidade para férias, mas trata-se de uma alternância de dois estados igualmente inconfortáveis, sendo irreal a mania, e a depressão, intolerável.

Na questão dos relacionamentos interpessoais, como os que se dão entre pessoas totais, com o tema central do complexo edipiano e a criança tipicamente no círculo familiar, não fica claro se há ou não uma aplicação direta do tema de Balint. Neste estágio, estando a criança com 2-3-4 anos de idade, desenvolveram-se vastas e novas organizações defensivas — e novos tipos de ansiedade. As idéias de castração e de morte apareceram, o instinto tornou-se fálico e genital, e a fantasia agora permite que a criança brinque de papai e mamãe, sonhe com a relação sexual e identifique-se com cada um dos pais por sua vez, assim como tolera ficar fora por curtos períodos de tempo.

Apesar disso, os vestígios dos tipos contrastantes podem talvez serem vistos na fantasia e no brinquedo até mesmo dos mais normais. O equivalente neste estágio pode provavelmente ser encontrado nas alternativas de matar o genitor rival e de identificação com ele ou ela, no relacionamento triangular básico. (Omito intencionalmente intrusões grosseiras de conflitos e padrões de conduta irresolvidos, oriundos de estágios anteriores, neste estágio avançado do conflito edipiano propriamente dito.)

Na adolescência, há uma aplicação nova e especial da idéia de Balint, por causa das novas dificuldades de SOU, como já indiquei. Em consequência, as atividades do adolescente, que são transicionais entre o brinquedo e o trabalho, tendem a ser coloridas pelos fenômenos da independência e da dependência, da temeriedade e do aferrar-se, até mesmo nos sadios.

Na saúde, contudo, a temeriedade se oculta nas habilidades especiais e o aferrar-se se esconde no respeito bem-justificado pela habilidade e confiabilidade de outras pessoas, bem como pela tradição.

II. Resenha de *The Doctor, His Patient and the Illness*⁴

1958

Fico contente por fazer a resenha deste livro, não apenas por ele tratar de um assunto muito importante, mas também porque sinto que o autor expressa bem a sua personalidade neste tipo de trabalho. Este livro pode revelar-se pioneiro.

4. London: Pitman, 1957. Esta resenha apareceu no *International Journal of Psycho-Analysis* (1958). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.

Não é a respeito da psicanálise, mas interessa ao psicanalista em seu relacionamento com o público geral. Estamos acostumados à reação que a sociedade tem à idéia do inconsciente reprimido e da sexualidade infantil, mas não nos achamos inteiramente atentos a outro perigo, que é o de que se somos também bons aterradores. Oferecemos algo, mas parecemos também retirá-lo. Poderia acontecer que a psicanálise sobrevivesse à perseguição e, contudo, fosse destruída porque, sendo boa, ela reserva os seus benefícios para aqueles poucos indivíduos que acontece poderem conseguir fazer análise.

No trabalho descrito neste livro, Balint faz uma tentativa específica de ampliar o campo de ação da análise e assim fazer por utilizar o potencial que existe na clínica geral. Quatorze clínicos gerais formaram um grupo com Michael Balint e Enid Balint, sob os auspícios da Clínica Tavistock. Gradualmente, o grupo chegou a um enunciado do problema e talvez os primórdios de uma solução puderam ser discernidos. No que segue, tentarei mostrar algo do conteúdo deste livro e das razões porque sinto ser ele de importância para a psicanálise.

A clínica geral proporciona um bom veículo para a disseminação da psicoterapia ao longo de linhas psicanalíticas. Existem certas coisas na clínica geral que tornam o clínico especialmente apropriado para este trabalho. Estará claro que não é possível agir com base em que cada clínico tenha uma análise pessoal. Os médicos devem ser utilizados tal como são, e, se são capazes de ter uma vida social e, talvez, serem casados e terem famílias, e, ainda, podem conduzir a carga imensa de uma clínica geral, há probabilidades de que sejam maduros no sentido que é importante na efetivação da psicoterapia. Em verdade, concorda-se hoje de modo geral que grande parte do trabalho do clínico é psicoterapia, goste ele dela ou não.

Apona-se, contudo, que muitos médicos excelentes são potencialmente enfermos no sentido psiquiátrico, e eles são aconselhados a não abandonar o campo da medicina física, onde se sentem em casa.

A primeira formulação feita pelo grupo foi que o medicamento mais importante é o próprio médico. Tal como Balint aponta no prefácio, não há orientação nos livros didáticos quanto à dosagem em que o médico deva prescrever a si mesmo. Existe em verdade muito pouco na literatura sobre os "possíveis riscos deste tipo de medicação sobre as diversas condições alérgicas encontradas em pacientes individuais e que devem ser cuidadosamente observados, ou sobre os indesejáveis efeitos colaterais do medicamento". Pode-se dizer que o trabalho do grupo é uma tentativa de compilação de uma farmacopéia relativa ao médico, ele próprio, como remédio.

Existe uma coisa a respeito do clínico geral que o coloca em posição muito forte para fazer psicoterapia e que, em verdade, concede-lhe vantagem sobre o psicanalista, assim como sobre especialistas de todos os tipos: é a sua disponibilidade e a continuidade de sua clínica através de um certo número de anos. Por causa disto, não há necessidade de uma psicoterapia terminar, exceto na medida em que desenvolva uma intensidade que não possa ser mantida por mais do que um período limitado. O trabalho do grupo dos Balints fornece uma contribuição para o problema psicanalítico que diz respeito a certos pacientes cujas análises simplesmente não terminam ao final do período estabelecido. A maioria dos analistas tem a experiência de pacientes que, de fato, precisam reaparecer de tempos em tempos. Os analistas podem achar que algo saiu errado quando isto acontece, mas para o clínico geral, pareceria inteiramente natural que seus pacientes retornem de tempos em tempos, em momentos críticos ou simplesmente a fim de obter a tranquilização fornecida pela existência e saúde continuadas do médico. Toda a vizinhança sabe a respeito do clínico geral e da família dele, e é possível que a sua psicoterapia principal seja feita com pacientes que na realidade não vêm para vê-lo, mas usam de maneira positiva o fato de poderem vê-lo, se sentirem a necessidade disso.

Até agora, referi-me a generalizações. O trabalho dos Balint e do grupo é também mais específico, interessado, por exemplo, na psicoterapia que certos pacientes individuais parecem exigir. Um princípio que se tornou enunciado é descrito pela expressão "as ofertas do paciente e as reações do médico". Exemplos são fornecidos, tornando claro que quando o paciente vai ao médico ele ou ela oferecem-lhe algo, oferecem-lhe dores, ou ansiedades, ou variados grupamentos de sintomas. O paciente não pode predizer como o médico reagirá. A reação deste é "um fator contribuinte altamente importante nas vicissitudes da enfermidade em desenvolvimento". Segue-se um exame dos efeitos colaterais do médico como medicamento. Exemplificando, há o efeito de um exame físico, que alguns médicos acham que sempre tem de ser feito, e o efeito do médico que tem de tranquilizar e cujas próprias ansiedades, de uma maneira ou outra, dominam a cena.

Sob o título "conluio do anonimato", chama-se a atenção para um estado muito importante de coisas que é também bem-conhecido na assistência social. Às vezes acontece que muitos médicos acham-se envolvidos com um só paciente ou uma só família, e não se comunicam livremente uns com os outros. Não existe uma pessoa única assumindo responsabilidade central. Na assistência social, a expressão "estudo de caso" [*case work*] descreve o esforço por reunir todos os diferentes elementos e situar a responsabilidade central em um só assistente social. Observou-se a respeito da assistência social que podem haver muitas agências interessadas em um caso, de maneira que o problema central tende a ser dividido entre essas várias agências, e pode ou não existir uma maquinaria para a reintegração do caso. Este estado de coisas, ou ausência de "estudo de caso", é descrito no livro sob o título de "conluio do anonimato". É questionável se este termo realmente transmite o que o autor pretende transmitir. Eu sugeriria que o grupo está descrevendo a *disseminação dos agentes responsáveis* e mostrando como, em certos casos, esta disseminação tem como causa um transtorno psiquiátrico do paciente ou de uma das figuras centrais do drama social. Contudo, esta expressão alternativa falha em transmitir um pouco do que o autor quis dizer. Fornece-se uma descrição clara do efeito deste conluio de anonimato sobre a evolução do caso.

Outra questão com que se lida é a formação do clínico. Obviamente, se o clínico geral tem tempo, e há ensinamento disponível, ela é necessária. O grupo, na verdade, recebeu um pouquinho de instruções por parte de outros membros do pessoal da Clínica Tavistock. É importante entender, contudo, que a falta de conhecimentos teóricos confiáveis não constitui o problema principal, mas sim, que relaciona-se ao *uso do médico*, ou seja, a gama inteira do uso que o paciente pode fazer do médico, quer a doença seja na realidade principalmente física, quer principalmente psicogênica, quer essencialmente uma mistura de ambas.

O grupo começa a formular "a atmosfera psicológica especial da clínica geral". Há um debate de algumas das razões para o sucesso ou fracasso clínico, e também das indicações para a instituição de uma psicoterapia mais formal. Esta produz seus próprios problemas de início e cessação. Balint nunca perde de vista o fato de não ser apenas uma questão de psicoterapia especializada o que constitui a tarefa principal, mas que a psicoterapia passe, de maneira imperceptível, para a totalidade do trabalho do clínico geral, inclusive o seu manejo do caso quando o paciente se encontra fisicamente enfermo.

Balint dá ênfase ao que chama de "função apostólica" do médico. Esta expressão, que recebe proeminência considerável no livro, poderia ser enganadora. Balint explica o emprego dela da seguinte maneira: "Foi quase como se todo médico houvesse revelado conhecer o que era certo e o que era errado que os pacientes esperassem e suportassem, e, além disso, como se ele tivesse o dever sagrado de converter à sua fé todos os ignorantes e incrédulos entre os seus pacientes". Obviamente, tornou-se

muito importante para os clínicos gerais desse grupo serem apresentados à idéia de que *devem examinar os seus próprios motivos e, em verdade, as suas próprias personalidades*. Estes médicos têm algo com que lutar que é semelhante (mas não é o mesmo) à necessidade primária do analista, que é ser analisado. Se fosse possível aos clínicos que fazem este trabalho serem analisados, ainda assim eles precisariam empreender a tarefa especial que é examinada nos capítulos intitulados de "A Função Apostólica", ou seja, eles ainda precisariam começar desde o início, em uma tentativa de avaliar as premissas do trabalho do clínico médico. Poder-se-ia acrescentar que *não faria mal ao analista que ele, de tempos em tempos, reavaliasse as premissas de seu trabalho analítico*. Isso não é necessariamente uma questão de se alterar o que é feito. Quem quer que clinique como médico precisa ser capaz de olhar o que está sendo feito e interessar-se por sua própria atitude e ações, tal como se interessa pelos sintomas e pelas reações ao tratamento apresentadas pelo paciente. Balint evidentemente pensa que isto é muito importante e faz o comentário: "O estudo da função apostólica constitui talvez a maneira mais direta de estudar o efeito principal — o terapêutico — deste medicamento" (isto é, o médico).

A psicanálise certamente tem algo a aprender do estudo que o clínico geral faça de sua atitude e de sua prescrição de si próprio. (O inverso é também obviamente verdadeiro.) Balint alega que o que o psicanalista sabe a respeito da terapia do clínico geral acha-se na maior parte contido na literatura sobre a teoria e a prática da interpretação, especialmente a parte que se refere ao manejo da tendência que o paciente tem a "atuar". O clínico geral naturalmente é apanhado na atuação de seus pacientes e talvez seja verdade que, na maioria dos casos, ele pode lidar com os problemas imediatos que são pertinentes a um exemplo particular de atuação e omitir a análise do tema central. É interessante para o clínico, contudo, que ele possa entender qual é o tema inconsciente ou central, enquanto se vê apanhado na atuação situada na periferia.

O psicanalista dá-se mais conta do papel do clínico geral quando um paciente em análise com ele precisa de atenção por causa de asma, tonturas, ou uma impressão de morte iminente nas primeiras horas da manhã. Em outras palavras, os analistas ficam cientes do papel desempenhado pelo clínico geral no manejo geral do paciente que está fazendo uma análise. É possível que os analistas não se dêem conta tão bem do número tremendo de pacientes com quem os clínicos gerais lidam com sucesso, sem se acharem em análise de modo algum.

Melanie Klein: Sobre o Seu Conceito da Inveja

I. Resenha de *Envy and Gratitude*¹

1959

O recente livro da Sra. Klein chama a atenção para o conceito da inveja e estimula a consideração da origem dela na criança humana.

Pareceria apropriado utilizar este detalhe em um livro que contém muita coisa mais como uma escusa para uma declaração pessoal. É em verdade interessante tomar qualquer conceito, tal como o da inveja, e não apenas pensar sobre o seu significado na vida cotidiana, mas também tentar remontá-lo ao ponto de sua origem no bebê humano em desenvolvimento.

Neste livro, a Sra. Klein faz algumas declarações bastante definidas a respeito da inveja e, em minha opinião pessoal, inclui no que diz um certo grau de erro. Acho muito difícil apontar com exatidão o erro que acredito que ela está cometendo e, por esta razão, acho ser um importante exercício tentar formular uma opinião própria.

É valioso para o psicoterapeuta ser lembrado da importância da inveja, a qual, naturalmente, ele encontra em sua prática analítica assim como na vida. O emprego que Melanie Klein faz da palavra "inveja" é fácil de acompanhar, quando ela descreve os elementos destrutivos no relacionamento de um paciente com o analista, quando este último é sentido como satisfatório. Naturalmente, quando o analista está falhando em algum aspecto, pode-se esperar que o paciente fique com raiva, mas é necessário identificar as forças destrutivas que não pertencem à raiva reativa. Na saúde, estas forças destrutivas se alinham com aqueles impulsos que podem ser chamados de amorosos. Eu, pessoalmente acho-me completamente em desacordo com a Sra. Klein, contudo, quando ela leva o assunto de volta à própria primeira infância, tal como quando diz: "Considero que a inveja é uma expressão oral-sádica e anal-sádica de impulsos destrutivos, a operarem desde o início da vida, e que ela possui uma base constitucional" (prefácio).

Acho necessário distinguir a descrição de um bebê da descrição dos processos primitivos, tal como são vistos na análise de crianças e adultos. Enquanto estou escrevendo isto, uma paciente que recentemente começou comigo inicia uma sessão analítica com as seguintes palavras: "Afim! encontrei alguém que não preciso invejar. não invejo que você seja um bom analista. Posso querer matá-lo, mas não acho que

1. London: Tavistock, 1957. Esta resenha apareceu em *Case Conference* (janeiro de 1959).

tenha de destruir a coisa em você que o torna capaz de fazer a minha análise". Posteriormente, é natural, é provável que esta paciente me inveje, mas terá uma razão para isso. A inveja estará associada ao meu fracasso em manter-me disponível. Perto do início da análise, eu ainda não fui "encontrado" e fui capaz de acompanhar de perto as necessidades da paciente, de maneira que, se não existe inveja, eu posso fazer o tratamento dela. Deste detalhe pode-se ver como a inveja constitui um tema vitalmente importante a recorrer nos tratamentos, e, nas análises, ela pode ser estudada com pormenores e sua evolução pode ser seguida. A inveja aparece da mesma maneira no relacionamento do assistente social e seus clientes, e em todos os outros relacionamentos profissionais, e precisa ser entendida. Ela é uma daquelas coisas de que a pesquisa deve ser feita pelo analista e aplicada em trabalhos que sejam mais gerais.

Pareceria que a palavra "inveja" implica uma atitude, algo que é mantido no decorrer de um período de tempo. Nesta atitude do sujeito para com o objeto existe ainda, implícita na palavra "inveja", a percepção de uma propriedade do objeto, uma propriedade que não constitui uma projeção oriunda do sujeito, um fator ambiental, um fenômeno externo, algo que pertence inerentemente ao objeto. A inveja pode ser aqui comparada com a piedade; o objeto tem realmente em si algo bom ou algo mau, caso em que o sujeito fica envolvido, quer com a inveja, quer com a piedade. Para mim, a palavra "inveja" implica um alto grau de sofisticação, isto é, um grau de organização do ego no sujeito que não se acha presente no início da vida. Pode achar-se presente em questão de semanas ou meses, mas precisamos de um termo (tal como sadismo oral) para descrever o relacionamento do bebê com um objeto, relacionamento que é conduzido por uma pulsão instintiva e que data quase desde o começo. (No começo, tem-se de dar o desconto de um estágio, antes de se dizer que existe uma fusão de impulsos destrutivos e eróticos).

Melanie Klein vê a inveja em seu trabalho analítico e, neste livro, ingressa profundamente em sua importância. Faz sentido, ao referir-se a uma análise, trazer-se à baila a palavra "inveja". Em uma análise, mesmo quando o paciente se acha gravemente regredido ou dependente, há uma parte da personalidade que está cooperando com o analista, uma parte que é sofisticada e não-regredida. Desta maneira, o paciente pode trazer a si mesmo ao analista e pode mesmo ter um trabalho ou dirigir uma casa, embora seja gravemente regredido e dependente no lugar em que o trabalho analítico real está sendo feito. Mas Melanie Klein também leva este conceito de volta à primeiríssima infância.

É aqui que quero expressar uma opinião pessoal. Se eu aceitar como um fato que Melanie Klein está descrevendo algo que é verdadeiro em relação a nosso trabalho analítico e a outros trabalhos profissionais, resta-me uma objeção. Para mim, não existe descrição de bebê que deixe de fora o comportamento da pessoa que toma conta dele, ou, num relacionamento objetal, a conduta do objeto. Embora me possa ser muito valioso ver os mecanismos primitivos da natureza humana a partir de um estudo do indivíduo em análise, não posso transferir isto para a situação real da primeira infância sem levar em consideração a atitude e o comportamento da pessoa que cuida do bebê. De início, tal como o vejo, o relacionamento do bebê com um objeto acha-se tão intimamente ligado com a apresentação do objeto ao bebê que os dois não podem ser separados. Em termos de relacionamentos objetais, o bebê é inteiramente dependente da maneira pela qual cada pedacinho do mundo lhe é trazido, de maneira que se pode dizer que o mundo é apresentado ao bebê, *quer* de um modo tal que o objeto parece ser criado pela pulsão instintual do bebê, *quer* de uma maneira tal que não existe vínculo entre o elemento criativo do bebê e a existência do objeto externo.

Se esta opinião que repetidas vezes apresentei for aceitável, pareceria que a inveja em um bebê só pode fazer parte de um estado de coisas muito complexo, no qual há uma representação aterradora do objeto. A inveja da mãe por algo de bom nela só poderia aparecer se a mãe for aterradora em sua apresentação de si própria ao bebê. "Aterradora" aqui significa que a mãe adapta-se apenas o suficiente para que o elemento criativo do bebê seja atendido e este comece a perceber que existe algo de bom externo ao *self*, mas contudo, não mantido, de maneira que, até certo ponto, o bebê sente-se privado. Onde as qualidades boas da mãe acham-se disponíveis ao bebê, então a inveja não encontra lugar e a questão dela não surge. De acordo com esta visão, a inveja tem raízes profundas na natureza do bebê e o aparecimento dela constitui uma reação ao fracasso de adaptação da mãe.

Talvez se ache aqui uma solução para a dificuldade. O tema da inveja poderia ser enunciado em termos de um processo de desilusão que começa pela adaptação da mãe e inclui o fracasso gradual dela em adaptar-se, combinado com a capacidade crescente que o bebê tem de lidar com esse fracasso. Naturalmente, tem de haver um fracasso de adaptação, tal como em breve eu falharei em atender as necessidades de minha nova paciente, que ainda não "me encontrou" [*found me out*]. Seria então possível ver-se a inveja como uma coisa real na vida do bebê. Ela seria então percebida como um subproduto do relacionamento mãe-bebê em desenvolvimento e da organização do ego no bebê. Se, por outro lado, a inveja for descrita como sendo uma característica infantil, sem menção ao comportamento do objeto e a tudo o que isso implica, acho então que algo está errado. Falar sobre bebês não é o mesmo que falar sobre estágios primitivos no desenvolvimento emocional de pessoas, tal como vistos no estudo de pacientes. Estas duas coisas são diferentes porque, como disse, os pacientes trazem para a análise muito desenvolvimento sadio e sofisticação, juntamente com as suas doenças e os aspectos primitivos de suas próprias naturezas, e também por que não podem apresentar aspectos do cuidados materno dos quais nunca estiveram cientes.

Em minha opinião, a palavra "inveja" na expressão "inveja sádica oral" enfraquece o conceito do sadismo-oral. Este conceito sempre teve uma importância tremenda na imensa área do pensamento e da prática psicanalítica que foi explorada por Melanie Klein. O sadismo oral é valioso como conceito por juntar-se ao conceito biológico de fome, um impulso a relacionamentos objetivos que provêm de fontes primitivas e que têm influência pelo menos desde a ocasião do nascimento.

II. Primórdios de uma Formulação de Uma Apreciação e Crítica do Enunciado Kleiniano da Inveja²

Datado de 16 de julho de 1962

Neste ensaio, tento fazer um uso pessoal do trabalho apresentado ao Congresso de Genebra por Melanie Klein³ e de seu livro *Envy and Gratitude*.⁴ Com frequência,

* Referências na próxima página.

expressei críticas a respeito desta parte de seu trabalho, mas minha crítica se limita a dois aspectos e, fora de dúvida, eles se acham inter-relacionados. Em primeiro lugar, acho que a palavra "inveja" não pode ser utilizada na descrição do início da vida do bebê. Um emprego desse tipo da palavra não "senta" e produz em mim e em outros um preconceito desnecessário contra a idéia geral contida no livro. Em segundo lugar, a introdução da idéia de agressão herdada enfraquece o argumento principal do livro e desafia-nos a procurarmos quaisquer pontos fracos que possam existir na argumentação total. A existência e a importância daquilo que é herdado é algo que ninguém pode pôr em dúvida. Surge a questão: deve-se efetuar uma discussão metapsicológica para explicar fenômenos por referência à hereditariedade até que se tenha chegado a uma compreensão plena da interação dos fatores pessoais e ambientais? Em minha opinião, existe uma séria lacuna de compreensão no argumento de Melanie Klein e ela não é reconhecida, mas a nossa visão dessa lacuna é enevoadada pela referência à agressão herdada.

Em um debate na Sociedade Psicanalítica Britânica⁵ (que se seguiu a um artigo da autoria do Dr. Donald Meltzer), no qual desafiei a aceitação pronta do trabalho de Klein sobre inveja *in toto*, o Dr. S. S. Davidson observou que Melanie Klein não apenas se sentou e pensou: "Sobre o que escreverei?", ela foi levada a escrever por causa de sua impressão de que a inveja constituía uma questão importante a necessitar exame por causa de sua importância no trabalho clínico psicanalítico e por que sentiu que tinha uma contribuição a fazer à sua etiologia. Este ponto é facilmente aceito e, para mim, como para muitos outros, foi valioso haver tido a atenção chamada para a importância da inveja em nosso trabalho psicanalítico, embora o tema não seja novo e seja improvável que muitos analistas fiquem habitualmente cegos à inveja quando ela se torna aspecto importante de uma análise. Ademais, foi importante para nós que nos dissessem que a inveja tinha de ser examinada separadamente do caso especial da "inveja do pênis", termo que tem sido muito usado e que não foi bem-traduzido do alemão. Melanie Klein lembrou-nos que utilizamos a palavra "inveja" fora do contexto específico da posição feminina na fase fálica.

Em verdade, Klein demonstrou-nos que os pacientes invejam o analista quando este faz um trabalho analítico bom, um trabalho que é eficaz e do qual o paciente obtém exatamente o benefício que poderia querer da análise. No jargão de nossas intercomunicações psicanalíticas, os pacientes invejam o seio bom.

Baseado em meu próprio trabalho, não tenho dúvidas de que esta é uma observação verdadeira e dou valor a que tenha sido enfatizada. Ao mesmo tempo, há muito trabalho a se fazer com esta idéia, antes que possa ser aceita tal como é enunciada por Klein.

Sugiro que Melanie Klein não poderia desenvolver seu argumento do "seio bom" do analista sem entrar na questão da qualidade do trabalho do analista, isto é, da capacidade que este tem de adaptar-se às necessidades do paciente. Vinculada a isto acha-se a capacidade que a mãe tem de efetuar uma adaptação, no próprio início, às necessidades do ego do bebê recém-nascido (inclusive as necessidades do Id). O argumento de Klein conduziu-a a um ponto em que ela tem, quer de lidar com a dependência do bebê na mãe (do paciente no analista), quer deliberadamente ignorar o fator externo variável da mãe (analista) e fazer investigações em busca dos *mecanismos*

2. Há evidências de que este artigo, em que Winnicott está elaborando os detalhes de suas idéias, foi redigido tarde da noite e, embora posteriormente datilografado, nunca foi revisado por ele. — Os organizadores.
3. Trabalho apresentado ao XIX Congresso Psicanalítico Internacional, Genebra, julho de 1955; ver *A Study of Envy and Gratitude* (1956) em *The Selected Melanie Klein*, org. de Juliet Mitchell (Penguin, 1986).
4. London: Tavistock; 1957.
5. Provavelmente em uma Reunião Científica em 15 de fevereiro de 1961 — Os Organizadores.

primitivos que são pessoais ao bebê. Ao escolher o último curso, Klein envolveu-se numa denegação* implícita do fator ambiental, desqualificou-se quanto à descrição da primeira infância, que é uma época de dependência. Desta maneira, foi forçada a uma chegada prematura ao fator herança.

Compete àqueles que seguem Melanie Klein desenvolver este rico tema e ree-nunciar o problema sem valer-se de uma denegação implícita do meio ambiente. Tem-se de enfatizar que não houve denegação explícita do meio ambiente e a própria Melanie Klein sempre se afligiu com a idéia de que uma negligência da importância desse ambiente lhe estivesse sempre sendo atribuída, especialmente por mim. Mas permanece o fato de que, neste trabalho sobre inveja, está implícito, um descaço pelo comportamento do meio ambiente.

Seria fácil ilustrar o tema principal de Melanie Klein, de inveja do seio bom na transferência na psicanálise, uma vez que em quase todos os casos isto se torna de tempos em tempos o tema principal, e especialmente perto do fim de uma análise.

Um paciente masculino perto do fim de sua análise

A análise foi efetuada principalmente com base em uma transferência positiva, com a transferência negativa sempre se expressando em termos de pessoas do meio ambiente. A princípio, isto envolveu o paciente em antagonismos quase delirantes, mas já por um longo tempo agora o paciente conseguiu usar homens de modo bastante objetivo em sua atuação da transferência negativa. Houve exemplos muito agudos em que a transferência negativa recaiu sobre mim.

O término da análise foi elaborado principalmente com base na primeira identificação com o pai na puberdade e, por fim, na destruição deste e em sua suplantação. No curso disto, o complexo surgiu sob uma forma simplificada, que era importante por causa de certas qualidades na mãe deste paciente que distorciam o quadro. No caso de sua mãe, ele sempre manteve que existem razões pelas quais um menino precisa afastar-se da mãe que são mais profundas e mais iniciais que as razões do complexo edipiano, que precede o triângulo edipiano.

A destruição do analista bom surgiu de modo bastante repentino no material e sem que o paciente entendesse as razões para isso. Na transferência, o paciente empregou agora outra cisão no objeto, a existente entre professor e analista. O analista não ensina e o paciente resiste aos professores. O paciente não tem dificuldade em aceitar o analista, mas professores são eliminados desde o início, por causa de sua necessidade de ensinar a si mesmo. Isto data da infância. Há uma exceção no relacionamento de ensino e ela é que ele sempre achou que quando há um professor realmente bom ele sempre valorizou muito esse professor realmente bom. Em sua história, porém, os professores bons parecem falecer, seja por causa da guerra, seja por doença, etc.

Ao examinar este material nesta ocasião, o paciente esteve muito próximo de sua própria destruição do professor bom, e neste ponto, foi necessário interpretar a inveja do professor bom. A interpretação foi bastante longa e tinha a ver com a grande dificuldade que o paciente sente em permitir que alguém mais seja necessário. Ele pode ensinar a si próprio, mas a fim de que lhe seja ensinado francês, tem de emprestar ao professor dessa língua o papel de ensinante. Ele gostava de seu bom professor de francês, mas este foi morto na guerra. Se o professor bom que é apreciado sobrevive, ele então tem de destruí-lo para deixar de precisar dele. É como se só pudesse suportar esta delegação do ensino a outrem por um tempo limitado ou de maneira limitada.

Retornei então à amamentação teórica. Disse-lhe: "Você podia alimentar-se melhor do quem quer que pudesse alimentá-lo, porque sabia o que queria; a fim de obter leite, contudo, teve de ceder a alimentação à sua mãe. Pôde fazer isso por um tempo limitado e então se desmamou você mesmo, por assim dizer. Se isto houvesse acontecido de maneira satisfatória, você nunca teria precisado saber quão raivoso ficou por ter de ceder o papel de alimentador à sua mãe ou ao seio. No caso de sua mãe, contudo, houve uma certa tendência da parte dela de aferrar-se ao seu papel e, por esta razão,

* No original *denial*, foi utilizada a tradução *denegação* proposta por Moore & Fine, *Termos e Conceitos Psicanalíticos*, Porto Alegre, Artes Médicas, 1992. Sugerimos ao leitor consultar este dicionário para o esclarecimento da diferença deste termo de *negação (negation)* e compartilhar a complexidade da utilização de expressões advindas do alemão — *Verneinung* e *Verleugnen*, termos originalmente utilizados por Freud (1925). (N. dos R.)

em seu caso, você ficou cômico de uma necessidade tremenda de libertar-se, e isto dominou grande parte de sua vida. Por trás está a sua raiva por sua mãe ou por um seio bom, por serem necessários”.

Reconheci que, ao fazer esta interpretação, estou concedendo algo que é quase exatamente o mesmo que o conceito que a Sra. Klein tem da inveja que o bebê sente do seio bom. Quando tudo sai bem, é um antagonismo teórico à idéia de que objeto externo é necessário, algo que não é verdade no começo, porque o objeto é um objeto subjetivo; gradualmente, porém, torna-se verdadeiro, à medida que o objeto se torna objetivamente percebido. Em um número muito grande de casos, deve acontecer que o bebê nunca sabe a respeito disto que a Sra. Klein chama de inveja do seio bom e que eu denomino de intolerância da necessidade de um representante externo daquilo que é originalmente sentido como fazendo parte do *self*. Quando a mãe abandona o seu papel de má vontade ou de modo demasiado lento, a criança então desenvolve ódio e uma necessidade de liderar-se, mas isto não é a inveja do seio a que a Sra. Klein se refere; é raiva com a mãe pelo fracasso técnico dela, que traz para o relacionamento vivo um sentimento que pertence ao inconsciente primário teórico latente.

Um analista praticante tem então oportunidade de verificar esta parte do enunciado de Melanie Klein ou de descobrir uma ausência de verificação. É um fato notável, contudo, que havendo completado uma fase deste aspecto da análise, o analista não descobre que a análise do paciente está finda. Há um alívio imenso quando esta interpretação é feita no momento certo, mas resta algo, e, indubitavelmente foi isto o que Melanie Klein sentiu quando prosseguiu declarando que alguns dos indivíduos que chegam para análise herdaram uma tendência poderosa no sentido da agressão.

Tentar-se-á aqui ilustrar a maneira pela qual há muito trabalho a ser feito na análise de um paciente *após a interpretação da inveja do seio bom*, e isto não seria verdade se o enunciado de Melanie Klein estivesse correto. Se assim fosse, após a análise da inveja do seio bom nada mais haveria a ser dito a respeito da agressão do paciente, exceto em termos de herança. Isto pode ter sido achado correto, mas na realidade, não acontece. Seria uma parte importante do trabalho de Melanie Klein sobre a inveja que ele conduzisse a uma melhor compreensão do que ela talvez erradamente denominou de inveja do seio bom no relacionamento vivo do bebê e da mãe em um estágio muito inicial.

No caso do paciente cujo material foi utilizado para ilustrar a inveja do seio bom na transferência, uma grande quantidade de trabalho ulterior demonstrou precisar ser feita.

Um paciente, perto do final de sua análise, trouxe um sonho à sessão. No padrão de sua análise, ele primeiro tivera um longo período de trabalho direto no qual cooperou desde um nível profundo. Isto constituiu uma grande diferença para ele e demorou três anos. Então a análise inverteu-se e tornou-se caótica, e havia uma razão clara para isto, qual seja, a de que agora o paciente precisava produzir material que não era facilmente compreendido. Isto conduziu gradualmente a uma certeza de que não havia esperança de que ele conseguisse o que viera buscar. Na primeira fase, não tivera absolutamente nenhuma dúvida, mas agora se tornava cada vez mais certo de que a análise acabaria sem haver terminado. Nesta fase desesperançada, um bom trabalho analítico estava sendo efetuado, tal como acontecera na primeira fase, e mudanças clínicas resultaram de tal trabalho, mas as expectativas do paciente se haviam alterado. A inveja do analista sempre fora evidente e fora interpretada sempre que surgira para interpretação; ela estivera relacionada com a infância do paciente, de acordo com o padrão dele.

O paciente sonhou que havia inesperadamente adquirido 20.000 libras; não era pagamento por nada e sequer tivera de apostar num cavalo. Estava irritado consigo mesmo por não se lembrar de mais nada a respeito do sonho. A interpretação baseada no material disponível foi de que agora ele sabia por que havia entrado em análise e estava me dizendo que de fato o conseguira. Ele viera em busca de 20.000 libras.

Nos primeiros estágios insistiu em pagar-me honorários que se achavam além de sua capacidade de pagar e tinham havido muitas indicações durante toda a fase inicial da análise de que isto era uma formação reativa e que acabaria por descobrir-se que ele viera por dinheiro. Havia furtos de mim, de forma simbólica, de tempos em tempos. Interpretações ao longo destas linhas produziram resultado e o paciente disse que, na

realidade, a análise havia aumentado a sua capacidade de ganhar, ao ponto de montar ao equivalente de um aumento de £ 20.000 em seu valor de capital. Juntamente com a interpretação do sonho veio o sentimento de que a análise agora poderia findar, em vez de ser artificialmente terminada. Isto significava um reconhecimento do que ele havia conseguido de mim e vinculava-se com a introdução, por Melanie Klein, da idéia de gratidão na resolução satisfatória destas dificuldades. A gratidão é uma dependência que é reconhecida. Foi necessária uma análise maior da necessidade de dinheiro em seus dois aspectos: primeiro como símbolo de amor e, em segundo lugar, como um substituto do amor a conduzir consigo o reconhecimento de uma privação. Neste caso, a carência era relativa e muitíssimo ligada com a atitude real do pai para com dinheiro, que, por sua vez, achava-se associada à homossexualidade reprimida do pai.

Em termos do desenvolvimento emocional do bebê, esta questão da inveja relaciona-se à provisão ambiental. Onde existe uma mãe suficientemente boa, então o bebê, a princípio absolutamente dependente, recebe de fato um "seio bom"; a mãe suficientemente boa recebe a capacidade crescente do bebê de ter uma qualidade pessoal de "seio bom" que pode ser projetada. A mãe suficientemente boa recebe esta projeção. Desta maneira, no decorrer das semanas e dos meses, o seio bom que o bebê usa não constitui apenas uma projeção, mas acha-se também disponível, ainda que externo ao *self*. À época em que o bebê vem a perceber que o seio bom é externo e pertence ao meio ambiente e não ao *self* já se desenvolveram os germes de numerosos mecanismos mentais que o capacitam a permitir a separação do objeto e a fazer uso desta separação no início da jornada para a independência.

(Tentei descrever os principais destes mecanismos mentais pelo nome de "fenômenos transicionais", isto é, uma área intermediária de experiência que é ao mesmo tempo *self* e não-*self*, isto, tanto bebê quanto mãe.)

Tem-se de lembrar que o paciente que lida com o relacionamento básico com o seio em uma análise precisa chegar a um acordo com o *fato da dependência*. Isto envolve, em um dos extremos, a regressão, e, no outro, o lugar onde o ego pode tolerar fatos, gratidão (ou culpa).

Para o bebê, que ainda é levado aos braços, estas condições não se aplicam. A dependência é uma realidade viva e começa pela dependência absoluta; gratidão e ressentimento como reconhecimento da dependência não encontram lugar. Nada mais é conhecido ainda.

Para os bebês, existe uma razão básica de "seio bom", sem a qual os estágios iniciais do desenvolvimento emocional do indivíduo não se iniciam. Vários autores tentaram formular isto: Balint em seu conceito de amor primário, eu em minhas expressões "maternagem suficientemente boa" e "preocupação materna primária". O "seio bom" mostra ser uma expressão de jargão para (a) "maternagem suficientemente boa", (b) "amamentação satisfatória" e (c) a união de (a) e (b), primeiro no meio ambiente e, depois, na mente do bebê.

Em questão de poucos meses após seu nascimento, o bebê está obviamente capacitado a ter experiências sádicas orais, isto é, ele pode experienciar um amar primitivo em que os impulsos motores fundem-se com as satisfações de zona erógena e o bebê chega ao comer o objeto, e ser comido, se amado. Por volta da mesma época, este objeto primário deixa de ser um fenômeno subjetivo e, se toda a experiência é dirigida no sentido do que é simbólico do objeto primário, o bebê torna-se capaz de brincar e de imaginar, e experiencia o uso do objeto primário somente em sonhos.

O ponto principal é que existe um período de tempo, ou fase, na vida do bebê recém-nascido em que os problemas principais que preocupam os pacientes em análise não imperam. Isto equivale a dizer que há uma fase importante antes que a posição depressiva (para utilizar a expressão de Melanie Klein, mesmo que ela não

seja um bom nome para um estágio muito importante e real do desenvolvimento) possa ser atingida e o desenvolvimento que isto representa se consolide.

Nesta fase inicial o bebê está desenvolvendo um sistema de memória e uma percepção de si que se tornam disponíveis para projeção. A mãe suficientemente boa recebe esta projeção e, desta maneira, a experiência do bebê em relação ao seio bom é um relacionamento com uma projeção provinda do *self*. *Não existe lugar para a inveja aqui*. O bebê cuja maternagem não é suficientemente boa nunca se reúne com o que se acha disponível para projeção com o seio bom desta mãe. A última fracassa em receber a projeção. Nos casos que vêm até nós na análise pode-se presumir que houve uma situação aterradora em que a maternagem foi suficientemente boa e não suficientemente boa, de maneira que o bebê soube da existência de um seio bom, mas não o conseguiu, exceto como algo que surgiu como uma invasão ou intrusão [*impingement*] para romper a continuidade de ser do *self*. Nestas circunstâncias, o bebê inveja o seio bom ou o destrói quando lhe chega de maneira tal que não recebe as projeções do bebê.

Temos aqui o paradoxo de um seio bom que é um perseguidor, uma coisa que tem de ser destruída. Dessa maneira, a agressão aparece, dirigida no sentido do objeto bom, mas ela é reativa e não é a agressão do impulso amoroso primitivo que representa uma realização; uma fusão do erotismo muscular e da orgia sensorial das zonas erógenas.

Em outras palavras, não existe lugar em nossa teoria para a inveja que o bebê tem do seio bom quando este é uma projeção, como acontece quando há uma maternagem suficientemente boa. Este conceito de inveja do seio bom não é válido, exceto no caso de um relativo fracasso da maternagem nos primeiríssimos estágios.

Em minha opinião, a tentativa de Melanie Klein de enunciar a história inicial da agressão estava condenada ao fracasso desde que ela tentou enunciar-la separadamente da questão do comportamento do meio ambiente. Entre o fator hereditário e a inveja encontra-se o amar primitivo com o comer, que ainda não se tornou cruel por ser uma conquista da fusão e o efeito sobre o objeto ainda não é matéria para preocupação. Isto se dá exatamente antes da posição depressiva, no gráfico teórico do desenvolvimento emocional humano.

A seguinte observação clínica ilustra isto. Ela pertence à análise de uma mulher de 25 anos de idade. Ela se descreveu como sendo alguém que toda a sua vida diminuiu suas perdas e para isso empregou uma defesa bem-sucedida, a saber, a exploração plena de objetos substitutos. Isto constitui uma das variedades de falso *self*, a falsidade situando-se antes na aceitação de substitutos do que no estabelecimento de um *self* substituto. O motivo que a paciente teve para entrar em análise foi ser tirada do emprego desta defesa, que não lhe concedia constância objetual e que a fazia sentir-se todo o tempo incerta quanto ao valor da vida.

Em uma semana decisiva de sua análise a paciente chegou à posição depressiva. Descreveu-se como a favor da mamadeira e contra o seio. Declarou ser uma mamadeira. Jogou esta no chão, quebrou-a, ficou olhando e exultou com a sua destruição. Sua morte era sempre uma idéia excitante, por causa de uma dramatização deste evento que implicava claramente estar ela viva em todos os seus outros *selves*-mamadeiras — desfrutando de seu próprio funeral, por assim dizer. Na realidade, ela entrou em análise a fim de tornar-se capaz de morrer. De seu material, podia-se ver que estava explorando ao máximo seu tipo particular de defesa maníaca e exultação. Mas ela tinha um sonho incômodo. Estava fazendo análise com M. e como podia M. fazer interpretações do tipo Klein, de morder e sujar o seio bom e de todos os ataques ao corpo da mãe quando ela própria era um tipo maternal, terrivelmente entediante? E assim por diante.

A interpretação que foi fornecida com base em provas muito claras foi que M. representava a parte Melanie do nome de Melanie Klein. Em outras palavras, ela chegara à coisa à qual havia virado as costas, qual seja, o seio moribundo da mãe. Isto foi um choque para a paciente, que disse nunca haver pensado em Melanie Klein como

tendo algo a ver com um seio bom — apenas com o ataque ao seio. Aqui estava ela agora, tendo uma análise tipo Melanie — seio bom — (cf. "cérebro de seio bom", de Meltzer) e isto a levava a fazer o oposto do que chamava de diminuir suas perdas. Conduzia-a a olhar para o seio moribundo (fracasso em sua própria experiência de amamentação) e ficar preocupada com o papel que poderia ter desempenhado no fracasso da mãe. Podia-se dizer ser esta a "primeira vez" que a paciente genuinamente sentira interesse pelo relacionamento bebê-objeto. Ao mesmo tempo, tinha um interesse bem-desenvolvido pelo relacionamento mãe-bebê ou mãe-criança.

Neste ponto de sua análise, por acaso, um pássaro ferido apareceu em sua vida. A caminho da análise deparara-se com uma ave machucada e chegara à análise aflita, consciente de haver mais uma vez "diminuído suas perdas", por afastar-se da ave da qual havia sentido medo. Após alguns minutos, retornou ao pássaro, embora isto significasse uma longa volta, mas primeiro me deu tempo para interpretar a ave como uma representação do seio moribundo de sua própria experiência de bebê. Ela encontrou a ave e restaurou-lhe a vida, e isso foi a sua sessão analítica naquele dia. A experiência assinalou uma virada em sua análise e, talvez, em sua vida, embora as mudanças envolvessem um abandono da exultação que acompanha uma defesa maníaca bem-sucedida contra a preocupação. (Não se pode chamar isto exatamente de defesa maníaca, uma vez que este nome foi dado à denegação da depressão, ou, em outras palavras, a uma defesa organizada *após* a chegada à posição depressiva.)

Esta paciente se achava agora exatamente no ponto em que a inveja do seio bom (análise boa) tende a aparecer, mas isto não aconteceu porque o analista suficientemente bom estava recebendo uma projeção das próprias qualidades dela. Não apenas tinha havido muito material do tipo mãe-suficientemente-bom-para-a-criança, mas também, no próprio dia que conteve o enunciado principal de uma cisão entre ela diminuir suas perdas (seio morto) e o seu *self* infinitamente envolvido com objetos substitutos (mamadeiras), ao final da sessão disse sentir-se certa de que eu devia achá-la, um caso interessante e, quando foi embora, sentiu-se vazia, mas havia vindo a conhecer que após algumas horas, especialmente se pudesse dormir, ela se recuperaria. Interpretei aqui que, desta maneira, eu era o bebê e que ela estava me amamentando com o seio bom, e que ela já sabia do poder que tem o seio de novamente encher-se.

Nesta análise, mais que na maioria delas, segundo minha experiência, houve uma necessidade de o analista ser alguém que cuidadosamente não faz mais do que atender ou tornar reais as projeções do paciente. Nesta análise também falei muito pouco, com frequência nada e raramente mais do que para fazer uma interpretação por sessão. De modo muito claro, aqui, a minha análise suficientemente boa neste caso é uma projeção, que atendo e com que tento não interferir. Desta maneira não há inveja do seio bom. Houvesse eu, contudo, por erro técnico, feito ou dito algo que fosse estranho ao material do paciente disponível para projeção, então me tornaria imediatamente um perseguidor, e teria de ser destruído, bom ou mau, e especialmente se bom.

Conclusão

A maternagem suficientemente boa fornece oportunidade para o desenvolvimento continuado do processo pessoal no bebê. Aqui a qualidade de seio bom da mãe é uma projeção de uma qualidade correspondente no bebê. A mãe suficientemente boa recebe a projeção boa e torna-a real. Na medida em que isto acontece, o bebê não inveja o seio bom, mas é capaz de identificar-se com ele e com a mãe suficientemente boa e gradualmente reconhecer que a mãe que recebeu a projeção faz parte do meio ambiente, do mundo NÃO-EU.

Na maternagem que não é suficientemente boa, a mãe não é capaz de receber as projeções boas e, então, há caos e os primórdios da psicose, ou então há uma condição aterradora em que o bebê sabe da existência de um seio externo bom que não pode

reunir-se com aquela qualidade do bebê que se acha disponível para projeção sobre um seio bom. Em tal caso, o seio bom é um perseguidor e tem de ser recusado ou destruído. A palavra "inveja" não se aplica a isto que o bebê sente a respeito de um seio bom que fracassou em receber a projeção.

Nas mesmas condições, transportadas para a análise de crianças e adultos, a palavra "inveja" pode ser usada, e utilizada da maneira pela qual Melanie Klein a emprega. A diferença entre a situação analítica e a situação nos primórdios da infância é que o paciente analítico deve forçosamente lidar com o fato da dependência, enquanto que, no começo, o bebê é dependente e não conhece outra condição. Da mesma maneira, a criança ou o adulto que não são capazes de gratidão são enfermos, mas para o bebê, não há lugar para a idéia de gratidão, porque uma razão básica de cuidado suficientemente bom faz parte do bebê, ainda que precise ser fornecido por uma mãe.

Desta maneira, embora o enunciado de Melanie Klein sobre a inveja seja de grande importância para o analista praticante, não se trata de algo que possa ser aplicado a bebês e, portanto, não é possível tirar desse enunciado conclusões referentes às origens das tendências agressivas em um indivíduo.

Na realidade, o enunciado da inveja de Melanie Klein, na medida em que as idéias dela são distendidas para abranger a primeira infância, parece enfraquecer seu trabalho muito importante a respeito do que chamou de posição depressiva. A teoria das raízes da agressão não é enriquecida por esse enunciado, mas tornado confuso por ela cair de volta nos fatores herdados sem seriamente enfrentar o efeito da maternagem (ou análise) que é suficientemente boa ou não suficientemente boa.

Pode-se presumir que a herança seja de máxima importância, mas o psicólogo não pode apoiar-se no fator herança até que tudo que é possível tenha sido feito em termos de psicologia.

Finalmente, o ponto principal em questão é o seguinte: Quando um analista (mãe) faz um trabalho suficientemente bom (fornece um cuidado suficientemente bom) com um paciente (bebê), isto é feito com base em uma projeção, para o analista (mãe), de fatores internos satisfatórios do paciente (bebê)? Em minha opinião, a resposta é afirmativa, e, a menos que isto seja tornado verdadeiro pelo analista (mãe), a análise boa (seio bom) constitui essencialmente um objeto persecutório para o paciente (bebê).

Isto me parece ser um enunciado moderno de um dos pontos principais da técnica de Freud, qual seja, o de que o analista segue o processo do paciente e interpreta *apenas aquilo que já foi apresentado pelo paciente para interpretação*.

É a mãe que cria o bebê ou o bebê que cria a mãe? Na metapsicologia da psicanálise, sustento que o bebê cria o seio, a mãe e o mundo.

III. Raízes da Agressão

Datado de 9 de setembro de 1968⁶

Existe atualmente uma necessidade de que a psicanálise efetue um novo exame da agressão. O recente livro da autoria de Anthony Storr⁷ demonstrou que o público acha-se faminto por um enunciado que indique que um reconhecimento devido está sendo dado ao problema pela ciência. A fim de basear idéias na observação objetiva, o cientista tem de estar com o palco pronto para observar e é o psicoterapeuta que possui o melhor ponto de observação, se puder fazer uso de sua posição privilegiada. E, para mim, tal como para muitos outros, o psicanalista é, dos psicoterapeutas, o que mais tem probabilidade de contribuir com algo de novo, principalmente por causa do processo analítico que esteve atuando nele e que continua pelo resto da vida, isto é, independentemente da análise real por que passou e a respeito da qual, em determinado estágio, concordou com seu analista em dizer: isto é o fim.

Nenhum progresso na teoria psicanalítica é feito sem pesadelos. A pergunta é: quem deve ter o pesadelo? A questão seguinte — por que ele precisa ter pesadelos? — não é importante e pode ser ignorada. Aqui, em nossa Sociedade, embora prestemos serviço à ciência, precisamos todas as vezes fazer um esforço para reabrir assuntos que parecem ter sido estabelecidos. Não é apenas a inércia que tem pertinência ao medo da dúvida; é que também possuímos lealdades. Associamos idéias específicas com picos de realização que assinalam o progresso de nossos pioneiros. Desta maneira, quando olhamos de maneira nova para as raízes da agressão, existem dois conceitos em particular, ambos devendo ser jogados fora deliberadamente, de maneira a podermos ver se eles retornam espontaneamente ou se estamos melhores sem eles. Um deles é o conceito freudiano de um instinto de morte, um subproduto de suas especulações, no qual pareceu estar alcançado uma simplificação teórica que poderia ser comparada à eliminação gradual dos detalhes na técnica de um escultor como Michelângelo. O outro é o estabelecimento por Melanie Klein da inveja no lugar proeminente que lhe concedeu em Genebra, em 1955.

Não nos é possível fazer avançar o debate científico, a menos que estejamos preparados para pôr de lado ambos estes conceitos, desvinculando o primeiro de Freud e o segundo de Melanie Klein. Desta maneira, libertamo-nos de crenças e de lealdade, e mais uma vez a única coisa pela qual temos apreço é a verdade.

Assim que atingimos esta disciplina, imediatamente percebemos quanto fomos doutrinados pela interjeição constante das palavras "instinto de morte" e "inveja" em trabalhos e enunciados. O essencial é que nenhum dos conceitos pôde ser debatido na ocasião, por não constituir o tema principal, e um debate dessas expressões deve portanto desviar a atenção e o que as debate deve parecer, e em verdade, ser rude. É com alívio, portanto, que nos descobrimos aqui sem noções pré-concebidas a respeito do instinto de morte ou da inveja, e, se qualquer dos termos for utilizado, ele deve ser deliberadamente trazido à discussão como parte da coisa que está sendo discutida e sobre a qual concordamos ser ignorantes.

6. Este artigo foi preparado para a Sociedade Psicanalítica Britânica, mas se acha inacabado e, na realidade, não foi apresentado. — Os Organizadores.

7. *Human Aggression* (London: Allen Lane, 1968).

Quão facilmente esses termos se tornam lugares comuns! Exemplificando, Melanie Klein não reivindicaria ter descoberto a inveja ou haver inventado o conceito. Temos de utilizar as palavras "inveja" e "ciúme" sempre que elas forem apropriadas à nossa fala e a nossos textos, tal como foram usadas nos longos anos que precederam o nascimento de Melanie. Em verdade, estas duas palavras têm suas próprias histórias.

Melanie Klein tomou a palavra "inveja" e lhe concedeu um uso específico em uma exploração legítima das origens da agressão na natureza humana, em termos do indivíduo em desenvolvimento. Mas a palavra adquiriu hoje uma aura, de maneira que provavelmente não existe trabalho da autoria de um seguidor de Klein ou de um estudante do grupo dela que não tenha incluído a palavra "inveja", não como termo descritivo (a paciente demonstrou inveja dos meninos mais novos, constituindo isto um vestígio dos sentimentos que teve para com a irmã, por ocasião do nascimento deste, e em relação à atitude dos pais, etc.), mas como parte da etiqueta que indica o lugar de origem da mercadoria (algodão de ilha marítima, lavagem garantida, secagem rápida).

O efeito triste desta coisa horrível a respeito da inveja é que ela impede uma apreciação verdadeira da contribuição de Melanie Klein que facilmente poderia ter sido particularmente audaz e rica exatamente aqui. Algo que parece estar errado a respeito de seu trabalho de Genebra pode revelar ser um pequeno detalhe, e uma verdade pode emergir se pudermos nos afastar desta lealdade à Melanie, que coloca fora de questão a avaliação científica ou objetiva. Aqui e agora talvez possamos chegar atrás do que existe nesta questão de lealdade (provavelmente baseada, em seus aspectos compulsivos, na inveja) e chegar ao próprio problema. Estamos debatendo a natureza humana e nos achamos particularmente interessados nos processos desenvolvimentais e no que chamaríamos de etiologia na investigação de uma enfermidade.

Incidentalmente, reivindico que nos é legítimo dizer que sentimos haver algo de errado com o enunciado de Genebra. Não há problema que sintamos haver algo errado com a formulação do Instinto de Morte por Freud, porque ele próprio parece haver tido dúvidas, dúvidas próprias a um cientista que sabe que nenhuma verdade é absoluta e final, e que são o pensamento, o sentimento e a liberdade de especular que contam. Mas Melanie Klein foi "mal-servida" por seus seguidores, que tomaram o que ela disse e o pregaram em uma bandeira, quando ela teria lucrado mais se fosse criticada. Esta tendência entre os seguidores de Klein é melhor percebida na frase de Joan Rivière em seu prefácio ao livro *Developments in Psycho-Analysis*⁸: "Ela em verdade produziu algo de novo em psicanálise, a saber, uma teoria *integrada* que, embora ainda em esboço, apesar disso leva em consideração todas as manifestações psíquicas, normais e anormais, do nascimento até a morte, e que não deixa abismos intransponíveis, nem, tampouco, fenômenos a salientar-se sem relação inteligível com o restante". É uma frase que Melanie teria desaprovado, houvesse sido ela mesmo verdadeiramente uma cientista.

Ingressei nestas questões com certos detalhes porque quero poder chegar a qualquer conclusão que possa surgir sem ter de preocupar-me, mesmo que me descubra dizendo exatamente o que Melanie Klein disse. Se isto acontecer, deve provir de mim a partir dos dados objetos fornecidos por meus pacientes e não, de maneira alguma, por lealdade a um homem ou a uma mulher, por muito que lhes possa dever ou sentir-me grato.

Pode-se dizer que Freud e Melanie Klein estiveram ambos profundamente interessados na agressão e na origem desta. Em ambos os casos o interesse teve uma profundidade de significado que é rara e pertence apenas a pessoas especiais, pessoas que têm a capacidade de sentir profundamente e que se tornaram enriquecidas por

8. London: Hogarth Press, 1952.

uma longa experiência e estabilizada pelo trabalho árduo sem os quais a realização pessoal não pode ser conceptualizada e posta por escrito. Melanie, em particular, foi afetada pela agressão enraizada que encontrou em seus pacientes a quem tinha tanto de bom a oferecer. Os pacientes dela haviam ido longe e o seu antagonismo não podia ser mais afastado pela análise da raiva com a frustração. Cada vez mais se tornou claro para ela que o seu valor gerava ou fazia deflagrar impulsos destrutivos em seus pacientes, tanto masculinos quanto femininos; de uma boa proporção de seus casos ela muito sensatamente se livrou como não-analisáveis, e outros avançaram para uma lealdade fixa que, infelizmente, exigia demais deles. Ela ficou intrigada e dedicou-se especificamente a este problema da destrutividade na transferência, que não parecia fazer sentido. Nesta altura, já havia um certo sentido de pressa, porque estava envelhecendo e, finalmente, porque viria a ter uma enfermidade física que se revelaria fatal. Ela queria ultrapassar essa barreira e efetuou uma tentativa de fazê-lo em Genebra. A solução surgiu ao longo de duas linhas:

1. Fazer tudo pular para trás e enunciar, sem originalidade, que, uma vez que tudo é herdado, algumas pessoas poderiam nascer com uma herança mais carregada do lado agressivo. Este foi um enunciado estéril e incorria em uma petição de princípio quanto a toda a questão da agressão e sua evolução no bebê e na criança individuais e em desenvolvimento.

2. Agarrar o touro pelos chifres e dizer em voz alta o que era clinicamente evidente, ou seja, que os seus pacientes na transferência em nível muito profundo, invejavam-na por ser valiosa, ou "boa"⁹.

Poder-se-ia dizer destas duas linhas de pensamento que a primeira, embora irrefutável, só deveria ser apresentada e enfatizada por um metapsicólogo após uma exploração muito cuidadosa das alternativas psicológicas ou emocionais, e é possível argumentar que Melanie não se qualificara com respeito a isso. Existem outras considerações que ela ignorou. A segunda linha de pensamento foi audaz e em conformidade com uma experiência clínica que todos os analistas podem partilhar, mas (...).

IV. Contribuição a um Simpósio sobre Inveja e Ciúme

*Redigido para uma Reunião Científica da Sociedade Psicanalítica Britânica, em 19 de março de 1969*¹⁰

Sinto-me muitíssimo inclinado a tomar parte neste debate, especialmente porque a idéia dele surgiu de uma sugestão minha ao Secretário Científico, mas gostaria de participar dele apenas se houver uma possibilidade de que possa dizer algo construtivo.

9. A própria palavra "boa" estava se tornando um lugar comum, a indicar um objeto idealizado ou, talvez, um objeto idolatrado. — D. W. W. Ver Masus Khan, *Reparation to the Self as an Idolised Internal Object* (1968), em *Alienation in Perversions* (London: Hogarth Press, 1979). — Os organizadores.
10. Lido, na ausência de Winnicott, pela Sra. Enid Balint. — Os Organizadores.

Primeiro de tudo assumo que não nos achamos, neste debate, interessados na inveja e no ciúme tal como estas duas palavras aparecem em aproximadamente todos os artigos clínicos apresentados em anos recentes por kleinianos. Alego também que no uso atual desses dois termos a inveja é um estado mental e pertence a uma organização mental altamente sofisticada, enquanto que o ciúme possui a característica que o seu uso implica de que a pessoa total já começou a mobilizar a vingança ou o roubo.

A única coisa em que estamos interessados é a maneira pela qual Melanie Klein apresentou a inveja em seu artigo de Genebra. Poderia prontamente perdoar-lhe isso se ela houvesse necessitado de outra palavra, mas não pude encontrar nenhuma.

Como com frequência declarei, aprendi muita coisa diretamente de Melanie Klein na década que precedeu a guerra. Poder-se-ia dizer que as novas idéias que vieram dela naquele frutífero período de seu trabalho me impressionaram e tiveram um efeito positivo sobre a totalidade de meu trabalho. Descobri-me capaz de usar a sucessão de idéias novas, mas isto nunca se tornou tão obviamente verdadeiro após a guerra e após o período em que a Sra. Klein organizou-se, e a seus colegas, para defender a sua posição. Meus sentimentos a respeito do trabalho da Sra. Klein mudaram na Conferência de Genebra, durante sua leitura de seu trabalho sobre a inveja. Não foi fácil perceber por que é que eu não podia mais aceitar o seu novo enunciado teórico.

De modo muito sucinto, embora eu pudesse ver que a Sra. Klein estava tentando chegar a maiores profundezas e abranger um aspecto muito difícil das forças transferenciais que só podem se desenvolver ao final de uma longa análise que parecia estar indo bem, mas que começou a fracassar, apesar disso eu sabia que tinha de fazer um protesto e o fiz imediatamente à própria Sra. Klein. Minha objeção tem a ver com a determinação dela de efetuar um enunciado completo do desenvolvimento individual do bebê em termos somente do bebê, sem referência ao meio ambiente. Isto, em minha opinião, é impossível. É verdade que tem sido uma característica principal da psicanálise chegar ao fator individual e pessoal e perceber a maneira pela qual o fator ambiental pode ser parcial ou mesmo inteiramente um fenômeno subjetivo; apesar disso, existe um estágio no começo do desenvolvimento do indivíduo em que o ambiente ingressa por si, tem seu lugar apropriado, e um enunciado da sua importância não pode ser evitado. O novo bebê ainda não separou o NÃO-EU do EU, de maneira que, por definição, o NÃO-EU ou o ambiente fazem parte do EU em termos do ego do bebê. Não há maneira de contornar esta dificuldade.

No artigo de Genebra, a Sra. Klein pulou sobre este problema e veio a cair em outro. Ela retornou a uma exploração do fator hereditário, tal como, por exemplo, uma herança de uma quantidade anormal de potencial agressivo. O fator hereditário naturalmente é real, mas não se pode dizer que a psicanálise tenha tentado evitar esta complicação. Toda tendência no sentido do amadurecimento é herdada e a psicanálise está simplesmente interessada na interação entre o que é herdado e o que é ambiental. Foi um choque descobrir a Sra. Klein evitando algo pela exploração de outra coisa. Incidentalmente, em termos da organização do ego do bebê muito pequeno, a tendência herdada constitui um fator *externo* de um tipo particularmente grosseiro. É possível que a Sra. Klein tenha pensado que o fator hereditário era pessoal e não ambiental, mas isto seria deixar de fora todo o problema do ego imaturo e a dependência que se baseia no fato de que o NÃO-EU ainda não se separou do EU.

O que se necessita daqueles que se interessam por este assunto é um estudo da mudança gradual no desenvolvimento de um bebê no início, que pertence à separação entre o NÃO-EU e o EU. A inveja do objeto NÃO-EU tem um precursor, que é o relacionamento com o objeto ainda-não-separado a que me referi pelo nome de objeto subjetivo. Existe aqui uma área para estudo que pode ocupar os psicanalistas por um

longo tempo vindouro e sem o qual não haverá compreensão psicanalítica eficaz da esquizofrenia.

Posso dizer que minhas opiniões se forjaram em meu consultório, no tratamento, nem sempre exitoso, mas às vezes suficientemente bem-sucedido de casos fronteiriços [*borderline*] em que a regressão à dependência era uma questão assinalada e, em verdade, essencial. Acho-me agudamente ciente da importância do fator qualitativo no meio ambiente quando isto é minha própria compreensão e conduta e um paciente fica, por um período de tempo, fundido comigo, o analista.

Nesta excitante área de estudo, o estudioso ver-se-á envolvido no conceito dos fenômenos transicionais, precisará poder aceitar (não resolver) o paradoxo de que o bebê cria o que já se acha lá para ser criado, e descobrir-se-á inteiramente levado além do limite em sua crença na realidade da dependência, tal como impera no estágio inicial, antes que o ego individual tenha criado elementos NÃO-EU. Isto é anterior à raiva com as frustrações que pertencem ao encontro com o Princípio da Realidade.

Pode existir um lugar em tudo isto para o que Melanie Klein está chamando de inveja, mas ela não possuirá esse nome quando a sua forma for corretamente delineada. Poderá ser avidez, mas seja qual for o nome que se descobrir ou inventar, precisará ser visto que a qualidade é afetada pela qualidade da provisão ambiental.

É triste para mim que a Sra. Klein, após tudo com o que contribuiu, não tenha sido capaz de contribuir para este ponto e, em verdade, por não contribuir, ela parece ter passado a seus seguidores uma tarefa peculiarmente difícil, pelo fato de que eles terão de avançar exatamente aqui com base não em todas as contribuições positivas que a Sra. Klein fez, mas com base em sua denegação de algo que é, apesar disso, um fato. Esta é outra maneira de dizer que também ela era humana.

Gostaria de fazer referência ao fato de que o Dr. Bion, em um de seus enuncios, pareceu mostrar estar livre desta poderosa tendência, a qual sugiro que tem de ser aceita como fazendo parte da constituição da Sra. Klein, qual seja, negar o fator ambiental mesmo no começo.

Como analistas, sabemos muito bem que, em um *setting* transferencial em que está sendo feito um trabalho que chega a estados muito iniciais, faz realmente diferença o jeito que o analista tenha. Da mesma maneira, no início do desenvolvimento de todo indivíduo o meio ambiente possui importância primordial, fazendo parte ainda da criança. Sustento que um estudo das sutilezas existentes nesta área pode trazer ricas recompensas ao estudioso.

Joseph Sandler

I. Comentários sobre *On The Concept of the Superego*¹

Apresentado em uma Reunião Científica da Sociedade Psicanalítica Britânica, em 7 de dezembro de 1960

Antes de começar a fazer minha contribuição, quero tomar claro que se eu soubesse o que se esperava de mim não teria concordado em falar nesta reunião. O trabalho do Sr. Sandler fornece um enunciado muito completo do tema do superego e um estudo apropriado dele tomar-me-ia muito mais tempo do que aquele que me foi concedido.

Acho o enunciado do desenvolvimento da idéia do superego na mente de Freud muito útil e fico sempre grato a quem quer que se dê ao trabalho de efetuar este tipo de pesquisa e desenvolver este tipo de conceito. Dele pode-se perceber que, embora Freud, mais que todas as pessoas, soubesse que muitas coisas estão acontecendo quando o superego afeta o id e quando o ego se acha em desacordo com o superego, ou em união com este, apesar disso ele estava falando em termos que parecem, a princípio, referir-se à vida consciente. Um paciente pode nos dizer, como recentemente me disse um rapaz de 20 anos, exatamente o tipo de coisas que Freud pôs por escrito e que são citadas por Sandler. Até certo ponto, esse rapaz de 20 anos estava influenciado pelo pensamento desta década, que é, naturalmente, muitíssimo influen-

1. O trabalho do Professor Sandler foi lido em uma Reunião Científica da Sociedade Psicanalítica Britânica em 7 de dezembro de 1960 e publicado em *The Psycho-Analytic Study of the Child*, vol. 15 (1960). Ele começa por um levantamento do desenvolvimento do conceito de superego no texto de Freud e prossegue demonstrando como o conceito alcançou complexidade através do trabalho de outros autores, em particular dos psicólogos do ego e também Klein, cujas opiniões sobre o desenvolvimento muito inicial de um superego e da culpa são examinadas com certo detalhe. Sandler acredita que os desenvolvimentos na psicanálise resultaram em um enfraquecimento do conceito de superego mediante uma "dissolução conceptual", em que o que anteriormente fora visto como conflito de superego tendia agora a ser percebido mais em termos de relacionamentos objetivos dentro da transferência. Na segunda parte do trabalho, Sandler busca, remontando, o desenvolvimento do superego desde o início da infância, reformular o conceito. Aqui ele enfatiza "a obediência [da criança pequena] às exigências dos pais e a submissão a elas" e "a identificação com os pais e a imitação destes" como meio de diminuir o insulto narcísico inerente à aceitação do Princípio da Realidade. Embora concedendo um "esquema pré-autônomo de superego" pré-edipiano, o autor, apesar disso, situa firmemente a cristalização do superego propriamente dito na resolução do complexo edipiano. Uma exposição mais recente das idéias de Sandler sobre o superego pode ser encontrada em seu livro *Da Segurança ao Superego* (London: Karnak; New York: Guilford Press, 1987; Porto Alegre, Artes Médicas, 1991). — Os Organizadores.

ciada pelo trabalho de Freud. Apesar disso, foi este próprio rapaz que elaborou, em uma auto-análise, ter ele em sua mente uma instituição que estava todo o tempo influenciando-o. Isto se achava parcialmente baseado na idéia do pai, e dos genitores em combinação, e aqui ele descobriu que podia manejá-lo através do desafio. Parte se achava baseado, no entanto, em um *self* analisante e observante muito pessoal, que estudava tudo o que estava acontecendo na vida dele e capacitava-o a passar por isso sem demasiado sofrimento. Isto podia ser chamado de superego, podia ser sádico e ele reconhecia que o seu próprio sadismo ingressara no sadismo do superego; reconhecia também a perversão masoquista, que era uma maneira de lidar com o superego sádico. Disse-me que tentara utilizar o superego sádico transformando-o na parte de si mesmo que abominava, que era um falso *self*. Não chamou isso de falso *self*, porque estava falando a sua própria linguagem. Falou de uma criança muito boa, que todos achavam que ele havia sido, mas que, como viera a perceber, não era de maneira alguma o seu *self*. Fora assombrado, por exemplo, pelo mito do *Doppelgänger*, e estava todo o tempo procurando o outro *self*, que apareceria no momento da morte, quando não mais estaria vivo para manter funcional a cisão. Aquilo de que padecia era a falta de espontaneidade, e a única maneira pela qual podia reconquistar essa espontaneidade que havia perdido era através do uso do álcool, o qual, durante alguma horas, lidaria com esse superego e liberaria sua espontaneidade, sua capacidade de estabelecer relacionamentos e de tentar alcançar a heterossexualidade. Tudo isto é superficial, contudo, ao pensar-se no que apareceria na análise do rapaz.

Deve ter sido de pacientes como este que Freud coligiu o material para o seu trabalho sobre o superego. Freud, contudo, estava interessado todo o tempo nos aspectos mais profundos desta questão, e quero sugerir que no resumo do Sr. Sandler ele não nos lembrou o suficiente do interesse de Freud pelos sonhos, pela realidade psíquica e pela fantasia. Sugiro que ele falou da vida do indivíduo de uma maneira tal que um leitor que chegue ao seu enunciado, sem um conhecimento anterior de Freud, pensaria que tudo acontece na mente, antes que na psique.

Acho impossível ir mais além no debate deste ponto sem referir-me ao tema que desenvolvi em meu artigo "A Mente e sua Relação com a Psique-Soma"², reunindo isto com o conceito de verdadeiro *self* e falso *self*. Referi-me a um falso *self* que vive através de uma mente ou uma vida intelectual que se tornou separada da psique-soma. Por muito que admire aqueles que podem considerar intelectualmente um conceito, estou sempre à espera de um fracasso por parte do analista em lidar com este problema do paciente que possui uma mente clara e que, contudo, não se encontra intimamente relacionada ao corpo em funcionamento, à psique e ao ego corporal. Acho que o Sr. Sandler encontra-se em perigo de referir-se demasiadamente a seres humanos em termos de uma fuga para a mente.

Tenho de agora referir-me à pergunta: devemos estudar o desenvolvimento dos pensamentos de Freud tal como expressos (ao final) sob o termo "superego", aceitar o que pensamos que Freud quis dizer e limitar o nosso emprego da expressão "superego" de maneira tal que não nos afastemos do que acreditamos ter sido a intenção de Freud? Por outro lado, devemos estudar idéias semelhantes e tentar arrastar o significado do conceito de superego para abranger outros fenômenos?

Tenho esperança de que, neste debate, os manifestantes não se atolem em um cabo-de-guerra entre aqueles que desejam manter puro o conceito freudiano de superego e aqueles que querem enriquecê-lo ou conspurcá-lo.

Quando falamos, sempre temos de estar lembrando a nós mesmos que um conceito não é uma coisa. Um conceito é uma maneira que utilizamos para falar a

2. 1949: em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London Hogarth Press, 1975).

respeito de uma coisa. Podemos usar uma palavra tal como "superego" de qualquer maneira que decidirmos e podemos escolher estudar Freud e empregar essa palavra tal como acreditamos que ele veio a usá-lo. Se fazemos isso, é simplesmente porque queremos uma linguagem comum. Em contraste, se tomarmos uma palavra tal como *self*, esta é uma palavra que faz parte da língua; tem sua história e o seu próprio significado, e não podemos andar sujando-a por aí. Essa palavra, *self*, pode ensinar-nos algo, mas não podemos alterar o seu significado, nem mesmo que queiramos fazê-lo. O Sr. Sandler foi bastante cuidadoso em seguir esta regra, mas mesmo ele comete um ou dois equívocos, referindo-se, por exemplo, ao superego como se fosse uma coisa, ao invés de um conceito sobre um fenômeno e um termo que concordamos em usar ao nos referirmos a esse fenômeno.

Eu diria que o cuidadoso enunciado que o Sr. Sandler faz do desenvolvimento do pensamento de Freud nos faria dizer que se Melanie Klein não houvesse existido, teríamos tido de inventá-la. Isto, acredito eu, se deve ao que descrevi como sendo a apresentação que o Sr. Sandler faz do caso freudiano, sem referências suficientes ao inconsciente e, talvez, à realidade interna não-verbalizada, o cerne do mundo onírico do indivíduo. Ao ler a obra de Freud, não fico com esta impressão de modo algum, porque embora Freud utilize a mente, os processos intelectuais e a parte verbalizada do sentimento, ele nunca nos deixa esquecer que está falando a respeito de fenômenos que têm suas raízes em material não-verbal. Desta maneira, no artigo do Sr. Sandler, ficamos sentindo falta de algum tipo de enunciado semelhante aos que Melanie Klein acaba por nos dar sobre uma realidade psíquica que se acha muito estreitamente relacionada ao corpo e ao funcionamento corporal. Teria pensado que o enunciado, pelo Sr. Sandler, das opiniões de Melanie Klein, poderia ser aceito.

Parecer-me-ia, portanto, que estamos falando sobre dois assuntos, e talvez pos-samos decidir ao final que eles são um só ou que gostaríamos de deixá-los como sendo dois. Estamos debatendo a idéia que Freud tinha do superego como sendo algo que pertence à passagem do complexo edípico; estamos também discutindo os elementos, mecanismos e fenômenos intrapsíquicos que datam do início da vida do indivíduo. Se decidirmos que, na saúde, existe uma construção gradual ao longo das linhas destes mecanismos intrapsíquicos, no sentido do que acaba por tornar-se o superego do conceito freudiano, então decidiremos que estamos todos nós debatendo um só problema. Podemos decidir deixar a questão em aberto, mas também podemos escolher (e eu, pessoalmente, não me importaria de modo algum se o fizéssemos) que estes mecanismos do funcionamento mental inicial não devem ser chamados de superego ou sequer receberem a dignidade da expressão "esquema pré-autônomo de superego".

Gostaria de dizer que acho muito importante que uma distinção seja traçada entre a idade pré-autônoma e a idade autônoma, se por isto entender que se está fazendo referência à dependência e à jornada gradual que vai da dependência para a independência. Da mesma maneira, fico impressionado pela importância de avaliar a qualidade subjetiva na visão que a criança tem dos pais e a qualidade da percepção objetiva. O Sr. Sandler considerou madura e claramente as diferenças existentes aqui.

Neste ponto, gostaria de passar para uma comparação dos elementos que, na conceptualização kleiniana, são chamados de elementos de superego (mas não precisam necessariamente ser assim chamados) e o superego clássico de Freud, que pertence à passagem do complexo edípico. Gostaria de fazer uma comparação em termos da análise de pacientes. Diria primeiro que a análise dos elementos de superego de Klein nos conduz de volta à vida instintual do indivíduo; é esta que determina no bebê e na criança pequena a construção de elementos benignos e apoiadores e de elementos persecutórios e perturbadores na realidade psíquica interna, embora também haja lugar para introjeções que, por assim dizer, contornam o viver instintual do indivíduo.

Em contraste, a análise do superego de Freud, que pertence à passagem do complexo edípico, leva-nos aos pais e ao efeito que a autoridade destes tem sobre a vida instintual da criança. À primeira vista, pareceria que há uma distinção muito grande entre estas duas maneiras de olhar para o mesmo fenômeno através das análises de indivíduos. No conceito de superego de Freud, porém, sobra lugar para as idéias da visão subjetiva dos pais, que introduz a idéia destes como projeções, assim como de seu uso e aceitação como os indivíduos que realmente são. Desta maneira, o trabalho da análise chega ao mesmo lugar nos dois casos, isto é, à vida instintiva tal como experienciada na transferência.

É necessário que tenhamos uma teoria que abranja o efeito, sobre a criança, da ausência de pais. Não se pode lidar com o desenvolvimento do superego na criança que vive sem autoridade parental e mora em uma comunidade em que as crianças encontram figuras de superego onde quer que se achem. Temos de levar em consideração o fato de que, no desenvolvimento sadio da criança sadia, há uma simplificação muito grande da totalidade do desenvolvimento do superego se a criança na realidade vive na família e tem acessíveis ambos os pais. Os pais reais, portanto, contribuem por serem reais, como o Sr. Sandler indica, ainda que a visão subjetiva deles possa ser o elemento principal na formação do superego do indivíduo. Desta maneira, e levando em consideração a realidade psíquica, a fantasia e o mundo onírico da criança, chegamos aos elementos pré-genitais que contribuem para a visão subjetiva dos pais. Juntamente com a consideração da vida instintual pré-genital estamos também na área dos objetos parciais, da dependência, dos mecanismos primitivos de defesa, da difusão dos instintos, etc.

Se tomarmos portanto o superego de Freud, que surge da passagem do complexo edípico, encontramos elementos que derivam da vida instintiva pré-genital e da fantasia pertencente àquelas áreas da experiência dos relacionamentos sub-humanos; na realidade, descobrimo-nos na própria área de que Melanie Klein trata. Com o que é que Melanie Klein contribui aqui, de modo especial? Minha própria maneira de dizê-lo a mim mesmo é que Melanie Klein referiu-se à fantasia que a criança tem de que a fantasia dele ou dela possui uma localização dentro do *self*, dentro da pele, dentro do ego corporal em funcionamento, na realidade, na barriga ou na cabeça. Filosoficamente, é claro, a fantasia que é pessoal ao indivíduo e que chamamos de realidade psíquica não possui localização. Na psicologia, contudo, e na saúde, é-lhe concedida uma localização pelo indivíduo, e as guerras entre os elementos benignos e os elementos persecutórios na realidade psíquica interna são travadas no corpo, assim como projetadas para fora do corpo. Em outras palavras, elas pertencem a todo o esquema corporal do indivíduo, mas o lugar real de origem dos conflitos encontra-se dentro do indivíduo, ou seja, na fantasia deste. O ponto ora em debate, na realidade, só tem a ver com esta área intermediária de nosso processo de pensamento sobre o assunto, esta questão da fantasia da criança de que a sua fantasia pessoal acha-se dentro, a menos que seja projetada. Na análise do superego freudiano, exatamente como na análise das ansiedades hipocondríacas e das projeções correspondentes nos casos paranóides, o que em última análise faz diferença para o paciente é o surgimento da vida instintiva na transferência. É aqui onde se dá uma união da análise das ansiedades hipocondríacas kleinianas e da análise do superego freudiano; todos são em última análise remontados, na análise, à vida instintual do indivíduo. Apenas o conceito kleiniano levanta a questão de que os pais reais têm autoridade, se existem e desempenham seu papel, e corretamente dá ênfase a este aspecto da formação do superego. Contrariamente, o conceito kleiniano sublinha os elementos do superego que não necessariamente chegam ao ponto de desenvolvimento em que podem tornar-se totais e humanos. Certamente, é apenas na saúde que o superego clássico pertencente à passagem do complexo edípico pode ser observado. Por saúde quero

dizer que o desenvolvimento emocional do indivíduo se deu de modo satisfatório nos estágios mais iniciais de dependência, que a família existe e que os pais se acham presentes, a desempenharem sua parte de maneira razoavelmente boa. É um grande alívio para uma criança ser capaz de experienciar as ansiedades que pertencem ao complexo edípico. Temos de dizer: esta criança se acha suficientemente bem para ser uma pessoa total entre três, experienciar a situação triangular e ser capaz de elaborar, na presença dos pais, tudo o que se quer dizer por passagem do complexo edípico e estabelecimento de um superego que tem um certo relacionamento com os pais, tal como percebidos, e com os pais, tal como concebidos. Um número muito grande de crianças jamais tem este alívio. O que acontece em casos desse tipo não é que não haja superego, mas que a formação do superego nunca se torna humanizada e continuará tal como o politeísmo antes do monoteísmo. Acontece então que é como se existissem forças e instâncias mecanicistas que são temidas e que devem ser magicamente controladas, e que, certamente, não podem ser desafiadas. Todo tipo possível de mecanismo assustador pertence à falta de saúde nesta área. Na saúde, a criança pode (certamente) desenvolver uma psiconeurose, mas apesar disso, ela possui o grande alívio de um superego que se acha relacionado com seres humanos de fato, o pai e a mãe. A análise pode tirar vantagem disto. Esses seres humanos podem ser amados e odiados, obedecidos e desafiados, da maneira comum que é bem-conhecida.

Tenho de ajustar minhas opiniões teóricas à experiência que tive em meu segundo caso de criança, a análise fácil e bem-sucedida de uma menina de 2 anos e meio de idade, que era o que eu chamaria de normal. Ela tinha uma grave inibição alimentar e isto começara em seu primeiro aniversário, quando pela primeira vez fizera uma refeição na mesa junto com os pais. Ela estendeu a mão, retraiu-se e assim começaram os seus sintomas principais. A análise (dos 2 e meio aos 3 anos e meio) foi em grande parte uma encenação da cena primitiva em termos desta refeição, com ambos os pais devorando a criança, e, no lugar da inibição, apareceu um desafio extremado, um comer os pais e uma virada amiúde repetida da mesa que era o mundo dela. Gradualmente, a identificação com cada um dos pais forneceu alívio. Incidentalmente, como mãe ela era sádica com as suas bonecas e também sádica como professora, ainda que os pais fossem muito tolerantes e ela própria não tivesse problemas com referência a manter-se seca e limpa.

Esta criança, por que era normal, quase empregou os pais reais em lugar de elementos mais primitivos de superego aos 2 anos e meio de idade. Com minha ajuda e apoio analítico, ela rapidamente, dos 2 e meio aos 3 anos e meio, tornou-se capaz de desafiar e de virar a mesa, de identificar-se e até mesmo de obedecer. Ela possui hoje dois filhos saudáveis, nascidos em santo matrimônio!

Em uma grande proporção de nossos casos, os mecanismos primitivos da realidade psíquica interna não obtêm um alívio desse tipo e é preciso que façamos a análise dessas ansiedades hipocondríacas ou de suas projeções. Com frequência, o enunciado delas acha-se avançado demais e o nosso auxílio é necessário para a administração de ansiedades ainda mais primitivas (ou psicóticas), quando a criança precisa tornar-se altamente dependente e manifestar uma transferência delirante.

Embora eu discorde de quatro ou cinco pormenores do que entendo ser a teoria total da Sra. Klein, dou-me conta de quanto aceito a teoria dela quando leio a alternativa do Sr. Sandler. Quanto a meu próprio trabalho, fui a figura de proa do movimento no sentido de um reconhecimento da *satisfação da necessidade* como mais inicial e fundamental que a realização de desejos, e tentei fazer com que a palavra "internalização" fosse usada para designar a elaboração imaginativa da função corporal, enquanto reservava "introjeção" para o processo mágico que pode ocorrer separadamente do comer.

Escrevi, também, com grandes detalhes sobre a correspondência existente entre o comportamento da mãe e a "imagem interna da mãe psicoenergeticamente investida". Para examinar apenas um dos pontos: quando a conduta da mãe não corresponde de fato à imagem interna da mãe psicoenergeticamente investida, a criação não "experimenta frustração, desprazer e raiva" (...); o que acontece é que ela tende a perder a capacidade de relacionar-se com objetos. Se a capacidade de sentir raiva é mantida, as coisas não são tão ruins.

Uma frase importante é: "É em grande parte através da instância dos pais que o princípio da realidade substitui o princípio do prazer". Sim, mas os pais não agem pela introdução de sua idéia do mundo real à criança; eles o fazem adaptando-se suficientemente bem às necessidades dela, e, depois, por um fracasso graduado em adaptar-se. Tudo isto precede a introjeção, a identificação e a imitação. Havendo-se tornado estabelecida a capacidade de relacionamentos objetivos, a criança pode então progredir para coisas tais como a obediência, o desafio e a identificação. Observo que o Sr. Sandler deixa de fora o desafio. Fala ele da necessidade que a criança tem de sentir-se amada, mas ela deve também sentir-se real e, se o desafio é omitido do esquema e a criança apenas obedece ou identifica-se, ela mais cedo ou mais tarde queixar-se-á da falta de sentir-se real.

Entretanto, talvez podendo encontrar algum valor na idéia das funções "representativas" e "orientadoras" das introjeções, a crescerem até chegar à formação do superego humano que se relaciona com a passagem do complexo edípico em crianças que são sadias e que chegam até esse ponto.

Nas páginas seguintes existem enunciados que precisam ser examinados. Discordo de muitos dos detalhes e encontro uma simplificação excessiva do tema. Exemplificando, a identificação com o agressor faz parte de um processo complexo: (1) introjeção, (2) controle, (3) ameaça de ser controlado por ele (identificação), e (4) tendência a reprojeter, etc. O Sr. Sandler relaciona isto à reação à perda. Ao lidar com a perda, a criança (1) introjeta, (2) sujeita o introjeto a agentes destrutivos (um humor deprimido indica uma identificação com um introjeto morto), e (3) libera o introjeto para que reviva de novo, após um gasto suficiente deste ódio voltado para dentro. Os dois processos me parecem ter pouco em comum.

Ao chegar ao fim, faço simplesmente uma anotação: o que foi feito da fantasia? Talvez se ache lá, mas esteja perdida, tal como a moeda que se esconde no pudim de Natal.

Há uma citação final de Freud, em que este fala sobre a saúde e presume existir no indivíduo uma capacidade de identificação com pessoas totais. Isto deixa de lado, contudo, o crescimento do superego a partir dos elementos que pertencem à vida primitiva de dependência extremada, na qual existem apenas objetos parciais.

Sigmund Freud

Resenha de *Letters of Sigmund Freud, 1873-1939*¹

1962

Pode-se com segurança dizer que Freud, quando jovem, jamais ouvira falar de psicanálise, e, também, que nunca estivera, sequer indiretamente, sob a influência dela. Suas cartas íntimas à noiva, Martha Bernays (a primeira centena, pouco a mais ou a menos, desta coleção), dão-nos, a nós que valorizamos Freud por sua contribuição à ciência e à terapêutica, uma nova oportunidade melhor ainda do que a que nos foi concedida pela biografia de Jones, de julgar Freud como homem. Revela-se ele um ser humano humano? Estas cartas fornecem uma resposta.

Freud nasceu em 1856 e noivou com Martha, então com 21 anos, quando contava 26 anos de idade, em 1882. Temos sorte em saber tanto sobre este jovem médico quando ele se achava apaixonado. Como tal, ele apresenta todos os sinais costumeiros, de maneira que quem quer que tenha sido similarmente afetado deve rapidamente identificar a afeição.

Descobrimos que ela guarda uma lealdade dupla e dirige-se à "majestosa ciência" do seguinte modo: "Sua Alteza, permaneço sendo o seu humilde e muito devotado servo, mas por favor, não use isto contra mim; Sua Alteza nunca me olhou com bondade, jamais me dirigiu uma palavra de conforto; não me respondeu quando lhe escrevi ou escutou quando lhe dirigi a palavra, mas conheço outra dama para quem signifique mais que para Sua Alteza, que paga cada serviço meu multiplicado por cem e que, ademais, tem apenas um servo e não, como Sua Alteza, milhares deles. Entenderá Sua Alteza que eu agora me devoto a esta outra dama que tão pouco me pede e é tão graciosa. Mantenha-me em benevolente lembrança até que eu retorne à Sua presença. Tenho de escrever para Martha" (p. 29). Martha parece ter aceito este fato da lealdade dupla. Em data posterior, Freud refere-se à própria ambição de Martha e é de supor-se que esta encontrou plena realização no sucesso final de Freud, mas pode-se perceber quão facilmente o trabalho científico dele poderia ter sido destruído houvesse Martha necessitado de uma satisfação mais imediata para as suas ambições.

Naqueles primeiros dias, Freud reuniu em torno de si um pequeno grupo social composto do irmão de Martha, do noivo da irmã dela e de alguns de seus próprios amigos. Este grupo era chamado de *Bund* e fica-se pensando se seria possível relacio-

1. London: Hogarth Press, 1961. Esta resenha apareceu no *British Journal of Psychology*, 53 (1962).

nar esse grupo social com o *Bund* [liga, união] posterior, o profissional, composto de certos colegas que o ajudaram a formar uma sociedade psicanalítica.

Estas cartas mostram como Freud, muitíssimo um judeu, tinha uma necessidade e talvez uma tendência a encontrar, dia-a-dia, o meio ambiente em que poderia ter liberdade, liberdade de ser ele próprio e liberdade de desenvolver-se à sua própria maneira. Desse modo, como adulto, ele foi notavelmente independente talvez por causa desta sua própria dependência de um grupo, um grupo sempre mutante, um grupo que, em última análise, dependia por sua vez, em qualquer momento determinado, da própria escolha de Freud, e de sua tolerância e intolerância.

Mas Freud tinha oculto em si um potencial espantoso. É verdade que escreveu, com evidente sinceridade: "Considero um grande infortúnio que a Natureza não me tenha concedido aquele algo indefinido que atrai as pessoas. Acredito ter sido essa falta, mais do que qualquer outra, que me privou de uma existência rósea. Tomou-me tanto tempo conquistar meus amigos. Tive de lutar tanto por minha preciosa garota, e a cada vez que encontro alguém dou-me conta de que um impulso, que desafia análise, leva essa pessoa e me subestimar" (p. 211). E também, a respeito de si mesmo: "(...) que é ainda jovem e, contudo, nunca se sentiu jovem" (p. 138). E ainda "(...) em minha juventude nunca fui moço e, agora que estou entrando na idade da maturidade, não posso amadurecer corretamente" (p. 214). Mas ficou contente que Breuer houvesse dito: "(...) oculto sob a superfície da timidez, reside em mim um ser humano extremamente ousado e destemido. Sempre pensei assim, mas nunca me atrevi a falar a ninguém. Com frequência senti-me como se houvesse herdado todo o desafio e todas as paixões com que os nossos ancestrais defenderam seu Templo e alegremente sacrificaria minha vida por um só grande momento na história" (p. 215). Em complementação a isto, podia fazer uma declaração definida, tal como a contida em sua carta dirigida à Barbara Low, após o falecimento de David Eder: "Éramos ambos judeus e sabíamos, um quanto ao outro, que portávamos em comum aquela coisa miraculosa que — inacessível a qualquer análise, até o presente — faz o judeu" (p. 424). (A propósito, ele ao final tentou chegar atrás dessa própria coisa, quando apresentou a tese de que Moisés, o egípcio, inventara o judeu.)

Dessa maneira, obtemos das cartas o retrato de um homem a estabelecer o fato pessoal: *sou*, e certamente é esta a razão para as ansiedades que são frouxamente chamadas de paranóides e que levam à necessidade que um homem tem de conseguir um círculo de amigos, tanto como defesa contra todos os outros que estão jogando o jogo vital "Eu Sou o Rei do Castelo", quanto, de maneira positiva, como um grupo de pessoas que é seguro amar. Esta parece ser a tarefa da metade masculina na divisão mítica de Platão, e corresponder à tarefa complementar da metade feminina, que é formar um círculo em torno do recém-concebido.

Foi neste padrão que Martha evidentemente encaixou-se bem. Ela manteve a posição de ser a outra metade de Freud, que era, por natureza, o verdadeiro oposto do promíscuo. Talvez este fato isolado, mais do que qualquer outro, tenha dado a Freud o direito de espantar e perturbar a mente do mundo e tornado possível o lançamento de naves tais como o Inconsciente Dinâmico, a Sexualidade Infantil, o Complexo de Édipo, a Realidade Psíquica, e muitas outras que provaram ser não vapores de turismo, mas encorajados na guerra pela Verdade.

Para Freud, certamente, esta união feliz com Martha até certo ponto resolveu seu problema pessoal de bissexualidade. Referiu-se a ela como Cordélia e, assim o fazendo, descobriu-se muito contente no mesmo barco que Breuer (p. 55, 56). Mas certamente isso deixa a nós descobrir o lugar de Goneril e Regan. Lear teve de padecer as maquinações de suas primeira e segunda filhas (com ambivalências sexuais) antes de poder chegar à essencialmente feminina Cordélia: "Sua voz era sempre suave, gentil e baixa, coisa excelente em uma mulher".

Se Freud alcançou esta simplificação em sua vida através do meio legítimo de um casamento feliz, ele também nos forneceu o instrumento, a técnica psicanalítica, com o qual poderíamos ir mais à frente na questão do temor à MULHER, tal como ela pode ser no inconsciente de qualquer pessoa, homem ou mulher.

As últimas cartas de Freud à Martha antes de seu casamento estão evidentemente faltando. O leitor subitamente descobre Freud escrevendo à sogra, relatando a chegada de um bebê. Ele sofrera durante o nascimento, como os homens sofrem, e agora já se acha amando muitíssimo a sua meninazinha, que está apenas com cinco horas de idade. Relata ele, como bom aluno em observação de bebês: "Ela pesa quase 3,5 kg., o que é bastante respeitável, parece terrivelmente feia, esteve sugando a mão direita desde o primeiro momento, sob outros aspectos parece ter boa disposição e comporta-se como se realmente se sentisse em casa aqui. Apesar de sua esplêndida voz, não chora muito, parece muito feliz, fica deitada bem-abrigada em seu magnífico carrinho e não dá qualquer impressão de achar-se perturbada por sua grande aventura" (p. 233).

Tudo isto parece muito natural e normal e constitui um pano de fundo apropriado para as outras cartas que gradualmente conduzem ao território que já foi explorado por Jones.

Encontrei uma riqueza imensa neste livro e no *insight* que ele nos dá da personalidade de um homem tão notável. Freud podia falar a respeito de conceder "livre ação a todas as fontes de minha irresponsabilidade" (p. 175); podia escrever: "(...) no âmago, sou ainda uma criança; posso ficar feliz simplesmente porque estou em outro lugar e tenho uma moeda diferente em meus bolsos" (p. 92). Podia rir uma noite inteira de uma apresentação romana de *Carmen* (p. 275); lendo *Dom Quixote*, podia estourar de rir (p. 59) e, ao receber uma carta de Martha, escreveu: "Pulei de alegria — nunca perco a oportunidade de fazer este exercício se existir a menor razão para ele" (p. 111).

E depois, seriamente, ao responder a carta de um amigo que havia sofrido a perda de um filho, e no aniversário da perda de sua filha do meio, Sophie, escreveu: "Embora saibamos que após uma perda desse tipo o estado agudo de luto diminuirá, sabemos também que permaneceremos inconsoláveis e nunca encontraremos um substituto. Não importa o que possa vir a preencher a lacuna; mesmo que ela seja completamente preenchida, apesar disso permanece algo mais. E, na realidade, é assim que deve ser, pois essa é a única maneira de perpetuar esse amor que não queremos abandonar" (p. 386).

Por fim, e as idéias de Freud a respeito da grandeza nos homens? "Tampouco tive grande interesse pela espécie como um todo. Sempre me pareceu que a crueldade e a autoconfiança arrogante constituem a condição indispensável para o que, quando alcança êxito, nos impressiona como grandeza, e também acredito que se deveria diferenciar entre grandeza de realização e grandeza de personalidade" (p. 295-296).

Pode-se reivindicar, com prova nestas cartas, que Freud foi humano, um homem de profundos sentimentos e que já é geralmente reconhecido como grande em realização. Pode ser que dele se possa dizer ter sido grande também em personalidade.

Harold F. Searles

*Resenha de The Non-Human Environment
in Normal Development and in
Schizophrenia*¹

1963

As idéias, tal como a Palavra, podem cair em solo pedregoso, ou serem recebidas em terreno bom e produzirem frutos. Uma idéia original precisa de uma audiência e a boa audiência consiste daqueles que já tiveram a idéia: eles ficam contentes por a verem formulada, e zangados também por haver sido perdida uma oportunidade de reivindicar prioridade. Dessa maneira, é difícil de avaliar e atribuir a originalidade, e cada criador, até certo ponto, é um copista.

Gosto de fazer parte da audiência, parte do solo bom que faz este trabalho de Searles produzir frutos. A idéia de um estudo do meio ambiente não-humano é correta e há muito tempo esperada nos círculos psicanalíticos. Searles examina por que foi que houve esta longa demora e, em verdade, pode esperar que analistas fiquem desconfiados de qualquer tendência que desvie a atenção quanto à teoria dos relacionamentos objetivos, com o objeto sendo humano, ou um objeto parcial à espera de que se lhe permita tornar-se total. Essa desconfiança provém do desenvolvimento da teoria psicanalítica, com base no id contido pelo ego e controlado pelo superego, ou do ego orientado tanto para o id quanto para a realidade externa, e permanentemente engajado na reconciliação destas duas realidades. Quando os psicanalistas sentiram-se suficientemente seguros para explorar a psicologia do ego e a capacidade de relacionamento [*ego-relatedness*] do ego, ganhou-se um novo *insight* do significado da dependência infantil e também das necessidades daqueles pacientes esquizofrênicos que conduzem, juntamente com sua doença, uma tendência no sentido de um desenvolvimento emocional sadio, ainda que retardado.

Searles dedicou um livro inteiro, e um livro muito interessante, a este tema do relacionamento do homem com o meio ambiente não-humano — com o cão como cão, independentemente de seu simbolismo, e com o mundo físico separadamente de seu significado como mãe ou como um lugar de receber projeções. Poder-se-ia talvez dizer que quando Sechehaye deu aquela maçã àquela menina naquele momento particular (realização simbólica), Searles chama a nossa atenção para o fato da maçã, que, presumivelmente, achava-se apropriadamente madura, e também para os pomares

1. New York, *International Universities Press*, 1960. Esta resenha apareceu no *International Journal of Psycho-Analysis*, 44 (1963). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.

donde as maçãs provêm, e para o acesso de Sechehaye aos produtos dos pomares, e assim por diante.

O tema certamente desenvolve-se de modo muito fácil, uma vez se tenha iniciado sua consideração, e mesmo que a idéia subjacente ao que está escrito possa ser separada e examinada aqui, é a leitura real do livro que recompensará o leitor.

Com referência à idéia, grande parte de meu próprio trabalho esteve relacionado com esse tema. Não tive temor de que a teoria do desenvolvimento individual pudesse sofrer interferência por causa do reconhecimento do papel desempenhado pelo meio ambiente fora da área das projeções do indivíduo. Somos aqui lembrados da área livre de conflitos do ego, de Hartmann, que de maneira alguma interfere com o conceito de conflito e ansiedade.

Poder-se-ia achar que o meio ambiente não-humano de Searles vem a equivaler no final à mãe, mas de uma maneira diferente da usual, em que os fenômenos ambientais são vistos como projeções e projeções de introjeções. Quero dizer que este meio ambiente não-humano pode ser encarado como uma extensão do meio ambiente que é a mãe, anteriormente à chegada do bebê aos relacionamentos objetivos, com investimentos psicoenergéticos do id. Desenvolvi este tema em termos de capacidade ou qualidade de relacionamento do ego, e em termos de dependência dupla. Por esta última quero significar o relacionamento do bebê com fenômenos ambientais de que o bebê não tem possibilidade de estar ciente, de maneira que, mais tarde, o bebê agora chegado à infância ou ao estado adulto não é capaz de reproduzi-lo como um padrão a revelar-se em uma transferência analítica. Em outras palavras, o meio ambiente a que me refiro no conceito de dependência dupla é um ambiente que, essencialmente, não é constituído de projeções. Mais tarde, o indivíduo pode chegar a um reconhecimento disto em uma aceitação sofisticada da realidade "partilhada". Esta aceitação do princípio da realidade é uma questão do intelecto.

Dessa maneira, um pouco do meio ambiente não-humano de Searles é humano, um pouco é animal, outro tanto é vegetal e um pouco é puramente físico. A força de gravidade é um elemento do meio ambiente não-humano que distingue o período que segue o nascimento do período pré-natal; do lado positivo, a criança sabe disso pela sensação de sentir-se pesada; do negativo, o bebê vem a conhecer a gravidade indiretamente, através do pânico infinito que se acha associado com ser segurado de maneira inconfiável. Foram necessários um Newton e milhares de anos de refinamento para que o conceito de gravidade fosse formulado, e todo o tempo, na observação de bebês em desenvolvimento, vemos os efeitos de detalhes ambientais não-humanos, que amiúde nunca atingem o *status* de enunciado. Searles está tentando, creio eu, efetuar um enunciado generalizado, um enunciado que abranja desenvolvimentos futuros, tal como, por exemplo, a possibilidade de que um dia a psicologia possa contribuir para a física com referência a algum detalhe.

Concordaria Searles com uma mudança de nome? Parece que a sua expressão não é suficientemente boa, porque o seu meio ambiente não-humano pode bem ser humano, tal como a cor dos cabelos da mãe, o fato da sobrevivência ou morte dela, a profissão do pai, que pode ser um mineiro e chegar preto em casa, ou um padeiro, e a esta retornar branco. Penso que Searles está se referindo ao meio ambiente não projetivo, ou a todos aqueles aspectos do meio ambiente do indivíduo que na realidade têm efeito ou com ele colidem antes que o bebê individual esteja pronto para conquistar o controle da realidade externa através dos mecanismos de projeção e introjeção.

A afinidade existente entre o ponto de vista de Searles e o meu pode ser facilmente ilustrada. Exemplificando (p. 416): "O paciente profundamente regredido, mais do que qualquer outra pessoa exceto o bebê, precisa ter um meio ambiente não-humano que seja não apenas relativamente estável e pouco complexo, mas também belo". Deixando de fora o detalhe da beleza, que introduz considerações mais com-

plexas, acho esta idéia de um meio ambiente não-humano relativamente estável e pouco complexo, quase a mesma coisa que a minha própria insistência na maternagem suficientemente boa, sem a qual o desenvolvimento que contribui para a saúde mental (no sentido de ausência de tendência à psicose) não pode se dar de modo satisfatório. Este é o meio ambiente não-humano que com efeito é a mãe, a mãe e o pai, a família, o lugar, a afetar o bebê antes da era do controle através da projeção e da introjeção.

A unicidade inicial do estágio que precede a separação, pelo bebê, entre mãe e *self*, aquilo que aparece na enfermidade psicótica como uma fusão, é uma unicidade, não com uma pessoa, nem, tampouco, com um objeto; trata-se de uma unicidade com o meio ambiente não-humano ou, como eu gostaria de chamá-lo, um meio ambiente não-projetivo. Desta maneira, o estudo de Searles é de grande importância para a compreensão das necessidades do esquizofrênico e também dos fenômenos que se acham a operar silenciosamente na maternagem comum suficientemente boa.

Searles, contudo, pode preferir apegar-se à sua expressão "meio ambiente não-humano" e dessa maneira concentrar-se na referência ao fato de que, no processo de vir a controlar a realidade externa através da introjeção e da projeção, o bebê em desenvolvimento (ou o paciente regredido) fica dependente de que realidade externa de fato exista, para uso no exercício destes mecanismos mentais.

C. G. Jung

Resenha de *Memories, Dreams, Reflections*¹

1964

A publicação deste livro proporciona aos psicanalistas uma oportunidade, talvez a última que terão, para chegar a um acordo com Jung. Se fracassarmos em fazê-lo declaramo-nos sectários autoproclamados, sectários de uma falsa causa.

Jung foi um ser, uma pessoa real, uma pessoa que aconteceu viver na época de Freud e que inevitavelmente encontrou Freud. O impacto de seu encontro fornece material para um estudo sério e o modo de sua separação é não menos interessante para o estudioso da natureza humana. Os psicanalistas podem escolher alinhar-se com Freud, e medir Jung contra ele, ou examinar Jung e examinar Freud, e permitir que os dois se encontrem e sigam juntos ou se separem. No último caso, eles têm de conhecer o seu Jung, e o valor deste livro é que ele nos permite conhecer Jung quando ele ainda se achava inteiramente inafetado por Freud e por todas as suas obras.

Por "este livro" quero significar as primeiras 115 páginas. Estes três primeiros capítulos são autobiografia genuína. Temos aqui uma autobiografia que merece assumir seu lugar com as outras autobiografias realmente convincentes; não se fica em dúvida a respeito do valor destes capítulos como um enunciado verdadeiramente auto-revelador. Minha resenha versará sobre estes importantes capítulos e, principalmente, o primeiro deles: "Primeiros Anos".

Estou certo de que *todo psicanalista deve ler* estes três primeiros capítulos e, dessa maneira, encontrar Jung tal como ele era, e de que nenhum analista que tenha deixado de lê-los acha-se qualificado para falar ou escrever a respeito de Jung e Freud, de seu encontro e de seu fracasso final em entender-se mutuamente.

Ao examinar estes primeiros detalhes da vida de Jung, coloco-me na categoria das pessoas que, nas palavras de Jung: "sempre me lembram aqueles otimistas girinos que se aquecem em uma poça ao sol, na mais rasa das águas, reunindo-se e amigavelmente meneando as caudas, totalmente não-cientes de que na manhã seguinte a poça terá secado e os deixado encalhados" (p. 28). Apesar disto, tenho de ir em frente utilizando o rico material trazido por Jung, a fim de olhar mais de perto o homem que Jung pretendia ser e, depois, foi.

1. London: Dollins and Routledge, 1963. Esta resenha apareceu no *International Journal of Psycho-Analysis*, 45 (1964). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.

Jung, ao descrever-se, fornece-nos um quadro de esquizofrenia de infância, e, ao mesmo tempo, sua personalidade demonstra uma força de um tipo tal que o capacitou a curar-se sozinho. Custosamente, ele se recobrou, e parte do que isso custou para ele é o que ele nos pagou, se pudermos escutar e ouvir, em termos de seu excepcional *insight*. *Insight* do quê? *Insight* dos sentimentos daqueles que são mentalmente cindidos.

Neste estágio, tenho de pedir ao leitor que compreenda que não estou depreciando Jung por etiquetá-lo como "um caso recuperado de psicose infantil". Posso ser um "girino amavelmente não-ciente de meu destino", mas não estou sujando a personalidade ou o caráter de Jung. Se quero dizer que Jung era louco e se recuperou, não estou fazendo nada pior do que faria se dissesse de mim mesmo que era sadio e que, através da análise e da auto-análise, alcancei uma certa medida de insanidade. A fuga para a sanidade, de Freud, pode ser algo que nós, psicanalistas, estamos tentando nos recuperar, tal como os junguianos estão tentando recobrar-se do "self dividido" de Jung e da maneira pela qual este lidou com ele.

De certa maneira, Jung e Freud revelam-se complementares; eles são como a cara e a coroa de uma moeda; podem perceber, quando conhecemos Jung, como podemos fazer agora, porque não foi possível a ele e a Freud chegarem a um acordo mútuo naqueles primeiros anos do século, aqueles anos iniciais em que Freud estava lutando para estabelecer uma ciência que pudesse gradualmente expandir-se, e Jung estava iniciando o "conhecer", mas dificultado por sua própria necessidade de buscar um *self* com o qual pudesse conhecer. Ao final de uma longa vida, Jung chegou ao centro de seu *self*, que se revelou um beco sem saída, e, comparado com isto, podemos preferir os tateios de Freud e o seu fracasso gradual em finalizar algo, exceto que ele havia posto em movimento um processo que nós — e todas as gerações futuras — podemos utilizar para terapia, que é uma pesquisa da natureza do homem, e para pesquisa, que é uma terapia do homem.

Permitam-nos dizer isto a respeito do relacionamento entre Freud e Jung: eles tinham de encontrar-se, mas Freud não poderia ter ido até Jung em busca de análise porque Freud inventara a psicanálise, e, também, Freud precisava deixar de lado a área da insanidade a fim de passar adiante com a aplicação dos princípios científicos ao estudo da natureza humana, e Jung não poderia ter feito análise com Freud porque, na realidade, Freud não poderia ter feito esta análise, que teria envolvido aspectos da teoria psicanalítica que apenas agora, meio século depois, estão começando a emergir como um desenvolvimento da metapsicologia psicanalítica. Em outras palavras, estes dois homens, cada um deles possuído por um *daimon*, só podiam encontrar-se, comunicar-se sem uma compreensão básica, e, então, separar-se. O modo de encontro e de separação é de interesse, mas de pouca significância.

A melhor maneira de eu contribuir para uma consideração deste livro é fazer um estudo preliminar do primeiro capítulo. Deve-se recordar, contudo, que quando uma autobiografia se acha sob exame, nenhum comentário pode suplantar a experiência real de ler. Só posso comunicar-me com aqueles que leram o enunciado do próprio autor e já o absorveram.

Por causa de meus interesses especiais, posso contribuir mais para os primeiros capítulos do que para os últimos, e chego ao primeiro deles, "Primeiros Anos", com uma teoria precisa e detalhada do bebê e com uma considerável experiência clínica de todos os diversos tipos de observação, direta e indireta, que constituem o estofado da prática da psiquiatria infantil. Naturalmente, fico excitado em descobrir esta fonte excepcionalmente rica.

As primeiras lembranças de Jung são de uma consciência [*consciousness*] de beleza e felicidade e elas mostram a introdução deste filho único (nasceu-lhe uma irmã quando já contava nove anos de idade) ao mundo da beleza por parte daqueles que dele cuidavam. Há um lado negativo a este tipo de experiência positiva dos

sentimentos, que, ao final, temos de tentar descobrir. Ele revelará ser uma distorção das tendências integrativas, secundária ao fracasso materno da mãe por causa de sua própria enfermidade.

Aos quatro anos de idade, a doença psicótica de Jung acha-se estabelecida e defesas que viriam a durar a vida inteira serviram-lhe bem; é notável que, ao final, ele tenha podido entender a sua própria psicose tão profundamente quando o faz nesta autobiografia.

Declarei alhures² ser na área da psicose, antes que na da psiconeurose, que devemos esperar encontrar cura pela autocura. Jung fornece um exemplo disto, mas naturalmente, a autocura não é o mesmo que a resolução pela análise.

Antes dos quatro anos Jung havia sofrido o colapso que é subjacente à organização de um padrão de defesa. Isto foi recordado como uma época em que o pai o conduzia consigo e cantava para ele. Estava sofrendo, pensa Jung, de um eczema generalizado, e relaciona esta moléstia ao alheamento entre os pais, que estava tomando forma nessa ocasião. Em outras palavras, ele se achava ameaçado por uma desintegração do ego (uma despersonalização), uma inversão dos processos de amadurecimento, e suas defesas estabeleceram-se em uma cisão da personalidade, relacionada, em um dos níveis, à separação dos pais. Podemos imaginar que, no caso de Jung, a cisão não constituía uma fraqueza herdada do ego, se existir isto, e não inteiramente um fracasso primário em atingir *status* unitário em estágios iniciais de desenvolvimento emocional, mas que se tratava de uma defesa organizada em uma ocasião de dependência da união dos pais. Há evidências de um fator externo mais inicial, a saber, a depressão materna, que afetou a primeira infância dele e forneceu o lado negativo das qualidades positivas que projetara para a paisagem, para as coisas e para o mundo. Sua lembrança mais primitiva não é da mãe. Fez uso, contudo, de mulheres que não eram a sua mãe, e uma dessas mulheres constituiu a base para sua concepção de sua própria *anima*. (Para mim, a *anima* é a parte de qualquer homem que pudesse dizer: "Sempre soube que era uma mulher".)

Jung consegue relatar um importante sonho, que fornece o padrão de sua vida e trabalho. Isto é Jung verdadeiro, e é legítimo construir sobre isso teorias tentativas das dificuldades pessoais dele e de sua maneira de lidar com essas dificuldades.

Tive o sonho mais antigo que posso lembrar, um sonho que deveria preocupar-me toda a minha vida. Tinha então entre três a quatro anos de idade.

O vicariato erguia-se de modo bastante isolado perto do castelo Laufen, e havia um grande prado, a estender-se desde a fazenda do sacristão. No sonho, eu me achava nesse prado. Repentinamente descobri no chão um buraco escuro, retangular, alinhado por pedras. Nunca o havia visto antes. Avancei correndo, com curiosidade, e espiei para dentro dele. Vi então uma escadaria de pedra que conduzia para baixo. Hesitante e temeroso, descí. No fundo havia um vão de porta, com uma arcada arredondada, fechado por uma cortina verde. Era uma cortina grande e pesada, de um material trabalhado semelhante ao brocado, e parecia muito suntuosa. Curioso por ver o que poderia achar-se oculto atrás, puxei-a para o lado. Vi à minha frente, à luz, uma câmara retangular de cerca de dez metros de comprimento. O teto era arqueado e de pedra talhada. O chão era coberto por lajes e, em seu centro, um tapete vermelho ia desde a entrada até uma plataforma baixa. Sobre esta erguia-se um trono dourado maravilhosamente ornado. Não tenho certeza, mas talvez um coxim vermelho repousasse sobre seu assento. Era um trono magnífico, um real trono de rei de conto de fadas. Algo se erguia nele, que a princípio pensei que fosse um tronco de árvore de três e meio ou quatro metros e meio de altura, com 45 a 60 centímetros de espessura. Era uma coisa

2. *Metapsychological and Clinical Aspects of regression within the Psycho-Analytical Set-Up* (1954), em *Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis* (London: Tavistock, 1958; New York: Basic Books, 1975; London: Hogarth Press, 1975).

imensa, que chegava quase até o teto, mas tinha uma composição curiosa: era feita de pele e pele nua, e, em seu topo, havia algo semelhante a uma cabeça redonda, sem rosto e sem cabelos. Exatamente no topo da cabeça havia um único olho, a olhar imóvel para cima.

Estava bastante claro na sala, embora não houvessem janelas, nem, tampouco, fonte aparente de luz. Por cima da cabeça, contudo, havia uma aura de brilho. A coisa não se moveu, mas no entanto, eu tinha a sensação de que ela poderia a qualquer momento rastejar para fora do trono como um verme e arrastar-se em minha direção. Fiquei paralisado de terror. Nesse momento escutei, do lado de fora e acima de mim, a voz de minha mãe. Ela gritou: "Sim, apenas olhe para ele. Esse é o comedor de homens!" Isso intensificou o meu terror ainda mais e acordei suando e morto de susto. Por muitas noites, depois, tive medo de ir dormir, por temer que pudesse ter outro sonho semelhante a este.

Neste estágio, já podemos mapear a enfermidade de Jung do seguinte modo: Potencial sadio.

Primeira infância perturbada pela depressão da mãe, com isto sendo neutralizado pela qualidade maternal do pai.

Três anos: colapso psicótico, relacionado à separação dos pais.

Defesa temporária: transtorno psicossomático, fazendo vir à tona a qualidade maternal do pai (continuação da dependência).

Quatro anos: organização defensiva principal e conquista da independência.

Com a ajuda do restante do livro, podemos continuar:

Várias ameaças de colapso na infância posterior, com autocura.

As defesas incluem: verdadeiro *self* (secreto); falso *self*; a forja de um trabalho de toda a vida a partir da organização de defesa, juntamente com uma tendência permanente a curar a cisão existente na personalidade.

Finalmente, no trabalho árduo da autobiografia, o lembrar de detalhes importantes da primeira infância e da infância propriamente dita, a autocura mais próxima possível da esquizofrenia infantil. Aqui, o verdadeiro *self* não é mais secreto, e o falso *self*, que teve imenso valor por permitir a Jung levar uma vida "normal" no mundo, tornou-se relativamente inútil.

Vista desta maneira, a vida notável de Jung assume uma forma, e, para nós, surge uma coisa valiosa, por ficarmos capacitados e entender a mentira que Jung contou ao relatar um sonho a Freud, o qual, assim terminava (pgs. 155, 156):

Uma poeira espessa jazia sobre o solo e, nela havia ossos espalhados e cerâmica partida, como restos de uma cultura primitiva. Descobri dois crânios humanos, obviamente muito antigos e semidesintegrados. Então despertei.

O que interessou principalmente Freud neste sonho foram os dois crânios. Retornou a eles repetidas vezes e insistiu em que eu encontrasse um *desejo* que tivesse ligação com eles. O que era que eu achava desses crânios? E de quem eles eram? Eu sabia perfeitamente bem, naturalmente, ao que ele estava se dirigindo, qual seja, que desejos secretos de morte achavam-se ocultos no sonho.

(...) Submeti-me à sua intenção e disse: "Minha mulher e minha cunhada (...)"

E, assim, contei-lhe uma mentira.

Em seu lugar da vida de Jung, o contar esta mentira é talvez o mais próximo que ele chegou de um *self* unitário, até conseguir, na velhice, escrever sua autobiografia.

Quando Jung mentiu deliberadamente a Freud, ele tornou-se uma unidade com uma capacidade de ocultar segredos, ao invés de uma personalidade cindida, sem lugar para esconder coisa alguma. Desta maneira, talvez Freud tenha prestado uma certa espécie de serviço a Jung, embora sem sabê-lo. Podemos ver porque Freud não poderia saber, mas compete a nós saber e entender até onde se pode com base nos

fatos disponíveis. *Tout comprende rend très indulgent*. [Compreender tudo torna(-nos) muito indulgente(s).]

Não importa muito do que tratava a mentira. Em algum ponto, porém, Jung tinha de mentir para Freud, pois senão teria de começar uma análise com ele, uma análise que não teria possibilidades de ter levado à cura, ainda que pudesse ter levado a uma fuga da psicose para a sanidade ou para a psiconeurose.

Poder-se-ia dizer que os famosos desmaios de Freud contam a mesma história, ao inverso? Parece significativo que na ameaça de colapso de Jung, aos doze anos de idade, o seu sintoma fosse o desmaio; por trás deste havia um "impulso suicida" e, por trás deste impulso ainda, loucura infantil (desintegração, despersonalização, inversão dos processos de amadurecimento).

Podemos bem alegrar-nos de que Jung e Freud se tenham separado e que cada um deles houvesse mantido uma integridade pessoal e vivessem para enriquecer excepcionalmente o mundo.

Junguianos e Freudianos Hoje

É agora necessário examinar alguns dos efeitos da organização de defesa de Jung contra a psicose sobre o pensamento dos junguianos e freudianos de nossos dias. Não podemos deixar de notar que quando nos encontramos para examinar a natureza humana tendemos a utilizar os mesmos termos, com significados que são não apenas diferentes uns dos outros, mas que parecem irreconciliáveis. As duas palavras que mais ofendem são "inconsciente" e *self*

Inconsciente

Desde a época do sonho de de Jung, aos quatro anos de idade, ficou certo que ele e Freud não seriam capazes de comunicar-se a respeito do inconsciente. O que quer que Freud fosse, ele tinha uma personalidade unitária, com um lugar em si para o seu inconsciente. Jung era diferente. Não é possível a uma personalidade cindida ter um inconsciente, por não haver lugar para ele ficar. Tal como nossos floridos pacientes esquizofrênicos (embora ele não fosse um deles), Jung sabia de verdades inacessíveis à maioria dos homens e mulheres, mas passou sua vida procurando um lugar para guardar a sua realidade psíquica interna, embora tal tarefa fosse na realidade impossível. Com a idade de quatro anos ele já havia adotado a teoria sofisticada do subterrâneo do sonho, estreitamente associada, em seu caso, com o sepultamento dos mortos. Ele desceu ao subterrâneo e encontrou a vida subjetiva. Ao mesmo tempo, tornou-se uma pessoa retraída, com o que erradamente se pensou na época ser uma depressão clínica. Disto desenvolveu-se a exploração, por Jung, do inconsciente, e (para mim) seu conceito do inconsciente coletivo fez parte de sua tentativa de lidar com sua falta de contato com o que poderia agora ser chamado de o-inconsciente-de-acordo-com-Freud.

Isto nos dá uma idéia do trabalho de Jung como se achando fora de contato com o instinto e o relacionar-se objetivamente (exceto em sentido subjetivo). A extrovertida personalidade nº 1 de Jung (em minha linguagem, falso *Self*) evidentemente fornecia uma impressão bastante normal e concedeu a ele um lugar no mundo, bem como uma rica vida familiar e profissional, mas Jung não faz cerimônia a respeito de sua preferência por sua personalidade nº 2 de verdadeiro *Self* (linguagem de Jung), que conduzia para ele o senso do real. O único lugar para o seu inconsciente (sentido freudiano) estaria em seu verdadeiro *Self* secreto, um enigma envolto em outro enigma. Isto foi dramatizado no conteúdo secreto de uma caixa de lápis secretamente escondida e,

depois, esquecida durante várias décadas. Naturalmente, o conteúdo secreto era importante e acabou-se por descobrir que se achava estreitamente relacionado com denominadores comuns no folclore antropológico.

Se o significado especial de Jung para a palavra "inconsciente" for entendido e mantido separado dos vários empregos que Freud deu ao termo, é então possível ao psicanalista unir-se àquelas muitas pessoas que encontram nos textos de Jung uma contribuição tremenda para o estudo das pessoas e para a correlação de fatos coletados de toda parte. Mas o psicanalista sacrificaria valores essenciais se abandonasse os variados significados de Freud para a palavra "inconsciente", inclusive o conceito do inconsciente reprimido. Não é possível conceber um inconsciente reprimido com uma mente cindida; ao invés, o que se encontra é a dissociação.

Quando Jung contemplou a idéia do pênis ereto no lugar do rei no trono da câmara subterrânea de seu sonho, como um menino de quatro anos de idade ele não vinculou isto com, por exemplo, uma projeção de suas próprias excitações fálicas. Pareceu temer que um analista girino insistente em que ele havia visto um pênis ereto em algum lugar, mas aquilo que um analista acharia estar faltando é qualquer tentativa de relacionar isto com a vida instintual do Jung de quatro anos.

Desta maneira, existe apenas pouco conflito edípico na personalidade cindida, e tampouco há um choque com o pai no viver extrovertido. Um choque com o pai sofreu, de qualquer modo, a interferência do alheamento dos pais nessa época e do fato de o pai de Jung haver se tornado a figura materna confiável em sua vida. Ele estava portanto despreparado, como homem, para chocar-se com Freud. Um embate imaginativo com Freud teria, só ele, formado uma base para uma amizade (homossexualidade sublimada) e há provas de que Freud teria dado as boas-vindas a um embate imaginativo desse tipo.

Jung chegou ao seu ódio do pai de maneira espantosa, por ter a idéia de ser intenção de Deus que os homens e as mulheres por ele criados pecassem, em sequência à idéia que teve de que Deus havia defecado desde seu trono dourado sobre o belo teto novo da catedral, despedaçando as paredes. Aqui, mais uma vez, naturalmente, Jung não retorna um passo atrás e relaciona isto com a sua própria destruição da beleza. Não poderíamos esperar encontrar Jung sentindo Deus como uma projeção de sua própria onipotência infantil e a defecção como uma projeção de seu próprio ódio do pai na mãe, ou, em nível mais primitivo, sua própria destruição do objeto bom por ser real, no sentido de achar-se fora da área de sua onipotência.

Jung descreve o seu brincar (que teve de acontecer muitíssimo a sós, até ele ir para a escola) como uma constante construção e reconstrução, seguidas sempre pela encenação de um terremoto e a destruição do que fora construído. O que não podemos encontrar no material que Jung fornece é a destruição imaginativa, seguida por um sentimento de culpa e, depois, pela construção. Parece que aquilo que foi reprimido no início da primeira infância de Jung, isto é, antes de seu colapso infantil, foi a agressão primitiva, e relembramos aqui que é precisamente esta destrutividade primitiva a que é difícil de se chegar quando um bebê é cuidado por uma mãe clinicamente deprimida. (Fordham referiu-se ao temor que Jung tinha de sua própria destrutividade.)³

O Self

Mais difícil para mim é o uso que Jung faz da palavra *self*. (Isto foi debatido com clareza por Fordham.)⁴

3. M. Fordham, *An Evaluation of Jung's Work* (London: Guild of Pastoral Psychology, Palestra nº 119, 1962).
4. M. Fordham, *The Empirical Foundation and Theories of the Self in Jung's Work*, *Journal of Analytic Psychology*, 8 (1963).

Self não é um termo psicológico, mas uma palavra que todos nós usamos, e é possível que Jung tenha contribuído mais do que Freud o fez para uma compreensão do que ela significa ou pode significar. Foi o próprio Fordham que me fez reconhecer com um choque que eu estava usando as palavras *self* e "ego" como se fossem sinônimos, o que, naturalmente, não são e não podem ser, uma vez que *self* é uma palavra e "ego" uma expressão a ser usada por conveniência com um significado sobre o qual se concordou.

O fato é que a expressão "ego" é utilizada de modo diferente, ao se usar o jargão freudiano ou o junguiano. Freud certamente usou o termo de diferentes maneiras, de acordo com a época em que estava escrevendo. Na metapsicologia freudiana, o conceito do ego tem a sua própria evolução. A idéia inicial do ego como sendo uma parte do id não resistiu ao teste do tempo. A psicologia do ego, nos círculos analíticos, começou a desenvolver-se na década de 30 e atualmente vem sendo levada à frente, de maneira que a idéia de haver um ego desde o início (anterior à experiência do id e abrangendo-a) é considerada, especialmente se isto é encarado como intimamente relacionado a um apoio do ego fornecido de modo sensível pela mãe ao bebê que tem a sorte de possuir uma mãe apoiadora do ego.

Têm sido apresentados na literatura psicanalítica trabalhos sobre a maturação em termos da evolução do ego, inclusive o conceito da tendência no sentido da integração e de uma capacidade de relacionar-se objetivamente e de associação psicossomática. No futuro próximo, é de se esperar uma grande expansão da compreensão teórica ao longo destas linhas. Tudo isto parece ser ignorado nos textos junguianos e não podemos nos permitir ignorar nada que seja válido. Apesar disso, a idéia de *self* é muito bem-tratada pelos junguianos e compete aos psicanalistas aprenderem o que puderem neste campo.

O que deve ser recordado, penso eu, é que o próprio Jung passou a vida procurando o seu próprio *self*, o qual nunca realmente encontrou, uma vez que permaneceu até certo ponto cindido (exceto na medida em que essa cisão foi curada em seu trabalho ou em sua autobiografia). Na velhice, ele parece ter abandonado em grande parte a sua personalidade nº 1 e ter vivido de acordo com o seu *Self* Verdadeiro; desta maneira, descobriu um *self* que podia chamar de seu. Não ficou ele, clinicamente, um tanto retraído em assim proceder?

Ele acabou por chegar ao centro de seu *self*. Como sugeri anteriormente, isto parece tê-lo deixado satisfeito, mas contudo, tratava-se um pouco de um beco sem saída, se encarado como uma conquista para uma personalidade notável e verdadeiramente grande. De qualquer modo, ficou preocupado com a mandala, que, do meu ponto de vista, é uma síntese mental defensiva, uma defesa contra aquela espontaneidade que tem a destruição como seu vizinho de porta. A mandala, para mim, é algo verdadeiramente assustador, por causa de seu fracasso absoluto em chegar a um acordo com a destrutividade, bem como com o caos, a desintegração e as loucuras. Ela é uma fuga obsessiva da desintegração. A descrição que Jung faz de suas últimas décadas, gastas na busca do centro de seu *self*, parece-me ser uma descrição de um longo e cansativo encerramento de uma vida de esplêndidos esforços. O centro do *self* é um conceito relativamente inútil. Mais importante é chegar às forças básicas do viver individual e, para mim, é certo que se a base real é a criatividade, o mais próximo dela é a destruição.

Esta é uma questão que precisa de um tratamento especial em um ambiente diferente. Permanece o fato de que a busca do *self* e de uma maneira de sentir-se real, e de viver a partir do verdadeiro antes que do falso *self*, é uma tarefa que pertence não apenas aos esquizofrênicos, mas também a uma grande proporção da raça humana. Apesar disso, deve-se também reconhecer que para muitos este problema *não* é o principal; suas experiências de primeira infância os conduzem satisfatoriamente através dos estágios iniciais, de maneira que nessa infância encontrou-se uma solução

para este problema humano essencial. De modo geral, os problemas da vida não têm a ver com a busca de um *self*, mas com o uso pleno e satisfatório de um *self* que constitui uma unidade e acha-se bem-fundado. Há muitos problemas de outros tipos para a personalidade unitária, ainda que, para ela, a palavra *self* tenha um significado claro que não precisa de explicações.

É verdadeiramente difícil para aqueles que possuem personalidades unitárias sadias alcançar empatia com aqueles cujos *selves* divididos lhes causam constantes problemas. Jung foi ajudado aqui, e, entre os psicanalistas, existem alguns que estão chamando a nossa atenção para a inaplicabilidade da chamada técnica psicanalítica clássica ao tratamento da esquizofrenia.

A vida de Jung demonstrou, acredito eu, como a moléstia psicótica pode não apenas proporcionar a uma pessoa um monte de problemas, mas também impulsioná-la a realizações excepcionais. Ele, naturalmente, lançou um raio de luz sobre o problema que é comum a todos os seres humanos, na medida em que existem defesas comuns contra temores intoleráveis ou que poderiam ser chamados de psicóticos.

Este é um livro que podemos nos permitir sermos objetivos em nossa avaliação de Jung, da mesma maneira que queremos ser objetivos a respeito de Freud. Nós próprios passamos por uma análise e temos de ser capazes de analisar também os nossos mestres; pela própria natureza das coisas, eles não teriam podido fazê-la.

O livro inteiro merece leitura cuidadosa, e é bem-traduzido. Uma palavra que questiono: "alcançado" como tradução de *erreichten*. *Ich konnte mich nie aufhalten beim einmal Erreichen*. Não seria isto "Nunca pude deter-me ante coisa alguma, uma vez houvesse estendido a mão para ela"? "Alcançado" parece implicar assimilação. Um erro de tradução aqui poderia prejudicar as regras de jogos futuros de análise junguiana.

Erik H. Erikson

Resenha de *Childhood and Society*¹

1965

“Nada tenho a oferecer exceto uma maneira de olhar para as coisas”.

É bom encontrar este livro agora disponível em brochura. Ele é uma miscelânea, “um itinerário conceptual”, mas gosto dele por causa disto e porque Erikson é uma pessoa simpática. Sua personalidade está livre de empolgação e ele possui uma humildade natural que o torna a pessoa certa para tentar aplicar descobertas psicanalíticas.

As quatro partes do livro precisam ser reunidas na mente do leitor. A primeira é um enunciado, por Erikson, de uma visão psicanalítica da infância, tanto os problemas clínicos quanto a teoria geral do desenvolvimento do homem e da mulher adultos e maduros, não a partir de um homúnculo, mas de um bebê dependente. Este bebê dependente é levado avante por processos maturacionais inatos. A parte dois bem poderia fornecer o ponto de partida para o leitor que é novo neste tipo de leituras. As descrições dos padrões infantis em duas tribos de índios americanos — que acontece serem muito diferentes uns dos outros — são fascinantes e o tema central do autor vê-se melhor ilustrado nesta seção.

A parte três refere-se ao crescimento do ego e aqui se vêem as fundações a serem assentadas para a contribuição principal de Erikson, o estudo dos problemas de identidade (tal como em seu *Young Man Luther*, 1958). A parte quatro — recomendada por mim como a segunda a ser lida pelo “novo” leitor — versa sobre a juventude e a evolução da identidade e dá uma descrição interessante da identidade americana e das lendas das infâncias de Hitler e Maxim Gorky.

O tema principal de Erikson é que estudos de sociedades raramente concedem um lugar apropriado para os padrões da primeira infância e da infância propriamente dita: “um ponto cego nos criadores e intérpretes da história: eles ignoram a função decisiva da infância no tecido da sociedade”. Todo indivíduo foi bebê e foi criança, e traz para o quadro social as pulsões, as ansiedades e as defesas mentais que pertencem a todo ser humano em crescimento. As sociedades locais, no padrão de sua atitude para com seus jovens, mobilizam essas pulsões, ansiedades e defesas para adaptar seus filhos e se tornarem não apenas adultos, mas adultos em sua comunidade específica.

1. London: Hogarth Press, 1965. Esta resenha apareceu em *New Society*, 30 de setembro de 1965.

"Somente uma identidade seguramente ancorada no 'patrimônio' de uma identidade cultural pode produzir um equilíbrio psicossocial operável", e "um temor da perda de identidade domina grande parte da nossa motivação irracional; ele invoca todo o arsenal de ansiedade que é deixado em cada indivíduo pelo mero fato de sua infância. Nesta emergência, massas de pessoas tornam-se prontas a buscar salvação em pseudo-identidades". Há aqui um *feedback* para a psicanálise. Como analista, pode-se não achar que o enunciado que Erikson faz da metapsicologia psicanalítica seja aceitável em todos os pormenores. O importante é que Erikson ensinou-nos muito, e, agora, a sua abordagem especial aos problemas individuais e mundiais será lida por muitos que não são realmente estudiosos do campo da psicologia social.

59

Virginia Axline

Um Comentário sobre *Play Therapy*¹

Sem data; provavelmente meados da década de 60

Isto não se destina a ser transmitido por rádio. Trata-se apenas de mim mesmo tomar notas desta maneira enquanto leio o livro da Srta. Axline sobre terapia infantil, chamado realmente *Play Therapy*. Não haverá tentativa de estabelecer continuidade e existirão longas lacunas.

Um parágrafo importante para citação aparece na p. 15: "A terapia não-diretiva baseia-se na presunção de que o indivíduo tem dentro de si não apenas a capacidade de solucionar satisfatoriamente os seus próprios problemas, mas também aquele impulso ao crescimento que torna o comportamento maduro mais satisfatório que o imaturo". A razão por que estou me dando ao trabalho de fazer um comentário a este livro e ao trabalho da Srta. Axline é que, segundo me parece, o seu método e a sua atitude são de um tipo que pode ser comunicado a pessoas adequadas em um período de tempo relativamente curto. Não se discute que alguma modificação do esquema de formação psicanalítica e da teoria da psicanálise tem de se desenvolver à sua própria maneira e ser desenvolvida por psicanalistas. Apesar disso, estes perdem algo de muito importante se não se juntarem ao trabalho de outros psicoterapeutas e, na realidade, descobrirão, tal como no caso da Srta. Axline, que o trabalho que estão lendo corresponde estreitamente à análise modificada que têm de fazer em certos casos, se é que querem chegar a algum lugar. A outra coisa é que a psicanálise evita a questão da necessidade social e da pressão social. Os psicanalistas têm de justificar-se socialmente por outras maneiras que não seja enfrentando a pressão social e podem ajudar aqueles que estão realizando um trabalho satisfatório ou muito bom, dando-lhes respaldo quando acham que o trabalho é genuíno e depende dos princípios reais do desenvolvimento e da necessidade infantil. Em minha opinião, este trabalho da Srta. Axline é uma das aplicações realmente boas da teoria psicanalítica e não sou dissuadido disso pelo fato de que provavelmente ela não se sentiria disposta a relacionar a teoria que utiliza à da psicanálise. Não sei a resposta a isto no momento, mas a verei e debatarei este ponto com ela. Tem-se de levar em conta, naturalmente, o

1: *Play Therapy: The Inner Dynamics of Childhood* (Boston: Houghton Mifflin, 1947). Este comentário foi transcrito de uma gravação em fita. Acha-se inacabado e nunca foi editorado por Winnicott. — Organizadores.

antagonismo americano à idéia da formação de pessoas não-médicas e isto deve inevitavelmente resultar no surgimento de grupamentos psicoterapêuticos onde é feito algo que não é chamado de psicanálise e não tem a vantagem da formação psicanalítica. Apesar disso, existem muitas pessoas capazes de fazer este trabalho e não se pode esperar que elas se afoguem para sempre na norma americana de que ninguém, exceto homens e mulheres medicamente qualificados, pode aprender a psicanálise como técnica. Está chegando a hora em que esta regra começa a parecer absurda, como em verdade se predisse que aconteceria. Afirmo isto sem negar o fato de que pode ter sido uma boa regra há 20 anos atrás.

Há uma importância muito especial para mim na afirmação que a Srta. Axline faz em sua introdução, na página 15, porque a afirmação se casa de modo exato com o que venho tentando dizer em minhas palestras sobre a psiquiatria infantil a enfrentar o desafio do caso, a explorar a primeira entrevista, e assim por diante. Aqui se acha, por exemplo, uma afirmação: "Este tipo de terapia começa onde o indivíduo se encontra e baseia o processo na configuração presente, permitindo a mudança de minuto a minuto durante o contato terapêutico, se ela ocorrer com essa rapidez, com o ritmo dependendo da reorganização das experiências, atitudes, pensamentos e sentimentos acumulados do indivíduo para ocasionar *insight*, que é o pré-requisito da terapia bem-sucedida". Não estou inteiramente certo a respeito da ênfase dada ao *insight* aqui; ele às vezes pode embarçar a teoria total, pois podem haver casos, até mesmo no livro da Srta. Axline, em que mudanças ocorrem sem *insight*. Parecer-me-ia que, na primeira infância e no começo da infância propriamente dita, muita coisa acontece sem *insight*, quer dos pais, quer da criança, e poderia ilustrar isto: fui a uma livraria comprar o livro e o atendente me chamou de lado e perguntou se poderia debater sobre uma criança comigo. Ele tinha uma criança de dois anos parando em sua casa, juntamente com a mãe dela. Era uma meninazinha cujos pais muito jovens haviam se separado, de maneira que a criança estava vendo apenas a mãe. O próprio homem tinha uma meninazinha da mesma idade, que estava se saindo muito bem, mas a garotinha que parava na casa não podia suportar vê-lo. Sempre que se aproximava, ela deitava-se no chão, sobre a barriga, e gritava sem parar. Ele próprio se encontrava num dilema: deveria tentar estabelecer amizade com ela e, assim, tornar-se um pai substituto, ou simplesmente aceitar a situação e ficar contente com que, pelo menos, a criança estava tendo uma reação manifesta à ausência de seu próprio pai, do qual, evidentemente, ele a lembrava sempre que entrava na sala? Ela acabou por tornar-se muito ligada a ele, mas então ela e a mãe deixaram sua casa e ele se sentiu mal por haver se envolvido, embora não pudesse fazer outra coisa, porque sabia que a criança teria então de sofrer mais uma perda. O que ele me disse foi que esta experiência havia-lhe proporcionado *insights* do que estava acontecendo com a sua própria filha. Ele e a esposa não teriam sabido quão importante era a sua união para a sua própria garotinha, se não houvessem visto o efeito terrível da separação dos pais sobre a outra menina de dois anos de idade. Eu pensaria que, se não tivessem tido esta experiência, teriam feito um trabalho muito bom como pais e a criança estaria se desenvolvendo bem, mas sem *insight*, e que o trabalho não seria adversamente afetado pelo fato de não ter havido ocasião para *insight*. De qualquer maneira, não foi conseguido um *insight* pela menina de dois anos, que se achava muito feliz em seu seguro lar. É improvável que, nessa idade, ela fosse suficientemente crescida para comparar o estado da outra meninazinha de dois anos com o seu. Penso que na psicoterapia existe algo equivalente, e, uma declaração como a que citei, tem-se de deixar espaço para a melhora clínica que é sólida e permanente, mas contudo, irrelacionada com o *insight*. Apesar disso, a afirmação contém elementos essenciais, tais como o da terapia começar onde o indivíduo se encontra e de basear o processo na configuração atual. Quando a terapia não-diretiva garante ao indivíduo a permissivi-

dade de ser ele próprio, ela aceita isso de modo completo, sem avaliação ou pressão para mudar. Ela identifica e esclarece as atitudes emocionalizadas que foram expressas por um reflexo do que o cliente expressou. Encontro aqui um enunciado muito claro de algo que tentei expressar, à minha própria maneira, em termos do espelho, isto é, em termos da idéia de que o primeiro espelho é o rosto da mãe e que uma das funções desta última e dos pais e da família é fornecer um espelho, figurativamente falando, em que a criança possa se ver. A criança não pode utilizar os pais e a família como espelho a menos que exista este princípio de permissividade de ser, seja o que for que ele ou ela são, aceitos de modo completo, sem avaliação ou pressão para mudar.

A grande diferença entre a terapia do brinquedo do tipo da Srta. Axline e a psicanálise, é que a terapia interrompe-se no ponto em que o terapeuta espelha a criança tal como ela realmente é. Em outras palavras, a complicação das interpretações psicanalíticas acha-se ausente.

60

Willi Hoffer

Um Tributo por Ocasão do Septuagésimo Aniversário de Hoffer¹

Datado de 13 de junho de 1967

Ao redigir este tributo a Willi Hoffer, começo pela descrição de um caso de psiquiatria infantil que atendi, passando disso para uma apreciação do trabalho de Hoffer.

Parte I

Em minha clínica hospitalar vi um bebê, um menino de quatro meses e meio de idade. Fora trazido pela mãe, e a mãe do pai da criança também viera. A avó marcara a consulta, mas deixou-nos sozinhos, a mãe, o bebê e eu.

Havia uma criança mais velha (uma menina de três anos) que fora amamentada durante dez meses e que não causara problemas. Por ocasião do nascimento desta filha mais velha, a mãe havia tido dificuldades pessoais, inclusive pesadelos e também dificuldades em relação à sua própria mãe, mas este estado de ansiedade na mãe não estragara a fase inicial da primeira infância da menininha. Mesmo uma atitude um pouco insensível por parte das enfermeiras na casa de saúde (empurrando o nariz do bebê contra o seio, a fim de fazê-lo começar a mamar e, de modo geral, não permitindo processos naturais) não havia interferido no manejo inicial dado pela mãe à menina.

Antes da chegada do segundo bebê, a mãe havia adicionado à suas experiências pessoais uma certa compreensão obtida através de leitura. Após o nascimento do menino, ela se comportou de maneira muito sensata, permitindo que o bebê encontrasse o seio com as mãos e, por todas as maneiras, o começo foi satisfatório. Apesar disto, e do fato de a mãe achar-se muito menos ansiosa do que na ocasião do primeiro nascimento, o menino fora difícil.

Durante dois meses após o nascimento tudo correu bem. Então (aos dois meses) o bebê começou a recusar a amamentação do começo da noite. Isto passou e, depois, após uma semana, novamente recusou ser amamentado ao seio. A mãe achava-se então menstruada, mas ele tomou o leite do seio em uma mamadeira e, desta maneira, demonstrou que o problema não era da qualidade do leite. Tornou-se claro que, quando recusava o seio, isto era motivado por fatores poderosos dentro de si: ele

1. Publicado em alemão em *Psyche* (1967).

apenas não podia aproximar-se do seio, e, quando neste estado, chorava de dar pena se acontecia tocar no mamilo. A mãe tentou esguichar leite, de seu abundante suprimento, diretamente na boca do bebê, mas este reagiu a isto “como se lhe tivessem dado veneno”.

Todo este tempo o bebê ficava muito bem e contente entre as amamentações e aceitava a mamadeira com satisfação.

A mãe ficou perturbada por descobrir que seu bebê demonstrava uma aversão pelo seio real dela. Aceitou a situação, contudo, e tomou disposições no sentido de ele ser alimentado regularmente, por mamadeira, com o leite do seio. Aceitou também conselhos no sentido de abandonar a tentativa de superar a aversão demonstrada pelo bebê ao seio.

Aos quatro meses e meio, quando vi a mãe e o menino juntos, pude perceber que esta criança era uma pessoa, e inteligentemente ciente do que se lhe achava em torno. Adorava olhar para a irmã e havia recentemente se tornado muitíssimo ciente do pai. Na verdade, a aversão ao seio tornara-se um aspecto importante em um feriado de segunda-feira em que o pai achava-se em casa, e pela primeira vez presente à hora da amamentação do bebê. A relação com o pai era positiva.

Tínhamos, então, aqui, um distúrbio emocional em um menino saudável, começado aos dois meses de idade e bastante bem-organizado aos quatro e meio. As pessoas envolvidas eram:

	O menino	
A mãe		A irmã
(A mãe da mãe)	O pai	
		A mãe do pai

Fiz na ocasião uma nota de que não se podia pensar na mãe como sendo inteiramente normal. Embora não manifestamente ansiosa, era bastante excitável, e muitíssimo frustrada porque queria amamentar o bebê e preencher sua função como mãe. Calculei que tivesse de lidar com uma quantidade considerável de um elemento masculino em sua personalidade total, o que (se verdadeiro) complicaria a fantasia de sua função de amamentação, e também sua atitude para com este bebê menino, comparado à atitude dela para com a menina.

Havia um outro detalhe clínico de importância. A mãe, com frequência, achava que poderia manejar a amamentação do menino se não fosse pela atitude muito especial da irmã. Esta mostra-se intensamente interessada, mas é incapaz de suportar o choro do irmão. Assim que ele chora, ela grita: “Dá-lhe de mamar! Dá-lhe de mamar!” Ao mesmo tempo, o outro lado dos sentimentos da irmã mostrava-se em sua propensão a ter acidentes durante os períodos reais de amamentação do irmão e com frequência a mãe tinha de interromper a amamentação a fim de lidar com uma crise na vida da irmã.

Fui também informado que havia na casa distúrbios (associados com outros parentes) que despertavam consideráveis tensões, com a mãe sendo incapaz de impedi-los e com o pai parecendo ausente, incapaz de perceber a necessidade que a esposa tinha de que ele criasse uma atmosfera calma em torno dela, de modo que ela pudesse desempenhar esta delicada tarefa de modo suficientemente bom.

Experiência

Conseguí fazer uma experiência, aplicando o que sei dos problemas de bebês que sofrem intensa aflição por serem incapazes de seguir seu instinto natural de aproximar-se do seio e da mãe.

Enquanto a mãe, o bebê e eu estávamos sozinhos, o bebê passou por uma dessas fases em que ficou negativamente orientado quanto ao seio da mãe e intensamente aflito. Coloquei minha mão entre a mão do bebê e o seio, produzindo assim uma oposição. Em reação a isto, ele temporariamente perdeu a inibição e esforçou-se por alcançar o seio. A experiência foi repetida várias vezes, sempre com o mesmo resultado. Ele acabou por ficar deitado nos braços da mãe, sugando o polegar esquerdo, com o polegar direito na mão esquerda e a mão direita no seio. A mãe não havia tido um momento pacífico como este, em sua relação com o bebê, por mais de uma semana.

O que eu havia feito, sem dúvida, fora colocar temporariamente fora do bebê o elemento inibidor de sua mente, que obstruía o impulso real de estender a mão e encontrar o seio.

Descubro, pela experiência, que este limitado material clínico pode ser usado como base para uma boa discussão teórica, e não é minha intenção explorá-lo aqui ou fornecer uma dedução dogmática.

O menino está hoje com nove anos e a irmã, doze. Ele teve uma sessão psicoterapêutica comigo quando contava sete anos, e, recentemente, uma outra. O importante é que o seu problema poderia ser enunciado hoje nos termos que registrei quando o vi com quatro meses e meio.

Parte II

Foi em inumeráveis experiências deste tipo que baseei minhas próprias idéias com referência à teoria do desenvolvimento emocional da criança humana. Disto se poderia facilmente adivinhar que admiro e valorizo as duas contribuições efetuadas por Hoffer:

1. "Mouth, Hand, and Ego-Integration", *The Psycho-Analytic Study of the Child*, vols. 3-4 (Imago, 1949), p. 49-56.
2. "Development of the Body Ego", *The Psycho-Analytic Study of the Child*, vol. 5 (Imago, 1950), p. 18-23.

Aqui, Hoffer estava usando observações de minúsculos detalhes que fizera em associação com Anna Freud e seus outros colegas na *Hampstead War Nursery*.

Para mim, o importante é o fato geral de que Hoffer estava usando estas observações como base segura para a teoria. Se as observações não se encaixam na teoria, então esta última tem de ser mudada. Os dois artigos de Hoffer também assinalam uma mudança — entre os psicanalistas — que passou por uma longa fase inicial, na qual se pensava que a primeira infância podia ser vista através da análise de adultos ou de crianças pequenas, enquanto que, de fato, ela só pode ser vista nas análises através das lentes deformantes de defesas organizadas em datas posteriores à da primeira infância.

Lembro-me de que, nos anos que se seguiram à guerra (a II Guerra Mundial), Hoffer apresentava, também, um filme que fizera de uma criança a comer sua própria boca. Tratava-se de uma criança carente. Isso o interessou como interessa a todos nós descobrir o que existe nos bebês que os faz tão raramente comerem a si próprios, ou mesmo machucar os dedos com os dentes, e que, às vezes, deformem as mandíbulas e os dedos através do sugar incessante.

A essas contribuições pode-se agora acrescentar o trabalho de Hoffer, uma Conferência pronunciada no Aniversário de Freud em 1966, intitulado *Infant Observation and Concepts Relating to Infancy* (ainda não publicada)².

2. Hoje publicada, juntamente com os outros dois trabalhos acima mencionados, em Willi Hoffer, *The Early Development and Education of the Child* (London: Hogarth Press, 1981).

Aqui está uma passagem de "Mouth, Hand, and Ego-Integration" que mostra a qualidade da atenção dada por Hoffer aos detalhes:

Se nos voltarmos agora para os bebês da *Hampstead Nurseries*, o fato mais notável em seu comportamento de sugar era o aspecto direto e a resolução com que, a partir da 12ª semana, o bebê faz os dedos aproximarem-se da boca e nela penetrarem. Isto podia ser observado a qualquer hora em que estava desperto e, naturalmente, era mais acentuado antes da alimentação e imediatamente após esta. A mão pode ser introduzida pelo caminho mais curto ou através de um amplo círculo descrito pelo braço, enquanto que os olhos podem seguir os movimentos da mão. Nessa idade, raramente pude observar movimentos vigorosos de sugar quando dedos ingressavam na boca, algo inteiramente contrastante com a reação que acontecia quando a mamadeira era levada à boca. O sugar dos dedos é, principalmente, um sugar ritmado, intenso e prazeroso. A extensão de sua duração parece mais importante que a intensidade. Ele pode interromper-se por um período menor ou maior, enquanto a mão, com os dedos curvados, pende da mandíbula. Isto indica irritação das gengivas devida à dentição.

No exemplo que segue, tirado do mesmo artigo, Hoffer descreve com prazer o que observa:

Bertie, um menino de 16 semanas, é um sugador de dedos experiente, que suspende seu dedo anular na boca curvando os três dedos restantes e apertando-os como um andaime contra o lábio inferior, impedindo assim que a mão deslize para dentro da boca. Não se pode desprezar o alto grau de adaptação que o bebê alcança na minimização da tensão oral. É a mão que com perícia se adapta às necessidades da zona oral e a forma e o volume dela são alterados do punho cerrado até um só dedo pequeno, de acordo com a necessidade de estimulação. O dedo ou o punho podem penetrar de modo profundo ou superficial na boca e serem dirigidos no sentido das estruturas externas ou internas da última. A versatilidade da mão no processo de sugar admite originalidade e a elaboração de padrões individuais de prazer em grande número. Com referência ao andaime de Bertie, contudo, tenho uma reserva a fazer. Ele foi amamentado durante as primeiras sete semanas, enquanto ainda se achava em casa. Pode ser que uma sensação tátil tenha sido despertada em seu queixo ou lábio inferior pela mão da mãe a segurar o mamilo na boca da criança. A posição dos dedos desta enquanto os suga pode, dessa maneira, ser também interpretada como uma reprodução voluntária de uma estimulação epidérmica que sentiu quando sugava o seio.

De modo semelhante:

Outro exemplo de um movimento genuíno e autodirigido da mão para a boca foi observado em Tom, quando contava 16 semanas de idade. Ele nunca fora amamentado, mas havia sido criado com mamadeira de maneira muito satisfatória. Filmado enquanto sugava o polegar, revelou um esforço e uma aplicação singulares para uma criança dessa idade. Tom mantinha os braços ligeiramente curvados na frente do rosto, os dedos estirados, e os da mão esquerda tentavam segurar o polegar direito com um movimento de pinça. Enquanto ambas as mãos tentavam aproximar-se uma da outra com movimentos espasmódicos, a boca de Tom era mantida aberta e ele fazia um esforço como se estivesse tentando levantar a cabeça do travesseiro, e os lábios sugavam ar como uma turbina. Quando conseguia apanhar o polegar e introduzi-lo na boca, a mão esquerda era então mantida sobre esta, trancando-a e impedindo a mão direita de resvalar para fora. Ou, se ela resvalava, a mão esquerda rapidamente a empurrava de volta para dentro e o polegar era empurrado bem para trás, no sentido do palato, acompanhado por um sugar bastante intenso. Nenhuma outra forma de voracidade oral em conexão com a comida foi observada em Tom.

O conteúdo do artigo justifica-lhe a conclusão: "Podemos, dessa maneira, presumir com segurança que, quando ingressa no segundo ano de vida, o bebê já construiu

um conceito oral-tátil de seu próprio corpo e do mundo que o rodeia, e regula até certo ponto, por este meio, as suas pulsões eróticas e agressivas (ativas)".

No segundo artigo a que estou me referindo, "Development of the Body Ego", Hoffer acompanha idéias do estado indiferenciado como uma teoria que suplanta aquela pela qual o ego se torna diferenciado do id. E "a capacidade do bebê em distinguir entre o *self* e o mundo que o rodeia?" Esta pergunta precisa ser equilibrada com um estudo da "reação a estímulos provindos de dentro do sistema de órgãos".

Hoffer examina este tema, de novo fazendo uso das detalhadas observações que esteve efetuando na *Hampstead Nursery*. Rapidamente ele nota que, para o bebê, sentir o *self* envolve duas experiências, aquilo que a mão sente e o que é sentido pela mão.

Ele observa "uma diferença notável entre bebês de até dez semanas, quando comparados com os de doze a dezesseis semanas".

Um bebê de quatro semanas, quando se acha ligeiramente com fome e esperando para ser alimentado, pode apresentar algumas atividades orais, acompanhadas por movimentos da cabeça, dos braços e das mãos. Estas últimas podem ainda ser mantidas em uma posição que se assemelha à posição uterina em que as mãos ficam mais próximas da boca. Enquanto a mão está se movimentando sobre o rosto, a boca pode agarrá-lo e seguir-se-á o sugar dos dedos. Até algumas semanas de idade não fará muita diferença que a mão inteira ou um ou dois dos dedos deslizem para dentro da boca, se uma mamadeira ou um bico foram oferecidos ao bebê. O comportamento que este apresenta é (a) excitação motora, muito provavelmente devida à fome e influenciada por experiências anteriores de alimentação (busca do seio) e (b) tentativas de aliviar a excitação através de atividades orais que podem conduzir ao sugar dos dedos.

Inteira e diferente é o comportamento observado em um bebê de 16 semanas de idade. Pouca coisa é deixada à gratificação fortuita. Durante o estado de espera antes de ser alimentado ou após uma alimentação bem-sucedida, o bebê pode insistir em uma forma definida de gratificação oral-sugadora e as atividades que conduzem a esta gratificação estão de acordo com quase todos os critérios pelos quais avaliamos o funcionamento do ego.

Segue-se aqui uma relação das funções de integração do ego:

1. Atividade perceptual genuína.
2. Controle motor.
3. Funcionamento da memória.
4. Teste da realidade.
5. Função sintetizadora do ego.

Desta maneira, o leitor é levado por Hoffer até o complexo conceito de ego, a partir de uma posição clínica. Isto certamente deve ter estabelecido um padrão para grande parte do trabalho que desde então vem sendo feito em várias partes do mundo. É em observações atentas deste tipo que sabemos que temos de basear nossas idéias a respeito de busca objetual, relacionamento com objetos, satisfação sensual excitada e não-excitada, exploração da satisfação na defesa contra a ansiedade, os primórdios do controle (em comparação com a onipotência, e mesmo a experiência da onipotência através da adaptação bem-sucedida à necessidade), e muitas outras questões de importância vital.

Sumário

Fornei uma espécie de introdução de observação clínica. Meu objetivo principal, contudo, terá sido alcançado se consegui levar os leitores a um reexame das duas contribuições de Hoffer, que requerem leituras repetidas e que devem ser estudadas

com atenção por todos aqueles que tentam formular idéias relativas aos primeiríssimos estágios da estruturação da personalidade humana.

61

James Strachey

Obituário¹

1969

Quando James Strachey faleceu em abril de 1967 estava com 79 anos de idade. Naturalmente, existem hoje apenas poucas pessoas vivas que o conheceram de modo pessoal e, portanto, não é fácil encontrar material para um comentário biográfico. Na ocasião em que sua morte foi anunciada estávamos tão próximos do fato de perdê-lo que acho que não quisemos falar ou escrever a seu respeito. Talvez agora já possamos obter prazer em começar a recordar como ele era.

Strachey era produto do que costumava ser um grupamento muito definido na sociedade inglesa, o Serviço Civil Indiano. Seu pai foi Sir Richard Strachey, G. C. F. I., F. R. S. (nascido em 1817, falecido em 1908) e era secretário do governador das Províncias Centrais na época do Motim.

Sir Richard e Lady Strachey tiveram uma grande família, 12 filhos, acredito, dois dos quais morreram. Os dez que sobreviveram, me foi dito, agruparam-se como se constituíssem duas gerações, com James sendo um dos cinco mais moços. Não sei nada do início de sua vida.

Quando chegou a época, James ingressou na *Hillboro Preparatory School* e lá teve como amigo o poeta Rupert Brooke. Esta amizade dá-nos uma indicação da natureza de Strachey quando menino.

No estágio seguinte, Strachey foi um sucesso. Foi aluno meio-pensionista da *St. Paul's School*, em Londres, e esteve cotado para receber uma bolsa de estudos. Parece que ele correspondeu às expectativas, pois de *St. Paul's* foi para *Trinity*, em Cambridge, onde me garantem que não fez absolutamente nada durante três anos, exceto, naturalmente, conhecer todos os que eram interessantes e conversar a respeito de tudo que lhe parecia ter importância. Ficaria surpreso em saber que a conversa versava sobre política. A única pergunta era: ele colaria grau? Foi dito que recebeu um grau de suficiência em Direito, o que eu teria achado ser aproximadamente o fundo do barril, à exceção talvez de um grau de suficiência em História, que, naquela época, em Cambridge, podia ser conquistado estudando-se uma hora por dia durante o período letivo. É difícil imaginar que ele estudasse Direito, mesmo que apenas por uma hora diária.

1. Publicado no *International Journal of Psycho-Analysis*, 50 (1969). Copyright (C) Institute of Psycho-Analysis.

Pode ser que após Cambridge ele se encontrasse um tanto sem direção. Isto foi exatamente antes da I Guerra Mundial, quando sua irmã já era diretora de *Newnham*. A guerra chegou e James foi-lhe um opositor de consciência. Ele era de constituição franzina e o oposto de um lutador, e, embora de maneira alguma efeminado, poder-se-ia dizer que tinha uma constituição delicada e era a pessoa errada para se ver na linha de combate. Foi sorte sua ele ter um irmão mais velho que era coronel do exército regular e que defendeu vigorosamente a objeção de James a lutar, de maneira que foi-lhe concedida permissão para trabalhar para uma organização *Quaker*, relacionada à alimentação das esposas inglesas de civis de nacionalidade alemã internados. Alix aventurou a opinião de que, efetuando este trabalho, James passou por uma espécie de "conversão à idéia de valor do amor", algo que lhe veio através de seu contato com as motivações dos *Quakers*. Nunca houve uma religião oficial em sua vida.

Após a guerra, apareceu uma abertura para James no jornalismo, porque seu primo, St. Loe Strachey era redator-chefe do *The Spectator*, e ele tornou-se secretário particular de St. Loe. Trabalhou também para *The Nation* (mais tarde incorporada por *The New Statesman*). Durante esta fase, escreveu muitas resenhas de livros. Alix descreveu-me a maneira pela qual James sempre deixava tudo para o último momento possível, e ilustrou isto com um retrato de um feriado passado em Lyme Regis. Uma resenha tinha de ser postada; ela foi com ele até o correio e James ainda se achava escrevendo a resenha enquanto caminhava pela rua. Isto era possível porque ele se achava sempre inteiramente certo do que queria escrever. Exatamente quando a caixa postal estava a ponto de ser esvaziada, ele escreveu a última palavra, fechou o envelope e o postou.

Houve os que disseram de Strachey, nesta época, que ele nunca se assentaria em coisa alguma. Evidentemente, estava Tateando em busca de algo e não sabia o quê.

Vim a saber que ele foi positivamente influenciado por uma citação de Freud em um livro de C. G. S. Meyer, e, a partir daí, desenvolveu a idéia de tornar-se psicanalista. Nessa época, Ernest Jones estava recomendando a todos os que se candidatavam a analistas que se tornassem medicamente qualificados e Strachey chegou a ingressar na escola de medicina. Após algumas semanas a dissecar pernas de rãs (tal como Alix o disse), descobriu-se mais uma vez sem objetivo ou direção. Talvez fosse característico de Strachey que desta vez ele tenha lidado com a sua dificuldade pessoal escrevendo diretamente a Freud. Para sua surpresa, recebeu deste uma carta convidando-o a ir a Viena, por achar-se Freud satisfeito que um pedido de informações lhe chegasse da Inglaterra praticamente nos calcanhares da guerra. Foi então que Alix e ele se casaram, foram para Viena juntos, e parece que algo a meio caminho entre uma análise e uma conversa irrompeu entre Strachey e Freud. Em sua volta, ele ingressou no andar térreo, por assim dizer, do edifício psicanalítico que se achava em construção, e foi aceito como analista por causa de seu contato pessoal com Freud.

Eu diria que Strachey tinha uma coisa inteiramente clara em sua mente, como resultado de sua visita a Freud: que um processo se desenvolve no paciente e que o que se torna conhecido não pode ser reproduzido, mas dele se pode fazer uso. Isto é o que sinto a respeito de minha própria análise com Strachey e, em meu trabalho, tentei seguir completamente o princípio e dar ênfase à idéia em sua rematada simplicidade. Foi minha experiência de análise nas mãos de Strachey que me deixou desconfiado das descrições do trabalho interpretativo em análise, que parece interpretar tudo o que acontece, como se o processo no paciente se houvesse perdido de vista.

Gradualmente, Strachey chegou à sua principal contribuição psicanalítica, uma série de conferências em 1933 (*International Journal of Psycho-Analysis*, 1934) nas quais formulou o conceito da interpretação mutativa. Nelas ele tornou explícito o princípio da interpretação econômica, da interpretação no ponto de urgência, no momento

exato, a reunir o material apresentado pelo paciente e a lidar de modo claro com uma amostra de neurose transferencial.

Nada sabia de Strachey como homem, naturalmente, até 1933, quando interrompi minha análise de dez anos com ele. Foi então que lentamente descobri que ele era aproximadamente tão tímido quanto eu. Ansiava por vir a conhecê-lo, mas sempre tivera a impressão terrível de que fosse erudito e sofisticado, algo que eu não era. Ele sentia-se em casa em uma área que somente descobri tarde demais, uma vez que eu não havia encontrado a vida cultural (exceto sob a forma de uma religião evangélica) até descobrir-me na escola pública [inglesa]. Strachey crescera nela, nessa terceira área do viver, a área da experiência cultural.

A familiaridade dele com a literatura, a música e o balé enchia-me de inveja e fazia-me sentir um tanto caipira quando me achava em sua companhia. Incidentalmente, Strachey tinha, fora de dúvidas, uma cabeça muito boa, o que é uma vantagem.

Acho que o que se notava a respeito desse homem tímido era a sua natureza não-agressiva, mas contudo, não há necessidade de pensar que ele não tivesse sentimentos agressivos, e, de qualquer modo, podia ser obstinado. Sua esposa sabe a respeito de sua indignação e, na verdade, de sua raiva, que amiúde não era evidente até chegar ao ponto de explosão. Com frequência ficava zangado em comitês e odiava a maneira pela qual o lado comercial da indústria editorial influenciava as questões, especialmente após a aposentadoria de Leonard Woolf. Acho que ele pôde ter sentido que a integridade da obra de Freud e de seu próprio trabalho de traduzi-la e organizá-la deveria ter automaticamente recebido precedência sobre as questões comerciais.

Já na década de 30 tornara-se bastante claro, para quem quer que houvesse pensado que Strachey jamais se prenderia a algo, que ele havia encontrado ao que se ligar, ao lado da prática da psicanálise clínica, que na verdade envolve perseverança. Ele havia se tornado vitalmente interessado pelos textos de Freud e adorava falar a respeito dos vínculos que mostravam o funcionamento da mente freudiana, vínculos que podiam ser feitos porque Freud relatara os seus sonhos e escrevera muitíssimas cartas. Havia também os atos falhos de Freud, a refletirem sentimentos ou conflitos que às vezes podiam ser rastreados.

Strachey ficava muito entediado com todas as controvérsias que levaram à cisão da Sociedade em torno de personalidades, mais do que ao redor das dificuldades inerentes à contribuição de Freud e aos desenvolvimentos científicos baseados na psicanálise clínica. Para ele, as tensões e as pressões que ocorriam na Sociedade, que não podiam ser evitadas se é que ela queria permanecer sendo uma unidade, eram inacreditavelmente irrelevantes. Em verdade, é possível que a coisa principal em Strachey fosse a *honestidade intelectual inatacável*. Não é verdade que a honestidade intelectual só é possível na área que era a própria vida dele, isto é, a área da experiência cultural? A honestidade intelectual no viver leva à fogueira e quase conduziu Strachey, como opositor de consciência durante a guerra, à prisão. Em termos místicos ou psicodélicos, a honestidade intelectual leva-nos apenas a uma visão pessoal da ave do paraíso. É talvez apenas na esfera cultural que a integridade intelectual se torna concreta e pode constituir uma característica permanente, e isto era James Strachey, tal como o vi.

Não tenho intenção de efetuar aquilo que, de qualquer modo, certamente não estou qualificado para fazer, qual seja, avaliar neste momento do tempo o valor da obra principal de Strachey, a Edição Standard, mas sugiro que o que Strachey fez foi apanhar os textos de Freud e situá-los na literatura, onde a honestidade intelectual reina suprema e até mesmo um erro tipográfico é uma calamidade.

Os últimos doze anos foram definitivamente felizes para a família Strachey. Quando ele e Alix se mudaram para Lords Wood, que a mãe de Alix, ela própria uma artista de considerável valor (Mary Sargent-Florence), havia por tanto tempo domina-

do com sua personalidade vigorosa, eles se estabeleceram para concentrar-se no tópico imenso dos textos freudianos. A casa ajudava por proporcionar isolamento; Strachey passava a maior parte de sua vida desperto em uma das grandes salas. Tudo o que ele fez foi compartilhado por Alix, cuja familiaridade com a língua alemã tinha uma importância óbvia. A devoção de Strachey a uma causa, mais uma vez o conduziu ao que nos deve parecer um tópico lateral, embora, em verdade, possa haver uma conexão entre as duas facetas da dedicação. James, em criança, fora muito ligado a seu irmão Lytton, que era alguns anos mais velho, e isto não cessou quando Lytton foi viver em um *ménage à trois* com uma amiga de Alix, uma artista que se autodenominava Carrington por não gostar de seu primeiro nome. Alix tem em sua posse dois sensíveis e notáveis retratos a óleo de Lytton, da autoria de Carrington. James teve de passar pela triste experiência da morte lenta de Lytton, causada por um câncer dos intestinos que durante longo tempo não fora corretamente diagnosticado.

Aconteceu que uma biografia de Lytton achava-se em preparação e, durante esses 12 anos de concentração nos textos de Freud, James estava ao mesmo tempo muito preocupado em estabelecer corretamente os fatos nessa biografia com a qual não se achava realmente contente. O trabalho nela tinha de ser (por assim dizer) roubado de Freud e é possível que James tenha trabalhado demais, em resultado de sua premência por terminar ambos os trabalhos, por consideração a Freud e a seu irmão.

As honras que lhe prestaram incluíram o Prêmio Schlegel-Tieck, concedido às traduções. Eu próprio aceitei este prêmio, após o falecimento de Strachey, em nome da Sra. Strachey, em uma recepção oferecida pela Embaixada Alemã.

Foi uma grande coisa para James ir passar férias no Caribe com Alix, férias pagas com os direitos autorais recebidos pelo trabalho efetuado.

Para terminar esta descrição informal de James Strachey, quero dizer que ele foi uma boa amostra de um inglês. Ele não foi um grande homem, penso eu, e espero, embora quem pode dizer a quem a posteridade concederá este prêmio? Foi, no entanto, um homem tão infinitamente enriquecido pelo que colheu da herança cultural que não dependeu de distrações para sentir-se contente por estar vivo. Aqueles que compartilharam de sua vida, indubitavelmente partilharam com ele esta mesma riqueza que provinha das amizades, da literatura e da arte. Ele será sempre o meu exemplo favorito de psicanalista.

Anna Freud

Resenha de *Indications for Child Analysis and Other Papers*¹

1969

Este livro é o octogésimo volume da Biblioteca Psicanalítica Internacional. Os primeiros 50 números foram editados por Ernest Jones; seu atual editor é M. Masud R. Khan. Embora o livro seja longo (690 páginas), não constitui leitura pesada, devido à maneira pela qual o material é apresentado. A Hogarth Press com muito sucesso auxiliou o leitor através de um belo emprego do papel e da impressão.

O livro representa o volume quatro de uma série de sete livros que apresentarão a totalidade da contribuição de Anna Freud em conferências e textos. Este volume abrange o período de 1945 a 1956, em que os textos da Srta. Freud achavam-se intimamente relacionados com o seu trabalho clínico e às atividades de ensino, e ela ainda se encontrava muitíssimo sob a influência de suas experiências na *Hampstead War Nurseries*.

Ao ler-se um livro deste tipo, não é necessário concordar com todos os detalhes. O importante é que se é confrontado com um quadro verídico da evolução da posição teórica de uma pessoa específica, e pode-se ver que a Srta. Freud é coerente, ao mesmo tempo em que cresce e permite ser influenciada pela experiência clínica e os textos de colegas tais como Ernst Kris e Heinz Hartmann, cuja obra entretém-se com a sua.

O livro também fornece uma oportunidade muito boa, para o iniciante, de olhar para a teoria psicanalítica através dos olhos de alguém que esteve intimamente associada com o Freud da última fase e que prosseguiu, após o falecimento dele, de acordo com o que sempre sentiu ser os princípios básicos que ele defendia. Como ela é basicamente uma professora, acredito que os professores concordarão com a sua apresentação.

Nunca deixei de ficar fascinado pelos detalhes observados na *Hampstead War Nurseries*. Os relatórios dessa experiência única são tão atuais hoje quanto o eram na década de 40, e o estudioso tem muito a aprender deste trabalho bem documentado. Da mesma maneira, existe bom material para debate em outros trabalhos clínicos, tal como, por exemplo, a investigação especial feita a respeito de seis jovens órfãos judaico-alemães, cujos pais morreram na pior maneira do regime de Hitler.

1. London: Hogarth Press, 1969. Esta resenha apareceu em *New Society*, 21 de agosto de 1969.

A Srta. Freud, na *Hampstead War Nurseries* e em todo o seu trabalho em Hampstead, conseguiu manter-se em contato com os observadores, ao mesmo tempo em que ela mesma permanecia relativamente não-envolvida com as crianças em si. Esta posição de desligamento pode ter-lhe concedido a liberdade de utilizar as observações como material de apoio, correção ou desenvolvimento de teorias ortodoxas de desenvolvimento infantil, as quais eram originalmente, é claro, construídas a partir da análise de adultos. Não posso dizer se a Srta. Freud sentiu ter este desligamento relativo na ocasião, pois não existe dúvida de que a totalidade deste importante trabalho prático em que uma psicanalista dispôs-se a atender uma necessidade social significou muito para ela.

Aqueles que a conheceram quando a guerra se desenvolvia e havia tanta ansiedade no ar, ficaram espantados com a maneira pela qual ela conseguia ser uma organizadora brilhante, como se não houvessem bombas caindo e ninguém se encontrasse em perigo. É fora de dúvida que as bombas não são tão más quanto a perseguição, que afeta a mente e ameaça a integridade pessoal de alguém, e a Srta. Freud faz referência a isto em uma nota de rodapé: "Seria injusto atribuir responsabilidade por quaisquer deficiências do trabalho às condições bélicas muito sérias que reinavam na Inglaterra na ocasião. Pelo contrário, a experiência do perigo comum, da ansiedade e da tensão comuns, criava no pessoal uma atmosfera de entusiasmo e de devoção exclusiva aos interesses comuns, a qual seria difícil de duplicar em condições de paz".

Obviamente, a leitura de um livro deste tamanho tem de levar tempo, mas é possível prometer ao leitor que será fácil lê-lo do princípio ao fim e que, ao final, muita coisa terá sido aprendida e aprendida da maneira certa, por assistir-se ao desenvolvimento da conceptualização da Srta. Freud, baseada em sua visão pessoal do trabalho de Freud e a sua liberdade de ser influenciada pela observação e pelo pensamento original de colegas. Este livro pertence tanto à estante quanto ao lazer. Está cheio de observações e avaliações objetivas e merece a posição que ocupa como octogésimo volume da Biblioteca Psicanalítica Internacional.

P A R T E 4

**Sobre Outras Formas
de Tratamento**

63

Terapia Física do Transtorno Mental: Terapia de Convulsão

Perto do fim da II Guerra Mundial, Winnicott tornou-se muito envolvido nas questões que rodeavam o emprego de tratamentos físicos de pacientes psiquiátricos hospitalares e que estavam, na ocasião, ganhando aceitação na prática psiquiátrica. Este capítulo e o seguinte contêm a maior parte de seus textos sobre o assunto, divididos em duas seções que se referem aos tratamentos com os quais ele estava mais preocupado, quais sejam, a terapia de convulsão e a leucotomia.

A primeira expressão pública dessa preocupação apareceu em sua carta à *The Lancet*, de 10 de abril de 1943, versando sobre a leucotomia pré-frontal. No decorrer desse ano ele preparou também o artigo intitulado "Tratamento da Doença Mental pela Indução de Convulsões", com vistas à publicação (possivelmente no *British Journal of Medical Psychology*), embora de fato nunca tenha aparecido. Em 1944 ele organizou um simpósio sobre terapia de choque, realizado em 15 de março, na Sociedade Psicanalítica Britânica. Trabalhos foram lidos por Hans Thomer, Helen Sheehan-Dare e Clifford Scott; o próprio Winnicott deu-lhe início com a Introdução reproduzida aqui. O artigo intitulado "Tipos de Efeito Psicológico da Terapia de Choque", encontrado após o seu falecimento, também fora evidentemente preparado para o simpósio; ao longo da parte de cima havia uma nota manuscrita que dizia: "O artigo que não li. D. W. W."

O artigo principal do *British Medical Journal*, "Terapia Física do Transtorno Mental", é uma condensação do artigo lido em 27 de novembro de 1946 perante a Seção Médica da Sociedade Psicológica Britânica. Este artigo, tal como a primeira carta de Winnicott ao *B. M. J.* (25 de dezembro de 1943), resultou em um debate prolongado e às vezes acrimonioso nas colunas de correspondência da revista, uma indicação dos sentimentos profundamente assentados dos praticantes médicos e, particularmente, dos psiquiatras sobre as questões que Winnicott levantou.

Durante o início da década de 50 houve um novo irromper de atividade por parte de Winnicott, vinculado principalmente com as considerações éticas a rodearem a prática da leucotomia, e, em 1951, ele foi convidado pelo Professor R. M. Titmuss a abrir um debate sobre o assunto na *London School of Economics*. O debate se deu em 13 de novembro e foi assistido por membros do quadro da escola e estudantes de pós-graduação nos campos da sociologia, da psicologia e da assistência social. As "Notas sobre as Implicações Gerais de Leucotomia" foram preparadas para esta ocasião.

Outras cartas abertas escritas por Winnicott sobre estes temas, mas não reproduzidas aqui, podem ser encontradas no *British Medical Journal* de 22 de dezembro de 1945, 13 de dezembro de 1947 e 25 de agosto de 1951; no *The Lancet* de 18 de agosto de 1951 e no *Spectator* de 12 de fevereiro de 1954.

Os Organizadores

I. Tratamento da Doença Mental pela Indução de Convulsões

Datado de julho de 1943

Os problemas que se apinham em torno do tratamento da doença mental através de convulsões são de três tipos, que indicarei mediante perguntas.

A. O que a *idéia* de receber convulsões ou de ter uma convulsão significa para o paciente? (Não me acho, naturalmente, apenas pedindo a resposta consciente do paciente, ainda que saber mesmo isso possa ser valioso.)

B. O que a incontrolável coisa interna que acontece, a *convulsão concreta*, significa para esse paciente? (Quero aqui dizer para o inconsciente do paciente.)

C. Que efeito físico a convulsão tem sobre o tecido cerebral? (Presumivelmente, imagina-se que seja leve, mas doutra maneira, como se pode sustentar que ela certamente não causa dano? E, de qualquer modo, a resposta a esta pergunta é relativamente sem interesse para o psicólogo, porque a convulsão é a mesma, seja o paciente deprimido, esquizofrênico ou neurótico. Qualquer efeito físico deve ser do tipo de tiro-no-escuro, comparável às "alternativas" da medicina medieval.

É na primeira destas perguntas que este artigo está interessado.

Qual é a posição atual? Um grande número de homens e mulheres experimentaram melhoras com a terapia convulsiva, de maneira que, em vez de serem casos crônicos em um asilo, tornaram-se mais ou menos independentes e retornaram ao lar e ao trabalho. Alguns pacientes enfermos, mesmo aqueles que poderiam não se ter recuperado espontaneamente, foram curados pela aplicação de convulsões, ou, pelo menos, retornaram ao estado em que se achavam antes de haverem sofrido colapso. Ademais, achando-se os asilos demasiado cheios, qualquer coisa que capacite os pacientes a terem alta é valioso para o Estado.

Embora ainda não tenha sido provado que as convulsões são inóculas ao tecido cerebral, posso perfeitamente acreditar que o sejam, pois, afinal de contas, as características convulsivas são de músculos, não do cérebro, e provavelmente apenas a parte congestiva da convulsão coloca em perigo o delicado tecido cerebral em si. De qualquer modo, é mais simples basear este debate na pressuposição de que as convulsões não possuem qualquer efeito físico, o qual bem pode ser o caso.

A menos que me tenha escapado algo na considerável literatura sobre o assunto, nenhum pesquisador desse campo explicou satisfatoriamente a ação terapêutica das convulsões, nem se mostrou muito interessado a respeito desta falta de conhecimento, o que torna o tratamento, para dizer pouco, não-científico, mesmo que seja muito belamente realizado por uma equipe cuja perícia e técnica se acham mais além de qualquer louvor. Penso que posso presumir que qualquer luz que possa ser lançada sobre o modo de ação do tratamento por convulsões será bem-vindo, e, por esta razão, estou escrevendo este artigo, embora eu próprio não faça esse tratamento.

A questão é: *O que o tratamento e as convulsões significam para o paciente?* Como possuo algumas evidências sobre este ponto, desejo apresentá-las. Elas provêm de minha prática psicanalítica, o tipo de pesquisa que se acha na melhor posição para fornecer as pistas relativas a este tipo de problema.

A psicanálise capacita o paciente e o analista a irem muito fundo no significado inconsciente das coisas, pelo menos na medida em que concerne ao paciente específico. Na realidade, tantos detalhes se tornam compreendidos em uma análise que é

muito difícil, em verdade, transmitir o que sucede no curso do tratamento para aqueles que acontece não haverem experienciado a análise eles próprios. Ademais, é difícil, ao relatar um caso, tornar absolutamente certo que nada é escrito que tenha possibilidade de revelar a identidade do paciente, razão pela qual nenhuma tentativa pode ser feita de descrever o caso integral, que tão claramente ilustrou para mim o significado do tratamento por convulsões pelo menos para uma paciente. O trabalho envolvido foi considerável. A análise demorou um ano (um tempo curto, não suficientemente longo para completar o tratamento), durante o qual visitei a paciente cinco vezes por semana em um hospital psiquiátrico e, em cada vez, permaneci com ela por uma hora.

A paciente era uma moça de 25 anos, inteligente e proveniente de uma família de cultura. Durante alguns anos a sua vida vinha se tornando cada vez mais envolvida, de maneira política, e o irromper da guerra havia complicado seu problema pessoal, por tornar as intrigas disponíveis menos amplas em seu raio de ação.

Para as pessoas comuns, a guerra ocasiona uma simplificação das questões, sendo, portanto, um alívio. Para ela, esta própria simplificação tornou-a menos capaz de esconder a sua própria personalidade dividida, de maneira que não teve outra alternativa senão parecer louca. Deu baixa em um hospital psiquiátrico em um estado de confusão aguda e classificada (corretamente, creio eu) como esquizofrênica. Mais tarde, foi assim oficialmente atestada.

Enquanto se achou em diversas instituições, recebeu primeiro tratamento insulínico e, depois, convulsões de cardiazol; em seu caso, porém, disso não decorreu nenhum bom resultado. Aconteceu neste caso que a paciente, embora conscientemente odiando a psicanálise todo o tempo, cooperou plenamente comigo e reagiu de modo muito satisfatório. Sua personalidade mudou no sentido do normal em relação ao trabalho feito na análise e, ao final do ano, conseguiu receber um atestado negativo e ter alta. Desde esta ocasião, ela retornou a um trabalho de secretariado relacionado com a política, com algum sucesso, e, embora eu não reivindique este caso como "cura", alego que um terapeuta convulsivo ficaria satisfeito em obter um resultado assim¹.

No decurso desta análise, que foi, incidentalmente, um trabalho de pesquisa altamente complexo e detalhado, tornei-me capaz de perceber um pouco do significado das convulsões e deste tipo de terapia para a jovem. Isto pode ser difícil de ser descrito por uma maneira que seja facilmente inteligível a um não-analista e, portanto, abordarei o assunto registrando uma observação indireta. Se esta puder ser entendida, fornecerá um ponto de apoio para maior compreensão.

Pedira-se à moça que desse sua permissão para a terapia convulsiva. Na análise, tornou-se claro que a concessão da permissão fora uma expressão dos desejos suicidas da paciente. Ela entendeu o tratamento como sendo algo que deveria fazê-la esquecer. Parece que um dos médicos, na realidade, explicou o processo nessas palavras, mas de qualquer modo, ela teria sentido isso como verdadeiro. Para ela, o tratamento visava a destruir parte de seu cérebro, e, *por esta razão*, deu permissão. *Por esta razão* também ela controlou os fenômenos que poderiam seguir-se às convulsões e não permitiu que nenhum efeito delas decorresse, quer bom, quer mau, porque não podia admitir que houvesse expressado desejos suicidas ao concordar com o tratamento.

A paciente tinha uma alta valorização da mente e do cérebro, por razões que posso fornecer, e, para ela, a parte importante da personalidade, sem a qual a vida é inútil, era esse cérebro, ou mente. O exercício intelectual sempre significara mais para ela que o exercício e a experiência corporais, e, na realidade, isto pode tê-la levado a

1. A cessação da análise deveu-se principalmente ao conselho de um psiquiatra bem-conhecido, que relatou: "A psicanálise não ajuda neste tipo de caso; dessa maneira, embora pareça haver ajudado aqui, não aconselho que ela seja continuada". — D. W. W.

atingir um alto padrão acadêmico. Infelizmente, seu cérebro não era acima da média (diria eu) em capacidade, e o cérebro que ela valorizava de modo excessivo era o do pai, que ela (inconscientemente) "amamentava" [*nursed*] em sua própria cabeça.

Devo informar, neste ponto, que o pai desta moça falecera antes de ela nascer. A única maneira pela qual ele lhe era conhecido dava-se através dos textos dele, que significavam muitíssimo para ela. Era o cérebro dele que fora capaz de encontrar, amar e incorporar, e este pai idealizado, de quem nunca tivera raiva, ela o alojara em seu próprio cérebro.

Em algum lugar, naturalmente, achava-se o ódio pelo pai, do qual nada conhecia na experiência real, e esse ódio pelo pai era representando por um medo ou convicção de que alguém destruiria o cérebro dela, ou parte dele (ou seja, o pai, alojado em seu cérebro).

Em sua doença, ela se achava lutando com sua necessidade aguda de ser a pessoa mais arguta (na intriga política, por exemplo, impedindo a guerra) e ficou confusa por descobrir sua incapacidade de fazer o que se estabelecera conseguir, e por sua tendência crescente a "perder o barco" como moça adolescente ou jovem mulher. Ela tinha de lutar cada vez mais com seu ódio pelo pai, por ele haver morrido sem que ela o conhecesse e também por ele não haver lhe concedido um cérebro suficientemente bom, que a capacitasse a solucionar os problemas mundiais como por magia.

Neste estado de confusão, foi ver um psiquiatra, e estava consciente de um medo de que as pessoas estivessem conspirando para destruir-lhe o cérebro (isto é, aquela parte sua com a qual se sentia identificada com o pai).

Teve o impulso de fazer isso ela própria, pelo suicídio, mas seu amor pelo pai idealizado fê-la protegê-lo com sucesso de seus próprios ataques a ele.

Neste ponto, foi-lhe pedido que consentisse à terapia convulsiva. Ela deu permissão e então cuidou que esta forma de terapia não funcionasse, pois o único resultado que podia *imaginar*, quanto ao tratamento, era a demência, a representar uma depressão grave vinculada à morte de tudo o que restava do pai dentro dela, e por todas as maneiras, responsabilidade dela.

De tudo isto pode-se ver que quando se pede a um paciente permissão para a terapia convulsiva, é sempre possível que a resposta positiva possa ser, e tem muita probabilidade de ser, um ato suicida. Isto equivale a dizer que o médico compreensivo poderia, se soubesse exatamente o que estava fazendo em todos os casos individuais, oferecer ao paciente uma tentativa de suicídio que na realidade não mata. É bem-sabido que tentativas genuínas, mas mal-sucedidas de suicídio podem ter um efeito benéfico, até mesmo curativo, e o tratamento convulsivo talvez pudesse ser utilizado desta maneira específica. Mas ele não é usado assim e tende a ser empregado como um tratamento mal-administrado, sem teoria a apoiá-lo.

Esta minha paciente tendia a encarar toda psicoterapia como um ataque ao cérebro e a sua oposição consciente à psicanálise revelou possuir esta base também, pelo fato de ser uma expressão de seu delírio de que as pessoas estavam conspirando para torná-la incapaz de lembrar. O fato de este tratamento analítico tê-la capacitado a recordar algumas experiências muito importantes da infância, que se haviam tornado reprimidas, não teve qualquer efeito sobre este delírio, que teve de ser tratado como tal, ou seja, analisado, sem com ele discutir-se. O psiquiatra que finalmente aconselhou-a a abandonar o tratamento quando recebeu um atestado negativo, pareceu-lhe estar correto por aparentemente partilhar do delírio dela de que a psicanálise fazia parte da conspiração para destruir o cérebro bom que acreditava haver recebido do pai, que protegera do ódio que por este sentia, mas sobre o qual não sabia nada até haver entrado em análise.

Deixei muita coisa de fora. Exemplificando, não disse nada a respeito do amor muito profundo que a moça sentia pela mãe, que descobrira após ter vindo a saber

que a amara muito mais do que ela havia odiado sua mãe real e sofrido sob a depressão e o ódio reprimido que esta tivera pelo pai, que falecera antes do nascimento da paciente. A rivalidade entre mãe e filha não se expressava de maneira melhor do que em suas depressões: quem era que tinha o pai (marido) morto dentro de si? Nunca se permitira à minha paciente reconhecer a depressão, sendo isto privilégio da mãe. Comigo, ela se tornou deprimida, achando valiosa a experiência nova. Tornou-se capaz de ficar deprimida porque descobriu que o analista, diferentemente da mãe, podia tolerar que ela ficasse deprimida. A mãe a teria alegrado em uma falsa felicidade, mimado-a de todas as maneiras, e tornar-se-ia francamente deprimida ela própria.

O ponto principal é que quase toda terapia violenta, e a terapia convulsiva em particular, tende a ser sentida como um ataque a algo que se tem dentro de si, algo para com que se tem sentimentos confusos e conflitantes: um grande amor misturado com um grande ódio. Isto possui significância especial para um paciente com delírios paranóides. A coisa boa que fica dentro está morta e, portanto, um laxante deve ajudar; se está viva, então é melhor deixar um médico atacá-la aplicando-lhe convulsões, ou cortando fora o cérebro. O intolerável é descobrir que alguma coisa é odiada e amada ao mesmo tempo.

O tratamento convulsivo não pode, em verdade, deixar de significar muitíssimo para um paciente, e também para uma pessoa normal, se se propusesse aplicar um tratamento desse tipo a uma pessoa normal, "por razões profiláticas". O fato de que pessoas normais não consentiriam em submeter-se a este tratamento, é outra maneira de dizer que as pessoas normais são o oposto das suicidas, isto é, elas querem preservar as coisas existentes dentro delas, as quais valorizam.

É de importância muito grande que estas considerações psicológicas sejam entendidas e recebam reconhecimento pleno. Não apenas é mau para a nossa profissão que psiquiatras estejam dispostos a continuar uma terapia do tipo tiro-no-escuro (e de um tipo tão violento, também); mas também se dá por esse meio um estímulo à antiga crença conservadora de que a insanidade é uma doença física do cérebro.

Nos dias de hoje, a década de 40, deveria ser axiomático que as doenças mentais são essencialmente independentes da enfermidade do tecido cerebral, que elas são transtornos do desenvolvimento emocional. O fato de moléstias cerebrais e outras enfermidades físicas se acharem relacionadas a transtornos mentais não altera este axioma. O novo clamor é sempre por novos tratamentos dirigidos ao tecido e à função cerebrais, e os cirurgiões acham-se agora exercitando a sua engenhosidade na leucotomia pré-frontal. Não ficamos impressionados, contudo, porque nenhum deles publicou uma pesquisa satisfatória do que significa, para um paciente, ser operado em seu tecido cerebral. Pessoas insanas com frequência imploram que alguém retire os seus cérebros, juntamente com o coração, os pulmões e outras localizações de coisas internalizadas, mortas, outrora amadas e que hoje se encontram mais além do luto. Pode-se com mais facilidade desculpar os anseios desses insanos do que as novas invenções de terapeutas ávidos e sinceros.

Dou-me conta de que esta pequena pesquisa constitui uma gota em um oceano. Mas ela talvez indique a necessidade de maior pesquisa, e do tipo de pesquisa que é necessário, e, ainda que se refira a apenas uma só paciente, envolveu cerca de 200 horas de trabalho consistente. Este trabalho foi uma aplicação de muitos trabalhos semelhantes feitos com outros pacientes que não aconteceu haverem tido tratamento convulsivo antes de chegarem a mim, e poderia ser de valor na análise de outros pacientes esquizofrênicos, independentemente de haverem tido tratamento insulínico ou convulsivo, naturalmente em cooperação com psiquiatras que não são antagonistas à análise.

O trabalho foi uma aplicação direta da técnica e da teoria terapêuticas imaginadas por Freud e desenvolvidas por seus seguidores, especialmente por Melanie Klein. Muito é devido também a vários debates que tive com Clifford Scott.

II. Tratamento de Choque do Transtorno Mental

Carta ao redator-chefe do British Medical Journal, 25 de dezembro de 1943

Prezado Senhor: De acordo com minha opinião, o curso sereno da evolução médica foi interrompido e feito retroagir pelo tratamento do transtorno mental através da indução de convulsões — um atalho curto à psicoterapia e uma maneira maravilhosa de fazer psiquiatria sem ter de conhecer nada a respeito da natureza humana. Convido os clínicos gerais a declararem de modo claro se eles favorecem esse tratamento, possuidor de aspectos que nos fazem lembrar uma das mais violentas das tentativas medievais de expulsar espíritos maus.

Na realidade, não percebo como a permissão é sequer obtida para que o tratamento seja feito, uma vez que há boas provas de que quando um adulto concede permissão para que lhe seja aplicado, ele o faz com base em um impulso que é aparentado ao impulso suicida. O que faz um homem sentir vontade de ferir-se, faz também ele permitir e até mesmo solicitar o tratamento de choque. A ética da colaboração com este impulso suicida é duvidosa. Deve-se recordar que o tratamento não está sendo aplicado a casos sem esperança, mas sendo experimentado em todos os tipos de enfermidade psicológica. Pessoalmente, jamais daria permissão para esta terapia de choque, simplesmente porque não vejo maneira de provar que ela é inofensiva, mas acho que a nossa profissão, como um todo, poderia razoavelmente opor-se ao tratamento com base nos fundamentos de que ele oferece uma variante à compreensão verdadeira da natureza humana, exatamente em uma época em que estamos nos tornando tremendamente capazes de enriquecer nossa prática médica através da assimilação de pesquisas recentes na psicologia.

Eu iria mais além. Planejar, se é que quer ser tão bom quanto correr ao lado, tem de levar em consideração fatores inconscientes. Não existe coisa tal como o antagonismo inconsciente de um médico a pessoas enfermas que não reagem à sua terapia. Em minha opinião, a terapia de choque é um tratamento violento demais para que possamos fazer uso dele, achando-nos ao mesmo tempo seguros de que não estamos, inconscientemente, pretendendo que ele fira o paciente. Os psiquiatras devem em verdade conhecerem-se muito bem para sentirem-se felizes ao administrar o tratamento, e suportarem críticas e até mesmo antagonismo, que devemos esperar, mais cedo ou mais tarde, na imprensa leiga. (Atenção já foi chamada pelo seu correspondente, Dr. Martin Cuthbert [20 de novembro] a determinado tipo de reação pública.)

Esta carta tem a intenção de ser um convite a que a profissão de modo geral discuta a matéria, que, por causa de suas implicações éticas, não pode permanecer sendo um problema puramente psiquiátrico ou científico. E eu gostaria muitíssimo de saber quantas pessoas há que se sentem como me sinto de que ninguém pode ter o direito de sancionar a aplicação de convulsões a uma criança. Permaneço, etc., etc.

D. W. Winnicott

III. Terapia de Choque

Carta ao redator-chefe do British Medical Journal, 12 de fevereiro de 1944

Prezado senhor: Ficaria grato se me permitissem responder às cartas que se seguiram à minha de 25 de dezembro. A maior parte delas proveio de psiquiatras, e isto me desapontou, uma vez que meu objetivo era sondar a opinião da profissão como um todo. O clínico geral acha-se provavelmente, no presente, ocupado demais até para ler cartas, mas, apesar disso, acho que a opinião dele sobre práticas especializadas deveria ser constantemente buscada pelos especialistas, por outra razão que não fosse a de que o clínico geral, ele próprio, vive entre os seus pacientes, entre os fracassos terapêuticos, assim como entre os sucessos.

Estou bem ciente de que um certo número de psiquiatras que são estudiosos da natureza humana estão utilizando diversos tipos de terapia de choque como adjuntos a seu trabalho psicoterapêutico. Estes não têm nada a temer de uma carta dirigida por mim à imprensa médica. Eles continuarão com seu trabalho, mantendo, modificando ou descartando de acordo com a sua cuidadosa observação dos efeitos. Inteiramente diferente disto é a idéia que está se desenvolvendo de que o tratamento do transtorno mental é o tratamento de choque de um tipo ou de outro, e que isto é algo que pode ser receitado e aplicado tal como a quimioterapia no caso da septicemia. Nenhum tratamento do transtorno mental será jamais inventado, que possa ser apropriadamente praticado por alguém que não seja estudioso da natureza humana. Minha carta teve algum valor pelo fato de haver produzido uma afirmação autorizada de que a terapia de choque (de qualquer espécie) não constitui um tratamento em si. A opinião que expressei — de que a terapia de choque do transtorno mental (mesmo que possa ser valiosa em boas mãos) representa um sério retrocesso para a saúde da psiquiatria — é estritamente pessoal, e não é mais que justo para os meus colegas psicanalíticos que eu torne claro que a minha carta expressava apenas o meu sentimento pessoal.

Vários daqueles cujas cartas foram publicadas, presumiram que eu tinha a psicanálise em mente como alternativa à terapia de choque. Na realidade, eu não mencionei essa palavra, embora seja verdade que a minha formação tenha sido feita na disciplina psicanalítica. A alternativa que estou advogando é uma boa administração geral, uma boa assistência pessoal por parte de médicos e enfermeiras, com tolerância quanto ao fracasso terapêutico. Isto é extremamente difícil de ser colocado em prática no caso de material psiquiátrico desesperador, mas para cada caso deste último tipo existem centenas, ou melhor, milhares de casos esperançosos, e é para eles que temos de planejar a prática psiquiátrica. Isto pode soar de modo surpreendente para alguns psiquiatras de instituições, mas os clínicos gerais entenderão o que quero dizer quando digo que, quando a ciência médica for capaz de controlar a parte física de certas condições comuns, tais como gripe, reumatismo e pressão sangüínea alta, muita coisa da depressão grave, paranóia e hipomania crônica será revelada. Estas terão de ser tratadas como a gripe, o reumatismo e a hipertensão sempre foram tratadas, ou seja, pela atenção pessoal de médicos e enfermeiras. Uma das coisas realmente úteis que os psiquiatras costumavam nos ensinar era que as fases de depressão tendem a passar de modo espontâneo, com não mais que uma tolerância inteligente por parte daqueles que cuidam do paciente, com a manutenção de uma vigília sobre as tentativas de suicídio, deliberadas ou acidentais. Freud tornou este ensinamento compreensível por apontar a relação da melancolia com o luto normal, que tem seu termo e do qual se

pode esperar a recuperação. Se os psiquiatras estão realmente interessados em ajudar, eles podem fazer muito mais do que (com notáveis exceções) fazem agora a respeito da terapia ocupacional. Talvez a expressão "terapia ocupacional" seja infeliz, por nos fazer lembrar o provérbio a respeito das "mãos ociosas", enquanto que um termo melhor indicaria que o que se quer é uma forma especializada de orientação vocacional que conceda à realidade subjetiva o seu lugar apropriado, ao longo da relação do paciente com o mundo externo.

Poder-se-ia ficar contente em deixar a pesquisa a respeito do valor da terapia de choque seguir seu próprio curso, não fosse uma certa comunicação que recebi com referência ao planejamento do pós-guerra. Foi-me dito que, quando a paz chegar, separar-se-á uma instituição para a enfermidade psiquiátrica na infância, na qual crianças psicóticas serão tratadas pela terapia de choque. Exatamente isso. Ora, o meu amigo Dr. Rogerson pode achar-se gravemente em erro ao pensar que a psicose na infância é rara. Em minha opinião, é comum. Aquilo com que a esquizofrenia, a depressão, a paranóia e a hipomania se parecem na infância é uma questão situada fora do raio de ação desta carta, mas o importante é que a imensa maioria dos casos recupera-se espontaneamente com uma administração correta ou, pelo menos, consegue encontrar alguma maneira de vida que combine com o tipo de personalidade. Aqueles que utilizam a terapia de choque no tratamento de adultos, generosamente admitem não ter idéia de como ela funciona, quando funciona. Ao mobilizar a opinião médica geral, tive a esperança de tornar impossível que essa pesquisa seja feita com crianças na Inglaterra. Permaneço, etc., etc.

D. W. Winnicott

IV. Introdução a um Simpósio sobre a Contribuição Psicanalítica à Teoria da Terapia de Choque

Livro da Sociedade Psicanalítica Britânica, em 15 de março de 1944

Em 7 de outubro de 1942, a Sociedade dedicou uma noite ao tema da terapia de choque, com o Dr. Freudenberg lendo um artigo que foi ilustrado por um filme. (Devido a uma enfermidade, não me foi possível estar presente.) Penso ser verdade, contudo, dizer que a reação plena da Sociedade não foi mostrada nesse encontro. Em verdade, não poderia ser, uma vez que o tema é amplo e muitos membros não haviam concedido à questão muita reflexão, antes de escutarem a valiosa contribuição do Dr. Freudenberg. Mesmo hoje não é certo que a Sociedade, como um todo, se ache ciente da amplitude da aplicação desta forma de tratamento, que agora inclui a aplicação de convulsões induzidas por corrente elétrica a pacientes ambulatoriais que freqüentam um dos hospitais universitários de Londres, e em outras partes.

No *International Journal of Psycho-Analysis* do ano passado (1943), o Dr. Cyril Wilson publicou o que denominou de "Um Ponto de Vista Individual sobre a Terapia de Choque". Pode-se ter como certo que este artigo é conhecido da Sociedade e,

portanto, o Dr. Wilson não está lendo um trabalho hoje. No artigo, o aspecto psicológico da teoria da terapia de choque é trazido à discussão, e a minha idéia, ao arranjar este simpósio, foi continuar o trabalho dele, tentando desenvolver uma contribuição psicanalítica ao assunto. Consideraria o simpósio um sucesso se ele incentivasse a Secretaria Científica a estabelecer um grupo de pesquisa com o objetivo de reunir os frutos de experiências individuais de analistas que têm a ver com a terapia de choque. A experiência psicanalítica é tão mais profunda do que qualquer outra de seu tipo que bem se pode dizer que, mediante nossas análises de alguns pacientes que passaram por esse tratamento sob uma de suas variadas formas, possuímos uma compreensão coletiva que é mais importante do que a dos muitos psiquiatras cujo trabalho é administrar o tratamento a grande número de pacientes.

Alguns membros expressaram sua indisposição a oferecerem suas opiniões, por não haverem pessoalmente administrado a terapia de choque, nem, tampouco, assistido a ela. Sugiro não haver necessidade de tal hesitação. Se houvermos tido a oportunidade de analisar um só paciente que haja passado pelo tratamento, não devemos desperdiçar o valioso material que por essa maneira ganhamos. Mas eu sugeriria ainda que cada analista pode contribuir, independentemente da análise real de pacientes que receberam choques. Ele veio a conhecer muitos pacientes de modo íntimo, tão intimamente que poderia imaginar o que significaria para qualquer deles passar pelas experiências que esses choques proporcionam. Seria bastante lógico, para um psiquiatra que tenha inventado uma forma nova de terapia, consultar os psicanalistas quanto aos resultados esperados dessa terapia, antes de aplicá-la.

Acredito se achar muitíssimo dentro do campo de ação da Sociedade Psicanalítica estudar os aspectos psicológicos deste tratamento físico de pessoas mentalmente enfermas, e deveríamos estar tão interessados em ajudar os psiquiatras a entenderem porque eles obtêm bons resultados tanto quanto em apontar-lhes as limitações e os perigos. Deveríamos mesmo poder auxiliá-los, desde o ponto de vista teórico, em sua escolha de casos e na seleção de determinada forma de tratamento de choque em relação a outra. Se estou correto, é por causa de nossa crença no inconsciente, como por causa de nosso conhecimento da estrutura da personalidade, que temos valor. É por isso que não podemos esperar que nos peçam auxílio. Pode ser que a explicação atual dos resultados desta terapia em base física constitua um erro sério, um erro que ninguém, exceto o psicanalista, pode corrigir. De qualquer modo, se houver uma explicação física, isto não elimina a necessidade de um exame completo dos mecanismos psicológicos em ação, juntamente com os físicos.

Neste debate, poder-se-ia achar aconselhável presumir que nenhum dano físico cerebral é causado pelo tratamento. Ninguém pode estar certo de que isto seja verdadeiro, mas é improvável que nós, nesta sala, possamos trazer provas em qualquer dos sentidos. Contudo, se presumirmos que nenhum dano físico cerebral é causado, alguns poderiam pensar que devemos também assumir que mudanças físicas não ocorrem no cérebro de modo algum, nem mesmo mudanças para melhor. Naturalmente, existe a momentânea modificação elétrica ou química causada pelo excitante, mas é difícil acreditar que mudanças físicas, que se possa confiar que façam bem e não causem dano, possam ser ocasionadas no cérebro por este método de atirar às cegas.

Devo lembrar aos membros presentes que alguns médicos administram o tratamento por acreditarem que ele *danifica* o cérebro e, dessa maneira, cerceia lembranças suprimidas irritantes. O passo seguinte é a operação da leucotomia pré-frontal, em que as fibras associativas existentes entre os lobos frontais do cérebro são realmente *cortadas*.

Em minha opinião, não caberia argumentar aqui a respeito das considerações éticas que levantei em uma carta dirigida ao *British Medical Journal*, porque nesta Sociedade estamos interessados no assunto como algo merecedor de estudo científico,

e presumimos que se pudesse demonstrar à profissão médica que o tratamento era mau, então a profissão automaticamente o abandonaria na prática. Não tenho dúvidas pessoais quanto à integridade de qualquer psiquiatra que pratique o tratamento de choque, mas tenho de reservar-me o direito de interessar-me por seus motivos, como sempre nos interessamos por nossos próprios motivos, como analistas. Em um debate científico, não se pode apresentar com utilidade considerações éticas, até que um progresso considerável tenha sido feito na teoria. Na *prática* da psiquiatria, contudo, e foi a esta a que me referi em minha carta ao B. M. J., as considerações éticas têm de receber seu peso devido desde o início.

Se posso me referir à correspondência mantida com o B. M. J., acho que dela emergiram diversos pontos que têm valor em um debate científico. Um deles é que nenhuma reivindicação é feita de que alguém realmente sabe como o tratamento funciona. Dessa maneira, não estaremos pisando nos calos de ninguém, se possuímos as nossas próprias teorias. Da correspondência, e também de uma impressão que tive em um encontro recente da Sociedade Médico-Psicológica, é evidente que milhares de tratamentos estão sendo aplicados anualmente e que a reivindicação de que o tratamento torna os pacientes acessíveis à psicoterapia deve ser tomada como valiosa apenas em determinados casos, pois cada praticante desta forma de terapia relata um número de casos tratados grande demais para que acreditemos que ele fez uso do aumento de acessibilidade em mais do que uma pequena proporção do total. Por outro lado, tenho provas de que certos psiquiatras estão realmente só utilizando os choques como adjuntos a seu trabalho psicoterapêutico, e me parece que estes pesquisadores do campo acham-se em uma posição muito diferente da da maioria que se apóia principalmente nos choques.

Depreendo que hoje se concede que os melhores resultados são conseguidos na melancolia involutiva e nas fases de depressão do tipo mais brando, que tendem a recobrar-se espontaneamente com uma boa administração. Os resultados com as melancolias graves são indubitavelmente notáveis e, se quisermos contribuir de modo útil, temos de examinar as maneiras pelas quais estes bons resultados poderiam ser obtidos através de mecanismos psicológicos.

A fim de esclarecer o debate, sugeri trabalhar com os três problemas seguintes, que, é natural, se sobrepõem parcialmente:

- a. Os efeitos dos variados choques sobre a anatomia, a bioquímica e a fisiologia do cérebro e do corpo em geral, bem como o significado de tais mudanças corporais para o paciente.
- b. O significado dos choques e, mais especificamente, das convulsões, bem como da idéia de receber choques e convulsões, para as pessoas normais e diversos tipos de pessoas enfermas. Refiro-me aqui a significado consciente e inconsciente, e também ao inconsciente reprimido.
- c. O significado, para o paciente, da convulsão real ou de acontecimentos corporais incontroláveis. Refiro-me aqui ao significado inconsciente (não especificamente inconsciente reprimido).

V. Tipos de Efeito Psicológico da Terapia de Choque

Redigido para o Simpósio sobre Terapia de Choque, realizado na Sociedade Psicanalítica Britânica, em 15 de março de 1944

Desejo debater isto sob cinco classificações:

1. *O efeito da terapia sobre o staff e a atmosfera da instituição.* Quando se examina o efeito psicológico de qualquer tratamento novo, penso que seria um equívoco ignorar a diferença que a introdução desse tratamento pode causar na atmosfera geral da instituição e na atitude dos médicos e das enfermeiras. Talvez seja importante, de modo especial, levar em consideração exatamente este tipo de coisa ao considerar o trabalho que é feito em um hospital psiquiátrico. Em um hospital deste tipo, há um grande número de pessoas enfermas, gravemente enfermas, cronicamente enfermas e enfermas de uma maneira que significa que não podem evitar serem um peso grave para as pessoas. O peso do caso psiquiátrico tem de ser carregado por pessoas e não por máquinas, e às vezes me espanta que consigamos encontrar médicos e enfermeiras que estejam dispostos a efetuar esse trabalho. É bem sabido que, no passado, a crueldade floresceu em hospitais psiquiátricos, uma das razões para isso é que alguns dos pacientes "estão pedindo" por ela, e outra sendo que, ao cuidar de tanto material humano incurável, os assistentes têm de desenvolver uma atitude especial, devida ao fato de haver apenas pequeno alívio do tipo a que os psicanalistas se acham acostumados quando vêem pacientes a melhorar diretamente como resultado de seu trabalho. O trabalho no hospital psiquiátrico carrega consigo uma imensa frustração e isto tem de aplicar-se também às consultas psiquiátricas comuns, que conduzem apenas a uma boa administração de casos e não à cura de pessoas. Entre parênteses, gostaria de dizer quão importante é que eu, como psicanalista, reconheça o ônus especial do trabalho psiquiátrico puro, porque, na análise de psicóticos, o psicanalista periodicamente precisa da cooperação do médico do hospital psiquiátrico e não a obterá se não puder entender a natureza especial desse tipo de trabalho.

A introdução de uma forma de terapia que pode ser aplicada a um grande número de pacientes, de outra maneira intratáveis, pode facilmente ter causado uma grande diferença no sentimento que prevalece entre o *staff* dos hospitais psiquiátricos. Se assim é, penso que deve ser verdade que médicos, enfermeiras e assistentes se tenham tornado melhores médicos e enfermeiras por causa da nova esperança e da diminuição do senso de frustração através da introdução da terapia de choque. Também o alto grau de perícia e conhecimento que é exigido para o controle apropriado da terapia insulínica, por exemplo, traz para o hospital psiquiátrico médicos e médicas que têm conhecimento e perícia em bioquímica e outros assuntos. Isto tudo deve tender a despertar ou a manter vivo um espírito de indagação científica que, acredito, achava-se de modo geral faltando nos hospitais psiquiátricos há algumas décadas atrás.

Parecer-me-ia ser relevante a este debate levar em conta a possibilidade de que a atitude do *staff* do hospital psiquiátrico para com os pacientes mentais tenha melhorado em resultado da introdução de novas terapias que incluem a terapia de choque e, presumindo que isto seja verdade, incentivar pesquisas sobre o efeito que se esperaria que tal melhoria tenha sobre os vários tipos de casos psiquiátricos.

2. *O efeito do tratamento através do que o paciente pensa dele como fazendo parte da relação emocional do médico com o paciente.* Os psiquiatras falam da importância do relacionamento emocional de seus pacientes com eles e, até certo ponto, examinam os

resultados da terapia de choque à luz disto que chamam de "transferência". Acho que pensam que aprenderam a respeito dos fenômenos transferenciais com a psicanálise e, em certa medida, referem-se à mesma coisa que os psicanalistas querem dizer quando utilizam o termo. Eles percebem que o laço emocional entre o paciente e o médico baseia-se em um reviver da experiência passada ou constitui uma dramatização da fantasia. Acho, porém, que usualmente existe apenas uma compreensão limitada da visão psicanalítica de que os sentimentos transferenciais são anormais apenas na medida em que são inconscientes. É provavelmente muito raro que os psicoterapeutas baseiem seu tratamento, tal como os psicanalistas o fazem, em tornar gradualmente conscientes, mediante interpretações baseadas em material apresentado dia-a-dia pelo paciente, os elementos reprimidos na transferência. O Dr. Wilson trata da questão da transferência em casos psicóticos em seu recente artigo publicado no *Journal*². Cito uma de suas frases: "Desconfio que alguns psiquiatras que utilizam terapia de choque tendem a apoiar-se demais em sua insulina ou em sua máquina, e muito pouco em sua própria personalidade".

Ele desenvolve este tema de modo completo e dá a impressão de que ele próprio valoriza a terapia de choque apenas como um método de tratar pacientes que de outra maneira permaneceriam sem tratamento, sem abandonar a idéia de que é possível que os resultados sejam atingidos através de mecanismos puramente psicológicos.

Para desenvolver este tema, eu estaria repetindo grande parte do que o Dr. Wilson escreveu.

3. *O efeito do tratamento de acordo com idéias e fantasias conscientes e pré-conscientes.* Lendo um pouco da literatura a respeito e escutando debates, fiquei impressionado com a maneira pela qual alguns psiquiatras parecem ignorar mesmo os aspectos psicológicos mais superficiais do problema. Pode tratar-se de um engano de minha parte, ou é possível que se tenha achado não valer a pena relatar a discussão ordinária do assunto com o paciente. Eu gostaria que um psiquiatra que relata casos me dissesse qual o tipo de debate que ele tem com cada paciente, antes de começar. Uma ilustração ajudaria aqui, embora não me ache alegando que ela prove algo. Uma paciente que havia sofrido convulsões eletricamente induzidas em uma instituição me contou: "Não nos haviam dito que o tratamento nos dá convulsões e não estou certa de que se suponha que o saibamos, mas na realidade, todos sabemos, porque a história se espalha em segredo". Isto parece demonstrar que, neste caso específico, a paciente não estava obtendo informações das quais facilmente poderia ter feito bom uso. Quando lhe perguntei se sabia, de experiência de primeira mão, como é que era uma convulsão, disse que nunca havia visto uma delas, mas então repentinamente lembrou-se de que, ainda meninazinha pequena, ficara assustada em ver outra criança ter uma convulsão em uma turma do jardim de infância. Forneço este exemplo apenas para ilustrar a maneira pela qual, talvez somente em casos isolados, sentimentos comuns conscientes e pré-conscientes podem ser ignorados ou desperdiçados quando grande número de pacientes mentalmente enfermos estão sendo tratados por um tratamento físico. Aceito com um grão de sal quando psiquiatras relatam que forneceram psicoterapia, utilizando choques apenas como adjuntos àquela, a menos que se contentem em relatar haverem tratado apenas uns poucos casos. Se um homem aplicou várias centenas de tratamentos, não posso ver como ele possa ter acompanhado cada caso com uma psicoterapia satisfatória.

4. *O efeito do tratamento de acordo com a expectativa que pode ser predita em vários tipos de pessoas enfermas.* Deveria ser possível efetuar um enunciado do que cada tipo de paciente tende a esperar do mundo, e poder-se-ia pensar na terapia de choque em

2. Cyril Wilson, *An Individual Point of View on Shock Therapy*, *International Journal of Psycho-Analysis*, 24 (1943).

relação a essas expectativas. Fui incapaz de satisfazer-me de modo algum ao fazer tal enunciado e, se se vier a imaginar que esta linha de abordagem seja proveitosa, eu gostaria de obter auxílio. Exemplificando, alguns histéricos esperam que as pessoas expressem ambivalência para com eles. Talvez não fiquem surpresos quando médicos que estão cuidando deles lhes apliquem convulsões que são penosas e desagradáveis. Outros histéricos esperam um ataque sexual e talvez tendam a pensar no tratamento de choque sob esta luz. Os masoquistas, certamente, tenderão a transformar o tratamento em seu próprio proveito, à sua própria e especial maneira. Os que duvidam e outros obsessivos estão sempre esperando sentir-se culpados a respeito de algo e conheço pelo menos um que se sentia igualmente culpado por recusar o tratamento de choque e por solicitá-lo. Os casos de ansiedade constituem um grupo tão misturado que não admitem generalizações, mas eu pensaria que quaisquer pacientes de ansiedade que não estivessem ansiosos demais para receber o tratamento, experienciariam um alívio imediato, ainda que temporário, porque as fantasias deles são sempre piores que a realidade.

As pessoas deprimidas acham que deveriam destruir algo em si mesmas e pode-se confiar que utilizem qualquer coisa perigosa que aparece como um ato de autopunição ou suicida. Elas obtêm alívio se tentam cometer suicídio, mas não morrem. Esperam ter de matar-se ao destruir a parte má de si próprias, de maneira que a terapia de choque, que pode facilmente fazer o paciente sentir-se como se ela estivesse matando algo dentro do corpo, pode facilmente ser usada pelo paciente deprimido que acha que sobreviverá ao tratamento.

As pessoas cujas personalidades são construídas em uma base contradepressiva, personalidades hipomaníacas com um cerne central de depressão que não é reconhecido, delas se pode dizer que esperam ser capazes de desviar tudo, e imagino que possam defender-se contra serem fundamentalmente alteradas, de uma maneira ou outra.

As personalidades introvertidas tendem a não esperar nada do mundo externo, pelo menos nada de importância. Podem, contudo, achar que a convulsão é um assalto ao mundo que localizam dentro de si mesmas, e isto é uma questão inteiramente diferente.

As personalidades paranóides estão sempre esperando serem atacadas e, para elas, todos os tratamentos tendem a ser sentidos como um retorno de seu ódio projetado. O tratamento de choque facilmente se tornaria uma dramatização do delírio e têm havido casos relatados de pacientes que, a princípio, deram as boas-vindas ao tratamento e, depois, culpavam o médico por havê-los torturado (Wilson, Hardcastle)³.

5. *O efeito do tratamento de acordo com a fantasia que o paciente tem a respeito de sua personalidade e de seu corpo.* Só mencionarei este aspecto do problema de modo sucinto, embora acredite que seja o mais importante de todos.

Em todos os pacientes e, em verdade, em todas as pessoas, as fantasias pessoais sobre o corpo são importantes, mas as fantasias do paciente psiquiátrico a respeito de seu próprio corpo e personalidade são vitalmente importantes. Embora seja possível fazer grande parte da análise de uma pessoa neurótica com base na recuperação da vida instintiva na análise transferencial, sem utilizar as ricas fantasias do paciente a respeito de seu corpo, é impossível efetuar a análise de um paciente psicótico sem estar preparado para descobrir a qualquer momento que a fantasia do paciente sobre seu corpo é a coisa importante. Na realidade, a razão pela qual se imagina que os psicanalistas sejam incapazes de tratar psicóticos pode ser que, enquanto se sabe que os psicóticos se acham muitíssimo preocupados com suas fantasias a respeito de partes de dentro e partes de fora, geralmente não se sabe que os psicanalistas se

3. Wilson, *An Individual Point of View on Shock Therapy*; D. N. Hardcastle, carta do Redator-Chefe, *British Medical Journal*, 29 de janeiro de 1944.

acham hoje capacitados a levar em conta as fantasias do paciente sobre seu corpo, e fazê-lo sem se tornar místicos e sem sua tarefa principal, que é relacionar tudo finalmente ao instinto, à experiência e à realidade. Em outras palavras, temos de não apenas levar em consideração quaisquer retratos que possamos gostar de traçar para ilustrar nossa concepção da estrutura da personalidade do paciente; temos também de saber que existe uma estrutura real de personalidade, bastante rígida, se a pessoa for enferma, uma estrutura que podemos perceber se tivermos olhos e que podemos descobrir e modificar no curso da análise, sendo isto a própria fantasia inconsciente que o indivíduo tem de seu próprio *self*. Em termos de realidade psíquica, nada poderia ser mais real. Ela foi construída no decurso da experiência instintiva e, em sua estrutura, pode-se encontrar poderosas defesas e disposições cuidadosas, e o mundo externo do indivíduo também pode ser anormalmente afetado para ele pelo que quer que ele detenha lá, projetado, e pertencente ao seu interior (de acordo com a sua própria fantasia).

Existe aqui, em verdade, matéria para reflexão. Pacientes psicóticos, com estruturas complexas e rigidamente defendidas e disposições de personalidade, descobrem-se recebendo convulsões. Antes que alguém possa presumir que as mudanças que resultam de um tratamento desse tipo ou de qualquer outro tratamento são produzidas através de mecanismos físicos, ter-se-á de pesquisar a maneira pela qual esses choques são isolados pelo paciente ou se lhes permite que produzam alterações nas disposições internas que são tão tremendamente importantes em todos os detalhes para esses pacientes, ao ponto em que prefeririam morrer ou passar suas vidas em asilos, antes que afrouxar o controle.

VI. Terapia Física do Transtorno Mental⁴

1947

O título completo desta palestra era "Algumas Razões para um Preconceito Pessoal contra as Chamadas Terapias Físicas do Transtorno Mental". Ao representar minhas idéias sob esta forma, admito estar prejulgando a situação. Isto pode ser uma abordagem não-científica, mas talvez ela seja adequada no caso de tais métodos não-científicos de tratar a mente transtornada. Minhas objeções não se dirigem à brutalidade dos métodos. Comparados com a enfermidade psiquiátrica, mesmo uma espinha partida não é muito, e uma perna quebrada não é nada. Além disso, com um cuidado bom, estes acidentes podem ser reduzidos ao ponto de se tornarem compatíveis com o existir. Naturalmente, presumo a boa fé daqueles que praticam as artes contra as quais tenho preconceito. Não conheço caso algum em que poderia atribuir a aplicação da terapia física a quaisquer motivos que não sejam os motivos comuns de médicos que exercem sua profissão.

4. Do *British Medical Journal*, 17 de maio de 1947.

A Ciência na Prática Médica

Um médico é consultado porque alguém está sofrendo. Os pacientes, e especialmente seus parentes, solicitam terapia, mas o médico é treinado no método científico e seu trabalho é aplicar a ciência. Assim procedendo, ele desaponta, mesmo que dê alívio ao paciente, mas serve à comunidade por fazer parte de um baluarte contra a superstição. Acha-se aberto a qualquer um ir a um charlatão em busca de alívio mágico, mas é do médico que se espera que represente a ciência, ou a objetividade, e que não tenha medo de não fazer nada, se a ciência não puder ajudar. O diagnóstico se baseia no conhecimento científico; a base da terapia deveria ser a mesma.

Psicologia Científica

Uma abordagem científica aos fenômenos mentais decorre da aceitação da teoria de que o transtorno mental é um transtorno do desenvolvimento emocional, que a base da saúde mental se assenta no que é inato, a partir do nascimento, pelo curso do desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento dos contatos emocionais do indivíduo com a realidade externa. Através das formulações e do trabalho de Freud, especialmente de seu método para a investigação objetiva dos fenômenos inconscientes, tem havido um desenvolvimento constante do *insight* psicológico.

O desenvolvimento da psicologia científica poderia ser sucintamente descrito através de três estágios: o primeiro, que trouxe a compreensão da ambivalência neurótica; o segundo, que trouxe o entendimento da depressão e da hipocondria, e o terceiro, que trouxe a compreensão dos estados mentais mais primitivos, que reaparecem nas insânias.

Primeiro veio a elucidação dos relacionamentos perturbados entre as pessoas e dos distúrbios, em pessoas, de suas funções instintuais, em resultado de seus conflitos inconscientes. O trabalho foi feito a partir da separação entre amor e ódio, tal como apareciam na situação transferencial. Em seguida a isto, segundo me parece, a fantasia consciente e inconsciente do paciente a respeito de si mesmo começou a ser analisada: sua depressão e seu senso inconsciente de culpa tornaram-se o seu senso de algo estar errado dentro de si, e a psicologia da hipocondria tornou-se a psicologia dos resultados do amar e do odiar. A incorporação e a descarga de objetos chegaram à interpretação analítica. O trabalho de Melanie Klein tornou tudo isto possível, e a mania como alternativa à depressão foi vista como sendo um exemplo extremado da hipomania como negação da depressão.

O novo trabalho sobre a depressão naturalmente vinculou-se ao exame da integração da personalidade em si e pôde-se começar a lidar com fenômenos de integração e apreciação da realidade, etc., nos desenvolvimentos transferenciais, e eles foram postos em relação com os instintos. Estes desenvolvimentos permitiram à psicologia invadir o domínio do alienista, ou seja, o médico que trata do caso de insânia.

A Terapia Convulsiva

Juntamente com este progresso constante da ciência psicológica, houve um desenvolvimento da prática da terapia convulsiva. A minha objeção principal a esta terapia é que ela aparece como *uma fuga quanto à aceitação da psicologia do inconsciente* e quanto às implicações dos desenvolvimentos psicológicos dos últimos cinquenta anos.

É bem sabido que existem várias técnicas, mas do meu ponto de vista, a técnica elétrica é pior que as outras, por causa da facilidade com que pode ser aplicada. Além

disso, a eletricidade possui uma importância especial para o inconsciente e é bem-conhecido que pessoas paranóides e esquizóides misturam a idéia da eletricidade com idéias de influência mágica. Tais considerações não tornam necessariamente má a ECT*, mas certamente colocam-nos muitíssimo em guarda ao interpretarmos seus resultados, e quando nos defrontamos com o preconceito em favor da ECT, comum hoje entre os psiquiatras. Seja qual for a técnica, a terapia convulsiva é empírica. Ninguém tem a mais ligeira idéia de como ela funciona, quando funciona. É verdade que o empirismo não constitui uma objeção final, mas, no entanto, os cientistas odeiam-no e encaram-no como um estímulo à pesquisa.

A nossa responsabilidade é grande. O que é feito aqui na Inglaterra tende a ser feito às cegas em muitas partes do mundo, especialmente onde não existe acesso à bibliotecas, à formação no método psicanalítico ou a um debate científico livre. O mau efeito sociológico de uma terapia tem de ser considerado, assim como seu efeito imediato sobre os indivíduos.

A Teoria da Saúde Mental

A marcha da psicologia, por causa da psicanálise, é no sentido de completar a teoria do transtorno mental como sendo um distúrbio do desenvolvimento emocional. A base da saúde mental está sendo assentada na primeira infância, no relacionamento em desenvolvimento entre bebê e mãe, e de uma maneira ainda mais primitiva, entre o bebê e a sua mãe subjetiva; mais primitivamente ainda, no estabelecimento do *self* do bebê. O resultado desta teoria é o resultado proveitoso de que a prevenção do transtorno mental constitui uma tarefa nova da pediatria. Em contraste, o resultado da terapia empírica de pessoas mentalmente enfermas através de métodos físicos é relativamente infrutífera; é que se tem de encontrar, cada vez mais, neurologistas qualificados para aplicar convulsões às pessoas. Trata-se de dois resultados sociológicos que podem ser comparados um com o outro.

Muitos outros além de mim deploraram o fato de que a terapia convulsiva inevitavelmente afasta-se da abordagem psicológica, em favor de uma abordagem bioquímica e neurológica. A terapia convulsiva atrai para os hospitais psiquiátricos pessoas com qualificações de primeira ordem para lidar com as complexidades do choque insulínico e de todas as alterações bioquímicas que precisam ser estudadas neste tipo de trabalho. As terapias físicas, em geral, atraem para a psiquiatria médicos jovens que pensam de maneira física e é sempre improvável, que homens e mulheres que chegarem a um alto grau de formação pós-graduada no lado físico, estejam dispostos ou sejam capazes de começar de novo e ingressar na psicologia desde o seu início. A leucotomia, em grau extremado, atrai o tipo errado de médico para a psiquiatria. Em minha opinião, a moderna aceitação da leucotomia é o resultado direto da aceitação da teoria empírica do choque.

Se os resultados sociológicos da terapia convulsiva são maus, os da leucotomia são deploráveis. Acredito que a leucotomia é o pior erro honesto da história da prática médica. Nos hospitais psiquiátricos, o resultado da leucotomia é um novo acesso ao poder por parte do neurocirurgião, um praticante não-qualificado, do ponto de vista do psicólogo. Não nos deixemos enganar por seu altíssimo grau de perícia como neurocirurgião, pois isto nada tem a ver com o caso. Se deploramos a leucotomia e seus efeitos colaterais, temos de deplorar as terapias convulsivas que prepararam o caminho para ela. O sentimento contra a leucotomia é grande demais para encontrar expressão: o público em geral, assim como os médicos, está estarelecido demais por esta aplicação de um método empírico, para fazer algo a seu respeito. E têm medo de

* A tradução de *Electric Convulsion Therapy* (ECT) é Terapia eletroconvulsiva ou eletrochoque. Optamos por utilizar a sigla original por já ser habitual em nosso meio.

que, se levantarem objeções, os psiquiatras deixarão de aliviá-los do terrível ônus de parentes e pacientes insanos.

Permitam-me aplicar a fórmula que imaginei anteriormente. Hoje, em vez de um sofrimento a exigir tratamento mágico e que é atendido por um médico que aplica a ciência, tornou-se verdadeiro dizer que o sofrimento da sociedade (por causa de seus membros mentalmente enfermos) conduz ao uso do médico (porque se imagina que atue de acordo com princípios científicos) para ocultar uma aplicação (em pânico) da magia. A leucotomia deveria ser um remédio de charlatães, acessível àqueles que pedem "curas".

Deste tema da leucotomia, com suas alterações cerebrais irreversíveis, retorno à terapia convulsiva com uma sensação de alívio. Pelo menos aqui não se causam danos (ou assim delicadamente presumidos). Se revelamos que os efeitos, bons e maus, da ECT são, ao final das contas, efeitos psicológicos, nenhum indivíduo foi realmente prejudicado, e aquele que se submeteu à convulsão ainda pode empregar a psicoterapia, se ela lhe aparecer pela frente. Ele pode até mesmo recuperar-se espontaneamente, com o decorrer do tempo e uma boa administração, se assim se achar predisposto.

Objeções à Terapia Convulsiva

Para condensar as opiniões que expressei até aqui, eu não aplicaria terapia convulsiva, porque (1) não permitiria que ela me fosse aplicada; (2) ela atrai o tipo errado de médicos, habilitados de maneira errada; (3) solapa a justificação do público para apoiar-se em médicos que mantenham suas cabeças científicas em face da demanda por magia; (4) esta forma de terapia, que é feita aqui na Inglaterra, conduz a tratamentos massificados, pelos mesmos métodos, através de todo o mundo; (5) métodos físicos de tratamento representam uma tendência a afastar-se da psicologia científica. Aqui, eu gostaria de adicionar um novo ponto, qual seja, o de a indicação principal para a ECT parece ser a melancolia involutiva e as depressões menores.

Ora, *depressão é a moléstia das pessoas de valor*. Na depressão fronteira, ela é o colapso de pessoas que se acham sobrecarregadas de responsabilidade ou perda. Deste lado da linha divisória, temos a pessoa de valor, com frequência uma boa mãe, que se onera com uma preocupação demasiada. Do outro lado, temos o mesmo fenômeno, mas menos consciente, e isto é depressão. Na depressão, pelo menos, o paciente sofre por causa de sua própria enfermidade. A ECT, atualmente, está sendo aplicada a pessoas valiosas e, se isto for reconhecido, fora de dúvida torna o psiquiatra muito preocupado em verdade quanto à sua própria adequação para a tarefa. Poucos de nós somos imunes à depressão e, se dela escapamos, é possível que o tenhamos feito através de uma defesa contradepressiva que é mais anormal que a fase depressiva franca de um paciente.

Efeitos Psicológicos da Terapia Convulsiva

Havendo desta maneira resumido o meu preconceito, gostaria de dar meu palpite aos futuros desenvolvimentos da psicologia da terapia convulsiva. Penso que os psicanalistas — e aqueles por essa maneira treinados — deveriam trabalhar, atualmente, na presunção de que todos os resultados da ECT — bons, maus e indiferentes — são resultados psicológicos. O campo imenso dos efeitos psicológicos da idéia da ECT tem sido seriamente negligenciado. Para debater isto não é necessário ter aplicado a ECT a mil pacientes ou, em verdade, haver aplicado a um só tratamento que seja. O que precisamos fazer é reunir experiências dos sentimentos e das idéias encontrados

durante a análise de pacientes que fizeram terapia convulsiva e de pacientes que se achem em contato com outros que passaram por essa terapia.

Necessidade de Pesquisa

Apresento duas linhas de abordagem. O tema que precisa urgentemente de pesquisa é o das reações conscientes e inconscientes do paciente a (a) idéia da ECT, etc.; (b) a experiência de submissão à terapia convulsiva, e (c) a convulsão em si. Aqui vão algumas sugestões:

(a) *Reação à idéia de receber uma convulsão* - Imagino que uma pessoa *normal* odeie a idéia. Deve ser por esta razão que os psiquiatras não aplicam convulsões a si mesmos sempre que se sentem um pouco deprimidos. As pessoas *ansiosas* têm probabilidades de ficarem assustadas com a idéia das convulsões, da mesma maneira por que podem se assustar com qualquer coisa. Em comparação, podem mostrar-se especialmente bravos quanto à experiência real. As dificuldades dos pacientes *obsessivos* aumentam grandemente quando a idéia da terapia convulsiva lhes é apresentada. A defesa organizada contra a espontaneidade e a ausência de controle tende a ser fornecida. A dúvida obsessiva fica sujeita a encontrar um lugar no problema de dar ou não permissão, e sentir-se-á culpa seja qual for a linha que for seguida. Na *paranóia* organizada, as convulsões são facilmente sentidas como fazendo parte do ataque hostil que é esperado. Em certa paciente, uma moça que tinha o delírio de que alguém estava tentando destruir-lhe o cérebro, essa forma de terapia foi sentida como sendo uma confirmação absoluta do referido delírio. Em casos de *delírios de transferência de pensamento* e nas fantasias que tão facilmente se mesclam com teorias de fenômenos elétricos e influência maliciosa, pode-se bem imaginar que a terapia de choques elétricos tenha uma importância especial.

(b) *Reação à experiência de receber convulsões* - Em casos com tendência à *histeria de conversão*, um conhecimento parcial do funcionamento cerebral é facilmente empregado na racionalização das paralisias e parestesias que acompanham a terapia convulsiva. As *pessoas depressivas* igualam a convulsão ao morrer, e facilmente sentem-se absolvidas por haverem experienciado o que se assemelha a encontrar a morte. Elas têm desejos após a terapia convulsiva. Em alguns casos, cada convulsão sucessiva se torna mais temida, e a última é igualada à morte; a recuperação dela concede uma nova vida, por causa da experiência emocional. Impulsos *suicidas* podem ser atendidos através da convulsão. Através desta aparente experiência da morte, um paciente suicida pode utilizar a terapia convulsiva como uma alternativa ao suicídio. Ela é comparável ao alívio que um paciente desse tipo pode obter mediante uma tentativa genuína, ou seja, uma tentativa da qual o paciente só se recobra através de uma intervenção exitosa.

(c) *Reação à convulsão em si*. - No que pode ser chamado de *neurose de introversão* o paciente organizou um mundo interior secreto no qual os relacionamentos são bons, e isto foi alcançado à expensas da confiança no mundo externo, no qual são colocados os relacionamentos maus. É provável que, nestes casos, a convulsão em si seja sentida como uma ameaça ao mundo interno artificialmente bom, e, em consequência disso, tem-se de se fazer uma redistribuição, com um amearramento secreto menos completo de relacionamentos bons internos.

Esta abordagem é experimental e admitidamente incompleta, mas a forneci para indicar a maneira pela qual os resultados da terapia de choque podem ser examinados como fenômenos psicológicos. É exatamente aqui que se necessita mais urgentemente da pesquisa. De modo bastante curioso, também é exatamente aqui que os praticantes da terapia convulsiva se mostram menos dispostos a investigar. Grande parte da objeção à terapia convulsiva desapareceria se o mecanismo através do qual os resulta-

dos são obtidos fosse compreendido. O problema principal é que falsas teorias são erigidas em torno da pressuposição de que o mecanismo através do qual a mudança é ocasionada é físico, e estas teorias prepararam o caminho para o emprego amplo da leucotomia. Quem sabe o que pode seguir-se?

As Reações Inconscientes da Sociedade à Insanidade

Quero também apresentar a idéia de que estas terapias físicas expressam a reação inconsciente da sociedade à insanidade. Esta é, de longe, a coisa mais difícil que tenho a dizer. Tenho razões para crer que os resultados bons que podem provir destas terapias físicas dependem disto: de que, através deles, dá-se expressão, sob forma aceitável (porque oculta), à aflição inconsciente que a sociedade experiencia em face da doença mental. Por inconsciente quero dizer realmente inconsciente, quero dizer reprimido e inacessível à consciência. Sentimentos maciços de culpa, medo, e conseqüente ódio, são despertados em pessoas que estão preocupadas com pessoas mentalmente enfermas, e penso que este ódio inconsciente também se acha subjacente à crueldade com os pacientes psiquiátricos, que notoriamente coloriu a administração dos insanos até épocas recentes.

Conclusão

Como últimas palavras, gostaria de dizer que não tenho esperanças de que estes argumentos provocarão qualquer diferença súbita na prática hoje estabelecida da psiquiatria. O transtorno mental pode ser enlouquecedor de cuidar. A abolição da terapia de choque amanhã colocaria sobre os médicos e as enfermeiras dos hospitais psiquiátricos uma carga emocional que eles não podem repentinamente assumir, e existirão aqueles que alegam que somente isto justificaria o método. Percebo o seu argumento, e o respeito. Apesar disso, parece haver necessidade de que alguém registre uma objeção intensa a métodos fáceis e sedutores, que tendem a se afastar do difícil caminho que tem de ser percorrido por aqueles que tentam compreender a natureza humana e abster-se da magia.

Terapia Física do Transtorno Mental: Leucotomia

I. Leucotomia Pré-Frontal

Carta ao Redator-Chefe de The Lancet, 10 de abril de 1943

Prezado senhor: O Dr. Fleming e o Sr. McKissock descreveram 15 casos tratados por leucotomia pré-frontal e o Dr. Hutton, 50. É precisamente por seu trabalho ser de uma ordem tão alta que aproveito esta oportunidade de chamar a atenção para a objeção especial que facilmente se sente quanto ao tratamento do transtorno mental através de qualquer método que deixe uma deficiência física permanente ou uma deformidade do cérebro, mesmo que se possa demonstrar que resultados favoráveis seguiram-se em certos casos.

A teoria de que a esquizofrenia, a depressão maníaca, a psicose e a melancolia são enfermidades com base física, ainda é sustentada por algumas pessoas, mas a teoria alternativa de que essas moléstias mentais são transtornos do desenvolvimento emocional (com graus variáveis de fatores hereditários) não foi contestada. Sugiro que até que isto venha a acontecer com a última teoria, é em verdade algo muito sério para um médico sujeitar pacientes a uma operação em que os tecidos reais do cérebro são cortados fora. Compete àqueles que desejam curar o transtorno mental através de medidas operatórias, ou pela indução de convulsões, provar primeiro que as insanidades são realmente enfermidades do tecido cerebral.

Sustento a teoria de que a insânia comum é uma condição estreitamente aliada ao gênio, ao talento especial e à personalidade de excepcional valor, e, naturalmente, fico perturbado quando ouço falar em tratamentos que obstem completamente a recuperação completa, mesmo que se possa mostrar que esses tratamentos provocam uma mudança no sentido da sanidade, em certa proporção de casos.

Ademais, é uma ajuda muito grande para pessoas com dificuldades mentais poderem elas contemplar ou mesmo ter um período de colapso. A idéia do paciente voluntário parece-me achar-se erigida sobre isso, mas o público está começando a saber que um colapso significará um curso de convulsões ou, talvez, uma deformidade permanente do cérebro, e não acho que isto seja o tipo de coisa a incentivar àquele relato precoce de sintomas que é corretamente buscado por aqueles que tratam as psicoses.

D. W. Winnicott

II. Leucotomia¹

1949

Sob muitos aspectos, o estudante de medicina está lá para aprender, pospondo até sua habilitação à atitude de indagação que é pertinente à maturidade e à saúde. Talvez a leucotomia, o tratamento do transtorno mental através de um procedimento cirúrgico que destrói o tecido cerebral, forneça um bom exemplo de uma terapia que se acha aberta à questão, e essa necessidade não precisa ser aceita, sequer para o intuito de satisfazer os examinadores.

Na imprensa médica já expressei minha crítica pessoal da leucotomia nos mais fortes termos possíveis, por acreditar que ela representa a pior tendência possível na prática médica; essa crítica, porém, sempre foi feita com respeito às opiniões sustentadas por aqueles que utilizam o método e nunca com respeito aos próprios médicos, de quem tenho conhecimento como sendo pessoas comuns que fazem o melhor que sabem por seus pacientes e a experimentarem apenas quando genuinamente acreditam perceber justificativas para as experiências.

Deve ser recordado que existem, em grande número, pessoas insanas nos asilos das Ilhas Britânicas, e que isto representa um sorvedouro tremendo em termos de homens-horas de médicos e enfermeiras. Ninguém pode ser criticado por tentar aliviar o fardo que recai sobre a comunidade e é causado pelos irremediavelmente insanos. A leucotomia torna alguns pacientes muito difíceis menos difíceis e mitiga o sofrimento prolongado dos que padecem agudamente. Não é de admirar que os neurocirurgiões se voltem da técnica altíssimamente capacitada, que lhes permite retirar raros tumores cerebrais, para a extirpação, que exige uma perícia muito menor, de tecido nervoso com respeito a uma condição comum. De qualquer modo, poder-se-ia argüir, os cérebros dos piores casos mentais já se acham enfermos — sífilicos, esclerosados, marcados por cicatrizes de processos inflamatórios.

Quais são então as razões que me fazem pensar que a operação deva ser abandonada?

Em primeiro lugar, responderia eu, se o que se aprende é aliviar a comunidade do ônus dos desesperadoramente insanos, porque não um corte mais completo, da "medula ablougata", digamos, ou então, uma política deliberada de eutanásia? A resposta é que isto coloca sobre o médico uma responsabilidade que ele não deve ter, qual seja, a de decidir sobre a vida e a morte com respeito a um semelhante. Trata-se de algo diferente das decisões que médicos fazem todos os dias com relação a suas opiniões quanto a diagnóstico e tratamento para curar a enfermidade.

O argumento simples, qual seja, o de ser justificada qualquer coisa que alivie a comunidade ou mitigue o sofrimento pessoal, não é suficientemente bom. Os argumentos em favor da leucotomia podem começar pela reivindicação de que é um tratamento bom para um paciente que esteja mentalmente enfermo, isto é, com a probabilidade de que efetue uma cura, mas ele tem de ir mais além e demonstrar que não é prejudicial para as pessoas em geral.

Deve ser lembrado aqui, que é uma coisa curar um paciente de câncer do seio pela retirada do seio e outra, inteiramente diferente, "curar" um paciente de transtorno mental pela remoção de uma parte da função cerebral. No primeiro caso, a pessoa permanece intacta; no segundo, é a pessoa que é mutilada.

1. Para o *British Medical Students' Journal* 3 (1949).

A teoria atual é de que é o tecido cerebral de que se precisa antes que a mente possa sequer começar a existir, e qualquer outra teoria tem de primeiro resolver esta, se quiser ser aceita. Aqueles que praticam a leucotomia não tentaram fornecer uma teoria nova, mas deixaram que se presumisse ser o cérebro o órgão físico necessário para o funcionamento da mente e, conseqüentemente, para a organização da personalidade.

Neste ponto do argumento, temos de considerar o fato de que certos pacientes muito enfermos foram consideravelmente ajudados pela leucotomia, abandonaram mesmo o hospital e retornaram ao trabalho e à vida familiar. Se o tratamento foi aplicado apenas a pacientes muito doentes, então nenhum mal foi causado e, para alguns, houve até benefícios.

Infelizmente, um tratamento não pode existir dentro de uma maneira circunscrita como esta, e ele logo é aplicado a casos menos graves. Teorias surgem e (no caso da leucotomia) a possibilidade de tratamento concede poder e direção no hospital psiquiátrico ao neurocirurgião, cuja perícia reside na cirurgia do cérebro e que não foi treinado para ser um estudioso da natureza humana.

Primeiramente, com referência à aplicação mais ampla do tratamento, é natural que cada unidade queira completar o seu milhar de casos, a fim de ter um número redondo para os relatórios, e alguns desses mil encontrar-se-ão diagnosticamente situados na extremidade menos enferma; de fato, poder-se-á ver nos relatórios, que já foram leucotomizados pacientes diagnosticados como padecendo de depressão, neurose obsessiva, etc., ou seja, certamente casos que não se acham confinados aos cerebralmente enfermos.

Isto levanta a imensa questão da psicogênese da insanidade. Pode-se dizer que é impossível ser cirurgião e, também, estar psicologicamente bem-informado. As duas disciplinas são exigentes demais para que um só médico as aprenda de modo completo, a um só e mesmo tempo. É seria mais fácil para um psicólogo, realmente de primeira linha, aprender a ser neurocirurgião do que este aprender a ser psicólogo, simplesmente porque a psicologia só pode ser aprendida no decorrer de um período de tempo no qual quem a aprende tem de crescer para atender às demandas emocionais que a psicologia coloca sobre ele. Nenhum estudante de medicina, por brilhante que seja, pode apenas *aprender* psicologia; ele tem de passar anos amadurecendo e desenvolvendo a sua própria personalidade, enquanto gradualmente aprende a lidar com o assunto. Na realidade, a experiência demonstra que a psicologia ensinada a estudantes de medicina pode facilmente perturbar até mesmo aquelas personalidades que parecem ser estáveis. A regra dos psicanalistas é indubitavelmente certa: a psicologia do inconsciente só pode ser ensinada a pessoas que estejam sendo analisadas ou que tiveram uma análise anterior bem-sucedida.

Relatórios sobre a psicologia de pacientes antes e depois da leucotomia, fornecidos de boa fé por neurocirurgiões, tendem a parecer extremamente ingênuos ao psicanalista, que está forçosamente acostumado à extrema complexidade do material humano e mais ciente do que a maioria com relação às áreas de ignorância na compreensão das pessoas.

Existe uma imensa quantidade de provas disponíveis àqueles que se importam em estudar os aspectos da psicologia mais profundos do que as insânias comuns — a esquizofrenia, as depressões, a paranóia, assim como a neurose obsessiva e a delinquência — são transtornos do desenvolvimento emocional, *não transtornos que dependem de mudanças no tecido cerebral*. Obviamente, alterações do tecido cerebral produzem mudanças de personalidade e comportamento, mas as pessoas que são mentalmente enfermas, em geral, o são apesar de possuírem um tecido cerebral sadio. A doença mental, que não é apenas um estado de confusão, é um padrão organizado, uma organização de defesas, de resistências e de adiamentos do desenvolvimento emocio-

nal para a frente. Este padrão pareceria lógico ao investigador se toda a verdade fosse conhecida. Se uma pessoa insana for estudada em detalhe suficiente, o curso da enfermidade se torna inteligível como expressão das dificuldades inerentes à vida, quais sejam, as dificuldades no desenvolvimento pessoal, as dificuldades da influência ambiental e a interação entre as duas. Não se pode argumentar que, pelo fato de a sífilis cerebral produzir idéias de grandeza e de a arteriosclerose causar perseverança de idéias ou estreitamento do intelecto, o distúrbio emocional releve mudanças subjacentes do tecido cerebral. Na realidade, todas as provas apontam na outra direção.

O neurocirurgião, contudo, que parte pronto a ver a insânia como uma coleção de enfermidades separadas, com modificação do tecido cerebral, não se persuade facilmente de que seus pacientes ainda são seres humanos. Mesmo quando se mostram retraídos, degenerados ou incontinentes, eles ainda se acham lutando com os problemas da vida que, para os mais felizes de nós, foram meramente um pouco mais fáceis de solucionar. Quando aqueles que não são psicólogos vêem sintomas e resistências desaparecem após a leucotomia, eles se sentem apoiados em suas teorias e não têm idéia de que a remoção das resistências pode significar a perda final da individualidade da pessoa interessada.

São realmente apenas os psicanalistas que respeitam as resistências e percebem nelas a luta inconsciente da pessoa por se encontrar. Toda a tendência da terapia moderna (não-psicanalítica) é contornar as resistências.

Talvez o melhor exemplo que possa haver desse contornar das resistências seja a operação de leucotomia. Na verdade, qualquer pessoa que sinta estar ficando enferma de maneira mental, nos dias de hoje, não pode estar segura de que não será insultada pela interferência física em seu tecido cerebral. Esta não é exatamente a melhor maneira de fazer as pessoas se apresentarem espontaneamente para tratamento nos estágios iniciais de transtorno psiquiátrico. Muitas que se recuperariam espontaneamente com alguns meses de tolerância e se possível, cuidados em algum lugar e impedidos de se suicidarem quando em estado depressivo, em verdade lutam, em sua vida comum, com o medo (bem-fundado) de que não se recuperarão sem que lhes seja aplicada pelo menos uma série de convulsões e, talvez, sem que o cérebro lhes seja irreversivelmente alterado. Após a interferência com o cérebro físico, nenhum homem ou mulher pode estar certo de sua identidade: ele não está mais lá para ter certeza, porque a pessoa que foi construída durante todo o tempo que se passou desde o nascimento não se acha mais lá.

Se me conduzo hoje de maneira aceitável, esta façanha é um trabalho de toda a minha vida e uma contribuição social positiva, um exemplo infinitamente complexo e ativamente significativo da relação existente entre tudo o que é meu, desde meu nascimento, com todo o meu meio ambiente. Se me comporto ainda melhor por haver feito uma leucotomia, não estou fazendo uma contribuição melhor, porque não sou eu que estou me comportando.

Os seres humanos têm o direito de terem todo o tipo de sonhos, inclusive os mais sádicos, e nosso trabalho, como praticantes médicos com formação científica, é fornecer ao público uma realidade com a qual possam comparar seus sonhos. Os pacientes sonham que seus médicos acham-se apaixonados por eles, mas o juramento médico impede isso, e só muito raramente acontece que um médico abuse de suas oportunidades de intimidade. Os sonhos podem ser comparados com a realidade.

Da mesma maneira, os pacientes sonham com médicos maus a realizarem operações fantásticas e mutiladoras. De modo geral, os médicos não operam exceto em condições altíssimamente controladas, empregando princípios científicos que justifiquem completamente as suas ações. A leucotomia parece, para mim, pessoalmente, achar-se na linha fronteira entre a ciência e a superstição. Acho que as pessoas não deveriam ter de passar por essa provação com a qual têm medo até de sonhar. Os que

praticam a leucotomia estão assustando pacientes muito mais do que aliviando o sofrimento de uns poucos indivíduos colocados a seus cuidados, estão produzindo um medo dos médicos e aumentando o medo da loucura. Isto tem efeitos de grande alcance. O medo da loucura leva a uma fuga para um extremo de sanidade que constitui um passo falso em civilização; significa uma fuga para o lógico, para o consciente e para o facilmente planejado, e uma perda de contato com a integridade individual e com as profundezas ocultas da personalidade de cada pessoa.

Em minha opinião, a responsabilidade assumida por aqueles que cegamente cortam os cérebros de pessoas só porque elas são insanas é tremenda, e compete-lhes se dar mais trabalho do que se deram até aqui em demonstrar que reconhecem as implicações mais amplas de sua prática.

III. Notas sobre as Implicações Gerais da Leucotomia

*Utilizadas para abrir um debate sobre leucotomia realizado na
London School of Economics, em 13 de novembro de 1961*

Levantamento Preliminar

1. O fato da doença mental.
2. Os problemas reais de administração.
3. A revolução na enfermagem do hospital psiquiátrico.
4. O valor dos tratamentos físicos.
5. A evolução gradual da opinião profissional sobre os variados tratamentos.

Enunciado da posição atual dos tratamentos físicos na psiquiatria.

Ponto de Vista Pessoal

Considerar uma série de tipos de tratamentos físicos; em uma das extremidades:

cuidado físico, permissão para regredir;
depois: adição de narcóticos;
depois: medicamentos que auxiliam o reviver de situações esquecidas;
depois: choque insulínico (trabalho qualificado de equipe);
depois: terapia eletroconvulsiva (trabalho relativamente não-qualificado);
depois: leucotomia;
depois: eutanásia.

Considerações Filosóficas

1. ECT — sendo não-qualificada, tem um efeito sobre as teorias do crescimento e anormalidade da personalidade humana sustentadas por quem a pratica.

2. A leucotomia altera a sede do *self*, dá valor ao alívio do sofrimento e cria equipes de neurocirurgiões exímios que constituem um tipo de interesse adquirido que pode afetar a avaliação científica. Teoria da insanidade como organização do *self* apropriada às circunstâncias.

Influência das Emoções Sobre o Julgamento

Separação, um do outro, de dois temas (inter-relacionados, naturalmente): (a) eficácia da (digamos) leucotomia, comparada com a da (digamos) psicanálise, e que envolve o debate do significado da palavra "eficácia" neste contexto; (b) considerações filosóficas, ética da interferência com o funcionamento cerebral, ética da terapia que envolve alterações irreversíveis.

Observação: Nos trabalhos psiquiátricos, atualmente, (a) está sendo inteiramente debatido sem referência a (b).

A Importância Relativa dos Vários Órgãos Corporais para a Existência de uma Psique Individual

Obviamente a psique sadia precisa de um órgão saudável e intacto. Apesar disso, é possível examinar os valores relativos de várias partes do corpo para a psique.

Mutilação do cérebro vis-à-vis castração:

ansiedade a respeito da mutilação cerebral, ansiedade a respeito da castração (consciente, inconsciente)

mutilação cerebral como *simbólica* da castração

Implicação falsa: a de que a mutilação cerebral é *apenas* simbólica de castração, ou seja, que não é por si mesma merecedora de medo, evitação, condenação, etc.

Ilustrações (considerando apenas indivíduos do sexo masculino, para simplificar):

a. *Mutilação dos nervos motores principais que conduzem aos membros superiores.* Resultado: desamparo. Poderia ser efetuada (imaginemos) como cura para a masturbação, o roubo, ou atos agressivos para com pessoas. É *impensável*; sabemos que nenhum cirurgião efetuariá essa operação neste país.

Ela, contudo, deixaria a psique intacta. Um biógrafo poderia escrever: "ele suportou o insulto com dignidade". Talvez a vítima pudesse dizer: "Perdoai-os, pois não sabem o que fazem!" A circuncisão é com frequência realizada para curar ou impedir a enurese, a masturbação, as aberrações sexuais, demonstrando que a cirurgia pode facilmente tornar-se serva da superstição e do ódio inconsciente.

b. *Castração, isto é, retirada dos testículos.* Aqui, conhecemos os resultados. Até certo ponto a psique é afetada, pelo fato de as pulsões instintivas serem modificadas. O efeito sobre ela, portanto, é mais direto que a retirada de outras (ditas) glândulas internas, isto é, glândulas que produzem hormônios.

Atualmente, a castração jamais seria realizada como tratamento de transtornos de comportamento, nem, tampouco, a pedido do indivíduo (embora faça parte da organização masoquista que exatamente essa solicitação seja feita). A operação deixa a psique, até certo ponto, intacta, mas a alteração é irreversível a menos que um extrato testicular possa ser preparado para substituir exatamente os hormônios internos perdidos, caso em que a psique ficaria novamente intacta, embora o indivíduo tivesse de ajustar-se

a ser incapaz de procriar. Os cirurgiões às vezes ligam os dutos que conduzem os espermatozoides desde os testículos, de maneira a que o paciente não precise temer engravidar a mulher com quem compulsivamente coabita. Isto não é necessariamente irreversível. (Cf. mulheres após retirada do [a] útero, [b] ovários, a quem se adicionam extratos ovarianos que substituem os hormônios.)

c. *Considerações subsidiárias.* Pode-se dizer que a ablação de ambos os rins deixa a psique intacta, exceto que, gradualmente, desenvolve-se uremia e há uma distorção crescentemente tóxica da personalidade, até que a morte sobrevenha. A retirada de um membro naturalmente afeta o indivíduo, sendo importante a causa dessa retirada. A psique, contudo, fica intacta. A cegueira, a surdez, etc., afetam todas elas o indivíduo, mas deixam intacta a psique: é a própria pessoa que se ajusta ou fracassa em ajustar-se à mutilação.

Até onde se pode dizer, nenhum dano é usualmente causado ao tecido cerebral em resultado de convulsões eletricamente induzidas, embora seja muito difícil provar isto. Poucos de nós voluntariamente submeter-se-iam a um tratamento de dez convulsões. (Podemos ignorar os acidentes pertinentes tanto a esta forma de tratamento quanto a qualquer outra. — dosagem excessiva, fratura da espinha, etc. — uma vez que eles não afetam o problema principal.)

d. O *tratamento cirúrgico do cérebro* tem de ser agora considerado. Tumores cerebrais podem com frequência ser removidos, constituindo esta operação uma das mais notáveis na cirurgia. Em alguns casos, ela pode ser completamente bem-sucedida. Em outros casos, a substância cerebral maior ou menor se acha envolvida, de maneira que, após a operação, o paciente não consegue efetuar um retorno completo ao normal. Algo da personalidade se foi ou alterou-se. Isto é inevitável. O mesmo pode ser dito de outras operações do tecido cerebral para *cura cirúrgica de anormalidades cerebrais*.

Não é este grupo de fenômenos que se acha em discussão. A consideração deles, contudo, é importante, uma vez que traz ao primeiro plano o axioma de que *o tecido cerebral, de maneira geral, é o pré-requisito somático (ou físico) para a existência da psique*. Algumas partes do cérebro são mais importantes do que outras a este respeito (os centros sensorio e motor são menos importantes, por exemplo), mas não existe outro órgão que tenha importância comparável para a existência da psique.

Pergunta: Isto é auto-evidente ou trata-se de algo que precisa ser estabelecido?

Tema Principal

O que está sendo discutido é a *mutilação de tecido cerebral normal e sadio para o tratamento de transtornos da psique*, isto é, alterar o comportamento de um indivíduo, minorar o sofrimento, tornar mais fácil a enfermagem, restaurar a *eficiência funcional*. Está sendo feito aqui algo que ataca a própria psique, pela perturbação de sua base física.

De uma pessoa assim tratada não mais podemos dizer que "ele suportou a mutilação com fortaleza de ânimo" porque o significado da palavra "ele" se alterou. Não podemos dizer que "ela sofre agora menos do que antes" porque "ela" não é mais a mesma de antes. Tudo o que poderíamos dizer seria: "Enquanto que ele ou ela total sofreram (ou se comportaram mal), o novo ele ou ela subtotal sofre menos (ou se comporta mal)".

Disse ser impensável que (a) ou (b) fossem realizadas por um cirurgião hoje, neste país. Contudo, essa operação infinitamente mais terrível foi efetuada em milhares de pessoas nos últimos dez anos, e os defensores do tratamento estão reivindicando um campo cada vez mais amplo para as suas atividades. A princípio, era apenas o caso hospitalar psiquiátrico sem esperanças que era leucotomizado. Depois, gradual-

mente, neuróticos obsessivos foram tratados desse modo, assim como melancólicos cujo próprio sofrimento não podia ser tolerado pelos médicos encarregados deles. Hoje, o tratamento é defendido para todo o tipo de transtornos psicossomáticos. Em breve, o único sintoma que não qualificará uma pessoa para esse tratamento será a obsessão no sentido do tratamento pela leutocomia, um transtorno contagioso que pode ser encontrado principalmente (ai de nós!) em psiquiatras.

O Efeito sobre o Público Geral

Este é um tema para pesquisa por parte do psicólogo social. O fato de a leucotomia ser praticada torna alguém mais ou menos temeroso da loucura? Pode acontecer que a apatia do público para com este problema — que se assemelha ao da eutanásia que fosse, por assim dizer, praticada diariamente — seja devida ao medo?

O Medo Associado ao Problema da Leucotomia

1. Temor consciente de que algum dependente que é insano seja mandado de volta para casa pelo hospital psiquiátrico.

2. Medo de que alguém que se torne um interno voluntário em um hospital psiquiátrico seja irremediavelmente mutilado.

3. Temor do desejo de ser mutilado (masoquista, culpa inconsciente, etc.); cf. medo do suicídio.

4. Medo da idéia de um médico malevolente; este temor sempre se acha à espreita por trás da crença usual no próprio médico, quando se está doente. Quando se está enfermo, um médico maligno é indispensável.

5. A questão da alma e sua relação com a psique-soma. Um bebê recém-concebido começa ao par com respeito à alma, ou a certo grau acima do par? Convicções religiosas muito profundas acham-se envolvidas neste problema, e a maioria das pessoas gosta de aceitar como certo que a alma é implantada, da mesma maneira que Deus não é concebido, mas percebido.

A Questão Crua

Para colocar o assunto de maneira crua, ou eu sou louco ou o psiquiatra em questão é louco.

No primeiro caso, o Dr. X assinará um atestado e ordenará a minha leucotomia (com as melhores intenções) e não existirá mais um D. W. W.; o *yes-man* que resultar será um D. W. W. subtotal, fora de dúvida muito mais feliz, livre de fervor missionário e senso social, liberado para os prazeres que pertencem à ausência de um objetivo verdadeiro.

No segundo caso, o psiquiatra é louco e eu o psicanaliso. Naturalmente, ele não quer ser psicanalisado, de maneira que permanece sem análise e eu permaneço um analista frustrado. Mas ele conserva intacta a psique. Esta é a diferença entre as duas terríveis alternativas.

Podem perceber porque, para mim, trata-se de uma questão muito séria, uma questão que é a escolha do mundo, pois a sociedade atual é que deve decidir, não os psiquiatras que se acham atravancados com problemas clínicos imediatos. Quem deve ser considerado louco? Mas enquanto eu estou lutando pela própria existência de minha psique, o meu adversário sabe que a psique dele lhe será deixada intacta e sabe também que, quando resiste ao tratamento psicanalítico, será pelo menos ele próprio quem resiste. Eu o invejo.

IV. Leucotomia Pré-Frontal

*Carta ao Redator-chefe do British Medical Journal,
de 28 de janeiro de 1956*

Prezado senhor: A correspondência sobre leucotomia que se reiniciou faz-nos lembrar que não existe lugar em que esse tema possa ser debatido em sentido amplo a não ser as colunas desse periódico.

Há alguns anos atrás expressei minha opinião de que a leucotomia constituía o pior erro honesto na prática médica recente e com freqüência me perguntam se o tempo me levou a alterar essa minha opinião. Na realidade, não alterou. Ela não conduz muito peso por causa do fato de eu não haver feito um esforço especial para examinar pacientes leucotomizados e a minha objeção não estar baseada em estudo clínico direto. Baseia-se, contudo, no estudo indireto, tal como a análise de pacientes, alguns dos quais foram pacientes em hospitais psiquiátricos. Viesse eu a encontrar um caso que indubitavelmente melhorou por causa da leucotomia, minha opinião não se alteraria. Na realidade, porém, só me deparei com a aflição, devido à existência da leucotomia como método de tratamento.

Tem-se de lembrar que a leucotomia constitui um distúrbio deliberado de tecido cerebral sadio, com o objetivo de ocasionar modificações mentais que, na opinião do psiquiatra, são boas. Nada existe aqui de comparável à tentativa de remover um tumor cerebral ou aliviar uma hemorragia subdural. Toda a questão gira em torno da visão que o psiquiatra tem do que é bom, e os psiquiatras não fizeram nenhuma tentativa de debater o significado da palavra "bom" neste contexto.

As cartas dos Drs. D. W. Standley (3 de dezembro de 1955, p. 1390) e Clifford Allen (17 de dezembro de 1955, p. 1502) fazem-me desejar reenunciar à minha opinião: (a) Existem hoje muitos casos aflitivos pós-leucotomia na comunidade, e os parentes acham-se preocupados agora não com colapsos de esforços humanos, que são compreensíveis, mas com efeitos posteriores de procedimentos neurocirúrgicos muito questionáveis. Mudanças irreversíveis foram produzidas em pacientes cujas moléstias eram, pelo menos *teoricamente*, capazes de remissão anteriormente à operação. Não é provável que a carga emocional destes casos seja assumida pelos psiquiatras, que são responsáveis por devolverem à comunidade algo pior que o terrível ônus de uma criança deficiente. (2) Todos os pacientes de hospitais psiquiátricos, voluntários ou atestados como insanos, tornam-se rapidamente preocupados com o problema: "Serei submetido à E.C.T., ao choque insulínico, à leucotomia?" Por uma razão ou outra, os psiquiatras parecem não saber disso, mas os pacientes psiquiátricos falam de pouca coisa mais. Eles se acham em um dilema no qual nunca deveriam encontrar-se, no qual o médico parece estar se apresentando do lado do impulso autodestrutivo, e, neste respeito, a leucotomia é muito pior que os outros métodos físicos. Eles se encontram permanentemente à sombra de uma ameaça de leucotomia, que vieram a conhecer como sendo um procedimento cirúrgico que os muda de si mesmos em outra coisa, que não sabem o que é. Aqueles que são capazes de artificialmente ficarem bem organizam-se em uma pseudo-recuperação causada pelo *medo*, e dessa maneira fogem para o mundo externo à psiquiatria. Hoje, quase não existem asilos para aqueles pacientes que precisam e podem fazer uso de um período de colapso; há apenas hospitais psiquiátricos para a cura mais rápida possível dos mentalmente enfermos e, infelizmente, o medo da leucotomia tornou-se um fator real na produção

de uma rápida renovação da população dos hospitais psiquiátricos. Esta renovação parece boa no papel. (3) A existência da leucotomia como procedimento aceito é muito má para os médicos e as enfermeiras. Ela fornece o exemplo extremo de uma psiquiatria que contorna o estudo da natureza humana e da saúde mental como uma questão de maturidade do desenvolvimento emocional do indivíduo. Nada melhor que a leucotomia para dividir a psiquiatria como terapia cega da psiquiatria como uma preocupação complexa, mas interessante, pelo ser humano que acha difícil a vida e cujos problemas podemos sentir serem representados em nós mesmos.

Se a profissão médica viesse a abandonar a prática da leucotomia, muito se ganharia. Tão substancial seria o lucro, em minha opinião, que a possível perda de alívio terapêutico em certos casos constituiria uma consideração insignificante. Permaneco, etc.

D. W. Winnicott

Terapia Ocupacional

I. Resenha do Livro de Adrian Hill, *Art Versus Illness*¹

1949

Acho que este livro é bom. Adrian Hill, ele próprio artista e professor de arte, passou por um período de ociosidade como paciente físico em um sanatório e descobriu uma nova razão para desenhar e pintar. Fê-lo sentir-se melhor e talvez tenha indiretamente afetado o processo físico de cura. O que seria mais natural para ele que tornar-se, ao ter alta do sanatório, protagonista militante da *Arte versus Doença*?

O livro conta a história de suas aventuras. A fim de vender a idéia que o consumiu quando teve de depender de vários tipos de permissão, precisou de muito autocontrole e uma compreensão paciente da mentalidade de médicos, enfermeiras e comitês de administração.

A idéia principal é que quando pessoas enfermas não se acham demasiadamente enfermas, elas precisam completamente de auxílio na administração de suas almas, ou mundos internos, ou seja o que for que se possa chamá-lo. O tempo de ociosidade forçada é um tempo desperdiçado ou, então, um tempo para crescimento e desenvolvimento interiores. É bem-sabido que tanto crianças quanto adultos podem desenvolver profundidade e postura durante uma enfermidade como mal cardíaco reumático ou quando se acham imobilizados pela tuberculose ou por um fêmur fraturado, mas isso é uma situação precária, se a tensão da simples contemplação não se mostrar grande demais, e o resultado pode ser mais perturbador do que produtivo.

Adrian Hill percebe claramente que um bom professor pode fazer toda a diferença entre perturbação e integração, por patrocinar pessoalmente o interesse e a atividade artística. Em alguns casos, ele não faz mais do que fornecer uma moldura na parede oposta ao leito, na qual uma série de gravuras interessantes pode ser inserida, enquanto que, em outros casos, organiza sessões reais de desenho e pintura, mas sempre visa a encontrar a contribuição pessoal verdadeira que o paciente individual tem a capacidade de efetuar.

Pergunta-se se o autor pode perceber que sua idéia, embora original em certo sentido, não é nova, que muitos outros em verdade tiveram a mesma idéia e a colocaram em prática, embora não talvez em ampla escala. Se pode, ficamos então contentes com seu entusiasmo pessoal e desejamos-lhe boa sorte em sua cruzada.

1. London: George Allen and Unwin, 1948. Esta resenha apareceu no *British Journal of Medical Psychology*, 22 (1949).

Qual é a relação disto tudo com a terapia ocupacional? A pergunta pode ter sido respondida alhures e a resposta não se encontra neste livro. Diria eu que, na pior das hipóteses, a terapia ocupacional constitui uma tentativa organizada de separar as pessoas de si próprias e que isto é o contrário do objetivo que Adrian Hill defende. Alguns acham que o ensino oficial da terapia ocupacional está se desviando perigosamente no sentido de um treinamento de habilidades, de um número imenso de habilidades, com o treinamento sendo o suficiente para fazer desistir os verdadeiros artistas, ceramistas, músicos. Naturalmente, porém, tem de haver um curso e uma qualificação oficiais, e seria o caos se a terapia ocupacional fosse entregue aos artistas.

Durante a guerra, minha esposa, ela própria artista, ceramista e modeladora (trabalhando no departamento de terapia ocupacional do *Maudsley Hospital*, então em Mill Hill), descobriu que o trabalho construtivo com barro podia ser utilizado desta mesma maneira auto-reveladora com homens e mulheres que tinham vários tipos de transtornos psiquiátricos. No trabalho psiquiátrico há necessidade de cooperação estreita entre o artista (ceramista, etc.) e o psiquiatra medicamente responsável por ele, e isto não é sempre bem-vindo, tendo mais probabilidade de desenvolver-se se o artista for um terapeuta ocupacional qualificado.

Em seu melhor aspecto, a terapia ocupacional é na realidade exatamente o que Adrian Hill descreve. Um artista, ceramista, músico, escultor, modelador, que vive no próprio meio que escolheu, dá-se ao trabalho de contactar um grupo de pacientes acamados ou imobilizados e, através do contato pessoal, capacita cada paciente, à sua própria maneira, a criar uma ponte entre o inconsciente e o viver comum consciente, uma ponte de duas mãos. Muita coisa acontece, mas o principal é que o paciente, por gradualmente descobrir suas premências criativas e forças integradoras positivas, fica capaz de olhar para o que está dentro do *self*, a fim de ver o que quer que esteja lá, sejam o caos, as tensões, a morte, assim como a beleza e a vivacidade inata.

Como exemplo do emprego da música, recordo uma casa de saúde de convalescência a longo prazo para crianças reumáticas em Warwickshire, em que todas as crianças se achavam fazendo gaitas de foles, tocando-as, escrevendo temas originais, regendo ou por alguma outra maneira contribuindo para o fundo comum musical. Um músico (não um terapeuta ocupacional) fazia parte do quadro de pessoal. Isto constituiu uma experiência imensamente enriquecedora para as crianças e não tem importância que nenhuma delas, mais tarde, tenha se tornado músico. Naturalmente, seria um inconveniente ser forçado a tornar-se músico se acontecesse ficar-se enfermo em uma instituição louca por música.

O rádio pode representar uma ajuda tremenda para a pessoa enferma, desde que os botões e a revista *Radio Times* se achem dentro de fácil alcance. Pode-se utilizar os variados programas para o crescimento pessoal. Por outro lado, ficar sujeito, quando doente, a um programa escolhido pelo técnico situado no porão do hospital é ser "ocupado" e impedido de descobrir a si próprio ou de crescer.

Este livro pode ser utilizado, pois, como um corretivo às tendências más (se é que existem) na aparência oficial da terapia ocupacional, e como um apoio às tendências boas. É falta de sorte que as palavras "terapia ocupacional" pareçam desviar a atenção da experiência enriquecedora para a manufatura de um artigo que pode ser exibido em dia de exposição de trabalhos.

Terapia Comportamental

*Carta ao Redator-Chefe de Child Care News,
em junho de 1969, em resposta a um artigo que defendia
o uso da terapia comportamental no tratamento de crianças
desajustadas*

Prezado Redator-Chefe:

Terapia do Comportamento

Indubitavelmente um comentário apreciativo poderia ser feito sobre o artigo de Carole Holder a respeito de Terapia Comportamental (*Child Care News*, maio de 1969, nº 86). Para escrevê-lo, contudo, precisar-se-ia estar em uma plataforma diferente daquela em que vivo e trabalho. Seria importante para mim ter a oportunidade de informar a meus muitos colegas assistentes sociais que desejo matar a tendência desse artigo. Gostaria de ir mais além e, pelo menos, começar a dizer porque quero matá-la.

Seria uma boa idéia fornecer este enunciado da terapia comportamental a assistentes sociais que sejam auto-selecionados, escolhidos e treinados para trabalhar com casos. Só pode ser bom ser recordado de que sistema locais de moralidades são ensinados não apenas pelo exemplo, mas também por palmadas no traseiro e sanções. Mas será que temos probabilidade de esquecer este fato básico, uma vez que grande parte de nosso trabalho origina-se do *fracasso* da terapia comportamental, tal como praticada em casa e em instituições?

Poderia reivindicar ter conquistado o direito de fazer este protesto, uma vez que nunca aceitei a palavra "desajustado", que nos foi enviada através do Atlântico, na década de 20, como parte do Acordo sobre Orientação Infantil. Uma criança desajustada é uma criança a cujas necessidades alguém falhou em ajustar-se em alguma fase importante do desenvolvimento dela.

Imagine-se um grupo de assistência social baseado nos princípios da terapia comportamental. Um grupo desse tipo logo seria preenchido (através da auto-seleção e da seleção) por aqueles que naturalmente adotam a atitude da terapia de comportamento. O treinamento simplesmente aprofundaria os sulcos e as saliências de padrões de personalidade já estabelecidos à maneira behaviorista.

Esta seria verdadeiramente uma batalha perdida, porque essas pessoas que estou descrevendo em termos de sulcos e saliências *não saberão* que existe outro tipo de assistência social, uma assistência orientada no sentido da facilitação dos processos desenvolvimentais; *não saberão* do valor positivo de conter as tensões e os estresses de indivíduos e grupos, e de permitir que o tempo cure; *não saberão* que a vida é

realmente difícil, e que é apenas a luta pessoal a que conta, e que somente isto é que o indivíduo sente valer a pena.

O artigo de Carole Holder mostra com clareza que é possível olhar para a vida com extrema ingenuidade. O problema é que esta super-simplificação espantosa deve atrair aqueles de que precisamos que dêem apoio à assistência social em termos de dinheiro. A terapia comportamental pode ser facilmente vendida a membros de comitês que, por sua vez, vendem-na aos outros membros de conselhos municipais cujos conhecimentos situam-se em outros campos. Há sempre aqueles que alegam ter derivados benefícios quando seus pais lhes impuseram a moralidade familiar ou quando um determinado professor, na escola, fez que lhes doesse ser preguiçoso ou roubar. *Isto é o que as pessoas acreditam de saída.*

Infelizmente, médicos e enfermeiras, de modo geral, têm de ser incluídos aqui porque seu trabalho baseia-se também em uma super-simplificação essencial: a enfermidade já se acha presente e a tarefa é erradicá-la. Mas a natureza humana não se assemelha à fisiologia e à anatomia, embora nelas se baseie, e os médicos mais uma vez são, por auto-seleção, seleção e treinamento, inaptos a realizar o trabalho que o assistente social desempenha de reconhecer e conter e acreditar no conflito e no sofrimento humanos, o que significa tolerar sintomas que fornecem evidência de aflição profunda.

Os assistentes sociais precisam exatamente agora cuidar a filosofia de seu trabalho todo o tempo; necessitam saber quando devem lutar para que se lhes permita (e pague) fazer a coisa difícil e não a fácil; têm de buscar apoio onde ele pode ser encontrado e não esperar que este lhes venha da administração, dos que pagam impostos e de figuras parentais de modo geral. Na realidade, nesta situação localizada, os assistentes sociais precisam ser eles próprios as figuras parentais, seguros de sua própria atitude, mesmo quando não apoiada, e com freqüência na posição curiosa de reivindicar o direito de se exaurir no exercício de seus deveres, antes que serem seduzidos para o caminho fácil da indução da conformidade.

Pois a Terapia Comportamental (escrevo-a com maiúsculas para torná-la uma Coisa que pode ser morta) é uma saída fácil. Tudo o que é necessário é que os terapeutas concordem com uma moralidade. É mau sugar o polegar, é mau molhar a cama, é mau sujar, roubar e quebrar vidraças. É mau desafiar os pais, criticar os regulamentos escolares, encontrar falhas nos currículos universitários, odiar a perspectiva de uma vida passada na linha de montagem ou se assustar perante uma vida regulada por computadores. Está aberto a qualquer um possuir uma lista pessoal do que é bom e do que é mau, assim como está aberto a um batalhão de behavioristas, com sintomas morais mais ou menos idênticos, reunir-se e pôr-se a produzir curas sintomáticas.

Haverá fracassos, mas haverá também muitos sucessos, e crianças por aí a dizer: "Estou tão contente porque não molho mais a cama graças à Srta. Holder, ou a um aparelho com uma campainha elétrica, ou a algum outro modelador de reações". Tudo o que é necessário é que o terapeuta explore o fato de que os seres humanos são um tipo de animal com uma neurofisiologia semelhante a dos ratos e a das rãs. O que se deixa de fora é que os seres humanos, mesmo aqueles cuja inteligência é de grau bastante baixo, não são apenas animais. Eles têm muita coisa que os animais não possuem de modo algum. Eu, pessoalmente, pensaria na Terapia Comportamental como um insulto até mesmo aos macacos mais evoluídos, e incluiria nisso os gatos.

É triste que não haja assistentes sociais suficientes e que nunca haverá. É algo muito mais triste pensar que o último parágrafo da Srta. Holder talvez seja usado pelos responsáveis pelos Departamentos Infantis para justificar a entrega desse "procedimento econômico e sensato" aos funcionários encarregados do cuidado de crianças, um procedimento destinado a tornar bons os clientes travessos.

Obviamente, estou fazendo experiências com a modelação de reações. Quero matar a Terapia Comportamental através do ridículo. Sua ingenuidade deveria permiti-lo. Se não permitir, então terá de haver uma guerra, e essa guerra será política, como a que acontece entre as ditaduras e a democracia.

Atenciosas saudações
Dr. D. W. Winnicott

Fisioterapia e Relações Humanas

1969¹

A expressão “transtorno psicossomático” é de uso comum. O público entende bastante bem o tipo de doença a que as pessoas estão comumente sujeitas e que não é simplesmente um transtorno corporal tal como a escarlatina ou a apendicite, mas que esse transtorno está em parte ou no todo relacionado à vida emocional do indivíduo. É geralmente aceito que a vida é difícil e que essas dificuldades podem manifestar-se, às vezes, em uma distorção da maneira pela qual a mente funciona e, outras vezes, em uma distorção da maneira pela qual o corpo funciona.

Assim que se faz uma tentativa de examinar as diversas maneiras pelas quais o transtorno psicossomático pode surgir, descobre-se que o tema é vasto e que um enunciado desse transtorno não pode ser abrangido, exceto em um grande livro, redigido por uma equipe de autores. Ademais, o transtorno psicossomático se funde com o problema universal da interação sadia entre a psique e o soma, ou seja, entre a personalidade de um indivíduo e o corpo em que a pessoa vive.

Se, a fim de refletir a respeito do assunto, nos forçamos a efetuar uma espécie de classificação, podemos dizer que existem três maneiras principais pelas quais o corpo é afetado pela mente; antes de enumerá-las, porém, gostaria de indicar que, quando emprego a palavra “mente”, não estou me referindo a atividades de processos intelectuais ex-cindidos [*split-off*], mas sim a tudo o que existe da pessoa, à exceção do corpo.

1. *Fases de Excitação*

A maneira mais evidente pela qual o corpo se torna afetado tem a ver com as fases de excitação. De tempos em tempos a pessoa fica excitada, ou seja, por uma maneira ou outra seus instintos são despertados. Não importa qual seja a natureza do instinto; uma vez que os instintos tenham sido despertados, quer mediante o ritmo que provém do interior, quer em reação a estímulos chegados de fora (reais ou imaginados), o corpo começa então a percorrer um caminho que, em termos de fisiologia pura, deveria conduzir a um clímax: a fome levando a uma refeição; um certo tipo de

1. Do periódico *Physiotherapy* (junho de 1969).

sensação que conduz naturalmente a uma atividade excretória; excitação sexual que pode findar em orgasmo genital, ou uma acumulação de impulsos agressivos que podem conduzir a uma briga. Naturalmente, alguns destes despertares fisiológicos são mais facilmente trazidos a um estado de satisfação do que outros, mas o princípio é o mesmo: uma vez a excitação tenha se iniciado, a pessoa em quem estamos pensando tem de conseguir, seja levá-lo a um clímax (ir e comer a maçã), seja passar por uma fase em que o corpo tem de absorver as modificações pertinentes à excitação sem que haja qualquer clímax. O sono é uma das maneiras pelas quais se pode passar uma esponja no quadro negro, ou, em verdade, um clímax pode ser alcançado em associação com um sonho.

Nos estágios iniciais de uma excitação — isto é, de uma mudança na fisiologia do corpo que tem associada a si algum tipo de idéia excitante — é comparativamente fácil para o indivíduo administrar a vida até que a excitação e seus efeitos tenham se dissipado. Entender-se-á prontamente, contudo, que quanto mais longe a excitação houver avançado, mais difícil será para o indivíduo acomodar a fase de clímax fracassado. A vida está muito ligada à administração destes clímaxes falhados e eles podem dar origem a uma inconveniência tal que as pessoas se organizarão até onde possível para serem deles distraídas, de maneira que, durante longos períodos de tempo, não surjam excitações. Isto pode ser muito conveniente, mas, naturalmente, em excesso pode ser entediante. Qualquer um poderia escrever um livro denominado de "A Técnica de Viver", que seria uma descrição das maneiras pelas quais essa pessoa aprendeu a adaptar-se, a fim de evitar os começos de excitação e, alternativamente, conseguir que as excitações cheguem a um clímax.

Talvez esta seja uma das dificuldades que a vida apresenta que não pode ser ensinada, embora as pessoas obtenham auxílio em saber que o problema é inerente.

2. Os Efeitos do Humor

O corpo se torna envolvido de maneira diferente em associação com o humor. Na depressão, a pessoa deprimida está administrando os conflitos que surgem no que poderia ser chamado de "alma" através de um controle global. Isto desce automaticamente, como uma nuvem. A organização da realidade interna que fornece o sentimento de depressão acontece de modo inconsciente; isto é, separadamente de qualquer coisa que possa ser chamada de deliberada. Da mesma maneira, a nuvem se levanta quando as coisas estão prontas para que isso aconteça. Este controle global pode afetar o corpo e, em alguns tipos de depressão, toda a fisiologia do corpo encontra-se em maré baixa. Os tecidos se acham menos vivos e um pouco mais próximos de estarem mortos.

Temos então, aqui, um grupo de transtornos psicossomáticos que não reagem muito a coisas que possamos fazer ao corpo. O principal é que a pessoa seja auxiliada a atravessar o humor depressivo. Durante este, o conflito entre o que poderia ser chamado de "bom" e "mau" que está acontecendo internamente pode ser dramatizado em termos corporais, de maneira que há muitas queixas de dor e desconforto durante a depressão, e, se alguma enfermidade física real existir, isto pode ser explorado.

Aqui temos obviamente uma dificuldade para os médicos, por ser no caso destes pacientes que o médico é posto num desvio e impedido de perceber a doença real que existe ou, então, ele pode muito facilmente mergulhar em tratamentos físicos e procedimentos operacionais, quando o problema se encontra realmente na psique do paciente, não no soma.

É de se notar que uma condição deprimida tende a ter associada a si um tônus muscular débil ou, então, tensão e rigidez compensadoras. De modo semelhante,

falhas de postura combinam com a desesperança do paciente a respeito do estado de coisas na realidade interna pessoal. Ao fornecer tratamento, o fisioterapeuta está todo o tempo trabalhando contra a desvantagem da qualidade de morte interna do paciente.

3. Transtorno da Personalidade

No terceiro grupo desta classificação bastante grosseira, existe um transtorno de tipo mais primitivo na personalidade e não é possível descrever o que se quer dizer por isto sem afetar algum tipo de enunciado sobre a maneira pela qual as pessoas desenvolvem-se desde o começo de suas vidas, de maneira a acabarem por se tornar pessoas psicossomáticas sadias. O resto deste artigo será uma tentativa de efetuar um enunciado desse tipo.

Enunciado das Fases de Desenvolvimento Inicial

É importante que o fisioterapeuta tenha compreensão desta área, por ser aqui que a fisioterapia entra em cena. Em outras palavras, é aqui, no tratamento de pessoas que se acham enfermas por este terceiro modo, que ela se une com a administração inteiramente natural que a maioria das mães é capaz de permitir-se no cuidado de cada bebê. Digo cada bebê por estar me referindo a questões que pertencem aos verdadeiros primórdios da vida; tal como cada bebê é um filho único no começo, também é verdadeiro que na fisioterapia é necessária, durante o tratamento, dar ao paciente toda a atenção. Menciono isto para ilustrar a conexão estreita que existe entre a fisioterapia de homens e mulheres de qualquer idade e o cuidado inicial que uma mãe é capaz de conceder a seu bebê. Na realidade, a formação do fisioterapeuta deveria incluir oportunidades para uma observação atenta de um cuidado de bebês natural e não-instruído.

Formação da Personalidade

Uma vez que a atenção tenha sido chamada para o fato, não é difícil para ninguém perceber que aquilo com que uma pessoa se parece em qualquer momento determinado, não pode ser apropriadamente avaliado sem referência ao desenvolvimento total desde o início. Não está certo em que idade temos de começar a pensar no indivíduo como começando a ser um ser humano, mas certamente não faz mal pensar que coisas importantes já começaram por ocasião do nascimento do bebê. Tendemos a pensar no começo como sendo uma soma de inícios e assim contornamos a dificuldade das datas, porque o que acontece nos primeiros dias e semanas de vida pode naturalmente ser corrigido, mas se o padrão de uma anormalidade se estabelece, quem pode dizer em que momento ele se estabeleceu?

Na descrição que se segue e que traça o desenvolvimento da personalidade humana, muita coisa teve de ser deixada fora, mas as características essenciais para o fisioterapeuta foram mantidas. O novo ser humano traz ao mundo um potencial herdado e imediatamente se torna afetado pelo tipo de cuidado que acontece lhe ser proporcionado. Na vasta maioria dos casos, a mãe é capaz de iniciar de maneira satisfatória, por ser orientada a fazer exatamente esta única coisa, qual seja, o cuidado do bebê que esteve carregando durante nove meses. Cedo ela se tornará distraída por outras coisas, começará a descobrir de novo que outras coisas do mundo têm importância além do cuidado de seu bebê, e pode, naturalmente, ficar doente ou por

qualquer outra maneira impedida de dedicar-se ao cuidado continuado do bebê. Na imensa maioria dos casos, o novo bebê recebe uma fisioterapia satisfatória no começo, sob a forma de uma combinação de cuidados físicos e psicológicos que nos torna desnecessário distinguir entre psique e soma.

Será uma supersimplificação útil dizer que, para um bebê a quem se deu partida desta maneira e cujo cuidado infantil não foi significativamente perturbado, não é provável que se precise posteriormente de um fisioterapeuta na vida desse indivíduo (omitindo-se deliberadamente a referência ao lugar do fisioterapeuta no tratamento de enfermidades fisicamente determinadas). Contrariamente, esse fisioterapeuta será verdadeiramente necessário sempre que a criança tenha experienciado uma perturbação traumática das técnicas de cuidado infantil. (No caso extremo, em que uma criança não tenha recebido uma fisioterapia natural de início, não é provável que o fisioterapeuta possa na vida posterior compensar uma deficiência tão grosseira de manejo, mas com frequência far-se-á uma tentativa.)

É necessário tomar como princípio básico a tendência herdada de cada novo indivíduo no sentido do crescimento e do desenvolvimento. Sob condições ambientais suficientemente boas, o indivíduo conduz, entre outras coisas, uma tendência no sentido da integração da personalidade. A partir de um estado relativamente não-integrado, cada menino ou menina acaba por tender a tornar-se uma unidade, e uma unidade autônoma. A princípio, a mãe empresta a unidade dela à criança e, sob sua égide, essa criança é uma pessoa total e, muito gradualmente, vem a ser e a permanecer uma unidade quando separada e afastada daquela. Disto pode-se facilmente compreender que, nos estágios iniciais, há uma dependência muito grande, quase absoluta, e a coisa mais difícil no cuidado infantil é o fracasso gradual de adaptação da mãe, que se destina a atender à necessidade crescente que a criança individual tem de esforçar-se por uma maneira pessoal de vida.

Estas coisas não podem ser aprendidas e tampouco podem ser feitas por máquinas. Elas dependem inteiramente do cuidado e da compreensão humanas e de uma coleção de coisas que podem ser reunidas e descritas através da palavra "amor". Pode-se dizer da psicoterapia e da fisioterapia, que faz parte daquela, que o terapeuta está fornecendo profissionalmente e em data posterior exatamente aquilo que normalmente é dado por amor em data anterior.

Há um aspecto da integração e do processo geral de crescimento e desenvolvimento que interessa particularmente ao fisioterapeuta. Ele tem a ver com o relacionamento da pessoa dentro da criança com o corpo da criança. Não é fácil encontrar as palavras corretas para descrever este processo. Não é claro o que se pode chamar aquela parte da personalidade que, na saúde, torna-se estreitamente ligada com o corpo e as funções deste, mas que precisa ser considerada de modo separado. Pode-se utilizar a palavra "psique", mas isto pode sugerir ao leitor algo que se acha vinculado com o espírito e até mesmo com o espiritualismo, e certamente não se quer significar a mente, que se pode tomar como referente ao intelecto e com ser esperto ou obtuso, e que, quando ex-cindida [*split off*] fornece a área em que pensar, e pensar coisas, tem uma espécie de vida sua própria.

No emprego da expressão "enfermidade psicossomática", estas dificuldades não surgem, porque, de uma maneira ou outra, sabemos que estamos falando a respeito do inter-relacionamento existente entre o funcionamento do corpo e o da personalidade (não do intelecto).

Querer-se-ia poder dizer que a psique e o soma (isto é, a pessoa e o corpo que, juntos, são essa pessoa) não se iniciam como uma unidade. Eles formam uma unidade *se tudo corre bem no desenvolvimento desse indivíduo*, mas isto é uma conquista. Não podemos de maneira alguma tomar por certo que, em todos os casos, a psique e o soma do bebê virão a operar como uma unidade, com a criança vivendo no corpo e

este funcionando de acordo com a "intimidade" que a criança tem com seu corpo. Faz parte da integração que a criança e o seu corpo possam ser o que queremos dizer quando falamos a respeito dessa criança. Quando dizemos que "Billy tem um rosto bonito", não queremos dizer que há um rosto que é bonito e esquecer que existe uma pessoa que possui esse rosto. Ou então, quando dizemos: "Susan, venha cá". Não esquecemos que Susan tem de usar seu corpo, seja para fazer o que dizemos, seja para ir na direção oposta. Aceitamos tudo isso como garantido, exceto quando a associação se estabelece erroneamente.

Embora uma tendência no sentido do desenvolvimento, a que estou me referindo seja herdada por todo menino e menina, apesar disso o desenvolvimento não pode se dar a menos que a pessoa que está cuidando da criança consiga manejar o bebê e o corpo do bebê como se os dois formassem uma unidade. Há algumas mães, ou pessoas que cuidam de crianças, que estabelecem bom contato com o bebê como pessoa, mas parecem incapazes de saber o que o corpo do bebê está sentindo ou precisando; de modo semelhante, há outras que são naturalmente boas em cuidados físicos, mas parecem ignorar o fato de que há um ser humano começando a alojar-se no corpo que estão banhando e limpando. Quando aqueles que cuidam de um bebê ou criança pequena possuem este tipo de dificuldade, a criança de que cuidam não pode tornar-se integrada em uma unidade.

Nesse caso, assenta-se a base para uma cisão psicossomática. As forças herdadas que tendem à unidade esforçam-se por produzi-la, mas o sucesso é apenas relativo e a criança fica com uma tendência a perder a capacidade de simplesmente viver como uma unidade psicossomática. Esta é uma razão pela qual o estudante de fisioterapia pode aprender tanto por assistir ao cuidado comum de bebês, e, naturalmente, existem também as lembranças do fisioterapeuta, a maioria delas situadas mais além da rememoração, mas ainda assim influentes, de ter sido um bebê a ser cuidado.

Pode-se constantemente perguntar: onde é que o fisioterapeuta entra na correção desses manejos falhos? Provavelmente é o *psicoterapeuta* quem é mais necessário, ou o professor especializado, quando, na história inicial da criança, a mãe ou o substituto materno saiu-se melhor no estabelecimento de um relacionamento com o corpo do que com a pessoa do bebê. Pode-se esperar que o *fisioterapeuta* entre onde, nessa história inicial, houve um contato bom, com base em uma comunicação como a que se dá entre pessoas, mas um baixo grau de reconhecimento das necessidades corporais. Repetindo, o fisioterapeuta executa um trabalho profissional a partir da mesma coisa que foi chamada de cuidado amoroso no manejo inicial.

Mas, e se o fisioterapeuta esquecer que existe uma pessoa a quem ministrar atenção e que o cuidado do corpo é apenas metade da tarefa?

Um fisioterapeuta pode ficar surpreso em descobrir quão importante o relacionamento humano se torna, quando o que foi aprendido como técnica está sendo colocado em prática. Como acontece em toda terapia, o terapeuta recebe um pouco do relacionamento temporário e especial de dependência, amor, desconfiança e até mesmo ódio que o psicanalista chama de "transferência". O psicanalista na realidade utiliza esta "transferência" para a parte principal de seu trabalho, mas o mesmo pode ser encontrado, e precisa ser aceito como um desenvolvimento natural, quando é o corpo que está sendo manipulado ou aliviado. O que se faz é sempre importante porque aqueles que o fazem são humanos e não máquinas. É bom recordar isto como um princípio básico, algo a manter-se ao lado de todas as técnicas especializadas que são aprendidas pelos estudantes de fisioterapia.

Quando falamos de crianças pequenas, esperamos que os pais sejam capazes de nos informar toda uma série de coisas de que seu filho ou filha especialmente gostam, tal como o banho, talvez, ou ser aconchegado na cama, ou ser levantado nos braços, ou um brinquedo de nadar no ar. Todas estas coisas e os contatos físicos que as

acompanham pertencem à vida de pais e crianças, e o fisioterapeuta não deve se surpreender que muita coisa que está sendo efetuada de modo profissional, no departamento, é feita em termos de contato e comunicação humanas diferentes das físicas. Mesmo estar à disposição, confiavelmente, na hora necessária, ou manter o quarto aquecido e livre de correntes de ar pode ser uma comunicação que implica: "Conheço as suas necessidades básicas".

Um exemplo de um tipo extremado de deficiência que o fisioterapeuta se descobre corrigindo provém da sustentação física e do manejo falhos do tipo mais simples possível. Exemplificando, quando uma mãe, através da identificação com o seu bebê (isto é, por saber o que o bebê está sentindo), é capaz de sustentá-lo de maneira natural, o bebê não tem de saber que é constituído de uma coleção de partes separadas. O bebê é uma barriga unida a um dorso, tem membros soltos e, particularmente, uma cabeça solta: todas estas partes são reunidas pela mãe que segura a criança e, em suas mãos, elas se tornam uma só. Um exemplo grosseiro de manejo errado ocorre quando a mãe falha em lidar satisfatoriamente com a cabeça, de maneira que repentinamente o bebê fica em duas partes, corpo e cabeça. Isto produz o maior sofrimento mental. Se este tipo de manejo falho acontece de modo regular no padrão de manejo de uma criança, essa criança fica então permanentemente afetada e pode acabar nas mãos do fisioterapeuta por causa de uma rigidez patológica na região do pescoço. De qualquer modo, quando o fisioterapeuta tem de lidar com problemas de coluna vertebral *que não são devidos à enfermidade física*, tais problemas podem muito apropriadamente serem relacionados a uma história, no caso individual, de sustentação e manejo falhos no estágio crítico em que a psique e o soma ainda não se soldaram em uma unidade.

Existe um limite ao emprego que pode ser feito deste tipo de teoria. Certamente, não há sentido em tentar culpar alguém por algo que aconteceu no passado. Apesar disso, é mais fácil fazer-se o próprio trabalho se a etiologia da moléstia pode ser até certo ponto compreendida, especialmente quando, como no caso da fisioterapia, o trabalho que está sendo profissionalmente efetinado é tão amiúde uma tentativa deliberada de fazer-se o que é geralmente feito de modo inteiramente natural e sem pensar por aqueles que cuidam dos próprios filhos, de uma maneira que permite que a tendência herdada ao crescimento se cumpra.

Neste breve relato, não tentei ser abrangente, quer na apresentação de uma teoria de desenvolvimento individual, quer na construção de uma teoria da fisioterapia. O que tentei fazer ao pôr as mãos neste tema enorme, foi fornecer algumas linhas de pensamento deliberadamente supersimplificadas que o fisioterapeuta possa utilizar na construção de uma atitude pessoal para com este importante tipo de trabalho profissional.

Pós-Escrito: D.W.W. sobre D.W.W.

Janeiro de 1967

Em janeiro de 1967, quatro anos antes de seu falecimento, pediram a Winnicott que dirigisse a palavra ao *Clube 1952* (uma sociedade de analistas britânicos mais antigos que se reuniam informalmente para o debate de idéias) a respeito do tema do relacionamento de sua teoria com outras formulações de desenvolvimento anterior, exercício a que ele preferiu dar o nome de "D. W. W. sobre D. W. W.". Isto lhe forneceu oportunidade de passar em revista cronológica o desenvolvimento de suas idéias e falar a respeito daqueles cujo trabalho achava tê-lo influenciado em diversos estágios. Parece adequado que esta última coleção de trabalhos dirigidos àqueles que têm um investimento particular na psicanálise termine pela transição desta palestra.

Winnicott deu início aos trabalhos da noite distribuindo um extrato de suas declarações, com espaços deixados em branco para que a platéia os preenchesse como achasse apropriado. Ele é reproduzido aqui sem alterações.

A palestra real sobreviveu apenas sob a forma de uma gravação bastante má, e isto, juntamente com a extrema informalidade da linguagem, tornou difícil transcrevê-la e editorá-la. Foi uma maratona que demorou hora e meia e a parte principal dela é fornecida aqui, inclusive tudo o que Winnicott disse diretamente a respeito de sua própria história e sobre o desenvolvimento de suas idéias.

Os Organizadores

D. W. W. SOBRE D. W. W.
Clube 1952
Janeiro de 1967

O Método de Investigação. P. A. [psicanálise]		Freud
Protesto contra a referência à regressão universal a partir da satisfação/frustração do Id no triângulo edipiano		Alice Balint Ribble Suttee Lowenfeld
Positivo — exame do relacionamento genitor-bebê <i>real</i>		
<i>Diagnóstico</i> — Teoria da psicose		
Freud		Freud
Klein para a depressão e a paranóia		Klein
Esquizofrenia e fases esquizóides		
1940	Delinqüência	
	—	
	Esperança —	T. A.-S. ¹
	—	
	até lucros secundários	
	<i>Delinqüência</i>	Furto Agressão Relacionamento objetal Controles
Classificação do Meio Ambiente (posposto) tornou-se meio ambiente facilitador		Greenacre
P. M. P. ² Adaptação, desadaptação		
<i>Dependência</i>		
Processos maturacionais individuais		Bowlby
Hereditariedade		
Esfera livre de conflitos no Ego		Hartmann
Desenvolvimento Emocional Primitivo		A B C
Estudo do Indivíduo sem perda de interesse no meio ambiente		
Inicial não é Profundo acrescentar Transferência Delirante		Little
EU real	SENTIMENTOS	Fairbairn
movimento		
Agressão objeto no caminho		
agressão		
= NÃO-EU encontrado por agressão (tornando-se complexo)		Erikson Laing
Busca Objetal		
	Paradoxo Essencial	Fenômenos transicionais
SOU		Uma posição paranóide
Sozinho, na presença do segundo paradoxo		

Meio ambiente tal como experienciado
 acrescentando como lembranças
 integrado na crença no meio ambiente
 = controle do *self*

acrescentar raiz da paranóia
 em SOU + meio ambiente introjetado

mania: retorno do reprimido
 isto é, privação de controlos ambientais
 identificação com o meio ambiente
 preço: perda da identidade
 da espontaneidade criativa

(Aplicações práticas)

Entretimentos: explorando a contribuição de Klein,
 comparar dissociação ("cisão") com repressão

Dá o estágio SOU
 integração à unidade
 capacidade de preocupação
 humor depressivo
 "valor da depressão" Klein

Em termos de administração: o ensino de
 habilidades *vis-à-vis* reparação

Na Assistência Social
 A técnica do *holding* [sustentação]
feed-back à P. A. [psicanálise]

Psique-soma — relativos ao intelecto
 Intelecto explorado
 Transtorno psicossomático:
 uma chamada de volta ao ego corporal desde a fuga para o intelectual

O paciente psicossomático divide os cuidados médicos

Duas categorias de pessoas
 A. Carregam consigo "terem sido loucas"
 B. Não são assim.

Louco significa colapso das defesas do ego
 (tal como existiam na ocasião, inclusive o apoio do ego da mãe),
 com aparecimento clínico de ansiedade arcaica ou impensável:
 queda eterna
 desintegração
 desorientação
 despersonalização, etc.

Fordham

Pânico como defesa contra a ansiedade impensável

Axioma de Winnicott

A. Medo da loucura, loucura que já foi
 B. Pulsão a recordar através do experienciar

*Etiologia**Surpresa*

Psicose	Privação
T. A. -S.	Deprivação
Psiconeurose	Tensões e estresses internos em meio ambiente "não demasiada- mente mau"

Conceito de mãe suficientemente boa

Hartmann

Adaptação da mãe P. M. P.

baseada na identificação
não-mecânica

não primariamente por via de aparelhos cf. no autismo

Contribuição ao conceito de sublimação

Freud

Três áreas para viver

A. Realidade pessoal psíquica (interna)

B. Relacionamentos com objetos

Comportamento no mundo real

C. Cultural

Localizada no espaço potencial existente entre a criança que brinca sozinha e a "mãe"
cuja presença é necessária

Implicações para a teoria do Ego

Área do ego (não a esfera livre de conflitos) baseada em experiências reais de vida que podem
ou não ter realidade na vida de uma criançaTeoria da realidade [*actuality*]

como projeção

Mas dependência, especialmente no estágio do objeto subjetivo

Exemplo: sobrevivência do real após assomos agressivos conduz à (ou reforça) capacidade de
fantasia, ódio em vez de aniquilamento*Acrescentar:* Excitação (não-orgiástica) na junção do subjetivo e do que é objetivamente percebido
— entre continuidade e contigüidade*Notas Adicionais*

Aplicação destas idéias

à Prática da obstetrícia

à Teoria da separação

a Conversas com pais e com aqueles que cuidam de crianças

à Teoria da assistência social

à Psicoterapia, exploração da primeira entrevista

ao conceito de saúde

riqueza do potencial

estado adulto

sexo

maturidade

sabedoria

Anna Freud

Kris

Regressão

Calmaria adolescente

Funcionamento da família

Democracia como desenvolvimento da família que funciona

1. Tendência anti-social. — Os Organizadores.

2. Preocupação materna primária. — Os Organizadores.

À medida que o tempo ia passando, dei-me conta cada vez mais de quanto eu havia perdido por não haver correlacionado apropriadamente o meu trabalho com o trabalho dos outros. Isso é não apenas irritante para as outras pessoas, mas é rude também, e significou que o que eu disse ficou isolado e as pessoas tiveram de dar-se a um monte de trabalho para chegar a ele. Acontece que é esse o meu temperamento e constitui uma grande falha.

Permitam-me interromper-me por um momento para lhes dizer que tomei algumas notas. Elas seguem um pouquinho as linhas do que vou dizer. Não se acham sequer apropriadamente corrigidas e muito menos têm importância vital, de serem penduradas em paredes, mas achei que, se tiverem consigo um lápis, poderão querer escrever Hartman e Hoffer, entendem, no canto da margem. Na margem direita deixei espaço para que escrevam todos os tipos de nomes, de maneira que possam ajudar-me, porque agora estou chegando ao estágio em que gostaria de ser mais correlacionado.

O outro lado disto é que, comigo, assim como com outras pessoas, o desenvolvimento do pensamento se deu ao longo da linha de algo que tem a ver com o crescimento e, se acontece assemelhar-se a alguém mais, isso apenas aparece por estarmos todos lidando com o mesmo material. Na realidade, a série de trabalhos que significaram alguma coisa para mim foram uma continuação de algo que aconteceu em minha longa análise de dez anos com o Sr. Strachey, em que tive uma série de sonhos. Não me lembro de nenhum deles, mas o ponto é que sabia que outras pessoas escreveram sobre este mesmo assunto. Sabia também que estes sonhos eram diferentes dos outros. Eles não se destinavam à análise, mas eram uma consolidação de um trabalho efetuado. E sempre disse que, se tivesse começado a fazê-lo no início, teria posto por escrito esses sonhos, de maneira a poder reuni-los um dia, mas nunca o fiz, é claro. Ao se começar a fazer isso, a gente nunca os sonha. De maneira que, após o final da análise, estas coisas assumem a forma de artigos que sentimos que temos de escrever e o espantoso é que se pode encontrar pessoas para escutar. Estou realmente traçando um espécie de compulsão, e se eu apenas pudesse fazê-lo bem, isto seria uma oportunidade maravilhosa.

De início, soube que — tal como todos, imagino, nesta sala — assim que descobri Freud e o método que ele nos deu para investigação e tratamento, estive de acordo com ele. Foi exatamente semelhante ao que aconteceu quando eu estava na escola, estudando Darwin, e, de repente, soube que gostava do que ele dizia. Senti isso de modo tremendo e imagino que, se houver algo que eu faça que *não seja* freudiano, gostaria de sabê-lo. Não me importa que não seja, mas apenas acho que Freud nos forneceu este método que podemos usar e não importa ao que ele nos conduz. O ponto é que ele nos leva a coisas; trata-se de uma maneira objetiva de examinar as coisas e é para pessoas que podem ir até algo sem idéias preconcebidas, o que, em certo sentido, é a ciência.

No começo, lá estava eu, aprendendo a fazer análise como um pediatra que havia tido uma tremenda experiência de escutar pessoas a falar sobre bebês e crianças de todas as idades e havia tido grande dificuldade de ver um bebê sequer como humano. Foi somente através da análise que gradualmente tornei-me capaz de ver um bebê como um ser humano. Este foi realmente o resultado de meus primeiros cinco anos de análise, de maneira que posso sentir extrema simpatia por qualquer pediatra ou quem quer que seja que não possa perceber os bebês como humanos, porque eu absolutamente não podia, por mais que costumasse tentar. De maneira que esta coisa aconteceu e, então, tornei-me muito interessado em tudo.

Quando comecei a tentar aprender o que havia para ser aprendido a respeito da psicanálise, descobri que, naqueles dias, estávamos sendo ensinados a respeito de tudo em termos do complexo edípico dos 2, 3 e 4 anos de idade e da regressão quanto a ele. Foi muito aflitivo para mim, alguém que havia estado examinando bebês, mães

e bebês, por longo tempo (de dez a 15 anos já), descobrir que isso era assim, porque eu sabia que havia visto um bocado de bebês já começarem doentes e outro bocado deles tornar-se doente cedo. Exemplificando, eu havia tido um bocado de experiências como a que tive esta semana, de dois pais muito inteligentes e normais que me trouxeram o problema de seu bebezinho de 22 meses. Este bebê, com a idade de 16 meses, desenvolvera uma neurose obsessiva muito bem-organizada. Os pais perguntaram: "Bem, o que fazemos?" e eu pude pegar a teoria psicanalítica e dizer-lhes: "Façam isso". E eles o fizeram, e a criança abandonou a organização obsessiva e foi em frente. Tratou-se de uma aplicação totalmente direta. Parece-me que haver dito isto agora é pura e simplesmente experiência ordinária, mas dizê-lo em 1935, neste país, seria defrontar-se com a objeção: "Mas isso não pode acontecer". Não havia uma audiência para isso, por causa do fato de que, para ter uma neurose obsessiva, ter-se-ia de haver tido uma regressão quanto a dificuldades no estágio edípico aos três anos. Sei que estou elaborando demais este ponto, mas tratou-se de algo que me forneceu uma linha. Pensei comigo: vou demonstrar que bebês ficam enfermos muito cedo, e, se a teoria não se ajustar a isso, ela terá de ajustar a si própria. E foi assim.

Ora, havia pessoas falando a respeito destas coisas antes de eu entrar em cena. Minha ignorância a respeito do que a Srta. Freud estava fazendo até vir para este país, é abismal. Depois, sou capaz de emparelhar, porque ela própria cresceu e eu a vi crescer através das experiências das *War Nurseries*, e ela mudou, tremendamente, acho eu. Ela descobriu, em um trabalho prático que as pessoas estavam fazendo e ela supervisionando, que estavam acontecendo coisas que realmente a influenciaram, e foi grande prazer assisti-la trabalhar. Acho que ela efetuou uma contribuição tremenda, mas eu não sabia, na época, que trabalho ela estava fazendo antes deste. Sei também que Alice Balint estava interessada nas coisas de que estou falando. Havia outras pessoas que não eram analistas que também estavam falando a respeito delas: havia Sutee, e Margaret Lowenfeld, que tinha uma experiência tremenda, desde o começo da década de 20, de ensino sobre mães e bebês, e também Merrill Middlemore.

Agora, com referência às psiconeuroses, senti que a teoria de Freud e o seu esquema em desenvolvimento para as coisas, à medida que pude vir gradualmente a aprendê-las, abrangia o tema, e, até onde sei, não fiz contribuição alguma nessa área. Como sabem, na década de 1930 a 40, entrei profundamente na área de aprendizagem da Sra. Klein, e ela se deu ao trabalho de tentar ajudar-me com casos e contar-me tudo a respeito de seu próprio trabalho. Recebi dela, sem sempre entender a configuração, muita coisa que acho que era original desde o seu ponto de vista. Isso realmente se reduz à localização, pelo paciente ou pela criança, da fantasia na parte interna. A Sra. Klein não gostava dessa maneira de dizê-lo; conversei com ela a respeito e ela me disse que não era certo. Do meu ponto de vista, porém, as pessoas sabiam a respeito da realidade psíquica interna através de Freud e também sabiam a respeito da fantasia e do sonho, mas foi ela quem apontou a importância das localizações de tudo o que se passa entre o comer e a defecação e que tinha a ver com o interior do corpo. E achei que foi ela quem me ensinou tudo isto, sem o que eu não teria podido fazer psicanálise de crianças de modo algum, e não poderia haver impedido aquela criança de tornar-se gravemente neurotizada, por eu ter dito à mãe o que fazer.

Ora, onde foi que comecei a despertar um pouco? Fiquei completamente perdido na longa controvérsia que prosseguiu durante a guerra e arruinou todos os nossos encontros científicos, quando as pessoas estavam lutando pelos direitos da Sra. Klein. Tinha de ser feito, mas me deixou completamente frio; eu não sabia nada a respeito dela e mantive-me inteiramente fora do caminho. Achei difícil, e ainda acho hoje, entendê-la. Mas o que me aconteceu foi que comecei a ficar interessado pelo meio ambiente, e isto conduziu a algo em mim. Agora, quem mais estava fazendo isto? Não acho que saiba, no momento. O importante é que, nessa ocasião, eu estava fazendo

análise com a Sra. Rivière, que era grande amiga da Sra. Klein, e disse-lhe que estava escrevendo um trabalho sobre a classificação do meio ambiente, e ela simplesmente não o aceitou. Isto foi realmente uma pena, porque ganhei muito de meus cinco anos com a Sra. Rivière, mas tive de esperar um longo tempo antes que pudesse recuperar-me de sua reação.

Eu acabara de passar por um período de dez anos em que não fizera praticamente nada a não ser análise infantil, mas ele foi na realidade desperdiçado, pois o fato é que a Srta. Freud não o aceitava porque disse que se eu apresentasse um caso, mesmo que fosse um caso clínico direto, eu o apresentaria sob um ponto de vista kleiniano, e a Sra. Klein não o queria porque eu não era um kleiniano. De maneira que tive de abandonar a aplicação de minha experiência ao ensino e, durante algum tempo, fazer trabalhos de outros tipos.

Havia uma guerra em curso, com hospedarias para crianças difíceis, e trabalhando em Oxfordshire, acabei por entrar em contato com crianças desajustadas que eu sempre evitara em minha clínica, porque elas perturbam qualquer clínica. Ao se ter três crianças desajustadas, passa-se o tempo todo preparando relatórios para tribunais e todos os casos interessantes por quem se pode fazer algo de modo imediato são inteiramente desprezados. Fica-se fazendo essa coisa inútil, e sempre enviara as minhas crianças anti-sociais para outras clínicas, e fico muito contente que o tenha feito em todos os 20 anos a contar de 1923, porque consegui ter um número muito grande de crianças por quem pude fazer algo em tempo muito curto. Eu disse à Sra. Rivière um dia: "Existe apenas uma linha como essa entre eu e a teoria da delinquência, e um dia isso vai ser algo e, então, vou ficar separado. E sinto que o dia está chegando, sabe?" Somente não pude fazê-lo enquanto me achava em análise com ela porque — não digo que a Sra. Klein se importasse, mas — os psicanalistas foram as únicas pessoas, por cerca de dez ou 15 anos, que sabiam que existia algo *que não era* meio ambiente. Todos estavam berrando que tudo se devia ao fato do pai de alguém ser bêbado. De maneira que a coisa era como retornar ao meio ambiente sem perder tudo o que fora ganho pelo estudo dos fatores internos.

Acho que foi uma contribuição muito importante, desde meu ponto de vista, o dia em que subitamente, em uma palestra, descobri-me dizendo que o ato anti-social de delinquente pertence ao momento de esperança. De maneira que então tive de inventar a expressão "tendência anti-social", para reuni-la com a criança que furta um tostão do bolso de alguém ou que tira alguns bolinhos, a que tem perfeito direito, da despensa. Quis unir isso com as tendências que podem conduzir à delinquência. Nesta última, que não significa nada definido, os lucros secundários tornaram-se mais importantes que a causa original, que se perdeu. Meu material clínico, porém, trouxe-me ao fato de que o que existe por trás da tendência anti-social em qualquer família, normal ou não, é a privação, e o resultado da privação é a calma, a desesperança, a depressão de algum tipo, ou qualquer outra defesa de vulto. Mas, à medida que a esperança começa a aparecer, então a criança estende a mão para ela, tentando recuperar por sobre a área de privação, o objeto perdido. Trata-se de algo importante, e a vida foi diferente para mim após isso, porque agora sabia o que fazer com os meus amigos que me estavam trazendo suas crianças por estas apresentarem uma tendência anti-social em um lar perfeitamente bom. Descobri que, antes de os lucros secundários aparecerem, isto não era algo difícil de tratar, mas sim fácil, ainda que não em todos os casos. Acho que isso foi uma contribuição. Não conheço ninguém que estivesse realmente fazendo isso então, e, se houvesse, gostaria de saber.

Afortunadamente, sempre tive de fazer palestras — como todos aqui, acho eu —, mas descobri que a coisa mais valiosa foi ter de fazer conferências para pessoas que não eram analistas. Em 1936, Susan Isaacs atribuiu-me o trabalho de fazer dez palestras por ano no Instituto de Educação, o que fiz durante aproximadamente 15 anos, e

isso foi muito importante para mim. Imaginava-se que a palestra fosse sobre febre reumática, de começo, e o diagnóstico precoce da dor, a fim de que as pessoas não ficassem com doenças cardíacas, mas, felizmente, antes que muito tempo se passasse, a febre reumática cessou. De qualquer maneira, descobriu-se que metade das pessoas encaminhadas como reumáticas eram deprimidas e que metade das que eram enviadas como coréicas não o eram de modo algum, mas sim casos de desassossego ansioso comum, de modo que nos pusemos a examinar aquilo tudo. Mas ter de dar palestras para assistentes sociais, professores, pais e todos os tipos de pessoas é tremendamente importante. Alguém, talvez um pai ou assistente social, dizia: "Olhe aqui, eu entendo isto a respeito de estender a mão de volta sobre a lacuna em busca do objeto, mas o senhor não descreveu porque um outro tipo de tendência anti-social é destrutivo". E me tomou três a quatro anos para chegar à coisa muito simples, que é, naturalmente, o fato de existirem dois tipos de privação. Uma se dá em termos de perda de objeto e a outra em termos de perdas de molduras, de limites. Em certo sentido poder-se-ia dizer perda da mãe e perda do pai — o pai paterno, não o pai que fica em lugar da mãe. O importante é a moldura, a força — a privação em termos disso. Depois, uma coisa muito complicada acontece quando a criança fica bem e começa a sentir confiança em um homem, em uma estrutura ou em uma instituição. Ela começa a quebrar coisas para ficar inteiramente certa de que o arcabouço pode agüentar. Isto me demonstrou que a tendência anti-social tem dois aspectos em si.

A outra coisa que surge disto é que quando uma criança é privada de um controle ambiental o que ela faz é tornar-se um sistema controlador identificado com a situação parental ou com o meio ambiente e ela perde completamente a sua identidade. É esta a razão porque, quando o controle começa a ser reimposto e essas crianças começam a ganhar confiança e a entregar os controles a outrem e estabelecem-se de novo, a primeira coisa que têm de fazer é provar se os controles serão suficientes. Quando isto funciona, as crianças serão muito agressivas. Poder-se-ia dizer que têm crises maníacas às vezes, mas o ponto é que elas estão começando a existir. Tem-se aqui uma idéia da extrema importância da situação para se ver a diferença entre fato e fantasia, porque essas crianças vêm a saber que elas destruíram o mundo muitas vezes, exatamente como um bebê faz com os pais, normalmente, mas contudo, o mundo ainda se acha lá. Assim, elas começam a perceber que existe uma fantasia de destruição que é diferente da realidade, e esta é a lição que têm de aprender, pois não a aprenderam quando eram bebês.

É inteiramente possível que eu tenha tirado de algum lugar esta idéia original minha a respeito da tendência anti-social e da esperança, e que me foi extremamente importante em minha prática clínica. Nunca sei o que obtive de dar uma olhada em Ferenczi, por exemplo, ou ver de passagem uma nota de rodapé de Freud.

Chegamos agora ao meio ambiente facilitador e ao processo maturacional. Existe aqui algo de Greenacre que eu tomei sem reconhecê-lo, particularmente ao desenvolver as teorias que cercam os processos maturacionais, a hereditariedade e as tendências que contribuem para criar um ser humano, bem como a interação disto com o meio ambiente. Aqui temos de introduzir a "esfera livre de conflitos" de Hartmann, que na realidade, e acho que estou certo em dizê-lo (ele não se importou quando lhe falei isso), tem a ver com as tendências herdadas. Descobri então que tinha de formular uma espécie de base teórica de uma provisão ambiental a começar, no início, com 100% de adaptação, e a diminuir rapidamente, de acordo com a capacidade que a criança tem de fazer uso do fracasso ou da adaptação. Isto já foi dito em outros termos. A Sra. Rivière acentuou os fracassos da mãe como sendo tão importantes para o relacionamento objetal quanto os sucessos, e existe outro trabalho em que se pode traçar estas idéias. Mas não me satisfaço em apenas tomar o conceito de "simbiose", porque esta palavra para mim é fácil demais. É como se, tal como acontece na

biologia, apenas aconteça que duas coisas estão vivendo juntas. Acredito que isso deixa de fora a coisa extremamente variável que é a capacidade que a mãe tem de identificar-se com o bebê, o que, acho eu, é a coisa viva nisto que denominei de "preocupação materna primária". A capacidade dela varia, com diferentes crianças, não com o seu temperamento, mas com as experiências dela, e com a maneira que ela se encontra na ocasião, e isto me parece ser uma linha de investigação mais proveitosa.

Isto me traz à dependência e às teorias da adaptação. É interessante para mim que tenha achado cada vez mais difícil a escavação cada vez mais regressiva feita pela Sra. Klein nos conflitos e processos do bebê individual. Então, uma noite, Fairbairn desceu para nos dar uma palestra e esse foi o tipo de noite que vai mais além de minha compreensão, mas, contudo, indubitavelmente teve uma importância tremenda. A questão foi a de se a primeira introjeção que é feita é de um objeto bom ou um objeto mau, o tipo de coisa em que não sou bom. Nessa ocasião, não pude ver coisa alguma em Fairbairn. Percebi mais tarde que ele tinha uma coisa extremamente importante a dizer, algo que tinha a ver com ir mais além das satisfações e frustrações instintuais, até chegar à idéia da busca objetal. Ele e a Sra. Klein tinham várias coisas em comum e não pude perceber isso por anos e anos. Mas não me envolvi nas teorias da Sra. Klein que se baseiam no conceito do instinto de morte e dos fatores hereditários que me pareceram ser acentuados em seu trabalho sobre Inveja. Isto não teve importância, porque, à essa época, ela já havia feito uma tremenda contribuição. Trata-se de algo sobre o que o futuro tem de se manifestar, não eu. Mas podem ver como, por esta época, eu me achava inteiramente mergulhado na palavra "dependência" e não podia falar a respeito do bebê sem levar em conta a dependência e a adaptação e sem ver a capacidade da mãe em desadaptar-se no ritmo que seu bebê específico no momento podia fazer uso. Isto era uma coisa extremamente sutil que pertence à vida, e que às vezes tem-se de pensar em saúde e má saúde nesses termos. Dessa maneira, nunca pude entrar inteiramente em comunicação adequada com Melanie Klein, mas isso não teve importância porque ela e eu havíamos concordado em divergir. Ela tinha uma cabeça tremenda e disse, muito corretamente: "Sempre reconheci a importância do meio ambiente em todos os meus textos, mas estou falando sobre o indivíduo". Bem, isso foi bastante justo. Eu estava tentando dizer algo de que ela não gostava e ainda não sei se ela está certa ou não, mas tem a ver com o fato de que, no começo, parece impossível falar a respeito do indivíduo sem falar sobre a mãe, porque, em minha opinião, a mãe ou a pessoa que se encontra no lugar dela é um objeto subjetivo — em outras palavras, não foi objetivamente percebido — e, portanto, a maneira pela qual a mãe se comporta faz realmente parte do bebê. E penso que é quase como tentar contar o número de anjos, que pode ficar na cabeça de um alfinete ou perceber até onde se pode chegar falando a respeito do que está acontecendo em um bebê, deixando de fora o fato de que o meio ambiente é, de início, parte do bebê.

Acho que a dificuldade é que existe um paradoxo, o mesmo paradoxo que aparece nos fenômenos transicionais e que tentei elaborar a fim de lidar com ele. O paradoxo é que o meio ambiente faz parte do bebê e, ao mesmo tempo, não faz. O bebê tem de acabar por aceitar isto, a fim de tornar-se adulto. Ele surge na teoria dos fenômenos transicionais, porque se tomarmos o caso simples em que há um objeto transicional sabemos que não perguntaremos ao bebê: "Você criou este objeto ou o achou?" porque sabemos que as duas coisas são verdadeiras e que ele não o teria criado se o objeto não houvesse estado lá, mas que ele o criou. Este é um conceito extremamente difícil a não ser que apenas se diga que existe um paradoxo e temos de aceitá-lo. Ele me parece ter bastante importância filosófica, só que acontece que não sou filósofo. Tem importância para a totalidade do relacionamento objetal onde os objetos podem ser vistos de modo criativo.

Ora, havia uma coisa que eu precisava e não podia chegar a ela, que era o uso pleno do conceito da transferência delirante. Esta é uma das coisas mais difíceis com que temos de lidar na análise e, do meu ponto de vista, na realidade tirei essa parte de alguém. Se Margaret Little não houvesse sido capaz de tornar isto claro, eu o teria adiado indefinidamente, o que acho que o fazem um bocado de analistas. Acho que ainda se pode ouvir pessoas incapazes de enfrentar uma transferência delirante, que é uma das coisas mais difíceis que temos de fazer. De maneira que esse é um pedacinho de minha vida em que realmente obtive algo de outra pessoa, quase como se o houvesse furtado da bolsa de minha mãe.

Depois, uma coisa importante que me aconteceu foi reconhecer que inicial não é profundo, e isto me ajudou um bocado em minha tentativa de fazer uso pleno de Klein sem ficar atolado. Dei-me conta repentinamente — em Paris ou em outro lugar — que inicial não é profundo, que um bebê precisa de tempo e desenvolvimento antes que a profundidade apareça, de maneira que quando se está retornando às coisas mais profundas não se vai até o início. Vai-se até algo como três, dois ou um ano e meio, e isto foi muito importante para mim, porque alguns mecanismos que têm a ver com os grupamentos esquizóides parecem ser pertinentes ao inicial e não ao profundo, e a depressão pertence ao profundo, não ao inicial. E penso que isto teve um efeito sobre a nossa teoria da origem da agressão, porque realmente acredito que há algo a ser dito para falar sobre agressão (em termos do desenvolvimento do bebê) como sendo o *movimento* do bebê — isto é, erotismo muscular — e algo acontece estar no caminho. Parece-me que este é o início da agressão. Se vamos falar a respeito de ódio, isso fica muito mais à frente, e um episódio maníaco acha-se também muito afastado de alguém que apenas acontece dar um pontapé em algo porque estava no caminho quando lhe deu vontade de dar um chute. De maneira que obtive um vislumbre de como poderia entender um pouco melhor as origens da agressão, examinando estas duas maneiras diferentes de chegar ao começo dela no indivíduo.

Podem perceber que existe, incidentalmente, um corolário a isto. Eu estava me afastando da necessidade de uma interpretação verbal em sua forma mais plena. Eu passei pelo longo processo de interpretar tudo o que tinha possibilidade de ver que pudesse ser interpretado, entendi, sentindo-me horrível se não podia encontrar nada e pulando em cima de algo porque descobrira que podia colocá-lo em palavras. Passei por tudo isso e me dei conta de que, em certos casos, não adiantava nada, juntamente com outras pessoas que conheço que fizeram a mesma coisa. Balint escreveu a respeito e outros também o fizeram desde então, e muitas coisas foram ditas nos últimos 40 anos sobre o tema das sessões silenciosas e dos longos períodos de dependência. Desde que me dei conta disto, tive de lidar com um bocado de fases silenciosas na análise, que duraram longo tempo, e é muito difícil saber quando isso é tempo perdido e quando é extremamente produtivo, mas tudo isto é agora algo que adoro estudar. Hoje, nesta tarde, um paciente — um paciente que está chegando perto do final da análise — me trouxe um sonho e, de repente, percebi antecipadamente uma solução de onde ele estava chegando, de maneira que lhe disse a minha idéia de onde ele se encontrava, e ele ficou muito insatisfeito com que o sonho que havia trazido, com os próprios significados dele, houvesse sido tratado dessa maneira. Ficou completamente zangado comigo, completamente desesperançado, e perguntou: "Quando é que você vai aprender?" Se eu estava certo, havia-lhe tirado a oportunidade de ser criativo, de trazê-lo da vez seguinte e após; se estava errado, interrompera a chegada dele a uma importante compreensão através desse sonho. Isso foi o máximo que ele pôde aceitar na ocasião e o superamos ao final porque eu já o havia feito antes. Ele disse: "Para falar a verdade, tive hoje um dia muito satisfatório, mas há só uma coisa que o está estragando. Esta noite vou ficar me preocupando com você, porque você vai estar pensando que analista vagabundo você é". De qualquer modo, existe

tanta coisa que acontece em análise, se não se tratar apenas de um caso psiconeurótico direto.

Estou hoje me dando conta de que Fairbairn efetuou uma contribuição tremenda, mesmo que apenas tomemos duas coisas. Uma delas é a busca objetal, que entra na área dos fenômenos transicionais e assim por diante, e a outra é esta coisa de sentir-se real em vez de irreal. Nossos pacientes, cada vez mais, mostram estar precisando sentirem-se reais e, se não se sentem, então a compreensão é de importância extremamente secundária. O esquisito é se estão pretendendo ser analistas, pois precisarão então de um pouco de compreensão. Mas a vasta maioria de meus pacientes não foi composta de analistas e tenho de ficar contente com que tenham ido embora sentindo-se mais reais do que quando chegaram. Fora de dúvida, um grande número de pessoas tratou disto — Erikson, e, espero, muitos mais.

Não posso abranger tudo o que desejaria. Direi apenas que não sei se gostariam de debater alguma coisa disto ou se prefeririam ajudar-me, por carta, a corrigir-me e a reunir-me com as várias pessoas através do mundo que estão fazendo trabalhos que eu quer furtei, quer apenas ignorei. Não prometo segui-lo até o fim porque sei que vou continuar a ter idéias que pertencem ao lugar em que estiver no momento, e não posso deixar de fazê-lo.

Índice Remissivo

NOTA: Os números de páginas em negrito indicam discussão maior sobre o assunto. Um “t” após o número da página indica material em tabela e um “i” após o número da página indica ilustração. As drogas são listadas em seus nomes genéricos. Quando for utilizado um nome comercial na lista, será indicado para o leitor o nome genérico.

Abandono:

pela mãe, 40
pelo analista, 28

Aborto espontâneo, 128

Abraham, K., 303, 316, 318

Acariciar: e fenômenos transicionais, 46

Acessos de cólera, 55

Adaptação:

da mãe ao bebê, 37, 78, 81, 113-114, 122, 141, 197, 332, 340, 341, 434, 435, 441

desadaptação e, 114, 340, 430, 441

diminuição da, 81

do analista ao paciente, 79, 103, 129, 164, 341

do paciente ao analista

e externalização do objeto, 197

Adolescente: relacionamento com a mãe, 255-259

Adolescência, 51-52, 58-58, 249-249, 252-253, 333

acne na, 218

atividade sexual na, 253, 254, 257

calmaria na, 436

destrutividade na, 185

fase de sexo indeterminado na, 52, 284

identificações homossexuais na, 52, 283-285, 31, 51-52

masturbação na, 31, 51-52

organização das defesas na, 95

pacifismo reativo da, 181

reencenação na, 220

Adoção, 217, 323

Afeição, 45, 116, 117, 160

Aflição, 54-55, 247, 250-251

Agonias primitivas, 71-72

Agressão, 26, 50, 176, 221, 434, 439

e impulso primitivo, 242-243

estudo psicanalítico da, 348-349

falta de, 183-184

fusão da, com componentes eróticos, 81, 185, 344-345

herdada, 340-341, 343

raízes da, 176, 190-191

relacionamento objetal e, 81

repressão da, 27

teoria da, 442

Álcool, uso do:

para controlar ansiedades desintegradoras, 147-148

para liberar a espontaneidade, 354

Alimentação ao seio, 128, 285-286, 379

Alimentação, 68-69, 198

Alucinação, 33-35, 44-45, 271, 290

vs. pensamento lógico, 121, 123

Ambivalência:

cisão e, em Fairbairn, 319-320

conquista da, 51, 105, 113, 115

na mãe, 114, 194

neurótica, 407

psiconeurose e, 57

Amigos: de D. W. W., 3, 6, 7-9

Amizade, 25

Amor cruel: repressão de, 27

Amor, 126, 132, 203, 205, 344-345, 430

do objeto que sobrevive, 174, 177

primitivo, 131, 344-345

- sem sanções, 205, 217
- Análise Infantil, 327
- D. W. W. e a, 438
- Análise, 25, 73-74, 77-79
- ambiente de sustentação [*holding*] e, 28
 - brinquedo na, 24-25, 125
 - conluio na análise, 73-74, 78, 84-85, 172
 - contato físico na, 28, 199
 - de criança com mãe deprimida, 193
 - de pacientes psicóticos, e fantasia corporal, 406
 - de sonhos, 159
 - dependência na, 344
 - destruição e atividade construtiva na, 193
 - do superego comparado com ansiedades paranóides, 356
 - erros na, 66-67
 - falta de senso de realização na, 193
 - fracasso ambiental na, 28
 - fracasso da, 172
 - frustração na, 42
 - futilidade na, 73-74, 134
 - influência ambiental como idéia traumática na, 138
 - interminabilidade na, 134, 135, 172, 177, 342-344
 - lentidão da, 134
 - não-uso na, 182
 - necessidade de conhecimento teórico na, 134
 - primeira entrevista na, 245-246
 - reexperiência de ansiedade intolerável na, 60-61, 98-99, 100
 - regressão profunda na, 39
 - retraimento e regressão na, 116-117
 - Ver também Analista; Psicanalista; Psicoterapia, Terapeuta
 - silêncio na, 66-69, 165, 442-443
 - tranquilização na, 246
 - tratamento equivocado da parte ex-cindida na, 137
 - uso de brinquedos, lápis e papel na, 24-25
 - vs. auto-análise, 172, 175
- Analista:
- abandono pelo, 28
 - aceitação de presentes pelo, 117-118
 - adaptação do, 103, 129, 164, 341
 - apoio do ego no, 100
 - área interna e externa de onipotência, 104-106, 130-131, 172
 - atitudes do, 164
 - bom, como perseguidor, 346
 - capacidade de investimento psicoenergético no, 80
 - capacidade do paciente de usar o, 172
 - como fator qualitativo no meio ambiente, 352
 - confiabilidade profissional do, 80, 103, 156
 - confiança no, 28
 - dependência do, 79
 - e ataques dos pacientes, 175
 - erros do, 129-131, 156
 - evitação de casos fronteirícios [*borderline*] e, 101
 - exigências ao, 78-79
 - existência do, como pessoa separada, 62, 64
 - experiência no, de mãe com bebê, 195
 - fracasso do, 61, 71, 73, 129, 156, 169, 199, 340
 - fracasso em sustentar no, 199
 - importância da não-retaliação no, 175-176
 - incapacidade do, em permitir fracasso, 169
 - inconfiabilidade do, 80, 246
 - inveja do, 338 e segs., 341 e segs.
 - mutualidade com paciente e, 199
 - necessidade de interpretar do, 172
 - potência do, 62-64, 147
 - processos inconscientes do, 146
 - que desloca genitor insatisfatório, 129
 - receptividade do, às comunicações do paciente, 134, 164
 - remoção do refugio e, 175
 - separação do, 93
 - sobrevivência do, 175
 - tolerância da loucura no, 99, 100-101
 - tosse do, e irritação do paciente, 41
 - trabalho de outros psicoterapeutas e, 375-376
 - Ver também Análise; Paciente; Terapeuta; Transferência
 - transferência delirante e, 67, 104, 117, 135, 442
 - visitar e comprar comida para paciente, 39
- Anamnese, 9, 108-109, 249, 261
- Aniquilamento, 61, 75, 90, 176, 435
- Aniversário: da morte do pai, 278, 279
- Anorexia nervosa, 85
- Anormalidade física, 204-210, 211-217
- ajustamento à, 205, 209-210, 217
- Anseios homossexuais, 247
- Ansiedade de castração, 168, 207, 334, 417
- Ansiedade, 56-57, 60-62, 99, 107, 217
- de castração, 168, 207, 334, 417
 - elementos primitivos do superego e, 356-357
 - impensável, 91, 100, 108, 153, 155, 202, 435
 - masturbação e, 31
 - perda da capacidade de brincar e, 51
 - primitiva ou arcaica, 108, 202, 435
 - psicótica, 28, 100, 147-148, 172, 330
 - terapia de choque em casos de, 405, 410
- Apercepção, 315
- Apoio do ego, 96, 100, 233
- suprido pela mãe, 81, 330, 370
- Apresentação objetal, 71-72, 340
- Área de brinquedo: tudo é permissível na, 10
- Artes, as, 300, 422-423
- Assistência social, 336, 424-425, 435, 436
- Assistência Social, 38
- Associação de Psicologia e Psiquiatria Infantil, 44
- Associação livre, 24
- Associação Médica Britânica, 305
- Atadura, 12
- Athenaeum, 158
- Atividade sexual; usada para impedir os indivíduos de fundirem-se, 257
- Atriz, 41
- Atuação:
- da fantasia de masturbação, 52
 - de lembrança de ser abaixado, 28
 - de pacientes de clínicos gerais, 337
 - e erros do analista, 79

Ausência: da mãe, 48, 273
 Autismo, 72, 119, 155
 Auto-sustentação, 71-72, 90
 Axline, Virginia, 375-377

Babar, 45
 Babá, 5, 33
 Bach, 11
 Balint, Alice, 433, 437
 Balint, Enid, 334, 350n
 Balint, Michael, 82, 331-337, 442
 Barkin, Leonard, 1n
 Barriga, 128, 234-236
 coisas que caem para fora da, 85, 236, 237-238
 idéia da gravidez e, 235-236, 237-238, 240, 241-242
 Barulho, 290
 Bater com a cabeça, 36-37
 Beatles, 12
 Bebê(s), 45, 55, 60-61
 a alimentar a mãe, 68-69
 a criar o objeto e o mundo, 44, 347
 conceptualmente inseparável o cuidado de bebês,
 59-61, 340
 estudo de, 340, 344, 346-347
 Bebê, Bebês, 122
 alimentação ao seio, 173
 anal, 65
 capacidade de SER no, 141
 capacidade inicial de objetificar no, 197
 crença na confiabilidade no, 202, 221
 destrutividade no, 176, 439
 doença inicial no, 59, 437
 fantasias da mãe a respeito do, 127
 humano desde antes do nascimento, 429
 mãe que alimenta, no brinquedo, 68-69, 198
 menino, tratado como menina, 43, 135
 mundo subjetivo do, 220-221
 não pode ser descrito sozinho, 196, 351
 nascido com defeito, 127, 128
 no útero, 65
 primeiros sorrisos do, 328
 propriedades do, 120
 qualidade de vida do, 185, 220
 que dá pontapé no seio, 221
 que olha o rosto da mãe, 198
 que pula para cima e para baixo, 267, 273
 uso da mãe pelo, 181-185
 Beethoven, 11, 47-48
 Bernays, Martha, 359, 360
 Bettelheim, Bruno, 191n
 Bíblia, 6
 Biblioteca Psicanalítica Internacional, 304, 306
 Bion, W. R., 106n., 162, 167, 352
 Bíssexualidade, 134, 136-137, 138, 139, 148
 Blake, William, 184
 Bleuler, Eugen, 318
 Bloqueio mental, 207
 Boca, 22, 40, 44, 45, 380-383
 Bonaparte, Marie, 260, 270n.

Boneca(s), 5-6, 12, 46
 Bornstein, Berta, 124-125
 Bowlby, John, 55, 323-330, 434
 Bowra, M., 69
 Bracelete, 12
 Breuer, Joseph, 360
 Brill, A. A., 303
 Brinquedo/Brincar, ix, 2-3, 10-11, 24-25, 49-52, 160
 brinquedo de espalhar desenhos, 236
 capacidade da criança de, 241-242
 de duas irmãs na infância, 252-253
 de Frankie, na análise, 125
 de país, 334
 elaboração imaginativa da função corporal e, 50, 120
 excitação no, 162
 experiência e, 2, 13
 interpretação com o, 134
 psicoterapia e, 231, 243
 Brinquedos: na análise de adultos, 24
 Brooke, Rupert, 384
 Bryan, Douglas, 303
 Bulbo de jacinto, 100
 Burlingham, Doroty, 312-315, 328
 Busca objetual, 198, 314, 318, 320, 434, 443

C. C. T., ix, 100, 407-410
 Ver também Terapia de choque
 Café, 24-25
 Campanário, 107-108
 Canguru, 235, 238, 239-240, 241-242
 Cão, 30, 208, 235-236
 Caos primário, 27, 28
 Cartas:
 a D. W. W., de um amigo, 8
 D. W. W. a Clare, 12
 D. W. W. a Stanley Ede, 7-8
 D. W. W. à sua mãe, 7
 de Freud, 359-361
 Cartões de Natal, 11
 Carência, *ver* Privação
 Casal que cria, 45
 Castração, 185, 417
 do analista, 63-64, 64
 Catalogação, 120
 Centro de Educação de Devon, 119
 Cérebro, 122, 396, 414
 efeito da terapia de choque sobre o, 394-395
 tumor do, 97, 417
 Chapéu(s), 235-235, 241-242
 Chocolate, 118
 Choque causado pela explosão de granadas, 303
 Choro: atingido por paciente, 104
 Ciência: lógica e intuição na, 123
 Circuncisão, 417
 Cisão, 20-21, 51, 89-90, 152, 202, 431
 da personalidade, 369-370
 Ver também Intelecto ex-cindido; Elementos mas-
 culinos e femininos ex-cindidos.
 de elemento masculino ou feminino, 134-150

- de observador e observado, 259
 de sadismo e masoquismo, 179
 do ego, na teoria de Fairbairn, 316 e segs.
 entre cabeça e corpo, 155
 no cuidado ambiental, 126
 sonhos e, 317
 Ciúme, 349, 350
 de irmã imaginária, 25
 entre irmãs, 251, 256
 idéias de paciente sobre o, 66, 68, 69
 Clavícula, 7
 Clímax, 31-32, 54, 427-428
 Clínica Davidson, 70
 Clínica de Psicanálise de Londres, 296, 304
 Clínica geral: psicoterapia psicanalítica e, 334 e segs.
Ver também: Médico(s)
 Clínica: de D. W. W., em Paddington Green, 9-10
 Clube 152, 431
 Clube: De D. W. W., 158-159
 Clínica particular, 9, 225-227
 Tabela da de D. W. W., em, 228-229
 Clínica Tavistock, 334
 Cobertor, 48
 Colapso, 70-71, 98-100, 122
 ambiental, 113
 já experienciado, 72-74, 96
 medo do, 70-71
 revivido na transferência, 61
 total, 96, 98, 412
 Colisão ou invasão, 75, 100, 332, 344
 Colite: criança com, 87-88
 Comer, 23, 41, 55, 75, 81, 218, 221
 ser comido e, 68-69, 344
 Comissão Curtis, 296
 Complexo edipiano, 55, 57, 63-64, 69, 94, 113, 115, 187, 191, 195, 196, 314, 328, 332, 342, 355, 356, 357, 433, 437
 Compulsão à repetição, 317
 Compulsão(ões), 90, 181, 254, 317
 a furtar, 109, 253
 Comunicação, 198-202, 247
 jogo do rabisco e, 232
 na consulta terapêutica, 230
 perda de, 39-40
 verbalizada e não-verbalizada, 163
 Concepção: idéias do bebê sobre sua própria, 60-61
 Conciliação, 131
 Conferência Interclínica de Orientação Infantil, 249
 Confiabilidade, 153, 156, 200-202
 fé na, e capacidade de regredir à dependência, 272, 280
 Confiança, 166, 203
 como base para brincar, 49, 50, 51
 na família, e capacidade de usar o analista, 103, 112-113
 na primeira entrevista terapêutica, 230, 291
 regressão e, 154, 275
 Conflito, 30, 31, 53-54, 56-57
 Confrontação, 150
 Confusão, 26-28, 200-202
 Congresso Ortopsiquiátrico Escandinavo, 53
 Congresso Psicanalítico Internacional, 58, 124, 303n., 340-341
 Conluio psicossomático, 92, 100, 203, 205, 431
 perda do, 71-72, 432
 processos de amadurecimento e, 81
Ver também Personalização
 Conluio:
 da mãe com o bebê, 81
 de anonimato, 336
 de paciente e analista, 84-85
 Constância objetal, 176
 Consulta terapêutica, 230-232, 244-248, 250-251, 261, 291
 anamnese através da criança na, 108-109, 261
 capacita a criança a usar a família, 111-113, 231, 243
 única, 107, 225, 231, 243
 Contar mentiras, 253, 254
 Contato físico: na análise, 28, 199
 Continuidade das gerações, 140-141
 Continuidade do ser:
 ameaçada, 273
 interrompida, 75, 155, 332, 344
 Contratransferência, 73, 148, 195
 Controle, 45, 50, 79, 180, 428, 435
Ver também Onipotência
 Cooperação inconsciente, 117
 Coordenação, 45, 50
 Copos, 147
 Cordélia, 360
 Corpo, 53, 210, 381, 427-428
 Coçar a pele, 19
 Crença: erigida sobre a confiabilidade introjetada, 153
 Crescimento: durante toda a vida, 219, 222
 Criança (s):
 ajustamento em, a anormalidade física, 205, 209-210, 217
 alucinação e, 33-34
 capacidade de, em objetificar, 196
 complexidade da, aos 2 anos, 328
 doença de, 87-88
 e depressão da mãe, 192-193
 e novo bebê, 107-108, 109, 196, 258
 e separação dos pais, 376
Ver também Bebês
 evacuada, 10
 existência separada em, 220
 importância do pai para a, 188-189
 inibição em, do funcionamento corporal orgástico, 17-19
 privação em, 323-325
 Criança desajustada, 424
 Criança(s) e dar(em) seus primeiros passos: sintomas neuróticos na, 55-56
 Criar, 123
 do bebê, 44-45, 347
 Criatividade, 134, 193, 300, 321, 371
 inibição da, 183-184
 percepção e, 300, 314-315
 Cromwell, 184-185
 Crueldade, 11
 Crueldade, 55

Culpa, 130-132
 de paciente com espinha bífida, 214
 de paciente feminina por ficar com raiva, 117
 inconsciente, em criança carente, 325
 inibição de funcionamento corporal orgástico e,
 17, 23
 masturbação e, 31
 relativa a idéias destrutivas, 180-181
 senso consciente de, 407
 Cura, em psicanálise, 169

Dartington Hall, 170
 Darwin, Charles, 437
 Davidson, S. S., 340-341
 Deboche, 146, 266
 Defeito mental, 210
 Defesa maníaca, 27, 42, 273, 329, 333-334
 Defesa(s), 26-27, 56, 71-72, 95, 134
 a ansiedade intolerável na primeira infância, 60-61,
 100, 200-202
 de não ser nada, 290-291
 enroscar-se como, 207
 esquizofrenia como, 71-72, 154-155
 pânico como, 435
 rigidez da, 57, 58, 94-95, 248
 usada na privação, 439
 Delinquência, 434, 439
 Democracia, 436
 Denaidés, 193
 Denegrecimento, 180-181, 184, 217-218
 Dentes, 208
 Dentro, 128, 142
 Dependência, 55, 152, 204, 331 e segs., 434, 435, 440-441
 a aparecer na transferência, 71
 absoluta, 58, 113, 126, 196-197, 430
 estágios da, 55, 71-72, 81
 grau de, 114
 inconsciência [*unawareness*] inicial da, 81, 346-347
 infantil, na teoria de Fairbairn, 321
 inicial, 59-61, 189, 351-352
 perigosa, na análise, 79
 progressão a partir da, 152
 regressão à, 37, 79, 344, 352
 relativa, e reconhecimento da, 81
 trauma e, 113
 Depressão, 26-28, 31, 40, 192-193, 428-429
 como enfermidade de pessoas de valor, 409-410, 435
 de crianças e bebês, 327
 dependência e, 55
 destrutividade e, 54
 em menina adolescente, 250 e segs.
 em país, 65-65
 em Patrick, 268, 274, 276
 Klein e a, 407, 434
 perda de fenômenos transicionais e, 48
 reconhecimento, pelo analista, da, 397
 recuperação espontânea da, 399, 429
 suicídio e, 27, 399, 405
 terapia de choque e, 405, 409-410, 410

valor da, para o paciente, 41
 Desadaptação, 113, 340, 434
 adaptação e, 114, 340, 430, 441
 coisa mais difícil no cuidado infantil, 430
 lenta demais, 342
 rápida demais, 122
 Desafio, 18, 22, 357-357
 Desalucinação, 34-35
 Desenho, pintura abstrata, 111-113, 132, 213, 261
 Desenhos de rabiscos:
 da filha de G., 285-286
 de Hannah, 213-214
 de Jill, 207-208
 de L., 234 e segs.
 de Mark, 287-290
 de menino com *sindactilia*, 205
 de Mollie, 217-218
 de Patrick, 261 e segs.
 do próprio D. W. W., 11
 Desenvolvimento do ego, 28, 57, 89
 Desenvolvimento emocional, 71-72, 123
 Desenvolvimento, 71-72, 429, 434
 Desespero, 75, 107
 na rejeição pela mãe, 105, 111
 Desilusão, 17-19, 103-106, 113-114, 328
 Desintegração, 71-72, 87, 122, 203
 ameaça de, e câibra no pescoço, 88, 432
 como ansiedade psicótica, 100, 108, 155, 202
 não-integração e, 28
 Desmame, 114
 Desonestidade, 17, 20
 Desorientação, 108, 155
 Despersonalização, 31, 71-72, 88, 203
 ameaça de, 90, 91
 como ansiedade psicótica, 100, 108
 Destino, 69-69
 Destruição, 131, 174-176, 177-181, 190, 193
 do objeto, 2, 180, 370
Ver também Destrutividade
 Destrutividade, 11, 45, 50, 185-187, 338
 culpa pela, 180-181, 193
 de paciente menino, 290
 externalidade e, 2, 174-175, 177, 179
 medo da, 184
 Deus, 76, 162, 184-185, 214, 333, 419
 Devanear, 51, 253
 Devine, H., 303
 Diagnóstico, 100, 182
 Disseminação dos agentes responsáveis, 82, 87, 88, 336
 Dissociação(ões), 75, 152
 entre aspectos masculinos e femininos, 136-138, 148
 na enfermidade psicossomática, 82, 85, 87, 90, 92
vs. repressão, 370, 435
 Doença mental, *ver* Enfermidade mental
 Doppelgänger, 354
 Dor de cabeça, 85
 de D. W. W., 178-179

Ede, Stanley, 7-8

- Eder, David, 360
 Educação, Susan Isaacs e a, 295-296
 Ego Observador, 36
 Ego, 45, 76, 89, 89, 119, 189, 435
 distorções do, 210
 do bebê, 81
 integração do, 380-383
 materno, 69
 Elaboração imaginativa da função corporal, 50, 120, 180
 Elemento feminino, 140, 148
 homossexualidade e, 138-139
 na personalidade de paciente masculino, 134-137, 138, 143-146
 Elemento masculino, 139-142
 Elementos masculinos e femininos ex-cindidos, ix, 137, 138
 Eliot, T. S., 3, 12
 Embalar, 36
 Empédocles, 187-189
 Enfermidade esquizóide, 131, 155, 202, 321, 434
 Enfermidade obsessiva, 26-27, 57, 123-124
 terapia de choque e, 405, 410
 Enfermidade ou doença física: e distúrbio emocional, 399
 Enfermidade ou doença mental, 152, 399, 408-409, 415, 416
 imaginada como enfermidade física, 397, 410, 412, 415
 ódio da sociedade pela, 411
 vantagem do colapso na, 412-413
 Enfermidade psicossomática, 82-82, 435
 Enfermidade:
 começo de, com nascimento do novo bebê, 107
 física, 422
 psicológica, 328, 437
 Engano, 21
 Enurese, 88, 110, 242
 Erikson, Erik, 95, 141, 373, 374, 434
 Erotismo: fusão do, com a agressão, 81
 Erros: na análise, 66-67
 Escola, 111-113, 114, 272 e segs., 280, 296
 Escotomização, 35-35
 Escravos: os gregos antigos e os, 189
 Espaço potencial, 157-158, 162, 437
 Espaço: entre médico e paciente, 9-10
 Espelho, 157, 376-377
 Esperança, 27, 90, 105, 434, 439
 Espinha bífida, 211
 Espontaneidade, 300, 371
 perda de, 354, 435
 Esposa, 43, 145-146
 Espírito Santo, 184
 Esquizofrenia, 96, 98, 152, 154, 434
 como defesa, 71-72, 154
 como organização de defesa *vs.* regressão, 151
 e fracasso inicial de seu cuidado, 58
 efeito da, no meio ambiente, 97
 etiologia da, e psicanálise, 96, 350
 terapia da, e confiabilidade, 156
 Estresse: e trombose coronária, 29-30
 Etologia, 328
 Eu real, 434
 "Eu sou o rei do castelo", 76, 89, 89
 Eutanásia, 414, 416
 Excitação, 29-32
 clímax e, 31-32, 427-428
 não-orgiástico, 436
 no relacionamento objetal, 172
 produzido por ser desejável, 142
 vida instintual e, 54, 427-428
 Excreções, 45
 Existencialismo, 76
 Experiência cultural, 157-161, 374, 435
 Experiência instintual, 180
 Experiência psicossomática: raiz do ego na, 76
 Experiência, 11, 31-32, 80, 162
 brincar e, 2, 13, 25
 de colapso, 73-74, 96
 de loucura, 96
 de mutualidade, 198
 de onipotência, 73, 113, 220
 erótica, e elemento masculino, 140
 psicossomática, e raiz do ego, 76
 registro da, 119
 sexual, 138
 Experiências religiosas: objetos transicionais e, 48
Fairbairn, W. R. D., 316-322, 434
 busca objetal em, 198, 318, 320, 440, 443
 Falar, 22, 25
 Família, 132, 436
 de D. W. W., 4-5, 7
 terapia na, 107, 111-112, 112-113
 trauma e, 102-115
 Fantasia de espancamento, 38-40
 Fantasia, 17-19, 22-23, 25, 51-52, 57, 120, 180-181
 canibalística, 218
 começo da, no uso do objeto, 174
 da mãe, a respeito do bebê, 127
 de destrutividade, 439
 de leões e tigres, 285
 de ser espancado(a), 38-40
 destruição do objeto na, 174, 176, 190
 do bebê, 122
 no estágio dos primeiros passos, 334
 pré-genital, de fecundação e gravidez, 63-64, 64, 65-65, 241-242
 separação entre a, e o objeto externo, 185, 190
 Fantasmar, 25, 57n.
 Fase pré-púbere, 103
 Fatores esquizóides, 316 e segs.
 Fazer, e desfazer, 26
 Fecundação *Ver também* Gravidez
 Fecundação, 63-64, 65
 Felação, 139, 148
 Fenômenos transicionais, 1, 2, 36, 45-48, 161
 área intermediária e, 344
 Ferenczi, S., 303, 440
 intimidade na área dos, 253

- paradoxo e, 253
 Feridas narcísicas, 60-61
 Ferir, 10, 115
 Ferocidade, 184, 236 e segs.
 Feto: fantasias dos pais a respeito do, 127
 Fine, Bernard, 170, 189
 Fisiologia, 29, 31
 Fisioterapia, 427-432
 Fixação, 40
 Flato: e comunicação com a mãe, 39-40
 Flugel, J. C., 303
 Fobia de elevadores, 126
 Fobia(s), 57, 71, 126, 184, 242, 271-272
 Fogo: saído da boca do dragão, 185
 Follett, M. P., 299
 Fordham, M., 370, 435
 Formação: psicanalítica, 304, 376
 Forsyth, D., 303
 Fracasso:
 ambiental, 28, 61, 71, 75, 152, 153, 155, 168
 da análise, 172
 do analista, 65, 71, 73, 129, 156, 169, 199, 340
 graduado, de adaptação, 113, 340, 430
 materno, 89, 92, 345
 trauma como, 113
 Freud, Anna, 55, 185, 328, 380, 388-389, 409, 437, 438
 Freud, S., 94, 151, 171, 187-189, 198, 316, 326, 359-361, 397, 407, 433, 434, 435, 437, 440
 "Análise Terminável e Interminável", 186-187
 capacidade de, para a dúvida, 349
 capacidade de, para a felicidade, 361
 conceito do superego em, 353 e segs.
 ego corporal em, 89
 fuga para a sanidade em, 366
 função do ego em, 36, 370
 idéia do crescimento a parar com o estado adulto em, 219
 instinto de morte e, 188, 348-349
 introdução de D. W. W. a, 9, 437
 Jones e, 302 e segs., 310-311
 Jung e, 365 e segs.
 melancolia, luto e, 412
 método psicanalítico e, 437
 Moisés e o Monoteísmo, 187
 o inconsciente em, 72, 369-370
 princípios da psicanálise e, 77
 processo da psicanálise e, 366
 realidade psíquica e, 354
 significado ligado a sintomas em, 154
 Strachey e, 385 e segs.
 teorias de, e Fairbairn, 316 e segs.
 "Uma Criança é Espancada", 38
 Freudenburg, 400
 Frigidez, 31, 32
 Frustração, 31, 141
 Funcionamento corporal, 17-19, 120
 desenvolvimento do ego e, 89
 identidade do, com a psique, 89
 objetos transicionais e, 45
 orgásmico, 22
 Funcionamento oral: fantasia e, 128
 Furtar, 37, 143-144, 253, 343-344, 434
 Fusão, 87, 258-259, 363
 Fusão:
 de pulsões libidinais e agressivas, 81, 185, 190, 339, 344-345
 dos instintos de vida e de morte, 190
 fase anterior à, 185
 Futilidade: falta de capacidade de brincar e, 50
- G**alsworthy, John, 159
 Gardner, D. E. M., 297
 Gasell, Arnold, 313
 Gatinhos, 274
 Gato, 253, 274
 Gêmeos, 312-315
 Giovacchini, P. L., 287
 Glover, Edward, 27n., 304, 305
 Glover, James, 304
 Goldfarb, S., 325
 Gosto: senso do, 45
 Gratidão, 344, 347
 falta de capacidade de, 18, 19
 Gravidade, 363
 Gravidez, 42, 128, 131, 235 e segs., 241-242
 fantasia de, em paciente homem, 63-64, 65, 135
 reação da criança à, da mãe, 107-108, 130-131, 241-242
 Greenacre, Phyllis, 28, 174n., 434
 Gristein, Alexander, 302
 Grito, gritar, 92
 Grolnic, Simon A., 1n.
 Grupo(s): social(is), 115
 Guardanapo, 43, 143-144
 Guerra; adolescência e, 52
- H**ambling, John, 30
 Hamlet: elemento feminino ex-cindido em, 142-143
 Hampstead War Nurseries, 41, 328, 380, 388-389, 437
 Hardcastle, D. N., 405
 Harding, D. W., 120
 Harley Street, 9
 Hartmann, Heinz, 200-201, 388, 435
 área livre de conflitos no ego e, 363, 434, 440
 Heimann, Paula, 95
 Hereditariedade, 142, 340-341
 agressão e, em Klein, 347, 350, 351
 Hill, Adrian, 422-423
 Hiller, E., 303
 Hipocondria, 9, 57, 62-64, 82, 284
 elementos primitivos de superego e, 356-357
 fantasias de gravidez e, 65
 Histeria, 31
 terapia de choque e, 405, 410
 Hoffer, Willi, 378-383
 Holder, Carole, 424-426
 Holding, ver Sustentação
 Homossexualidade, 39, 65, 138, 139, 256, 370
 em paciente masculino, 64, 143-144, 148

idéias paranóides de referência e, 257, 281
 Honestidade: compulsiva, 18-21
 Hospital Infantil de Paddington Green, 9, 10, 225
 Hospital(is), 102-103
 consultas hospitalares de D. W. W., 9
 efeito da terapia de choque sobre os, 403-404, 411
 Humor, 26, 27, 428-429, 435

Id, 143
 Idealização, 105, 113, 131, 180, 182, 232-233
 Identidade, 89, 137, 140, 252, 395
 elemento feminino e, 140, 141-142
 perda da, 87, 435, 439
 perda da, através da leucotomia, 415-416, 416, 418, 419
 problemas de, em Erikson, 373-374
 Ver também Identificação(ões)
 Identificação homossexual, 52, 56
 Identificação(ões) cruzada(s), 52, 137-138, 149, 172, 198
 para lidar com nascimento de irmão ou irmã, 108, 109
 Identificação(ões), 159, 357
 brinquedo e, 50
 de analista com paciente, 28
 de criança com a mãe, 108, 111, 258
 de criança com o meio ambiente, 95, 435, 439
 de crianças pequenas com os pais, 55, 56, 334
 de homem com mulher, 138
 de mãe com bebê, 28, 37, 81, 122, 198, 198, 200-201, 440
 de meninas com a mãe, 46
 elementos masculinos e femininos e, 141, 142
 masculinas e femininas, 63-64, 221
 masculinas, 52, 285, 286
 materna, em meninos, 52
 na teoria de Fairbairn, 320
 patológica, na mãe, 200-201
 primária, 140-141, 320, 321
 projetiva e introjetiva, 140, 142, 149, 198
 Ver também Identificações cruzadas; Identidade.
 Ileostomia, 211-212
 Ilusão, 44, 45, 300, 314, 328
 onipotência e, 113, 322
 Imaginação, 5, 222
Imago Group, 160
Imago Publishing Company, 312
 Imaturidade, 60-61
 Imitação, 357
 Impotência, 31, 32, 138
 Impressão, 140
 Impulsos destrutivos, 338, 339
 Impulsos motores, 344
 Incesto, 103, 252
 Inconsciente, o, 47, 55, 72-73, 123
 reprimido, 56, 152
 Incorporação, 142, 221, 313, 407
 fantasias de, 128
 idéias de, 131
 Individuação, 219

Indivíduo: estudo do, 434
 Inibição, 150, 184
 da função da mão, 18, 19, 23
 do funcionamento corporal orgânico, 17, 23
 Inicial não é profundo, 434, 442
 Insanidade, 71, 412, 416
Insight 376-376
 Instinto de morte, 188, 348-349
 Instinto(s), 30-32, 53-54, 139-141, 142, 427-428
 de vida e morte, 187, 190
 exploração do(s), 50, 51
 no estágio dos primeiros passos, 334
 Instituto de Educação, 295, 297
 Instituto de Psicanálise, 77, 297, 304
 Integração, 71-72, 81, 90, 121, 155
 enfermidade psicossomática e, 88-89
 estudo científico da, 407
 pai como modelo para a, 188-189
 tendência herdada no sentido da, 197, 430
 Intelecto ex-cindido, 100, 124, 152, 168, 430
 Intelecto, 121, 122, 261, 354, 435
 e psique-soma, 81, 90, 355, 435
 Ver também Mente; Intelecto excindido
 Interesse, *ver* Preocupação
 Interferência: dos pais, com o funcionamento corporal orgânico, 17-19
 Internalização: *vs.* introjeção, 357
International Journal of Psycho-Analysis, 304
 Interpretação, 68-69, 128, 134, 146-147, 164-166, 172
 ameaçadora ao paciente, 165-166, 346
 avidez excessiva por fazer, 231, 244, 442
 do relacionamento do paciente com o analista, 57
 do sadismo oral, 26
 imprevista, 105-106
 mutativa, 134, 137, 386
 na consulta terapêutica, 230-231, 248
 peneiramento da, 63-64
 perigo da, 175-176
 só possível através do material fornecido, 40, 165, 172, 347
 vs. reviver, 98-99
 Interpretações que aparecem no texto:
 da identidade do Dr. X, 62
 da loucura da mãe, 290
 da loucura do analista, 135
 da necessidade de incrementar a potência do analista, 63-64
 da realidade a irromper a fantasia, 66
 de aceitação e recusa simultâneas, 111-112
 de achar-se sob compulsão a furtar, 253
 de delírio de ser odiado, 106-107
 de desejo de castrar, 63-64
 de desesperança a respeito da mãe, 146
 de dor de cabeça em moça com anorexia, 85-86
 de identificações masculinas e femininas, 63-64
 de inveja do pênis, 134, 135
 de inveja do professor bom, 342
 de movimento dos dedos do paciente, 163-164
 de nada no centro, 42
 de não haver homem, 146

de ódio do analista, 62
 de sadismo reprimido na mãe, 40
 de sonho da laranja e do rato, 165
 de sonho de adquirir dinheiro, 344
 do lapso lingual, 20-21
 do paciente, do ciúme do analista, 66, 68
 do seio moribundo, 340-340
 prematura, de sonho do paciente, 443
 relacionada ao medo de fundir-se, 258-259
 relacionada com a cena primeva, 290
 relacionada com o brincar, 134
 sobre *self* feminino ex-cindido, 135, 143-144 e segs.
 sobre agressividade, 184
 sobre beber uísque, 148
 sobre comer e ser comido, 68
 sobre deboche, 146
 sobre gritar, 92, 93
 sobre ser repreendido, 67-68
 sobre sintomas neuróticos como defesa, 147
 "você está doente", 273
 Intimidade, 5
 Introjção, 142, 221, 313, 317
 Introspecção, 253
 Invasão, *ver* Colisão,
 Inveja do pênis, 134, 208, 341
 Inveja, 62-64, 141, 176, 338-352
 meio ambiente atormentador e, 141, 344
 uso kleiniano do termo, 349
 Investimento psicoenergético, 172, 176
 Irmã(s), 251, 256-259
 imaginária, 25
 Isaacs, Nathan, 297, 297
 Isaacs, Susan, 295-298, 313
 1ª Guerra Mundial, 3, 8

Jacobsen, Edith, 189
 James, Henry, 9, 66, 67
 Jesus College, Cambridge, 8
 Jogo do Rabisco [*Squiggle Game*], 230-244, 263
 Jogo de Frankie, 125
 Jones, Ernest, 168, 226-311, 361, 385, 388
 textos de, 302 e segs., 305 e segs., 309-311
 Jones, Katherine, 302, 304, 305, 309, 311
 Jung, C. G., 72, 170, 178, 219, 303, 365-372
 Junguianos, 121

Keats, John, 75
 Khan, Masud, 133, 156n., 200-201n., 316, 350n., 388
 Klein, Melanie, ix, 48, 58, 65, 316, 397, 434, 435, 442
 apoiada por Jones, 307
 complexo edipiano e, 187
 conceito da inveja em, 81, 338-352, 440-441
 criatividade básica e, 162, 321
 denegação implícita do meio ambiente em, 341-342, 351-352
 depressão e defesas contradepressivas em, 327 e segs.
 dívida de D. W. W. para com, 350, 438

Fairbairn e, 319, 321
 identificação projetiva e introjetiva e, 198
 importância da realidade psíquica em, 355
 interesse de, pela agressão, 349-350
 lealdade a, 349
 mecanismos iniciais em, 328
 o trabalho de, sobre a depressão, 407
 posição depressiva em, 192, 329-330, 333, 344
 posição esquizóide em, 317
 posição paranóide em, 190
 reparação e restituição em, 181, 190
 superego em, 355 e segs.
The Psycho-Analysis of Children e, 356-356, 438
 Knights, L. C., 143
 Knox, Ronald, 45, 162
 Kris, Ernst, 388, 436

Lágrimas, 110
 Laing, Ronald, 97, 101, 434
 Lapso lingual, 20, 21
 Lar: bom, 57
 Leão, 45
 Lear, Edward, 12
 Lembrança, lembranças, 27, 28, 120, 435
 eu/não-eu: ausência de separação entre, 190, 196-197, 331, 351
 repúdio do não-eu, 76, 190, 331-332
 separação do eu/não-eu, 71-72, 351
 Lembrar:
 sonhos, 276
 vs. reviver na transferência, 74, 98
 Lenço, 66
 Leucorréia, 284, 286
 Leucotomia, ix, 393, 397, 401, 409, 412-421
 Lewin, Bertram L., 233
 Leys School, 6
 Limericks, 45
 Linguagem pré-verbal, 123
 Little, Margaret, 34, 98, 104, 106n., 434, 442
London School of Economics, 393, 416
 Lorde Horder, 9
 Loucura, 45, 48, 94-101, 435
 da mãe, a aparecer no filho, 287 e segs.
 medo da, 94, 98, 99-100, 325, 416, 418-419, 435
 Ver também Colapso; Psicose; Esquizofrenia
 Low, Barbara, 303
 Lowenfeld, M., 433, 437
 Lábios, 45
 Luto, 279, 329, 330

Mãe:
 alienada quanto ao bebê no nascimento, 125
 ambivalência na, 194
 apoio do ego por parte da, 81, 89, 330
 atormentada, 340, 344
 ausência da, 48, 273 e segs.
 capacidade de ter um seio que é, 141-142
 capacidade psicológica de produzir um bebê, 127

- como objeto transicional, 36, 45-46
 como parte do bebê, 55
 confiança na, e capacidade de brincar, 49
 confusão da, 27, 127
 conluio da, com bebê, 81
 cuidado mental do bebê pela, 260 e segs.
 depressão na, 193
 desesperança do paciente em relação à, 39
 e deficiência da criança, 204-205, 209, 210
 e experiência da maternagem, 198
 enfermidade da, que aparece na criança, 88
 engano da criança e, 21
 estado retraído na, 28
 fracasso da, 69, 89, 112-113, 125-126, 330
 função ex-cindida da, 125-126
 identificação da, com o bebê, 37, 81, 122, 200-201
 identificação patológica na, 200-201
 incapacidade de desmamar o bebê, 114
 inveja da, 340
 loucura da, a aparecer no filho, 287 e segs.
 melancolia na, 111-112
 necessidade inconsciente na, 46
 nova gravidez na, 107-108, 130-131
 ódio reprimido na, 114, 194
 perda da, 328-330
 preocupação patológica na, 37, 92
 proteção da, por paciente, 184
 que aceita a projeção do bebê, 344
 que apresenta o mundo ao bebê, 152
 que dá ao bebê experiência de onipotência, 113
 que desilude o bebê, 113-114
 que empresta unidade ao bebê, 430
 que permite ao bebê criar o mundo, 44, 198, 340
 que se adapta às necessidades do bebê, 37, 60-61, 81, 89, 113-114, 122, 141, 150, 197, 332, 341, 429, 441
 que trata o bebê menino como menina, 43, 135, 143-144
 reação moralista na, 176, 221
 rejeição da criança e, 109-112
 relacionamento da, com filha adolescente, 255-259
 sadismo reprimido na, 40
 sobrevivência da, 176
 suficientemente boa e não suficientemente boa, 37, 141, 152-153, 173, 346, 435
 transtorno puerperal na, 109
Malting House School, 295, 297
 Manejo, 141, 431-432
 meio ambiente facilitador e, 71-72, 81
 Mania, 27, 407, 435
 Mão(s), 380-383
 inibição da função da(s), 18, 23
 Masoquismo, 40, 405
 Masturbação, 25, 31, 51, 52, 66, 239
 inibição da função da mãe e, 18-19, 23
 Material clínico:
 bebê com dificuldades de alimentação, 378
 bebê com neurose obsessiva, 437
 Frankie, 124-126
 G., filha de, com 6 anos, 285-286
 G., menina de 10 anos, 283-285
 homem com elemento feminino dissociado, 134-137
 homem com nada no centro, 43
 homem cujo sonho foi prematuramente interpretado, 443
 homem que era calado, 163
 homem que estava começando a brincar, 25
 homem que invejava o analista, 62-66
 homem que invejava o professor boni, 342
 homem que não era agressivo, 183-185
 homem que veio buscar, 342
 Jane, de 12 anos, 249-259
 L., menina de 5 anos, 233-241
 menina com colite, 87-88
 menina de 2 anos cujos pais se haviam separado, 376
 menina de 2 anos e meio com inibição para comer, 357
 menina de 2 anos e meio que chegou com o pai, 246-247
 menina de 6 anos privada quando do nascimento da irmã, 109-112
 menina perturbada por perverso, 102-105
 menina que revivia a loucura original, 98-99
 menino com esquizofrenia, 34-35
 menino com sindactilia, 204-205
 menino com tumor cerebral, 97
 menino cuja mãe adormeceu, 199
 menino de 5 anos encantado com a consulta, 247
 menino de 6 anos atacado por homem, 247
 menino que fazia desenhos abstratos, 111-113
 moça com anorexia nervosa, 85-86
 moça de 12 anos cujo pai faleceu cedo, 205-209
 moça de 13 anos com espinha bífida, 211-217
 rapaz de 15 anos com consciência do superego, 340
 Mark, que reagia à loucura da mãe, 287-292
 Mollie, de 6 anos, 217-218
 Patrick, cujo pai se afogou, 260-281
 Phyllis, de 12 anos, que estava apenas se equilibrando, 107-108
 mulher a quem se mandou endireitar as meias, 78
 mulher assustada pela idéia da T. E. C., 405
 mulher com cisão psicossomática, 86-87
 mulher com fantasia de ser espancada, 38-40
 mulher com inibição da função da mão, 18, 19
 mulher com nada no centro, 41-43
 mulher com parte masculina dissociada, 136-137n.
 mulher com transferência delirante, 105-106
 mulher mulher que não podia pensar, 168-169
 mulher próxima da posição depressiva, 28
 mulher que cometeu suicídio, 75
 mulher que descobriu a sua maldade, 131
 mulher que estava fazendo 'terapia' de choque, 395-397
 mulher que exigia silêncio, 66-69
 mulher que experienciou um vazio, 75
 mulher que explorava objetos substitutos, 345-345
 mulher que não podia chegar à culpa verdadeira, 131
 mulher que não podia gritar, 91-92
 mulher que não podia transigir, 131-132
 mulher que precisava de contato físico, 199

- mulher que precisava de um ambiente constante, 79-80
mulher que queria café, 24-25
mulher que sabia e não sabia, 20-21
mulher que se retraiu, 116
mulher que sonhou com laranja e rato, 165
mulher que sonhou com uma alucinação, 33, 35
mulher que tocou duas vezes a campainha da porta, 106-107
mulher vista a comer no restaurante, 22-23
Ver também Pacientes.
- Maternagem, 27, 67, 344 e segs., 429 e segs.
suficientemente boa, 156, 197, 344 e segs., 363
- Mau: triunfo do, 26
- Maudsley Hospital, 423
- McLean Hospital, 151
- Mead, Margaret, 133, 141
- Médico(s), 7-8, 9, 334 e segs., 398, 404, 416
enfermidade psicossomática e, 82, 86
relacionamento de pacientes e, 404
- Medo ou temor:
associado com a leucotomia, 415-416, 418-419
compulsão e, 73, 74-75, 75
da alucinação, 33
da cisão, 259
da doença mental, 272, 272
da fusão, em relacionamentos, 258-259
da loucura, 94, 190
da mania, 27
da morte, 74-75, 284
de nada a que reagir, 41
do colapso, 70-71
primitivo, de agressão, 184-184
Ver também Ansiedade
- Meio ambiente expectável médio, 106, 113
- Meio ambiente, 45, 49, 113-115, 131, 141, 362, 434-435
a tornar-se menos importante com a autonomia, 152
atormentador, 72, 141, 168, 340, 346
cisão do, e enfermidade psicossomática, 83, 85
colapso no, 95, 113
como parte do bebê, 350, 441
como parte do desenvolvimento da criança, 189, 196
como pré-condição para o indivíduo, 220-221
confiabilidade no, 56, 57, 95
denegação implícita do, em Klein, 341-342, 351
esquizofrenia no, 97
estresse no, e trombose coronária, 29-30
expectativas patológicas no, 149, 152
facilitador, 69, 71-72, 80-81
fracasso no, 28, 61, 71, 75, 152, 153, 155, 168
identificação com o, 95, 435, 439
importância do, no início, 152, 341, 351
impredizível, 155
no desenvolvimento do *self* 210
posição paranóide e, 190, 221
reação no, e perda da agressão, 190-191
regressão à dependência e, 37, 78
separação entre *self* e, 381
sustentação [*holding*] na análise e, 28
teoria do, 440
- Melancolia, 105, 138, 327, 402
- Meltzer, Donald, 340-341
- Membrana limitadora, 47
- Membro: partido, 208-209
- Menina(s), 46, 52, 193
- Menino(s), 43, 46, 52, 193
- Menstruação, 283
- Mente, 120, 122
separada da psique-soma, 354-355, 430-431
Ver também Intelecto
- Meyer, C. G. S., 385
- Michelangelo, 348
- Micção, 88, 283
Ver também Mijar
- Middlemore, M. P., 45, 327, 437
- Mijar, 43-43
- Miller, Crichton, 21
- Milner, Marion, 299-300
- Mito grego: homossexualidade e, 139
- Molhar a cama, 88, 110, 242
- Monoteísmo, 189, 356
- Moody, Robert, 34
- Moore, Henry, 261
- Morada, 81, 89
Ver também Conluio psicossomático
- Moralidade: implantação da 27
- Morrer, 2, 3, 4, 98
Ver também Morte
- Morte, 105-106, 176, 260 e segs., 334
de D. W. W., 13
medo da, 74-75, 98
- Movimento: perfeito, 18, 19
- Moynihan, Rodrigo, 305
- Mulher, mulheres, 3
medo de, 360
- Mundo interno, 27, 422
- Mundo onírico, 12, 220
- Musica, 11
- Mutualidade, 198-202
- N**ada a que reagir, 41, 42, 43
- Nada no centro, 41-43
- Não-existência, 76
como defesa contra a loucura da mãe, 287, 291
- Não-integração, 27, 28, 89
- Narcisismo, 72, 76, 150, 331
- National Childbirth Trust, 171
- Necessidade:
vs. pulsão 198
vs. desejo, 188, 198, 357
- Negrume, 34
- Neurose obsessiva, 124, 437
Ver também Enfermidade obsessiva; Tendência obsessiva
- Nível anal, 39-40
- Nível oral: perda de comunicação no, 40
- Normalidade: na fase edipiana, 58, 94-95
- Núcleos do ego, 27

Objeto bom, 28
 Objeto parcial, 330
 Objeto(s) transicional(is), 1, 2, 10, 36, 44-48, 344
 ambivalência e, 115
 paradoxo e, 161-162, 173, 220
 perda de valor do, 330
 separação de eu/não-eu, 333
 Objeto(s):
 cisão do, 51
 destruição do, 174, 177, 180, 190
 duro e macio, 46
 fora da área de onipotência, 81, 174-175
 fora do controle onipotente, 174, 177, 179
 idealizado, e ódio, 105
 imaginário, 34
 interno *vs.* transicional, 48
 não-eu, incluído no esquema corporal, 60-61
 objetificação do, 185, 328, 330, 342, 344, 344
 primário, 344
 proteção do, 180, 182
 qualidade separada do, na satisfação pulsional, 141
 sobrevivência do, 174, 177, 186-187, 190, 435
 subjetiva *vs.* objetivamente percebido, 44, 81, 156, 173-175, 180, 197, 245, 248, 253, 253, 328, 330, 340, 342, 350
 subjetivo, e elemento feminino, 140
 Ver também Objeto transicional
 Observação de bebês, 198, 210, 315, 380, 382-383
 Obstetrícia, 436
 Odio, 26, 57, 146, 182, 435
 como delírio de ser odiado ou perseguido, 107, 115
 de pacientes, na transferência, 18, 62, 64, 104-105, 106, 107
 do objeto bom, e desilusão, 106, 113, 114-115
 inconsciente, no analista, 246
 reprimido, na mãe, 114, 193, 194
 Onipotência, 45-45, 60-61, 69, 120-121, 137-138
 agonia primitiva e, 72-73
 analista e área de, do paciente, 104-106, 130, 175
 experiência de, 73, 113, 220
 potencial ilusional e, 322
 Orelha, 45
 Organização do ego: colapso da, 71, 100
 Orientação, falta de, 41, 43
 Originalidade, 362
 Oscilação maníaco-depressiva, 334
 Owen, Morfydd, 304
 Oxfordshire, 10, 438

Pacientes fronteirizos [*borderline*], 96, 154, 156, 172, 246, 351-352
 Pacientes descritos no texto:
 alívio por deixar a análise ao analista, 62
 anorético, 85
 homem cuja mãe o tratava como um bebê menina, 43, 135, 143-144
 homem que descobriu seu *self* feminino, 145-146
 homem que descobriu unidade primária com analista, 137

mantida na mente do terapeuta durante episódio louco, 292
 menina perturbada pelas palavras do analista, 103-104
 moça com vínculo homossexual com a mãe, 214
 mudanças em mulher, após interpretação, 165
 mudanças na aparência de adolescente, 250
 mulher com desejo de controle sobre o analista, 79
 mulher que derrubou a bandeja do café da manhã, 168-169
 mulher que experienciou agonia em vez de raiva, 130
 mulher que gostava do analista e ficou zangada com ele, 116-117
 mulher que precisava de maternagem, 67
 mulher que precisava de separação da mãe e do analista, 93
 mulher que se enganou quanto à hora da sessão, 106
 mutualidade com analista através do embalo, 199
 que chutou a mãe no desenho, 218, 221
 trabalho de casa de homem, 184, 184
Ver também Material clínico,
 Pacientes, 129-130, 164-164, 181-182, 193-194
 confidencialidade e, 395
 e exigências regressivas, 76
 e o presentear, 117-118
 e uso do analista, 172, 181-182
 exploração de fatores internos pelos, 137-138
 partes doentes dos, 80
 raiva dos, nos fracassos do analista, 199
 relacionamento dos, com médicos, 404
 Ver também Análise; Analista
 Pai, 3, 188
 de paciente feminina, que morreu, 105-106
 de paciente incapaz de controlar a agressão, 184
 descoberto em momento de excitação sexual, 35, 39
 introjetado, e autocontrole, 184
 morte do, 208-209, 260 e segs.
 nos sonhos das crianças, 56
 paciente feminina buscando o amor do, 132
 potente, do triângulo edipiano, 63-64
 privação do, 247, 254
 que não quer o *self* feminino da filha, 75, 132
 valor do, para paciente feminina, 21
 Pais, 61, 108, 334, 355 e segs.
 de adolescentes, 185-187
 efeito da separação dos, 376
 fantasias referentes a criança não-nascida e, 65
 relacionamento entre os, de Patrick, 269-271
 Paixão segundo São Mateus, 162
 Palavras, 119, 121, 123, 355
 Pânico, 100, 156, 272, 435
 Papel, 10, 66, 79
 Paradoxo, 60-61, 162, 169, 434, 435
 fenômenos transicionais e, 161-162, 220, 352, 434, 441
 Paralisia geral do insano, 97
 Paranóia, 97, 103-106, 271-272, 332, 434-435
 hipersensibilidade e, em paciente menino, 272-273, 275
 terapia de choque [ECT] e, 405, 408, 410

- Payne, Sylvia, 304, 305
 Pediatria, 2, 9, 408
 Pele: doenças da, 88, 91
 Pênis, 19, 35, 43, 66, 142, 207
 Pensar, 119-123, 167-168
 Ver também Cérebro; Intelecto; Mente
 Perda, 28, 48, 335-330, 357
 Perfeccionismo, 57
 Perseguidor:
 mulher que atendeu à porta como, 106
 "seio bom" como, 345
 Perseguição, 54, 76, 88, 125, 271-272, 332
 Ver também Paranoia
 Personalização, 89, 203, 205, 210
 Ver também Morada; Conluio psicossomático
 Perversão(ões), 65, 145-146
 Pervertido(s), 102-103, 247, 283-284
 Pesadelo(s), 33, 55, 178
 Pesar, 28, 334
 Pessoas e animais imaginários, 25, 34, 55
 Piaget, J., 119, 313
 Picasso, 265
 Pintura, desenho abstrato, 111-113, 132, 213, 261
 Platão, 360
 Plínio, 185
 Plymouth, 4, 6, 7, 9
 Poesia, 70, 253
 Polegar: objetos transicionais e, 44, 46
 Porco, 217, 285
 Posição depressiva, 27-28, 65, 76, 193, 333, 344
 Posição homossexual, 56
 Posição paranóide, 190, 221
 Posições do instinto, 37
 Potência, 43, 63-65, 88, 145
 Prazer, 23, 49
 Pré-prazer, 31
 Preocupação (ou interesse):
 a respeito da destruição, 180
 a respeito do seio moribundo, 345
 bloqueada pela atitude da mãe, 221
 capacidade de, 435
 na posição depressiva, 334
 Ver também Culpa; Interesse
 Preocupação materna primária, 28, 197, 220, 344, 434, 435, 440
 Presentes: de paciente para analista, 117-118
 Primeira infância, estágios da, 55
 Prince, Morton, 303
 Princípio da realidade, 60-61, 113, 131, 363
 agressão e, 221
 agressão reativa e, 176, 352
 uso de um objeto e, 174-175
 Privação ou Carência, 435
 Privação, 48, 51, 109-110, 122, 218, 279
 dois tipos de, 439
 materna, 323-326
 tendência anti-social e, 54-55, 439
 Processo analítico:
 contínuo através da vida, 348
 Freud e o, 366
 Processos de amadurecimento ou maturacionais, 59, 60-61, 71, 81, 89, 210
 herdados, 80, 152
 meio ambiente facilitador e, 71-72, 80, 115, 174, 219, 440
 Processos maturacionais, *ver* Processos de amadurecimento
 Projeção 76, 81, 142, 172-175, 221, 363
 analista como, 62, 175, 346
 criatividade básica e, 162
 do "seio bom", 344 e segs.
 realidade [*actuality*] como, 435
 Propaganda, 327
 Provisão cultural, 95, 141, 374
 Prurite, 91
 Pseudologia fantástica, 37
 Psicanálise, 94, 163, 172, 195-195, 334 e segs., 362, 375-376
 aceitação do termo, 305
 biologia e, 188
 clássica, 57, 372
 compreensão dos efeitos da terapia de choque [ECT] e, 395, 401, 409-410
 cura e, 169
 de crianças, *vs.* consulta terapêutica 244
 desenvolvimento do processo de paciente em, 386
 elucidação da observação direta na, 315
 Ernest Jones e a, 303 e segs., 310
 estudo da agressão e, 348-349
 etiologia do transtorno psicótico e, 96, 195, 350
 etologia e, 328
 experiência cultural e, 160-161
 importância da observação de bebês para a, 380
 interesse da, na hereditariedade mais meio ambiente, 351
 modo de lidar com a ansiedade na, 61
 necessidade da sobrevivência da técnica na, 176, 193
 psicologia do inconsciente e, 415
 respeito pela resistência e, 415
 Ver também Análise,
 Psicologia:
 científica, 404-407
 da trombose coronária, 29-30
 estudos de, 323
 vs. neurocirurgia, 415
 Psicológico: entrevista de criança com, 245
 Psiconeurose, 53-58, 96, 152, 434, 435, 437
 organização da, no transtorno psicótico, 172
 sintomas de, na criança sadia que começa a caminhar, 55, 94
 Psicose, 53-54, 94, 96, 191, 195, 435
 como defesa contra a agonia primitiva, 72
 flerte com a, na saúde, 58
 moléstias da pele e, 90
 realização excepcional e, 372, 412
 relacionamentos mais iniciais e, 2
 religião e, 187
 terapia de choque e, 406
 Psicossomático (a, os, as), 82, 83, 85, 86
 Psicoterapia, 156, 375-377
 brinquedo e, 231, 243
 primeira entrevista na, 436
 Psique-soma, e alma, 419

Psique:

- e funcionamento físico, 89
- e vários órgãos corporais, 417-418

Psiquiatria, 96, 226, 403

Puberdade, 55-55, *Ver também* Adolescência

Pulsão destrutiva, 2, 11, 185, 191

Pulsões, 185, 190

Pêssegos, 117-118

Q. I., 225

Qualidade de relacionamento do ego, 362, 363

Qualidade viva: destrutividade e, 185

Queda eterna, 28, 100, 108, 147, 155

Queen's Hospital for Children, 9

Raiva, 81, 117, 146

- com o fracasso ambiental, 115, 130, 156

de D. W. W., 2, 12

na transferência, 199

Read, Stanford, 303

Realidade externa, 47, 50

Realidade psíquica interna, 47-50, 55, 355-356, 406, 435

crescimento da, 115

elementos benignos e persecutórios na, 356, 356

fantasias de gravidez e, 65

figuras imaginativas na, 138

Realidade, 173-174, 363

Ver também Sentir-se real

Realizar, 81

"Realização simbólica", 44, 363

Realização: meio ambiente facilitador e, 81

Regra básica, 163

Regressão, 37, 56, 116, 153-154, 433, 436

como reexperiência de estar fundido, 220

de paciente menino, 272 e segs.

em paciente feminina, 34, 39

na análise, 77

tipos de caráter e, 331

vs. retraimento, na análise, 116-117

Rei Lear, 3, 360

Relacionamento objetal, 71-72, 81, 172-173, 434, 435

com objeto objetivamente percebido, 180, 221

com objetos subjetivos, 81, 180, 330

elementos masculinos e femininos e, 139-141, 142, 149

falta de, como ansiedade psicótica, 100

impulsado pelo instinto *vs.* afeição, 160

inseparável da apresentação do objeto, 340, 357

onipotência e, 113

perda de, como ansiedade psicótica, 72, 155

Relacionamento(s), 31-32, 222

bebê-genitor, 434

entre bebê e objeto subjetivo, 330

trombose coronária e, 29

genitor-bebê, e paradoxo, 60-61

instintual, 45

mãe-feto, 127-128

mais inicial, estudo de D. W. W. do, 2

medo de fundir-se no, 258-259

tricolor, 187, 191

Relacionamentos objetais, 44, 53-54, 56-57

Relacionamentos triangulares, 57, 69, 187

Relaxamento, 31

Relação sexual: dos pais, idéias do bebê a respeito, 60-61

Relação sexual: expectativa social e, 138

Religião, 6, 187, 333

Reparação, 6, 181, 190, 193, 435

Repressão, 27, 45, 56-57, 74, 121

vs. dissociação, 370, 435

Resistência, 42, 415

Respirar, e destrutividade primária, 185

Restaurante, 23

Restauração: de pênis danificado, 19

Retaliação, 175-176, 186-187, 190-191

Retraimento, 116-117, 259

Ribble, M., 433

Rickman, John, 304

Riggall, R. M., 304

Rigidez, 44

de defesas, na psicose, 57, 58, 94-95

Rilke, Rainer Maria, 1, 186-187

Ritvo, S., 189

Rivalidade entre irmãos e irmãs, 57

Rivers, H. R., 304

Rivière, Joan, 303-304, 307, 349, 438

Robertson, James e Joyce, 326

Roer unhas, 284

Romulo e Remo, 220

Rosenfeld, Herbert, 133

Rosto, 46

Rycroft, Charles, 333-334

Saber, 20-21

Sadismo oral, 26, 41, 339, 340

Sadismo, reprimido, na mãe, 40

Saliva, 45

Sandler, Joseph, 353-358

Sanidade: fuga para a, 416

Sargent-Florence, Mary, 387

Satisfação: no brinquedo, 49

Saúde mental: do bebê, 221, 408

Saúde, 58, 138, 300, 328

ambivalência na, 131

capacidade de usar objeto na, 180, 181

diagnosticada em moça adolescente, 284

identidade do *self* com o corpo na, 89, 203

luto e, 329

raiva e, 156

regressão e, 154

superego pós-edipiano e, 356

tipos de caráter e, 331, 334

vs. doença, 249

Scott, Clifford, 174n., 393, 397

Searles, H. F., 116, 362-364

Sechehayé, M. A., 44, 363

"Seio bom", 341 e segs., 346

Seio, 48, 66, 141-142, 176

- alimentação ao, 173
 ataque ao, 18, 285-286
 idealizado, simbolizado por pêssegos, 118
 uso da palavra, em análise, 330
Self falso, 36-37, 154, 167-168, 192-193, 221, 345, 354
 Jung e, 368, 369
Self, 27, 42-43, 140, 142, 371
 baseado no corpo, 210
 bissexualidade do, 136-137
 busca de Jung pelo, 366, 371
 definição de, 210
 definido por membrana limitadora, 47
 diferente do ego, 370
 do bebê, 81
 duas experiências sensoriais e, 381
 identidade do, com o corpo, 89
 Senso de humor, 5, 58, 261
 valor do, na análise, 24, 25
 Senso do olfato, 45
 Sensualidade: no bebê, 45
 Sentimentos de irrealidade, 31, 72, 100
 Sentir-se real, 26, 45, 121, 131, 357
 SER e, 332-333
 através da aflição na análise, 104
 brinquedo e, 50
 busca do *self* e, 371
 Separação [*separateness*], 11, 141
 Separação [*separation*]: teoria da, 436
 Ser, 140, 142
 continuidade do, 75, 155, 273, 332
 cuidado materno e, 332
 vs. fazer, 143, 149-150
Setting: na análise, 77, 79-80, 247
 Sexo:
 biológico vs. características do outro sexo, 149
 uso construtivo do, 181
 Shakespeare, 12, 142, 143
 Sharpe, Ella, 304
 Shehan-Dare, Helen, 393
 Sigilo, segredo, 18-20
 Significado, 45, 48
 Silêncio, 66-69, 165, 442-443
 Simbiose, 440
 Símbolo(s), 47, 55, 147
 e brinquedo, 49, 50
 e objeto transicional, 36, 44-45
 perda da capacidade de utilizar, 46, 330
 vs. palavras, 123
 Simmel, George, 303
 Simpatia; de paciente por analista, 28
 Sindactília, 204-205
 Sintoma(s), 55, 109, 154, 182-183, 425
 Ver também Sintomatologia
 Sintomatologia, 90, 94-95, 147, 244
 Socialização, 51, 131
 Sociedade de Pesquisas Psicossomáticas, 29, 82
 Sociedade de Psicanalistas de Londres, 303
 Sociedade Médico-Psicológica, 401
 Sociedade Psicanalítica Americana, 303
 Sociedade Psicanalítica Britânica, 12, 94, 133, 134, 295, 296, 303, 305, 340-341, 348n., 350, 353, 386, 393, 400, 403, 438
 Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, 170, 171, 189, 303
 Sociedade Psicológica Britânica, 219, 304, 393
 Sofrimento:
 como resultado da integração, 115
 em casos fronteiros [*borderline*], 156
 vs. invulnerabilidade da esquizofrenia, 155
 Sonhar, 21
 Sonho(s), 92, 120, 159, 184, 275-276, 344, 416, 443
 de D. W. W., que o levou a escrever, 437
 teoria de Fairbairn sobre o(s), 317
 trabalho do, 165, 178
 Sonhos descritos no texto:
 da filha de G., 285
 de Clare W., 13
 de D. W. W., 12, 158, 178-179
 de Jung, 367-369
 de L., 238
 de pacientes femininas, 33, 35, 92, 118, 165, 345-345
 de pacientes masculinos, 145, 147-148, 343
 de pacientes meninas e moças, 85, 109-111, 208, 214
 de Patrick, 266-267, 275
 Sono, 12, 42, 157-158, 184
 Sorriso: de bebês, 328
 SOU, 76, 89, 89, 332, 435
 Souza, Décio Soares de, 133
 Sozinho na presença de, 435
St. Bartholomew's Hospital, 9
 Status unitário: conquista do, 189, 189, 430
 Sterba, Richard, 133
 Stoddart, W. H. B., 303
 Storr, Anthony, 348
 Strachey, Alix, 304, 385 e segs.
 Strachey, James, 304, 384-387
 Strachey, Lytton, 387
 Strachey, Sir Richard, 384
 Subjetividade: vs. objetividade, 299-300, 314-315
 Sublimação, 160, 184, 435
 Sugar o polegar, 17-19, 23, 36, 46, 333
 Suicídio, 27, 75, 88, 106, 130, 146
 desejo de, e terapia de choque, 395-397
 fracasso da análise e, 172
 Superego, 353 e segs.
 Sustentação [*holding*], 28, 230, 262 e segs.
 cuidado físico do bebê e, 200-202
 fisioterapia e, 431-432
 meio ambiente facilitador e, 71-72, 81
 Suttee, Ian, 433, 437
- T**
 alião, 68, 69, 190
 Tapete(s), 117
 Tela onírica, 233
 Temor, *ver* Medo
 Tendência anti-social, 54-55, 88, 181, 434, 435, 439
 Tendência obsessiva, 57
 Tensão, 31-32, 39, 52

e funcionamento corporal orgástico, 17, 31
 Tensões instintuais, 52
 Teoria: necessidade da, 134
 Terapeuta, 111-156
 como objeto subjetivo, 245, 248, 253
 Ver também Analista
 Terapia de choque, 393-411, 417
 Ver também T. E. C.
 Terapia do comportamento, 424-426
 Terapia insulínica, 404, 416
 Terapia ocupacional, 399, 422-423
 Teste de Apercepção Temática, 232, 246n.
 Thomas, Dylan, 12
 Thorner, Hans, 393
 Titmuss, R. M., 393
 Tolstói, L., 159
 Tomada de notas, 66, 250, 258, 261
 Tosse, 41
 Tranqüilização: na análise, 246
 Transferência:
 ambivalência na 407
 analista como esposa e mãe na, 146
 analista como louco na, 148, 149
 analista como mãe na, 193
 assuntos profundamente enterrados na, 134
 compreensão da, pelos psiquiatras, 404
 confiança na, e interpretação, 165-166
 confiança na, e não integração, 28
 delirante, 34, 98, 104, 105, 106, 107, 117, 135, 357,
 434, 442
 dependência, 71
 destrutividade na, 350
 dissociações trazidas à, 87
 evolução da, 172
 experiência inicial descoberta na, 199
 fisioterapia e, 431
 medo do colapso na, 73-74
 ódio na, 18
 positiva, 104
 reviver de ansiedade intolerável na, 60-61
 surgimento da vida instintual na, 356
 Transições: e objeto transicional, 44-45
 Transtorno psicossomático, 29-32, 57, 427, 429 e segs.

em paciente menino, 272, 280
 Ver também Enfermidade psicossomática
 Trauma, 102-115, 155-156, 200-201
 loucura da mãe como, 290-292
 Travesseiro(s), 117
 Travestismo, 25, 52
 Treinamento: maternagem inicial e, 27
 Trens, 287 e segs.
 Três áreas para viver, 47, 435
 Tristeza, 28, 209
 Trombose coronária, 29-32
 Trotter, Wilfred, 301-302
 Jung e, 368, 369, 371
 self verdadeiro, 36, 42-43, 154.

Unidade: primária, 137, 185
 Universo, 47
 Ursinho de pelúcia, 323
 Uso de um objeto, ix, 2, 10, 11, 170-191

Vaca, 34
 Vazio, 42, 75
 Verbalização, 163
 Verdade: mutante, na psicoterapia, 251
 Vida cultural, 47, 48
 Vitalidade, 5
 Voz: produção da, 22

Wilson, Cyril, 401, 404
 Winnicott, aldeia de, 4
 Winnicott, Alice, 423
 Winnicott, Clare, vii, 1-13
 Winnicott, D. W., 1-13, 433-443
 Winnicott, Richard, 5
 Winnicott, Sir Frederick, 5
 Wolff, Leonard, 386

Zeus, 139



BIBLIOTECA ARTMED

Psicanálise

- Aberastury, A. – Psicanálise da criança
Aberastury, A. – Abordagens à psicanálise de crianças
Aberastury & Knobel – Adolescência normal
Ballint, M. – A falha básica: aspectos terapêuticos da regressão
Bergeret, J. – Personalidade normal e patológica (3.ed.)
Bettelheim & Zelan – Psicanálise da alfabetização
Bleichmar & Bleichmar – A psicanálise depois de Freud: teoria e clínica
Bleichmar, S. – Nas origens do sujeito psíquico
Blos, P. – Transição adolescente
Chenama, R. – Dicionário de psicanálise
Etchegoyen, R.H. – Fundamentos da técnica psicanalítica (2.ed.)
Freud Museum London – Diário de Sigmund Freud
Giovacchini, P.L. – Táticas e técnicas psicanalíticas: D.W. Winnicott
Glenn, J. – Psicanálise e psicoterapia de crianças
Groznick, S. – Winnicott: o trabalho e o brinquedo
Graña, R.B. – Além do desvio sexual: teoria-clínica-cultura
Graña, R. – Homossexualidade: formulações psicanalíticas atuais
Greenberg & Mitchell – Relações objetais na teoria psicanalítica
Hannah, B. – Jung - vida e obra: uma memória biográfica
Kernberg, O.F. – Agressão nos transtornos de personalidade e nas perversões
Kernberg, O.F. – Ideologia, conflito e liderança em grupos e organizações
Kernberg, O.F. – Transtornos graves de personalidade
Kernberg, O.F. – Psicoterapia psicodinâmica de pacientes borderline
Langer, M. – Maternidade e sexo
Laplanche, L. – Vida e morte em psicanálise
Moore & Fine – Termos e conceitos psicanalíticos: dicionário referendado pela APA
Osorio, L.C. – O enigma da esfinge: o ponto de vista evolutivo em psicanálise
Sillamy, N. – Dicionário de psicologia
Tyson & Tyson – Teorias psicanalíticas do desenvolvimento: uma integração
Wallerstein, R.S. – A cura pela fala
Winnicott, Shepherd & Davis – Explorações psicanalíticas: D.W. Winnicott
Winnicott, D.V. – O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional
Winnicott, D.V. – Pensando sobre crianças
Zimmerman, D.E. – Bion - da teoria à prática: uma leitura didática (2.ed.)
Zimmerman, D.E. – Fundamentos psicanalíticos - teoria, técnica, clínica: uma abordagem didática
Zimmerman, D.E. – Manual de técnica psicanalítica: uma re-visão
Zimmerman, D.E. – Vocabulário contemporâneo de psicanálise
Young-Eisendrath & Dawson – Manual de Cambridge para estudos junguianos

EXPLORAÇÕES PSICANALÍTICAS D.W. WINNICOTT

CLARE WINNICOTT

RAY SHEPHERD

MADELEINE DAVIS

Organizadores

Winnicott deixou-nos um legado de conceitos, idéias e atitudes, cuja importância continua a crescer e que abrange os campos teórico e clínico. Agora, os editores de *Winnicott Trust* reuniram em um só volume 92 trabalhos de interesse para psicanalistas e psicoterapeutas — *Explorações psicanalíticas* —, sendo caracterizado como o livro-fonte do pensamento de Winnicott.

Esta seleção abrange os anos que vão da Segunda Guerra Mundial ao falecimento de Winnicott, em 1971, e testemunha a ampla gama de seus interesses intelectuais e de sua experiência clínica. Ela inclui críticas anteriormente não-publicadas das idéias de Melanie Klein e comentários sobre o trabalho de outros psicanalistas, assim como exemplos clínicos, estudos de casos e jóias de reflexão extraídas dos arquivos de D.W.W.

Muitos dos tópicos são de utilidade direta para os clínicos, tais como, por exemplo, o brinquedo na situação analítica, o uso do silêncio, o transtorno psicossomático e a interpretação na análise; o livro apresenta, ainda, sete capítulos que versam sobre a psicoterapia de crianças e de adolescentes. Outros capítulos tratam de temas como o destino do objeto transicional, o medo do colapso, os eementos masculinos e femininos ex-cindidos e a base para o *self* no corpo. Acham-se também incluídos os textos de Winnicott sobre ECT e leucotomia, o seu último grande artigo teórico — “O uso de um objeto” —, além de uma comovente e reveladora lembrança do autor por parte de sua viúva, Clare, e, como pós-escrito, uma palestra que fez já bem tarde na vida e na qual debate as influências que modelaram o seu trabalho.

ISBN 978-85-7307-017-0



9 788573 070170

artmed®
EDITORA

RESPEITO PELO CONHECIMENTO



www.artmed.com.br